



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**LAPORAN KINERJA TAHUNAN
RS PRIMA HUSADA MALANG
TAHUN 2025**

Jl. Banjararum Selatan No. 3, Mondoroko, Singosari - Malang

Telp. 0341 - 458679, 458916, Fax. 441874

Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
BAB II GAMBARAN UMUM	4
2.1 Visi	4
2.2 Misi	4
2.3 Motto	4
2.4 Nilai Budi Utama	4
2.5 SOTK	4
BAB III KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN DAN HASIL YANG DICAPAI	5
3.1 SDM	5
3.1.1 Ketenagaan (Distribusi Tenaga, Kualifikasi dan Kebutuhan)	5
3.1.2 Orientasi	11
3.1.3 Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	11
3.1.4 Evaluasi Kinerja Staf	13
3.2 Hasil Pengembangan Pelayanan	16
3.3 Kinerja Produktifitas Unit dan Instalasi	19
3.3.1 Penunjang	19
3.3.1.2 Farmasi	19
3.3.1.2 Radiologi	25
3.3.1.3 Laboratorium	26
3.3.1.4 Rekam Medis	26
3.3.1.5 Gizi	31
3.3.1.6 CSSD – Laundry	34
3.3.1.7 Unit Kamar Jenazah	40
3.3.2 Pelayanan	40
3.3.2.1 IRJA	40
3.3.2.2 IRNA	44
3.3.3 Umum	68
3.3.3.1 Humas – Marketing	68
3.3.3.2 IPSRS	81
3.3.3.3 <i>Cleaning Service</i>	94
3.3.3.4 Gudang	95
3.3.3.5 <i>Security</i>	97
3.3.3.6 Asuransi Center	100
3.3.3.7 PIPP	102
3.3.3.8 IT-SIMRS	106
3.3.3.9 Driver	108
3.3.3.10 Keuangan	109
3.3.4 Program Nasional (PROGNAS)	109
3.4 Kinerja Produktifitas Komite MFK dan K3	151
3.4.1 Fasilitas Kesehatan	151
3.4.2 Gedung dan Bangunan	153
3.4.3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja	158
3.5 Kinerja Produktifitas Komite Mutu	162
3.5.1 Mutu Nasional	162
3.5.2 Mutu Prioritas Rumah Sakit	173
3.5.2.1 Mutu Sasaran Keselamatan Pasien (SKP)	173
3.5.2.2 Mutu Pelayanan Klinis Prioritas	186
3.5.2.3 Mutu terkait Tujuan Strategis Rumah Sakit	187
3.5.2.4 Mutu terkait Perbaikan Sistem	187
3.5.2.5 Mutu terkait Manajemen Resiko	190
3.5.3.6 Mutu prioritas Internal Unit	190
3.6 Kinerja Produktifitas Komite PPI	247
3.7 Kinerja Produktifitas Tim PKRS	257
3.8 Kinerja Produktifitas Geriatri	274
3.9 Kinerja Produktifitas Produktifitas Komite Farmasi Terapi	280
3.9 Kinerja Produktifitas Produktifitas Tim Review Rekam Medis	298
3.11 Kinerja Produktifitas Komite PPRA	298
3.13 Kinerja Produktifitas Komite Keperawatan	306
3.14 Kinerja Produktifitas Komite Medis	309
3.15 Kinerja Produktifitas Komite Tenaga Kesehatan Lain	312
BAB IV KINERJA KEUANGAN	314
4.1 Pendapatan Tahun 2025	314
4.2 Biaya Tahun 2025	314
4.3 Rasio Keuangan	314
4.4 Kinerja Piutang	315
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	316
BAB VI PENUTUP	317

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rumah Sakit Prima Husada adalah sebuah Rumah Sakit Swasta tipe C yang terletak di Banjararum Selatan, Singosari, Malang. Rumah sakit berperan sebagai ujung tombak dalam pembangunan kesehatan masyarakat, harus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi, produktivitas dan penerapan praktek bisnis yang sehat. Rumah sakit harus mengacu pada prinsip – prinsip akuntabilitas, transparansi, efektifitas dan efisiensi.

Dalam rangka terselenggaranya *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan rumah sakit dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan Kinerja rumah sakit dalam hal ini Rumah Sakit Prima Husada Malang adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban Rumah Sakit Prima Husada Malang untuk mempertanggungjawabkan kinerja, keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi misi Rumah Sakit Prima Husada Malang dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Selain dari tuntutan akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja juga sebagai alat ukur keberhasilan Rumah Sakit dalam mencapai tujuan dan/atau sasaran atau kegiatan utama yang dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja di masa datang, kuncinya adalah penekanan pada tujuan dan sasaran atau program kegiatan yang perlu mendapat perhatian sebagai ukuran keberhasilan.

Rumah Sakit Prima Husada Malang adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan dibidang kesehatan berkelanjutan secara paripurna dengan mengutamakan pengobatan dan pemulihan tanpa mengabaikan peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan melalui penyediaan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, penunjang dan tindakan medik.

1.2. Dasar Hukum

Dalam penyelenggaraan Rumah Sakit harus berlandaskan peraturan dan undang undang yang berlaku, diantaranya :

1. Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Bidang Perumahan sakitan
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Rumah Sakit
3. Undang – Undang No 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien
5. Peraturan Menteri kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Penyelenggara Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Rumah Sakit
7. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Keanggotaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit
10. Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2013 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit

1.3. Maksud dan Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Rumah Sakit Prima Husada Malang tahun 2025 adalah untuk:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan pelayanan antar unit untuk meningkatkan kinerja rumah sakit
3. Menetapkan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam sasaran strategis

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Visi

Menjadi Rumah Sakit berkualitas prima pilhan seluruh lapisan masyarakat

2.2. Misi

1. Memberikan Pelayanan Kesehatan dengan Aman, Tepat, Cepat dan Akurat
2. Mengutamakan Kepuasan dan Keselamatan Pasien
3. Meningkatkan Mutu Pelayanan yang Berkelanjutan

2.3. Motto

Sahabat Menuju Sehat

2.4. 7 Nilai Budi Utama

1. Jujur
2. Tanggung Jawab
3. Visioner
4. Disiplin
5. Kerjasama
6. Adil
7. Peduli

2.5. SOTK



BAB III
KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN DAN HASIL YANG DICAPAI

3.1 SDM
3.1.1 Ketenagaan

NO	UNIT	PENDIDIKAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
1	Direktur	Dokter Umum	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Kabid Pelayanan Medis	D3 Kebidanan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Kabid Penunjang Medis	D3 Kebidanan	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1
4	Kabid Keperawatan	Profesi Ners	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
5	Kabid Umum & Keuangan	Dokter Gigi Umum	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Satuan Pengawas Internal	SMK	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Dokter IGD	Dokter Umum	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
8	Dokter Casemix	Dokter Umum	0	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1
9	Farmasi	Profesi Apoteker	13	13	13	13	13	13	13	12	12	12	12	12
		S1 Farmasi	3	3	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3
		D3 Analis Farmasi dan Makanan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		D3 Farmasi	20	20	20	20	20	20	20	22	22	22	22	22
		SMK	2	4	4	4	4	4	4	1	1	1	1	1
		S1 Manajemen	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Asuransi Center	D3 Asuransi Kesehatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
		SMK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		SMA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	CSSD	D3 Keperawatan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2
		SMA	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		SMK	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
12	Fisioterapi	D4 Fisioterapi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		D3 Fisioterapi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		D3 Terapi Wicara	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	Gizi	S1 Ilmu Gizi	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		D4 Gizi dan Dietetika	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		D3 Ahli Gizi	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		SMK	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
		SMA	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		SMP	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
14	Humas & Marketng	D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

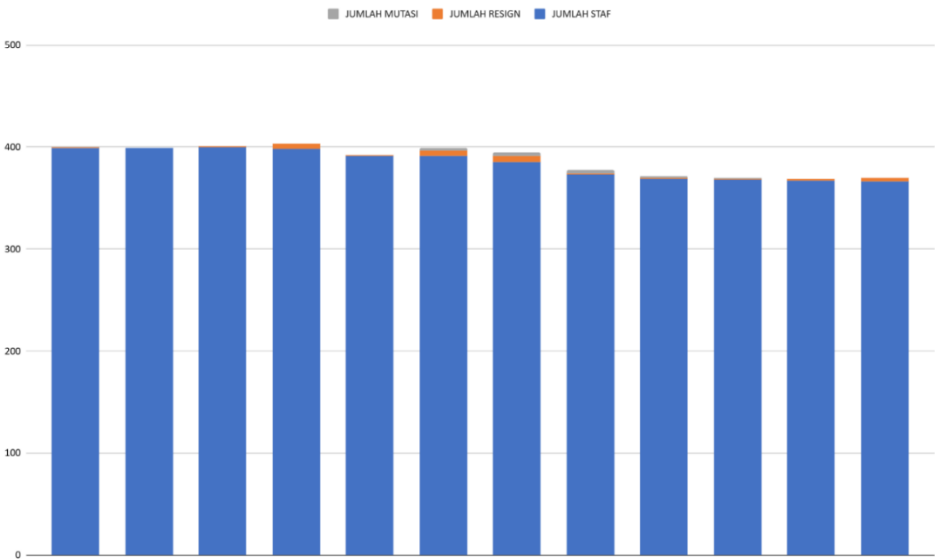
NO	UNIT	PENDIDIKAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JU L	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
		S1 Teknik Informatika	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15	ICU dan HCU	Profesi Ners	4	6	6	6	6	6	6	5	5	5	5	5
		D3 Keperawatan	7	6	6	6	6	6	6	7	7	7	6	5
16	IGD	Profesi Ners	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
		D3 Keperawatan	9	9	9	9	8	8	8	8	8	8	7	8
		D4 Kebidanan	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		D3 Kebidanan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2
17	IKO	Profesi Ners	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8
		D3 Keperawatan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
		D3 Kebidanan	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
18	IPCN	Profesi Ners	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19	IPSRs	S1 Tenik Elektro	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		S1 Kesehatan Masyarakat	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		D3 Teknik Elektromedis	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		SMK	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
20	IRJA	Profesi Ners	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
		D3 Keperawatan	13	14	14	14	14	14	14	15	15	15	15	15
		D4 Keperawatan Gigi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
		Profesi Kebidanan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		D3 Kebidanan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
21	IRNA 2C	Profesi Ners	6	6	6	6	6	6	6	5	5	5	5	5
		D3 Keperawatan	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	2	2
22	IRNA 2A, 3A, & 4A	Profesi Ners	5	5	5	5	5	5	5	7	7	7	7	7
		D3 Keperawatan	13	13	13	13	13	13	13	11	11	11	10	10
23	IRNA 3C Anak	Profesi Ners	6	6	6	6	6	6	6	4	4	4	4	4
		D3 Keperawatan	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
		D3 Kebidanan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
24	IRNA 5C	Profesi Ners	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		D3 Keperawatan	6	6	6	6	6	6	6	5	5	5	5	5
25	IRNA 6A, 7A, & 8A	Profesi Ners	12	12	12	12	12	11	11	8	8	8	8	8
		D3 Keperawatan	8	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
26	Maternitas	Profesi Kebidanan	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1
		D4 Kebidanan	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3
		D3 Kebidanan	8	8	8	8	8	8	8	7	7	7	7	7
27	Neonatologi	Profesi Ners	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3
		D3 Keperawatan	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5
		D3 Kebidanan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
28	Keuangan & Akuntansi	S1 Ekonomi	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3
		S1 Akuntansi	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1

NO	UNIT	PENDIDIKAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JU L	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
		S1 Manajemen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		SMK	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		SMA	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
29	Laboratorium	D4 Analis Kesehatan	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1
		D3 Analis Kesehatan	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	7
30	Laundry	SMK	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
		SMA	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2
		SMP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
31	Rekam Medis	D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan	10	10	10	10	10	9	9	7	7	7	7	7
32	Pendaftaran	S1 Sastra Inggris	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		S1 Manajemen	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
		S1 Kesehatan Masyarakat	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		D4 Pariwisata	1	1	1	1	1	1	2	0	0	0	0	0
		D3 Asuransi Kesehatan	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1
		D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan	6	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7
		D1 Administrasi Perkantoran	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		SMK	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1
		SMA	4	4	4	4	4	2	2	3	3	3	3	3
33	PIPP & MPP	Profesi Ners	2	2	1	2	2	2	2	0	0	0	0	0
		D4 Kebidanan	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		D3 Keperawatan	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		D3 Kebidanan	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
34	PMKP	Profesi Ners	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
35	Radiologi	D3 Radiodiagnostik & Radioterapi	7	7	7	7	7	7	7	7	7	6	6	6
36	SDM	S1 Psikologi	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
		S1 Ilmu Sosial	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
37	Sekretaris	S1 Administrasi Publik	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
38	SIMRS & IT	S1 Teknik Informatika	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	3
39	Umum & Rumah Tangga	S1 Ekonomi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1
40	Cleaning Service	SMK	16	17	17	17	17	14	14	14	14	14	1	14
		SMA	24	24	24	24	24	23	23	21	21	21	14	21
		SMP	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	21	5
41	Security	SMK	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

NO	UNIT	PENDIDIKAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JU L	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
		SMA	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	5	7
42	Driver	D1 Administrasi Perkantoran	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	1
		SMA	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	1	4
		SMP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	1
43	Gudang Umum	SMP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
44	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Pendidikan Dokter Spesialis	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	1	5
45	Dokter Spesialis Anak	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	3
46	Dokter Spesialis Bedah Umum	Pendidikan Dokter Spesialis	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4
47	Dokter Spesialis Bedah Plastik	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	1
48	Dokter Spesialis Obsitetri dan Ginekologi	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	3
49	Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2
50	Dokter Spesialis Mata	Pendidikan Dokter Spesialis	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	2	3
51	Dokter Spesialis THT	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2
52	Dokter Spesialis Paru	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3
53	Dokter Spesialis Saraf	Pendidikan Dokter Spesialis	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4
54	Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3
55	Dokter Spesialis Orthopedi dan Traumatology	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
56	Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2
57	Dokter Spesialis Urologi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
58	Dokter Spesialis Anestesi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	2	2	3	3	3	2	2	3	2	3
59	Dokter Spesialis Radiologi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2
60	Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
61	Dokter Spesialis Patologi Klinik	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
62	Dokter Spesialis Patologi Anatomi	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
63	Dokter Spesialis Gigi Periodontis	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
64	Dokter Spesialis Gigi Pedodontis	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

NO	UNIT	PENDIDIKAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JU L	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
65	Dokter Spesialis Gigi Orthodontis	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
66	Dokter Spesialis Gigi Orthodontis	Pendidikan Dokter Spesialis												1
Total			447	459	461	458	462	451	452	430	429	431	429	430

Grafik Data Mobilitas Staf Selama Tahun 2025



No	Nama	Unit	Tanggal Resign	Alasan Resign
1	Dinda Kartika Rahmadani, S.Psi	SDM	18 Januari 2025	Mendapat kesempatan di tempat lain
2	Rizky Dinda Maulidya, A.Md.Kep	Neonatologi	22 Maret 2025	Mencari pengalaman baru
3	Anistya Pebryani Widoastoro, S.Ak	Kasir	30 April 2025	Tidak di perpanjang kontrak
4	Agustina Kusuma Wardani, S.Tr.Keb	Maternitas	22 April 2025	Tidak memperpanjang kontrak
5	Saveinisa Satya Abdarashtra	Laboratorium	30 April 2025	Kembali ke kota asal
6	Rahma Yunita, Amd. Keb	IGD	25 April 2025	Pindah domisili
7	Rizki Maulana Oktavinanta	CS	22 April 2025	Tidak di perpanjang kontrak
8	Yoga Kurniawan	CS	23 Mei 2025	Sakit dan butuh istirahat lama
9	Rosi Slamet Saputri, S.Kep., Ns	IRJA	16 Juni 2025	Buka praktik pribadi di tempat tinggal asal suami
10	Mochamad Fahad, S.Kep., Ns	IRNA 678A	16 Juni 2025	Buka praktik pribadi di tempat tinggal asal
11	dr. Sheila Dyah Prasetyo	Dokter Casemix	30 Juni 2025	Pindah domisili
12	Putra Kukuh Catur Ari, S.Tr.Kep., Ns	IRNA 678A	16 Juni 2025	Pindah domisili
13	Ica Anindya Pangestika, S. Farm., Apt	Farmasi	01 Juni 2025	Pindah domisili
14	Yeni Khikmatus Sholikhah, A.Md. Akt	Pendaftaran	31 Juli 2025	Pindah domisili
15	Fakhrur Rifqi Aliyanto, S. Kep., Ns	IGD	31 Juli 2025	Buka praktik pribadi di tempat tinggal asal

No	Nama	Unit	Tanggal Resign	Alasan Resign
16	Octa Fitri Muazizah, S. Tr. kep	IRNA 234A	31 Juli 2025	Pindah domisili
17	Maharani Juwita Zhalsabilla, S.Tr.Par	Pendaftaran	31 Juli 2025	Kontrak Selesai dan tidak di perpanjang
18	Muhammad Riza Kurniawan	CS	31 Juli 2025	Tidak bersedia mutasi ke RSDH dan memilih resign
19	Rina Tri Wahyuni, Amd. RMIK	Pendaftaran	31 Juli 2025	Menjaga anak karena suami mendadak pindah kerja ke luar kota
20	Annadiva Fikri Chandra Maulana	SDM	31 Agustus 2025	Tidak berkenan di mutase
21	dr. Nur Mazidah	Direksi	11 September 2025	Fokus kehamilan
22	Zahrocha Fathmananda Refarin, Amd. Kep	IGD	24 Oktober 2025	Pindah domisili
23	Diah Lusiana Eko Tohari, Amd. Kep	Neonatologi	30 November 2025	Pindah domisili
24	Bella Kristyana Dewi, Amd. AK	Laboratorium	30 November 2025	Pindah domisili
25	Yurike Devita Ratna Sari Dewi , S. Kep., Ns	IKO	31 Desember 2025	Pindah domisili
26	Dwinta Widya Navita, Amd. Kep	ICU	31 Desember 2025	Pindah domisili
27	Mokhamad Nadhif Darmawan	Security	31 Desember 2025	Dapat kesempatan lain
28	Niken Eka Lidiani, A.Md. Farm	Farmasi	31 Desember 2025	Pindah domisili

Tabel Data Staf Mutasi Selama Tahun 2025

No	Nama	Asal	Tujuan	Tanggal Mutasi
1	Wahyu Rahmatun Nisa	PHM	PHS	09 Juni 2025
2	Rino Sanjaya	PHM	PHS	09 Juni 2025
3	Dalia Eka Pratiwi	PHM	PHS	16 Juni 2025
4	Rendra Tohedy, Amd. Kep	PHM	MS Lawang	14 Juli 2025
5	Adhita Krisna Prastiti, S. Tr. Keb., Bdn	PHM	MS Lawang	14 Juli 2025
6	Prima Dio Prasajo, S. Tr. Kep	PHM	PHS	22 Juli 2025
7	Aulia Rahmatul Amani, Amd. Kep	PHM	PHS	21 Juli 2025
8	Gusti Naila Ghufron	PHM	PHS	01 Agustus 2025
9	Sisca Puspitasari, S.Kep.Ns	PHM	PHS	05 Agustus 2025
10	Cindytya Andrawina, S. Kep.Ns	PHM	RSDH	11 Agustus 2025
11	Yanti	PHM	RSDH	20 September 2025
12	Kholilul Rohman, Amd. Kep	PHM	RSDH	01 Oktober 2025

- Analisa :**
- Jumlah staf mengalami penurunan karena adanya staf resign dan mutasi.
 - Mutasi staf ke RS Dharma Husada, RS Prima Husada Sukorejo dan Klinik Mutiara Sehat.
 - Turn over staf tahun 2025 sebesar 0,073%

3.1.2 Orientasi

Tabel Update Orientasi Staf Rumah Sakit

NO	NAMA	UNIT	PROFESI	TMT	AWAL ORIENTASI UNIT	AKHIR ORIENTASI UNIT
1	Nabila Rizki Amalia, S. Tr. Kes	Laboratorium	Analisis Kesehatan	02 Mei 2025	02 Mei 2025	01 Agustus 2025
2	dr. Kezia Berlianti Rukmana	IGD	Dokter Umum	28 Juli 2025	28 Juli 2025	27 Agustus 2025
3	dr. Resti Lestantini, M. Kes	Direksi	Dokter Manajemen	10 September 2025	10 September 2025	09 Desember 2025
4	Kendita Putri Mahadini, S. ST	IRJA	Perawat Gigi	21 Oktober 2025	21 Oktober 2025	20 Januari 2025
5	dr. Denny Prasetyo, Sp. An-TI	IKO	Dokter Spesialis Anestesi	21 Oktober 2025	-	-
6	dr. Khadijah Fauzi Basalamah, Sp. KG, M. Kes	IRJA	Dokter Spesialis Konservasi Gigi	19 November 2025	-	-

3.1.3 Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Tabel Update Pelaksanaan Diklat 2025

Bulan	Tanggal Pelaksanaan	Kegiatan Diklat	Pemateri	Jumlah Yang Diundang	Jumlah Yang Hadir	Jumlah Yang Tidak Hadir
Januari	Selasa, 07 Januari 2025	Inhouse Training Diklat Fibrinolitik	dr. Miryanti Cahyaningtias, Sp. JP	50	43	7
Maret	17 - 19 Maret 2025	Kebijakan Akreditasi RS	Dr. dr. Aslichah, M. Kes, AFP	400	351	49
April	23 - 26 April 2025	Manajemen Risiko	Faisal Aminudin Ilham, S.KM	448	424	24
	09 - 10 April 2025	Indikator Mutu Nasional dan Prioritas	Dr. Ari Putriani, Sp. PK Alifia Dian Sukmaningtyas, S. Kep., Ns	417	362	55
Mei	13 - 14 Mei 2025	PMKP	dr. Ari Putriani, Sp. PK Alifia Dian Sukmaningtyas, S. Kep., Ns	363	350	13

Bulan	Tanggal Pelaksanaan	Kegiatan Diklat	Pemateri	Jumlah Yang Diundang	Jumlah Yang Hadir	Jumlah Yang Tidak Hadir
	21 - 22 Mei 2025	PPI Dasar	Sherly Rosita, S. Kep., Ns	392	320	72
Juni	9 - 10 Juni 2025	Penggunaan APAR	Faisal Aminudin Ilham, S.KM	390	389	1
	23 – 24 Juni 2025	Komunikasi Efektif bagian Umum	Seluruh PJ Pokja yang terlibat	101	96	5
Juli	07 Juli 2025	Pengelolaan Limbah B3	Faisal Aminudin Ilham, S.KM	363	360	3
	09 – 10 Juli 2025	Komunikasi Efektif bagian Penunjang	Seluruh PJ Pokja yang terlibat	103	96	7
	15 Juli 2025	Kegawatdaruratan Maternal	dr. Aida Musyarofah, Sp. OG	68	51	17
	16 – 17 Juli 2025	Hak Pasien dan Keluarga	Fadhila Ayu Setiani, Amd. Kep Murwani Suryaning S., Amd. Kep	350	272	78
Agustus	13 – 15 Agustus 2025	Komunikasi Efektif bagian Pelayanan	Seluruh PJ Pokja yang terlibat	164	133	31
	26 Agustus 2025	Sasaran Keselamatan Pasien	dr. Ari Putriani, Sp. PK Khusnul Khotimah, Amd. Kep	308	226	82
	12 dan 28 Agustus 2025	BHD Advance	Dr. Arief Heru Wicaksono, Sp. An-TI	26	23	3
	15 Agustus 2025	Kegawatdaruratan Neonatal	dr. Fiona Paramitha, Sp. A	70	34	36
September	10 – 11 September 2025	BHD Dasar	Dokter IGD	369	360	9
	16 September 2025	Drill Emergency	dr. Amanda Firmandani	37	26	11

Bulan	Tanggal Pelaksanaan	Kegiatan Diklat	Pemateri	Jumlah Yang Diundang	Jumlah Yang Hadir	Jumlah Yang Tidak Hadir
Oktober	17 Oktober 2025	Medication Error	dr. Ari Putriani, Sp. PK	235	173	62
	24 Oktober 2025	Stunting Wasting	dr. Fiona Paramitha, Sp. A	42	32	10
Desember	8 Desember 2025	Penyiapan Obat Intravena dan Teknik Aseptik	Yuanita Eka Lestari, S. Farm., Apt Fadilah Maulana, S. Farm., Apt	166	137	29
	19 Desember 2025	HIV dan TB	dr. Andy, Sp. P Daning Pravitia YSM, S.Tr.Keb	49	28	21
	24 Desember 2025	Hipnotik Sedatif	dr. Arief Heru Wicaksono, Sp. An-TI	74	68	6

3.1.4. Evaluasi Kinerja Staf

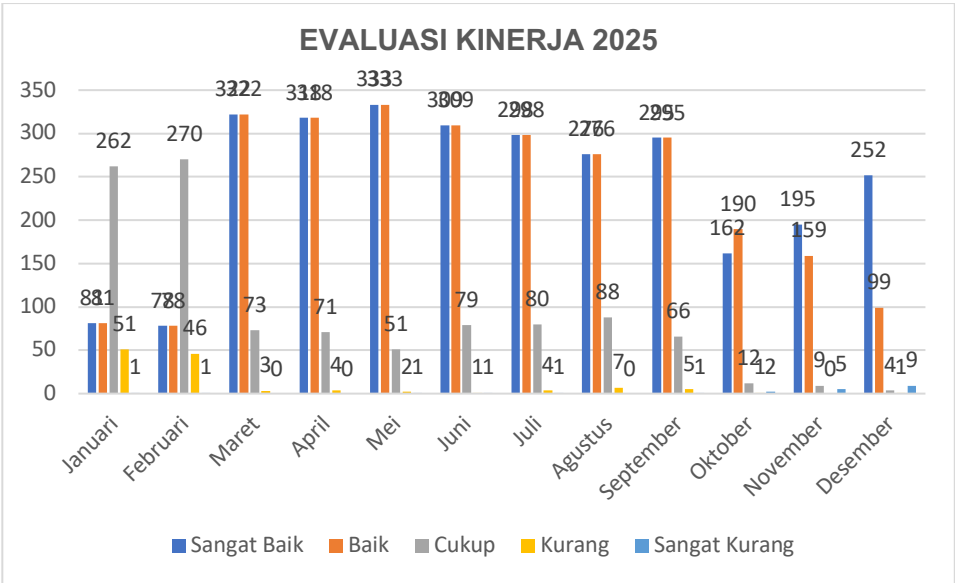
NO	UNIT	KETERANGAN
1	Direktur	Unit Direktur secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
2	Kabid Pelayanan Medis	Unit Kabid Pelayanan Medis secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
3	Kabid Penunjang Medis	Unit Kabid Penunjang Medis secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
5	Kabid Umum	Unit Kabid Umum & Keuangan secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
6	Casemix Manager	Unit Satuan Pengawas Internal secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
7	Farmasi	Unit Farmasi secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
8	Asuransi Center	Unit Asuransi Center secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
9	CSSD	Unit CSSD secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
10	Fisioterapi	Unit Fisioterapi secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
11	Gizi	Unit Gizi secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.

12	Humas & Marketing & PKRS	Unit Humas Markrting & PKRS secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
13	ICU dan HCU	Unit ICU & HCU secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
14	IGD	Unit IGD secara keseluruhan mendapatcatatan baik dalam penilaian kinerja umum.
15	IKO	Unit IKO secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
16	IPCN	Unit IPCNsecara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
17	IPSRS	Unit IPSRS secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
18	IRJA	Unit IRJA secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
18	IRNA 2C	Unit IRNA 2C secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
19	IRNA 2A, 3A, & 4A	Unit IRNA 234A secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
20	IRNA 3C Anak	Unit IRNA 3C Anak secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
21	IRNA 5C	Unit IRNA 5C secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
22	IRNA 6A, 7A, & 8A	Unit IRNA 6A, 7A & 8A secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
23	Maternitas	Unit Maternitas secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
24	Neonatologi	Unit Neonatologi secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
25	Keuangan & Akuntansi	Unit Keuangan secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
26	Laboratorium	Unit Laboratorium secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
27	Laundry	Unit Laundry secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
28	Rekam Medis	Unit Rekam Medis secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
29	Pendaftaran	Unit Pendaftaran secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
30	PIPP & MPP	Unit PIPP secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum. Terdapat 1 staf dengan evaluasi kinerja sangat kurang dikarenakan cuti melahirkan.
31	PMKP	Unit Mutu & PMKP secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
32	Radiologi	Unit radiologi secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
33	SDM	Unit SDM secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
34	Sekretaris	Unit Sekretaris secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
35	SIMRS & IT	Unit IT SIMRS secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.

36	Umum & Rumah Tangga	Unit IRJA secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
37	Cleaning Service	Unit Cleaning Service secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
38	Security	Unit Security secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
39	Driver	Unit Driver secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
40	Gudang Umum	Unit Gudang Umum secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.

Analisis :
Hampir seluruh unit di RS Prima Husada Malang berada pada kategori baik.

Grafik Evaluasi Kinerja 2025



Evaluasi Kinerja Karyawan 2025

Kategori	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Sangat Baik	81	78	322	318	333	309	298	276	295	161	195	252
Baik	262	270	73	71	51	79	80	88	66	192	159	99
Cukup	51	46	3	4	2	1	4	7	5	12	9	4
Kurang	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1
Sangat Kurang	4	4	2	5	4	1	1	2	2	2	5	9
Total	399	399	400	318	391	391	384	373	369	368	368	365

Analisa :
Secara umum terdapat penurunan kategori sangat baik ke baik akibat tidak adanya diklat seluruh staf di bulan November 2025 dan adanya peningkatan keterlambatan karyawan.

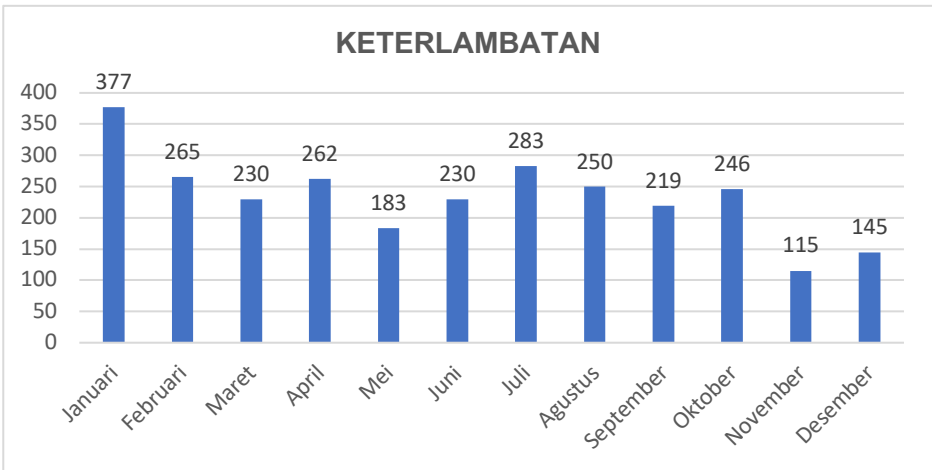
Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Sosialisasi kepada Karu dan Kabid untuk mengingatkan kembali kepada stafnya.
- 2. Melakukan tahapan teguran sesuai taat tertib yang berlaku.
- 3. Mempertahankan kinerja staf terkait kedisiplinan.
- 4. Membuat diklat dengan konsep baru sesuai arahan PT

Tabel Keterlambatan Karyawan Rumah Sakit

	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
KETERLAMBATAN	377	265	230	262	183	230	283	250	219	246	115	145

Grafik Keterlambatan Karyawan



Analisa :

Secara umum terdapat progress penurunand I tahun 2025

Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Sosialisasi kepada Karu dan Kabid untuk mengingatkan kembali kepada stafnya.
- 2. Melakukan tahapan teguran sesuai taat tertib yang berlaku.
- 3. Mempertahankan kinerja staf terkait kedisiplinan.

3.2. Pengembangan Pelayanan

NO	UNIT	PENGEMBANGAN PELAYANAN
BIDANG UMUM		
1.	SDM	1. Peningkatan Konseling 2. Peningkatan Supervisi 3. Penegakan Tata Tertib
2.	IPSRs	1. Pelaporan by SIMIPSRs 2. Aplikasi Pemeliharaan AC 3. Aplikasi Monitoring KWH Meter ATM, Suhu Ruangan UPS, Outlet IPAL, Oulet Air Bersih
3.	Security	1. Penertiban Jam Berkunjung Pasien 2. Kartu Tanda Penunggu Pasien 3. Pelayanan Terpadu Poli Berintegritas 4. Checklist sarana pemantauan CCTV

4.	Humas Marketing	1. Target vaksin internasional 1.800 pasien / tahun 2. Saluran WA Channel dengan 240 (Target subscriber pertahun) 3. Pengembangan Tiktok RS dengan 240 (Target subscriber pertahun)
5.	Cleaning Service (CS)	1. Penambahan wash bag kerja 2. Pengajuan pembelian alat kebersihan carpet extractor 3. Pengajuan Alat pembersih kaca candela model spin 4. Pelatihan manajemen cleaning service Rumah Sakit 5. Pengajuan maintenance alat kebersihan cleaning service 6. Pembursakan matras penunggu dan bed pasien
6.	IT	1. Pengembangan APM (Kiosk Mandiri) 2. Peremajaan PC dan Printer
BIDANG PELAYANAN		
1.	IRJA	1. Meningkatkan jumlah kunjungan pasien Poliklinik Sakura dengan adanya promo injeksi wegovy untuk pasien obesitas dan DM 2. Meningkatkan jumlah kunjungan pasien Poli Ortodonti (UMUM dan Asuransi) dengan pembuatan tarif khusus ortodonti dan pengadaan alat BMHP ortodonti 3. Meningkatkan jumlah kunjungan pasien Poli Konservasi gigi dengan ditunjang rontgen periapical 4. Meningkatkan jumlah kunjungan pasien poli vaksin (vaksin internasional maupun vaksin paten di poli anak) dengan adanya promo-promo menarik
1.	IRNA	Meningkatkan kualitas foto estetik bayi baru lahir dengan custom baru (foto dengan orangtuanya) khusus untuk pasien SC ERACHS, Asuransi dan Operasi UMUM.
3.	IKO	Meningkatkan kualitas bedah saraf dengan pengadaan Bor Craniotomy Elektrik
4.	IGD	1. Meningkatkan jumlah pasien IGD terutama pasien non BPJS Kesehatan (umum, asuransi, JR dan JKK) 2. Meningkatkan jumlah pasien trauma dengan responsif untuk penerimaan rujukan dari resita, Jasa marga dengan branding trauma center 3. Mempercepat pelayanan di IGD baik rawat jalan maupun rawat inap
BIDANG PENUNJANG		
1.	Rekam Medis	1. Memaksimalkan minim penggunaan kertas dan beralih ke sistem ERM , hard copy yang ada di rak akan di retensi jika sudah inaktiv, Serta Memaksimalkan Memasukan DRM yang belum memakai RM-e (hard copy yang ada di rak) di masukan ke dalam sistem SIMRS, sehingga rak tidak penuh 2. SIMRS a. Pembaharuan vitur sistem informasi rumah sakit secara berkala berdasarkan kebutuhan agar tercapainya sistem informasi yang valid dan terintegrasi. 3. ERM

		a. Pengembangan pelayanan Poli Rawat jalan yang sudah 100% berjalan dan akan di kembangkan terus sesuai dengan kebutuhan b. Pengembangan pelayanan ERM di rawat inap sudah merancang serta memasukan soft file “form rekam medis” yang di butuhkan untuk pencatatan di dalam sistem ERM yang akan ada target awal januari sudah bisa triyal . c. Ruangans tersendiri untuk rekam medis .
2.	Pendaftaran	Penambahan mesin APM yang merupakan mesin kios digital yang memungkinkan pasien untuk melakukan pendaftaran rawat jalan secara mandiri, tanpa perlu mengantre di loket
3	Laboratorium	a. Pengadaan Bank Darah Rumah sakit “BDRS” Berjalan dropping di mulai pada bulan November 2024 b. Pemantapan Mutu Eksternal (PME) PDS PATKLIN Laboratorium dilakukan Pengajuan ke direktur RS c. Pelatihan Plebotomi dilakukan Pengajuan ke direktur RS
4	Gizi	1) Pengaktifan poli gizi di rawat jalan: Poli gizi pada bulan Tahun 2025 sesuai target yaitu >5 orang per bulan yang melakukan konseling gizi. 2) QC sesuai sistem HACCP: a. Pelatihan HACCP dilakukan oleh seluruh Ahli Giz b. Memastikan proses quality control makanan sesuai standar c. Memastikan 7 prinsip HACCP. d. Koordinasi dengan SDM jika ada informasi terkait pelatihan tersebut. 3) Pemesanan diet melalui Whatsapp dan spreadsheet: a. Memastikan proses pemesanan diet lebih efisien dan mengurangi kesalahan pemesanan diet. b. Ahli gizi mengkonfirmasi diet di grup whatsapp jika ada penambahan diet/ganti diet saat selesai visitasi di ruangan. c. Proses cetak label langsung efisien sesuai dengan diet ter update 4) Pengaktifan kembali pembelian susu pasien dengan diet khusus di Apotek RS Prima Husada Malang: a. DPJP Menentukan diet pasien (diet cair) b. Ahli gizi mengedukasi diet pasien c. Ahli gizi melakukan edukasi pembelian susu di apoteker RS d. Ahli gizi memberikan resep pembelian susu
5	CSSD - Laundry	1) Adanya proses alat dan linen sterilisasi di unit CSSD dan Laundry a. Dengan adanya sterilisasi terpusat maka semua proses steril dan bahan steril terpusat di unit CSSD b. Terpusatnya semua instrument steril di unit CSSD, sedangkan untuk linen yang baik,dan pelayanan linen umum di kelola oleh unit Laundry.

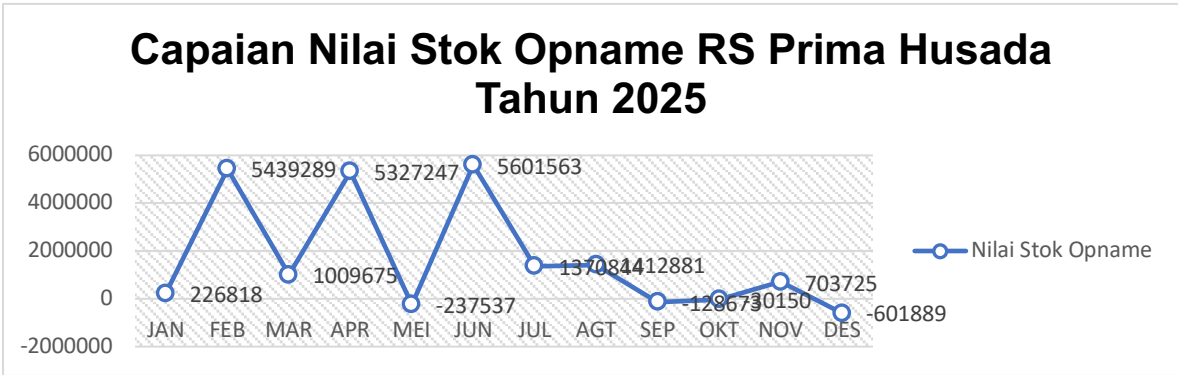
		c. Terpusatnya semua pengelolaan instrument di unit CSSD dan untuk unit Laundry linen yang rusak sudah tidak di gunakan lagi. d. Proses pencuciaan dan pengeringan linen sudah menggunakan mesin industry dan menggunakan dispenser otomatis. e. Serah terima sudah mulai menggunakan <i>google</i>. sudah di stok 3 PAR di Laundry f. Pencatatan BMHP laundry dan CSSD semua di lakukan by google form 2) Penggunaan dosis chemical laundry sudah menggunakan dispenser
--	--	---

3.3. Kinerja Produktifitas Unit dan Instalasi

3.3.1. Farmasi

3.3.1.1 Hasil Stok Opname Instalasi Farmasi Selama Tahun 2025

Grafik Capaian Nilai Stok Opname Instalasi Farmasi Selama Tahun 2025



Analisa :

- Selisih stok opname mengalami fluktuatif dari segi jumlah dan nominal pada setiap bulan karena adanya perubahan alur serta sistem stok opname, human error, dan system error.
- Terdapat master barang belum di tambahkan master rak di SIMRS, sehingga stok tidak diinput ketika stok opname.
- Gudang farmasi belum release pengeluaran barang di SIMRS sehingga menyebabkan selisih kurang.
- Kesalahan pengadaan PT dalam input master sediaan farmasi F04613 Fluconazole tab 150 mg – nulab Rak Obat Oral Generik satuan. Seharusnya 1 box isi 10 tab, sebelumnya terinput 1 box isi 30 tab menyebabkan adanya selisih stock 100 tab.
- Kesalahan penginputan master barang saat penerimaan barang pada SIMRS.
- Kesalahan perhitungan satuan terkecil.
- Stok paket dan box emergency tidak terhitung pada SO
- Ketidaksesuaian antara inputan resep dan barang yang diberikan disebabkan perbedaan nama barang sama namun beda pabrik atau beda ukuran yang digunakan.
- Ketidaksesuaian antara inputan merk saat stok opname dan merk sesuai fisik karena nama barang sama namun beda pabrik.
- Ditemukan hasil verifikasi SO oleh auditor PT. DPM tidak ditemukan selisih sehingga tidak ada arahan dari auditor untuk di cek perhitungan ulang jadi hanya dilakukan random stok barang lain. Namun setelah dilakukan tarikan laporan SO ditemukan selisih dan sudah dilakukan pehitungan ulang besok harinya stoknya sesuai dan ternyata petugas salah input jumlah SO.

11. F02985 Vaseline album – Brataco selisih lebih 602 gram karena termasuk barang untuk racikan salep sesuai peresepan dokter namun farmasi menyiapkan tidak di timbang pada timbangan digital sehingga terjadi selisih lebih (menyesuaikan ukuran pot salep).
12. Terdapat selisih koma dikarenakan salah penginputan pada saat meresepi obat dan tidak dikoreksi kembali oleh Apoteker.
13. Ketidaksesuaian dalam proses INPUT dan SIAP menyebabkan kesalahan dalam jumlah obat yang di input dan disiapkan, yang seharusnya dapat dihindari dengan melakukan double check.
14. Ketidaksesuaian antara barang yang diambil perawat IGD menggunakan resep manual dengan inputan resep di SIMRS.
15. Selisih lebih terjadi karena proses retur ODD harian yang tidak optimal dari rawat inap (Resep ODD harian tidak diinput retur di SIMRS oleh perawat IRNA sementara pasien sudah KRS).
16. Kesalahan dalam perhitungan buffer stok tidak sesuai.
17. BMHP dan obat yang diambil perawat untuk tindakan di Poli Rawat Jalan tidak segera dikembalikan saat poli selesai dan hutang inputan resep menyebabkan selisih kurang.
18. Ditemukan 8 item barang IKO yang selisih lebih masing-masing satu. Setelah di cek di monitoring stok terdapat anomali selisih dimana monitoring stok (sisa akhir) dengan stok sistem SO tidak sama (SO Juni 2025).
19. F00366 Human Albumin 20% tidak terinput stok opname, karena pengadaan mengaktifkan master F00366 namun belum menambahkan rak kulkas pada sistem yang seharusnya bisa menggunakan master barang F00112 Cairan Inf Human Albumin 20% - Kimia Farma sehingga terjadi double master (SO November 2025).

Rencana Tindak Lanjut:

1. Menertibkan penulisan kartu stok.
2. Kepala instalasi mengecek master barang dan koordinasi dengan Pengadaan PT. DPM untuk menambahkan master barang belum di tambahkan master rak di SIMRS.
3. Penggunaan scan barcode atau RFID dalam proses serah terima barang → follow up ke programmer terkait dengan program scan, pelaksanaan double check oleh petugas gudang dan unit, dan dilakukan retur barang unit jika tidak diambil oleh unit.
4. Koordinasi dengan Pengadaan PT untuk merubah master barang.
5. Meningkatkan ketelitian pada SDM saat melakukan input permintaan pembelian di SIMRS dan penerimaan barang dari distributor.
6. Meningkatkan ketelitian pada SDM sehingga meminimalisir kesalahan perhitungan stock.
7. Dilakukan pemahaman kembali pelaksanaan SO bahwa semua stok paket, FS, dan box emergency di tulis terpisah stoknya di lembar kerja tanpa akumulasi jumlah stok paket, FS, box emergency dengan jumlah stok yang ada di depo.
8. Memperbaiki sistem pengeluaran barang dari gudang ketika ada nama barang sama namun beda pabrik dengan memastikan stok depo dihabiskan terlebih dahulu sebelum dinonaktifkan, sosialisasi kepada perawat perbaikan fitur pencarian dalam SIMRS untuk meningkatkan akurasi pemilihan barang, dan memperbaiki sistem penyiapan barang bertanggungjawab atas input penjualan.
9. Pengadaan PT. DPM melakukan penyesuaian master barang dan produsen pada sistem dan pengajuan fitur laporan persediaan “kertas kerja stok opname” sehingga master barang yang aktif selalu update di kertas kerja.
10. Membuat berita acara penyesuaian stok opname dan koordinasi dengan progamer untuk penyesuaian stok.
11. Dilakukan pemahaman kembali proses penyiapan racikan salep vaselin album sesuai alur (ditimbang pada timbangan digital sesuai peresepan dokter) dan dilakukan supervisi berkala oleh Kains Farmasi.

-
12. Programmer menerapkan fitur kuantitas dengan nilai di belakang koma hanya berlaku untuk barang farmasi yang sharing dose untuk menghindari kesalahan inputan barang farmasi non sharing dose.
 13. Double check wajib dilakukan dengan alur kerja ISEP obat yang sudah ditentukan, supervisi oleh kains farmasi terkait penyiapan obat hingga alur penyerahan secara berkala, monitoring dan evaluasi oleh Kabid terkait dengan proses Input hingga penyerahan obat. Jika ada kesalahan dalam proses langsung di tegur dan langsung diperbaiki.
 14. Penegasan kembali kepada perawat IGD terkait kewajiban penulisan resep yang sesuai → kolaborasi dengan Karu IGD, petugas farmasi wajib double crosscheck sebelum obat atau BMHP di serahkan dan supervisi oleh kains farmasi, perbaikan alur resep akan diarsipkan oleh Petugas Farmasi dan dilakukan double crosscheck, jika ada yang belum terinput maka akan dishare di Grup dan meminta bukti inputan.
 15. Dilakukan pemahaman kembali proses return sesuai alur dan dilakukan supervisi berkala oleh Karu IRNA dan PJ Shift ruangan untuk mengontrol terkait proses return ke farmasi sesuai dengan alur yang sudah di sepakati, melakukan double crosscheck oleh petugas farmasi saat akan melakukan return di supervisi setiap hari oleh kains farmasi, melakukan audit dan evaluasi berkala oleh Kabid keperawatan dan Kabid penunjang terkait obat-obatan yang belum tereturn sesuai dengan alur.
 16. Perbaikan penataan ulang buffer stok sesuai rak di ruang buffer stok (sesuai alfabetis dan penggolongan obat), dan penambahan lemari buffer stok di ruang buffer agar buffer tidak di tumpuk di dalam kardus.
 17. Koordinasi dengan kepala bidang dan kepala ruang terkait alur serah terima BMHP untuk tindakan di Poli Rawat Jalan.
 18. Koordinasi dengan progamer PT untuk telusur. Hasil tindak lanjut progamer memperbaiki sistem stok mutase.
 19. Pengadaan koordinasi ke kains untuk melakukan double check master barang ketika diaktifkan.

Tabel Jumlah Resep Menurut Pelayanan Obat Racikan dan Obat Jadi Instalasi di Rumah Sakit Prima Husada Tahun 2025

Jenis Resep	Januari		Februari		Maret		April		Mei		Juni		Juli		Agustus		September		Oktober		November		Desember	
	Obat Racikan	Obat Jadi	Obat Racikan	Obat Jadi	Obat Racikan	Obat Jadi	Obat Racikan	Obat Jadi	Obat Racikan	Obat Jadi	Obat Racikan	Obat Jadi	Obat Racikan	Obat Jadi	Obat Racikan	Obat Jadi	Obat Racikan	Obat Jadi	Obat Racikan	Obat Jadi	Obat Racikan	Obat Jadi	Obat Racikan	Obat Jadi
Rawat Inap	216	8.639	195	8.229	220	8.506	207	9.245	164	9.011	146	8.274	260	8864	292	9.013	254	7606	273	8.023	313	8.367	249	8.683
IGD	133	2.225	84	1.944	122	1.940	94	2.073	87	2.028	99	2.282	78	2.477	112	2.465	121	2505	107	2.660	162	3.399	143	3.566
Rawat Jalan	2.005	7.929	1.726	7.389	1.686	7.529	1.676	7.533	1.590	7.611	1.512	7.322	1.803	7.994	1.757	7.220	1.851	7.835	1.861	8.084	1.829	7.668	1.834	8.483
IKO	0	899	0	794	0	919	0	1.058	0	1.045	0	996	0	1.142	0	1.051	0	1.025	0	1.049	0	1.082	0	1.157
Total	22.046		20.361		20.922		21.886		21.536		20.631		22.618		21.912		21.197		22.057		22.820		24.115	

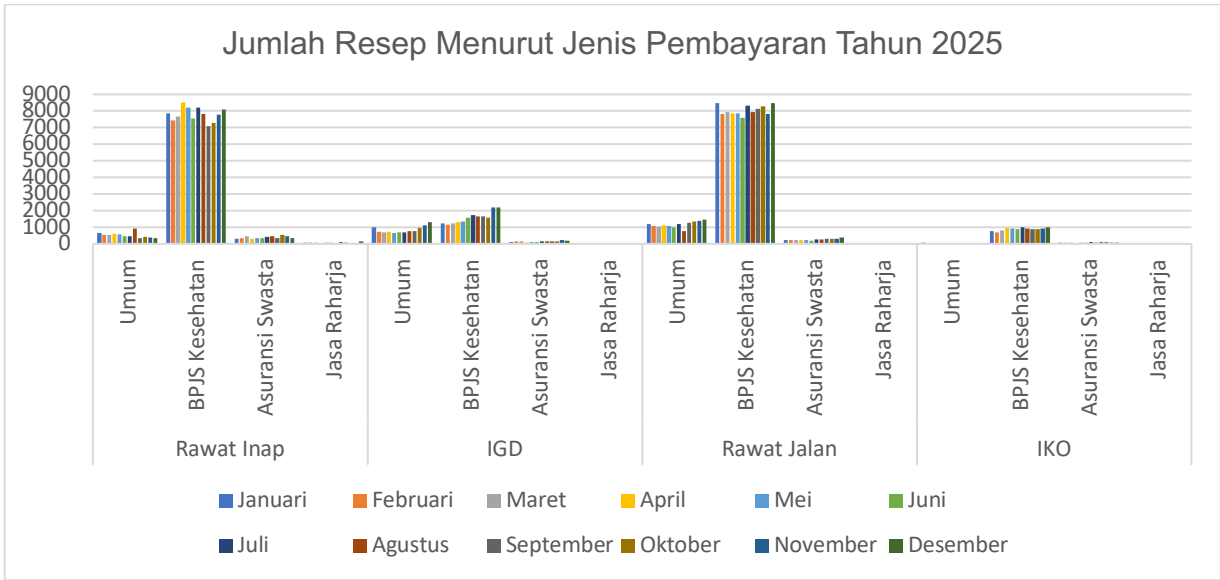
Grafik Jumlah Resep Menurut Bentuk Sediaan Instalasi di Rumah Sakit Prima Husada Tahun 2025



Tabel Jumlah Resep Menurut Jenis Pembayaran Instalasi di Rumah Sakit Prima Husada Tahun 2025

No	Unit	Bulan Ke-											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
1	Rawat Inap												
	Umum	656	547	523	598	567	444	452	919	325	429	391	362
	BPJS Kesehatan	7.847	7.434	7.659	8.519	8.197	7.563	8.219	7.832	7.106	7.294	7.800	8.084
	Asuransi Swasta	296	352	462	293	340	325	431	456	359	529	444	351
	Jasa Raharja	56	91	82	42	71	88	22	98	70	44	45	135
2	IGD												
	Umum	998	743	674	740	648	672	693	750	784	976	1.132	1.299
	BPJS Kesehatan	1.226	1.137	1.246	1.322	1.336	1.575	1.712	1.647	1.666	1.594	2.196	2.195
	Asuransi Swasta	123	132	132	88	117	115	139	154	149	159	213	178
	Jasa Raharja	11	16	10	17	14	19	11	26	27	38	20	37
3	Rawat Jalan												
	Umum	1.208	1.060	1.056	1.123	1.079	1.015	1.198	770	1.270	1.349	1.374	1.465
	BPJS Kesehatan	8.476	7.802	7.933	7.855	7.877	7.607	8.312	7.917	8.113	8.292	7.826	8.460
	Asuransi Swasta	243	246	220	227	239	204	285	283	293	300	292	388
	Jasa Raharja	7	7	6	4	6	8	2	9	10	4	5	4
4	IKO												
	Umum	60	26	26	50	25	26	44	29	26	49	45	22
	BPJS Kesehatan	760	684	799	948	922	883	992	907	870	879	926	1.010
	Asuransi Swasta	62	55	82	42	65	58	100	85	94	95	90	75
	Jasa Raharja	17	29	12	18	33	29	6	30	35	26	21	50

Grafik Jumlah Resep Menurut Jenis Pembayaran Instalasi di Rumah Sakit Prima Husada Tahun 2025



Analisa :

1. Dari data diatas diketahui bahwa jumlah resep setiap bulan mengalami perbedaan naik-turun berbanding lurus dengan jumlah kunjungan pasien.
2. Perbedaan jumlah resep dapat disebabkan dari berbagai hal seperti :
 - a) Kunjungan pasien rawat jalan, IGD, IKO, pasien rawat inap dengan penjamin BPJS Ketenagakerjaan dan Asuransi lebih memilih menggunakan BPJS Kesehatan sebagai pilihan utama dibandingkan Asuransi Swasta dimana benefit yang didapat sesuai dengan diagnosa yang tertera pada polis asuransi, dan berpotensi selisih biaya di akhir perawatan;
 - b) Adanya batasan plafon BPJS Kesehatan sehingga tidak semua obat dapat di cover sesuai kebutuhan pasien dengan pertimbangan biaya obat untuk pasien rawat inap;
 - c) Target PRB rawat jalan dimana pasien rujuk balik ke FKTP dikarenakan pasien sudah stabil;
 - d) Retur obat tertinggal rawat jalan yang tidak diambil pasien sehingga dilakukan penerimaan obat hibah lainnya;
 - e) Jumlah dokter yang tidak praktek atau izin atau cuti;
 - f) Jumlah tanggal merah atau hari libur pada bulan tersebut;
 - g) Harga poli sakura/ jasa dokter yang cukup mahal sehingga kunjungan pasien umum sering mengalami penurunan;
 - h) Kurangnya promo tarif vaksin di poli.

Rencana Tindak Lanjut :

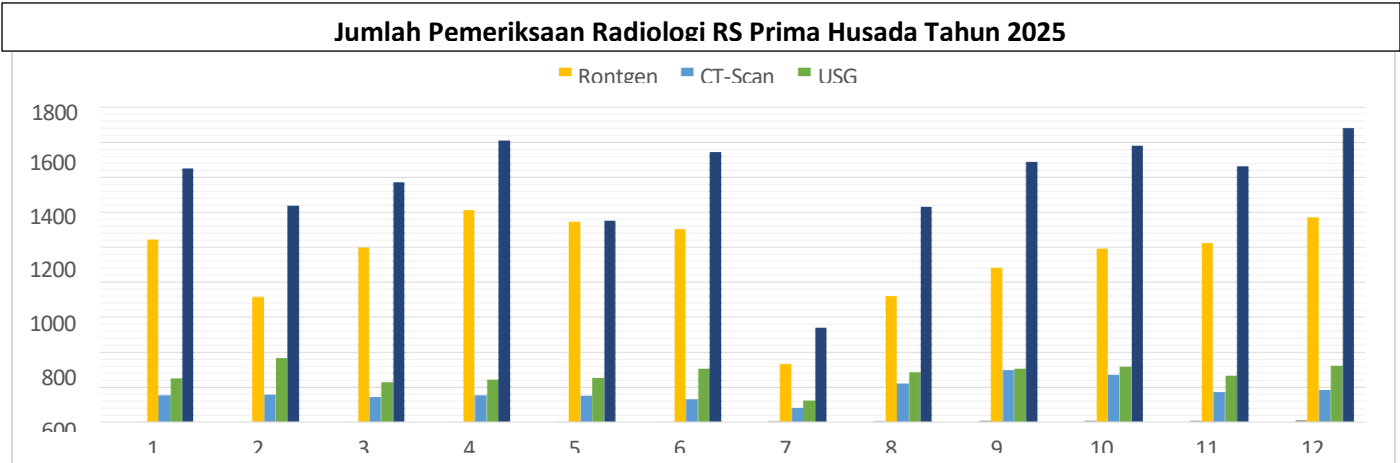
1. Meningkatkan promosi tarif dan tindakan RS di sosial media RS agar kunjungan pasien meningkat.
2. Meningkatkan pelayanan resep yang tepat, cepat, dan akurat sehingga meningkatkan kepuasan pasien terhadap pelayanan di Farmasi.
3. Menciptakan inovasi pengembangan pelayanan pengantaran obat dengan penambahan jumlah driver.
4. Kolaborasi dengan Petugas Pendaftaran IGD untuk menjaring pasien-pasien yang mempunyai jaminan Kesehatan lebih dari 1 untuk menggunakan asuransi swasta terlebih dulu.
5. Koordinasi dengan programmer menciptakan website primantara untuk memudahkan pendaftaran pasien.
6. Kebijakan pengambilan obat maksimal 2x24 jam menghindari penumpukan obat tertinggal yang mengakibatkan retur penjualan.
7. Mengadakan promo pelayanan pengantaran obat untuk pengguna baru.

3.3.2 Radiologi

Tabel Jumlah Pemeriksaan Radiologi Selama Tahun 2025

Pemeriksaan	Jumlah Pemeriksaan												KET
	Bulan Ke-												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Rontgen	1.044	715	998	1.211	1.147	1.106	334	722	884	993	1.026	1.173	
CT-Scan	155	156	144	155	152	133	82	223	298	273	171	185	
USG	252	366	230	245	254	306	124	286	306	316	266	324	
Total	1.451	1.237	1.372	1.611	1.153	1.545	540	1.231	1.488	1.582	1.463	1.682	
TOTAL TAHUN 2025 16.355 Pasien													

Grafik Jumlah Pemeriksaan Radiologi Selama Tahun 2025



Analisa :

Pelayan pemeriksaan pada tahun 2025 meliputi USG, CT-Scan, dan Rontgen terbagi menjadi pasien Umum, BPJS, Asuransi dan MCU (Medical Check Up). Pada tahun 2025 pemeriksaan terbanyak yaitu pada bulan Desember sebanyak 1.682 pasien. Serta kunjungan radiologi menurun pada bulan Juli yaitu sebanyak 540 pasien. Jumlah total keseluruhan pelayan di Instalasi Radiologi tahun 2025 sebanyak 16.355 pasien, meningkat dibandingkan dengan tahun 2024 sebanyak 15.805 pasien.

Tindak Lanjut:

- Optimalisasi Pelayanan pada Bulan dengan Kunjungan Tinggi (Desember)
Dengan:
 - Penambahan jadwal layanan dan jam operasional.
 - Penyesuaian jumlah SDM (radiografer, dokter radiologi, administrasi).
- Evaluasi Penurunan Kunjungan pada Bulan Juli dengan menganalisis penyebab penurunan (libur panjang, rujukan, alat, SDM). Koordinasi dengan unit terkait dan fasilitas perujuk.
- Peningkatan Promosi dan Kerja Sama Layanan dengan melakukan Sosialisasi layanan USG, CT-Scan, dan Rontgen ke poli dan faskes rujukan.
Penguatan kerja sama BPJS, asuransi, dan layanan MCU.
- Pemeliharaan dan Kesiapan Alat Radiologi dengan melakukan Maintenance rutin dan kalibrasi alat dan Antisipasi downtime alat.
- Monitoring dan Evaluasi Berkala jumlah kunjungan per bulan. Evaluasi capaian dibandingkan tahun sebelumnya.

3.3.3 Laboratorium

Tabel Daftar Pemeriksaan Laboratorium yang Dilakukan Didalam dan Diluar RS Selama Tahun 2025

	TARGET	JUMLAH PEMERIKSAAN LABORATORIUM TAHUN 2025	(PERSENTASE TERHADAP TARGET)
HEMATOLOGI	23.403	22.220	<5,05%
FAAL HEMOSTASIS	8.602	8.919	>3,44%
HEMATOLOGI LAIN	20	15	<25%
URINALISIS	5.019	3.538	<29,5%
ANALISA FEACES	355	118	<66,7%
FUNGSI HATI	7.334	4.208	<42,6%
LEMAK DARAH	9.679	9.221	<4,7%
GINJAL HIPERTENSI	16.735	16.288	<2,6%
GULA DARAH	14.249	21.659	>34,2%
JANTUNG	7.005	6.724	<4,01%
ELEKTROLIT DAN BGA	4.099	2.707	<33,9%
IMUNO SEROLOGI	5.776	4.926	<14,7%
REMATIK	74	17	<77,0%
ENDOKRINOLOGI	720	843	>14,5%
REPRODUKSI	532	575	>7,4%
MIKROBIOLOGI	387	580	>33,2%
PATOLOGI ANATOMI	781	874	>10,6%
Jumlah	104.770	103.432	<1,27%

Analisa :
Pada tahun 2025 jumlah pemeriksaan laoboratorium 1,27% di bawah target yang di tetapkan.

Rencana Tindak Lanjut :
Memberikan pelayanan yang lebih baik lagi supaya kunjungan ke Laboratorium meningkat di tahun 2026

3.3.4 Rekam Medis

Tabel Diagnosa terbanyak di Rawat Jalan pada Tahun 2025

NO	Code ICD 10	DIAGNOSIS	JUMLAH
1	E11.9	DM Tanpa komplikasi / Without complications	4574
2	I51.9	Decomp Cordis / Heart disease, unspecified	3955
3	I11.9	HHD / Hypertensive heart disease without (congestive) heart failure	3594
4	I25.9	Chronic ischemic heart disease, unspecified	3583
5	E11.4	With neurological complications	3564
6	I63.9	CVA Infark / Cerebral infarction, unspecified	2481
7	J47	Bronchiectasis	2423
8	J44.9	COPD / Chronic obstructive pulmonary disease, unspecified	2316
9	R50.9	Fever, unspecified	2115
10	K04.1	Necrosis of pulp	1937

Analisis :

Dari rekapan dan perbandingan tahun 2024 ke 2025 menurun untuk pasien penderita DM , 2024 di nilai (8153) dan di 2025 turun (4574) pasien dari analisis tabel 3.3.3.1 menunjukan bahwa ada penurunan penderita DM sebanyak 44% . (3579 psien)
Rms : (Jumlah px DM 2025-Jumlah px DM 2024)/Jumlah px DM 2024 X 100%

Masalah :

Karena pasien semakin banyak di tahun 2024 untuk penderita DM pun juga semakin meningkat, kurangnya

Rencana Tindak Lanjut:

- 1. Menyediakan data pasien dan no telfon untuk tindak lanjut ke bagian manajemen data tersebut bisa dilakukan untuk tindak lanjut ke bagian management,seperti melakukan :
 - a. Diadakan program senam kaki untuk penderita DM
 - b. Membagikan leaflet tentang senam kaki DM
- 2. Hasil dari follow up humas dan marketing :
 - a. Senam diabetes melitus nanti bisa di agendakan di acara senam geriatric
 - b. Program pemeriksaan gula darah juga sudah dilakukan
 - c. Leaflet mengenai DM sudah tersebar di seluruh unit rawat inap
 - d. Apakah ada komunitas, dan DM

Tabel Diagnosa Terbanyak di Rawat Inap pada Tahun 2025

NO	DIAGNOSA	KODE ICD-10	JUMLAH
1	Typhoid Fever	A01.0	2620
2	Cerebral infarction, unspecified	I63.9	519
3	Pneumonia	J18.9	469
4	Dengue Fever	A90	403
5	DM Tanpa komplikasi / Without complications	E11.9	371
6	Unspecified diabetes mellitus without complications	E14.9	248
7	Bronchopneumonia	J18.0	170
8	Gastroenteritis and colitis of unspecified origin	A09.9	150
9	Necrotizing fasciitis	M72.6	149
10	Calculus of kidney	N20.0	132

Analisis :

Diagnosa tertinggi rawat inap tahun 2025 adalah Typhoid Fever sebanyak 2620 pasien

Masalah : -

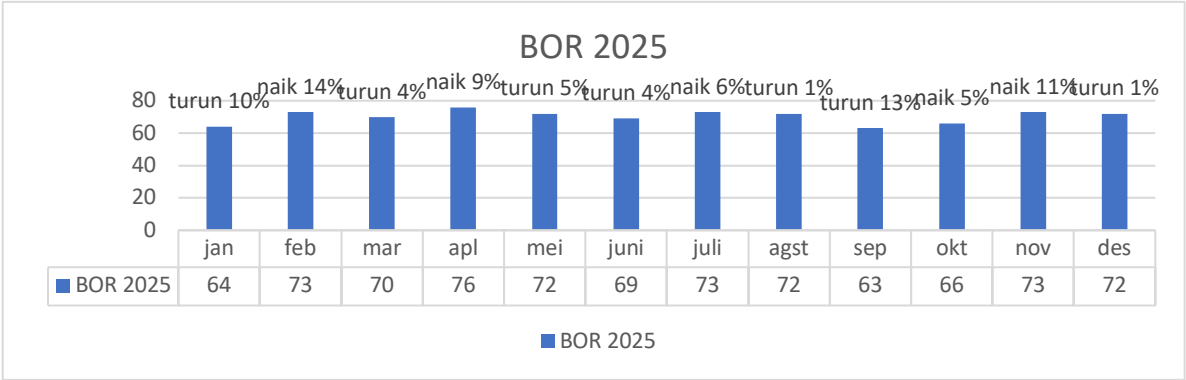
Rencana Tindak Lanjut : -

Tabel Capaian Kegiatan Kinerja Produktivitas Rekam Medis tahun 2025

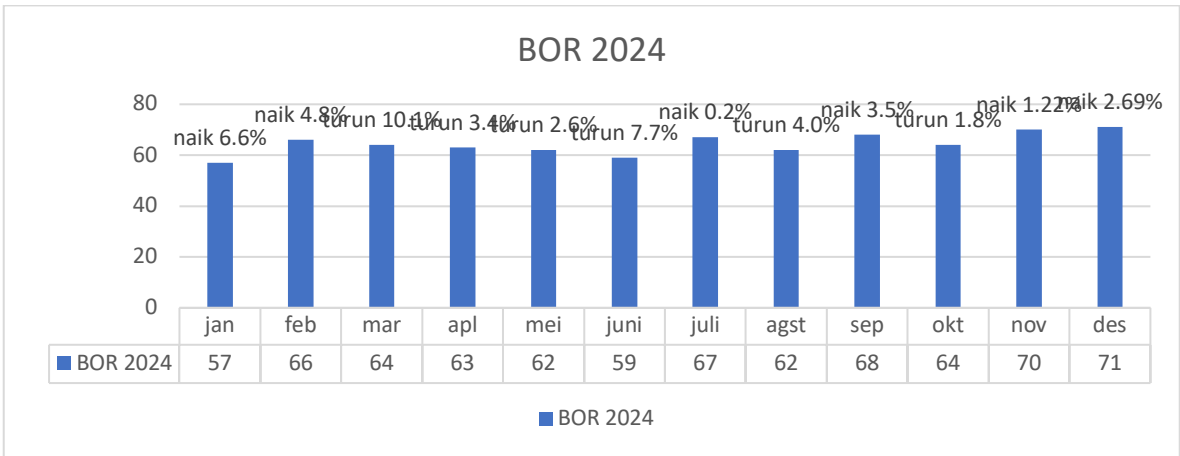
NO	JENIS PELAYANAN 2025	BOR	ALOS	TOI	BTO	NDR	GDR
1	Januari	64%	3	1	9	15%	15%
2	Februari	73%	3	1	8	15%	15%
3	Maret	70%	3	1	9	10%	10%
4	April	76%	3	1	10	19%	19%
5	Mei	72%	3	1	10	27%	27%

6	Juni	69%	3	1	9	26%	26%
7	Juli	73%	3	1	10	17%	17%
8	Agustus	72%	3	1	10	19%	19%
9	September	63%	3	1	9	24%	24%
10	Oktober	66%	3	1	9	19%	18%
11	November	73%	3	1	10	13%	13%
12	Desember	72%	3	1	9	23%	23%
Total rata rata 1 tahun 2025		70%	3	1	9	19%	19%

Grafik 1 Capaian Kegiatan Kinerja Produktivitas Rekam Medis BOR tahun 2025



Grafik 2 Capaian kegiatan kinerja produktifitas rekam medis BOR tahun 2024



Analisis :

- a. Pada grafik 3.3.1 diatas tampak bahwa pencapaian BOR pada tahun 2025 naik turun, rata rata BOR tahun 2025 adalah 70%, dinilai ini perlu dipertahankan. Akan tetapi 3 bulan terakhir pada bulan oktober (66%), november (73%) dan desember (72%), BOR rumah sakit mengalami penurunan yang cukup rendah pada bulan januari 64%. Rata rata BOR di tahun 2025 adalah (70%),

Adapun tabel analisa perbandingan tahun 2024 ke 2025, sebagai berikut :

BULAN	PERBANDINGAN TAHUN 2024 KE 2025				
	Jumlah pasien	BOR 2024	Jumlah pasien	BOR 2025	KETERANGAN
Jan	1148	57%	1218	64%	Naik 10.94%
Feb	1206	66%	1076	73%	Naik 9,59%
Mar	1341	64%	1216	70%	Naik 8,57%
Aprl	1297	63%	1270	76%	Naik 17.11%

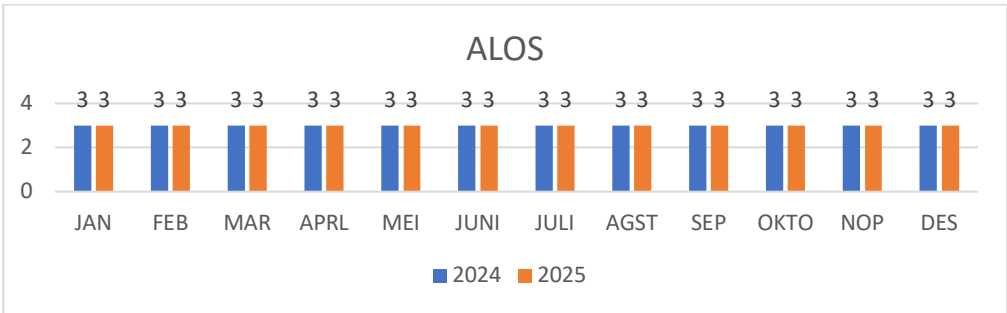
Mei	1332	62%	1269	72%	Naik 13.89%
Juni	1237	59%	1194	69%	Naik 14.49%
Juli	1240	67%	1294	73%	Naik 8.22%
Agst	1192	62%	1293	72%	Naik 13.89%
Sep	1235	68%	1173	63%	Turun 7,94%
Okt	1213	64%	1220	66%	Naik 3,03%
Nov	1228	70%	1253	73%	Naik 4,11%
Des	1262	71%	1263	72%	Naik 1,39%

Rms : $(2025-2024)/2024*100\%$

- Masalah :
- a. Terjadi penurunan BOR yang paling rendah di bulan september (63%) hal ini di sebabkan penurunan jumlah kunjungan pasien di awal tahun, dikarenakan salah satunya adalah kebijakan terkait sistem proporsi ,dan yang masih berimbas di awal tahun 2025 menolak pasien dan dari IGD sudah dirujuk ke rs lain
 - b. Jumlah rujukan ke rumah sakit prima husada dari faskes tingkat 1 menurun.
 - c. Ada beberapa dokter resign, umroh, naik haji, cuti melahirkan dan tugas luar negeri antara lain :
 1. dr. Andira Aulia Rahmah (resign)
 2. dr. Sofia Intani Putri (resign)
 3. dr. M noeryanto, Sp.OG (resign)
 4. dr. Adhya Aji Pratama Sp. PD (umroh)
 5. dr. Heriyatmo Sp. PD (naik haji)
 6. dr. Nur Rohman (resign)
 7. dr. Fiona Paramitha Sp.A (cuti melahirkan)
 8. dr. Ratih Kusumawardani Sp.A.,M.Biomed (cuti melahirkan)
 9. Dr. dr. Mohammad Kuntadi Syamsul Hidayat Sp. OT, M.Kes., MMR (tugas luar negeri ke gaza)

- Rencana Tindak Lanjut :
- a. Mendatangi DPJP untuk menjelaskan terkait sistem proporsi,serta memperbaiki SOP penerimaan pasien rujukan dari luar, menerima seluruh pasien yang datang ke rs prima husada dengan segala kondisi
 - b. Meningkatkan kembali kinerja dari humas marketing di rumah sakit prima husada malang

a. ALOS :

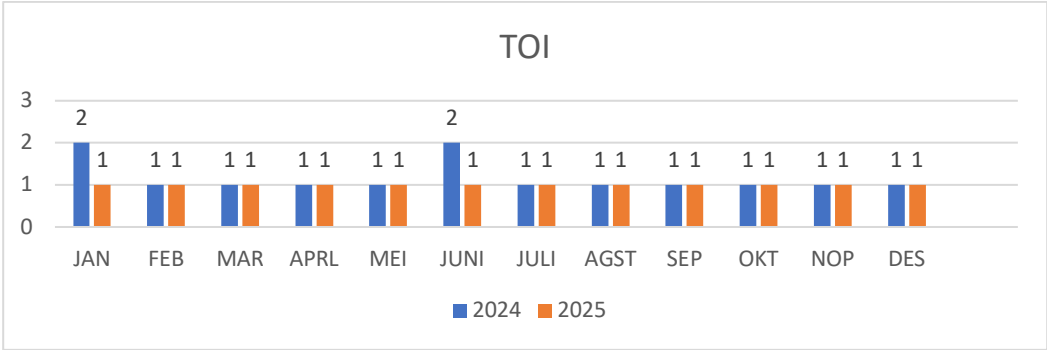


Analisa : Rata rata lama rawat seorang pasien pada periode tahunan (alos) tahun 2025 adalah 3 hari ,dan perbandingan untuk tahun 2024 juga sama rata rata alos 3 hari.sudah sesuai dengan kebijakan rumah sakit yaitu lama rawat seorang pasien <3 hari.

Masalah : Tidak ada masalah untuk Alos dikarenakan sudah sesuai dengan standart rumah sakit yang sudah ditentukan

Rencana Tindak Lanjut : Sudah sesuai standart sehingga perlu di pertahankan

b. TOI:

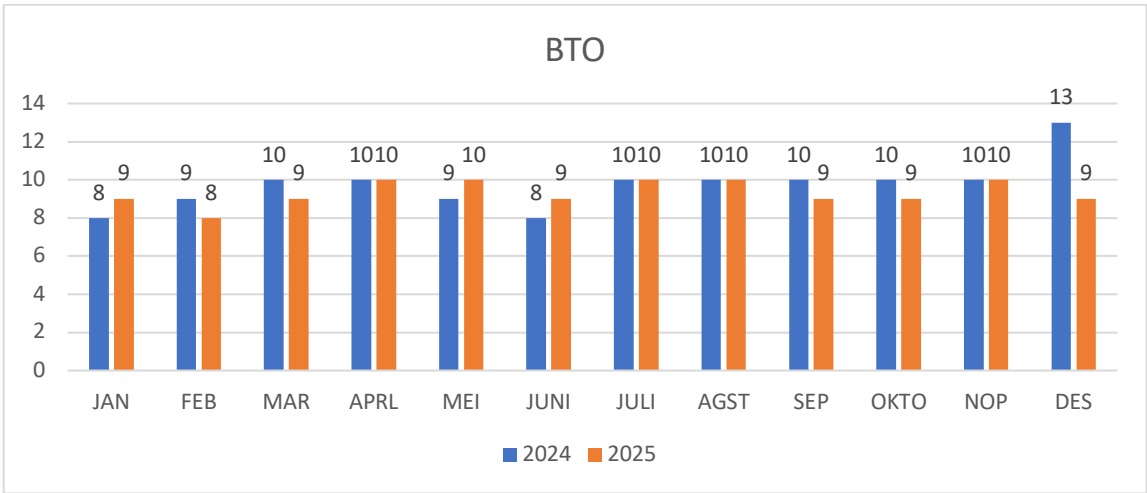


Analisa : Rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya. Indikator ini memberikan gambaran tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur. Idealnya tempat tidur kosong tidak terisi pada kisaran 1-3 hari,dari rata rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati pada periode tahunan (TOI) tahun 2025 adalah 1 hari sudah sesuai dengan standart depkes 1-3 hari dan untuk 2024 toi (1 hari)

Masalah : Tidak ada masalah dalam hal ini dikarenakan 2025 sudah sesuai standar.

Rencana Tindak Lanjut : Sudah sesuai standart sehingga perlu di pertahankan

c. BTO :



Analisa : Frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode, berapa kali tempat tidur dipakai dalam satu satuan waktu tertentu. Idealnya dalam satu tahun, satu tempat tidur rata-rata dipakai 40-50 kali, tabel di atas setelah di analisa untuk BTO tahun 2025 rata rata tempat tidur di pakai 9 kali, sudah sesuai dengan standard, dan di 2024 BTO (10 kali).

Masalah : Tidak ada masalah karena sudah sesuai dengan standard.

Rencana Tindak Lanjut : Sudah sesuai standartd sehingga perlu di pertahankan

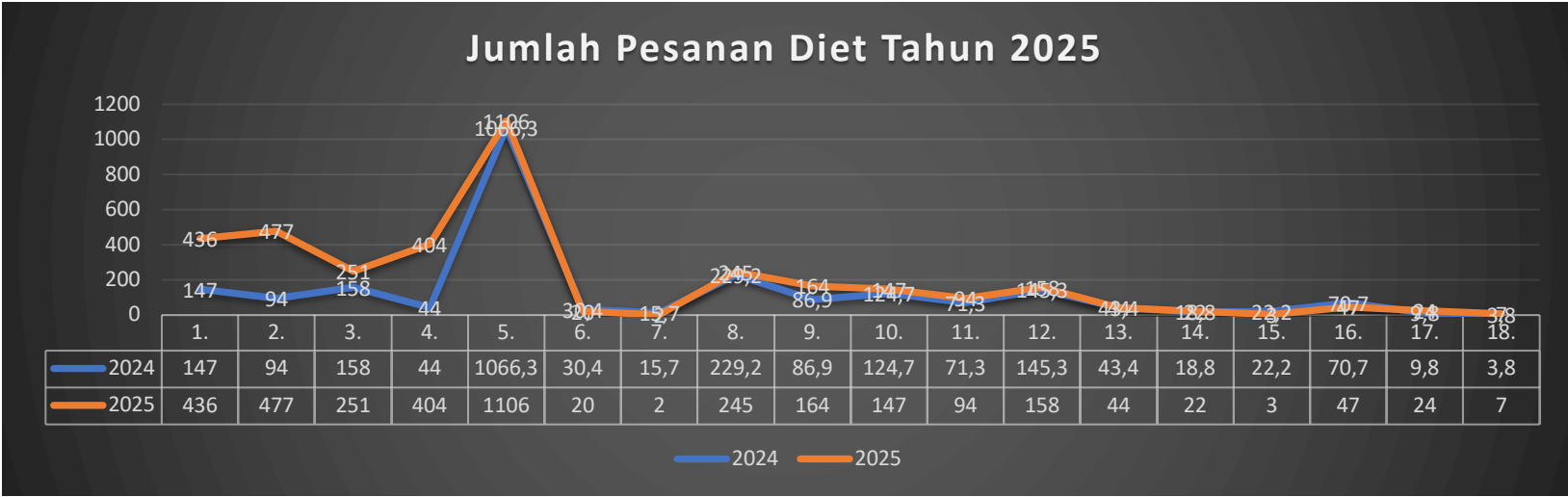
3.3.5 Gizi

Tabel Pemesanan Diit Selama Tahun 2025

No.	Nama Diet	Jumlah Pesanan Diet												Rata-rata
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	
1.	Diabetes Melitus	373	388	337	453	354	371	442	514	411	492	571	526	436
2.	Rendah Garam	526	419	380	649	411	350	460	445	359	564	586	580	477
3.	Jantung	265	222	184	228	280	211	262	227	249	287	291	308	251
4.	Rendah serat	369	321	375	394	449	382	614	408	399	358	434	349	404
5.	TKTP	1099	906	1033	1003	1158	900	1117	1187	1275	1240	1221	1130	1106
6.	Makanan Biasa	9	20	18	14	20	13	32	7	8	23	33	38	20
7.	Diet Alergi	0	0	0	0	0	0	5	2	0	8	5	6	2
8.	Rendah Lemak	199	225	201	226	225	148	257	295	200	284	352	329	245
9.	Rendah Protein	149	130	134	160	143	152	172	147	109	173	207	286	164
10.	Bubur Halus	140	152	175	121	139	78	175	138	124	153	160	209	147
11.	Cair	73	60	69	84	90	123	124	89	98	107	106	106	94
12.	Rendah Purin	251	140	111	142	167	99	171	142	145	175	175	177	158
13.	Tinggi Protein	28	26	35	60	35	36	43	56	58	43	63	42	44

No.	Nama Diet	Jumlah Pesanan Diet												Rata-rata
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	
14.	Blender	8	17	29	10	19	35	18	20	22	25	23	33	22
15.	Tinggi serat	0	5	7	3	8	2	1	0	5	0	5	0	3
16.	Tinggi Kalium	62	53	60	74	48	61	28	19	39	42	15	64	47
17.	Rendah Kalium	42	18	42	28	20	10	20	11	12	31	27	22	24
18.	Rendah Sisa	11	5	4	3	4	10	5	8	8	12	16	3	7
Total		3604	3107	3194	3652	3570	2981	3946	3715	3616	4017	4207	4208	3651

Grafik Jumlah Pesanan Diet di Unit Gizi Pada Tahun 2025



Analisis :

Rata-rata pemberian diet paling banyak tahun 2025 meningkat yaitu pemberian diet DM, RG, Jantung, rendah serat, TKTP, rendah lemak, rendah protein, BHG, Cair, Rendah purin, tinggi protein, blender, rendah kalium, rendah sisa. Sedangkan diet yang mengalami penurunan adalah diet Biasa, Diet alergi, tinggi serat, dan tinggi kalium dikarenakan hanya sedikit pasien dengan diagnose yang membutuhkan diet tersebut.

jumlah pemberian diet pasien di rawat inap. Dari hasil survey kepuasan pasien terhadap menu makanan tidak ditemukan penurunan kepuasan terhadap variasi makanan.

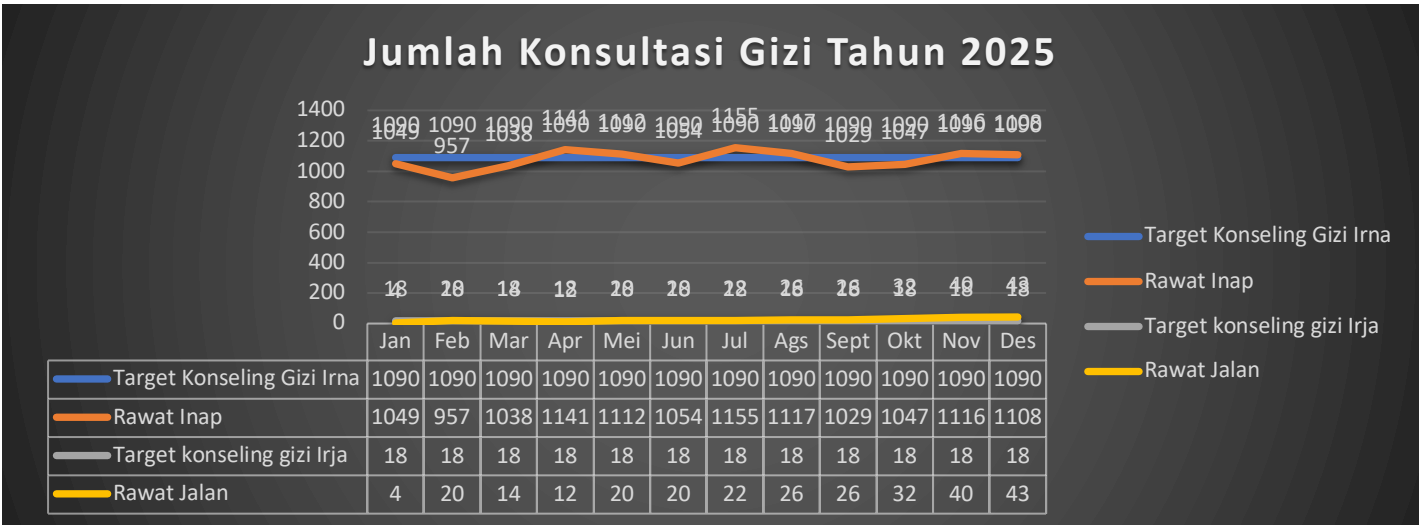
Rencana Tindak Lanjut :

Koordinasi dengan humas dan marketing untuk meningkatkan jumlah kunjungan pasien rawat inap. Evaluasi kembali terkait kepuasan pasien terhadap variasi menu makanan.

Tabel Jumlah Konsultasi Gizi

No	Indikasi	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1.	Target Konsultasi Gizi '25	1090	1090	1090	1090	1090	1090	1090	1090	1090	1090	1090	1090
2.	Konsultasi Gizi Rawat Inap '25	1049	957	1038	1141	1112	1054	1155	1117	1029	1047	1116	1108
3.	Target Konsultasi Gizi rawat jalan '25	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
4	Konsultasi Gizi Rawat Jalan '25	4	20	14	12	20	20	22	26	26	32	40	43

Grafik Jumlah Konsultasi Gizi



Analisis :

Jumlah konsultasi gizi ranap paling banyak pada bulan April dan Juli sebanyak 1141 dan 1155 karena mengikuti jumlah pasien yang rawat inap. Jumlah konsultasi gizi rajal paling banyak pada bulan November dan Desember dikarenakan Sebagian besar pasien ingin melakukan evaluasi pola makan dari konsultasi gizi dirawat inap, selain itu juga bersamaan dengan jadwal control pasien ke poli spesialis.

Rencana Tindak Lanjut :

Koordinasi dengan dokter DPJP agar sering merujuk pasien nya untuk ke poli gizi dan lebih baik lagi jika ada dokter spesialis gizi.

3.3.6 Laundry

Tabel Jumlah Alat dan Linen Unit CSSD dan Laundry pada Tahun 2025

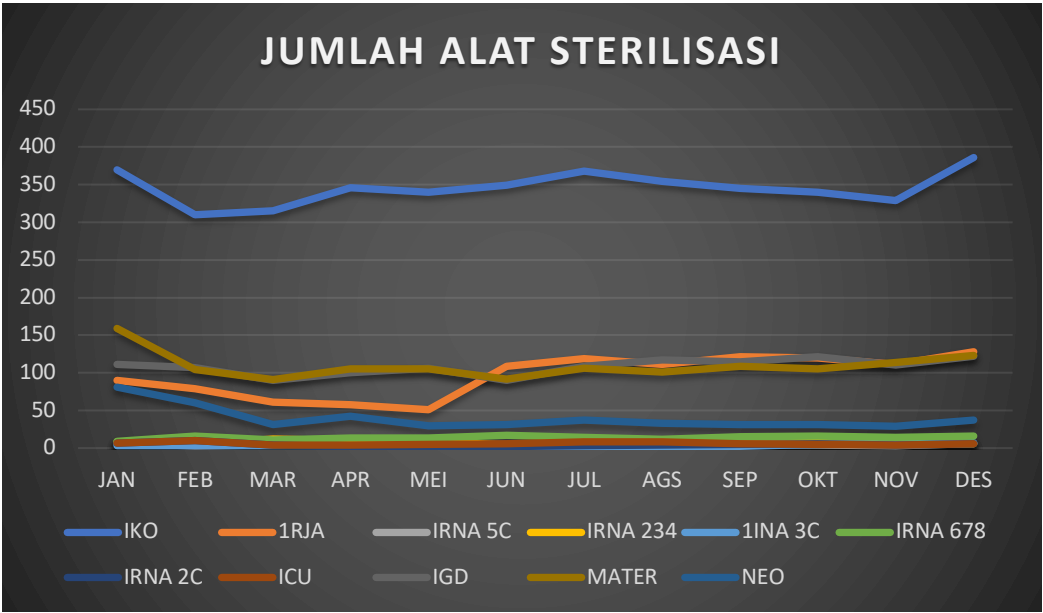
No	Nama Ruangan	Jumlah Alat dan Linen Sterilisasi												Rata tahun 2024	Rata tahun 2025
		Jan 24/25	Feb 24/25	Mar 24/25	Apr 24/25	Mei 24/25	Jun 24/25	Jul 24/25	Agu 24/25	Sep 24/25	Okt 24/25	Nov 24/25	Des 24/25		
CSSD															
1.	IKO	391/ 370	367/ 310	367/ 315	365/ 346	387/ 340	391/ 349	382/ 368	369/ 354	371/3 45	351/3 40	366/3 29	365/ 386	372,6	346
2.	IRJA	101/ 90	87/ 79	75/ 61	72/ 58	65/ 51	65/ 109	101/ 119	110/ 111	97/ 121	104/1 20	110/1 11	96/ 128	90,25	97
3.	IRNA 5C	7/ 6	7/ 3	4/ 4	3/ 6	2/ 4	1/ 5	2/ 6	1/ 5	2/ 5	7/ 4	6/ 3	1/ 6	4,3	5
4.	IRNA 2A, 3A dan 4A	3/ 8	3/ 6	2/ 12	3/ 10	4/ 9	3/ 4	2/ 5	3/ 6	2/ 9	6/ 8	3/ 5	4/ 6	3,1	7
5.	IRNA 3C ANAK	2/ 3	2/ 3	0/ 3	3/ 3	3/ 2	4/ 0	4/ 2	1/ 1	1/ 2	0/ 5	1/ 6	1/ 7	1,8	4
6.	IRNA 6A, 7A dan 8A	8/ 9	8/ 16	4/ 11	3/ 13	4/ 13	7/ 17	7/ 14	9/ 12	9/ 15	9/ 16	10/ 14	11/ 16	7,4	14
7.	IRNA 2C VIP	4/ 7	4/ 10	3/ 4	3/ 2	3/ 2	1/ 2	1/ 3	4/ 4	3/ 5	2/ 6	2/ 4	1/ 6	2,5	5
8.	IRNA ICU	10/	10/	11/	12/	12/	2/	2/	1/	5/	6/	7/	8/	7,1	6

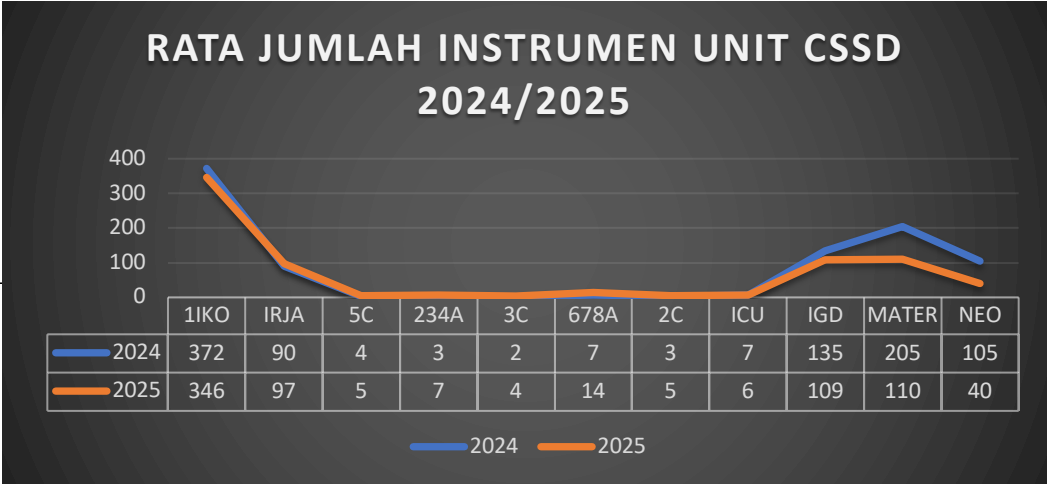
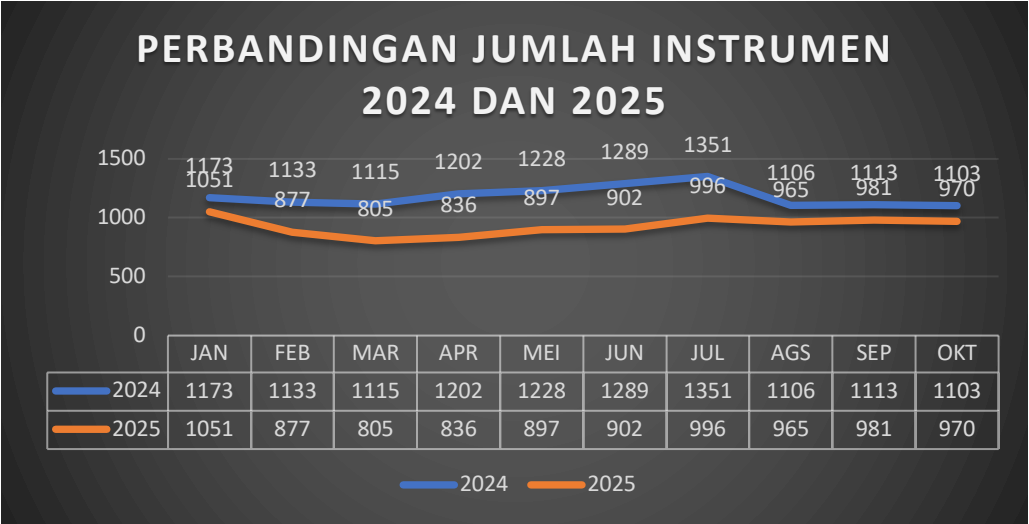
No	Nama Ruangan	Jumlah Alat dan Linen Sterilisasi												Rata tahun 2024	Rata tahun 2025
		Jan 24/25	Feb 24/25	Mar 24/25	Apr 24/25	Mei 24/25	Jun 24/25	Jul 24/25	Agu 24/25	Sep 24/25	Okt 24/25	Nov 24/25	Des 24/25		
		7	10	4	4	5	6	8	8	6	5	4	6		
9.	IGD	126/ 111	126/ 107	149/ 90	156/ 100	163/ 106	176/ 90	189/ 109	99/ 117	112/ 115	101/ 121	112/ 110	115/ 122	135,3	109
10.	MATERNITAS	203/ 159	203/ 104	179/ 91	243/ 105	256/ 105	269/ 92	282/ 106	188/ 101	191/ 109	147/ 105	151/ 114	156/ 123	205,6	110
11.	NEONATOLOGI	108/ 81	108/ 60	112/ 31	139/ 42	124/ 30	135/ 31	135/ 37	98/ 33	85/ 31	71/ 31	68/ 29	78/ 37	105	40
12.	LINEN IKO	194/ 191	194/ 168	191/ 175	188/ 202	192/ 198	221/ 190	227/ 211	210/ 202	223/ 211	188/ 202	191/ 196	185/ 221	200,3	198
13.	LINEN MATA	16/ 7	16/ 8	18/ 7	12/ 11	13/ 10	13/ 7	17/ 8	13/ 11	12/ 7	10/ 7	11/ 8	8/ 12	13,25	9
Total		1.173/ 1051	1.133/ 877	1.115/ 805	1.202/ 836	1.228/ 897	1.289/ 902	1.351/ 996	1.106/ 965	1.113/ 981	1103/ 970	1.038/ 729	936/ 920	1.148,5	911
LAUNDRY															
1.	LINEN INFEKSIUS	3350/ 2473	3190/ 2423	3687/ 2347	3467/ 2556	3759/ 2265	3865/ 2370	3871/ 2401	3655/ 2352	3459/ 2437	3403/ 2591	3135/ 2409	3144/ 2564	3.209,8	2432
2.	NON INFEKSI	2200/ 1806	2211/ 1693	1985/ 2149	1888/ 2076	1800/ 1969	1905/ 1983	1889/ 2282	1928/ 2157	1964/ 2097	1851/ 2347	1583/ 2037	1660/ 2546	1.905,3	2095
3.	LINEN TERKIRIM	3902/ 2890	2978/ 3091	3493/ 3290	3409/ 3375	3551/ 3432	3795/ 3765	3605/ 3773	3556/ 3811	3505/ 3936	3440/ 3919	3297/ 3600	3270/ 3711	3.483,4	3549

No	Nama Ruangan	Jumlah Alat dan Linen Sterilisasi												Rata tahun 2024	Rata tahun 2025
		Jan 24/25	Feb 24/25	Mar 24/25	Apr 24/25	Mei 24/25	Jun 24/25	Jul 24/25	Agu 24/25	Sep 24/25	Okt 24/25	Nov 24/25	Des 24/25		
4.	2,3,4 A	280	434	417	523	455	458	425	436	361	513	405	614		444
5.	6,7,8 A	630	634	598	648	612	503	501	532	571	553	602	642		586
6.	2C & ICU	316	256	279	269	221	295	301	348	375	491	394	468		335
7.	3 C	299	324	343	289	226	413	399	342	315	388	299	481		343
8.	4 C	350	237	334	296	275	326	345	314	311	382	322	464		330
9.	5 C	310	237	259	321	337	260	333	260	267	248	286	224		279
10	IKO	1847	1650	1887	1964	1741	1713	1883	1856	1865	1867	1762	1870		1826
11	IRJA	70	78	78	41	75	66	70	75	67	111	97	98		77
12	IGD	160	184	177	212	187	216	206	214	211	231	165	153		193
13	LABORAT	5	4	5	4	7	8	5	12	5	8	15	12		7
14	RADIOLOGI	3	4	5	4	7	4	4	8	3	6	10	14		6
15	DAPUR/GIZI	4	4	5	4	7	4	4	12	5	8	10	11		6
16	CSSD	5	4	5	10	13	8	9	13	7	9	10	12		7
17	Linen M.S		30	44	34	69	62	73	76	55	42	39	58		49
18	Umum		36	60	18	3	21	125	12	117	81	30	47		49
		5.550	5.401	5.672	5.357	5.559	5.770	5.924	5.583	5.423	5.254	4.718	4.804	5417	

No	Nama Ruangan	Jumlah Alat dan Linen Sterilisasi												Rata tahun 2024	Rata tahun 2025
		Jan 24/25	Feb 24/25	Mar 24/25	Apr 24/25	Mei 24/25	Jun 24/25	Jul 24/25	Agu 24/25	Sep 24/25	Okt 24/25	Nov 24/25	Des 24/25		
Total LINEN 2025		4279	4116	4496	4632	4234	4353	4683	4510	4535	4938	4446	5110	4527	

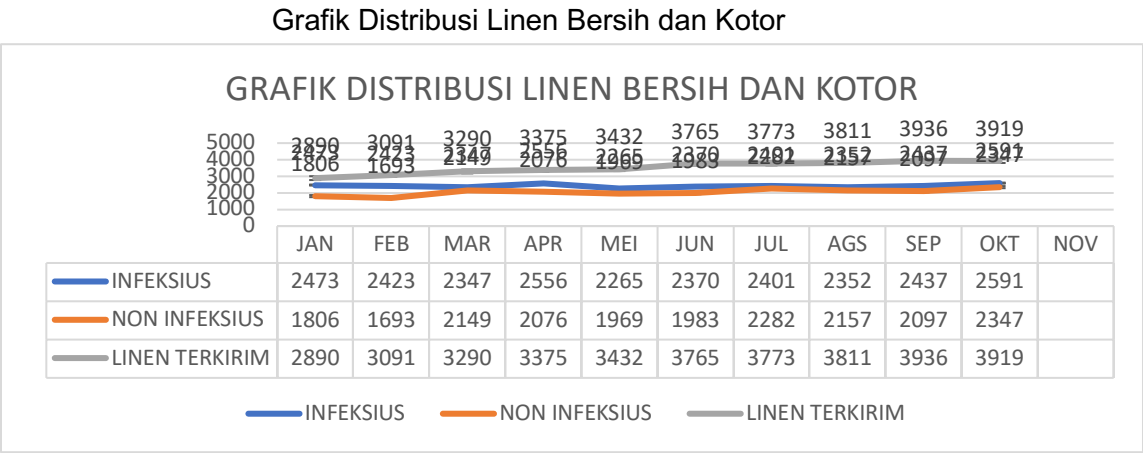
Grafik Jumlah Alat dan Linen di Unit CSSD dan Laundry pada Tahun 2025

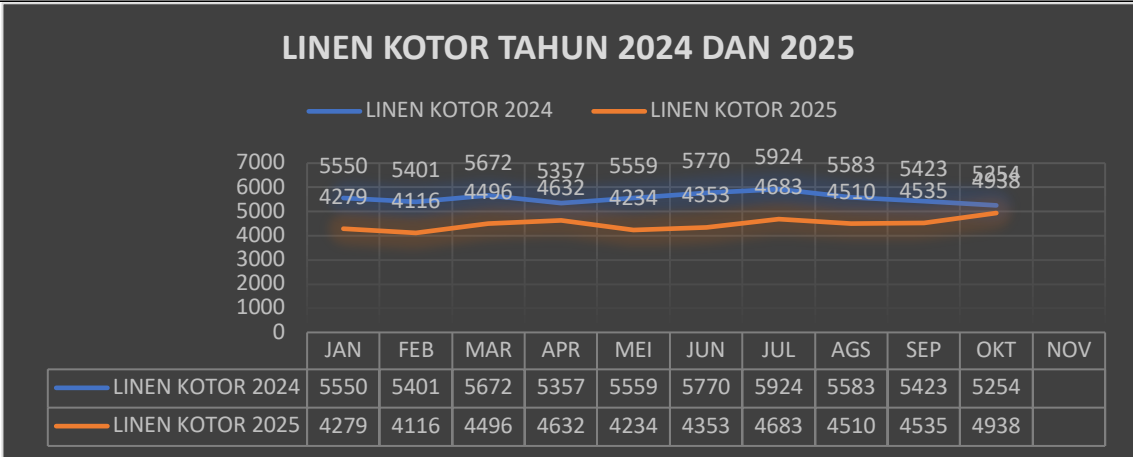




Analisis :
Rata-rata jumlah alat sterilisasi paling banyak tahun 2025 ada pada alat IKO, yaitu sebanyak 346 .Rata-rata alat sterilisasi di CSSD paling rendah tahun 2025 ada pada alat IRNA 3C Anak yaitu sebanyak 4

Rencana Tindak Lanjut :
Evaluasi kembali terkait alat sterilisasi terhadap penggunaan alat pada setiap ruangan.





Analisis :
Rata-rata jumlah linen terkirim paling banyak tahun 2025 yaitu sebanyak 3549 .Rata-rata linen di Laundry paling rendah tahun 2025 ada pada ruang 5C yaitu sebanyak 245 dan IKO paling banyak yaitu rata rata 1870

Rencana Tindak Lanjut :
Evaluasi kembali terkait linen bersih terhadap penggunaan linen pada setiap ruangan.

3.3.7 Unit Kamar Jenazah
Tidak ada proses pemulasaraan jenazah di RS Prima Husada Malang

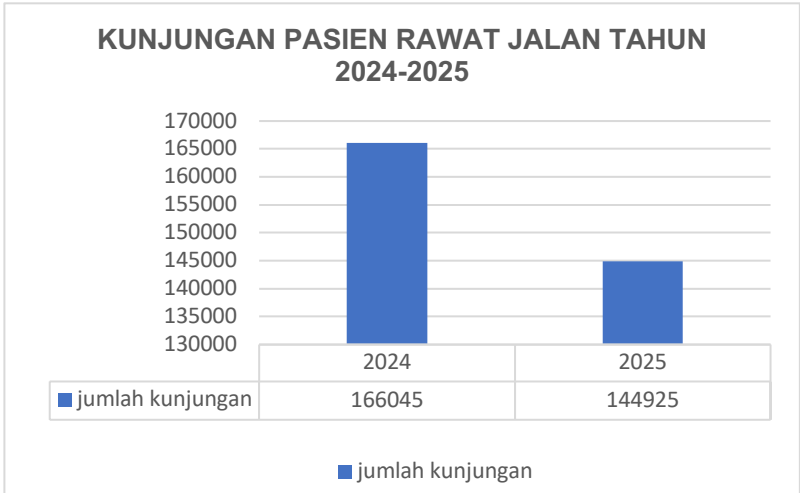
3.3.2 Pelayanan
3.3.2.1 Instalasi Rawat Jalan

Tabel Kunjungan Pasien IRJA Tahun 2024-2025

NAMA UNIT	2024	2025
Klinik Anak	13934	10789
Klinik anak sakura	26	60
Klinik Bedah	9753	8092
Klinik Bedah Plastik	346	352
Klinik bedah saraf	132	315
Klinik Fisioterapi	13948	12329
Klinik Gigi Spesialis	110	0
Klinik Gigi Ortodonti	114	246
Klinik Gigi Pedodontis	825	2017
Klinik Gigi Periodonti	402	644
Klinik Gigi Umum	0	6
Klinik Gizi	4	4
Klinik Ibu dan Anak	208	98
Klinik Jantung	13986	13376
Klinik Jiwa	3783	4317
Klinik Kandungan	13716	12195
Klinik Konservasi Gigi	0	34
Klinik Kulit & Kelamin	4879	3958
Klinik Mata	13810	8836
Klinik Obgyn Sakura	74	153
Klinik Orthopedi	6727	6550
Klinik Paru	5675	4415
Klinik Penyakit Dalam	30822	24226

Klinik penyakit dalam sakura	5	30
Klinik penyakit dalam sub EMD	7	0
Klinik Syaraf	16454	13953
Klinik THT	2786	2573
Klinik Urologi	4458	3475
Klinik Umum	543	1894
TOTAL	166045	144925

Grafik Kunjungan Pasien IRJA Tahun 2024-2025



Analisa :

Jumlah kunjungan masing masing tahun 2024-2025 mengalami penurunan kunjungan 13% ,sebanyak 21.120 pasien. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan dari BPJS Kesehatan terkait target PRB dan lterisasi, pembatasan rujukan FKTP hanya 1 x rujukan saja dan kuota masing-masing DPJP harus sesuai dengan HFIS.

Rencana Tindak Lanjut :

Tingkatkan jumlah kunjungan koordinasi dengan humas dan marketing, terutama untuk pasien umum dan non BPJS.

PDSA Kinerja Produktivitas IRJA

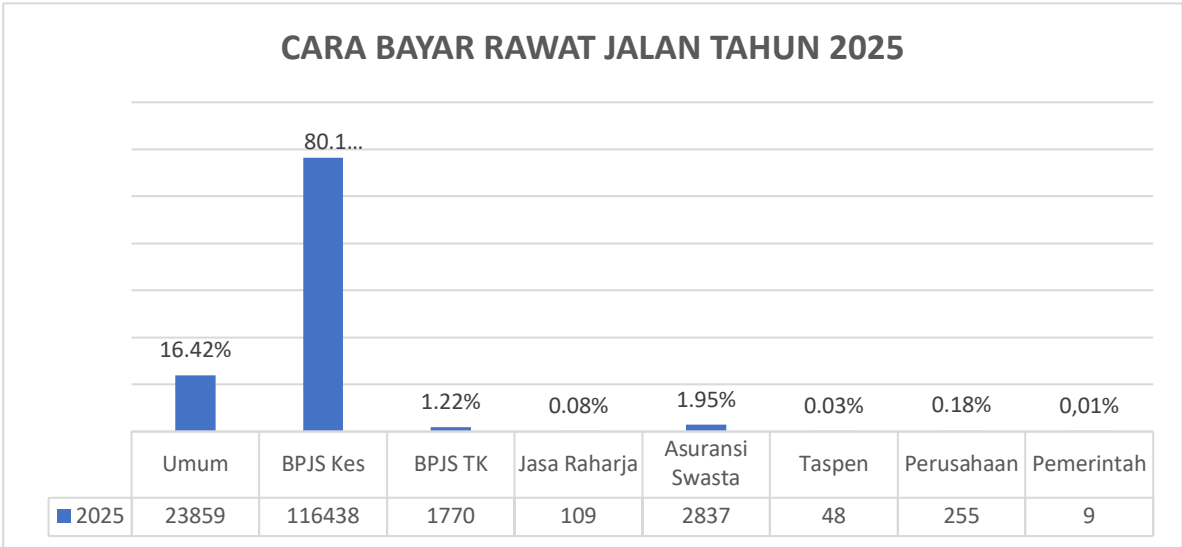
Problem	Kunjungan pasien menurun
Step	Mendata dan menganalisa jumlah pasien rawat jalan dalam satu tahun
Plan	Rencana : Mengetahui penyebab kunjungan rawat jalan yang menurun 13 % Harapan : - Pasien bpjs meningkat dari tahun sebelumnya - Pasien UMUM dapat ditingkatkan dengan pelayanan vaksin internasional dan MCU maupun poli reguler yang memakai penjamin umum - Pasien asuransi, Jasa raharja , BPJS TK bisa meningkat Tindakan : a. Memenuhi slot dokter spesialis sehingga pasien datang di jam efektif bisa diterima

	b. Koordinasi dengan PKRS untuk melakukan promosi bagi dokter PHM diantaranya branding DPJP , lewat penyuluhan, Instagram, acara besar nasional c. Humas MOU dengan perujuk baru dan memonitoring perujuk terbesar apabila rujukannya ada yang turun
Do	a. Home Doctor dengan kebijakan HD terbaru 2025 harus menaruh 3 SIP di PT Disa Prima Medika, ada 3 HD di RSPHM yang tidak memperpanjang HD b. Promosi dan branding DPJP melalui sosmed dan acara penyuluhan bertujuan mengenalkan lebih luas ke masyarakat dan membangun kepercayaan terhadap dokter tersebut agar tertarik untuk berkunjung ke RSPHM konsultasi maupun pengobatan c. Dengan data demografi pasien terbanyak yang berkunjung ke RS prima husada, humas juga kerjasama dengan FKTP yang non bpjs untuk menjaring pasien umum maupun asuransi
Study	Cara Staf mempromosikan apakah sudah sesuai dan tepat sasaran
Action	Pada bulan desember 2025, untuk pasien poli umum (vaksin dan MCU) sebanyak 1.894, dari tahun 2024 sebanyak 543 pasien. Peningkatan 72% dari tahun sebelumnya Follow-up dan Rencana Tindak Lanjut Evaluasi pencapaian pada periode tahun 2026 diharapkan kunjungan poli rawat jalan meningkat terutama untuk pasien Umum / non bpjs.

6.3.2.1.2 Rawat Jalan Per Cara Bayar Bulan Januari-Desember 2025

Cara Bayar 2025	BULAN												TOTAL
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Des	
Umum	2138	1930	1916	1833	1872	1825	2010	1964	1980	2041	2092	2258	23859
BPJS Kes	10237	9490	9883	9296	8804	8728	10625	9965	9949	10124	9641	9696	116438
BPJS TK	153	151	139	123	134	136	165	154	147	145	153	170	1770
Jasa Raharja	7	7	7	6	7	7	3	10	17	18	12	8	109
Asuransi Swasta	226	234	209	207	237	188	237	261	250	255	246	287	2837
Taspen	0	1	0	2	2	0	0	3	8	5	12	15	48
Perusahaan	28	18	22	17	28	12	28	20	16	28	14	24	255
Pemerintah	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
Total 2025	12797	11832	12176	11484	11084	10896	13068	12377	12367	12616	12170	12458	145325

Grafik Rawat Jalan Per Cara Bayar Bulan Januari – Desember 2025



Analisa :

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa cara bayar yang paling tinggi : 80.12% pasien menggunakan cara bayar bpjs, 16.42% pasien menggunakan cara bayar umum, 1.95% pasien menggunakan cara bayar asuransi swasta, 1.22% pasien menggunakan cara bayar bpjs TK, 0.18% pasien menggunakan cara bayar perusahaan, 0.8% pasien menggunakan cara bayar jasa raharja, dan paling rendah 0.01% pasien menggunakan cara bayar kemenkes

Rencana Tindak Lanjut :

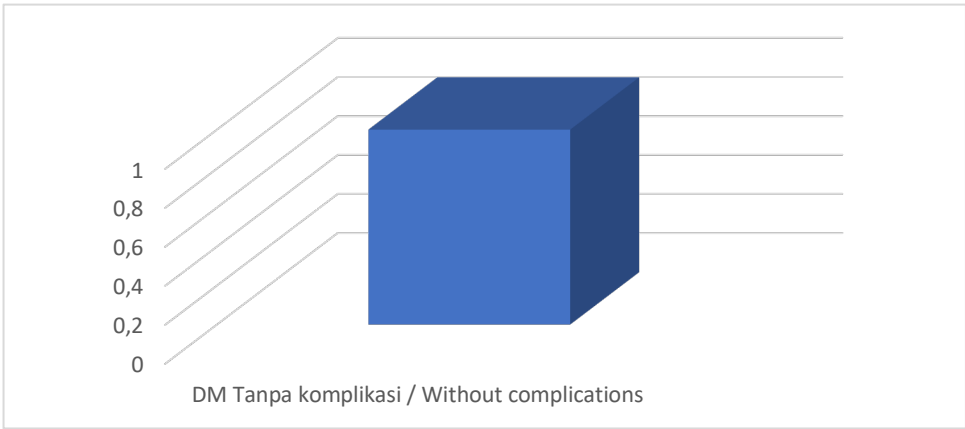
- 1. Tingkatkan kunjungan pasien umum dengan meningkatkan kunjungan MCU dan vaksin
- 2. Koordinasi dengan humas marketing untuk menambah dan memperbarui PKS dengan perusahaan maupun asuransi
- 3. Bekerjasama dengan FKTP untuk menjangir pasien yang berkenan menggunakan kontrasepsi pemerintah (BKKBN) karena kunjungan masih sangat sedikit.
- 4. Koordinasi humas dengan JR, Polisi dan Perusahaan untuk meningkatkan kunjungan pasien JR dan JKK

Tabel 10 Penyakit Terbanyak Rawat Jalan Tahun 2025

NO	Code ICD 10	DIAGNOSIS	JUMLAH
1	E11.9	DM Tanpa komplikasi / Without complications	4574
2	I51.9	Decomp Cordis / Heart disease, unspecified	3955
3	I11.9	HHD / Hypertensive heart disease without (congestive) heart failure	3594
4	I25.9	Chronic ischemic heart disease, unspecified	3583
5	E11.4	With neurological complications	3564
6	I63.9	CVA Infark / Cerebral infarction, unspecified	2481
7	J47	Bronchiectasis	2423
8	J44.9	COPD / Chronic obstructive pulmonary disease, unspecified	2316

9	R50.9	Fever, unspecified	2115
10	K04.1	Necrosis of pulp	1937

Grafik 10 Diagnosa Rawat Jalan Terbesar Januari – Desember 2025



Analisa :
 Dari rekapan dan perbandingan tahun 2024 ke 2025 menurun untuk pasien penderita DM , 2024 di nilai (8153) dan di 2025 turun (4574) pasien dari analisis tabel 3.3.3.1 menunjukan bahwa ada penurunan penderita DM sebanyak 44% (3579 pasien)

Rencana Tindak Lanjut :
 Meskipun jumlah pasien DM menurun dari tahun sebelumnya, RSPHM tetap berupaya mengurangi penyakit DM dengan program promotive dan perventif seperti Senam diabetes melitus nanti bisa di agendakan di acara senam geriatri, program pemeriksaan gula darah secara berkala berkerjasama degan FKTP MS (untuk event tertentu) dan menyediakan leaflet yang bisa diakses dengan mudah melalui barcode. Menyediakan data pasien dan no telfon untuk tindak lanjut ke bagian manajemen data tersebut bisa dilakukan untuk tindak lanjut ke bagian management, seperti melakukan program senam kaki untuk penderita DM dan membagikan leaflet tentang senam kaki DM. Hasil dari follow up humas dan marketing :

- a. Senam diabetes melitus nanti bisa di agendakan di acara senam geriatric
- b. Program pemeriksaan gula darah juga sudah dilakukan
- c. Leaflet mengenai DM sudah tersebar di seluruh unit rawat inap
- d. Apakah ada komunitas, dan DM

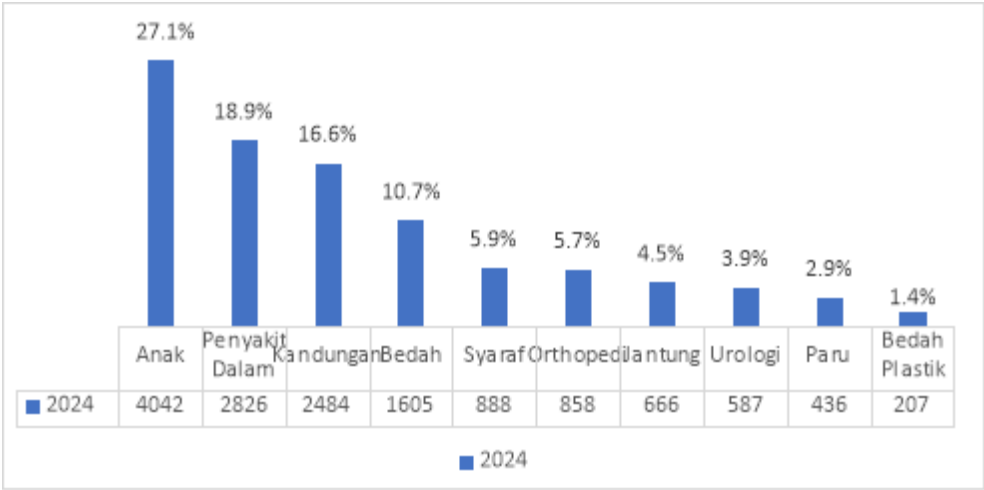
6.3.2.2 Instalasi Rawat Inap

Tabel Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Inap sesuai dengan Jenis Pelayanan Tahun 2024-2025

Jenis Pelayanan	2024	2025
Anak	4042	3778
Anastesi	5	1
Bedah	1605	1545
Bedah Plastik	207	225
Bedah syaraf	83	200
Jantung	666	707
Jiwa	1	0
Kandungan	2484	2227
Kulit & Kelamin	25	19
Mata	147	156
Orthopedi	858	981

Paru	436	514
Penyakit Dalam	2826	2896
Spesialis Gigi	26	25
Syaraf	888	932
THT	29	32
Urologi	587	501
Umum	19	3
TOTAL	14934	14742

Grafik Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Inap Sesuai dengan Jenis Pelayanan Tahun 2024 -2025



Analisa :
 Dari tabel di atas tahun 2025 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 1.29% , untuk selisih jumlah pasien turun 192 pasien.

Rencana Tindak Lanjut :
 Meningkatkan kunjungan pasien anak maupun dewasa, koordinasi dengan Humas – marketing untuk mempromosikan pelayanan IGD yang cepat dan tanggap, koordinasi dengan FKTP Mutiara sehat jika ada pasien rujukan rawat inap dari MS bisa dikawal dengan baik.

PDSA Kinerja Produktivitas IRNA

Problem	Kunjungan pelayanan rawat inap turun
Step	Mendata dan menganalisa jumlah pasien rawat inap dalam satu tahun
Plan	Rencana : - Mengetahui penyebab kunjungan pasien menurun Harapan : Kunjungan pasien rawat inap meningkat di tahun 2025 Tindakan : - Mempermudah rujukan yang masuk ke IGD terutama FKTP dan Puskesmas - Meningkatkan kunjungan rawat inap dengan memaksimalkan kunjungan dari poli maupun IGD

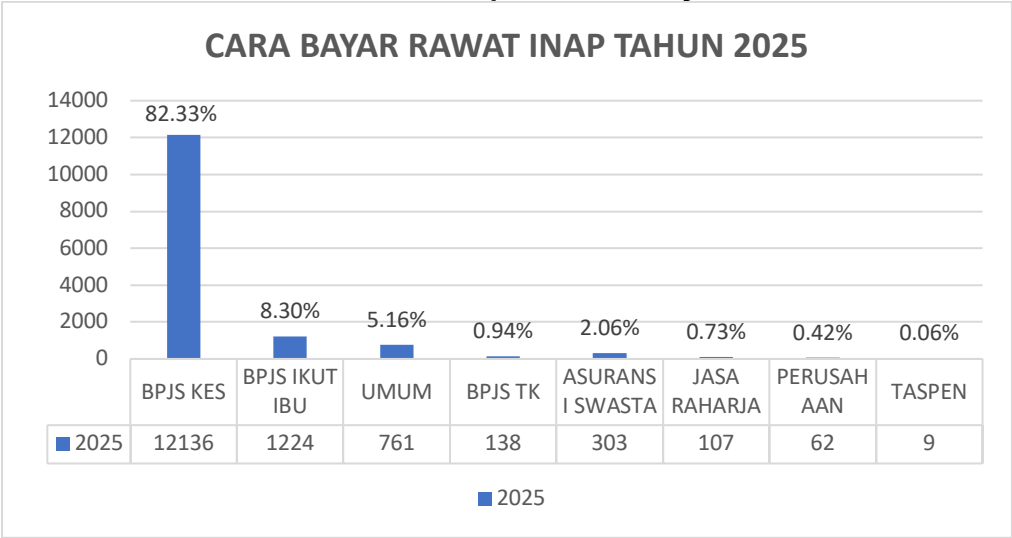
	c. Tahun 2025, sudah ada kebijakan untuk pasien poli bisa menggunakan SPRI dari rawat jalan dan langsung rawat inap tanpa melalui IGD. d. Adanya program mendoakan pasien, sebagai layanan unggulan RSPHM
Do	Koordinasi dengan humas untuk melakukan promosi kunjungan baik sosmed maupun door to door ke FKTP terutama untuk yang kunjungan rujuk nya turun
Study	Koordinasi apakah dengan tindakan yang dilakukan diatas dapat meningkatkan kunjungan pasien
Action	Kunjungan paling rendah adalah bedah plastik dan yang paling tinggi adalah kunjungan anak. Untuk meningkatkan kunjungan anak, beberapa dokter sudah melakukan usaha untuk promosi lewat acara Rumah sakit, diantaranya acara pertemuan dengan FKTP, penyuluhan di ruang tunggu pasien di farmasi dll. Untuk kunjungan bedah plastik, karena dari segi kondisi DPJP yang kurang fit, sehingga beliau membatasi praktek hanya sekali dalam seminggu dan membatasi pasien Bpjs Kesehatan. Sehingga kasus yang memang ada fraktur dan mengarah ke faksilofacial saja yang beliau berkenan. Jika ada kasus trauma kepala diarahkan bedah saraf , dan kasus vull app diarahkan ke bedum. Rencana tindaklanjut : Evaluasi pencapaian pada periode tahun 2025 diharapkan kunjungan pasien rawat inap bedah plastik meningkat dari tahun 2024

Tabel Rawat Inap Per Cara Bayar Bulan Tahun 2025

Cara Bayar 2025	Bulan												TOTAL
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Des	
Umum	91	72	64	79	66	59	60	60	41	71	57	41	761
BPJS Kes	986	890	984	1051	1070	994	1077	1055	963	977	1036	1053	12136
BPJS TK	17	11	21	7	6	7	11	10	11	16	16	5	138
Jasa Raharja	6	12	8	9	12	6	5	10	12	8	7	12	107
Asuransi Swasta	14	11	30	17	9	24	23	41	26	39	43	26	303
Taspen	0	0	0	0	2	0	0	1	0	1	2	3	9
Perusahaan	3	10	4	2	12	4	15	6	3	1	0	2	62
BPJS Ikut Ibu	101	70	105	105	92	100	103	110	117	108	92	121	1224
Total 2025	1218	1076	1216	1270	1269	1194	1294	1293	1173	1221	1253	1263	14740

\

Grafik Rawat Inap Per Cara Bayar Tahun 2025



Analisa :

Berdasarkan tabel dan grafik diatas menunjukan bahwa cara bayar yang paling tinggi 82.33% pasien menggunakan cara bayar bpjs , 8.30% pasien menggunakan cara bayar bpjs ikut ibu, 5.16% pasien menggunakan cara bayar Umum, 0.94% pasien menggunakan cara bayar Bpjs TK, 2.06% pasien menggunakan cara bayar asuransi swasta, 0.73% pasien menggunakan cara bayar jasa raharja, 0.42% pasien menggunakan cara bayar perusahaan, 0.06% pasien menggunakan cara bayar pemerintah/taspen

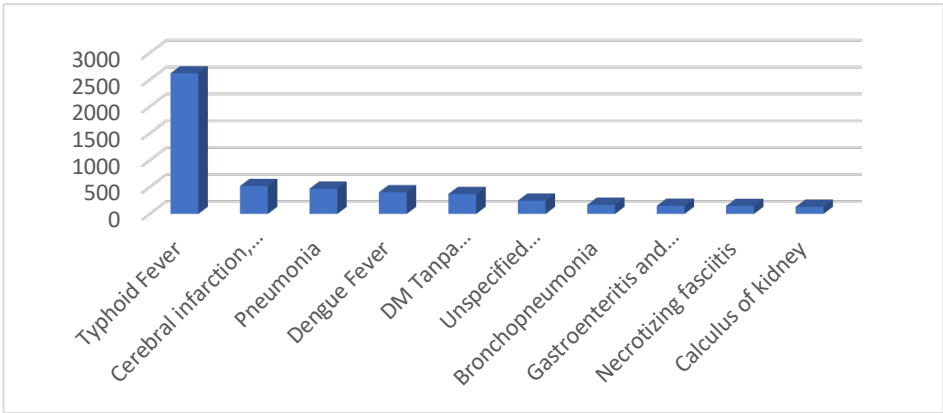
Rencana Tindak Lanjut :

1. Tingkatkan kunjungan pasien umum di IGD dan rawat inap
2. Koordinasi dengan humas marketing untuk menambah dan memperbarui PKS dengan perusahaan maupun asuransi
3. Bekerjasama dengan FKTP untuk menjaring pasien yang berkenan menggunakan kontrasepsi pemerintah (BKKBN) karena kunjungan masih sangat sedikit.
4. Koordinasi humas dengan JR, Polisi dan Perusahaan untuk meningkatkan kunjungan pasien JR dan JKK

Tabel Jumlah Penyakit Rawat Inap 10 Terbesar Tahun 2025

NO	DIAGNOSA	KODE ICD-10	JUMLAH
1	Typhoid Fever	A01.0	2620
2	Cerebral infarction, unspecified	I63.9	519
3	Pneumonia	J18.9	469
4	Dengue Fever	A90	403
5	DM Tanpa komplikasi / Without complications	E11.9	371
6	Unspecified diabetes mellitus without complications	E14.9	248
7	Bronchopneumonia	J18.0	170
8	Gastroenteritis and colitis of unspecified origin	A09.9	150
9	Necrotizing fasciitis	M72.6	149
10	Calculus of kidney	N20.0	132

Grafik Jumlah Penyakit 10 Terbesar Tahun 2025



Analisa :
Jumlah penyakit terbesar di rawat inap sama adalah Typoid Fever.

Rencana Tindak Lanjut :
Untuk diagnosa typoid fever seharusnya bisa dilayani di FKTP. Diagnosa tersebut dapat dilayani di faskes satu. Pasien yang dapat dirawat inapkan dengan diagnose Typoid fever adalah dengan IgM salmonella skala +6 dengan gejala memberat seperti dehidrasi sedang atau kegawatan yang mengancam nyawa. Salah satu upaya di tahun 2025 adalah meminimalisir pendingan pasien BPJS Kesehatan karena diagnosa non spesialisik dan menghindari case yang menyebabkan fraud. Dengan adanya pembaharuan PPK di IGD, diharapkan dokter IGD dapat melakukan skrining dan pengkajian lebih mendalam terhadap pasien yang datang, dan dapat memberikan KIE yang jelas terkait kriteria kegawatdaruratan yang dapat dilayani di IGD.

Tabel Jumlah TT dan Kelas Perawatan Rumah Sakit Prima Husada

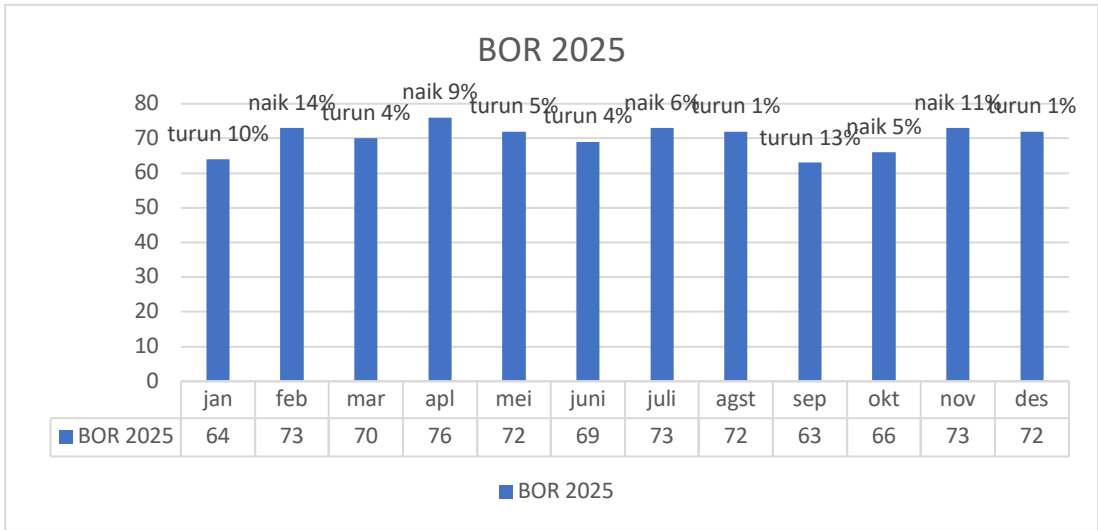
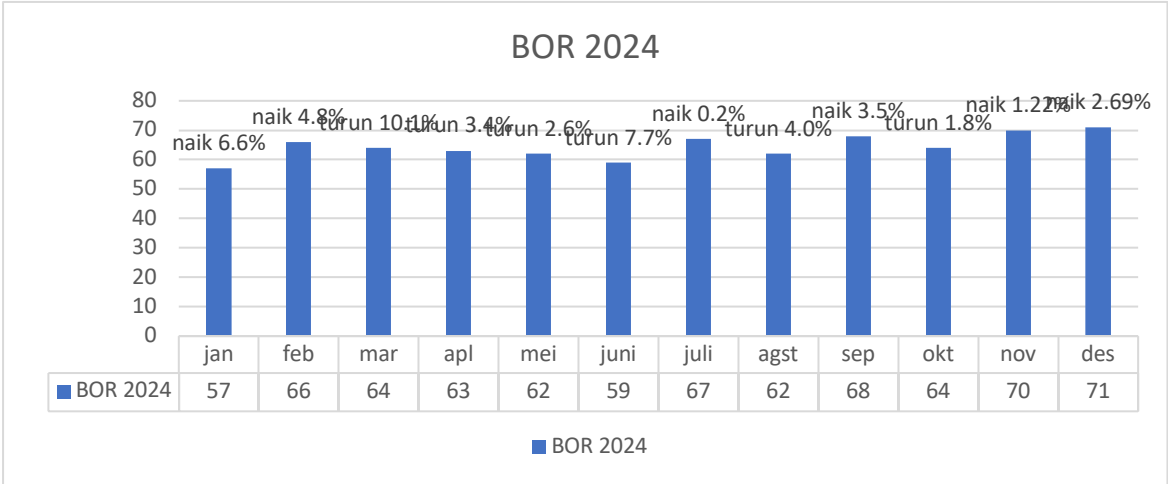
NO	JENIS KELAS	JUMLAH	PROSENTASE
1	Kelas VVIP	4	3%
2	Kelas VIP	3	2%
3	Kelas 1	18	14%
4	Kelas 2	28	22%
5	Kelas 3	48	37%
6	Perawatan Intensive		6%
	ICU Dengan Ventilator	6	
	ICU Tanpa Ventilator	2	
7	HCU	3	5%
8	NICU	2	
9	PICU	1	
	Isolasi		
10	Isolasi Tekanan Negatif	7	5%
	Isolasi <i>Immunocompromise</i>	6	5%
11	Perinatologi	2	2%
	TOTAL	130	100%

Tabel Perbandingan BOR tahun 2024 dan 2025

BULAN	PERBANDINGAN TAHUN 2024 KE 2025				
	Jumlah pasien	BOR 2024	Jumlah pasien	BOR 2025	KETERANGAN
Jan	1148	57%	1218	64%	Naik 10.94%
Feb	1206	66%	1076	73%	Naik 9,59%
Mar	1341	64%	1216	70%	Naik 8,57%

Aprl	1297	63%	1270	76%	Naik 17.11%
Mei	1332	62%	1269	72%	Naik 13.89%
Juni	1237	59%	1194	69%	Naik 14.49%
Juli	1240	67%	1294	73%	Naik 8.22%
Agst	1192	62%	1293	72%	Naik 13.89%
Sep	1235	68%	1173	63%	Turun 7,94%
Okt	1213	64%	1220	66%	Naik 3,03%
Nov	1228	70%	1253	73%	Naik 4,11%
Des	1262	71%	1263	72%	Naik 1,39%

Grafik Perbandingan BOR Tahun 2024 dan 2025



Analisa :

Pada grafik diatas tampak bahwa pencapaian BOR pada tahun 2025 naik turun, rata rata BOR tahun 2025 adalah 70%, dinilai ini perlu dipertahankan. Akan tetapi 3 bulan terakhir pada bulan oktober (66%), november (73%) dan desember (72%), BOR rumah sakit mengalami penurunan yang cukup rendah pada bulan januari 64%. Rata rata BOR di tahun 2025 adalah (70%),

Rencana Tindak Lanjut :

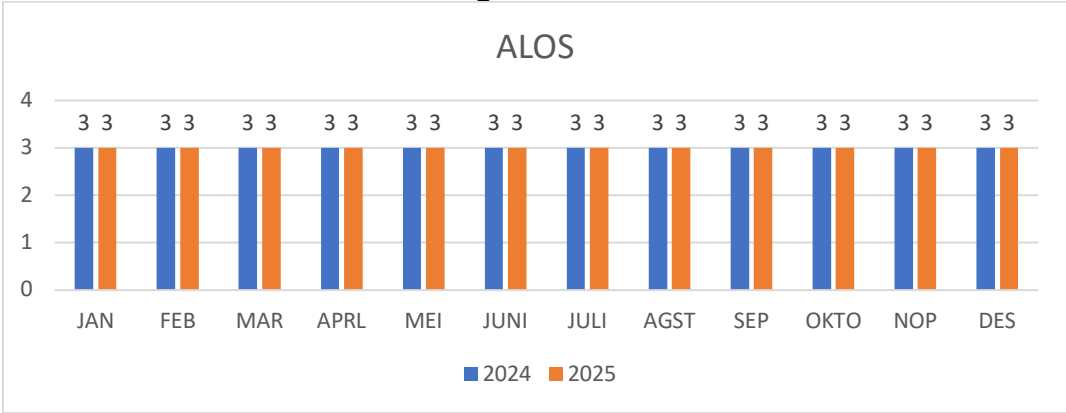
1. Sosialisasi pada DPJP dalam rapat komite medik maupun diskusi per SMF untuk penjelasan sistem proporsi

2. Koordinasi dengan humas dan marketing untuk promosi ke FKTP dan perusahaan untuk meningkatkan kunjungan ke IGD

Tabel Perbandingan ALOS Tahun 2024 dan 2025

NO	JENIS PELAYANAN	ALOS 2024	ALOS 2025
1	JANUARI	3	3
2	FEBRUARI	2	3
3	MARET	3	3
4	APRIL	4	3
5	MEI	4	3
6	JUNI	3	3
7	JULI	4	3
8	AGUSTUS	5	3
9	SEPTEMBER	3	3
10	OKTOBER	3	3
11	NOVEMBER	5	3
12	DESEMBER	3	3
Total rata rata 1 tahun		3	3

Grafik Perbandingan ALOS Tahun 2024 dan 2025



Analisa :

Rata rata lama rawat seorang pasien pada periode tahunan (ALOS) tahun 2025 adalah 3 hari dan perbandingan untuk tahun 2024 juga sama rata rata alos 3 hari. Untuk tahun 2023 lebih bervariasi untuk tiap bulannya, sedangkan untuk tahun 2024 rata-rata per bulan sudah sesuai 3 hari, DPJP cenderung patuh dengan adanya kebijakan proporsi, sehingga lebih hati-hati dalam efisiensi lama rawat dan penggunaan terapi pasien

Rencana Tindak Lanjut :

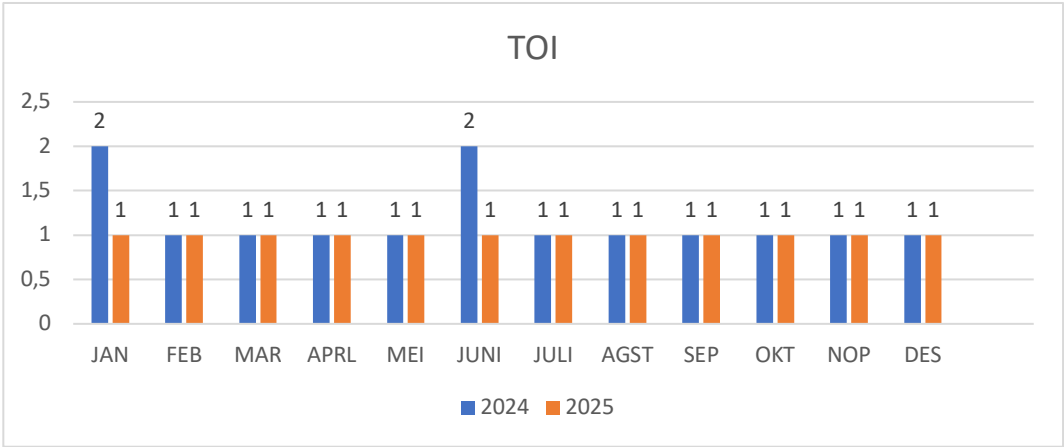
Sudah sesuai standart sehingga perlu dipertahankan pada tahun 2026

Tabel Perbandingan TOI tahun 2024 dan 2025

NO	JENIS PELAYANAN	TOI 2024	TOI 2025
1	JANUARI	2	1
2	FEBRUARI	1	1
3	MARET	1	1
4	APRIL	1	1
5	MEI	1	1

6	JUNI	2	1
7	JULI	1	1
8	AGUSTUS	1	1
9	SEPTEMBER	1	1
10	OKTOBER	1	1
11	NOVEMBER	1	1
12	DESEMBER	1	1
Total rata rata 1 tahun		1	1

Grafik Perbandingan TOI tahun 2024 dan 2025



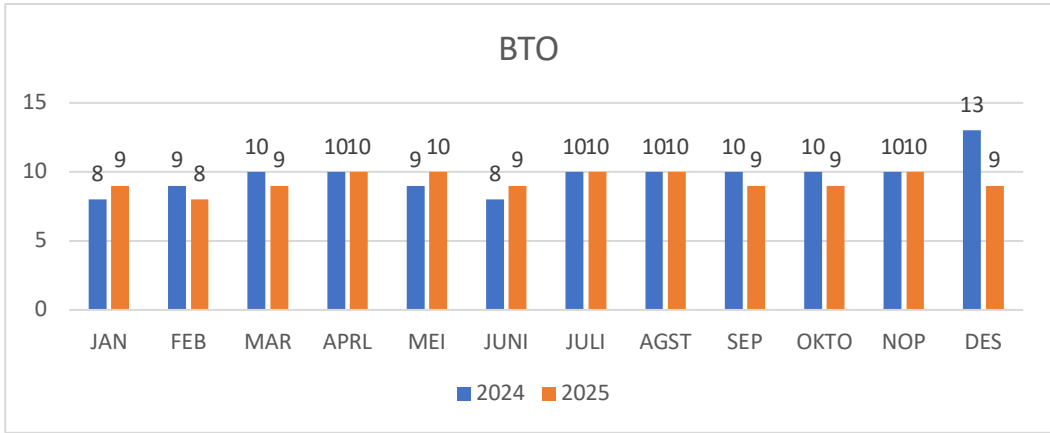
Analisa :
 Rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya. Indikator ini memberikan gambaran tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur. Idealnya tempat tidur kosong tidak terisi pada kisaran 1-3 hari,dari rata rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati pada periode tahunan (TOI) tahun 2025 adalah 1 hari sudah sesuai dengan standart depkes 1-3 hari dan untuk 2023 TOI (3 hari). Tidak ada masalah dalam hal ini dikarenakan 2025 sudah sesuai standar.

Rencana Tindak Lanjut :
 Sudah sesuai standart sehingga perlu di pertahankan di tahun 2026

Tabel Perbandingan BTO Tahun 2024 dan 2025

NO	JENIS PELAYANAN	BTO 2024	BTO 2025
1	JANUARI	8	9
2	FEBRUARI	9	8
3	MARET	10	9
4	APRIL	10	10
5	MEI	9	10
6	JUNI	8	9
7	JULI	10	10
8	AGUSTUS	10	10
9	SEPTEMBER	10	9
10	OKTOBER	10	9
11	NOVEMBER	10	10
12	DESEMBER	13	9
Total pemakaian dalam 1 tahun		83	112

Grafik Perbandingan TOI Tahun 2024 dan 2025



Analisa:

Frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode, berapa kali tempat tidur dipakai dalam satu satuan waktu tertentu. Idealnya dalam satu tahun, satu tempat tidur rata-rata dipakai 40-50 kali, tabel di atas setelah di analisa untuk BTO tahun 2025 rata rata tempat tidur di pakai 9 kali, sudah sesuai dengan standard, dan di 2024 BTO (10 kali).

Rencana Tindak Lanjut :

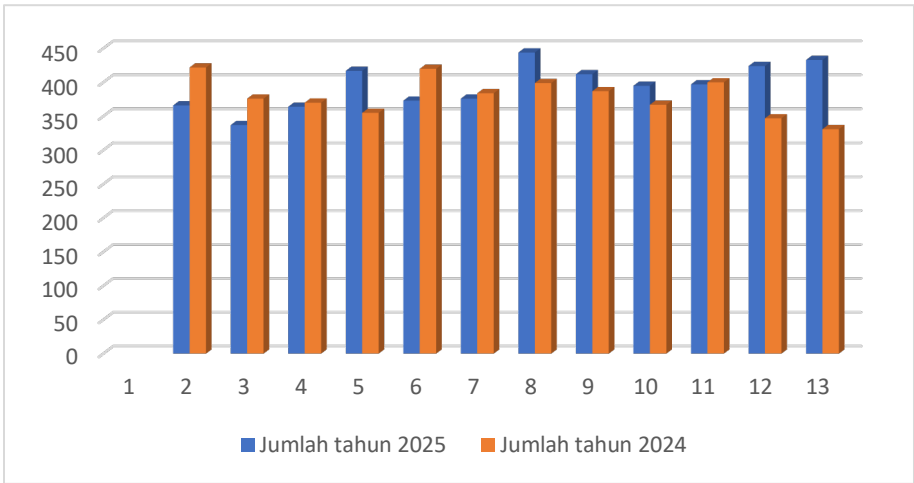
Sudah sesuai standart sehingga perlu di pertahankan.

6.3.2.3 Instalasi Kamar Operasi (IKO)

Tabel Jumlah Pasien Operasi di IKO Tahun 2024 – 2025

No	Hal	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jumlah Rekapitulasi
1.	Kecil	37	48	29	44	48	54	54	52	40	41	60	60	567
2.	Sedang	3	1	5	3	1	4	6	3	8	6	6	4	50
3.	Besar	262	233	266	314	268	278	318	292	279	280	281	309	3380
4.	Khusus	64	55	64	56	56	40	66	65	68	70	77	60	741
Jumlah tahun 2025		366	337	364	417	373	376	444	412	395	397	424	433	4738
Jumlah tahun 2024		422	376	370	355	420	384	399	387	367	400	347	331	4873

Grafik Jumlah Pasien Operasi di IKO Tahun 2025



Analisa :

Hasil analisis dan evaluasi ditahun 2025 didapatkan bahwa pelayanan kamar operasi ditahun ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu dari 4873 menjadi 4738 atau menurun sebanyak 2.77%. Hasil ini karena di tahun 2025 jumlah operasi kecil dan khusus lebih sedikit dibanding tahun 2024.

Rencana Tindak Lanjut :

Rencana tindak lanjut ditahun 2026 adalah dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan yang sudah berjalan serta melakukan pembenahan dibeberapa yang kurang agar mampu memberikan pelayanan yang lebih baik lagi ditahun 2026 serta melakukan pembenahan terkait pembagian jam operasional operasi masing-masing DPJP. Serta tetap terus melakukan koordinasi dengan beberapa pihak seperti Kabid Pelayanan Medis, Kabid Penunjang Medis, Kabid Keperawatan, SDM dan Humas Marketing RS serta program RS yang ada untuk terus melakukan supervisi berjenjang.

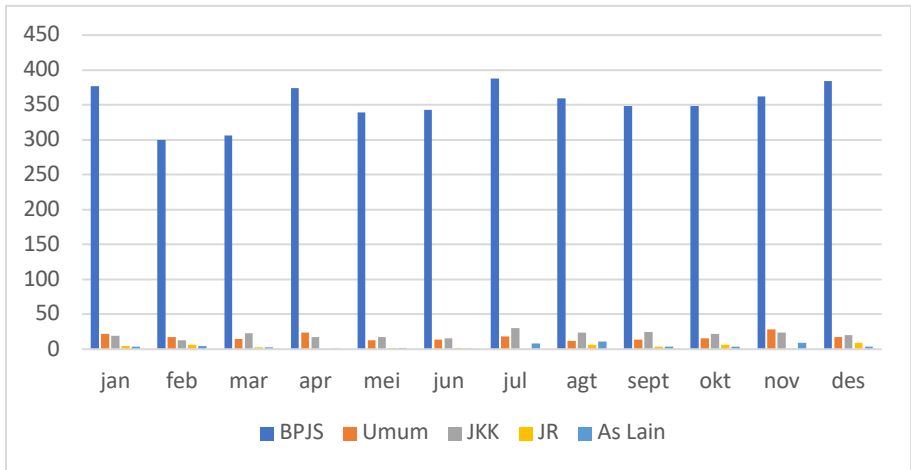
PDSA Kinerja Produktivitas IKO

Problem	Kunjungan Pelayanan IKO turun
Step	Mendata dan menganalisa jumlah pasien operasi dalam satu tahun
Plan	Rencana : - Mengetahui penyebab kunjungan pasien operasi tahun 2025 - Pasien operasi terdiri dari operasi besar, sedang dan kecil. Operasi kecil diantaranya adalah op phaco mata yang turun signifikan karena adanya Batasan/kuota BPJS Kesehatan Harapan : Kunjungan pasien operasi meningkat di tahun 2026 Tindakan : 1. Meningkatkan kunjungan IGD, poli dan rawat inap 2. Kerjasama dengan FKTP, PSC, Klinik dan Bidan untuk pasien trauma maupun PONEK bisa dikirim ke RSPHM
Do	Koordinasi dengan humas untuk melakukan promosi branding kecepatan pelayanan IGD dan pelayanan poli yang lengkap, agar kasus operatif juga naik
Study	- Koordinasi apakah materi promosi branding kecepatan pelayanan IGD dan pelayanan poli yang lengkap bisa disosialisasikan di sosmed, komunitas, maupun perujuk - Membuat video pelayanan IKO dengan branding kecepatan pelayanan saat operasi - Koordinasi pembagian kuota phaco tahun 2026 mengacu pada operasi phaco 2025
Action	- Mensosialisasikan pembagian kuota phaco di awal tahun pada dokter mata, agar bisa dikalkulasikan tindakan phaco tidak turun di satu bulan saja, karena ada target per bulan dan akan di evaluasi tiap 3 bulannya - Pembagian jumlah operasi phaco 2026 mengacu tahun 2025, tidak dibagi rata, agar kuota bsia teratur dibagi tiap bulannya - Video pelayanan unit IKO dan IGD sudah dibuat - Telah diadakan skrining mata oleh SMF mata, di acara HKN, prolanis dan geriatric yang berpotensi menjaring pasien poli mata Rencana tindaklanjut : Evaluasi pencapaian pada periode tahun 2026 diharapkan kunjungan pasien rawat inap bedah plastik meningkat dari tahun 2025

Tabel Kunjungan Ruang IKO Menurut Cara Bayar Pasien Tahun 2025

Bulan	BPJS	Umum	JKK	JR	Asuransi Lain
Jan	377	22	19	5	4
Feb	300	17	13	6	5
Mar	306	15	23	3	3
Apr	374	24	17	1	1
Mei	339	13	17	2	2
Juni	343	14	16	2	1
Juli	388	18	30	1	8
Agustus	359	12	24	6	11
September	348	14	25	4	4
Oktober	348	16	22	6	4
November	362	28	24	1	9
Desember	384	17	20	9	4
Total	4228	210	250	46	56

Grafik Kunjungan Ruang IKO Menurut Cara Bayar Pasien Tahun 2025



Analisis :

Hasil analisis dan evaluasi ditahun 2025 didapatkan bahwa pelayanan kamar operasi ditahun ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu dari 4542 menjadi 4873 atau meningkat sebanyak 29.55%. Hasil ini didukung oleh adanya Dokter Spesialis tambahan sehingga peningkatan masing-masing dokter spesialis semakin besar dan memberikan kontribusi terhadap jumlah pelayanan dikamar operasi. Analisa lainnya adalah dengan banyak jenis tindakan operasi yang bisa dilayani, kelengkapan alat operasi serta penambahan kebutuhan SDM baik kualitas dan kuantitas. Analisa terakhir adalah adanya peningkatan jumlah pelayanan pasien BPJS, BPJS ketenaga kerjaan serta pasien jasa raharja yang sudah bekerjasama dengan RS dan kepercayaan masyarakat akan kualitas dan kuantitas pelayanan dikamar operasi yang sangat bagus dan terjaga

Rencana Tindak Lanjut :

Rencana tindak lanjut ditahun 2025 adalah dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan yang sudah berjalan serta melakukan pembenahan dibeberapa yang kurang agar mampu memberikan pelayanan yang lebih baik lagi ditahun 2025 serta melakukan pembenahan terkait pembagian jam operasional operasi masing-masing DPJP. Serta tetap terus melakukan koordinasi dengan beberapa pihak seperti Kabid Pelayanan Medis, Kabid Penunjang Medis, Kabid Keperawatan, SDM dan Humas Marketing RS serta program RS yang ada untuk terus melakukan supervisi berjenjang.

No.	Deskripsi	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Jml	
1.	Bedah Umum:														
	Debridement Necrotomy	29	34	34	47	33	16	34	34	26	26	24	34	371	
	Excisi	24	38	24	37	23	39	29	27	32	37	37	29	376	
	HTHR	12	13	5	15	8	10	14	11	5	11	14	10	128	
	Appendectomy	9	3	7	3	3	5	4	8	13	9	3	14	81	
	Laparatomy	8	11	12	15	15	9	11	8	5	12	6	6	118	
	Hemoroidectomy	5	6	2	4	1	5	7	12	7	1	6	7	63	
	Biopsi	3	6	7	11	10	7	8	1	5	7	6	9	80	
	Cholesistectomy	3	1	0	2	4	2	3	2	2	0	1	3	23	
	Repair	1	0	4	3	3	1	1	1	0	1	1	2	18	
2	Obgin														
	SC	71	49	76	74	64	68	70	60	79	68	70	76	825	
	Histerectomy	3	1	2	3	4	1	3	3	2	5	3	2	32	
	Kistectomy	3	2	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	9	
	Myomectomy	2	1	0	1	1	0	1	0	0	1	3	0	10	
	Laparatomy	2	0	1	1	1	3	4	1	2	0	1	3	19	
	Curetage	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	
	Salphingoovorectomy	0	1	1	0	1	1	2	0	0	1	0	0	7	
	Salphingectomy	0	0	1	0	0	1	1	2	1	0	0	0	6	z
	Marsupialisasi	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	
	SVH BSO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
	Re Heacting	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	0	1	6	
	Partial Oovorectomy	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	2	0	6	
3	Orthopedi														
	Remove Implant	18	13	10	19	20	12	15	22	21	17	17	16	200	
	Orif	17	18	33	24	17	29	28	26	21	21	18	29	281	
	Repair	8	11	11	14	14	23	23	10	17	10	22	16	179	
	Close Reduction	5	9	6	9	6	14	14	10	8	10	13	10	114	
	Debridement	5	4	6	5	4	4	4	9	6	6	8	3	64	
	Hemiarthoplasty	2	0	1	1	0	0	3	1	0	1	4	0	13	
	Excisi	2	1	1	0	1	1	0	3	0	0	0	2	11	
	Release	1	2	2	1	0	0	2	0	0	0	0	1	9	
	Adv. Flap	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	
	Squestectomy	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	4	
	Aspirasi Hematrosis	0	0	0	0	2	1	1	0	0	1	0	0	5	
	Urologi														
	URS	15	10	9	10	10	9	8	6	14	4	13	9	117	
	TURP	13	11	6	12	14	3	13	8	8	9	10	8	115	

	Orchidopexy	4	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	6	
	Internal Uretrotomy	3	4	3	3	0	1	0	3	2	3	2	0	24	
	Vesicolithotripsi	2	4	1	2	0	0	2	0	2	4	2	4	23	
	Meatotomy	2	1	1	1	0	2	1	0	1	2	1	0	12	
	Corpectomy	1	1	0	0	2	1	0	1	0	1	0	1	8	
	ESWL	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
	URS + Aff Sten	1	1	5	5	7	4	6	1	1	4	5	2	42	
	Orchidectomy	0	1	0	0	2	0	1	1	0	0	0	0	5	
	Vesicolithotomy	0	0	0	0	1	0	2	0	0	4	0	0	7	
	Cistoskopi	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	2	0	6	
	Nefrolitotomy	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	
5	Bedah Plastik														
	Repair	5	11	13	10	12	10	9	9	8	12	14	11	124	
	Debridement	4	0	3	5	7	4	7	2	4	0	2	1	39	
	Rekontruksi	2	4	4	1	3	0	4	4	4	7	2	4	39	
	Remove Implant	0	0	1	0	0	1	0	1	0	2	2	4	11	
	Reposisi Nasal	0	0	0	0	2	1	1	3	0	0	1	1	9	
6	Mata														
	Phaco	35	43	22	38	36	45	47	42	35	36	54	54	487	
	Excisi	4	1	2	6	6	3	7	8	13	5	8	3	66	
	Extirpasi+Graft	3	5	1	3	1	4	6	3	8	3	4	3	44	
	Iridectomy	1	4	5	3	3	4	3	6	3	2	1	5	40	
	Graft Kornea	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	Explorasi	0	2	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	5	
	Debridement	0	0	1	0	0	0	0	2	2	0	0	0	5	
	Repair	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	
7	THT														
	Tonsilectomy	1	1	1	1	2	2	1	2	1	2	1	4	19	
	Kistectomy	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	
	Excisi	0	0	0	0	2	1	0	0	0	1	0	0	4	
	Biopsi	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
	Adenotonsilectomy	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
8	Kulit dan Kelamin														
9	Bedah Syaraf														
	Excisional Debridement	7	1	0	0	3	0	5	12	5	3	4	1	41	
	VP Shunt	3	1	0	0	1	0	2	2	3	1	1	0	14	
	Craniotomy	2	1	0	0	1	2	3	1	0	0	3	4	17	
	Evakuasi Hematom	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	4	
	EVD	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	0	0	4	
	Repair	0	0	0	0	0	5	3	1	1	5	2	4	21	

Cranioplasty	0	0	0	0	0	1	0	2	3	0	0	0	6	
Evakuasi ICH	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
Burrhole Drainage	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	

Analisa :

Analisa 10 besar tindakan operasi tahun 2025 untuk tindakan operasi paling tinggi adalah bedah umum dan obgyn. Untuk operasi terendah adalah THT-KL.

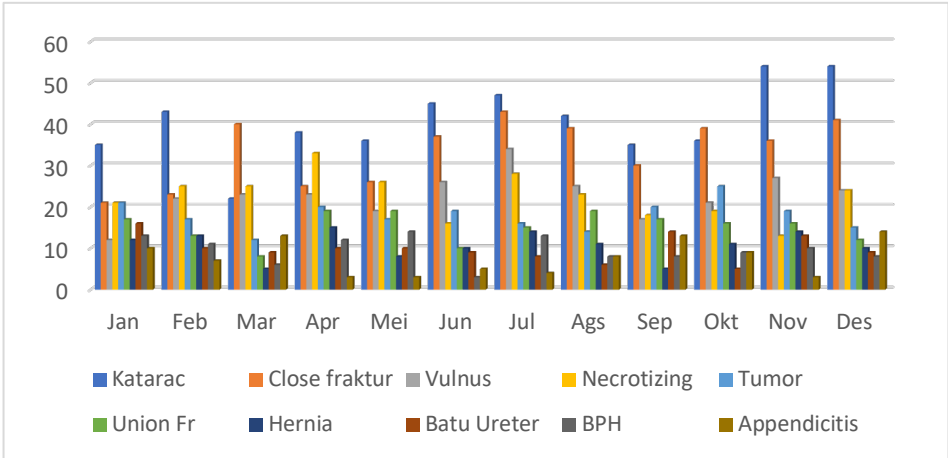
Rencana Tindak Lanjut :

Tetap mempertahankan kunjungan operasi yang naik akan tetapi sesuai dengan peraturan bpjs sehingga kunjungan tetap naik dan peraturan bpjs di patuhi oleh dpjp yang melakukan tindakan, target untuk tahun 2026 adalah meningkatkan operasi THT-KL yang bisa ditangani oleh RS

Tabel 10 Besar Diagnosa Operasi 2025

No	Hal	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jumlah Rekapitulasi	Ket
1.	Katarac	35	43	22	38	36	45	47	42	35	36	54	54	487	
2.	Close fraktur	21	23	40	25	26	37	43	39	30	39	36	41	400	
3.	Vulnus	12	22	23	23	19	26	34	25	17	21	27	24	273	
4.	Necrotizing	21	25	25	33	26	16	28	23	18	19	13	24	271	
5.	Tumor	21	17	12	20	17	19	16	14	20	25	19	15	215	
6.	Union Fr	17	13	8	19	19	10	15	19	17	16	16	12	181	
7.	Hernia	12	13	5	15	8	10	14	11	5	11	14	10	128	
8.	Batu Ureter	16	10	9	10	10	9	8	6	14	5	13	9	119	
9.	BPH	13	11	6	12	14	3	13	8	8	9	10	8	115	
10.	Appendicitis	10	7	13	3	3	5	4	8	13	9	3	14	92	

Grafik 10 Besar Diagnosa Operasi 2025



Analisa :

- 1. Jumlah operasi paling tinggi di rumah sakit prima husada malang yaitu oleh dr mata operasi katarak sebesar 487 pasien sesuai dengan kuota phaco yang ditentukan dari BPJS Kesehatan
- 2. Jumlah operasi terbesar kedua dari dr othopedi sebesar 400 pasien
- 3. Jumlah operasi pasien bedah dengan diagnose vulnus sebesar 273 pasien

Tabel Utilitas / Penggunaan Kamar Operasi 2025

No	Jam Kegiatan Operasi	Jumlah Pasien												Rata-rata (3 Kamar Operasi)
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	
1	05.00-06.00	41	34	31	47	40	34	42	43	40	55	55	59	174
2	06.00-07.00	43	42	49	50	45	48	61	52	46	35	41	44	185
3	07.00-08.00	51	40	49	53	38	42	56	50	42	42	46	47	185
4	08.00-09.00	30	29	42	38	28	35	46	31	27	26	43	36	137
5	09.00-10.00	13	18	17	25	20	26	24	12	18	23	20	16	77
6	10.00-11.00	5	5	3	9	12	5	6	6	5	8	7	1	24
7	11.00-12.00	5	5	3	9	7	5	9	7	5	4	7	9	25
8	12.00-13.00	11	8	15	17	18	12	20	19	17	25	21	24	69
9	13.00-14.00	25	20	24	20	25	16	19	19	17	18	23	13	80
10	14.00-15.00	13	12	14	18	13	7	9	13	14	15	8	12	49
11	15.00-16.00	22	15	23	15	14	19	18	22	27	23	17	26	80
12	16.00-17.00	19	26	18	28	14	21	27	27	32	32	21	28	98
13	17.00-18.00	8	11	8	12	7	14	10	15	18	10	10	15	46
14	18.00-19.00	16	11	6	12	15	12	18	14	14	15	11	15	53
15	19.00-20.00	9	9	5	9	15	12	8	14	11	11	13	15	44
16	20.00-21.00	10	0	7	5	8	8	7	7	11	4	7	4	26
17	21.00-05.00	7	3	5	3	5	2	5	6	3	4	5	5	18

Tabel Tindakan Anestesi 2025

No	Hal	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jumlah Rekapitulasi	Ket
Tindakan Anestesi di Kamar Operasi															
1.	GA	122	123	133	167	143	146	167	176	150	153	158	177	1815	
2.	Regional	205	166	187	182		173	218	182	197	200	204	193	2107	
3.	Lokal	42	51	30	46	48	57	60	54	48	43	62	63	604	
Tindakan Lokal Anestesi di Luar Kamar Operasi															
1.	Rawat Inap	10	3	4	2	4	12	10	13	14	6	3	16	97	
2.	Rawat Jalan	157	130	105	115	95	70	138	185	0	274	172	164	1605	
3.	IGD	-	26	27	26	0	0	19	0	23	21	0	15	157	
4.	Maternitas	39	20	34	42	28	29	18	51	45	47	30	46	429	
5.	ICU	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3	
6.	Radiologi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tindakan Sedasi di Luar Kamar Operasi															
1.	Rawat Inap	0	0	0	0	0	0	4	0	5	0	10	4	23	
2.	Rawat Jalan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	IGD	0	8	6	9	0	0	0	0	25	17	0	21	86	
4.	Maternitas	22	26	31	19	19	24	51	20	26	26	20	21	305	
5.	ICU	0	0	0	0	0	1	0	2	8	6	7	5	29	
6.	Radiologi	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	

Analisa :
Hasil analisis tindakan Anestesi yang dilakukan di RS Prima Husada Malang baik yang dilakukan di dalam Kamar Operasi maupun di luar kamar operasi adalah:
Untuk di dalam kamar operasi tindakan dengan regional anestesi lebih sering dilakukan dibanding dengan general anestesi. Hal ini sesuai dengan tindakan yang paling sering di lakukan di kamar operasi yaitu SC dimana pada pasien-pasien SC dilakukan pembiusan dengan Regional Anestesi.
Untuk pelaksanaan tindakan Lokal anestesi yang dilakukan di luar kamar operasi dengan dilakukannya supervisi ke luar kamar operasi sehingga data dilaporkan serta tindakan yang dilakukan juga terpantau. Untuk tindakan local anestesi di luar kamar operasi kebanyakan dilakukan di rawat jalan dan maternitas, sedangkan untuk sedasi kebanyakan dilakukan di ruang maternitas.

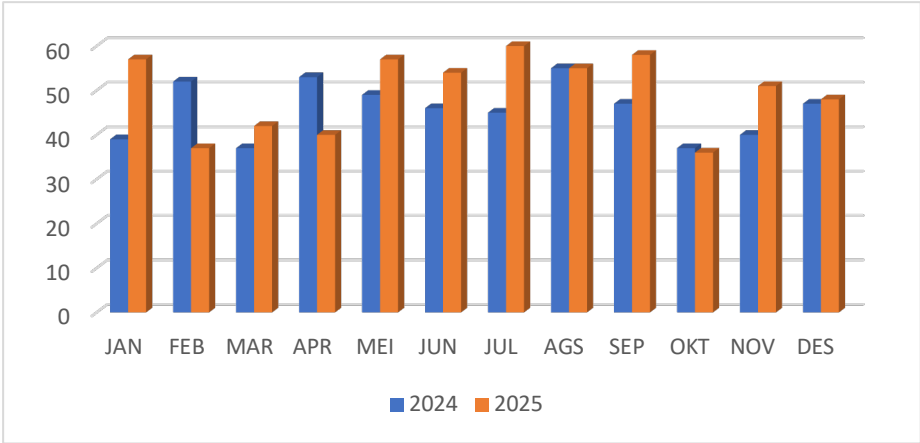
Rencana Tindak Lanjut :
Tetap melakukan supervisi terutama untuk tindakan anestesi yang dilakukan di luar kamar operasi, sehingga bila ada yang tidak sesuai agar bisa segera diluruskan

6.3.2.4 Intensive Care Unit (ICU)

Tabel Jumlah pasien di ICU Tahun 2024-2025

THN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	JUMLAH
2024	39	52	37	53	49	46	45	55	47	37	40	47	547
2025	57	37	42	40	57	54	60	55	58	36	51	48	595

Grafik Jumlah Pasien di ICU Tahun 2024-2025



Analisa :

Hasil analisis dan evaluasi ditahun 2025 didapatkan bahwa pelayanan rawat inap ICU ditahun ini kondisi stabil dan meningkat. Karena pasien yang di rawat di ICU berjalan sesuai kriteria Keluar dan Masuk ICU, dan sesuai dengan pedoman pelayanan di Unit ICU. dan untuk pasien BPJS pasien yang di rawat di ruang ICU sesuai dengan tingkat Tipe RS tipe C.

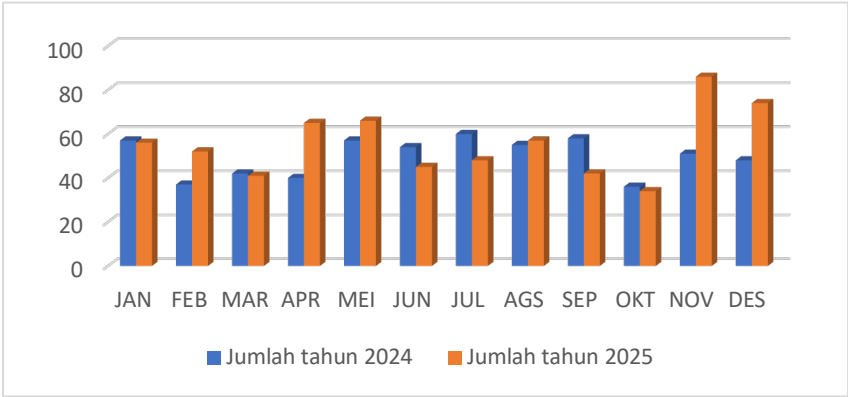
Rencana Tindak Lanjut :

Mempertahankan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan yang sudah berjalan serta melakukan pembenahan dibeberapa yang kurang agar mampu memberikan pelayanan yang lebih baik lagi ditahun 2026 serta melakukan pembenahan terkait penambahan fasilitas sarana dan prasarana di Ruang ICU

Tabel Kunjungan Rawat Inap ICU Menurut Cara Bayar

NO	HAL	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	JUMLAH REKAPITULASI	KET
1.	BPJS	55	35	40	39	56	52	57	45	55	34	49	43	560	
2,	UMUM	2	2	1	1	1	2	2	5	2	2	0	2	22	
3.	Asuransi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Pindahan	12	9	1	12	7	18	9	12	16	7	8	4	115	
5.	Dipindahka n	38	27	34	29	41	27	35	35	31	16	28	28	369	
6.	PP	0	0	1	0	1	1	0	2	0	0	0	0	5	
7.	Rujuk	6	3	4	4	2	5	12	5	5	5	7	7	65	
8.	Meninggal	10	6	3	10	14	21	10	10	21	14	14	11	144	
Jumlah tahun 2024		57	37	42	40	57	54	60	55	58	36	51	48	595	
Jumlah tahun 2025		56	52	41	65	66	45	48	57	42	34	86	74	666	

Grafik Kunjungan Rawat Inap ICU Menurut Cara Bayar



Analisa :
Hasil analisis dan evaluasi ditahun 2025 didapatkan bahwa pelayanan rawat inap di ICU tahun 2025 tertinggi dengan penjamin BPJS Kesehatan. Pasien terbanyak adalah pasien jantung, dilanjutkan dengan IPD , saraf dan pasien post op VP shunt.

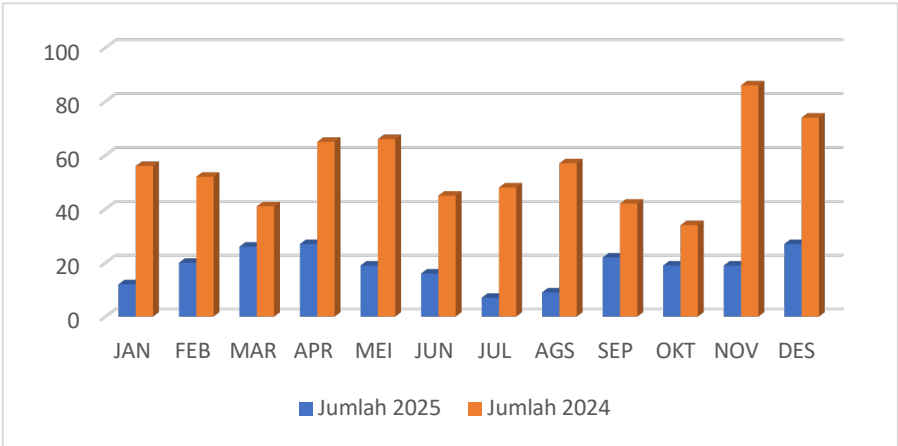
Rencana Tindak Lanjut :
Meningkatkan kunjungan BPJS Kesehatan dengan mengacu pada kriteria masuk dan keluar ICU. Saat ini perlu dipertimbangkan tarif kamar ICU, karena ada beberapa DPJP memberi masukan jika tarif ICU pasien bpjs terlalu tinggi, sehingga dapat berpotensi plafon minus sebelum pasien KRS

6.3.2.5 High Care Unit (HCU)

Kunjungan Rawat Inap HCU Menurut Cara Bayar 2025

NO	HAL	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	JUMLAH REKAPITULASI	KET
1.	BPJS	18	15	13	19	22	13	15	19	13	11	27	22	207	
2.	UMUM	0	1	1	2	0	0	1	0	1	0	1	2	9	
3.	ASSURANSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Pindahan	2	5	0	3	1	1	1	3	1	0	4	3	24	
5.	Di pindahkan	17	13	12	13	16	13	12	12	11	8	21	14	162	
6.	PP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Rujuk	1	0	1	4	2	3	3	0	2	2	4	3	25	
8.	Meninggal	0	2	0	3	3	1	0	4	0	1	1	5	20	
9.	KRS	18	15	13	19	22	13	15	19	13	11	27	22	207	
Jumlah 2025		12	20	26	27	19	16	7	9	22	19	19	27	668	
Jumlah 2024		56	52	41	65	66	45	48	57	42	34	86	74	666	

Grafik Kunjungan Rawat Inap HCU Menurut Cara Bayar 2025



Analisa :
Hasil analisis dan evaluasi ditahun 2025 didapatkan bahwa pelayanan rawat inap ditahun ini kondisi cukup stabil dan meningkat. Karena HCU buka tahun 2024, pasien yang di rawat di HCU berjalan sesuai kriteria Keluar dan Masuk HCU, dan sesuai dengan pedoman pelayanan di Unit HCU. dan untuk pasien BPJS pasien yang di rawat di ruang HCU sesuai dengan tingkat Tipe RS tipe C

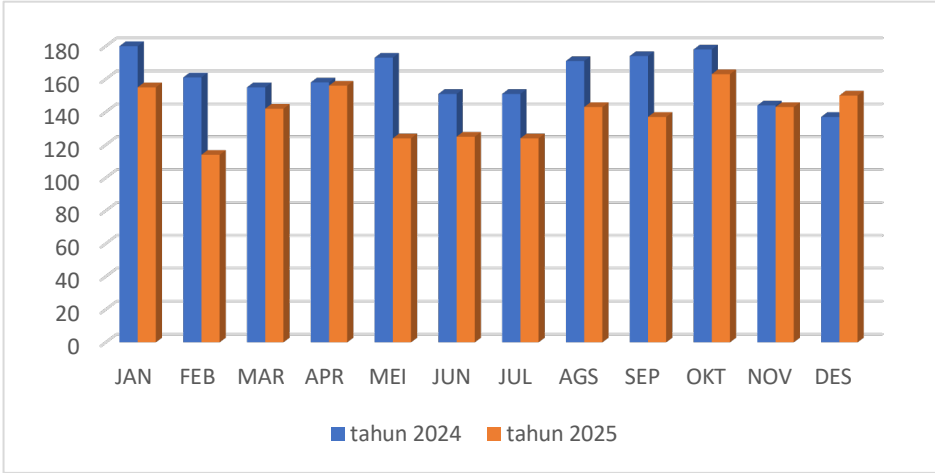
Rencana Tindak Lanjut :
Rencana tindak lanjut ditahun 2025 adalah dengan mempertahankan bahkan meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan yang sudah berjalan serta melakukan pembenahan dibeberapa yang kurang agar mampu memberikan pelayanan yang lebih baik lagi ditahun 2025 serta melakukan pembenahan terkait penambahan fasilitas sarana dan prasarana di Ruang HCU. Serta tetap terus melakukan koordinasi dengan beberapa pihak seperti Kabid Pelayanan Medis, Kabid Penunjang Medis, Kabid Keperawatan, SDM dan Humas Marketing RS serta program RS yang ada untuk terus melakukan supervisi berjenjang.

3.2.2.6 Maternitas

Tabel Kunjungan Rawat Inap Maternitas Menurut Cara Bayar 2025

Hal	Jan 2025	Feb 2025	Mar 2025	April 2025	Mei 2025	Juni 2025	Juli 2025	Ags 2025	Sept 2025	Okt 2025	Nov 2025	Des 202
BPJS	151	111	136	151	122	121	121	137	131	156	135	145
	0,13%	26,49	0,16%	99%	19,20%	0,81%	116%	4,37%	0,11%	5,12%	13,4%	0,06%
UMUM	4	3	6	5	2	3	3	4	5	6	7	5
	0,2%	25%	0,5%	16,6%	60%	33,3%	25%	20%	0%	16,6%	100%	0,28%
ASURANSI	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0
	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0,01%	0%	0%
Σ 2025	155	114	142	156	124	125	124	143	137	163	143	150
Σ 2024	180	161	155	158	173	151	151	171	174	178	144	137

Grafik Kunjungan Rawat Inap Maternitas Menurut Cara Bayar 2025



Analisa dan Rencana Tindaklanjut :

RAWAT INAP	ANALISIS	RTL	Kesimpulan
BPJS	Dari tabel dan grafik diatas tampak bahwa tren kunjungan pasien BPJS di Maternitas fleksibel naik turun Kunjungan tertinggi terjadi pada bulan Januari hal ini disebabkan karena beberapa pasien dengan diagnosa tertentu yang tidak bisa dilayani di faskes 1 sehingga harus dirawat di RS dan kunjungan paling rendah ada pada bulan 111 hal ini disebabkan karena pelayanan persalinan tidak ada komplikasi bisa dilayani di fasket tingkat 1 dan rujukan di tahun 2025 menurun yaitu 83 pasien dibandingkan tahun 2024 86 pasien. Total kunjungan dalam 1 tahun 2025 yaitu 1617 pasein, menurun jika dibandingkan dg tahun 2024 ada 1933 pasien, hal ini disebabkan karena pelayanan persalinan tidak ada komplikasi bisa dilayani di fasket tingkat 1	Meningkatkan pelayanan yang bekualitas agar bisa mencapai target disetiap bulan	Kunjungan menurun sehingga perlu Upaya peningkatan dan evaluasi program telusur sederhana
Umum	Dari tabel dan grafik diatas tampak bahwa tren kunjungan pasien Umum di Maternitas fleksibel naik turun Kunjungan tertinggi terjadi pada bulan November hal ini disebabkan karena banyak pasien yang menggunakan BPJS dan kunjungan paling rendah ada pada bulan mei hal ini disebabkan karena beberapa	Meningkatkan pelayanan yang bekualitas agar bisa mencapai target disetiap bulan	Kunjungan menurun sehingga perlu Upaya peningkatan dan evaluasi program telusur sederhana

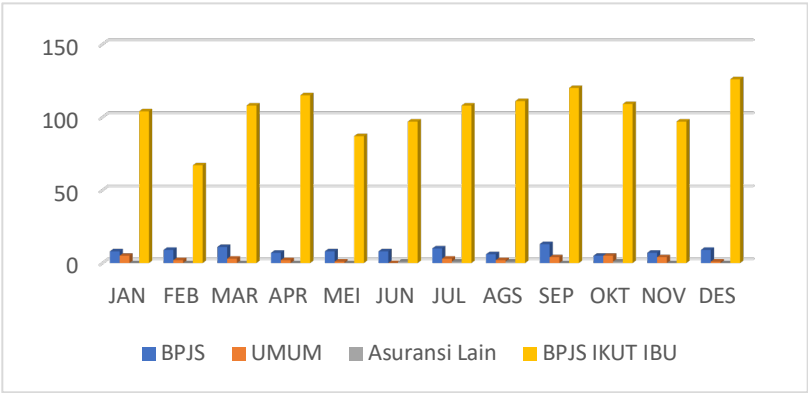
	pasien tidak mempunyai asuransi apapun. Total kunjungan dalam 1 tahun 2025 meningkat yaitu 53 pasien jika dibandingkan dengan tahun 2024 yaitu 52 pasien hal dikarenakan ada banyak pasien yang tidak mempunyai asuransi apapun		
JR/Asuransi	Dari tabel dan grafik diatas tampak bahwa tren kunjungan pasien Asuransi di Maternitas fleksibel hanya sedikit Pada bulan Juni,September, oktober jumlah pasien 1 orang,selain bulan ini tidak ada pasien asuransi, hal ini dikarenakan pasien lebih memilih memakai bpjs.	Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target disetiap bulan	Kunjungan menurun sehingga perlu Upaya peningkatan dan evaluasi program telusur sederhana

3.3.2.7 Neonatologi

Tabel Kunjungan rawat Inap Neonatologi Menurut Cara Bayar 2025

No	Hal	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jumlah Rekapitulasi	Ket
Klasifikasi Pembedahan															
1.	BPJS	8	9	11	7	8	8	10	6	13	5	7	9	101	
2.	UMUM	5	2	3	2	1	0	3	2	4	5	4	1	32	
3.	Asuransi Lain	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	4	
4.	BPJS IKUT IBU	104	67	108	115	87	97	108	111	120	109	97	126	1249	
Jumlah		117	78	122	124	96	106	122	120	137	120	108	136	1386	
Spesialisasi Per SMF															
1.	Anak	84	58	87	79	64	75	77	67	90	72	77	83	911	
2.	Obgyn	35	20	35	45	33	31	45	53	47	47	31	53	475	
Jumlah		119	78	122	124	97	106	122	120	137	119	108	136	1386	

Grafik Kunjungan Rawat Inap Neonatologi Menurut Cara Bayar 2025



Analisa dan RTL Kunjungan rawat Inap Neonatologi Menurut Cara Bayar 2025

NO.	BULAN	RAWAT INAP NEONATOLOGI			
		BPJS	UMUM	ASURANSI	BPJS IKUT IBU
1	JANUARI	8	5	0	104
	Analisis	Untuk pasien BPJS mengalami kenaikan dengan bulan sebelumnya sebanyak 6,84%	Untuk pasien Umum mengalami penurunan dengan bulan sebelumnya sebanyak 4,27%	Tidak ada pasien asuransi	Pasien BPJS Ikut Ibu mengalami kenaikan 88,9%
2	Februari	9	2	0	67
	Analisis	Untuk pasien BPJS mengalami kenaikan dengan bulan sebelumnya sebanyak 12,5%	Untuk pasien Umum mengalami penurunan dengan bulan sebelumnya sebanyak 6%	Tidak ada pasien asuransi	Pasien BPJS Ikut Ibu mengalami penurunan 35,6%
3	Maret	11	3	0	108
	Analisis	Untuk pasien BPJS mengalami kenaikan dengan bulan sebelumnya sebanyak 22,2%	Untuk pasien Umum mengalami kenaikan dengan bulan sebelumnya sebanyak 50%	Tidak ada pasien asuransi	Pasien BPJS Ikut Ibu mengalami kenaikan 61,2%
4	April	7	2	0	115
	Analisis	Untuk pasien BPJS mengalami penurunan dengan bulan sebelumnya sebanyak 36,3%	Untuk pasien Umum mengalami penurunan dengan bulan sebelumnya sebanyak 33%	Tidak ada pasien asuransi	Pasien BPJS Ikut Ibu mengalami kenaikan 6,48%
5	Mei	8	1	0	87
	Analisis	Untuk pasien BPJS mengalami penurunan dengan bulan sebelumnya sebanyak 14,3%	Untuk pasien Umum mengalami penurunan dengan bulan sebelumnya sebanyak 50%	Tidak ada pasien asuransi	Pasien BPJS Ikut Ibu mengalami penurunan 24,34%
6	Juni	8	0	1	97
	Analisa	Untuk pasien BPJS mengalami sma dengan bulan sebelumnya sebanyak 14,3%	Untuk pasien Umum mengalami penurunan dengan bulan sebelumnya sebanyak 50%	ada 1 pasien asuransi	Pasien BPJS Ikut Ibu mengalami kenaikan 11.5%
7	Juli	10	3	1	108
	Analisa	Untuk pasien BPJS mengalami kenaikan dengan bulan sebelumnya sebanyak 1,64%	Untuk pasien Umum mengalami kenaikan dengan bulan sebelumnya sebanyak 2,46%	ada 1 pasien asuransi	Pasien BPJS Ikut Ibu mengalami kenaikan 90,2%
8	Agustus	6	2	1	111
	Analisa	Untuk pasien BPJS mengalami penurunan dengan bulan sebelumnya sebanyak 3,33%	Untuk pasien Umum mengalami kenaikan dengan bulan sebelumnya sebanyak 0,83%	ada 1 pasien asuransi	Pasien BPJS Ikut Ibu mengalami kenaikan 2,5%
9	September	13	4	0	120
	Analisa	Untuk pasien BPJS mengalami kenaikan dengan bulan sebelumnya sebanyak 9,5%	Untuk pasien Umum mengalami kenaikan dengan bulan sebelumnya sebanyak 2,9%	Tidakada pasien asuransi	Pasien BPJS Ikut Ibu mengalami kenaikan 87,6%
10	Oktober	5	5	1	109
	Analisa	Untuk pasien BPJS mengalami penurunan dengan bulan sebelumnya sebanyak 6,8%	Untuk pasien Umum mengalami kenaikan dengan bulan sebelumnya sebanyak 3,3%	Ada 1 pasien asuransi	Pasien BPJS Ikut Ibu mengalami penurunan sebanyak 14,16%
11	November	7	4	0	97

	Analisa	Untuk pasien BPJS mengalami kenaikan dengan bulan sebelumnya sebanyak 6,5%	Untuk pasien Umum mengalami penurunan dengan bulan sebelumnya sebanyak 3,7%	Tidak ada pasien asuransi	Pasien BPJS Ikut Ibu mengalami penurunan sebanyak 11%
12	Desember	9	1	0	126
	Analisa	Untuk pasien BPJS mengalami kenaikan dengan bulan sebelumnya sebanyak 6,5%	Untuk pasien Umum mengalami penurunan dengan bulan sebelumnya sebanyak 3,7%	Tidak ada pasien asuransi	Pasien BPJS Ikut Ibu mengalami penurunan sebanyak 11%

Analisa : Hasil analisis dan evaluasi ditahun 2025 didapatkan bahwa pelayanan rawat inap ditahun ini mengalami kenaikan dan penurunan sebanyak 0,8% - 20% setiap bulannya. Hasil ini didukung oleh adanya penjamin BPJS Kesehatan yang sudah bekerjasama dengan RS dan fasilitas yang lebih lengkap di RS type C

Rencana Tindak Lanjut : Rencana tindak lanjut ditahun 2026 adalah dengan mempertahankan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan yang sudah berjalan serta melakukan pembenahan di beberapa yang kurang agar mampu memberikan pelayanan yang lebih baik lagi ditahun 2026 serta melakukan pembenahan terkait penambahan fasilitas sarana dan prasarana. Serta tetap terus melakukan koordinasi dengan beberapa pihak seperti Kabid Pelayanan Medis, Kabid Penunjang Medis, Kabid Keperawatan, SDM dan Humas Marketing RS serta program RS yang ada untuk terus melakukan supervisi berjenjang.

3.3.2.8 SHK

Hasil capaian SHK tahun 2025

Hasil capaian SHK tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah Spesimen : 1336
- b. Jumlah spesimen yang diperiksa : 1328
- c. Jumlah spesimen yang tidak dilakukan : 8 (pasien rujuk, meninggal <24 jam)
- d. Jumlah Sampel Rejected : 3
- e. Hasil TSH tinggi : 0
- f. Jumlah Konfirmasi : 0
- g. Jumlah Positive HK : 0

Jumlah Sampel Rejected Tahun 2025

NO	BULAN	JUMLAH REJECTED	KETERANGAN
1	Januari	0	
2	Februari	0	
3	Maret	0	
4	April	1	Sample tidak tembus pada kertas saring
5	Mei	1	Sample tidak tembus pada kertas saring
6	Juni	0	
7	Juli	0	
8	Agustus	1	Sample tidak tembus pada kertas saring
9	September	0	

10	Oktober	0	
11	November	0	
12	Desember	0	
Total		2	

Analisa dan Rencana Tindak Lanjut

NO	PENILAIAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
1	KIE orang tua dan keluarga terkait pelaksanaan SHK baik di RS maupun yang dilakukan di poli	√		Sudah dilakukan
2	Ada kendala KIE pada orang tua/keluarga, sebutkan	√		Beberapa orang tua bayi yang dengan SDM rendah, harus diulang beberapa kali, dengan orang tua yang dengan keterbatasan fisik (tuli, bisu)
3	Ada kendala penyediaan logistik pengambilan spesimen. Sebutkan		√	Penyediaan logistik dari Dinkes tidak ada kendala
				Pengiriman sampel teratur setiap hari senin, rabu dan jumat sehingga kertas saring tidak menandon terlalu lama
				Pengambilan spesimen pada bayi dengan kelainan biasanya spesimen gampang beku, sehingga segera mungkin untuk meneteskan pada kertas saring
4	Ada tenaga terlatih, baik dengan pelatihan atau kalakarya. Berapa	√		Semua perawat (8) bayi bisa melakukan SHK. Ada 1 perawat poli untuk SHK yang dilakukan di poli (jika sedang pelayanan, SHK tetap dilakukan di Unit Neo)
5	Berapa jumlah bayi yang dilakukan SHK	√		Dalam 1 tahun dilakukan sebanyak 1328 bayi
6	Ada penolakan pemeriksaan SHK oleh orang tua, sebutkan berapa	√		Ada 3-4 bayi, setelah dijelaskan mengenai fungsi, tata cara pengambilan dan sebagai syarat klaim penjamin ibu, keluarga setuju dan mau di lakukan

7	Ada hasil tinggi/ hasil normal/tidak bisa diperiksa, sebutkan berapa		√	Tidak ada hasil dengan TSH tinggi
8	Ada yang dilakukan tes konfirmasi, berapa		√	Tidak ada yang dilakukan tes konfirmasi
9	Ada yang mendapat pengobatan, sebutkan berapa		√	Tidak ada pengobatan lanjutan
10	Kendala dalam pelacakan kasus		√	Tidak ada
11	Mekanisme kerja SHK, berjalan baik/tidak	√		Sudah berjalan
12	Kualitas sampel tidak sesuai	√		Ada beberapa sample yang tidak sesuai (Tidak tembus, Terlalu sedikit, tidak sesuai dengan lubang di kertas saring) dan sudah dilakukan evaluasi ulang.
13	Pencatatan pada kertas saring	√		Ada beberapa penulisan masih menggunakan huruf kecil, harusnya Huruf Kapital.
				Penulisan kadang tidak lengkap
14	Penginputan data di stok kertas saring	√		Beberapa tidak menulis sesuai dengan list nama yang sudah tersedia sehingga menimbulkan miss komunikasi pada laporan stok Kertas Saring BMHP
15	Pengentrian data di Swalab	√		Sudah dilakukan dengan baik, tetapi kadang ada data yang tidak masuk saat di cek oleh dinkes, sehingga Tim melakukan entri data ulang agar terbaca.

3.3.3. Umum

3.3.3.1 Humas dana Marketing

3.3.3.1.1 PKS – IKS

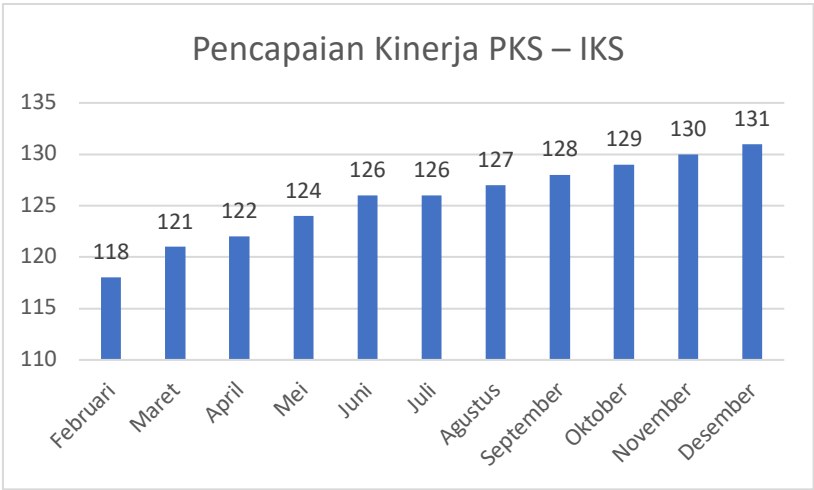
Tabel Pencapaian Kinerja PKS – IKS

No	Bulan	Target	Jumlah					
			Berlaku	ED	Baru	Kurang Baru	Progres	Total Kurang
1	Januari 2025	1 IKS baru	115	6	0	0	2 (review pihak kedua) 1 (progres evaluasi) 1 (tdk diperpanjang)	4
2	Februari 2025	1 IKS baru	118	1	1	0	3 (Proses Tanda Tangan Pihak kedua)	3
3	Maret 2025	1 IKS baru	121	1	1	0	1 (Proses review)	1
4	April 2025	1 IKS baru	122	1	1	0	1 (Proses Review Pihak ke 2)	1

5	Mei 2025	1 IKS baru	124	0	1	0	1 (Proses Review Pihak ke 2)	1
6	Juni 2025	2 IKS Baru	126	0	1	1	(2 Proses Review Pihak ke 2)	2
7	Juli 2025	1 IKS Baru	126	1	0	0	1 (Proses Review)	1
8	Agustus 2025	1 IKS	127	1	0	1	1 (Klinik Utama Kedungdoro)	1
9	September 2025	1 IKS	128	1	1	0	1 (Proses Review)	1
10	Oktober	1 IKS	129	0	1	0	1 (Proses Review)	1
11	November	1 IKS	130	1	0	1	1 (Proses Review)	1
12	Desember	1 IKS	131	2	1	0	2 (Proses TTD Pihak ke - 2) 1 (Proses Review)	3

- Analisis ;
- 1. Target PKS – IKS baru dalam satu tahun hanya memenuhi sebesar 66.67%
 - 2. Draft yang dikirim ke perusahaan masih dalam tahap review.
 - 3. Follow up ke perusahaan sudah dilakukan, tapi belum ada feedback.
- Rencana Tindak Lanjut :
- 1. Memfollow up PKS yang sudah dikirim ke pihak kedua

Grafik Pencapaian Kinerja PKS – IKS



Tabel Penambahan IKS Baru

NO	NAMA PKS	PROGRES PENGURUSAN	KENDALA
1	PT Nayaka Era Husada	Review pihak kedua	Selesai
2	Klinik Brawijaya Lawang	Review pihak kedua	Selesai
3	PT. Asuransi Mandiri Inhealth Manage Care Indonesia	Review pihak kedua	Selesai
4	PT. Kasoem Hearing	Proses TTD	Selesai
5	PT Global Excel	Review	Perbedaan template draft PKS
6	PT Malang Intermedia Pers	Review	Proses Perpanjangan
7	PT BNI Life Insurance	Penambahan Addendum	Selesai
8	Dispenduk Kab. Malang Ketan Ireng	Review (konfirmasi terakhir bulan April masih menunggu pihak sekda)	Proses pihak Dispenduk
9	PT Softex Indonesia (Kimberly-Clark Softex)	Review	Proses Perpanjangan
10	Kirim Proposal Nestle Event Lacto Club	Proses Event	Kirim Dokumen Tambahan
11	PT Mane Indonesia	Review	Proses Pihak Kedua
12	PT Pindad (Persero)	Review	Selesai
13	RS Panti Nirmala	Review	Proses
14	BRI Life	Review	Proses
15	Klinik Utama Kedungdoro	Review	Proses
16	TPA Halodoc	Review	Proses Review
17	Ambulance Relawan Siaga Utara	Review	Proses
18	PKS AXA Financial	Proses cetak	Proses
19	CV. Karunia Edi Peni (Aumireta Group)	Review	Proses
20	BPJS Ketenagakerjaan	Proses TTD Pihak kedua	Proses
21	BPJS Kesehatan	Proses TTD Pihak kedua	Proses

3.3.3.1.2 Medical Checkup

Tabel Hasil Kinerja MCU dan Vaksin

NO	BULAN	TARGET	JUMLAH PASIEN GOSHOW	ON SITE
1	Januari	25	95	-
2	Februari	25	135	-
3	Maret	150	156	43
4	April	150	56	53
5	Mei	150	115	-
6	Juni	150	210	-
7	Juli	150	254	-
8	Agustus	150	168	-
9	September	150	174	-
10	Oktober	150	202	39
11	November	150	165	
			68 (MCU Haji)	21 (MCU Haji)
12	Desember	150	197	

			30 (MCU Indonesian Tobacco)	
			40 (MCU Citra Karsa Dinamika)	
a. Analisis Berdasarkan data tersebut, jumlah pasien MCU & Vaksin rata – rata 185 orang perbulan, hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah pasien MCU & Vaksin mencapai target yang diinginkan yaitu 150 orang per bulan. b. Review Hasil Plan : 1. Meningkatkan capaian jumlah pasien MCU dan Vaksin secara konsisten setiap bulan 2. Mengoptimalkan kerja sama dengan perusahaan, instansi, dan kegiatan MCU on site 3. Menjadikan MCU dan vaksin sebagai salah satu layanan unggulan dengan target minimal tercapai 100% per bulan. 4. Mempromosikan program MCU setiap kali melakukan kunjungan ke instansi, komunitas, maupun perusahaan. 5. Melakukan koordinasi dengan bagian keuangan terkait review tarif MCU agar bisa bersaing dengan Fasilitas Kesehatan lainnya 6. Menjalin kerjasama dengan perusahaan maupun komunitas dan travel Haji (Khusus untuk meningkatkan Kunjungan peserta Vaksin) 7. Melakukan kunjungan ke perusahaan dengan mempromosikan layanan rumah sakit 8. Membuat konten promosi paket MCU yang laris pada tahun 2025 dan akan di Publish kembali pada tahun 2026 9. Mengajukan tarif harga Hot Deals MCU Package untuk perusahaan. Do : Pelaksanaan layanan MCU dan Vaksin selama tahun 2025 berjalan meliputi: 1. Pelayanan MCU dan Vaksin secara rutin di rumah sakit (baik Reservasi & Gshow) 2. Pelaksanaan MCU on site pada beberapa bulan tertentu 3. Penyelenggaraan MCU khusus, antara lain: - MCU Haji (November) - MCU kerja sama perusahaan (Indonesia Tobacco dan Citra Karsa Dinamika) pada bulan Desember Secara umum, pelaksanaan MCU berjalan sesuai rencana, dengan peningkatan aktivitas pada semester kedua. 4. Penyelenggaraan Vaksin khusus antara lain : - 20 Orang dengan Ibu Latifah (Juli) - 32 Orang dengan Travel Ustadz Erryk Kosbandhono (Agustus) - Abitour continue setiap ada jamaah dengan lokasi rumah dekat RS Prima Husada Malang Study : a. Evaluasi Capaian Target - Januari – Maret : capaian melebihi target yang ditetapkan - April – Mei : capaian belum memenuhi target 150 pasien/bulan - Juni – Oktober : terjadi peningkatan signifikan, bahkan melampaui target pada bulan Oktober - November – Desember: capaian dipengaruhi oleh MCU khusus dan kerja sama instansi				

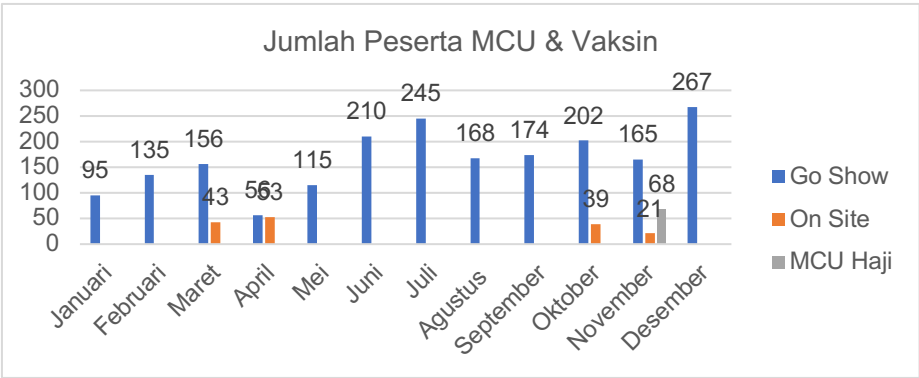
- Total penggunaan vaksin mengalami peningkatan signifikan mulai Bulan ke-6
 - Lonjakan tajam terlihat pada bulan 6–12 dengan total pelayanan bulanan antara 211–334 layanan
 - Vaksin dengan penggunaan tertinggi :
 - Meningitis: dominan dan stabil tinggi setiap bulan
 - Polio: mulai meningkat signifikan sejak Bulan ke-6
 - Vaksin Influenza: Penggunaan relatif rendah namun konsisten
 - Total layanan tertinggi pada Bulan ke-7: 334 pelayanan dan pada Bulan ke-12: 305 pelayanan
- b. Analisis Tren
- Terdapat tren peningkatan jumlah pasien MCU pada pertengahan hingga akhir tahun
 - Bulan dengan kegiatan MCU on site dan kerja sama menunjukkan capaian yang lebih tinggi
 - Peningkatan penggunaan vaksin sejalan dengan mulai aktifnya promosi dan informasi layanan dan bulan keberangkatan umroh
- c. Faktor Pendukung dan Penghambat
1. Faktor pendukung:
 - Kerja sama perusahaan dan instansi
 - Kegiatan MCU khusus (haji dan perusahaan)
 2. Faktor penghambat:
 - Belum meratanya jadwal MCU on site
 - Harga MCU mempengaruhi jumlah kunjungan MCU
 - Klien memilih harga MCU paling murah dan benefit MCU (Seperti snack/makan)
 - Beberapa perusahaan memilih MCU yang ditawarkan secara gratis dari klinik rekanan sebagai syarat pemenuhan dari Disnaker terkait kesehatan karyawan

Action :

Berdasarkan hasil evaluasi, ditetapkan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Menyusun jadwal MCU on site rutin minimal setiap triwulan
2. Meningkatkan kerja sama berkelanjutan dengan perusahaan dan instansi
3. Memperkuat promosi layanan MCU dan Vaksin melalui media sosial, brosur, dan jejaring HR perusahaan, Travel dan agensi Tour.
4. Menyesuaikan target MCU bulanan berdasarkan tren dan potensi riil
5. Melakukan evaluasi capaian MCU secara berkala untuk perbaikan berkelanjutan
6. Promosi telah dilakukan baik offline maupun online

Grafik Jumlah Peserta MCU & Vaksin



Tabel Evaluasi Hasil Penawaran MCU Tahun 2025

NO	BULAN	INSTANSI	HASIL
1	Januari	PT Berca Kawan Sejati Cab. Malang Official	Tidak ada konfirmasi dan Jawaban setelah di lakukan Follow Up
2	Februari	PT Pesta Pora	Tidak ada konfirmasi dan Jawaban setelah di lakukan Follow Up
		PT Green Mountains Natural Food	Konfirmasi untuk Peserta 106 orang
3	Maret	Meteor Cell Singosari	Sudah terlaksana
		PT Green Mountains Natural Food	Konfirmasi untuk Perubahan Peserta menjadi 53 orang dan pengajuan dengan Bus MCU
4	April	PT Green Mountains Natural Food	Sudah terlaksana
5	Mei	PT Kencana Tiara Gemilang	Sudah terlaksana 10 Orang Pelaksanaan di Rumah Sakit
		Laboratorium Radika Diagnostik	Sudah terlaksana 11 Orang Pelaksanaan di Rumah Sakit
6	Juni	PT Puninar Jaya	Sudah terlaksana 7 Orang Pelaksanaan di Rumah Sakit
		Laboratorium Radika Diagnostik	Sudah terlaksana 1 Orang Pelaksanaan di Rumah Sakit
7	Juli	PT Puninar Jaya	Sudah terlaksana 5 Orang Pelaksanaan di Rumah Sakit
		PT Indonesian Marine	Sudah terlaksana 5 Orang Pelaksanaan di Rumah Sakit
8	Agustus	PT Arjaya Mukti Santosa	Sudah terlaksana 4 Orang Pelaksanaan di Rumah Sakit
9	September	Sjava Travel Indonesia	Sudah terlaksana Vaksin dengan 32 Jamaah di Rumah Sakit
10	Oktober	PT Exel Mandiri Inovasi	Sudah terlaksana 39 Orang Pelaksanaan On Site Perusahaan
		PT Aneka Tuna Indonesia	Sudah terlaksana 2 Orang Pelaksanaan di Rumah Sakit
		PT Sukanda Djaya	Sudah terlaksana 5 Orang Pelaksanaan di Rumah Sakit
11	November	Shanaya Resort	Sudah terlaksana 3 Orang di Rumah Sakit, Deal untuk Setiap Karyawan Baru akan melakukan MCU di RS
		MCU Haji	Sudah terlaksana MCU Haji On Site PKM Ardimulyo 21 Orang
12	Desember	Shanaya Resort	Sudah terlaksana 4 Orang Pelaksanaan di Rumah Sakit
		PT Indonesian Tobacco Tbk	Sudah terlaksana 30 Orang Pelaksanaan di Rumah Sakit
		PT Citra Karsa Dinamika	Sudah terlaksana 40 Orang Pelaksanaan di Rumah Sakit

3.3.3.1.2 Rujukan Eksternal

Tabel Pencapaian Jumlah Pasien Rujukan Eksternal Klinik Satelit (3 MS) Berdasarkan Jenis Klinik Tahun 2025

UNIT	BULAN											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ANAK	37	27	32	25	28	27	26	34	28	30	36	33
BEDAH	30	31	18	36	22	32	31	46	29	27	19	40
BEDAH PLASTIK	0	1	0	0	3	0	0	0	0	2	1	1
BEDAH SARAF	1	1	0	0	3	1	1	1	1	1	1	0
PENYAKIT DALAM	118	121	108	108	102	82	169	104	158	131	124	117
GIGI ENDODONSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
GIGI PEDODONTIS	17	17	27	22	18	21	21	18	16	33	20	13
GIGI PERIODONTIS	2	4	3	4	0	3	2	3	8	6	5	10
INSTALASI REHABILITASI MEDIK	13	15	12	12	11	12	9	14	10	10	11	12
JANTUNG	92	76	81	62	103	73	69	87	68	65	83	78
JIWA	17	14	17	13	22	19	18	18	20	26	14	21
MATA	31	24	27	41	31	37	31	53	40	51	48	56
OBGYN	43	39	40	49	51	39	42	38	43	43	46	56
ORTHOPEDI	18	22	23	23	16	23	20	24	23	23	20	21
PARU	34	19	16	24	24	20	31	22	27	19	19	24
SARAF	84	71	59	77	60	54	85	73	76	65	73	58
THT	10	6	7	17	4	8	13	6	14	6	12	11
KELAMIN	9	4	4	8	7	7	8	15	7	14	15	11
UROLOGI	17	17	17	16	21	18	18	12	16	20	15	26
IGD	50	41	55	60	50	59	80	85	100	100	85	113
JUMLAH	623	550	546	597	576	535	674	653	684	672	647	709
Analisa : Review hasil Rujukan Eksternal pasien. Plan : 1. Menjaga stabilitas dan meningkatkan jumlah kunjungan pasien 2. Rujukan eksternal terkelola dengan baik sesuai indikasi medis Do : 1. Pelaksanaan rujukan pasien sesuai indikasi medis dan prosedur rujukan 2. Koordinasi dengan fasilitas kesehatan rujukan 3. Pencatatan dan rekapitulasi data rujukan perbulan 4. Monitoring rujukan oleh unit pelayanan terkait Study : a. Evaluasi Data • Total rujukan eksternal selama tahun 2025 menunjukkan tren fluktuatif dengan total bulanan antara 535–709 pasien • Rujukan tertinggi terjadi pada Bulan ke Desember sebanyak 709 pasien dan Bulan Juli sebanyak 674 Pasien • Rujukan terendah terjadi pada Bulan ke juni yaitu 535 pasien • Klinik dengan Rujukan Tertinggi yaitu Klinik Penyakit Dalam dengan konsisten tinggi setiap bulan • Klinik Jantung dan Saraf juga menunjukkan volume rujukan besar dan stabil • Sedangkan pada Klinik Obgyn dan Mata meningkat pada semester II b. Analisis Tren • Tingginya rujukan pada Penyakit Dalam, Jantung, dan Saraf mengindikasikan tingginya kasus kronis dan kompleks												

- Lonjakan IGD pada akhir tahun menunjukkan peningkatan kasus akut dan kebutuhan fasilitas rujukan lanjutan
 - Fluktuasi bulanan dipengaruhi oleh variasi kasus serta sarana prasarana layanan
- c. Faktor Pendukung dan Penghambat**
1. Faktor pendukung:
 - Ketersediaan Pelayanan IGD 24 jam
 - Stabilitas pelayanan IGD
 2. Faktor penghambat:
 - Beberapa DPJP tidak praktek dan cuti
 - Pembatasan kunjungan oleh BPJS
 - Angka Rujukan yang ditekan oleh BPJS membuat kunjungan pasien menurun
 - Tidak tersedianya fasilitas pelayanan di Rumah Sakit Prima Husada sesuai dengan kondisi penyakit pasien yang membutuhkan sarana prasana tingkat lanjutan
 - Plavon biaya asuransi habis tetapi pasien masih membutuhkan perawatan.
- Act :
1. Penguatan layanan klinik dengan rujukan tinggi (Penyakit Dalam, Jantung, Saraf)
 2. Monitoring dan evaluasi rujukan eksternal secara berkala (triwulan)
 3. Memperkuat hubungan dengan Faskes pertama

Tabel Pencapaian Jumlah Pasien Rujukan Eksternal Ambulance Resita Tahun 2025

BULAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Jumlah Rujuk masuk	7	5	7	6	8	4	8	19	17	11	10	15

3.3.3.1.3 Digital Marketing

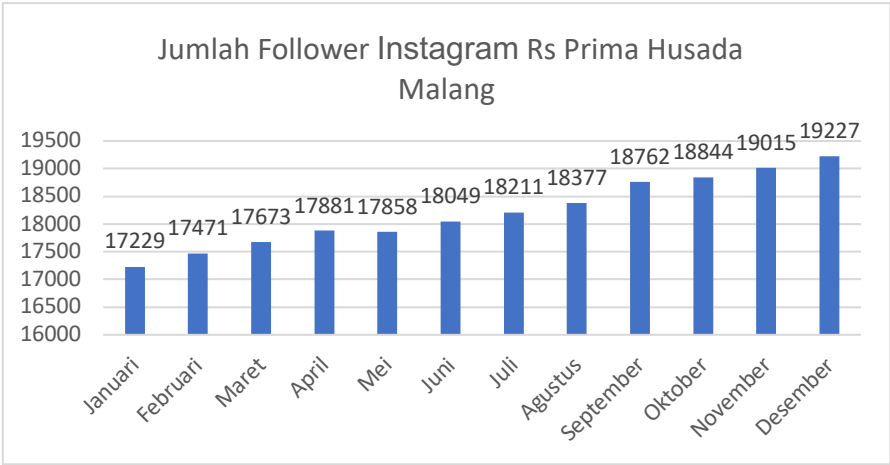
Tabel Rekapitulasi Hasil Instagram

Bulan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Jumlah Follower	17,229	17,471	17,673	17,881	17,850	18,049	18,211	18,377	18,762	18,844	19,015	19,227

Tabel Jumlah Peningkatan Follower Media Sosial Instagram

Bulan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Peningkatan Follower	496	242	202	208	374	286	346	283	385	82	171	212
Target	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300

Grafik Jumlah Follower Instagram RS Prima Husada Malang



ANALISA :

- 1. Plan (Perencanaan) :
 - Memperluas jangkauan informasi dan promosi layanan rumah sakit
 - Meningkatkan engagement dan citra positif rumah sakit di media digital dengan Konten edukatif, informatif, dan promotif yang konsisten sepanjang tahun kolaborasi dengan PKRS
- 2. Do (Pelaksanaan)
 - Publikasi konten rutin berupa edukasi kesehatan, promosi layanan, dan informasi kegiatan RS
 - Pemanfaatan fitur Instagram (feed, story, reel)
 - Kolaborasi internal dengan unit pelayanan untuk penyediaan materi konten
 - Monitoring jumlah follower dan performa akun secara berkala
- 3. Study (Studi / Evaluasi Hasil)
 - a. Evaluasi Capaian
 - Jumlah follower Instagram meningkat dari 17.229 pada awal tahun menjadi 19.227 pada akhir tahun
 - Terjadi kenaikan total follower sebanyak 1.998 akun selama periode pelaporan
 - b. Evaluasi Peningkatan Follower Bulanan
 - Peningkatan follower melampaui target (300) pada beberapa bulan, antara lain bulan 1, 2, 4, 6, dan 7
 - Pada beberapa bulan lain, capaian peningkatan follower belum mencapai target, terutama pada bulan 9 dan 10
 - c. Analisis Tren
 - Secara umum terdapat tren peningkatan follower yang positif dan konsisten
 - Penurunan capaian pada beberapa bulan menunjukkan perlunya strategi konten baru
- 4. ACT (Tindak Lanjut / Perbaikan)
 - Meningkatkan konten video pendek (reels) untuk memperluas jangkauan
 - Kolaborasi dengan Komite PKRS untuk memperkaya variasi konten
 - Monitoring capaian follower setiap bulan dan evaluasi strategi konten

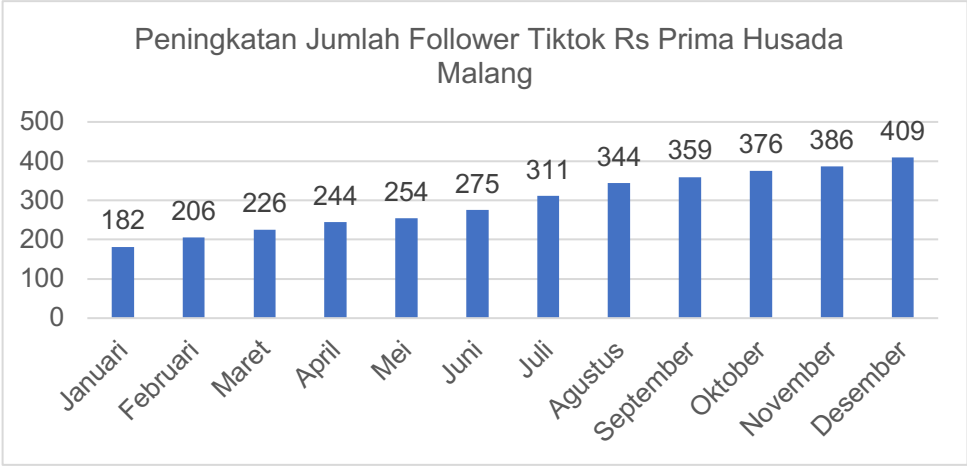
Tabel Jumlah Follower Media Sosial Tiktok

Bulan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Jumlah Follower	182	206	226	244	254	275	311	344	359	376	386	409

Tabel Jumlah Peningkatan Follower Media Sosial Tiktok

Bulan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Peningkatan Follower	16	24	20	18	10	21	36	33	15	17	10	23
Target	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Grafik Peningkatan Jumlah Follower Tiktok



ANALISA :

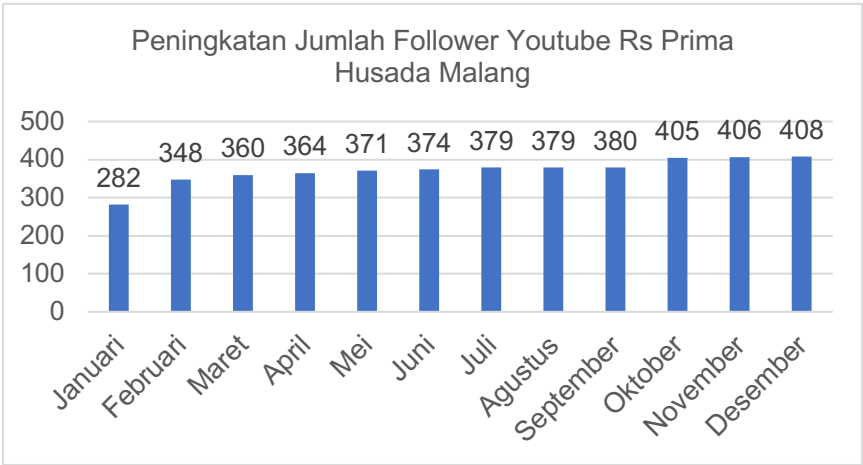
1. Plan (Perencanaan) :
 - Memperluas jangkauan informasi dan promosi layanan rumah sakit
 - Meningkatkan engagement dan citra positif rumah sakit di media digital dengan Konten edukatif, informatif, dan promotif yang konsisten sepanjang tahun kolaborasi dengan PKRS
2. Do (Pelaksanaan)
 - Pengunggahan konten TikTok secara rutin setiap bulan
 - Variasi Konten dengan Edukasi Kesehatan, Informasi layanan rumah sakit serta Dokumentasi kegiatan dan event
 - Pemanfaatan format video pendek sesuai tren TikTok
 - Penggunaan caption informatif dan hashtag
3. Study (Studi / Evaluasi Hasil)
 - a. Hasil Capaian
 - Jumlah follower meningkat dari 182 (Bulan Januari) menjadi 409 (Bulan Desember)
 - Total kenaikan follower selama 1 tahun: 227 follower
 - Rata-rata peningkatan follower per bulan: ± 19 follower
 - Peningkatan tertinggi terjadi pada Bulan Juli sebesar 36 follower dan Bulan 8 yaitu sebesar 33 follower
 - Seluruh bulan belum mencapai target 100 follower/bulan
 - b. Analisa Temuan:
 - Pertumbuhan follower bersifat stabil namun lambat
 - Konten TikTok belum sepenuhnya mampu menjangkau audiens baru secara luas
 - Belum adanya pemanfaatan iklan TikTok (TikTok Ads)
4. ACT (Tindak Lanjut / Perbaikan)
 - Menyusun kalender konten TikTok bulanan dengan tema yang lebih variatif dan trending
 - Meningkatkan frekuensi unggahan konten
 - Mengoptimalkan Penggunaan hashtag trending, Audio dan format video viral
 - Melakukan evaluasi bulanan terhadap performa konten (reach, engagement, follower growth)

Tabel Jumlah Peningkatan Follower Media Sosial Youtube

Bulan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Jumlah Subscribe	282	348	360	364	371	374	379	379	380	405	406	408

Tabel Jumlah Peningkatan Follower Media Sosial Youtube												
Bulan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Peningkatan Subscribe	4	66	12	4	7	3	5	0	1	25	1	2
Target	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

Grafik Peningkatan Jumlah Follower Youtube



ANALISA :

- Plan (Perencanaan) :
 - Memperluas jangkauan informasi dan promosi layanan rumah sakit
 - Meningkatkan jumlah subscriber kanal YouTube RSPHM sebagai sarana edukasi kesehatan, publikasi kegiatan, dan promosi layanan rumah sakit.
- Do (Pelaksanaan)
 - Pemanfaatan kanal YouTube sebagai media arsip konten audiovisual
- Study (Studi / Evaluasi Hasil)
 - Hasil Capaian
 - Jumlah subscriber meningkat dari 282 (Bulan Januari) menjadi 408 (Bulan Desember)
 - Total kenaikan subscriber selama periode laporan: 126 subscriber
 - Rata-rata peningkatan subscriber per bulan: ±10 subscriber
 - Peningkatan tertinggi terjadi pada Bulan Februari yaitu sebanyak 66 subscriber dan Bulan Oktober yaitu sebanyak 25 subscriber
 - Terdapat bulan tanpa peningkatan subscriber pada Bulan Agustus
 - Sebagian besar bulan belum mencapai target 20 subscriber/bulan
 - Analisa Temuan:
 - Pertumbuhan subscriber tidak stabil dan cenderung fluktuatif
 - Ketergantungan pada momen atau kegiatan tertentu (event) untuk peningkatan subscriber
- ACT (Tindak Lanjut / Perbaikan)
 - Menetapkan PIC khusus pengelola YouTube karena YouTube digunakan untuk Tiga Rumah Sakit
 - Menyusun Thumbnail yang menarik untuk mengembangkan konten
 - Melakukan promosi silang melalui Instagram, TikTok, dan Website rumah sakit
 - Evaluasi performa YouTube setiap bulan

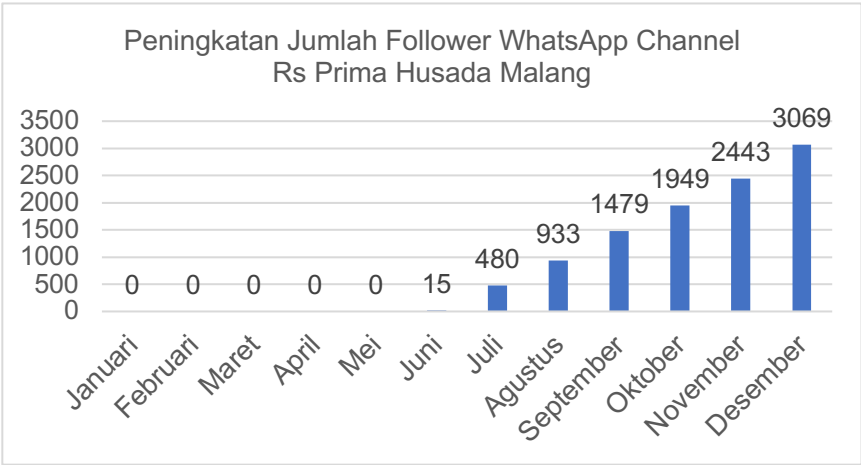
Tabel Jumlah Peningkatan Follower Media Sosial WhatsApp Channel

Bulan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Jumlah Subscribe	0	0	0	0	0	16	480	933	1479	1949	2443	3069

Jumlah Peningkatan Follower Media Sosial WhatsApp Channel

Bulan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Peningkatan Subscribe	0	0	0	0	0	16	464	453	546	470	494	626
Target	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

Grafik Peningkatan Jumlah Follower WhatsApp Channel



ANALISA :

1. Plan (Perencanaan) :
- Memperluas jangkauan informasi dan promosi layanan rumah sakit
 - Mengembangkan WhatsApp Channel sebagai media komunikasi resmi rumah sakit dalam menyampaikan informasi layanan, edukasi kesehatan, dan kegiatan rumah sakit kepada masyarakat.
2. Do (Pelaksanaan)
- Pemanfaatan WhatsApp Channel resmi RSPHM ebagai media Publikasi Informasi layanan, edukasi, promo dan informasi kegiatan maupun pengumuman resmi
3. Study (Studi / Evaluasi Hasil)
- a. Hasil Capaian
- WhatsApp Channel mulai aktif pada Bulan ke-6
 - Jumlah subscriber meningkat signifikan dari 0 menjadi 3.069 subscriber pada Bulan ke-12
 - Total peningkatan subscriber sejak kanal aktif: 3.069 subscriber
 - Seluruh bulan aktif (Bulan 6–12) melampaui target 20 subscriber/bulan
 - Peningkatan tertinggi terjadi pada Bulan Desember : 626 subscriber dan pada Bulan September : 546 subscriber
- b. Analisa Temuan:
- WhatsApp Channel sangat efektif sebagai media komunikasi langsung
 - Lonjakan subscriber dipengaruhi oleh ingginya kebutuhan informasi resmi rumah sakit dan kemudahan akses dan penggunaan WhatsApp oleh masyarakat
 - Konten bersifat informatif dan praktis lebih diminati oleh subscriber
4. ACT (Tindak Lanjut / Perbaikan)

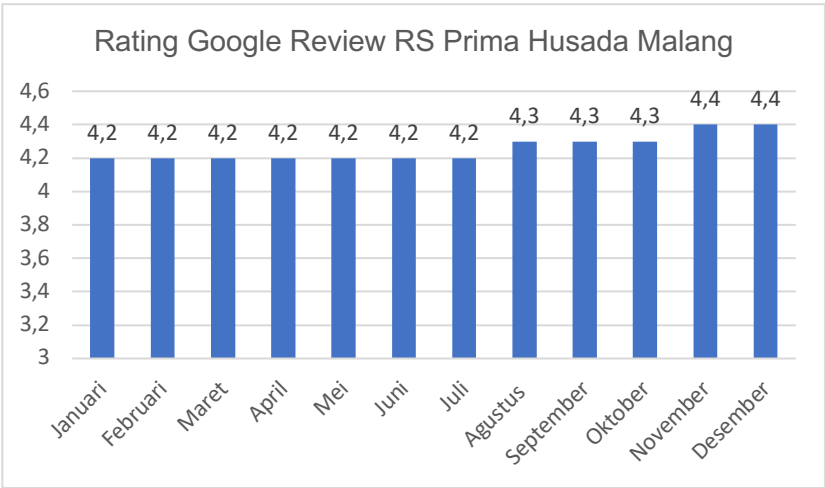
- Meninformasikan update jadwal setiap hari dan menyusun jadwal konten yang dapat di publish pada WA channel
- Menambahkan ajakan berlangganan (CTA) pada Loker pendaftaran, dan pada Media sosial lain
- Evaluasi performa Channel setiap bulan

3.3.3.1.4 Kepuasan Pasien

Tabel Capaian Rating Google Review

PROGRESS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
JUMLAH RATING	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.3	4.3	4.3	4.4	4.4

Grafik Rating Google Review RS Prima Husada Malang



BULAN	KOMENTAR POSITIF	KOMENTAR NEGATIF
Jan-25	18	6
Feb-25	13	6
Mar-25	7	5
Apr-25	25	10
May-25	15	7
Jun-25	19	3
Jul-25	60	3
Aug-25	44	10
Sep-25	104	5
Oct-25	173	9
Nov-25	117	6
Dec-25	115	8

ANALISA :

- Plan (Perencanaan) :
 - Mempertahankan rating Google Review minimal $\geq 4,2$
 - Mendorong peningkatan rating secara bertahap sepanjang tahun

2. Do (Pelaksanaan)
 - Monitoring rutin rating dan ulasan Google Review setiap bulan
 - Tindak lanjut terhadap keluhan dan masukan pasien yang disampaikan melalui ulasan
 - Koordinasi dengan unit terkait untuk perbaikan pelayanan
 - Edukasi dan motivasi kepada petugas layanan untuk menjaga sikap ramah dan komunikatif
3. Study (Studi / Evaluasi Hasil)
 - a. Evaluasi Capaian Rating
 - Rating Google Review pada awal tahun berada pada angka 4,2 dan stabil hingga bulan ke-7
 - Terjadi peningkatan rating mulai bulan ke-8 menjadi 4,3
 - Pada akhir tahun, rating meningkat menjadi 4,4
 - b. Analisis Tren
 - Secara keseluruhan terdapat tren peningkatan positif rating Google Review
 - Stabilitas rating pada awal tahun menunjukkan kualitas layanan yang konsisten
 - Peningkatan rating pada akhir tahun mencerminkan dampak positif dari perbaikan pelayanan dan respons terhadap masukan pasien
 - c. Faktor Pendukung dan Penghambat
 1. Faktor pendukung:
 - Respons aktif terhadap ulasan pasien
 - Perbaikan berkelanjutan pada pelayanan
 - Komitmen unit layanan terhadap mutu pelayanan
 2. Faktor penghambat:
 - Masih adanya ulasan negatif yang bersifat subjektif
 - Tidak semua pasien memberikan ulasan setelah menerima layanan
4. ACT (Tindak Lanjut / Perbaikan)
 - Mempertahankan monitoring Google Review secara rutin dan terstruktur
 - Menindaklanjuti ulasan negatif dengan cepat dan tepat
 - Memperkuat budaya pelayanan prima di seluruh unit
 - Mendorong pasien yang puas untuk memberikan ulasan secara sukarela

3.3.3.2 IPSRS

3.3.3.2.1 Pemeliharaan AC Split

Penghitungan capaian berdasarkan jumlah kunjungan per unit oleh elektromedis ke unit-unit di rumah sakit (39 ruang) dalam satu bulan

Tabel Capaian Maintenance Alat Medis Berdasarkan Ruangan

	Target	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
Capaian Maintenance Ruangan	90%	84.61%	66.6%	92.3%	76,92%	89,74%	69.2%	82.05%	64.10%	53,8%	84,61%	74,35%	82,05%

Tabel Capaian Maintenance Alat Medis Berdasarkan Jumlah Alkes

Bulan	Total Alat	Capaian	Prosentase
Januari	268	154	57.46%

Februari	270	135	50.00%
Maret	276	153	55.43%
April	276	150	54.34%
Mei	275	142	51.64%
Juni	276	165	59.78%
Juli	276	166	60.14%
Agustus	276	194	70%
September	276	77	27,8%
Oktober	276	136	49.27%
November	276	131	47,46%
Desember	276	138	50.00%

Tabel Jumlah Perbaikan Alkes

Total Alat (Perbaikan)	Total Alat
Januari	21
Februari	22
Maret	21
April	17
Mei	26
Juni	15
Juli	25
Agustus	29
September	17
Oktober	17
November	16
Desember	16

Analisa :
Rata-rata capaian maintenance alat berdasarkan maintenance ruangan tahun 2025 adalah 78% dan capaian maintenance total alat rata-rata adalah 55.81%. Hal ini telah disesuaikan dengan jam kerja atem dalam satu bulan menggunakan jadwal terstruktur. Kerusakan alat per bulan berada pada jumlah 20 alat per bulan.

Rencana Tindak Lanjut :
Koordinasi dengan PT untuk rekrutmen ATEM sesuai ABK (tidak ada pemenuhan rekrutmen)

3.3.3.2.2 Pemeliharaan Alat Non Medis
3.3.3.2.2.1 Air Conditioner

Tabel Capaian Pemeliharaan AC Split

Bulan	Maintenance / 1 Bulan	Maintenance / 2 Bulan	Maintenance / 3 Bulan	Total
TARGET/BULAN	42	30	23	95
JANUARI	11	6	16	33
FEBRUARI	23	17	11	51
MARET	14	41	6	61

APRIL	7	30	6	43
MEI	19	18	18	45
JUNI	7	16	2	25
JULI	15	21	12	48
AGUSTUS	3	4	16	23
SEPTEMBER	9	21	20	50
OKTOBER	6	13	10	29
NOVEMBER	1	21	16	38
DESEMBER	5	18	11	34

Analisa :
 Total target pemeliharaan AC per bulan tidak tercapai. Akan disesuaikan lagi jadwal Maintenance untuk tahun 2026. SDM juga mengcover 3 klinik Mutiara Sehat untuk maintenance AC.

Rencana Tindak Lanjut :
 Monitoring dan evaluasi

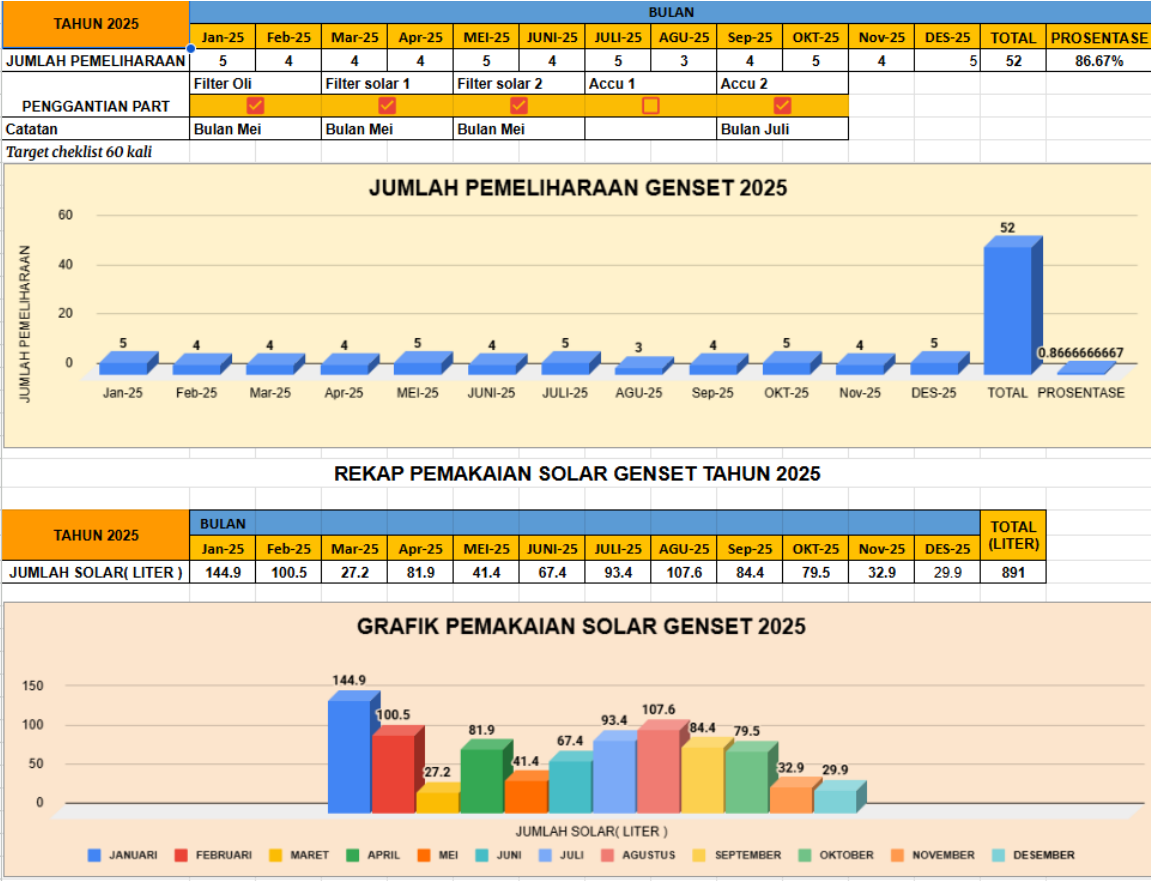
Link terlampir :
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y9Y3r4WUcch1rpMPxi3kN2P5nlyuxZi/edit?gid=1966879934#gid=1966879934>

3.3.3.2.2 Genset

Tabel Capaian Pemeliharaan Genset

Bulan	Jumlah Target (satu bulan)	Capaian	Prosentase	Keterangan
Januari	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
Februari	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
Maret	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
April	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
Mei	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
Juni	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
Juli	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
Agustus	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target

September	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
Oktober	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
November	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
Desember	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target



Analisa :
Tahun ini pemeliharaan genset sesuai jadwal dan terdokemuntasikan dengan baik. Adanya pelatihan SDM terkait genset menambah ilmu dan tanggung jawab dari PIC.

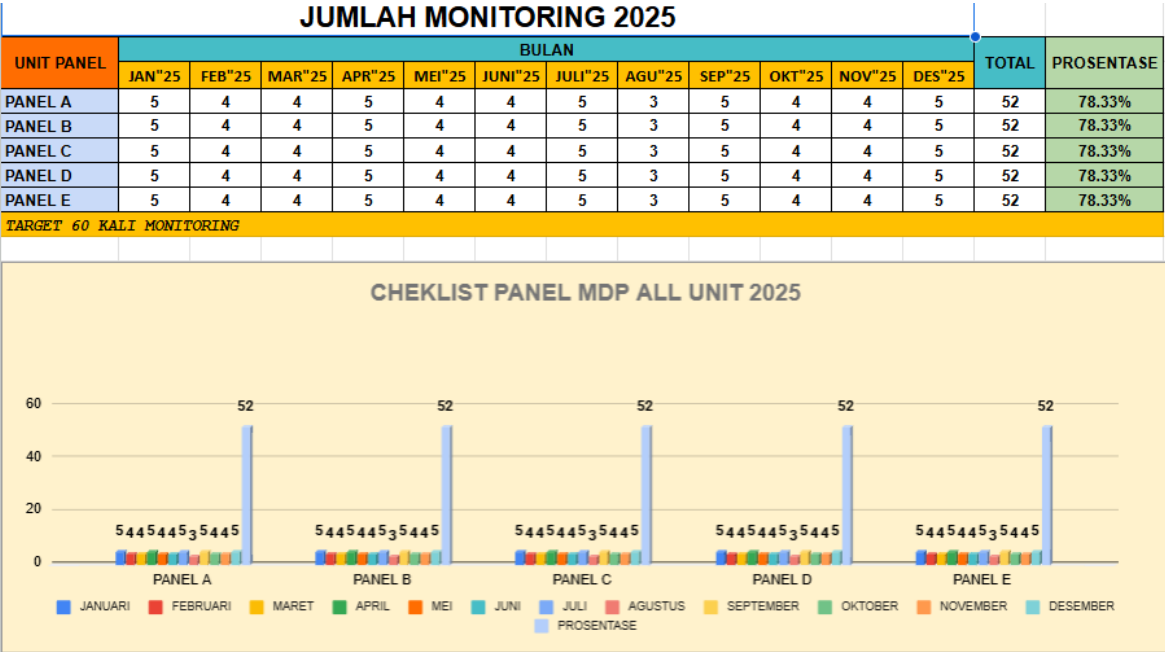
Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi berkala

Melalui link :
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-0AHgFu5NWnMdL9DwChzZ8cqQ21Y7Yq/edit?gid=331213613#gid=331213613>

3.3.3.2.2.3 Panel Listrik

Tabel Capaian Pemeliharaan Panel

Bulan	Jumlah Target (satu bulan)	Capaian	Prosentase	Keterangan
Januari	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
Februari	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
Maret	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
April	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
Mei	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
Juni	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
Juli	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
Agustus	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
September	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
Oktober	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
November	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
Desember	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target



Analisa :
Tahun ini pemeliharaan sesuai jadwal dan terdokemuntasikan dengan baik.

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan Evaluasi berkala.

- 1. Link Pemeliharaan Panel Gedung A
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-OVT5xA94U2TSG8tH6bNy0gRcMuU_4RqYxMOXGcKDak/edit?gid=1699997914#gid=1699997914
- 2. Link Pemeliharaan Panel Gedung B
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1J3DNzWtaJuGr0_n0VwQ-B5rVBmAXgBawC-xvfGxNyH4/edit?gid=104937937#gid=104937937
- 3. Link Pemeliharaan Panel Gedung C
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mDC2yPFf6ovPlwtTBJIEAV-PcRDqgikK6aIZ1UCQAVw/edit?gid=282071060#gid=282071060>
- 4. Link Pemeliharaan Panel Gedung D
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qyvPCZOKYMnaQl8Jn4qfdpDmrY7Cf_sbbNMwiHo2nTo/edit?gid=784906677#gid=784906677
- 5. Link Pemeliharaan Panel Gedung E
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DyEAielfLJ0EMBM7v3H5o93IFTiVtH_opz81Y2nMAIs/edit?gid=1010874025#gid=1010874025

3.3.3.2.2.4 Liquid Oksigen

Tabel Pemakaian Liquid Oksigen

LIQUID OKSIGEN	BULAN												TOTAL	LITER	MILILITER	CM KUBIK	GALON
	JAN-25	FEB-25	MAR-25	APR-25	MEI-25	JUNI-25	JULI-25	AGU-25	SEP-25	OKT-25	NOV-25	DES-25					
PEMAKAIAN	7658	7384	6677	7031	7597	7495	8449	8181	7801	8410	8175	8440	78256	1513.220621	1513220.621	1513220621	399490.2439
PENGISIAN	9028	6197	6057	4697	6407	8298	7441	7536	6619	9177	7960	8236	72428	1400.52575	1400525.75	1400525750	369738.7981

Analisa :
Kegiatan sudah dilakukan dengan baik sesuai target dan terdokumentasikan, setiap hari dilakukan pengecekan. Stok oksigen selalu terjaga.

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan Evaluasi

3.3.3.2.5 IPAL

Tabel Capaian Pemeliharaan IPAL

Bulan	Jumlah Target (satu bulan)	Capaian	Prosentase	Keterangan
Januari	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Februari	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Maret	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
April	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Mei	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Juni	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Juli	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Agustus	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
September	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Oktober	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
November	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Desember	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target

BULAN	INLET	OUTLET
JANUARI	53.8	154.2
FEBRUARI	36.6	83.5
MARET	32.2	70.2
APRIL	38.5	84.5

MEI	37.6	97.1
JUNI	56.5	149.1
JULI	36.4	99
AGUSTUS	33.7	93.3
SEPTEMBER	110.6	97.8
OKTOBER	42.7	34.6
NOVEMBER	35	47.5
DESEMBER	48.5	71.8
TOTAL M3	562.1	1082.6

Analisa :
Pelaksanaan sudah sesuai target dan di dokumentasikan. Pencatatan debit IPAL juga dilakukan dan di dokumentasikan.

Rencana Tindak Lanjut :
monitoring dan evaluasi melalui link :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yuzd_v1pO6Q2lDQr5clmEvCF-S0EF2VI8LY_e93lQE/edit?gid=342425059#gid=342425059

3.3.3.2.6 Filter Air

Tabel Capaian Pemeliharaan Filter Air

Bulan	Jumlah Target (satu bulan)	Capaian	Prosentase	Keterangan
Januari	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Februari	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Maret	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
April	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Mei	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Juni	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Juli	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Agustus	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
September	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Oktober	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target

November	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Desember	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target

Analisa :
Pelaksanaan sudah sesuai target dan di dokumentasikan dengan baik.

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi melalui
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aMBnSKVuoMC4Z1Wj1dya_t19f-XM272Mf0hcWAsBak4/edit?gid=0#gid=0

3.3.3.2.7 Lift

Tabel Lokasi dan Kondisi Lift

No	Lokasi	Kondisi
1	Lift Gedung A Pasien	Baik
2	Lift Gedung A Pengunjung	Baik
3	Lift Gedung B	Baik
4	Lift Gedung C Umum	Baik
5	Lift Gedung C Karyawan	Baik
6	Lift Gedung D (Garansi)	Baik

Tabel Capaian Pemeliharaan Lift

Bulan	Jumlah Target (satu bulan)	Capaian	Prosentase	Keterangan
Januari	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Februari	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Maret	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
April	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Mei	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Juni	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Juli	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Agustus	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
September	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target

Oktober	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
November	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target

LIFT RSPHM 2025	LIFT GEDUNG A	LIFT GEDUNG B	LIFT GEDUNG C	LIFT GEDUNG D	LIFT KARYAWAN	TOTAL
JUMLAH MAINTENANCE	8	9	8	8	9	42
PERBAIKAN INTERNAL	11	3	0	3	11	28
PERBAIKAN PT PILLAR	15	1	1	6	5	28
GANTI PART (PT PILLAR)	7	1	1	2	1	12

Analisa :
Pelaksanaan sudah sesuai target dan di dokumentasikan. Pada Akhir 2025 terdapat kerusakan yang sering pada lift Gedung A dan lift karyawan. Sudah dilakukan tindak lanjut kolaborasi tim internal dan vendor. Lift Gedung karyawans edang diajukan penawaran sparepart perbaikan.

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi melalui link
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-qMBqK_KT7GLwypkDMOm-X2vb5cPJtVV/edit?gid=730491017#gid=730491017

3.3.3.2.8 UPS

Tabel Capaian Pemeliharaan UPS

Bulan	Jumlah Target (satu bulan)	Capaian	Prosentase	Keterangan
Januari	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
Februari	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
Maret	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
April	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
Mei	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
Juni	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
Juli	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target

Agustus	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
September	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
Oktober	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
November	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
Desember	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target

Analisa :
Pelaksanaan sudah sesuai target dan di dokumentasikan.

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi melalui link
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1W11Uen83_wiMyVk-BL2oB4Nc24b7pgBOK6Lufn7skng/edit?usp=sharing

3.3.3.2.9 Air Minum

Nama	Lokasi	Kondisi
Instalasi Air Minum 1	Lantai 1 Gedung C	Baik

Bulan	Jumlah Target (satu bulan)	Capaian	Prosentase	Keterangan
Januari	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Februari	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Maret	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
April	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Mei	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Juni	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Juli	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Agustus	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
September	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target

Oktober	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
November	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Desember	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target

Analisa :
Pelaksanaan sudah sesuai target dan di dokumentasikan

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi melalui link

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aMBnSKVuoMC4Z1Wj1dya t19f-XM272Mf0hcWAsBak4/edit?gid=0#gid=0>

3.3.3.2.10 Filter Air Bersih Poli Gigi 1 dan Poli Gigi 2

Nama	Lokasi	Kondisi
Filter Air Bersih Poli Gigi 1	Lantai 2D	Baik
Filter Air Bersih Poli Gigi 2	Lantai 2D	Baik

Bulan	Jumlah Target (satu bulan)	Capaian	Prosentase	Keterangan
Januari	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Februari	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Maret	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
April	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Mei	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Juni	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Juli	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Agustus	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
September	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Oktober	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
November	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target

Desember	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
----------	----------	----------	------	-----------------------

Analisa :
Pelaksanaan sudah sesuai target dan di dokumentasikan

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi melalui link
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aMBnSKVuoMC4Z1Wj1dya_t19f-XM272Mf0hcWAsBak4/edit?gid=0#gid=0

3.3.3.2.11 Pemeliharaan Air Bersih

- 1. Utilitas : Air Bersih Torn Air Bersih
- 2. Jumlah : 12 unit
- 3. Frekuensi Pemeliharaan : 4/bulan
- 4. Target pemeliharaan : 100%

Nama	Lokasi	Kondisi
Torn 1	Lantai 9A Rooftop	Baik
Torn 2	Lantai 9A Rooftop	Baik
Torn 3	Lantai 9A Rooftop	Baik
Torn 4	Lantai 9A Rooftop	Baik
Torn 5	Lantai 9A Rooftop	Baik
Torn 6	Lantai 9A Rooftop	Baik
Torn 7	Lantai 9A Rooftop	Baik
Torn 8	Lantai 9A Rooftop	Baik
Torn 9	Lantai 9A Rooftop	Baik
Torn 10	Lantai 9A Rooftop	Baik
Torn 11	Lantai 9A Rooftop	Baik
Torn 12	Lantai 9A Rooftop	Baik

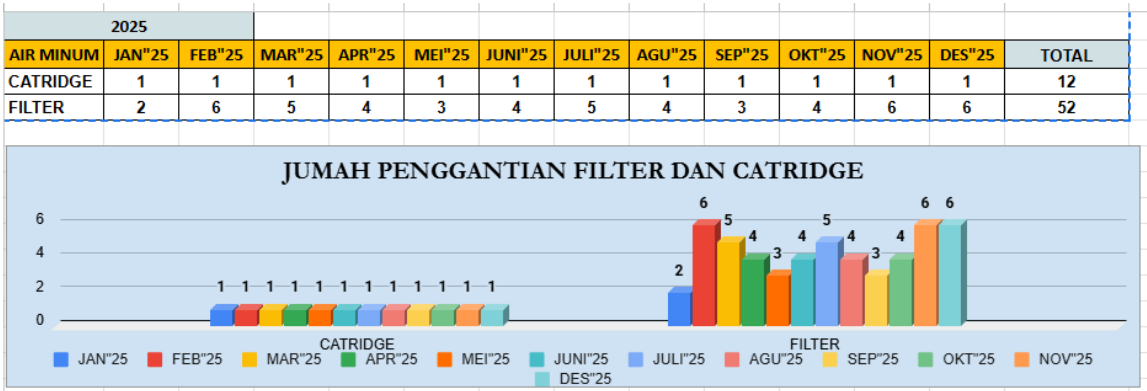
Target Per Bulan	Hasil Capaian / 100%											
4 x / 100%	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Nilai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Pelaksanaan sudah sesuai target dan di dokumentasikan

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi melalui link
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fYbB9NtKJyD5WDJtohOt-LeDqplpNqA_SAorhjUKBJI/edit?gid=512405157#gid=512405157

2025													
AIR MINUM	JAN"25	FEB"25	MAR"25	APR"25	MEI"25	JUNI"25	JULI"25	AGU"25	SEP"25	OKT"25	NOV"25	DES"25	TOTAL

CATRIDGE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
FILTER	2	6	5	4	3	4	5	4	3	4	6	6	52



3.3.3.2.12Rekapan Kegiatan External

BULAN	JUMLAH KEGIATAN (HARI)
Januari	4
Februari	4
Maret	4
April	15
Mei	12
Juni	15
Juli	6
Agustus	12
September	13
Oktober	12
November	16
Desember	4

Keterangan :

Pada tahun ini perbantuan eksternal ke klinik lebih banyak diakrenakan perbaikan AC dan dan dental

Rekapan link :

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y9Y3r4WUcch1rpMPxi3-kN2P5nlyuxZi/edit?gid=1966879934#gid=1966879934>

3.3.3.3 Cleaning Service

Tabel Indikator Kinerja Cleaning Service

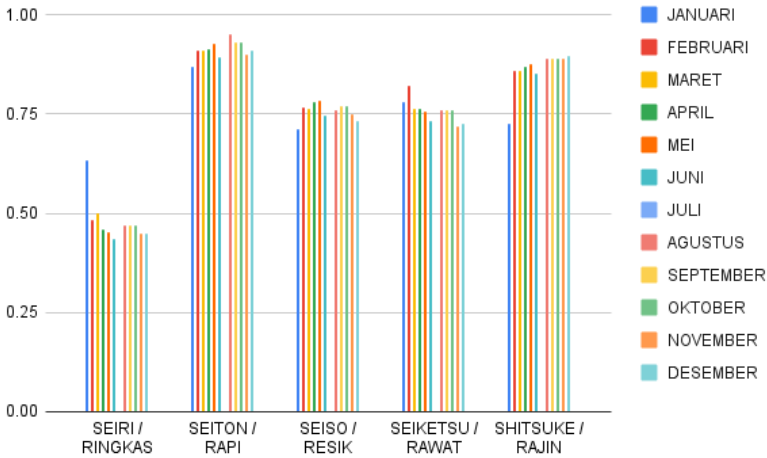
Kategori	Deskripsi
Seiri	Penempatan Alat Kebersihan Di Janitor/ Trolly
	Penempatan Alat Kebersihan Di Janitor/ Trolly
Seiton	Kerapian Baju Dan Kebersihan, Penampilan Petugas Cs
	Kerapian Baju Dan Kebersihan, Penampilan Petugas CS
Seiso	Membersihkan Area Kerja Secara Rutin Sesuai Jadwal
	Membersihkan Area Kerja Secara Rutin Sesuai Jadwal
Seiketsu	Mematuhi Sop Kebersihan
	Mematuhi SOP Kebersihan
Shiketsu	Konsistensi Dalam Menjalankan 5S Secara Mandiri Tanpa Pengawasan

	Konsistensi Dalam Menjalankan 5S Secara Mandiri Tanpa Pengawasan
	Konsistensi Dalam Menjalankan 5S Secara Mandiri Tanpa Pengawasan

Tabel Hasil Capaian Kinerja Unit Cleaning Service

NO	JENIS SPV	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	SEIRI / RINGKAS	63%	48%	50%	50%	45%	44%		47%	47%	47%	45%	45%
2	SEITON / RAPI	87%	91%	91%	91%	93%	89%		95%	93%	93%	90%	91%
3	SEISO / RESIK	71%	77%	76%	76%	78%	75%		76%	77%	77%	75%	73%
4	SEIKETSU / RAWAT	78%	82%	76%	76%	76%	73%		76%	76%	76%	72%	73%
5	SHITSUKE / RAJIN	72%	86%	86%	86%	88%	85%		89%	89%	89%	89%	90%

Grafik Capaian Kinerja Unit Cleaning Service



JENIS SPV	RATA-RATA
SEIRI / RINGKAS	44%
SEITON / RAPI	84%
SEISO / RESIK	69%
SEIKETSU / RAWAT	69%
SHITSUKE / RAJIN	79%

Analisa :
 Penilaian hasil supervise masih tidak tercapai 100%. Efisiensi telah dilakukan dengan mengurangi SDM namun dengan tidak mengurangi kualitas layanan.

Rencana Tindak Lanjut :
 Monitoring dan evaluasi

3.3.3.4 Gudang

Tabel Laporan Pencatatan Pengeluaran Barang di Unit Gudang Umum

No	Unit Asal	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nov	Des	Jumlah
1	IGD	3	2	1	2	2	3	1	2	2	3	3	4	28
2	MATERNITAS	2	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	3	18

3	IKO	2	2	2	2	3	0	1	2	1	1	1	2	19
4	IRNA 2A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
5	IRNA 2B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	IRNA 2C	2	1	3	2	0	10	5	4	2	3	4	4	40
7	ICU	0	2	2	1	2	3	2	1	1	3	2	2	20
8	IRNA 3A	1	0	1	0	2	5	3	2	1	2	0	0	17
9	IRNA 3C DEWASA	2	2	4	3	3	2	2	2	0	2	1	0	20
10	IRNA 4C+4A	2	3	3	2	1	0	0	0	0	0	2	0	13
11	IRNA 5C	1	2	1	1	2	1	0	0	1	1	1	1	12
12	MS PTP, LAWANG, KARLOS	12	10	8	10	12	11	10	11	12	11	10	12	129
13	KASIR	4	3	3	1	4	5	4	6	3	4	4	5	46
14	DAPUR	6	4	4	3	4	5	4	5	4	4	4	6	53
15	POLI	6	5	6	7	6	0	9	3	4	6	6	9	67
16	CLEANING SERVICE	5	4	5	4	4	4	4	3	6	5	4	6	54
17	IPSRs	5	4	4	3	4	4	5	4	4	4	4	5	50
18	GUDANG FARMASI	3	4	1	3	2	2	2	1	3	3	1	3	28
19	RUMAH DPM	3	1	4	2	1	1	3	0	3	2	3	1	24
20	SEKRETARIAT PT	4	2	4	2	2	4	3	3	3	4	4	3	38
21	SEKRETARIAT RS	4	2	3	4	4	5	7	4	3	3	3	8	51
22	CSSD	1	2	1	1	2	1	2	1	1	1	1	2	16
23	GIZI	3	2	4	3	2	2	3	2	2	1	2	3	29
24	REKAM MEDIS	3	3	4	1	4	2	4	3	3	3	4	5	39
25	PENDAFTARAN	4	1	2	3	3	4	3	3	1	4	2	4	34
26	DEPO FARMASI	7	6	6	6	7	7	4	4	6	5	5	5	68
27	SECURITY	1	1	1	1	1	2	1	1	0	1	2	1	13
28	LABORATORIUM	5	5	4	3	2	4	4	3	3	5	6	5	49
29	RADIOLOGI	2	2	2	2	1	1	3	2	4	5	3	6	33
30	FISIOTERAPI	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	IRNA 3C ANAK	4	1	3	1	2	2	2	2	1	0	2	1	21
32	NS NICU	3	2	3	2	1	2	2	1	2	3	2	1	24
33	LAUNDRY	0	0	1	0	0	1	0	0	2	1	0	3	8
34	LANTAI 6A,7A,8A	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
35	DRIVER	1	1	2	1	0	2	1	1	1	1	2	2	15
36	SIMRS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ASURANSI CENTER	4	3	4	2	4	3	3	2	3	3	4	4	39
38	DPW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

39	PIPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	RSDH				2	1	2	7	11	11	6	7	5	52

Analisis :
Kesimpulan pengeluaran terbanyak dalam 1 th adalah unit Mutiara sehat ,depo farmasi, cleaning cervis, RSDH ,poli dan dapur.

- Rencana tindak lanjut contoh koordinasi dengan unit :**
- a) Mendisiplinkan kepatuhan jadwal pengambilan barang
 - b) Memberi edukasi ke unit agar tidak salah input barang atau salah unit
 - c) Menyarankan ke all unit agar punya data inventaris ATK secara terperinci

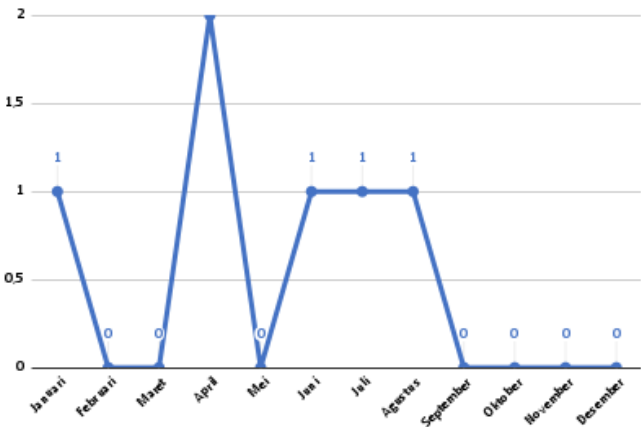
3.3.3.5 Security

3.3.3.5.1 Kejadian Kehilangan Barang

Tabel Angka Kejadian Kehilangan Barang

Jenis Aktivitas	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Angka kejadian kehilangan barang	1	0	0	2	0	1	1	1	0	0	0	0

Grafik Angka Kejadian Kehilangan Barang



Analisa :
Kejadian kehilangan barang dalam satu tahun hanya 6 kejadian. Hal ini relative sedikit dengan perbandingan jumlah kunjungan. Tidak ada complain masuk terkait kehilangan. SDM security dan system pengamanan sudah sesuai. Kendala hanya pada pintu masuk rawat inap tidak one gate. Pada tahun 2025 sudah diberlakukan buka tutup untuk pintu sebelah IKO.

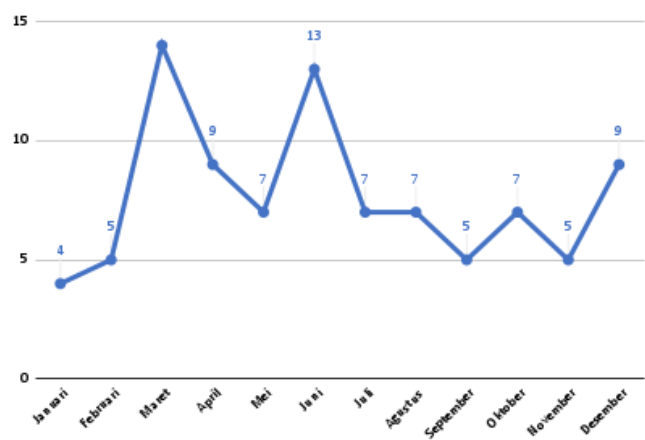
- Rencana Tindak Lanjut :**
Monitoring Evaluasi

3.3.3.5.2 Kejadian Potensi Kehilangan Barang

Tabel Angka Potensi Kejadian Kehilangan Barang

Jenis Aktivitas	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Angka kejadian kehilangan barang	4	5	14	9	7	13	7	7	5	7	5	9

Grafik Angka Kejadian Berpotensi Kehilangan Barang



Analisa :
Tahun 2025 mayoritas potensi hilang ada pada kunci motor karyawan yang tertinggal. Untuk pasien / keluarga sudah dilakukan proses pemngembalian 100%.

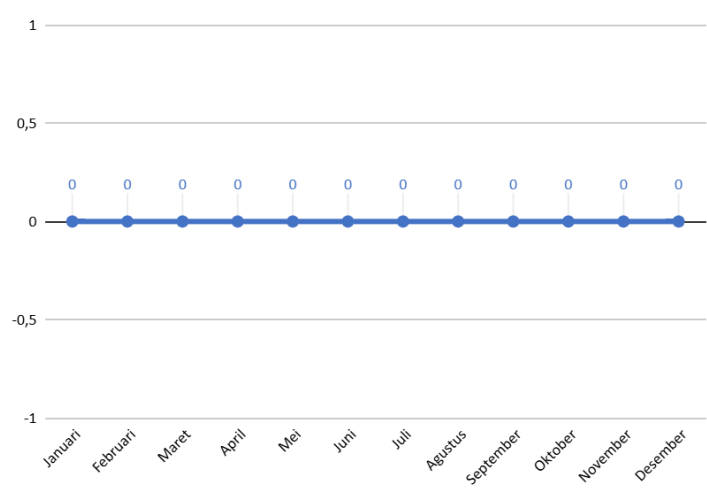
Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi

3.3.3.5.3 Kejadian Kekerasan di Lingkungan Rumah Sakit

Tabel Kejadian Kekerasan di Lingkungan Rumah Sakit

Jenis Aktivitas	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Angka kejadian kekerasan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Grafik Kejadian Kekerasan di Lingkungan Rumah Sakit



Analisa :
tidak terdapat kejadian kekerasan karena pelayanan dilakukan dengan baik oleh seluruh karyawan dan tidak ada oknum yang menciptakan kerusuhan.

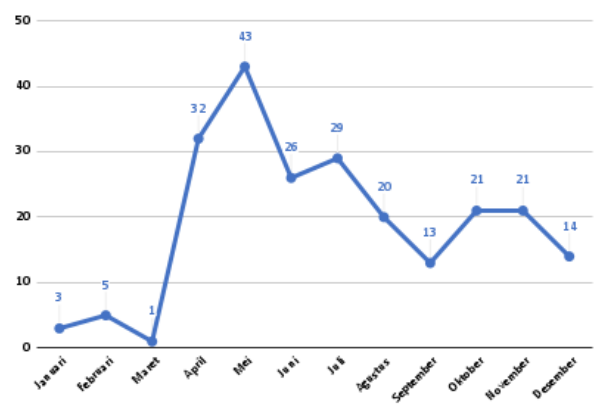
Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi

3.3.3.5.4 Kejadian Merokok di Area Rumah Sakit

Tabel Angka Kejadian Merokok di Area Rumah Sakit

Jenis Aktivitas	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Angka kejadian merokok di area Rumah Sakit	3	5	1	32	45	26	29	20	13	21	21	14

Grafik Angka Kejadian Merokok di Area Rumah Sakit



Analisa :
Terjadi tren penurunan. Aktifitas kontroling dan budaya lapor sudah berjalan.

Rencana Tindak Lanjut :

Monitoring evaluasi. Pencatatan melalui WA grup dan operan shift dengan instrument dashboard spreadsheet.

3.3.3.6 Asuransi Center
3.3.6.1 Kunjungan Pasien Asuransi

No	Jaminan	2024			2025			%
		RJ	RI	Total	RJ	RI	Total	
1	Umum	14.804	854	15.658	23.861	764	24.625	57,27%
2	BPJS Kesehatan	119.090	12.322	131.412	115.985	12.187	128.172	-2,47%
3	BPJS TK	1.330	267	1.597	1.770	158	1.928	20,73%
4	Jasa Raharja	138	109	247	103	102	205	- 17,00%
5	Asuransi Swasta	2.055	145	2.200	2.635	297	2.932	33,27%
6	Perusahaan	340	53	393	360	59	419	6,62%

3.3.6.2 Penyakit Terbanyak Rawat Jalan Pasien BPJS Kesehatan Periode 2025

No	Code	Deskripsi	Jumlah	Subtotal RS	Subtotal INA-CBG	Selisih
1	Z50.1	Other physical therapy	11,787	1.956.253.289	1.658.414.500	- 297.838.789
2	Z09.8^E11.9	Non-insulin-dependent diabetes mellitus without complications	4,457	991.594.954	888.664.500	- 102.930.454
3	Z09.8^E11.4	Non-insulin-dependent diabetes mellitus with neurological complications	4,18	914.800.903	837.307.400	- 77.493.503
4	Z09.8^I11.9	Hypertensive heart disease without (congestive) heart failure	3,647	648.620.369	738.184.200	89.563.831
5	Z09.8^I25.9	Chronic ischaemic heart disease, unspecified	3,641	721.643.856	734.863.100	13.219.244
6	Z09.8^I51.9	Heart disease, unspecified	3,386	625.269.810	676.891.700	51.621.890

7	Z48.0	Attention to surgical dressings and sutures	2,408	569.087.108	487.162.100	- 81.925.008
8	Z09.8^I63.9	Cerebral infarction, unspecified	2,385	397.292.497	490.456.300	93.163.803
9	Z09.8^J47	Bronchiectasis	2,293	356.700.180	450.794.900	94.094.720
10	Z35.9	Supervision of high-risk pregnancy, unspecified	2,169	366.241.353	421.997.400	55.756.047

3.3.6.3 Penyakit Terbanyak Rawat Inap Pasien BPJS Kesehatan Periode 2025

No	Code	Deskripsi	Jumlah	Subtotal RS	Subtotal INA-CBG	Selisih
1	A01.0	Typhoid fever	2,291	6.053.262.623	6.351.191.400	297.928.777
2	J18.9	Pneumonia, unspecified	478	1.555.819.212	2.036.172.200	480.352.988
3	I63.9	Cerebral infarction, unspecified	440	2.271.760.102	2.511.505.700	239.745.598
4	E14.9	Unspecified diabetes mellitus without complications	345	1.240.524.194	1.641.894.500	401.370.306
5	O63.0	Prolonged first stage of labour	338	1.681.496.919	1.057.649.100	- 623.847.819
6	A90	Dengue fever [classical dengue]	205	567.582.149	562.722.800	- 4.859.349
7	O32.2	Maternal care for transverse and oblique lie	202	1.787.482.565	1.191.572.000	- 595.910.565
8	Z03.8	Observation for other suspected diseases and conditions	201	696.824.232	456.079.200	- 240.745.032
9	E11.9	Non-insulin-dependent diabetes mellitus without complications	198	763.883.941	951.253.300	187.369.359
10	O42.0	Premature rupture of membranes, onset of labour within 24 hours	179	1.139.936.061	779.417.700	- 360.518.361

3.3.6.4 Tindakan Operatif Terbanyak dengan Biaya Tertinggi

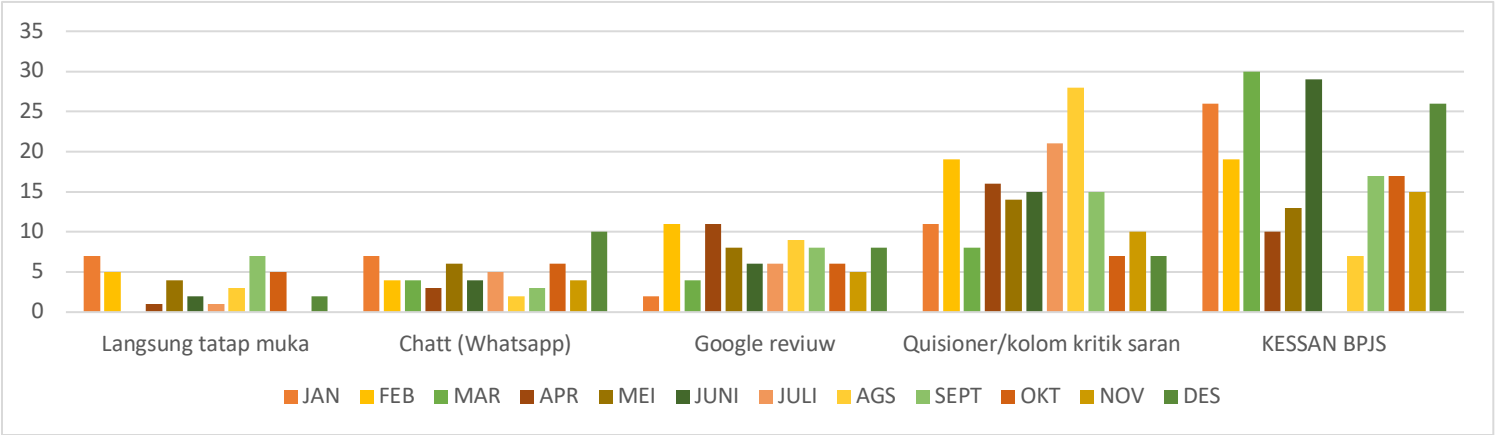
No	Code	Deskripsi	Jumlah	Subtotal RS	Subtotal INA-CBG	Selisih
1	74.4	Cesarean section of other specified type	455	3.558.795.611	2.666.720.700	- 892.074.911
2	73.59	Other manually assisted delivery	377	1.606.844.002	979.361.200	- 627.482.802
3	86.22	Excisional debridement of wound, infection, or burn	274	2.575.428.313	1.135.800.900	- 1.439.627.413
4	86.11	Biopsy of skin and subcutaneous tissue	176	1.648.281.501	783.220.100	- 865.061.401
5	85.12	Open biopsy of breast	153	1.463.231.273	883.708.800	- 579.522.473
6	56.0	Transurethral removal of obstruction from ureter and renal pelvis	139	1.692.729.446	1.073.830.300	- 618.899.146
7	74.0	Classical cesarean section	118	883.104.628	696.561.000	- 186.543.628
8	73.4	Medical induction of labor	115	575.222.209	338.154.900	- 237.067.309
9	66.39	Other bilateral destruction or occlusion of fallopian tubes	109	1.368.337.914	625.671.000	- 742.666.914
10	53.00	Unilateral repair of inguinal hernia, not otherwise specified	106	988.542.342	564.157.400	- 424.384.942

3.3.3.7 PIPP

Tabel Jenis Komplain Tahun 2025

NO	JENIS PASIEN KOMPLAIN	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	Σ
1.	Langsung	7	5	0	1	4	2	1	3	7	5	0	2	37
2.	Tidak Langsung :													
	Chatt (Whatsapp)	7	4	4	3	6	4	5	2	3	6	4	10	58
	Google reviuw	2	11	4	11	8	6	6	9	8	6	5	8	84
	Quisioner/kolom kritik saran	11	19	8	16	14	15	21	28	15	7	10	7	171
	KESSAN BPJS	26	19	30	10	13	29	0	7	17	17	15	26	209

Grafik Jenis Pasien Komplain Tahun 2025



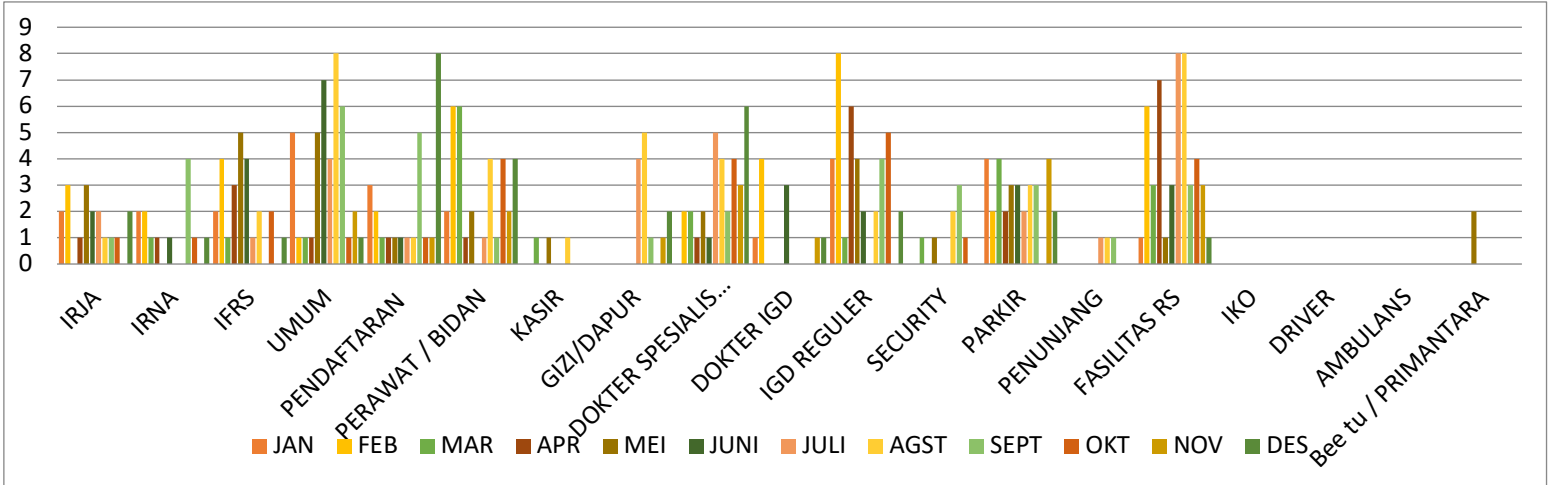
Analisa :
Pada grafik diatas dapat disimpulkan bahwa jenis pasien complain tertinggi pertama yaitu di dapat dari KESSAN sebanyak 209 komplain, tertinggi kedua yaitu Quisioner sebanyak 171 komplain di tahun 2025

Rencana Tindak Lanjut
Penyampaian complain berdasarkan jenis pasien ini bekerjasama dengan unit terkait seperti IRNA, marketing dan IRJA agar menyaring pasien untuk memberikan masukan kepada Rumah Sakit

3.3.3.7.1 Laporan Komplain Pasien

NO	JUMLAH KOMPLAIN PASIEN TERHADAP UNIT	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	Σ
1.	IRJA	2	3	0	1	3	2	2	1	1	1	0	2	18
2.	IRNA	2	2	1	1	0	1	0	0	4	1	0	1	13
3.	IFRS	2	4	1	3	5	4	1	2	0	2	0	1	25
4.	UMUM	5	1	1	1	5	7	4	8	6	1	2	1	42
5.	PENDAFTARAN /CSO	3	2	1	1	1	1	1	1	5	1	1	8	26
6.	PERAWAT / BIDAN	2	6	6	1	2	0	1	4	1	4	2	4	33
7.	KASIR	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	3
8.	GIZI/DAPUR	0	0	0	0	0	0	4	5	1	0	1	2	13
9.	DOKTER SPESIALIS (KOMITE MEDIS)	0	2	2	1	2	1	5	4	2	4	3	6	32
10.	DOKTER IGD	1	4	0	0	0	3	0	0	0	0	1	1	10
11.	IGD	4	8	1	6	4	2	0	2	4	5	0	2	38
12.	SECURITY	0	0	1	0	1	0	0	2	3	1	0	0	8
13.	PARKIR	4	2	4	2	3	3	2	3	3	0	4	2	32
14.	PENUNJANG	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	3
15.	FASILITAS RS	1	6	3	7	1	3	8	8	3	4	3	1	48
16.	IKO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	DRIVER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Ambulans	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Primantara	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2

Grafik
Jumlah Komplain Pasien Terhadap Unit Tahun 2025



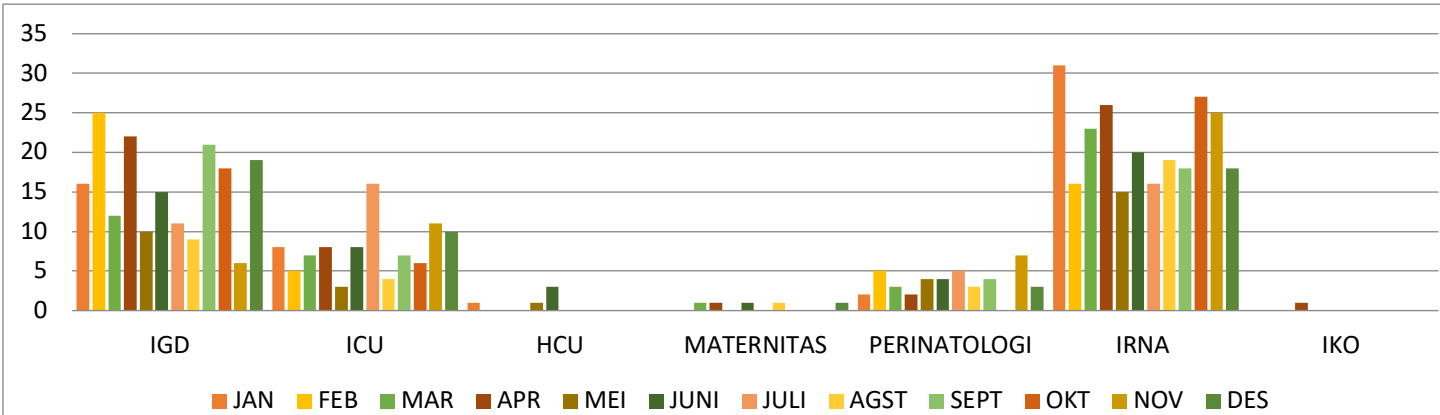
Analisa :
Pada grafik diatas dapat disimpulkan bahwa Jumlah Komplain Pasien terbanyak pada tahun 2025 yaitu fasilitas RS sebanyak 48 kasus, di ikuti bagian UMUM sebanyak 42 kasus, IGD sebanyak 38 kasus, Bagian perawat/Bidan sebanyak 32 kasus, Bagian Parkir sebanyak 32 kasus,

- Rencana Tindak Lanjut :**
- 1) Kolaborasi dengan Kabid umum terkait pengajuan perbaikan dan pemenuhan fasilitas RS yang masih bisa dilakukan perbaikan dan pemenuhan.
 - 2) Kolaborasi dengan Kabid umum terkait evalusi bagian umum RS
 - 3) Kolaborasi dengan Kabid Umum terkait Parkir dengan mengajukan diadakan kartu khusus penunggu IRNA sehingga tidak ada pembayaran yang terlalu banyak setiap keluar masuk RS
 - 4) Kolaborasi dengan Ka instalasi IGD terkait pelayanan IGD
 - 5) Kolaborasi dengan Kabid keperawatan terkait evaluasi kinerja perawat/Bidan

3.3.3.7.2 Laporan Pasien Rujuk

NO	UNIT PERUJUK	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	Σ
1.	IGD	16	25	12	22	10	15	11	9	21	18	6	19	184
2.	ICU	8	5	7	8	3	8	16	4	7	6	11	10	93
3.	HCU	1	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	5
4.	MATERNITAS	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	5
5.	NEONATOLOGI	2	5	3	2	4	4	5	3	4	0	7	3	42
6.	IRNA	31	16	23	26	15	20	16	19	18	27	25	18	254
7.	IKO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Grafik Jumlah Pasien Rujuk Eksternal Tahun 2025



Analisa :
Pada grafik diatas dapat disimpulkan bahwa Jumlah pasien rujuk eksternal tahun 2025 palling banyak yaitu IRNA sebanyak 254 pasien, terbanyak kedua yaitu IGD sebanyak 184 pasien yang dirujuk, Hal ini dikarenakan masih banyaknya pasien yang membutuhkan perawatan lanjutan dimana di RS Prima Husada Malang belum bisa melakukan perawatan tersebut.

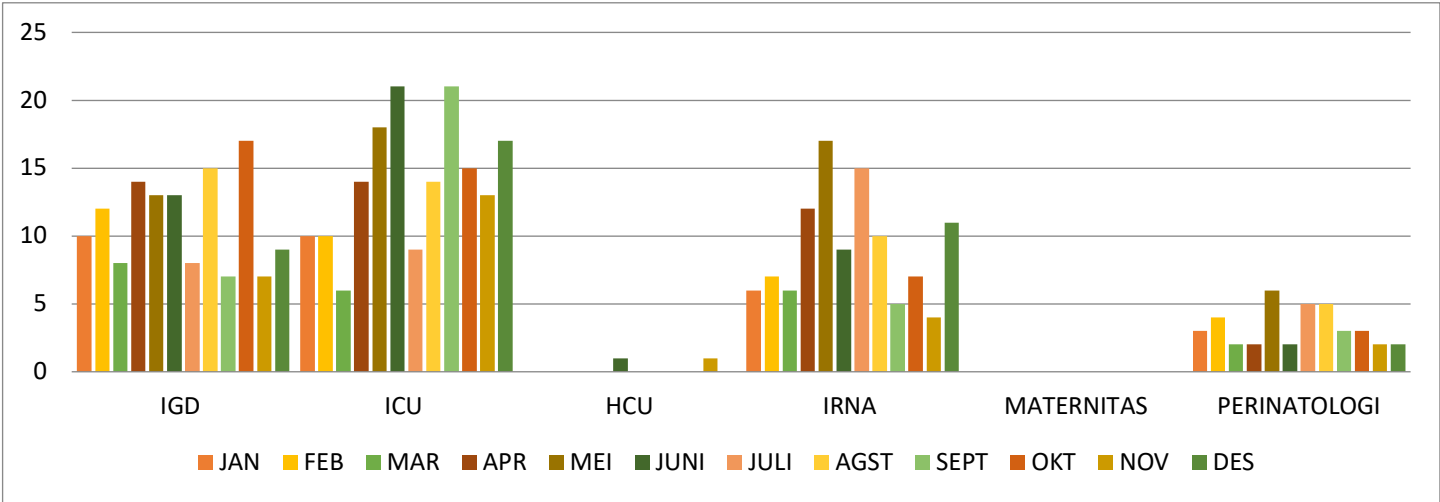
Rencana Tindak Lanjut :
Kolaborasi dengan Kabid pelayanan terkait tambahan layanan Rumah Sakit, sehingga pasien bisa dilakukan pelayanan di Rumah Sakit Prima Husada Mlang, seperti Unit HD, PICU.

3.3.3.7.3 Laporan Pasien Meninggal

Tabel Laporan Pasien Meninggal

NO	JUMLAH PASIEN MENINGGAL	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	Σ
1.	IGD	10	12	8	14	13	13	8	15	7	17	7	9	133
2.	ICU	10	10	6	14	18	21	9	14	21	15	13	17	168
3.	HCU	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2
4.	IRNA	6	7	6	12	17	9	15	10	5	7	4	11	109
5.	MATERNITAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	NEONATOLOGI	3	4	2	2	6	2	5	5	3	3	2	2	39

Grafik Jumlah Pasien Meninggal Tahun 2025



Analisa :
Pada grafik diatas dapat disimpulkan bahwa Jumlah pasien meninggal tahun 2025 palling banyak yaitu ICU sebanyak 168 pasienIGD sebanyak 160 pasien, dan terbanyak kedua yaitu dari IGD sebanyak 133 pasien. Hal ini dikarenakan masih banyaknya pasien yang membutuhkan perawatan lanjutan dimana di RS Prima Husada Malang belum bisa melakukan perawatan tersebut.

Rencana Tindak Lanjut :
Kolaborasi dengan Kabid pelayanan terkait tambahan layanan Rumah Sakit, sehingga pasien bisa dilakukan pelayanan di Rumah Sakit Prima Husada Mlang, seperti Unit HD, PICU.

3.3.3.8 IT-SIMRS

Tabel . Capaian Kinerja Produktivitas

No	Rincian Kegiatan	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
1	Inventaris hardware IT (setahun sekali)	1/1											1/1
2	Laporan Bulanan	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
3	Pemeliharaan ruang server	1/31	1/28	1/31	1/30	1/31	1/30	1/30	1/30	1/30	1/30	1/30	1/30
4	Pemeliharaan computer server	1/1				1/1			1/1			1/1	
5	Pemeliharaan Mikrotik	62/62	56/56	62/62	60/60	62/62	60/60	62/62	60/60	60/60	62/62	60/60	62/62
6	Pemeliharaan DVR dan Kamera CCTV	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
7	Pemeliharaan modem internet	1/1				1/1			1/1			1/1	
8	Pemeliharaan Komputer unit	7/15	15/15	6/15	6/15	9/15	15/15	15/15	12/15	5/15	7/15	8/15	2/15
9	Pemeliharaan printer unit	8/3	15/3	4/3	3/3	4/3	7/3	5/3	10/3	5/3	5/3	2/3	5/3
10	Perapian kabel internet	1/1				1/1			1/1			1/1	
11	Perapian kabel telepon	1/1				1/1			1/1			1/1	
12	Pemeliharaan access point	1/1				1/1			1/1			1/1	
13	Pemeliharaan switch internet di setiap panel dan unit	1/1				1/1			1/1		1/1	1/1	
14	Pemeliharaan modem gsm	1/1											

Analisa :
Maintenance yang belum tercapai adalah Maintenance PC per bulan. Hal ini diakarenakan beberapa PC target masih dipakai oleh user.

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan Evaluasi

Tabel Rekapitulasi Peremajaan Hardware

NO	JUMLAH TOTAL PC RS	JUMLAH PC YANG SUDAH DILAKUKAN PEREMAJAAN	JUMLAH PC YANG SUDAH DILAKUKAN PEMELIHARAAN	PROSENTASE	KETERANGAN
1	188	- Radiologi - Kiosk - Verif (dini) - SDM (susan) - All Irna Gedung A	107	56,91%	

NO	JUMLAH TOTAL PRINTER RS	JUMLAH PRINTER YANG SUDAH DILAKUKAN PEREMAJAAN	JUMLAH PRINTER YANG SUDAH DILAKUKAN PEMELIHARAAN	PROSENTASE	KETERANGAN
1	35	USG radiologi, Poli Gigi	35	100%	

3.3.3.8.1 Rekapitulasi Keluhan IT

Tabel Rekapitulasi Keluhan IT

	Kategori Keluhan (umum)		Keterangan
BULAN	HARDWARE	SOFTWARE	
JANUARI	41	18	Terselesaikan 100%
FEBRUARI	106	30	Terselesaikan 100%
MARET	30	12	Terselesaikan 100%
APRIL	31	12	Terselesaikan 100%
MEI	39	15	Terselesaikan 100%
JUNI	113	20	Terselesaikan 100%
JULI	146	39	Terselesaikan 100%
AGUSTUS	121	61	Terselesaikan 100%
SEPTEMBER	97	9	Terselesaikan 100%
OKTOBER	77	19	Terselesaikan 100%
NOVEMBER	90	7	Terselesaikan 100%
DESEMBER	104	24	Terselesaikan 100%

Kategori Keluhan (spesifik)							
BULAN	PC	PRINTER	SIMRS	JARINGAN INTERNET	TELPON PABX	CCTV	LAINNYA
JANUARI	15	16	5	19	0	2	2
FEBRUARI	30	31	6	58	5	3	3
MARET	12	8	1	18	2	1	0
APRIL	12	7	1	20	2	1	0
MEI	18	9	1	23	2	1	0
JUNI	32	14	8	61	2	2	14
JULI	56	20	7	84	0	2	13
AGUSTUS	28	25	9	88	4	4	17
SEPTEMBER	10	11	6	57	0	11	2
OKTOBER	14	10	5	57	1	2	4
NOVEMBER	16	5	1	65	2	4	1
DESEMBER	35	17	4	63	2	0	5

TOTAL	278	173	54	613	22	33	61
RATA-RATA	23	14	5	51	2	3	5

Analisa :
 Untuk Keluhan dapat terselesaikan oleh Tim IT dengan SDM saat ini.

Rencana Tindak Lanjut :
 Monitoring dan Evaluasi

3.3.3.9 Driver

Tabel Rekapitulasi Pengantaran Berdasarkan Keperluan

KEPERLUAN	JUMLAH												RATA-RATA	TOTAL
	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER		
RUJUK PASIEN KE RS LAIN	60	46	47	57	35	48	51	36	50	49	49	52	48	580
RUJUK PASIEN KE RSPHS	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	1	0	5
JEMPUT RUMAH PASIEN	17	13	18	16	11	14	21	15	14	15	18	14	16	186
ANTAR RUMAH PASIEN	19	14	11	16	20	13	18	23	9	11	5	7	14	166
SAMPEL LAB	19	19	12	14	15	30	30	27	26	18	21	31	22	262
SAMPEL SHK	4	2	3	3	3	5	3	5	4	4	3	3	4	42
KEPERLUAN NONKLINIS STAF RSPHM	5	6	2	7	5	5	2	3	7	6	11	2	5	61
KEPERLUAN NON KLINIS STAF PT	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	4
PENGANTARAN JENAZAH	25	29	16	23	44	35	31	36	26	33	24	33	30	355
RUJUK CT SCAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	2	3	37
ANTAR MCU RSPHM	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	3
LAIN-LAIN	7	11	13	6	12	11	6	10	9	11	10	11	10	117
TOTAL	158	140	122	142	145	162	162	156	147	183	141	160	152	1031

SHIFT	JUMLAH												RATA-RATA	TOTAL
	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER		
SHIFT 1	46	42	42	50	43	44	51	47	56	60	50	48	48	579
SHIFT 2	41	44	36	42	53	42	47	55	31	59	36	42	44	528
SHIFT 3	49	34	21	31	23	44	39	35	42	43	39	47	37	447
MIDDLE	21	21	21	15	26	31	25	18	18	21	15	21	21	253
ON CALL	1	0	2	4	0	1	0	1	0	0	1	2	1	12
TOTAL	158	141	122	142	145	162	162	156	147	183	141	160	152	1032

Analisa :
Keperluan terbanyak adalah rujuk ke RS lain dan pengantaran jenazah pasien. Kondisi Pengantaran dapat dikondisikan dengan jumlah personil yang ada. Dalam satu tahun hanya ada 12 kali On Call. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan pengantaran masih dapat dipenuhi dengan SDM dan Sarana Prasarana yang ada.

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi Dengan adanya peningkatan pasien.

3.3.3.10 Keuangan

PIUTANG RS PRIMA HUSADA MALANG																										
PERIODE 2025																										
NO	DESKRIPSI	SALDO AWAL PIUTANG	PEMBAYARAN (BULAN SEBELUMNYA)	SELISIH KURANG BAYAR (BULAN SEBELUMNYA)	SISA PIUTANG (BULAN SEBELUMNYA)	PENAMBAHAN PIUTANG (BULAN BERJALAN)	PEMBAYARAN (BULAN BERJALAN)	SELISIH KURANG BAYAR (BULAN BERJALAN)	SISA PIUTANG (BULAN BERJALAN)	SALDO AKHIR PIUTANG	UMUR PIUTANG					JUMLAH PIUTANG										
											Y	Z	AA	AB	AC											
											a	b	c	(a-b-c=d)	e		f	g	(e-f-g=h)	d+h	0-30 HARI	31-60 HARI	61-90 HARI	91-120 HARI	>120 HARI	Total
											PERIODE DESEMBER 2025 :															
1	Asuransi	365,763,239	157,130,658	4,069,247	204,563,334	217,353,863	40,252,270	2,488,949	174,612,643	379,175,978	306,083,359	37,019,208	12,513,724	9,735,415	13,824,272	379,175,979										
2	Perusahaan	628,339,622	421,301,342	526,580	206,511,700	283,931,794	-	-	283,931,794	490,443,494	395,868,163	8,028,394	47,889,611	-	48,657,327	490,443,495										
3	Mandiri Inhealth	167,785,401	64,787,170	1,511,696	101,486,535	52,768,084	-	-	52,768,084	154,254,619	154,254,619	-	-	-	-	154,254,619										
4	Jasa Raharja	260,845,598	218,626,708	1	42,218,889	186,456,651	82,569,144	1	103,887,506	146,106,395	146,106,395	-	-	-	-	146,106,395										
5	BPJS Ketenagakerjaan	619,614,952	597,740,684	798,501	21,075,767	557,155,732			557,155,732	578,231,499	557,155,732	375,949	-	-	20,699,818	578,231,499										
Total Saldo										1,748,211,985	1,549,468,267	45,423,551	60,403,335	9,735,415	83,181,416	1,748,211,986										

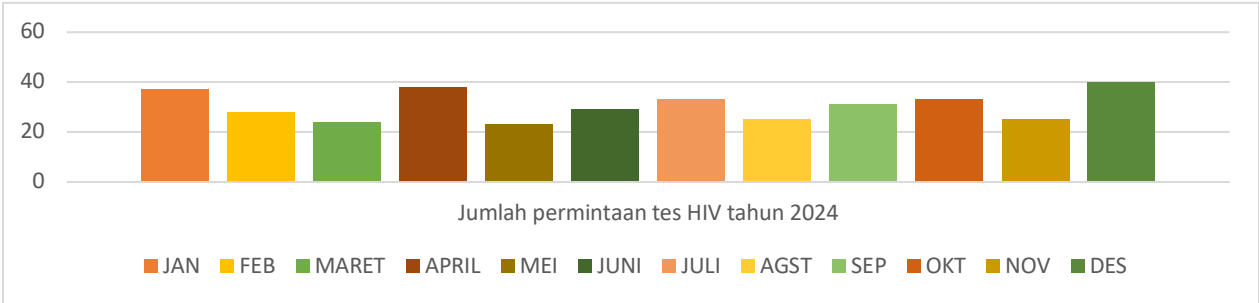
Keterangan :
- Cut Off Piutang per 31 Desember 2025 Rp 1.748.211.986,-

3.3.4. Program Nasional (PROGNAS)
3.3.4.1 HIV

3.3.4.1.1 Jumlah permintaan Tes HIV

NO	URAIAN	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	Σ
1	Permintaan Test HIV	37	28	24	38	23	29	33	25	31	33	25	40	366

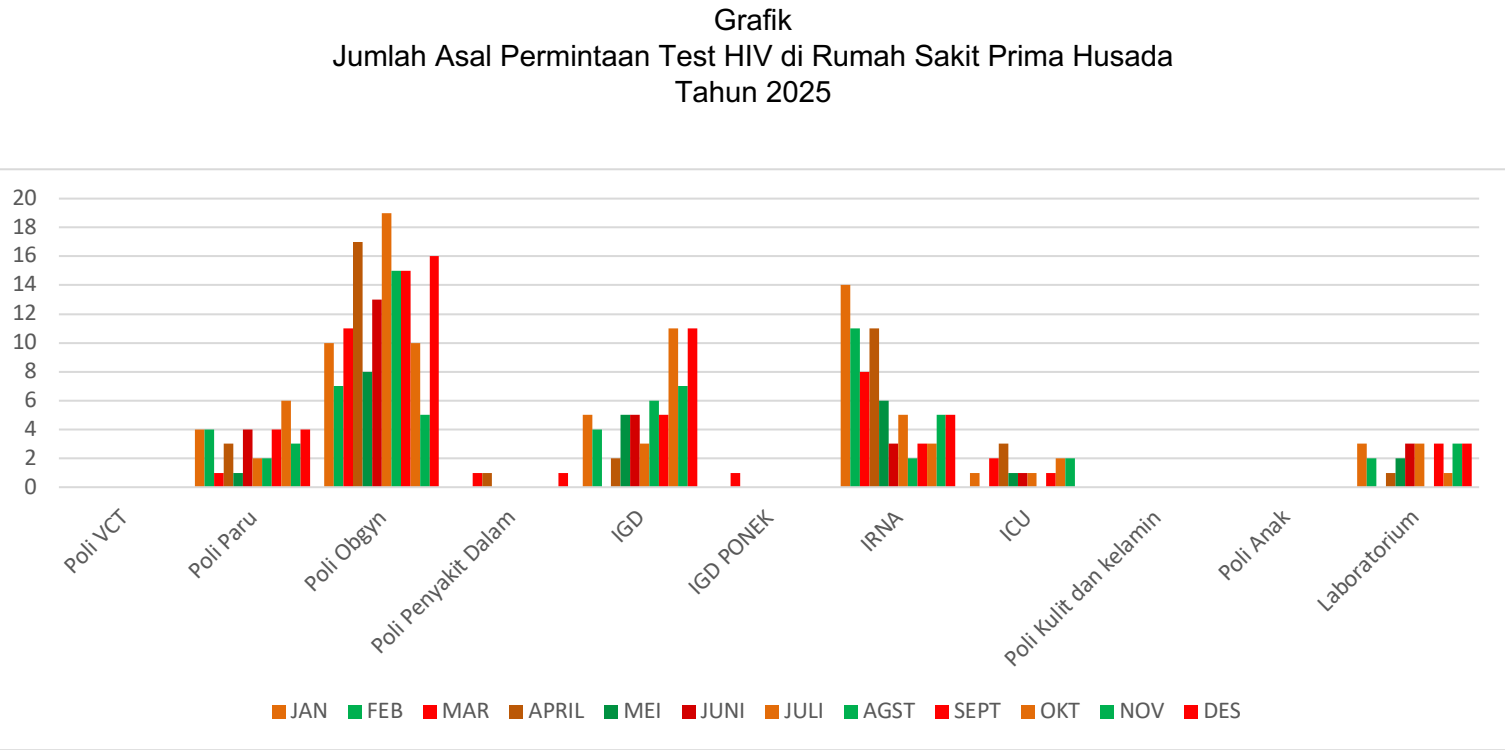
Grafik
Jumlah Permintaan Test HIV di Rumah Sakit Prima Husada Tahun 2025



Analisa :
Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa jumlah permintaan test HIV pada tahun 202 sebanyak 366 pemeriksaan, hal ini dikarenakan terdapat sedikit pasien dengan diagnose suspek HIV dan sudah berjalannya pemeriksaan PMTCT di poli kandungan dan PONEK IGD.

Rencana Tindak Lanjut :
Dilakukan skrining ulang pada pasien-pasien yang terduga HIV, pasien hamil trimester 3 dan juga pasien-pasien mandiri yang ingin dilakukan pemertiksaan HIV sesuai sukarela baik pasien IGD, rawat jalan maupun rawat inap.

Tabel Asal Permintaan Tes HIV														
NO	URAIAN	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	Σ
1	Poli VCT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Poli Paru	4	4	1	3	1	4	2	2	4	6	3	4	38
3	Poli Obgyn	10	7	11	17	8	13	19	15	15	10	5	16	146
4	Poli Penyakit Dalam	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	3
5	IGD	5	4	0	2	5	5	3	6	5	11	7	11	64
6	IGD PONEK	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
7	IRNA	14	11	8	11	6	3	5	2	3	3	5	5	76
8	ICU	1	0	2	3	1	1	1	0	1	2	2	0	14
9	Poli Kulit dan kelamin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Poli Anak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Laboratorium	3	2	0	1	2	3	3	0	3	1	3	3	24



Analisis :
 Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa jumlah asal permintaan test HIV di Poli kandungan pada tahun 2025 masih tinggi dibandingkan dengan unit lain yaitu 146 permintaan tes. Hal ini dikarenakan sudah tersdianya Reagen HIV dari Dinas Kesehatan Kabupaten Malang untuk program ibu hamil sehingga pasien dengan kriteria hamil trimester II sudah bisa dilakukan screening HIV.

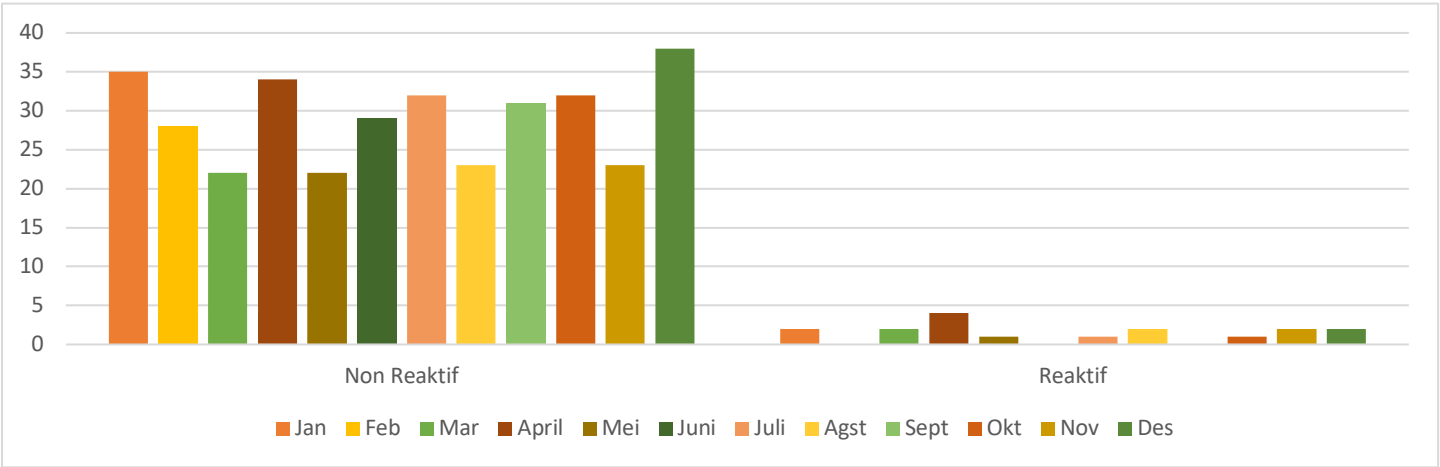
Rencana Tindak Lanjut :

Dilakukan sosialisasi terkait Permintaan testing HIV dilakukan baik di IGD, rawat jalan, maupun rawat jalan sesuai dengan kebutuhan pasien. Sehingga capaian permintaan testing HIV bisa berjalan.

Tabel Status HIV

NO	URAIAN	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	Σ
1	Non Reaktif	35	28	22	34	22	29	32	23	31	32	23	38	349
2	Reaktif	2	0	2	4	1	0	1	2	0	1	2	2	17

Grafik
Status HIV di Rumah Sakit Prima Husada Tahun 2025



Analisis Status HIV :

Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa status HIV dengan status non reaktif pada tahun 2025 terdapat 349 orang dan status pasien reaktif pada tahun 202 yaitu 17 orang pasien.

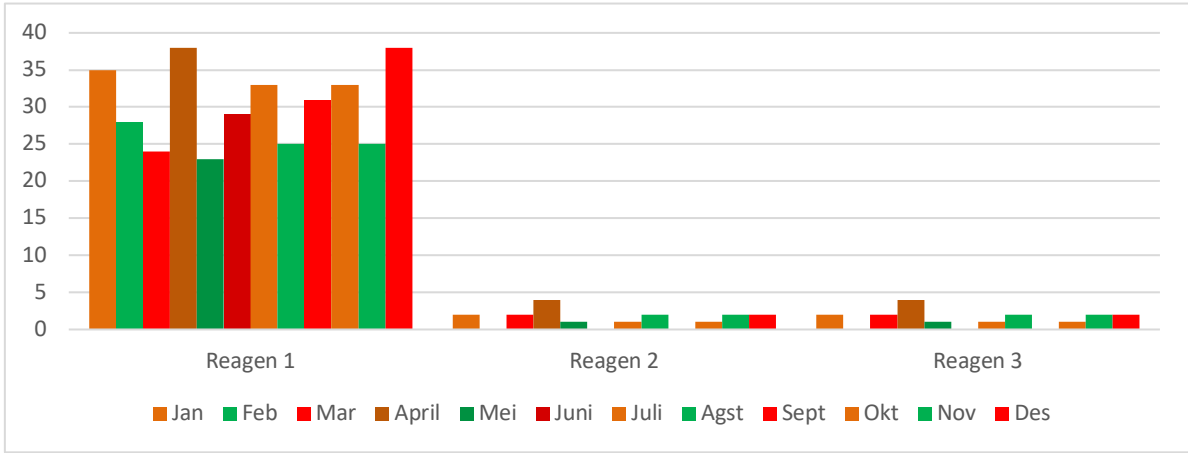
Rencana Tindak Lanjut :

Rumah sakt prima husada malang masih belum bisa melakukan pelayanan pasien dengan HIV/AIDS, apabila ditemukan pasien dengan HIV reaktif maka akan kami lakukan rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah MOU dengan RS Prima Husada Malang.

Jumlah Pemakaian Reagen

NO	URAIAN	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	Σ
1	Reagen 1	35	28	24	38	23	29	33	25	31	33	25	38	362
2	Reagen 2	2	0	2	4	1	0	1	2	0	1	2	2	17
3	Reagen 3	2	0	2	4	1	0	1	2	0	1	2	2	17

Grafik
Jumlah Pemakaian Reagen di Rumah Sakit Prima Husada Tahun 2025



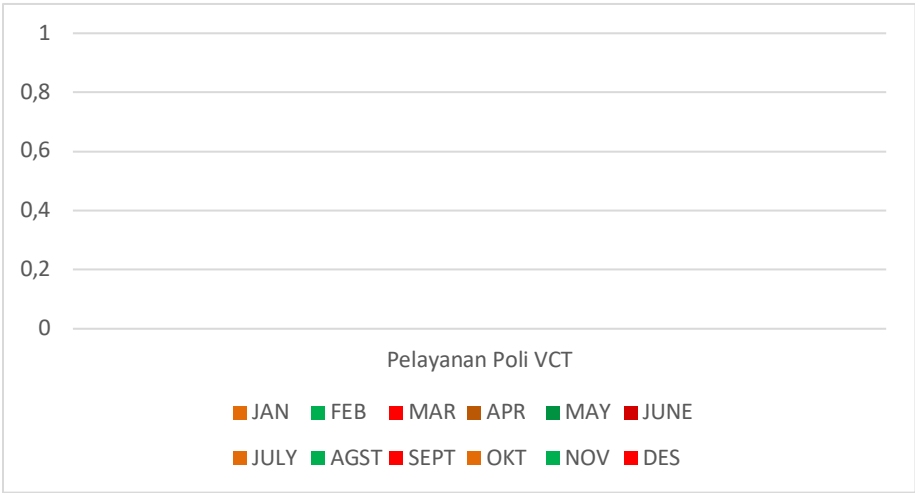
Analisis Jumlah Pemakaian Reagen :
Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa pemakaian reagen pada tahun 2025 sampai dengan reagen 3, dikarenakan terdapat 17 pasien dengan hasil HIV Reaktif.

Rencana Tindak Lanjut :
Pemakaian reagen HIV tergantung dari hasil pemeriksaan dengan Reagen 1. Apabila dilakukan pemeriksaan dengan Reagen 1 hasil Non Reatif maka tidak dilanjutkan pemakaian Reagen 2 dan 3.
Tetapi apaila saat pemeriksaan dengan Reagen 1 ditemukan hasil Reaktif maka pemeriksaan dilanjutkan dengan penggunaan Reagen 2 dan Reagen 3

3.3.4.1.5 Pelayanan Poli VCT (Voluntary Conseling And Testing)

NO	URAIAN	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	Σ
1	Pelayanan Poli VCT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Grafik
Pelayanan Poli VCT di Rumah Sakit Prima Husada Tahun 2025



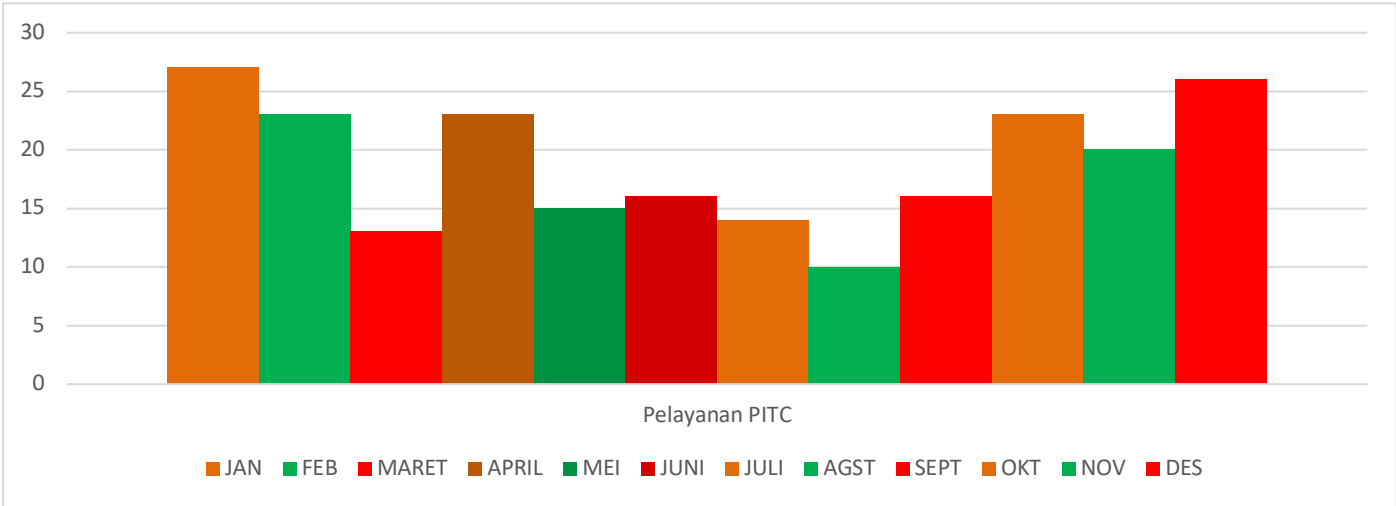
Analisis pelayanan Poli VCT :
Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa tidak ada kunjungan di poli VCT di RS Prima Husada pada tahun 2025 Hal ini dikarenakan kurang tahunya masyarakat terkait pentingnya deteksi pemeriksaan HIV/AIDS

Rencana Tindak Lanjut :
Pelayanan Poli VCT di Rumah Sakit Prima Husadabelum berdiri sendiri, melainkan masih bergabung dengan oli penyakit Dalam di Rawat jalan. Hal ini dikarenaka asih belum adanya kunjungan pasien ke poli VCT

3.3.4.1.6 Pelayanan PITC (Provider Initiated Testing and Counseling)

NO	URAIAN	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	Σ
1	Pelayanan PITC	27	23	13	23	15	16	14	10	16	23	20	26	226

Grafik
Pelayanan PITC di Rumah Sakit Prima Husada Tahun 2025



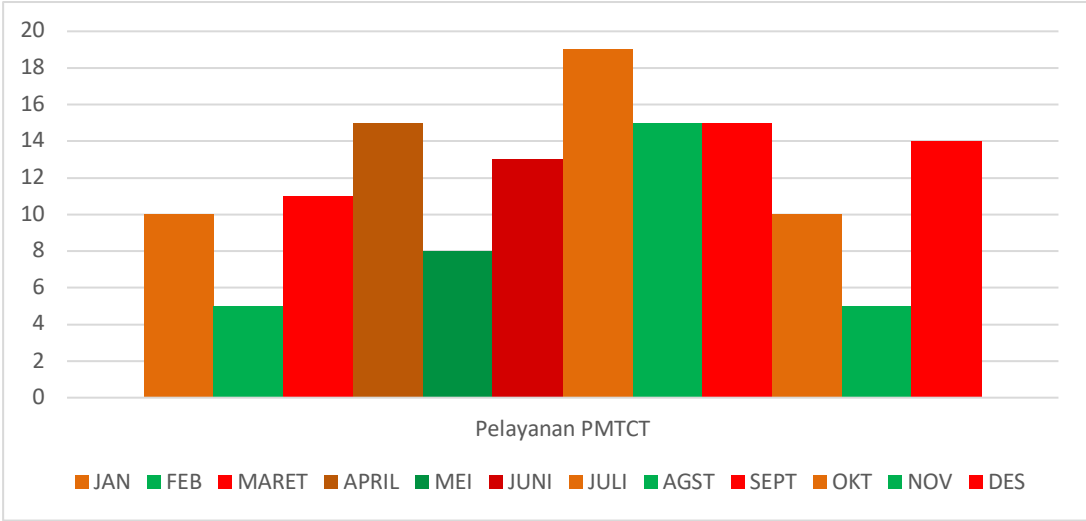
Analisis pelayanan PITC :
Dari data diatas terdapat keimpulan bahwa telah dilakukan edukasi pemeriksaan HIV oleh petugas kesehatan untuk dilakukan testing HIV pada tahun 2025 sebanyak 226 pemeriksaan. Hal ini dikarenakan testing dan konseling dilakukan saat pasien menunjukan gejala HIV dan dilakukanya sreening baik di ruangan maupun IGD

Rencana Tindak Lanjut :
Dilakukan peningkatan terkait penjangrian pasien dengan dialkukanya edukasi pasien tentang testing HIV kepada pengunjung atau masyarakat sehingga pasien paham tentang pentingya dilakukan pemeriksaan HIV.

3.3.4.1.7 Pelayanan PMTCT (Prevention to Mother Of Child Transmision)

NO	URAIAN	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	Σ
1	Pelayanan PMTCT	10	5	11	15	8	13	19	15	15	10	5	14	140

Grafik
Pelayanan PMTCT di Rumah Sakit Prima Husada Tahun 2025



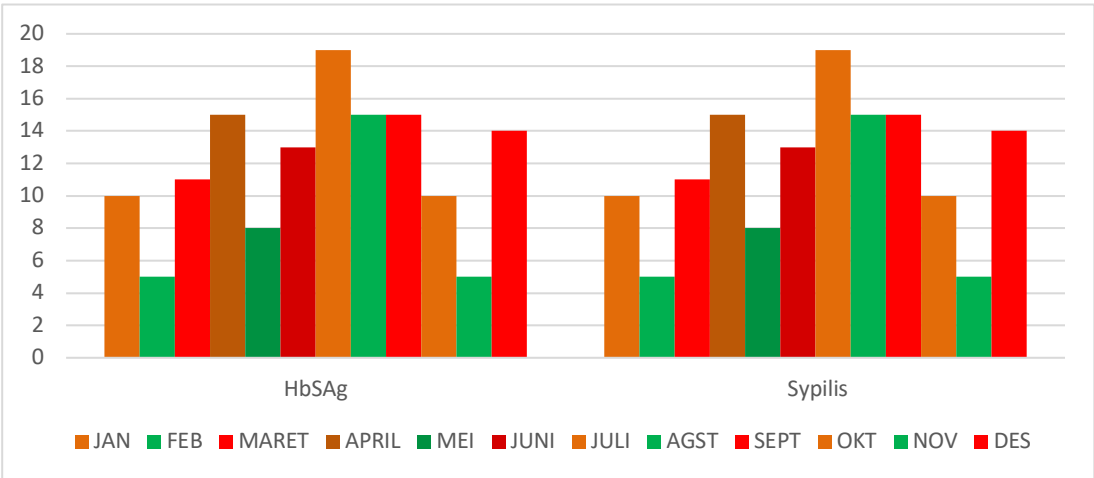
Analisis Pelayanan PMTCT :
Dari hasil grafik diatas ditemukan data pasien hamil yang dilakukan pemeriksaan HIV sebagai screening dan deteksi pencegahan penularan dari ibu ke Bayi. Pada tahun 2025 sebnayak 140 pasien. Hal ini dikarenakan pasien hamil yang sudah melakukan dan membawa hasil pemeriksaan PMTCT dari puskesmas domisili, sehingga saat kunjungan di poli kandungan RS Prima Husada Malang sudah tidak perlu lagi diulang pemeriksaanya. Sehingga pemeriksaan HIV di RS Prima Husada Malang untuk Prevention to Mother Of Child Transmision bias dilakukan.

Rencana Tindak Lanjut :
Reagen pemeriksaan HIV yang diperoleh dari dinas kesehatan sudah tersedia di RS Prima Husada Malang sehingga Sehingga pemeriksaan HIV di RS Prima Husada Malang untuk Prevention to Mother Of Child Transmision bias dilakukan.

3.3.4.1.8 Pelayanan Pemeriksaan Triple Eiminasi Pada Ibu Hamil

NO	URAIAN	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	Σ
1	Pemeriksaan HbSAg	10	5	11	15	8	13	19	15	15	10	5	14	140
2	Pemeriksaan Sypilis	10	5	11	15	8	13	19	15	15	10	5	14	140

Grafik
Pelayanan Pemeriksaan Triple Eliminasi Pada Ibu Hamil di Rumah Sakit Prima Husada Tahun 2025



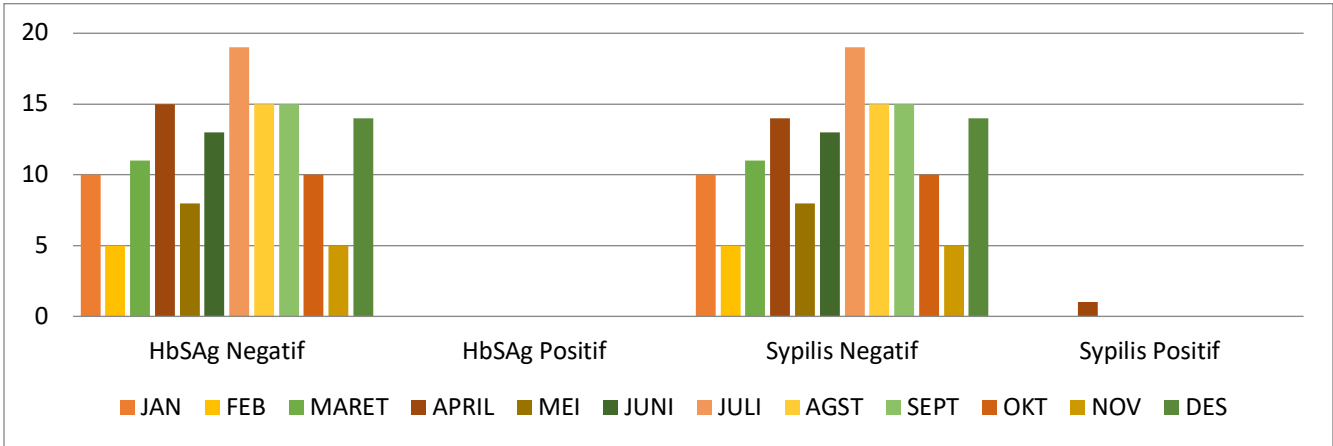
Analisis Pelayanan Pemeriksaan Triple Eliminasi Pada Ibu hamil :
Dari hasil grafik diatas ditemukan data pasien hamil yang dilakukan pemeriksaan HbSAg dan Sypilis pada tahun 2025 sebanyak 140 pasien Hal ini dikarenakan pasien hamil yang sudah melakukan dan membawa hasil pemeriksaan triple eliminasi dari puskesmas domisili, sehingga saat kunjungan di poli kandungan RS Prima Husada Malang sudah tidak perlu lagi diulang pemeriksaanya. Sehingga pemeriksaan Triple eliminasi di RS Prima Husada Malang untuk pemeriksaan HbSAg dan Sypilis bisa dilakukan.

Rencana Tindak Lanjut :
Pemeriksaan Triple eliminasi untuk ibu hamil bersifat wajib dan dilakukan 1 kali saat awal kehamilan. Di RS Prima Husada skrining pemeriksaan triple eliminasi sudah berjalan dan dilakukan saat kunjungan pada Trimester 2.

3.3.4.1.9 Status Pelayanan Pemeriksaan Triple Eiminasi Pada Ibu Hamil

NO	URAIAN	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	Σ
1	HbSAg													
	Negatif	10	5	11	15	8	13	19	15	15	10	5	14	140
	Positif	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Sypilis													
	Negatif	10	5	11	14	8	13	19	15	15	10	5	14	139
	Positif	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Grafik
Status Pelayanan Pemeriksaan Triple Eliminasi Pada Ibu Hamil di Rumah Sakit Prima Husada Tahun 2025



Analisis Status Pelayanan Pemeriksaan Triple Eliminasi Pada ibu Hamil

Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa ditemukan 1 kasus pasien dengan syphilis sepanjang tahun 2024. Sedangkan pada kasus HbSAg tidak ditemukan pasien dengan HbSAg positif. Hal ini dikarenakan pasien menerapkan pola hidup sehat saat kehamilan.

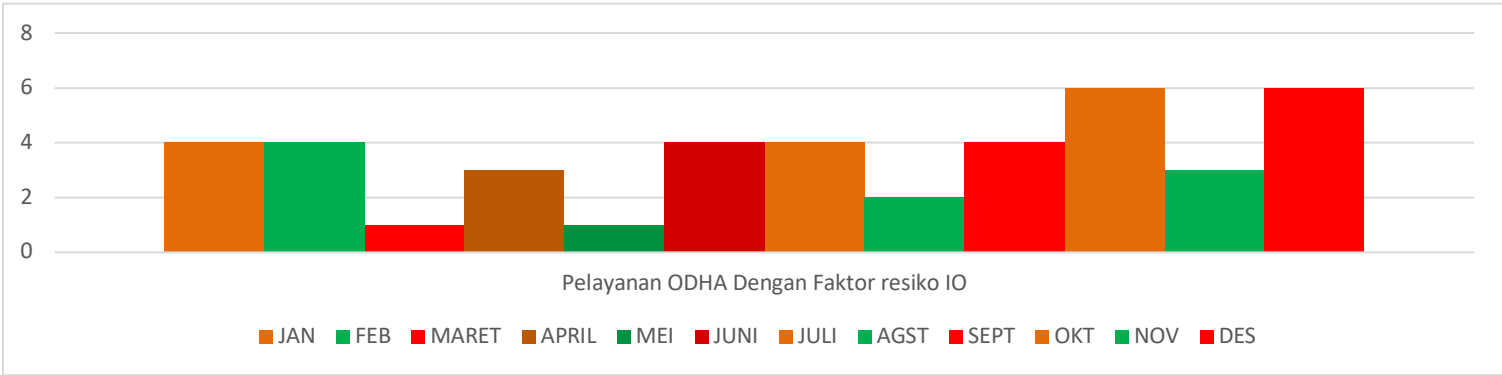
Rencana Tindak Lanjut

1. Pada pasien HbSAg
- Saat kelahiran aka nada pemberian vaksin Hepatitis kepada bayi yaitu Hiper Heb dan juga Hb.O unijec yang diberikan saat bayi baru lahir sampai dengan maksimal 24 jam pemberian. Untuk ibu dengan HbSAg akan dilakukan pemberian vaksin hepatitis oleh Puskesmas sesuai domisili pasien.Penanganan pasien dengan HbSAg Rumah Sakit Prima Husada Malang Kolaborasi dengan puskesmas sesuai dengan domisili pasien.
2. Pada pasien Sypilis
- Di rumah sakit Prima Husada Malang sudah bisa melakukan pengobatan pasien dengan syphilis positif. Sehingga tidak lagi melakukan rujuk keluar.

3.3.4.1.10 Pelayanan ODHA Dengan Factor Resiko Infeksi Oportunistik

NO	URAIAN	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	Σ
1	Pelayanan ODHA Dengan Faktor resiko IO	4	4	1	3	1	4	4	2	4	6	3	6	42

Grafik
Pelayanan Odha Dengan Faktor Resiko IO di Rumah Sakit Prima Husada Tahun 2025



Analisis pelayanan Pelayanan ODHA Dengan Faktor resiko IO

Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa terdapat pasien dengan diagnose TB positif yang dilakukan pemeriksaan HIV di RS Prima Husada malang selama tahun 2024 sebanyak 58 pasien. Hal ini dikarenakan dilakukanya screening pasien TB di RS Prima Husada Malang.

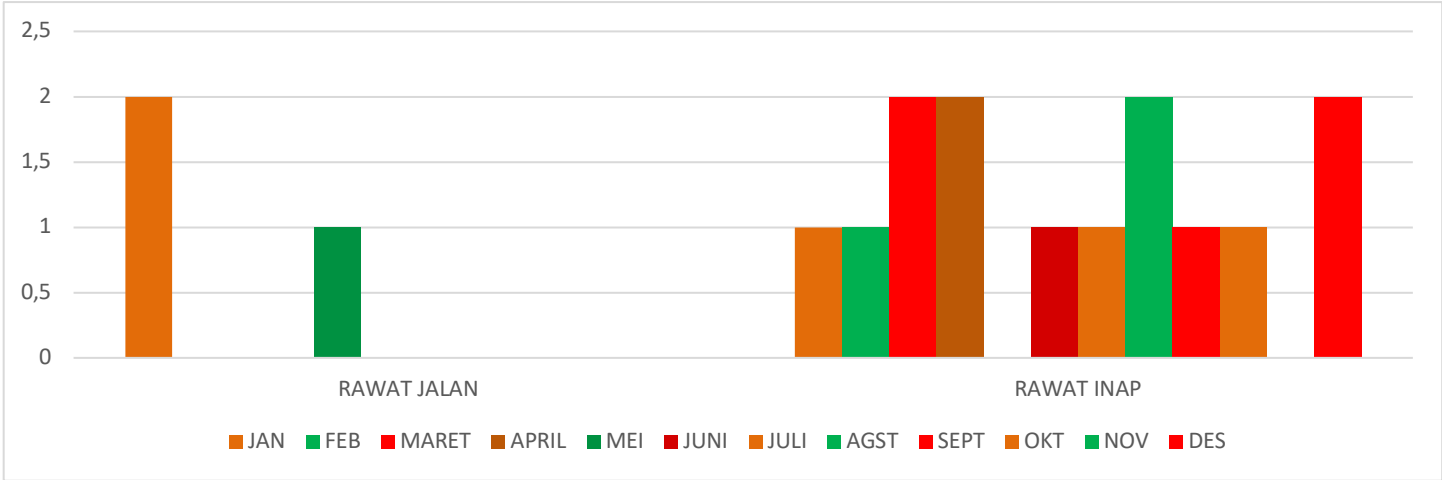
Rencana Tindak Lanjut

Pasien-pasien dengan diagnose TB positif di Rumah Sakit Prima Husada Malang sudah patuh dilakukan screening pemeriksaan HIV/AIDS sesuai dengan SPO. Diharapkan bisa saling kerjasama antar tim yaitu TIM TB dan Tim HIV.

3.3.4.1.11 Pelayanan Rujukan Pasien Dengan HIV/AIDS

NO	URAIAN	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	Σ
1	Rawat Jalan	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3
2	Rawat Inap	1	1	2	2	0	1	1	2	1	1	0	2	14

Grafik
Pelayanan Rujukan Pasien Dengan HIV/AIDS di Rumah Sakit Prima Husada Tahun 2025



Analisis Pelayanan rujukan pasien dengan HIV/AIDS

Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa pada tahun 2025 terdapat 18 pasien yang dilakukan rujuk eksternal. Hal ini dikarenakan tidak ada pasien yang ditemukan positif HIV

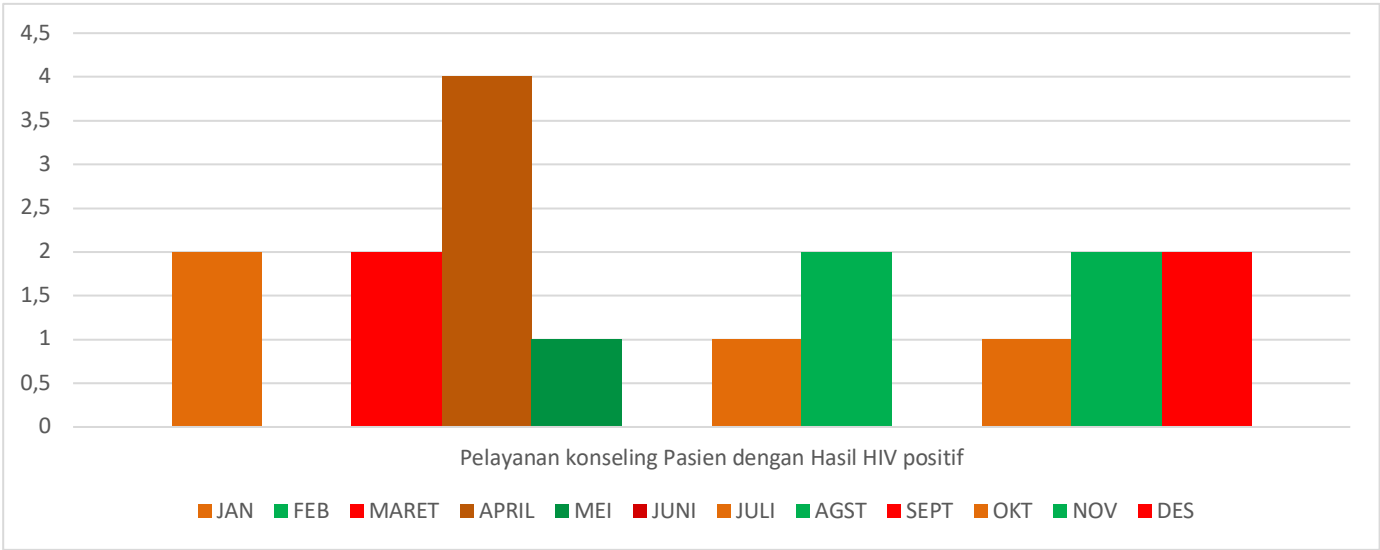
Rencana Tindak Lanjut

Pelaksanaan Rujukan dilakukan apabila hasil pemeriksaan HIV Reaktif. Rujukan dilakukan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah bekerjasama dengan Rumah Sakit Prima Husada Malang.

3.3.4.1.12 Kegiatan pelayanan konseling Pasien dengan Hasil HIV positif di RS Prima Husada Malang tahun 2025

NO	URAIAN	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	Σ
1	Pelayanan konseling Pasien dengan Hasil HIV positif	2	0	2	4	1	0	1	2	0	1	2	2	17

Grafik
Pelayanan Konseling Pasien Dengan Hasil HIV Positif di Rs Prima Husada Malang Tahun 2025



Analisis Pelayanan konseling Pasien dengan Hasil HIV Positif :

Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa pada tahun 2025 terdapat 17 pasien yang dilakukan konseling dengan hasil pemeriksaan HIV positif. Hal ini dikarenakan seluruh pasien dengan hasil pemeriksaan positif HIV perlu dilakukan konseling baik sebelum dilakukan pemeriksaan maupun sesudah pemeriksaan, dengan tujuan pasien paham terkait rencana tindak lanjut perawatan pasien.

Rencana Tindak Lanjut :

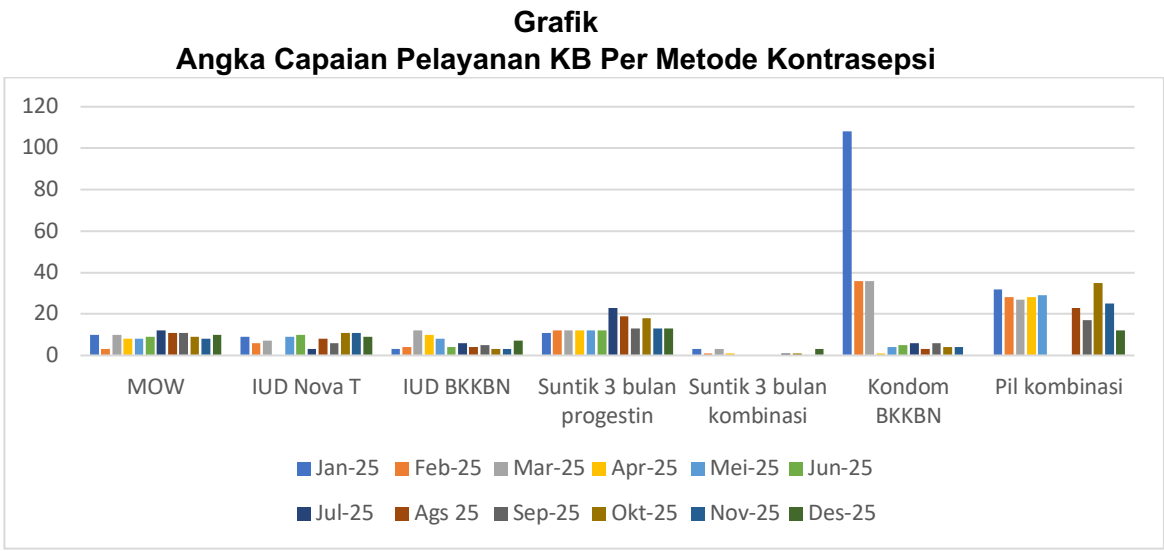
Pelaksanaan pelayanan konseling pasien dengan hasil HIV positif dilakukan kepada setiap pasien yang dilakukan pemeriksaan HIV, baik sebelum dilakukan pemeriksaan maupun setelah dilaksanakan pemeriksaan guna mengetahui rencana tindak lanjut pasien. Pelaksanaan konseling dilakukan di ruang dokter masing-masing poli spesialis dimana tempat pasien asal permintaan

3.3.4.2 PKBRS

3.3.4.2.1 Angka Capaian Pelayanan KB per Metode Kontrasepsi

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH PASIEN											
		JAN 25	FEB 25	MAR 25	APR 25	MEI 25	JUN 25	JUL 25	AGS 25	SEP 25	OKT 25	NOV 25	DES 25
1	MOW	10	3	10	8	8	9	12	11	11	9	8	10
2	IUD Nova T	9	6	7	0	9	10	3	8	6	11	11	9
3	IUD BKKBN	3	4	12	10	8	4	6	4	5	3	3	7
4	IMPLANT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5	SUNTIK 3 BULAN PROGESTIN	11	12	12	12	12	12	23	19	13	18	13	13
6	SUNTIK 3 BULAN KOMBINASI	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	3
7	SUNTIK 1 BULAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	PIL KOMBINASI	32	28	27	28	29	0	0	23	17	35	25	12
9	KONDOM BKKBN	108	36	36	1	4	5	6	3	6	4	4	0



Evaluasi :

1. Peserta MOW pada bulan Januari (10) Februari (3) naik Maret (10)
2. Peserta IUD Nova T pada bulan Januari (9) Februari (6) Maret (7)
3. Peserta IUD BKKBN Januari (3) naik Februari (4) Maret (12)
4. Peserta KB suntik 3 bulan kombinasi, pada bulan Januari (3) turun Februari (1) naik Maret (3)
5. Peserta KB suntik progestin Januari (11) naik Februari (12) Maret tetap (12)
6. Peserta KB pil kombinasi pada bulan Januari (32) turun Februari (28) Maret (27)
7. Peserta KB Kondom pada bulan Januari (108) menurun Februari (36) Maret tetap (36)
8. Peserta MOW pada bulan April turun (8)Mei tetap(8) Juni naik (9)
9. Peserta IUD Nova T pada bulan April turun (0) Mei naik(9) Juni (10)
10. Peserta IUD BKKBN April turun (10) Mei (8) Juni (4)
11. Peserta KB suntik 3 bulan kombinasi, pada bulan April turun (1) Mei (0) Juni(0)
12. Peserta KB suntik progestin April tetap (12) Mei tetap(12) Juni (12)
13. Peserta KB pil kombinasi pada bulan April (28) Mei naik (29) Juni (0)
14. Peserta KB Kondom pada bulan April turun (1) Mei naik(4) Juni (5)
15. Peserta MOW pada bulan Juli naik (12) Agustus (11) September tetap (11)
16. Peserta IUD Nova T pada bulan Juli turun (3) Agustus naik (8) September turun (6)
17. Peserta IUD BKKBN pada bulan Juli naik (6) Agustus (4) September naik (5)
18. Peserta KB suntik 3 bulan kombinasi, pada bulan Juli (1) Agustus dioperkan ke faskes lain sebanyak 80 vial,September (1)
19. Peserta KB suntik progestin pada bulan Juli naik (23) Agustus dipakai sebanyak (19) dioperkan ke faskes lain sebanyak (10) vial September turun (13)
20. Peserta KB pil kombinasi pada bulan Juli (0) Agustus (23) September turun (17)
21. Peserta KB Kondom pada bulan Juli (6) turun Agustus (3) September naik (6)
22. Peserta MOW pada bulan Oktober (9) pada November turun (8) pada Desember naik (10)

23. Peserta IUD Nova T pada bulan Oktober naik (11) pada November tetap 11 pada Desember turun (9)
24. Peserta IUD BKKBN pada bulan Oktober turun (3)November tetap (3) Desember naik (7)
25. Peserta KB suntik 3 bulan kombinasi, pada buan Oktober tetap (1) November turun (0) Desember naik (3)
26. Peserta KB suntik progestin pada bulan Oktober naik (18) November turun (13) Desember tetap (13)
27. Peserta KB pil kombinasi pada bulan Oktober naik (35) November turun (25) karena stok habis dan Desember naik (28)
28. Peserta KB Kondom pada bulan Oktober turun (4) November tetap (4) Desember turun karena stok habis (0)

Analisis:

- 1. Kolaborasi dengan bagian marketing rumah sakit terkait jumlah kunjungan pasien poli obgyn salah satunya dengan mengadakan promosi lewat sosial media.
- 2. Melakukan edukasi tentang pentingnya KB pada pasangan usia subur dengan rutin melakukan penyuluhan.
- 3. Melakukan edukasi kepada pasien ANC trimester 3 poli kandungan tentang pentingnya KB lewat penyuluhan.
- 4. Meningkatkan keterampilan bidan dalam pemasangan IUD pasca persalinan
- 5. Rutin dilakukan safari KB

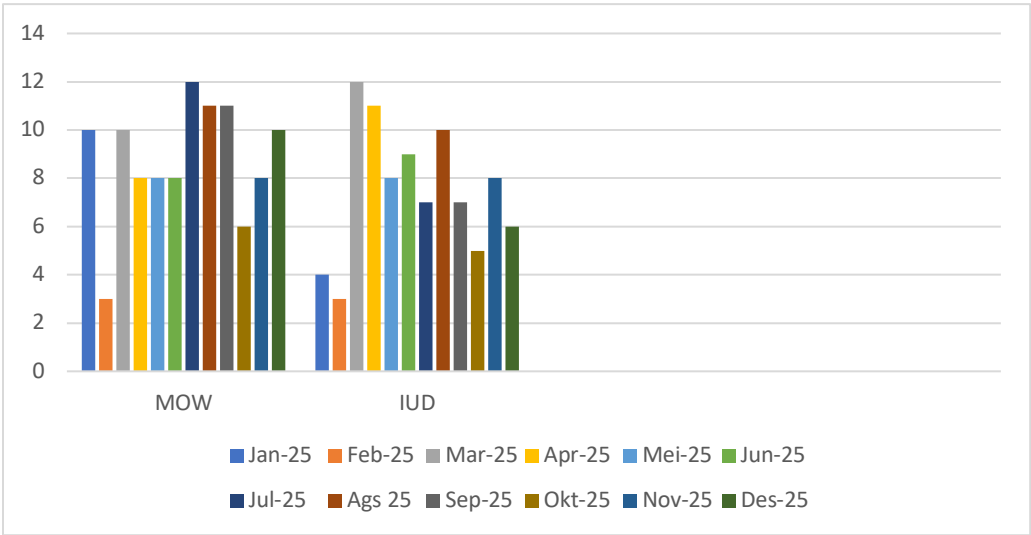
Rencana tindak laanjut :

Dengan adanya riwayat kekosongan barang dari pabrik,sebaiknya tim Gudang farmasi menambah stok minimal barang sehingga tidak terjadi lagi kekosongan jumlah barang

3.3.4.2.2 Angka Capaian Pelayanan KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran

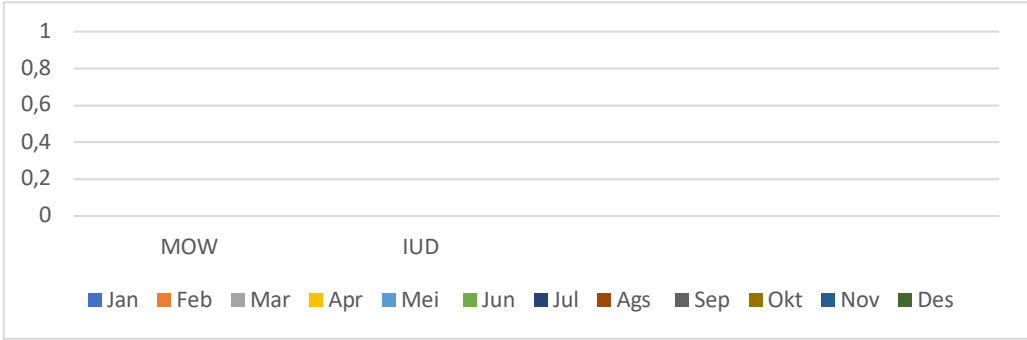
NO	JENIS PELAYANAN PASCA PERSALINAN	JUMLAH PASIEN											
		JAN 25	FEB 25	MAR 25	APR 25	MEI 25	JUN 25	JUL 25	AGS 25	SEP 25	OKT 25	NOV 25	DES 25
1	MOW	10	3	10	8	8	8	12	11	11	6	8	10
2	IUD	4	3	12	11	8	9	7	10	7	5	8	6

Grafik
Angka Capaian Pelayanan KB Pasca Persalinan



NO	JENIS PELAYANAN PASCA KEGUGURAN	JUMLAH PASIEN											
		JAN 25	FEB 25	MAR 25	APR 25	MEI 25	JUN 25	JUL 25	AGS 25	SEP 25	OKT 25	NOV 25	DES 25
1	MOW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	IUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

Grafik
 Angka Capaian Pelayan KB Pasca Keguguran



Angka capaian pelayanan KB pasca persalinan dan pasca keguguran

Evaluasi :

1. Angka capaian pelayanan KB pasca persalinan pada tahun 2025 mengalami peningkatan dan penurunan setiap bulannya.
2. Angka capaian pelayanan KB pasca keguguran pada pada tahun 2025 mengalami peningkatan dan penurunan setiap bulannya.

Analisis :

Peningkatan jumlah sasaran pada triwulan ketiga kemungkinan didapatkan karena sasaran KB sudah mengetahui pentingnya KB dari pengetahuan yang didapatkan saat sosialisasi yang dilakukan tim setiap bulannya.

Capaian pelayanan KB pasca keguguran juga mengalami peningkatan dan penurunan dikarenakan peserta mempunyai alasan ingin segera hamil lagi.

Rencana dan Tindak Lanjut :

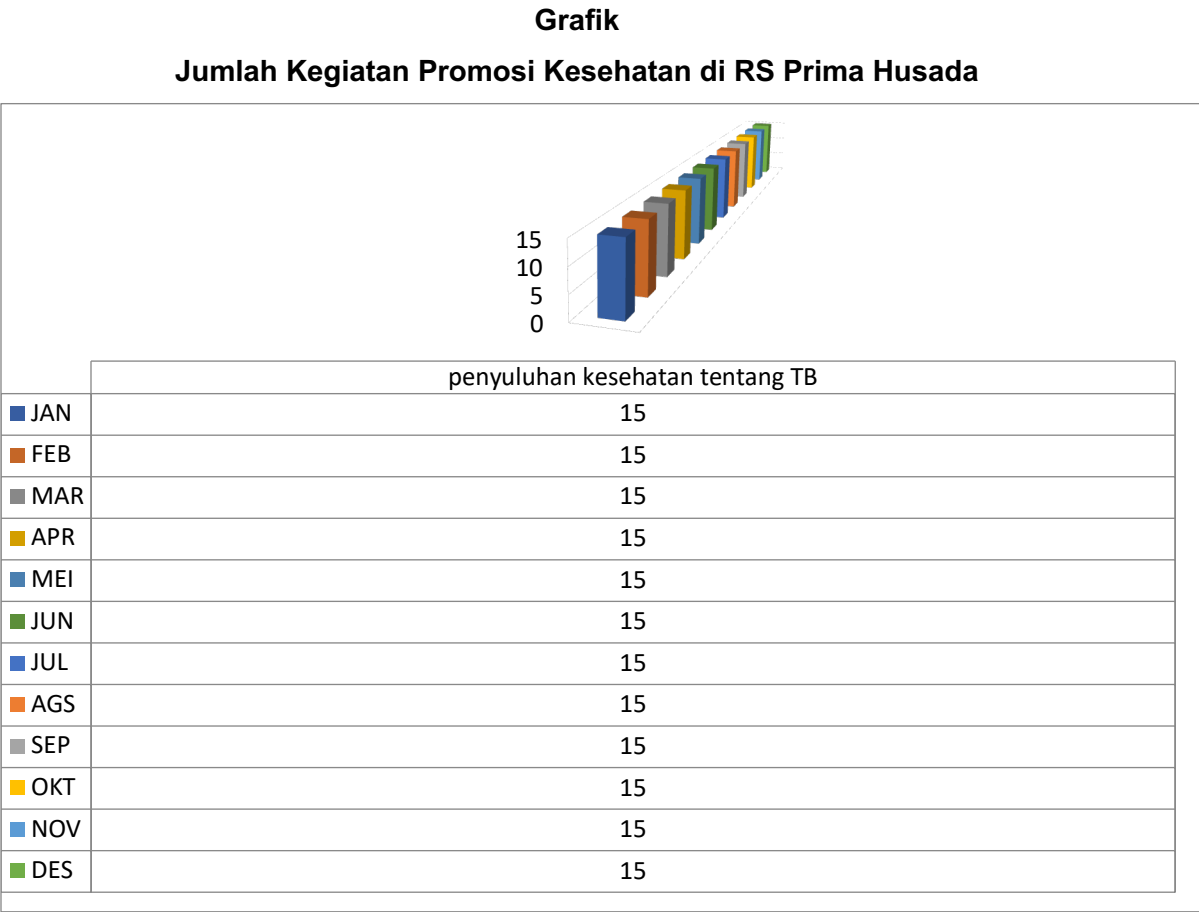
1. Kolaborasi dengan bagian marketing rumah sakit terkait jumlah kunjungan pasien poli obgyn salah satunya dengan mengadakan promosi lewat sosial media.
2. Melakukan edukasi tentang pentingnya KB pada pasangan usia subur dengan rutin melakukan penyuluhan.
3. Melakukan edukasi kepada pasien ANC trimester 3 poli kandungan tentang pentingnya KB lewat penyuluhan.
4. Meningkatkan keterampilan bidan dalam pemasangan IUD pasca persalinan
5. Rutin dilakukan safari KB

3.3.4.3 TB DOT'S

3.3.4.3.1 Jumlah Kegiatan Promosi Kesehatan Tentang Tuberculosis

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH KEGIATAN											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1	Penyuluhan kesehatan	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15

	tentang tuberculosis												
--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Evaluasi :
 Peserta audiens ditujukan kepada pasien dan keluarga paien, dengan harapan peserta memahami hasil penyuluhan.

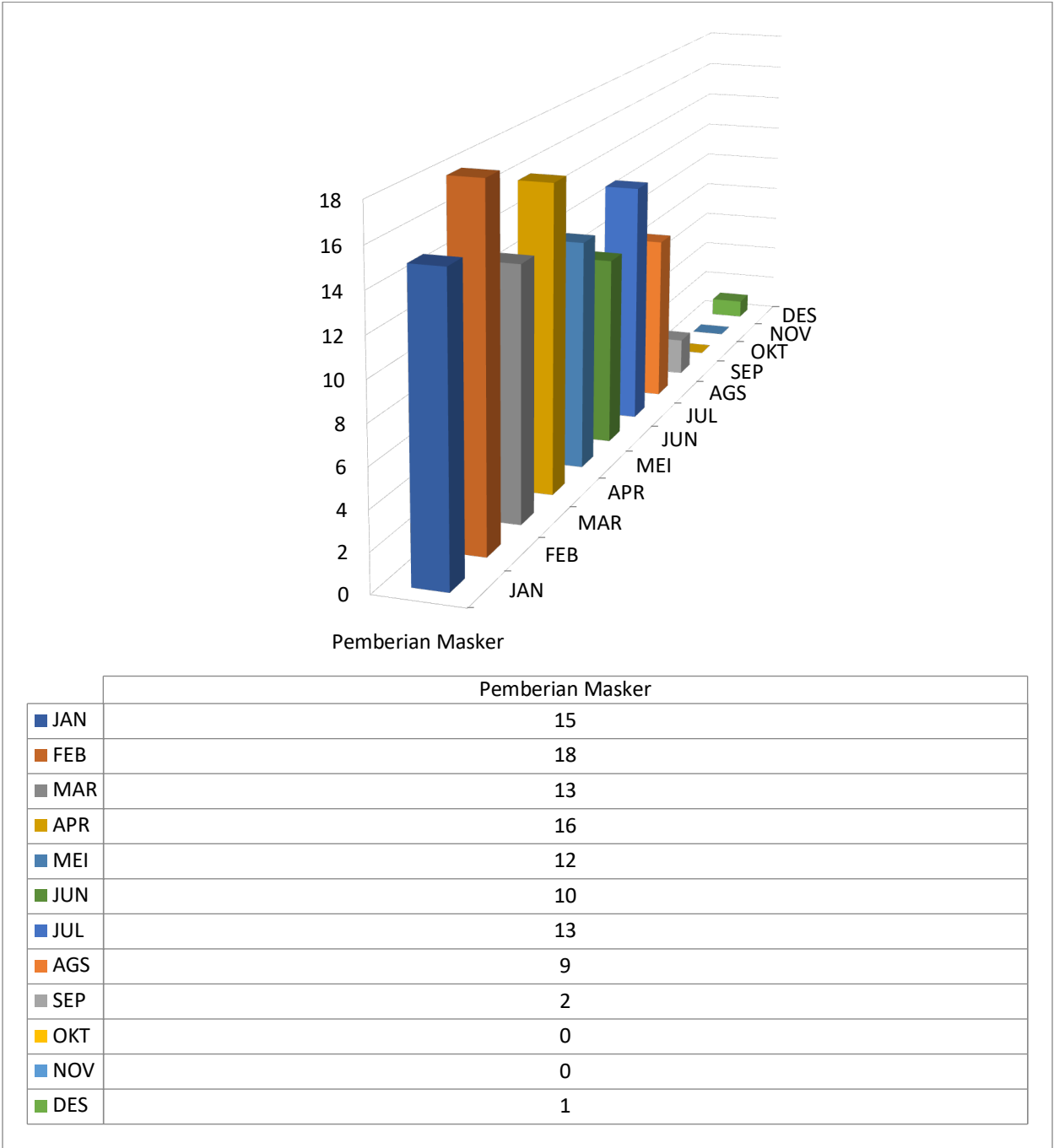
Rencana dan Tindak Lanjut
 Harus diadakan promosi kesehatan secara berkala terkait TBC seperti; pentingnya patuh dalam pengobatan TBC, kapan waktu yang tepat minum obat TBC, apa tanda gejala TBC, dlls.

3.3.4.3.2 Skrining Pasien

NO	JENIS SKRINING	JUMLAH KEGIATAN											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1	Pemberian Masker	15	18	13	16	12	10	13	9	2	0	0	1

Grafik

Jumlah Pasien Dengan Skrining Awal Pemberian Masker di RS Prima Husada



Evaluasi :

- 1) Pada bulan Januari 2025 terdapat 15 pasien yang diberikan masker karena masker yang dipakai kotor atau tidak standart
- 2) Pada bulan Februari 2025 terdapat 18 pasien yang diberikan masker karena masker yang dipakai kotor atau tidak standart
- 3) Pada bulan Maret 2025 terdapat 13 pasien yang diberikan masker karena masker yang dipakai kotor atau tidak standart
- 4) Pada bulan April 2025 terdapat 16 pasien yang diberikan masker karena masker yang dipakai kotor atau tidak standart
- 5) Pada bulan Mei 2025 terdapat 12 pasien yang diberikan masker karena masker yang dipakai kotor atau tidak standart
- 6) Pada bulan Juni 2025 terdapat 10 pasien yang diberikan masker karena masker yang dipakai kotor atau tidak standart
- 7) Pada bulan Juli 2025 terdapat 13 pasien yang diberikan masker karena masker yang dipakai kotor atau tidak standart

- 8) Pada bulan Agustus 2025 terdapat 9 pasien yang diberikan masker karena masker yang dipakai kotor atau tidak standart
- 9) Pada bulan September 2025 terdapat 2 pasien yang diberikan masker karena masker yang dipakai kotor atau tidak standart
- 10) Pada bulan Oktober 2025 terdapat 0 pasien yang diberikan masker karena masker yang dipakai kotor atau tidak standart
- 11) Pada bulan November 2025 terdapat 0 pasien yang diberikan masker karena masker yang dipakai kotor atau tidak standart
- 12) Pada bulan Desember 2025 terdapat 1 pasien yang diberikan masker karena masker yang dipakai kotor atau tidak standar

Rencana dan Tindak Lanjut :

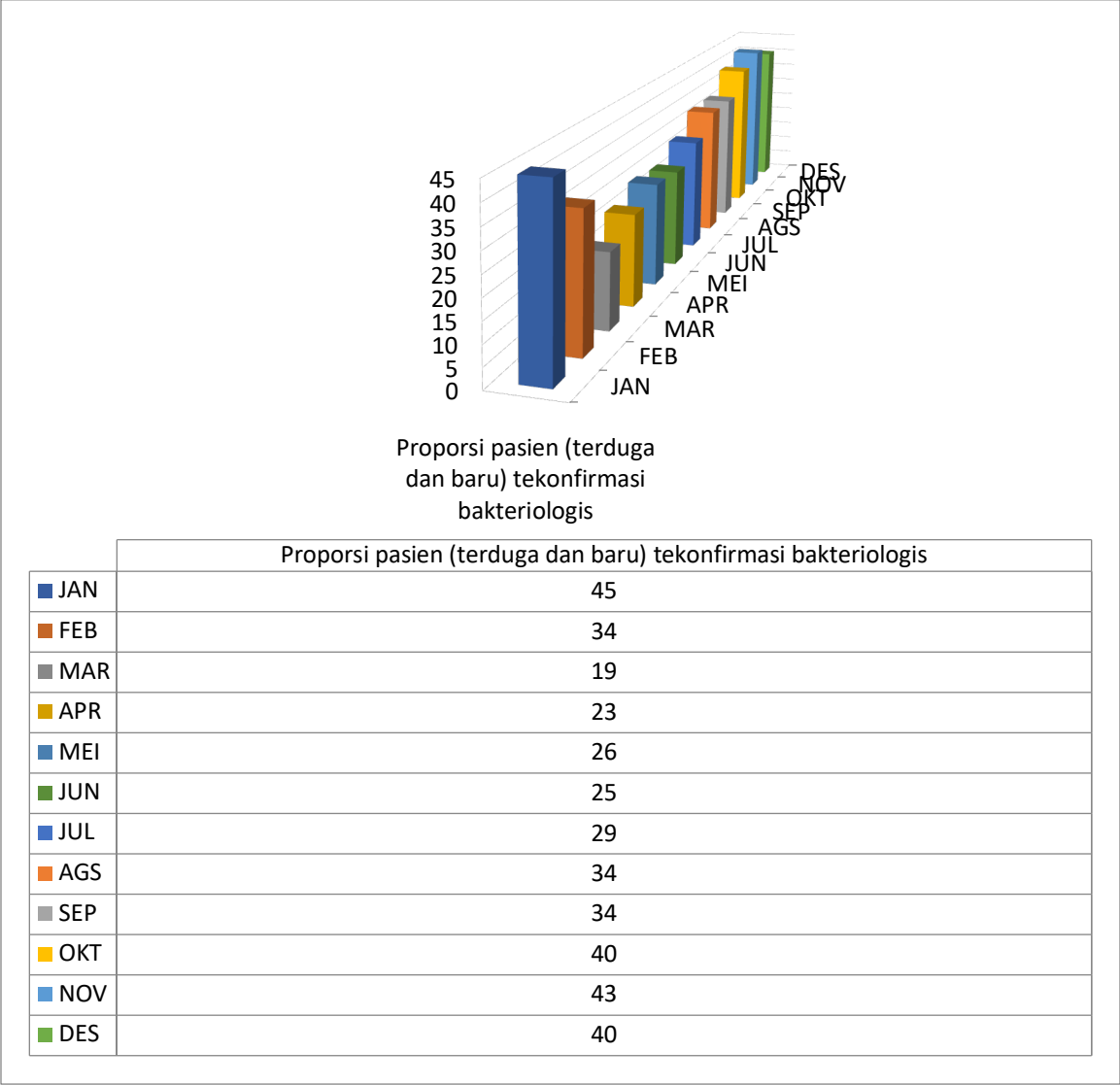
- 1) Memfasilitasi ketersediaan masker
- 2) Edukasi pemakaian masker (meliputi fungsi, waktu penggunaan, dan siapa saja yang perlu menggunakan).

3.3.4.3.3 Proporsi Pasien (Terduga dan Baru) Tekonfirmasi Bakteriologis

NO	JENIS SKRINING	JUMLAH KEGIATAN											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1	Proporsi pasien (terduga dan baru) tekonfirmasi bakteriologis	45	34	19	23	26	25	29	34	34	40	43	40

Grafik 3

Proporsi Pasien (Terduga dan Baru) Tekonfirmasi Bakteriologis di RS Prima Husada



Evaluasi :

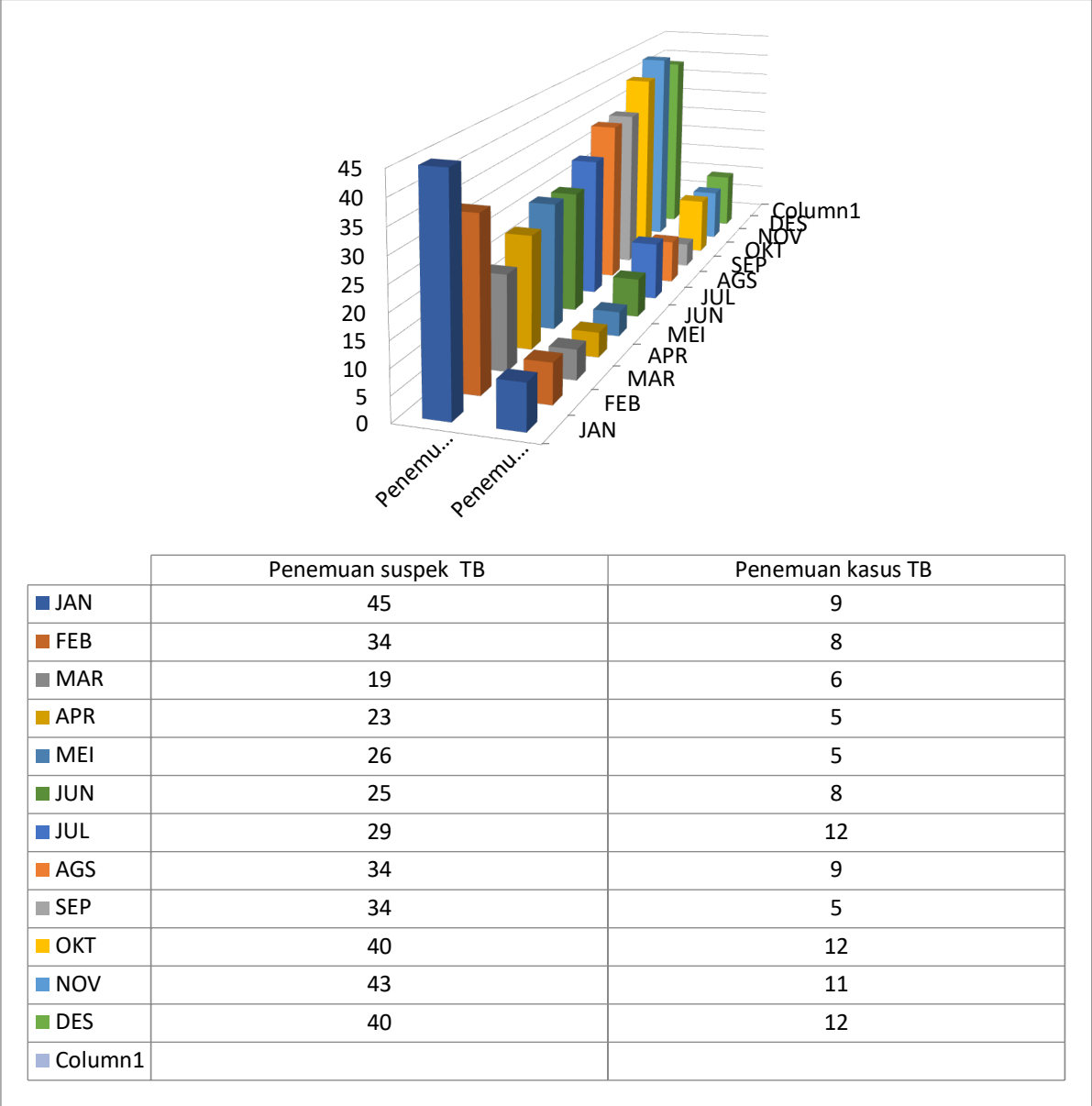
- 1) Pada bulan Januari 2025 jumlah proporsi Pasien terduga TB 45 pasien
- 2) Pada bulan Februari 2025 jumlah proporsi Pasien terduga TB 34 pasien
- 3) Pada bulan Maret 2025 jumlah proporsi Pasien terduga TB 19 pasien
- 4) Pada bulan April 2025 jumlah proporsi Pasien terduga TB 23 pasien
- 5) Pada bulan Mei 2025 jumlah proporsi Pasien terduga TB 26 pasien
- 6) Pada bulan Juni 2025 jumlah proporsi Pasien terduga TB 25 pasien
- 7) Pada bulan Juli 2025 jumlah proporsi Pasien terduga TB 29 pasien
- 8) Pada bulan Agustus 2025 jumlah proporsi Pasien terduga TB 34 pasien
- 9) Pada bulan September 2025 jumlah proporsi Pasien terduga TB 34 pasien
- 10) Pada bulan Oktober 2025 jumlah proporsi Pasien terduga TB 40 pasien
- 11) Pada bulan November 2025 jumlah proporsi Pasien terduga TB 43 pasien
- 12) Pada bulan Desember 2025 jumlah proporsi Pasien terduga TB 40 pasien

Rencana dan Tindak Lanjut :
Melakukan edukasi terhadap keluarga pasien dengan kontak TB untuk melakukan skrining TB

3.3.4.3.4 Penemuan Kasus TB

NO	JENIS SKRINING	JUMLAH KEGIATAN											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1.	Penemuan suspek TB	45	34	19	23	26	25	29	34	34	40	43	40
2	Penemuan kasus TB	9	8	6	5	5	8	12	9	5	12	11	12

Grafik
Penemuan Kasus TB Baru di Rumah Sakit Prima Husada



- Evaluasi :**
- 1) Pada bulan Januari 2025 terdapat 45 pasien jumlah penemuan suspek TB dan kasus TB positif sebanyak 9 pasien
 - 2) Pada bulan Februari 2025 terdapat 34 pasien jumlah penemuan suspek TB dan kasus TB positif sebanyak 8 pasien
 - 3) Pada bulan Maret 2025 terdapat 19 pasien jumlah penemuan suspek TB dan kasus TB positif sebanyak 6 pasien

- 4) Pada bulan April 2025 terdapat 23 pasien jumlah penemuan suspek TB dan kasus TB positif sebanyak 5 pasien
- 5) Pada bulan Mei 2025 terdapat 26 pasien jumlah penemuan suspek TB dan kasus TB positif sebanyak 5 pasien
- 6) Pada bulan Juni 2025 terdapat 25 pasien jumlah penemuan suspek TB dan kasus TB positif sebanyak 8 pasien
- 7) Pada bulan Juli 2025 terdapat 29 pasien jumlah penemuan suspek TB dan kasus TB positif sebanyak 12 pasien
- 8) Pada bulan Agustus 2025 terdapat 34 pasien jumlah penemuan suspek TB dan kasus TB positif sebanyak 9 pasien
- 9) Pada bulan September 2025 terdapat 34 pasien jumlah penemuan suspek TB dan kasus TB positif sebanyak 5 pasien
- 10) Pada bulan Oktober 2025 terdapat 40 pasien jumlah penemuan suspek TB dan kasus TB positif sebanyak 12 pasien
- 11) Pada bulan November 2025 terdapat 43 pasien jumlah penemuan suspek TB dan kasus TB positif sebanyak 11 pasien
- 12) Pada bulan Desember 2025 terdapat 40 pasien jumlah penemuan suspek TB dan kasus TB positif sebanyak 12 pasien

Rencana Dan Tindak Lanjut :

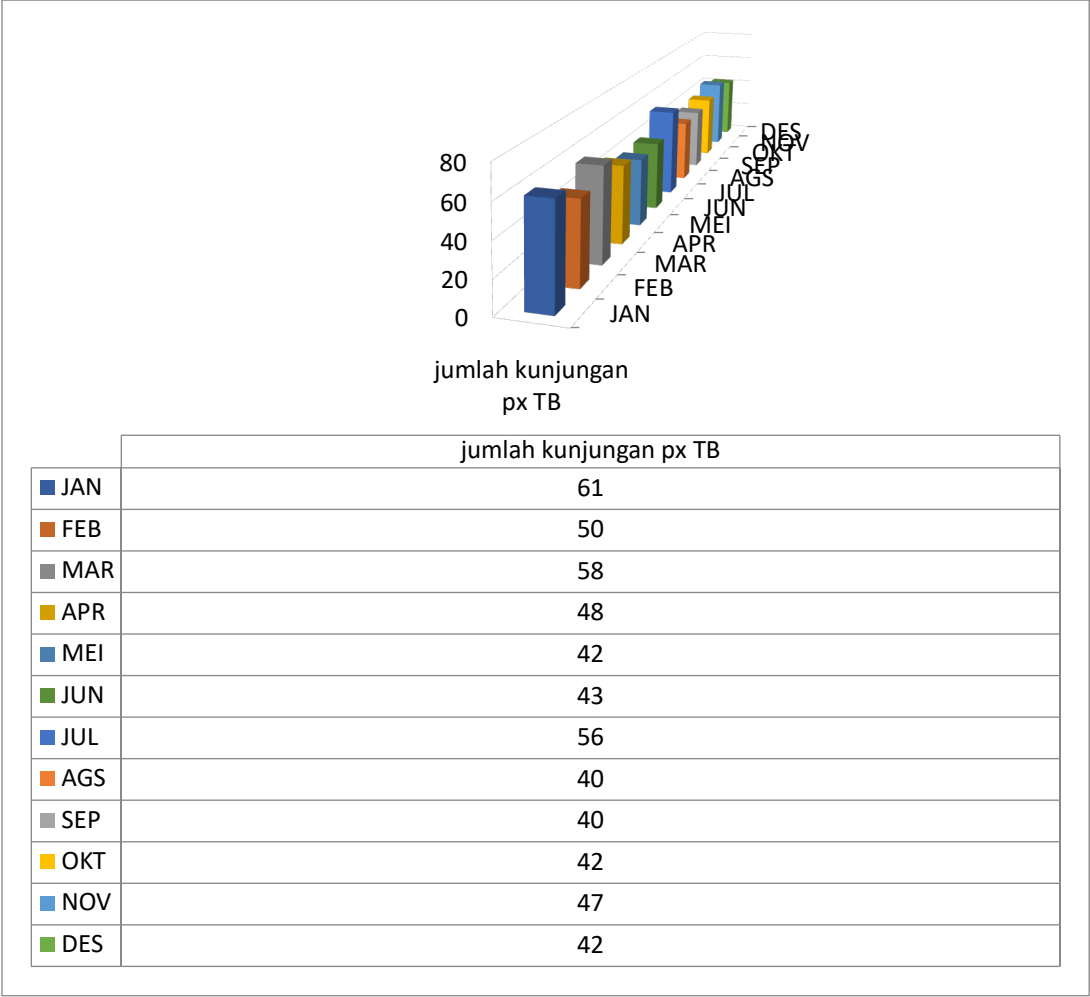
Menginformasikan kepada pasein dan keluarga pasien untuk melakukan pengobatan dengan teratur dan sesuai jadwal, serta mengedukasi kepada keluarga pasie untuk melakukan skrinning TB

3.3.4.3.5 Jumlah Kunjungan pasien TB

NO	KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1	Pasien TB kunjungan keseluruhan	61	50	58	48	42	43	56	40	40	42	47	42

Grafik

Jumlah Kunjungan Pasien TB Baru Di Rumah Sakit Prima Husada



Evaluasi :

Setiap bulannya terus meningkatkan jumlah kunjungan

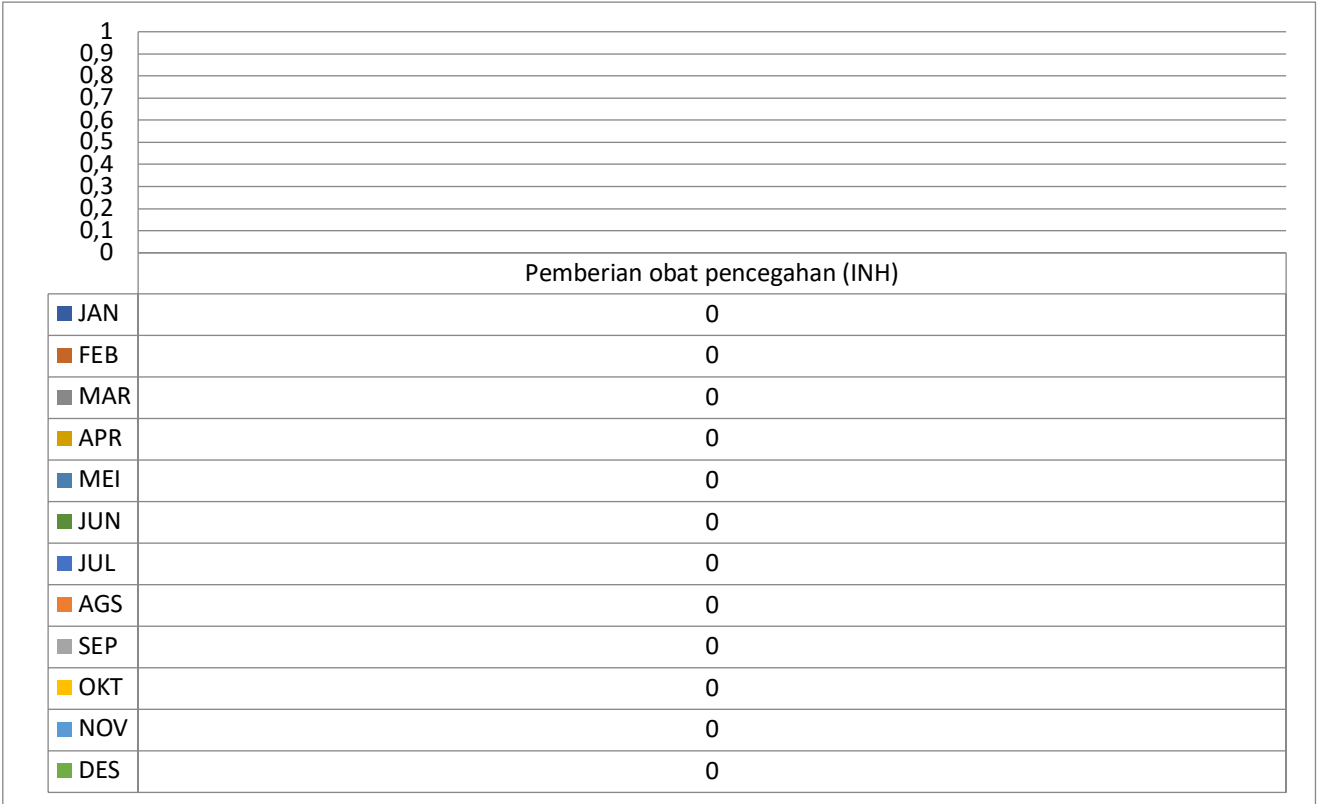
Rencana dan Tindak Lanjut :

Meningkatkan kunjungan pasien

3.3.4.3.6 Pemberian Obat Pencegahan

NO	KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1	Pemberian obat pencegahan (INH)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Grafik
Pemberian Obat Pencegahan di Rumah Sakit Prima Husada



Evaluasi :

Tidak ada yang mendapat obat pencegahan (INH), hal ini dikarenakan kurang pengetahuannya pasien dan keluarga pasien mengenai pengobatan pencegahan (INH)

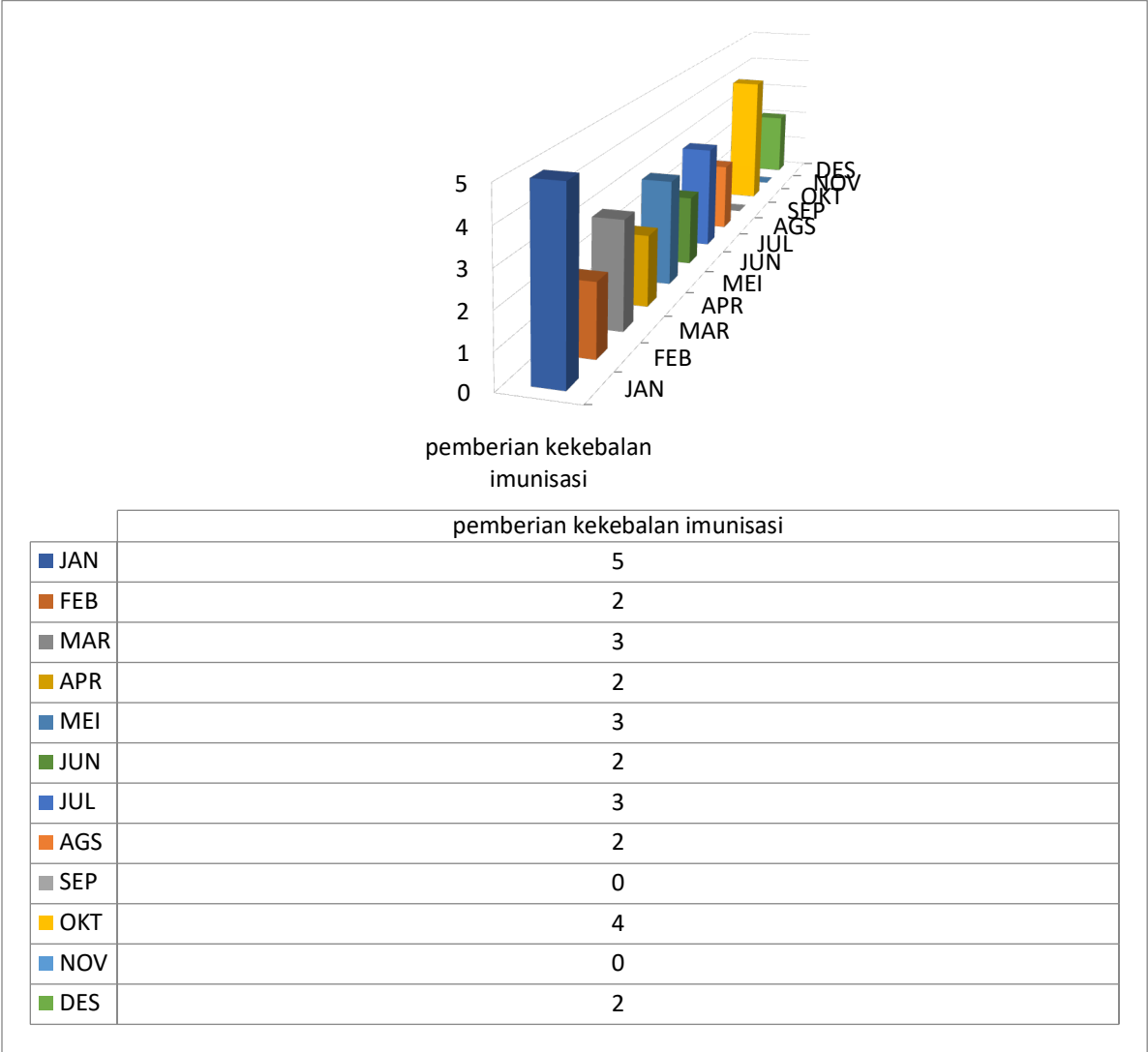
Rencana dan Tindak Lanjut :

- 1. Memberikan edukasi kepada keluarga pasien bahwa jika ada salah satu keluarga yang terdiagnosa TB kemudian memiliki saudara dengan usia dibawah 17 tahun, agar segera memeriksakan dan bersedia di berikan obat pencegahan (INH)
- 2. Pemberian obat INH ditujukan pada anak usia dibawah 5 tahun yang memiliki kontak erat dengan pasien TB aktif dan orang dengan HIV/AIDS yang tidak terdiagnosa TB

3.3.4.3.7 Pemberian Imunisasi BCG

NO	KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1	Pemberian imunisasi BCG	5	2	3	2	3	2	3	2	0	4	0	2

Grafik 7
Pemberian Kekebalan Imunisasi di RS Prima Husada



Evaluasi :

- 1) Pemberian kekebalan imunisasi TB diberikan dengan vaksin BCG pada bayi usia 1 bulan Terdapat 5 pasien yang diimunisasi pada bulan Januari
- 2) Pemberian kekebalan imunisasi TB diberikan dengan vaksin BCG pada bayi usia 1 bulan Terdapat 2 pasien yang diimunisasi pada bulan Februari
- 3) Pemberian kekebalan imunisasi TB diberikan dengan vaksin BCG pada bayi usia 1 bulan Terdapat 3 pasien yang diimunisasi pada bulan Maret
- 4) Pemberian kekebalan imunisasi TB diberikan dengan vaksin BCG pada bayi usia 1 bulan Terdapat 2 pasien yang diimunisasi pada bulan April
- 5) Pemberian kekebalan imunisasi TB diberikan dengan vaksin BCG pada bayi usia 1 bulan Terdapat 3 pasien yang diimunisasi pada bulan Mei
- 6) Pemberian kekebalan imunisasi TB diberikan dengan vaksin BCG pada bayi usia 1 bulan Terdapat 2 pasien yang diimunisasi pada bulan Juni
- 7) Pemberian kekebalan imunisasi TB diberikan dengan vaksin BCG pada bayi usia 1 bulan Terdapat 3 pasien yang diimunisasi pada bulan Juli
- 8) Pemberian kekebalan imunisasi TB diberikan dengan vaksin BCG pada bayi usia 1 bulan Terdapat 2 pasien yang diimunisasi pada bulan Agustus
- 9) Pemberian kekebalan imunisasi TB diberikan dengan vaksin BCG pada bayi usia 1 bulan Terdapat 0 pasien yang diimunisasi pada bulan September
- 10) Pemberian kekebalan imunisasi TB diberikan dengan vaksin BCG pada bayi usia 1 bulan Terdapat 4 pasien yang diimunisasi pada bulan Oktober
- 11) Pemberian kekebalan imunisasi TB diberikan dengan vaksin BCG pada bayi usia 1 bulan Terdapat 0 pasien yang diimunisasi pada bulan November

12) Pemberian kekebalan imunisasi TB diberikan dengan vaksin BCG pada bayi usia 1 bulan Terdapat 2 pasien yang diimunisasi pada bulan Desember

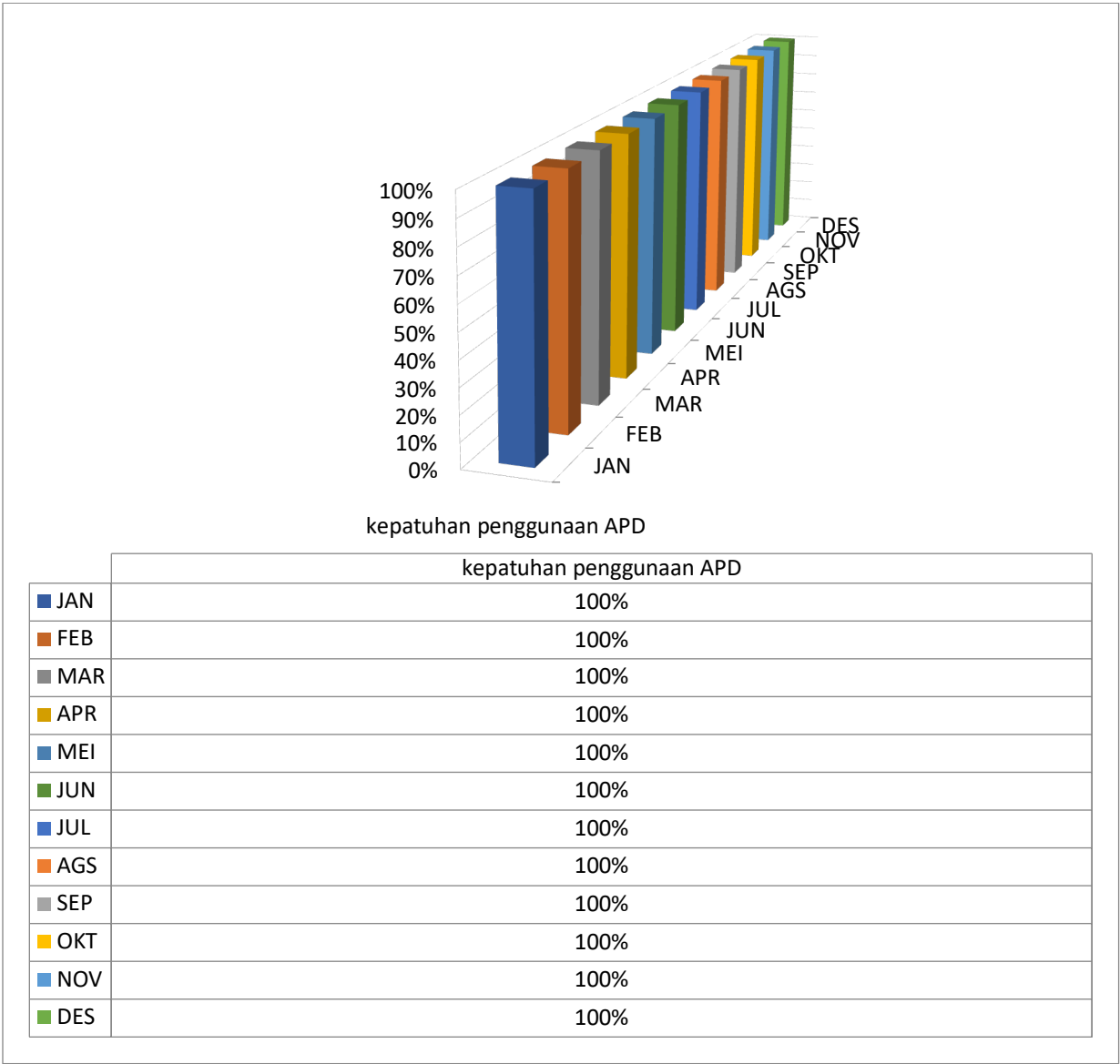
Rencana dan Tindak Lanjut :

- 1) Dilakukan screening pasien dalam memberikan vaksin BCG
- 2) Setelah dilakukan vaksin BCG dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pemberian vaksin yang akan dilakukan pencatatan dan pelaporan tiap bulanya.

3.3.4.3.8 Kepatuhan Staf Dan Petugas Terhadap APD

NO	KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1	Kepatuhan staf dan petugas terhadap APD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Grafik
Kepatuhan Staf dan Petugas Terhadap APDRS Prima Husada Bulan



Evaluasi :
Semua staf sudah patuh dalam penggunaan APD, hal ini menunjukkan kesadaran bahwa sangat penting menjaga diri agar tidak tertular pasien.

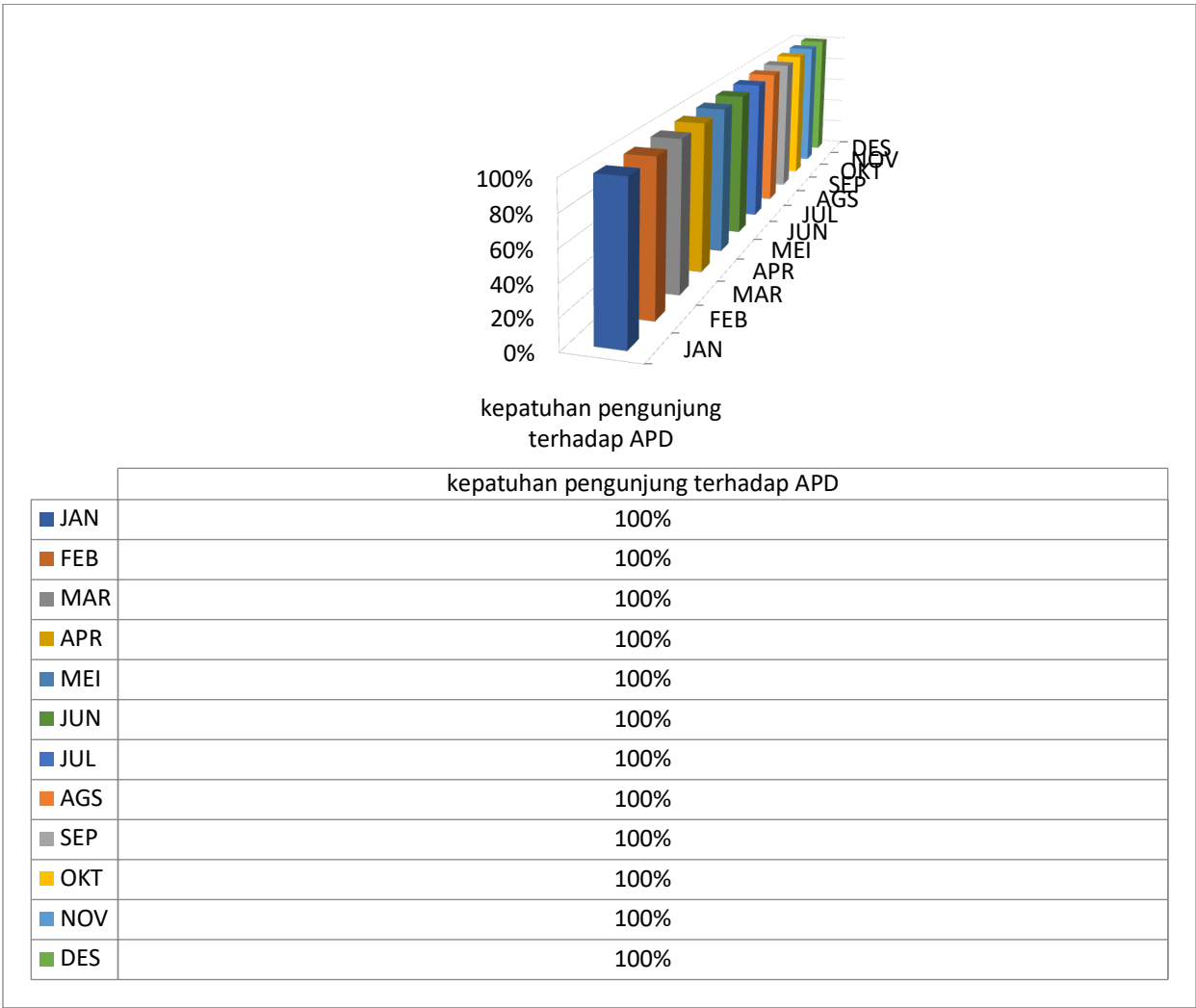
Rencana dan Tindak Lanjut :
Mempertahankan kepatuhan dalam penggunaan APD di tiap bulanya

3.3.4.3.9 Kepatuhan Pengunjung Pasien Terhadap APD

NO	KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1	Kepatuhan pengunjung pasien terhadap APD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Grafik

Kepatuhan Pengunjung Terhadap APD di RS Prima Husada



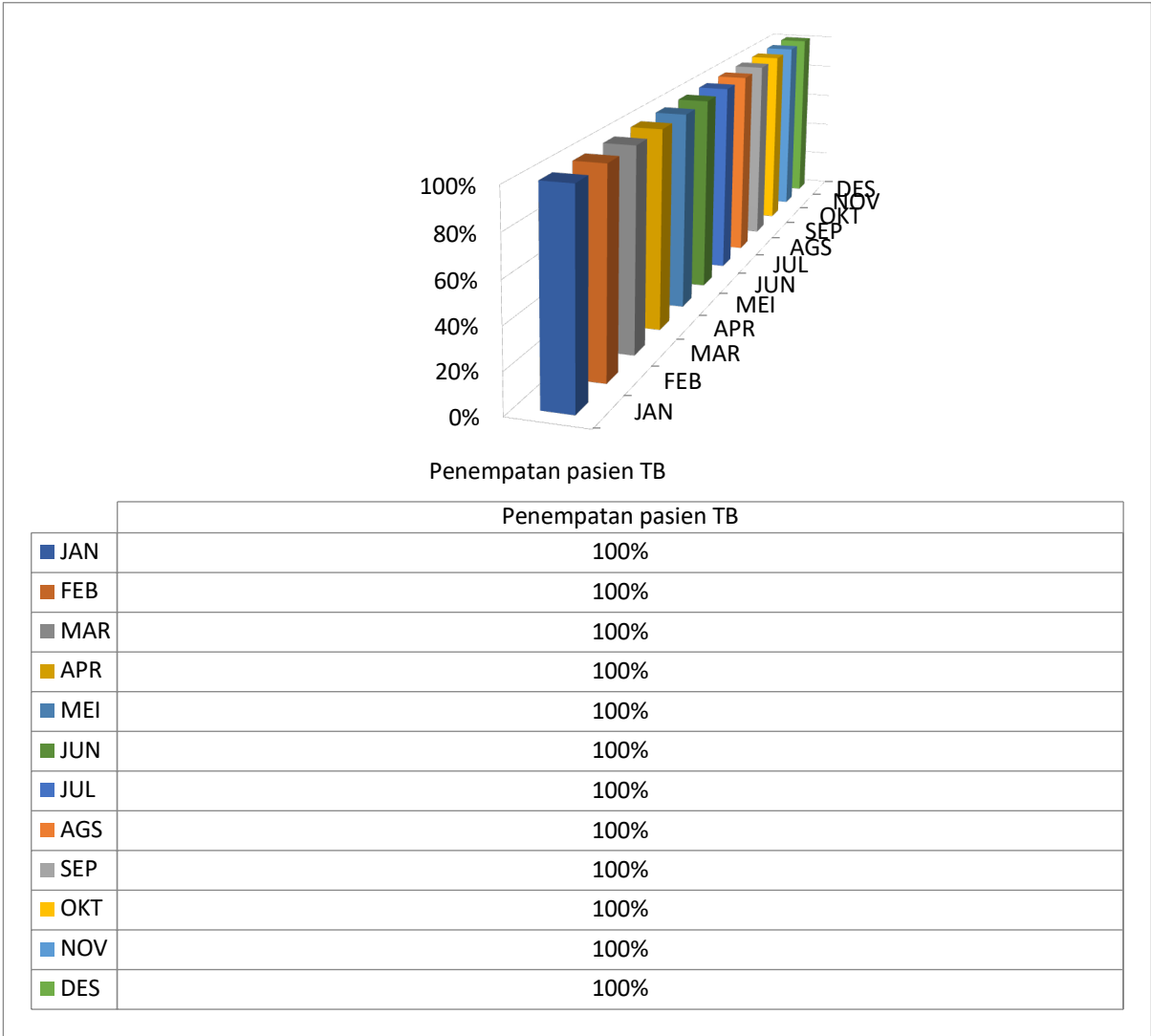
Evaluasi :
Hasil diatas menunjukan (100%) kepatuhan terhadap APD. Hal ini terjadi karna peningkatan kesadaran pengunjung akan cara penulara.n karena disebabkan covid yang terus menularkan virus

Rencana dan Tindak Lanjut :
Memperkuat kepatuhan pengunjung dengan cara wajib memberikan masker kepada pengunjung saat di nerstation dengan menanyakan keluarga dari pasien isolasi

3.3.4.3.10 Penempatan Pasien TB

NO	KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1	Penempatan pasien TB	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Grafik
Penempatan Pasien TB di Rumah Sakit Prima Husada



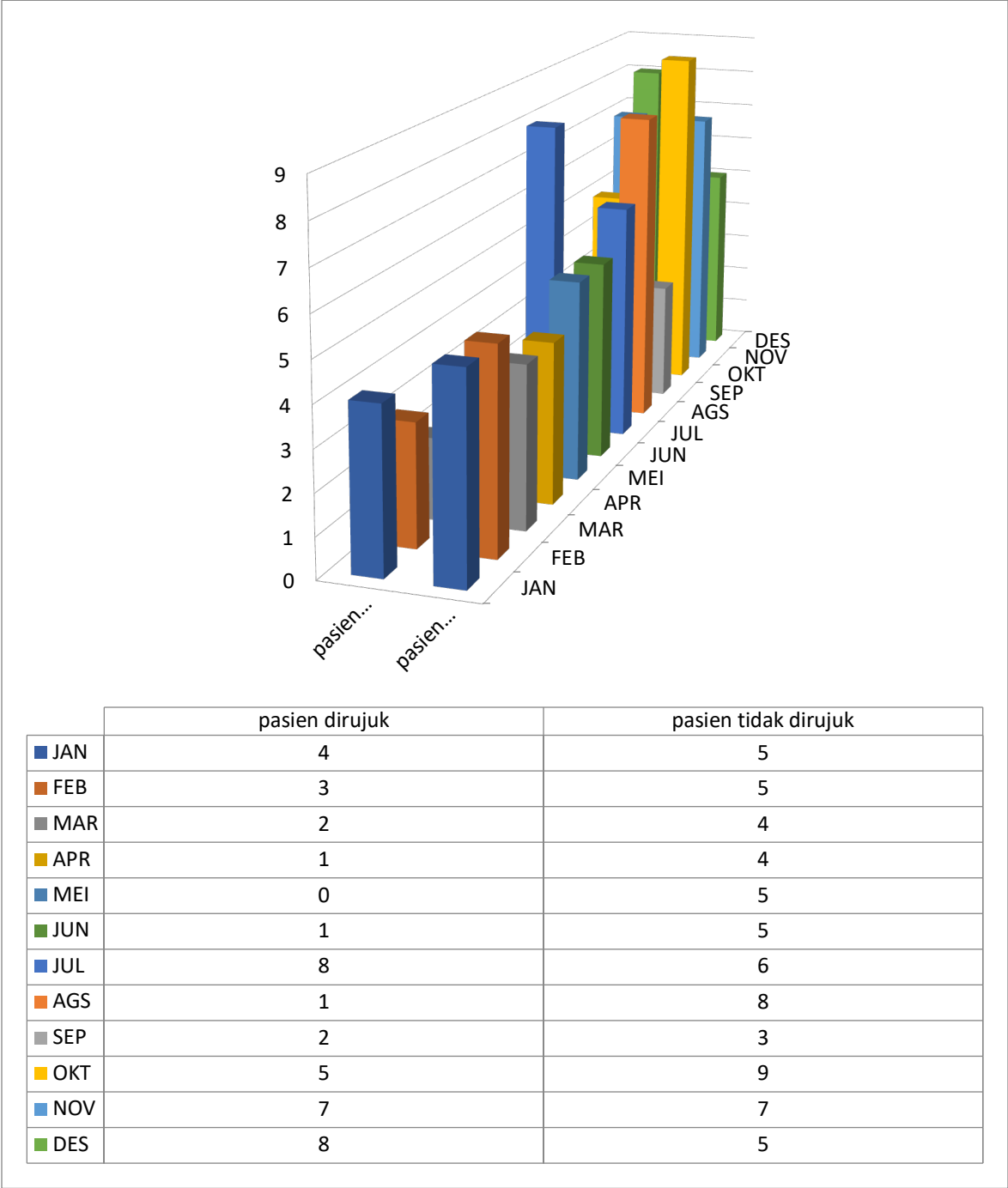
- Evaluasi :**
- 1) Semua pasien TB sudah ditempatkan di ruang isolasi, hal ini menunjukkan kesadaran staff medis agar antar pasien satu dengan lainnya tidak tertular.
 - 2) Dari bulan ke bulan mengalami stabilitas yang baik dalam penempatan pasien TB diruang isolasi.

Rencana dan Tindak Lanjut :
Mempertahankan penempatan dengan benar

3.3.4.3.11 Pasien TB yang Dirujuk

NO	JENIS SKRINING	JUMLAH KEGIATAN											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1.	Pasien TB yang dirujuk	4	3	2	1	0	1	8	1	2	5	7	8
2	Pasien TB yang tidak dirujuk	5	5	4	4	5	5	6	8	3	9	7	5

Grafik
Pasien TB yang dirujuk di Rumah Sakit Prima Husada



Evaluasi :

- 1) Pada bulan Januari 2025 terdapat 4 pasien yang dirujuk ke FKTP I karena pasien memilih lebih dekat dengan rumahnya.
- 2) Pada bulan Februari 2025 terdapat 3 pasien yang dirujuk ke FKTP I karena pasien memilih lebih dekat dengan rumahnya.
- 3) Pada bulan Maret 2025 terdapat 2 pasien yang dirujuk ke FKTP I karena pasien memilih lebih dekat dengan rumahnya.
- 4) Pada bulan April 2025 terdapat 1 pasien yang dirujuk ke FKTP I karena pasien memilih lebih dekat dengan rumahnya.
- 5) Pada bulan Mei 2025 terdapat 0 pasien yang dirujuk ke FKTP I karena pasien memilih lebih dekat dengan rumahnya.
- 6) Pada bulan Juni 2025 terdapat 1 pasien yang dirujuk ke FKTP I karena pasien memilih lebih dekat dengan rumahnya.
- 7) Pada bulan Juli 2025 terdapat 8 pasien yang dirujuk ke FKTP I karena pasien memilih lebih dekat dengan rumahnya.
- 8) Pada bulan Agustus 2025 terdapat 1 pasien yang dirujuk ke FKTP I karena pasien memilih lebih dekat dengan rumahnya
- 9) Pada bulan September 2025 terdapat 2 pasien yang dirujuk ke FKTP I karena pasien memilih lebih dekat dengan rumahnya
- 10) Pada bulan Oktober 2025 terdapat 5 pasien yang dirujuk ke FKTP I karena pasien memilih lebih dekat dengan rumahnya.
- 11) Pada bulan November 2025 terdapat 7 pasien yang dirujuk ke FKTP I karena pasien memilih lebih dekat dengan rumahnya.
- 12) Pada bulan Desember 2025 terdapat 8 pasien yang dirujuk ke FKTP I karena pasien memilih lebih dekat dengan rumahnya.

Rencana dan Tindak Lanjut :

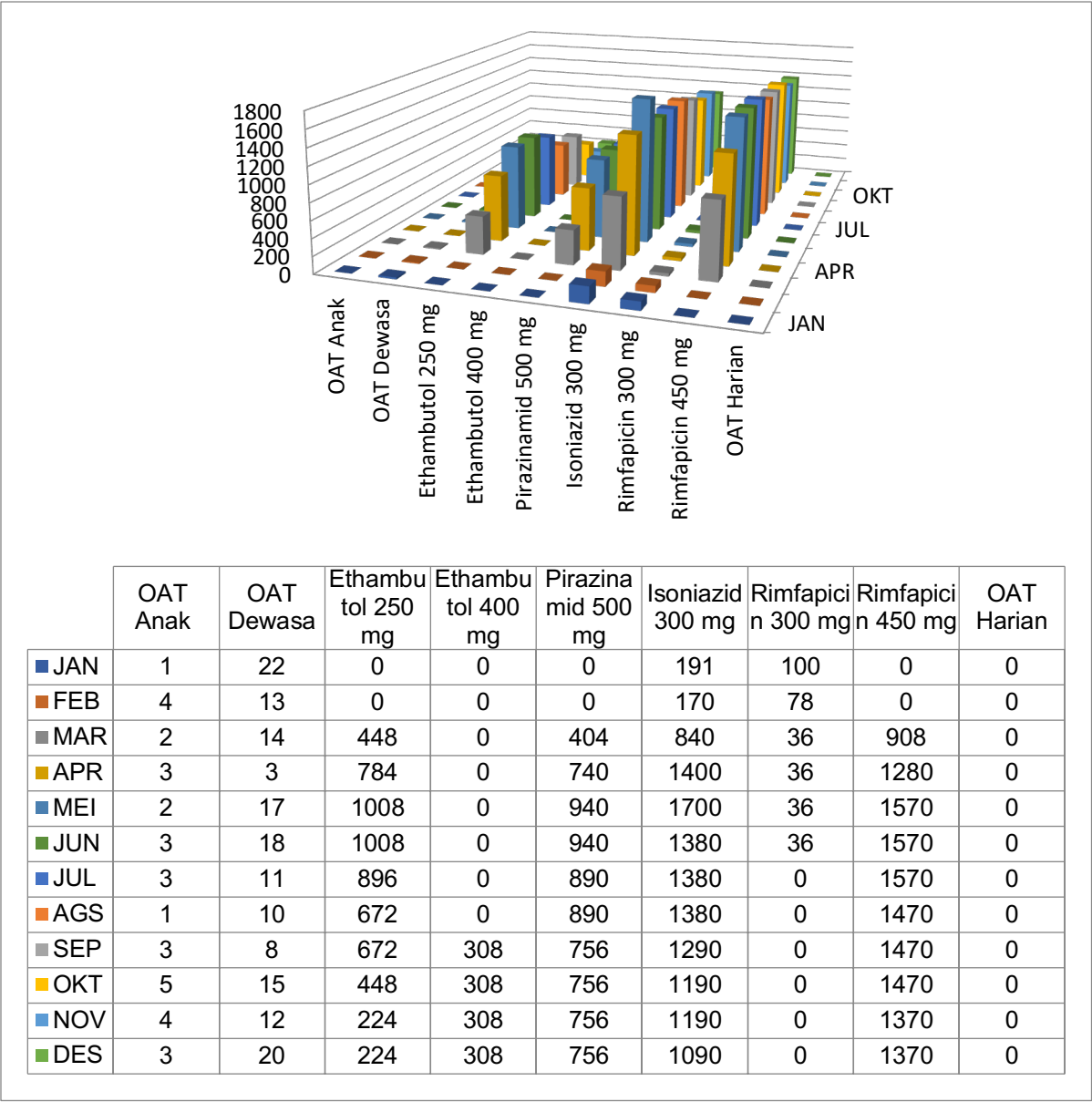
Mempertahankan pelayanan yang terbaik untuk pasien sesuai pilihan pasien untuk berobat.

3.3.4.3.12 Stok OAT

NO	KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1	OAT Anak	1	4	2	3	2	3	3	1	3	5	4	3
2	OAT Dewasa	22	13	14	3	17	18	11	10	8	15	12	20
3	Ethambutol 250 mg	0	0	448	784	1008	1008	896	672	672	448	224	224
4	Ethambutol 400 mg	0	0	0	0	0	0	0	0	308	308	308	308
5	Pirazinamid 500 mg	0	0	404	740	940	940	890	890	756	756	756	756
6	Isoniazid 300 mg	191	170	840	1400	1700	1380	1380	1380	1290	1190	1190	1090
7	Rimfapicin 300 mg	100	78	36	36	36	36	0	0	0	0	0	0
8	Rimfapicin 450 mg	0	0	908	1280	1570	1570	1570	1470	1470	1470	1370	1370
9	OAT Harian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Grafik

Stok Obat TBC di Rumah Sakit Prima Husada



Evaluasi :

Setiap 1 bulan sekali farmasi akan melakukan pengadaan obat terkait permintaan ke Dinkes

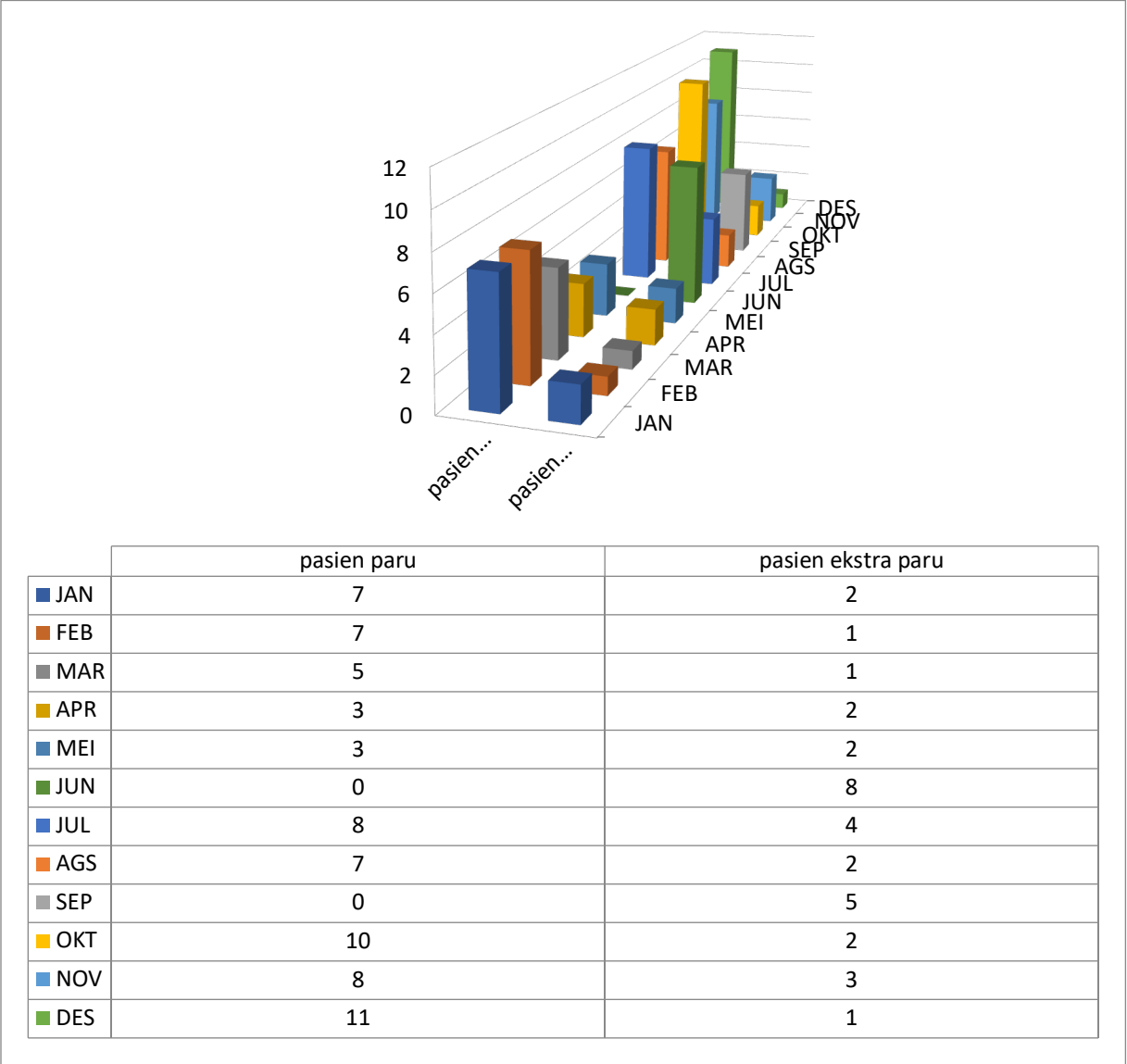
Rencana dan Tindak Lanjut :

Menetapkan pengambilan obat dengan sesuai jadwal

3.3.4.3.13 Pasien Paru dan Ekstra Paru

NO	KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1.	Pasien paru	7	7	5	3	3	0	8	7	0	10	8	11
2	Pasien Ekstra paru	2	1	1	2	2	8	4	2	5	2	3	1

Grafik
Pasien paru dan Ekstra paru di Rumah Sakit Prima Husada



Evaluasi :

- 1) Pada bulan Januari 2025 terdapat 7 pasien paru dan 2 pasien ekstra paru
- 2) Pada bulan Februari 2025 terdapat 7pasien paru dan 1 pasien ekstra paru
- 3) Pada bulan Maret 2025 terdapat 5 pasien paru dan 1 pasien ekstra paru
- 4) Pada bulan April 2025 terdapat 3 pasien paru dan 2 pasien ekstra paru
- 5) Pada bulan Mei 2025 terdapat 3 pasien paru dan 2 pasien ekstra paru
- 6) Pada bulan Juni 2025 terdapat 0 pasien paru dan 8 pasien ekstra paru
- 7) Pada bulan Juli 2025 terdapat 8 pasien paru dan 4 pasien ekstra paru
- 8) Pada bulan Agustus 2025 terdapat 7 pasien paru dan 2 pasien ekstra paru
- 9) Pada bulan September 2025 terdapat 5 pasien paru dan 0 pasien ekstra paru
- 10) Pada bulan Oktober 2025 terdapat 10 pasien paru dan 2 pasien ekstra paru
- 11) Pada bulan November 2025 terdapat 8 pasien paru dan 3 pasien ekstra paru
- 12) Pada bulan Desember 2025 terdapat 11 pasien paru dan 1 pasien ekstra paru

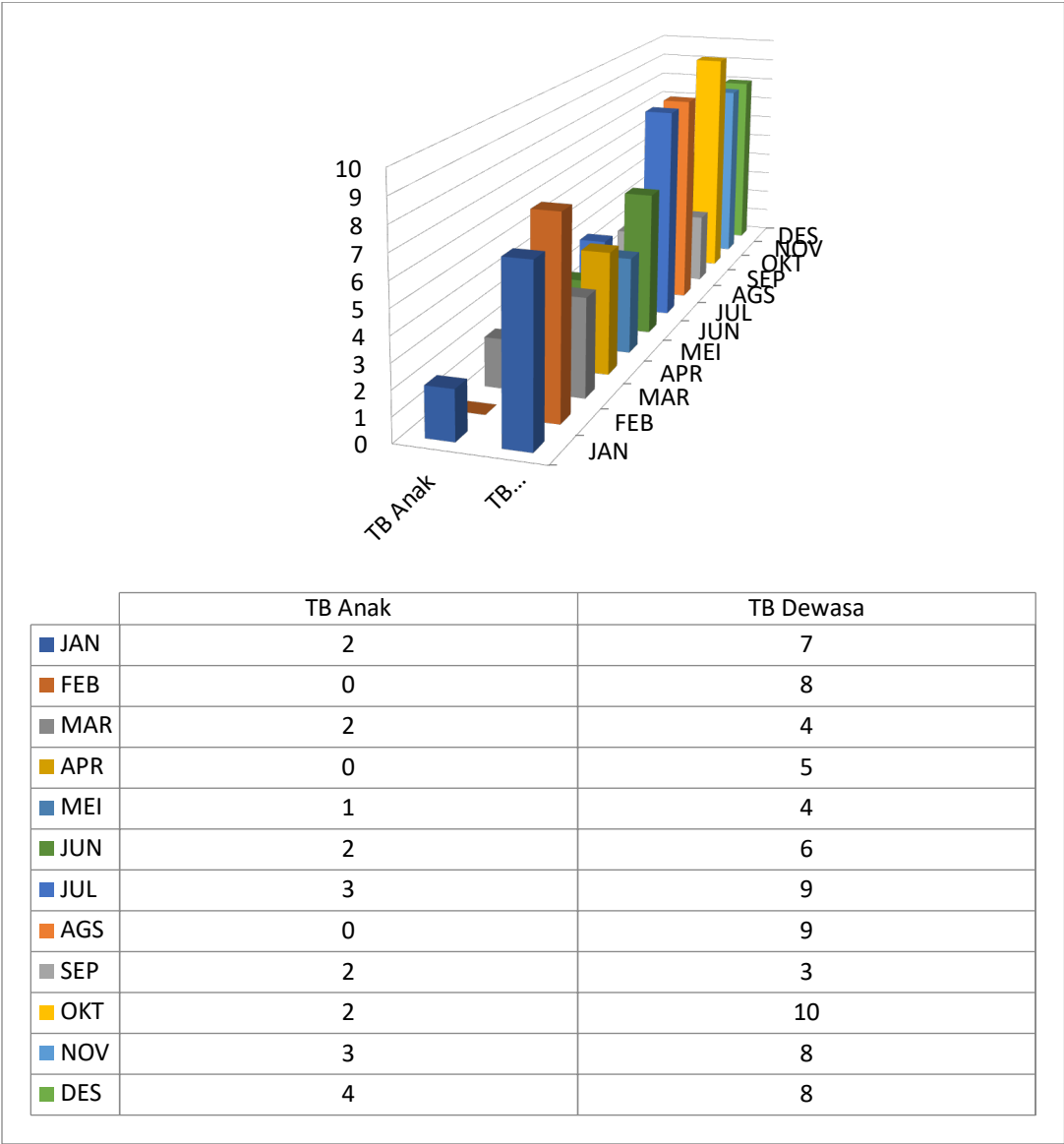
Rencana dan Tindak Lanjut :

Memberikan pengobatan yang sama pada ekstra paru meski pengobatannya akan lebih lama.

3.3.4.3.14 Pasien Anak dan Pasien Dewasa TB

NO	KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1.	Pasien Anak	2	0	2	0	1	2	3	0	2	2	3	4
2	Pasien Dewasa	7	8	4	5	4	6	9	9	3	10	8	8

Grafik
Pasien Anak dan Pasien Dewasa di Rumah Sakit Prima Husada



Evaluasi :

- 1) Pada bulan Januari terdapat 2 pasien TB Anak sedangkan pasien TB dewasa mencapai 7 pasien
- 2) Pada bulan Februari terdapat 0 pasien TB Anak sedangkan pasien TB dewasa mencapai 8 pasien
- 3) Pada bulan Maret terdapat 2 pasien TB Anak sedangkan pasien TB dewasa mencapai 4 pasien
- 4) Pada bulan April terdapat 0 pasien TB Anak sedangkan pasien TB dewasa mencapai 5 pasien

- 5) Pada bulan Mei terdapat 1 pasien TB Anak sedangkan pasien TB dewasa mencapai 4 pasien
- 6) Pada bulan Juni terdapat 2 pasien TB Anak sedangkan pasien TB dewasa mencapai 6 pasien
- 7) Pada bulan Juli terdapat 3 pasien TB Anak sedangkan pasien TB dewasa mencapai 9 pasien
- 8) Pada bulan Agustus terdapat 0 pasien TB Anak sedangkan pasien TB dewasa mencapai 9 pasien
- 9) Pada bulan September terdapat 2 pasien TB Anak sedangkan pasien TB dewasa mencapai 3 pasien
- 10) Pada bulan Oktober terdapat 2 pasien TB Anak sedangkan pasien TB dewasa mencapai 10 pasien
- 11) Pada bulan November terdapat 3 pasien TB Anak sedangkan pasien TB dewasa mencapai 8 pasien
- 12) Pada bulan Desember terdapat 4 pasien TB Anak sedangkan pasien TB dewasa mencapai 8 pasien

Rencana dan Tindak Lanjut :
Mempertahankan pencatatan TB sesuai kategori pasien.

3.3.4.3.15 Kepatuhan Dokter Terhadap PPK TB

NO	KEGIATAN	NAMA PASIEN	PATUH	TIDAK PATUH	ALASAN
1.	dr. Andy, Sp. P Bulan Januari 2025	Tn. T	V		
		Tn. K	V		
		Tn. B	V		
		Tn. A	V		
	dr. Andy, Sp. P Bulan Februari 2025	Ny. N	V		
		Ny. I	V		
		Tn. J	V		
		Ny. S	V		
		Ny. E	V		
	dr. Andy, Sp. P Bulan Maret 2025	Tn. S	V		
		Tn. N	V		
	dr. Andy, Sp. P Bulan April 2025	Ny. M	V		
		Ny. N	V		
		Tn. U	V		
	dr. Andy, Sp. P Bulan Mei 2025	Tn. B	V		
		Tn. I	V		
	dr. Andy, Sp. P Bulan Juni 2025	Tn. H	V		
		Tn. A	V		
	dr. Andy, Sp. P Bulan Juli 2025	Ny. A	V		
		Ny. Y	V		
		Ny. R	V		
		Tn. S	V		
		Ny. K	V		
	dr. Andy, Sp. P Bulan Agustus 2025	Tn. P	V		
		Tn. R	V		
		Ny. D	V		
		Nn. P	V		
		Nn. S	V		
		Tn.S	V		

	dr. Andy, Sp. P Bulan September 2025	Ny. A	V		
		Ny. D	V		
		Ny. S	V		
	dr. Andy, Sp. P Bulan Oktober 2025	Ny. R	V		
		Nn. D	V		
		Tn. S	V		
		Tn. B	V		
		Tn. R	V		
		Ny. M	V		
		Nn. H	V		
		Tn. A	V		
	dr. Andy, Sp. P Bulan November 2025	Tn. S	V		
		Ny. W	V		
	dr. Andy, Sp. P Bulan Desember 2025	Ny.S	V		
2	dr. Catur Elvi p., Sp. P-ONK Bulan Januari 2025	Ny. J	V		
		Ny. M	V		
		Ny. S	V		
	dr. Catur Elvi p., Sp. P-ONK Bulan Februari 2025	Ny. H	V		
		Ny. C	V		
	dr. Catur Elvi p., Sp. P-ONK Bulan Maret 2025	Ny. M	V		
		Ny. P	V		
	dr. Catur Elvi p., Sp. P-ONK Bulan April 2025	Ny. M	V		
		Ny. I	V		
	dr. Catur Elvi p., Sp. P-ONK Bulan Mei 2025	Tn. S	V		
	dr. Catur Elvi p., Sp. P-ONK Bulan Juni 2025	Tn. M	V		
		Ny. J	V		
		Ny. M	V		
		Ny. R	V		
	dr. Catur Elvi p., Sp. P-ONK Bulan Juli 2025	Tn. C	V		
		Tn.D	V		
		Ny. A	V		
		Ny. E	V		
		Tn. M	V		
		An. A	V		
	dr. Catur Elvi p., Sp. P-ONK Bulan Agustus 2025	Tn. T	V		
		Tn. H	V		
		Tn. K	V		
	dr. Catur Elvi p., Sp. P-ONK Bulan September 2025	-	-		
	dr. Catur Elvi p., Sp. P-ONK Bulan Oktober 2025	Tn. M		V	Meninggal sebelum pengobatan
		Tn. A	V		
	dr. Catur Elvi p., Sp. P-ONK Bulan November 2025	Tn. B	V		
		Ny. N	V		
		Ny. V	V		
		Tn. H	V		
		Tn. C	V		
	dr. Catur Elvi p., Sp. P-ONK Bulan Desember 2025	Tn. D	V		
		Tn. D	V		
		Tn. M	V		
		Ny.S	V		

		Tn. M	V		
		Tn.S	V		
		Ny. D	V		
3	dr. Dicky.Sp.A.M.Biomed Bulan Januari 2025	An. A	V		
	dr. Dicky.Sp.A.M.Biomed Bulan Februari 2025	-	-		
	dr. Dicky.Sp.A.M.Biomed Bulan Maret 2025	An. A	V		
		An. M	V		
	dr. Dicky.Sp.A.M.Biomed Bulan April 2025	-	-		
	dr. Dicky.Sp.A.M.Biomed Bulan Mei 2025	-	-		
	dr. Dicky.Sp.A.M.Biomed Bulan Juni 2025	An. H	V		
		An. D	V		
	dr. Dicky.Sp.A.M.Biomed Bulan Juli 2025	An. A	V		
	dr. Dicky.Sp.A.M.Biomed Bulan Agustus 2025	-	-		
	dr. Dicky.Sp.A.M.Biomed Bulan September 2025	An. M	V		
		An. A	V		
		An. A	V		
	dr. Dicky.Sp.A.M.Biomed Bulan Oktober 2025	An. A	V		
	dr. Dicky.Sp.A.M.Biomed Bulan November 2025	An. Z	V		
		An. A	V		
		An. T	V		
	dr. Dicky.Sp.A.M.Biomed Bulan Desember 2025	An. H	V		
		An. F	V		
		An. E	V		
4.	dr. Fiona Paramitha. Sp.A Bulan Januari 2025	-	-		
	dr. Fiona Paramitha. Sp.A Bulan Februari 2025	-	-		
	dr. Fiona Paramitha. Sp.A Bulan Maret 2025	-	-		
	dr. Fiona Paramitha. Sp.A Bulan April 2025	-	-		
	dr. Fiona Paramitha. Sp.A Bulan Mei 2025	-	-		
	dr. Fiona Paramitha. Sp.A Bulan Juni 2025	-	-		
	dr. Fiona Paramitha. Sp.A Bulan Juli 2025	-	-		
	dr. Fiona Paramitha. Sp.A Bulan Agustus 2025	-	-		
	dr. Fiona Paramitha. Sp.A Bulan September 2025	-	-		
	dr. Fiona Paramitha. Sp.A Bulan Oktober 2025	An. A	V		
	dr. Fiona Paramitha. Sp.A Bulan November 2025	-	-		
	dr. Fiona Paramitha. Sp.A Bulan Desember 2025	An. M	V		

5.	Dr. Ratih Kusumawardani Sp.A.M.Biomed Bulan Januari 2025	-	-		
	Dr. Ratih Kusumawardani Sp.A.M.Biomed Bulan Februari 2025	-	-		
	Dr. Ratih Kusumawardani Sp.A.M.Biomed Bulan Maret 2025	-	-		
	Dr. Ratih Kusumawardani Sp.A.M.Biomed Bulan April 2025	-	-		
	Dr. Ratih Kusumawardani Sp.A.M.Biomed Bulan Mei 2025	-	-		
	Dr. Ratih Kusumawardani Sp.A.M.Biomed Bulan Juni 2025	-	-		
	Dr. Ratih Kusumawardani Sp.A.M.Biomed Bulan Juli 2025	-	-		
	Dr. Ratih Kusumawardani Sp.A.M.Biomed Bulan Agustus 2025	-	-		
	Dr. Ratih Kusumawardani Sp.A.M.Biomed Bulan September 2025	An. A	V		
	Dr. Ratih Kusumawardani Sp.A.M.Biomed Bulan Oktober 2025	-	-		
	Dr. Ratih Kusumawardani Sp.A.M.Biomed Bulan November 2025	-	-		
	Dr. Ratih Kusumawardani Sp.A.M.Biomed Bulan Desember 2025	-	-		
6.	Dr. Ardhi Bustami, Sp.PD Bulan Januari 2025	-	-		
	Dr. Ardhi Bustami, Sp.PD Bulan Februari 2025	-	-		
	Dr. Ardhi Bustami, Sp.PD Bulan Maret 2025	-	-		
	Dr. Ardhi Bustami, Sp.PD Bulan April 2025	-	-		
	Dr. Ardhi Bustami, Sp.PD Bulan Mei 2025	Ny. K	V		
	Dr. Ardhi Bustami, Sp.PD Bulan Juni 2025	-	-		
	Dr. Ardhi Bustami, Sp.PD Bulan Juli 2025	-	-		
	Dr. Ardhi Bustami, Sp.PD Bulan Agustus 2025	-	-		
	Dr. Ardhi Bustami, Sp.PD Bulan September 2025	-	-		
	Dr. Ardhi Bustami, Sp.PD	-	-		

	Bulan Oktober 2025				
	Dr. Ardhi Bustami, Sp.PD Bulan November 2025	-	-		
	Dr. Ardhi Bustami, Sp.PD Bulan Desember 2025	-	-		
7.	Dr. Zoraiada, Sp.PD Bulan Januari 2025	-	-		
	Dr. Zoraiada, Sp.PD Bulan Februari 2025	Ny. R	V		
	Dr. Zoraiada, Sp.PD Bulan Maret 2025	-	-		
	Dr. Zoraiada, Sp.PD Bulan April 2025	-	-		
	Dr. Zoraiada, Sp.PD Bulan Mei 2025	-	-		
	Dr. Zoraiada, Sp.PD Bulan Juni 2025	-	-		
	Dr. Zoraiada, Sp.PD Bulan Juli 2025	-	-		
	Dr. Zoraiada, Sp.PD Bulan Agustus 2025	-	-		
	Dr. Zoraiada, Sp.PD Bulan September 2025	-	-		
	Dr. Zoraiada, Sp.PD Bulan Oktober 2025	-	-		
	Dr. Zoraiada, Sp.PD Bulan November 2025	-	-		
	Dr. Zoraiada, Sp.PD Bulan Desember 2025	-	-		
8.	dr. Akhmad Syahrir.Sp.S Bulan November 2025	Tn. M	V		

Analisis :

Semua dokter sudah patuh akan PPK (Panduan Praktek Klinis) TB, baik dari anamnesis, kriteria diagnosis, pemeriksaan penunjang, dan Edukasi. Akan tetapi pada *point* edukasi sosial (pencarian kontak serumah) tidak dilakukan

Rencana dan Tindak Lanjut :

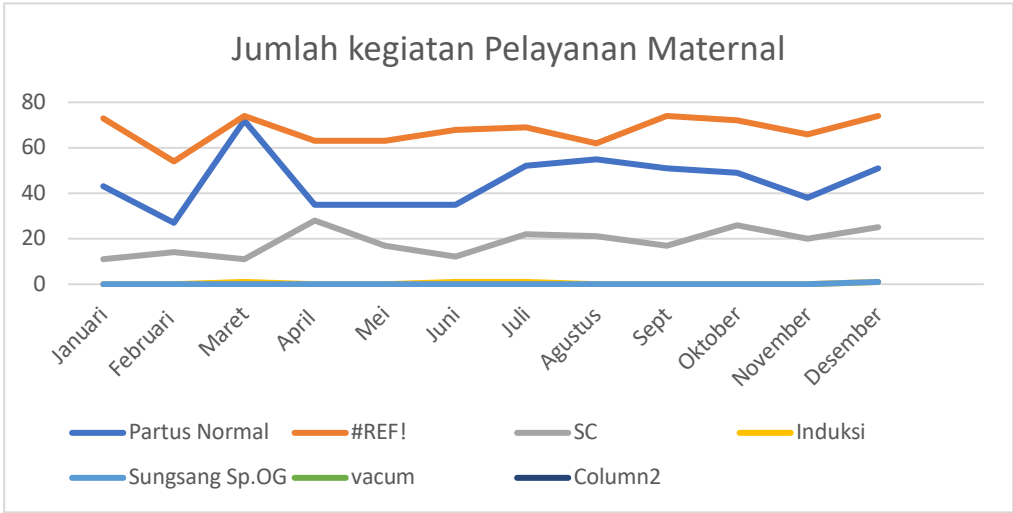
Tetap mempertahankan kepatuhan dokter sesuai dengan PPK TB yang berlaku di RS Prima Husada Kabupaten Malang.

3.3.4.4 PONEK
3.3.4.4.1 Kinerja Produktifitas Tim Ponek Tahun 2025

Tabel Jumlah Kegiatan Pelayanan Maternal Tahun 2025

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH PASIEN											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1													
	a. Persalinan Normal	43	27	72	47	35	35	52	55	51	49	38	51
	b. SectioCaesaria	73	54	74	75	63	68	69	62	74	72	66	74
2													
	a. Induksi / Drip	11	13	11	28	17	12	22	21	17	26	20	25
	b. Sungsang	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1
	c. Vacum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Grafik Jumlah Kegiatan Pelayanan Maternal Tahun 2025



Analisa	1) Pelayanan Sectio Caesaria yang tertinggi pada bulan April yaitu 75 pasien disebabkan banyak kasus yang tidak bisa dilayani dengan persalinan normal dan terendah Sectio Caesaria di bulan februari yaitu 54 pasien disebabkan banyak kasus inpartu dengan resiko rendah sehingga bisa dilayani dengan Tindakan persalinan normal 2) Pelayanan Persalinan normal tertinggi di bulan Maret yaitu 72 pasien, disebabkan banyak kasus yang bisa dilayani dengan resiko rendah dan persalinan paling rendah di bulan februari yaitu 27 pasien disebabkan banyak kasus resiko tinggi yang harus dilakukan Tindakan SC 3) Tidak semua pasien dilayani dengan observasi induksi/drip, hanya kasus-kasus tertentu yang dilakukan tindakan tersebut, tindakan ini dilakukan disebabkan ada kasus-kasus tertentu seperti his kurang adekuat.
RTL	1) Kolaborasi dengan bagian marketing rumah sakit terkait jumlah kunjungan pasien obgyn salah satunya dengan mengadakan pelatihan bidan-bidan perujuk.

	2) Melakukan edukasi kepada pasien hamil saat ANC tentang tanda dan bahaya pada kehamilan. 3) Melakukan edukasi kepada pasien ANC trimester 3 tentang tanda-tanda persalinan.
--	---

3.3.4.5 Stunting dan Wasting

Tabel Peningkatan Efektifitas Intervensi Gizi Spesifik

Program	Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Program 1000 HPK	Penyuluhan mengenai kehidupan 1000 hari pertama	Pengunjung RS Prima Husada Malang	IRJA anak dan Kandungan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Suplementasi Asam folat pada ibu hamil	1. Penyuluhan tentang pentingnya konsumsi asam folat pada ibu hamil 2. Pembagian tablet tambah darah dan asam folat	Ibu Hamil	Senam Hamil , Poli Kandungan, Hall gedung baru lantai 5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Pemberian PMT Ibu Hamil	Pemberian PMT dengan tinggi kalori terutama pada ibu hamil terindikasi KEK	Ibu Hamil	Hall gedung baru lantai 5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Promosi dan konseling Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI eksklusif	Penyuluhan mengenai pentingnya Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI eksklusif	Ibu hamil	IRJA anak dan kandungan, irna maternitas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA)	1. Penyuluhan tentang stunting, makanan sehat pada bayi dan balita 2. Pembagian PMBA	IRNA Anak	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Pemantau an pertumbuhan (Pelayan an Tumbuh Kembang Bayi dan Balita)	Melakukan Pencatatan dan plotting pada buku KIA setelah pengukuran berat badan dan tinggi badan anak	Pasien Anak	IRJA anak	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Pemberian Imunisasi	Memastikan ketersediaan imunisasi agar selalu tersedia di poli anak	Pasien anak dan Bayi baru lahir	IRJA anak	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Pemberian vitamin A	Bekerja sama dengan puskesmas terdekat untuk mendukung program pemerintah mengenai pemberian vitamin A	Pasien anak	IRJA anak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pemberian Makanan Tambahan Balita Gizi Kurang	Memberikan PMT tinggi kalori dengan membantu menyusun menu yang sesuai dengan ketersediaan bahan pangan di lingkungan	Pasien anak	Rawat Inap	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Pemberian Taburia pada Baduta	Bekerja sama dengan puskesmas terdekat untuk mendukung program pemerintah mengenai pemberian bubuk taburia	Pasien anak	Rawat Inap dan Rawat Jalan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pemberian Obat cacing pada ibu hamil	Bekerja sama dengan puskesmas terdekat untuk mendukung program pemerintah mengenai pemberian obat cacing pada ibu hamil	Ibu Hamil	Rawat Inap dan Rawat Jalan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Analisis :

Sebagian besar intervensi spesifik yang dapat dilaksanakan di rumah sakit telah dilaksanakan. Akan tetapi ada beberapa intervensi yang diberikan dengan bekerjasama dengan puskesmas karena ketersediannya hanya ada di puskesmas seperti pemberian bubuk taburia dan vitamin A.

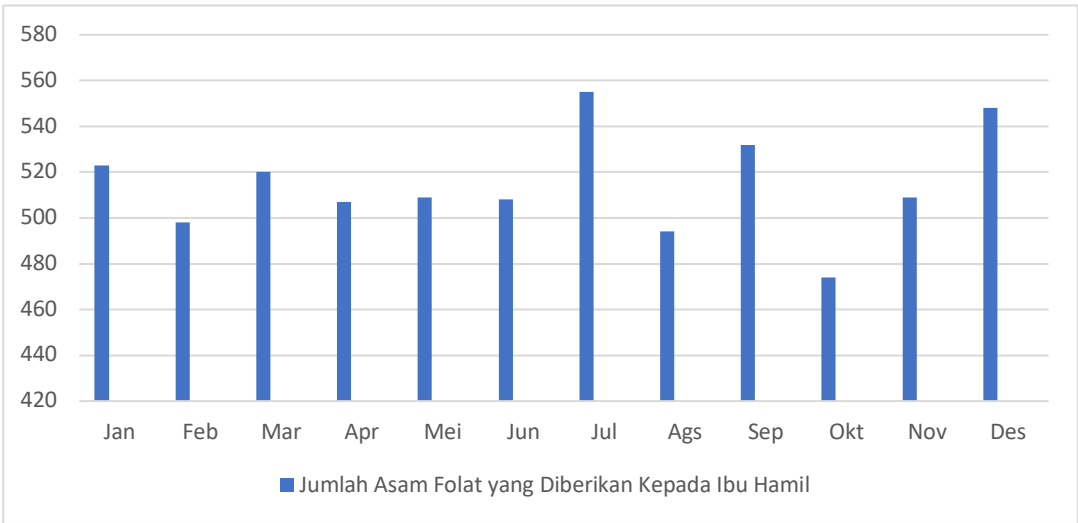
Rencana Tindak Lanjut :

Bekerjasama dengan puskesmas setempat agar dapat melakukan pendampingan intervensi spesifik di posyandu disekitar wilayah rumah sakit dan melakukan pemantauan kepada balita stunting.

Tabel Distribusi Tablet besi folat pada Ibu Hamil di RS Prima Husada Malang

Bulan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Jumlah Ibu Hamil yang diberikan tablet besi folat di Poli kandungan	523	498	520	507	509	508	555	494	532	474	509	548

Grafik Jumlah Pemberian tablet besi folat pada ibu hamil Di RS Prima Husada Tahun 2025



Analisis :

Pemberian asam folat diberikan kepada ibu hamil pada usia kandungan trimester pertama. Sedangkan pemberian tablet zat besi diberikan pada usia kandungan trimester 2 dan 3. Jumlah asam folat yang diberikan kepada ibu hamil mengalami naik turun pada tahun 2025 bergantung kepada jumlah kunjungan ibu hamil. Dan capaian paling tinggi terdapat pada bulan Juli, dan capaian terendah terdapat pada bulan Oktober.

Rencana Tindak Lanjut:

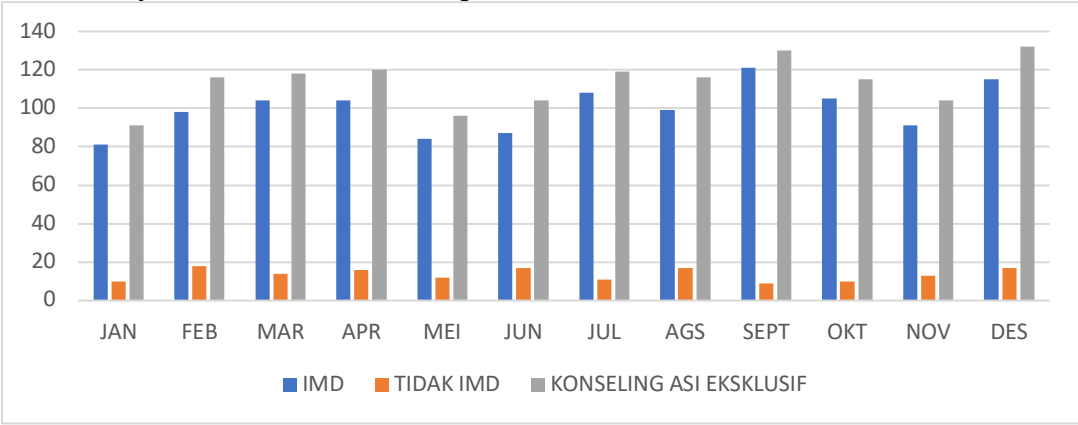
- 1. Koordinasi dengan tim farmasi untuk mendukung penyediaan tablet tambah darah, agar program suplementasi tablet tambah darah kepada ibu hamil terus berlanjut

2. Koordinasi dengan tim humas rumah sakit agar ibu hamil yang bergabung semakin banyak agar program suplementasi tablet besi folat semakin baik.

Tabel Jumlah Ibu Melahirkan yang Mendapat Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif

No	Uraian	Jumlah Pasien											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	IMD	81	98	104	104	84	87	108	99	121	105	91	115
2	Tidak IMD	10	18	14	16	12	17	11	17	9	10	13	17
3	Mendapat Konseling ASI Eksklusif	91	116	118	120	96	104	119	116	130	115	104	132

Grafik Pelayanan IMD dan Konseling ASI Eksklusif di RS Prima Husada Tahun 2025



Analisis :

1. Bayi yang dilakukan IMD, capaian tertinggi di bulan September selama tahun 2025. dan capaian bayi tidak dilakukan IMD paling tinggi pada bulan Februari. Kasus tidak dilakukan IMD hal ini terjadi diiringi dengan masih adanya bayi lahir dengan berat <2500 gr sehingga tidak dilakukan IMD.
2. Pada bayi yang tidak dilakukan IMD memang tidak memenuhi kriteria untuk dilakukan IMD dikarenakan BBLR yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.
3. 100% ibu melahirkan telah mendapatkan edukasi menyusui. Untuk mendukung pemberian ASI secara eksklusif. Jumlah Ibu mendapat konseling ASI Eksklusif capaian tertinggi pada bulan Desember 2025.

Rencana Tindak Lanjut:

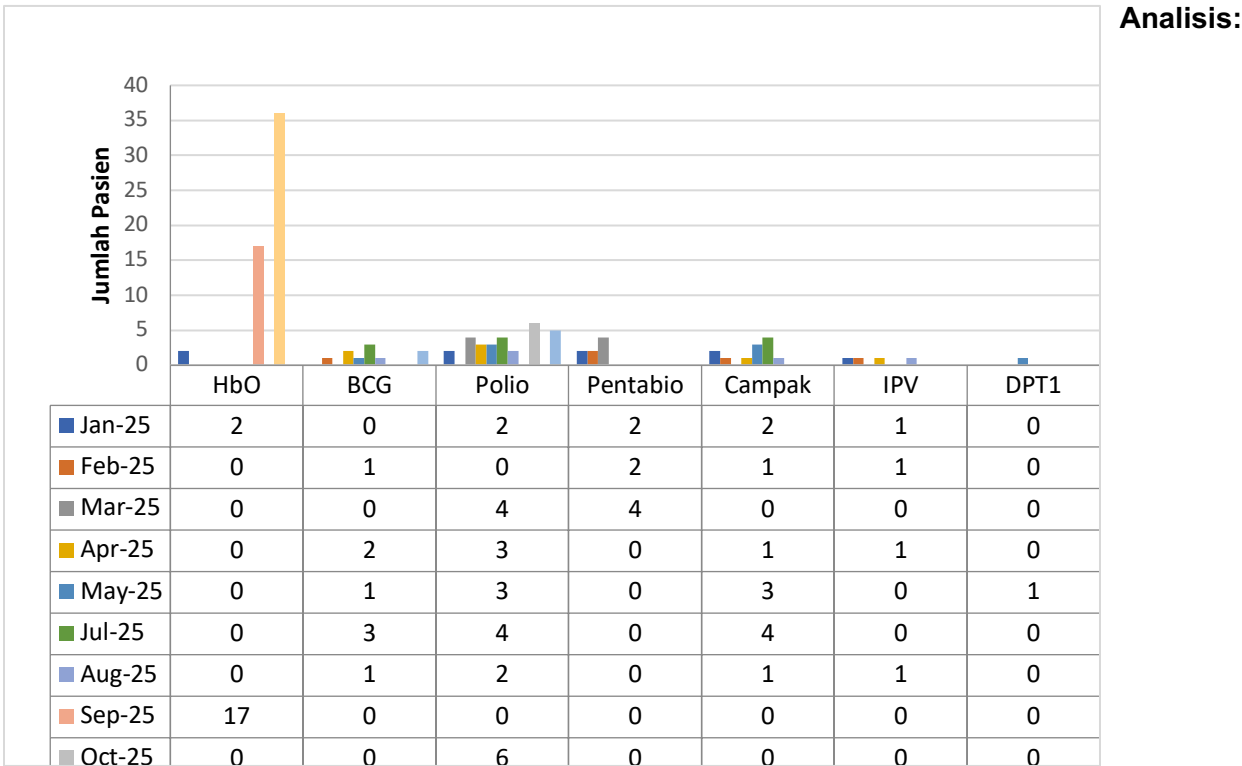
Tingkatkan koordinasi dengan dokter kandungan dan bidan rumah sakit dalam pemberian edukasi tentang pentingnya pemberian ASI eksklusif serta mendokumentasikan bukti telah melakukan edukasi kepada ibu melahirkan pada lembar edukasi.

Tabel Jumlah Balita yang Mendapat Imunisasi

No	Jenis Pelayanan	Jumlah											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	HbO	2	0	0	0	0	0	0	0	17	0	36	0

2	BCG	0	1	0	2	1	2	3	1	0	0	0	2
3	Polio	2	0	4	3	3	4	4	2	0	6	0	5
4	Pentabio	2	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Campak	2	1	0	1	3	0	4	1	0	0	0	0
6	IPV	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
7	DPT 1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
8	DPT 2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0
9	DPT 3	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0

Grafik Pelayanan Imunisasi Di Rumah Sakit Prima Husada Tahun 2025



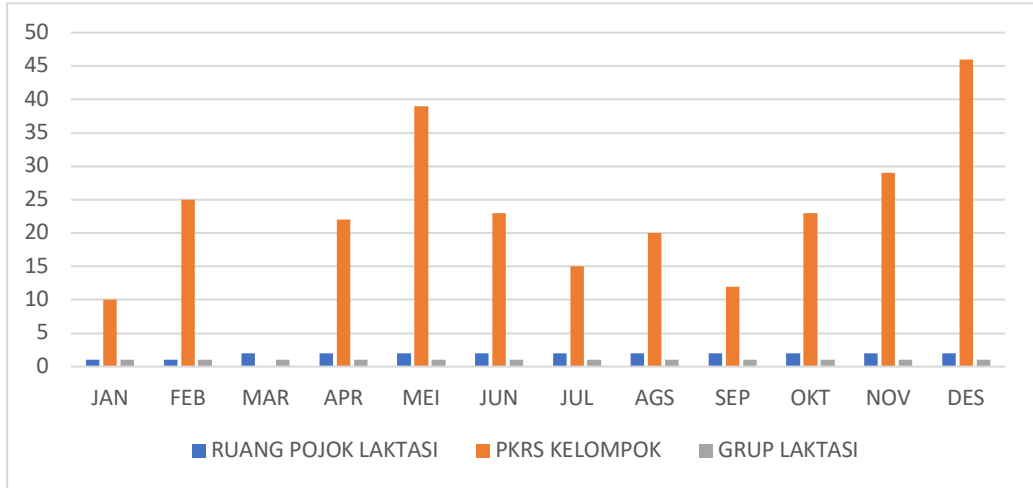
Rencana Tindak Lanjut :

Tim Penanggungjawab Imunisasi melakukan koordinasi dengan pihak Puskesmas Singosari untuk penyediaan vaksin HB0 dan rotavirus di RS Prima Husada Malang.

Tabel Penerapan Rumah Sakit sayang Ibu Bayi

Kegiatan Penerapan Rumah sakit sayang ibu dan bayi	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Ruang Pojok Laktasi	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Edukasi Ibu Hamil	10	25	0	22	39	23	15	20	12	23	29	46
Pembentukan Grup Laktasi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Grafik Senam Hamil Di Rumah Sakit Prima Husada Tahun 2025



Analisis :

- 1. Pojok laktasi sudah tersedia untuk ibu dan bayi yang akan menyusui di wilayah rumah sakit prima husada malang. Dan semenjak Maret 2025 RS Prima Husada Malang memiliki 2 ruang pojok laktasi.
- 2. Grup Laktasi dibentuk untuk memberikan tips menyusui.
- 3. Edukasi ibu hamil dilakukan di poli obgyn dan senam ibu hamil.

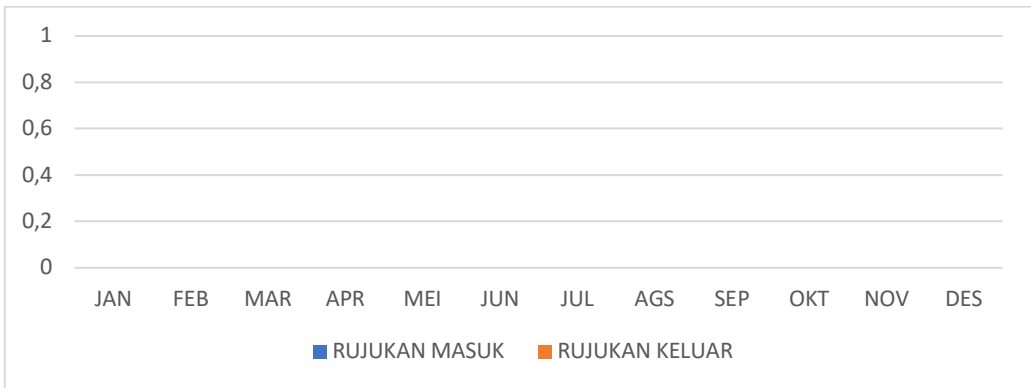
Rencana Tindak Lanjut :

Mengajukan perlengkapan untuk keperluan menyediakan pojok laktasi yang nyaman bagi bayi, balita, dan ibu menyusui seperti popok dan tissue basah jika terdapat pasien atau pengunjung yang membutuhkan.

Tabel Layanan Jejaring Rujukan Kasus Stunting Dan Wasting

No	Rujukan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	Rujukan Masuk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Rujukan keluar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Grafik 3.3.7 Layanan Jejaring Rujukan Kasus Stunting Dan Wasting



Analisis :

Tidak terdapat balita yang rujuk masuk ke RS Prima Husada Malang ataupun rujuk keluar dari RS Prima Husada Malang.

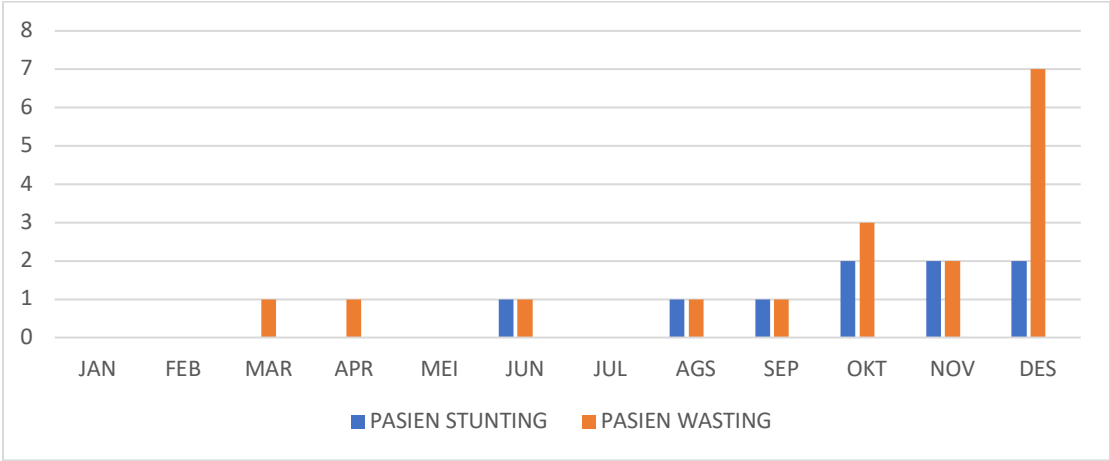
Rencana Tindak Lanjut:

Perlu diadakan kerjasama lagi dengan puskesmas dan klinik faskes pertama untuk bekerjasama dalam menjaring pasien stunting dan wasting.

Tabel Rumah Sakit Sebagai Pendamping Klinis Dan Manajemen Serta Merupakan Jejaring Rujukan

Bulan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Pasien Stunting	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	2	2
Pasien Wasting	0	0	1	1	0	1	0	1	1	3	2	7

Grafik Rumah Sakit Sebagai Pendamping Klinis Dan Manajemen Serta Merupakan Jejaring Rujukan



Analisa :

Terdapat balita terindikasi stunting dan wasting di RS Prima Husada Malang pada bulan Maret, April, Juni, Agustus, September, Okktober, November, dan Desember. Hal tersebut dikarenakan pola makan balita terbilang kurang karena hanya 1-2 kali sehari, pasien juga jarang megkonsumsi makanan tinggi protein dan jumlah asupan makan sekali makan terbilang kurang yaitu 2 sdm tiap makan. Dan memiliki riwayat BBLR dan sakit yang tidak kunjung mereda.

Rencana Tindak Lanjut :

Tim Stunting dan Wasting RS Prima Husada memberikan terapi dengan bekerja sama dengan dokter spesialis anak untuk memberikan diet TKTP, vitamin dan antibiotik yang dibutuhkan untuk mengatasi infeksi yang diderita pasien. Selain itu tim SW juga bekerjasama dengan cara melaporkan pasien stunting kepada petugas Gizi Puskesmas wilayah pasien tinggal untuk melakukan pemantauan lebih lanjut dan pemberian intervensi lanjutan kepada balita stunting dan wasting tersebut.

3.4. Kinerja Produktifitas Komite MFK dan K3

3.4.1. Fasilitas Kesehatan

1. X-Ray (D-AR 500mA)

Pemeriksaan DR yang di miliki RS Prima Husada bertujuan untuk membantu dokter mendiagnosis dan memantau beberapa kondisi tubuh. Misalnya, keluhan seperti infeksi, patah tulang, radang sendi, osteoporosis, ataupun kanker tulang.



2. CT-Scan 128 Slide

Prosedure pemeriksaan medis dengan menggunakan kombinasi teknologi Rongent atau sinar X dengan sistem komputerisasi khusus untuk melihat kondisi dalam tubuh dari berbagai sudut dan potongan. Hasil CT Scan yang di miliki RS Prima husada memiliki kualitas dan kedalaman yang lebih rinci.



3. USG 2 Dimensi dan 4 Dimensi

Pemeriksaan ultrasonografi (USG) di RS Prima Husada dapat digunakan untuk mendiagnosis penyakit seperti batu empedu, batu ginjal, batu saluran kemih, aneurisma aorta abdominalis, neoplasma hepar, karsinoma pankreas, dll.



4. Treadmill & Echo
RS Prima husada memiliki fasilitas treadmill dan echocardiographia dengan di lengkapi adanya dokter spesialis jantung yang berkompeten yang terletak diPoli Jantung
5. Spirometri
RS Prima husada memiliki fasilitas Spirometri dengan di lengkapi adanya dokter spesialis paru yang berkompeten yang terletak di Poli Paru
6. ESWL
Adanya layanan ESWL dapat melengkapi tindakan di bagian urologi RS Prima Husada

A. Unit Laboratorium

Unit laboratorium di RS Prima Husada memiliki jadwal pelayanan 24 jam denganSDM yang terlatih serta memiliki dokter Spesialis Patologi Klinik dan Patologi Anatomi yang berkompetensi. Adapun beberapa alat yang dimiliki oleh Laboratorium menjadikan RS Prima Husada mampu dalam melakukan beberapapemeriksaan antara lain:

1. Chemistry Analyzer Indiko
Alat ini digunakan untuk melakukan Pemeriksaan kimia darah seperti SGOT,SGPT hingga pemeriksaan CKMB
2. Gem Premier 3500 Analyzer
Alat ini di gunakan untuk melakukan pemeriksaan elektrolit dan BGA
3. Hipro Reader
Alat ini di gunakan untuk menunjang pemeriksaan HbA1C dan CRP
4. Mikroskop Analizer
Alat ini digunakan untuk menunjang pemeriksaan BTA SPS, UL, Widal danhapus darah
5. Mini Vidas
Alat ini di gunakan untuk pemeriksaan Enzim jantung dan Hormon tyroid
6. Centifruge WNA
Alat ini digunakan untuk semua pemeriksaan lab yang membutuhkan plasmaatau serum
7. Mindray BC 5000
Alat ini digunakan untuk pemriksaan DL, dan Hapusan darah tepi

Adapun pemeriksaan untuk patologi anatomi seperti pemeriksaan FNAB yangdapat di lakukan oleh dokter patologi anatomi yang berkompeten di RS Prima Husada



3.4.2. Gedung & Bangunan

No	Luas Tanah (M ²)	Luas Bangunan (M ²)
1.	5.411 m ²	Luas bangunan sebesar 6.924 m ² 1. Gedung DPM 2. Gedung A 8 Lantai 3. Gedung B 5 Lantai 4. Gedung C 5 Lantai 5. Gedung IRJA Sentral 6. Gedung IRJA Blok 1 7. Gedung Lama (Gudang Umum, Gudang Farmasi, Parkiran Motor Karyawan, Laundry) 8. Gedung Blok 3 (IPSRS dan Cleaning Service) 9. Parkiran Mobil Umum 10. Pakiran Motor Umum 11. Masjid

NO	NAMA UNIT	NAMA GEDUNG	LANTAI	NAMA RUANGAN	PANJANG (M)	LEBAR (M)
1	LABORATORIUM	Blok 1	1	R. ANALISA	4.3	3.9
2	LABORATORIUM	Blok 1	1	R. SAMPEL	2.8	2.9
3	LABORATORIUM	Blok 1	1	R. PENCUCIAN	3.4	3.2
4	LABORATORIUM	Blok 1	1	R. PENDAFTARAN	9.6	2.7
5	LABORATORIUM	Blok 1	1	R. TUNGGU PENDAFTARAN	3.69	9.79
6		Blok 1	1	R. TRAKSI	3.74	1.3
7		Blok 1	1	R. LAKTASI	3.74	1.3
8	REKAM MEDIS	Blok 1	1	REKAM MEDIS LT 1	6.54	7.6
9	REKAM MEDIS	Blok 1	1	REKAM MEDIS LT 2	14.63	9.11
10	REHAB MEDIK	Blok 1	1	REHAB MEDIK	4.79	4.09
11	REHAB MEDIK	Blok 1	1	R. TERAPI WICARA	2.8	3.33
12	REKAM MEDIS	Blok 1	1	REKAM MEDIS 2	6.89	14.78
13		Blok 1	1	IGD LAMA + MATERNITAS	18.5	28.38
14		Blok 1	1	CS	2.6	2.33
15		Blok 1	1	R. PERIKSA KANDUNGAN	4.3	5.5
16		Blok 1	1	R. BEDAH	8.44	4.22
17		Blok 1	1	R. PERIKSA ANAK	2.8	3.76
18		Blok 1	1	R. BEDAH PLASTIK	3.33	3.7
19		Blok 1	1	FISIOTERAPI 1	3	3.22
20		Blok 1	1	R. SAMPEL SWAB	2.1	3.4
21	IRJA	Blok 2	1	R. TUNGGU	14.87	2.79
22	IRJA	Blok 2	1	POLI GIGI	3.96	3.08
23	IRJA	Blok 2	1	POLI PARU	8.04	3.03
24	IRJA	Blok 2	1	POLI PARU TINDAKAN	3.6	1.53
25	IRJA	Blok 2	1	POLI Jiwa	2.83	3.8
26	IRJA	Blok 2	1	POLI BEDAH 1	2.8	3.7
27	IRJA	Blok 2	1	POLI BEDAH 2	3.02	3.06
28	IRJA	Blok 3	1	R. TUNGGU 1	12.4	2.79
29	IRJA	Blok 3	1	POLI MATA	8.67	3.4

30	IRJA	Blok 3	1	POLI UROLOGI	3.79	3.36
31	IRJA	Blok 3	1	POLI THT	3.79	2.85
32	IRJA	Blok 3	1	POLI KULIT	2.83	2.83
33	IRJA	Blok 3	1	POLI PENYAKIT DALAM 1	3.7	2.8
34	IRJA	Blok 3	1	R. GIZI	2.76	2.89
35	IRJA	Blok 3	1	R. UROFLOMETRI	1.92	2.1
36	IRJA	Blok 3	1	R. TUNGGU 2	11.6	4.8
37	IRJA	Blok 3	1	POLI PENYAKIT DALAM 2	6.87	4.3
38	IT	Blok 3	1	R. IT	7.41	2.74
39	LAUNDRY		1	R. LAUNDRY & JENAZAH	6.84	15.78
40	PINERE		1	PINERE	9.69	15.4
41	IGD	A	1	R. TINDAKAN	13.832	5.22
42	IGD	A	1	R. TRIAGE	3.63	5.22
43	IGD	A	1	R. PENAPISAN	3.45	3.47
44	IGD	A	1	R. DEKONTAMINASI	2.5	1.7
45	IGD	A	1	R. ISOLASI	3.19	2.1
46	IGD	A	1	R. PONEK	5.26	4.79
47	IGD	A	1	R. KONSELING	1.97	2.1
48	IGD	A	1	R. TINDAKAN BEDAH	2.49	2.02
49	IGD	A	1	R. TRANSIT	2.29	1.863
50	IGD	A	1	R. JENAZAH	2.29	2.33
51	IGD	A	1	R. DOKTER	4.41	2.1
52	IGD	A	1	R. KOMITE	4	2.2
53	IGD	A	1	R. STUNTING	4.2	2.3
54	EX MATERNITAS	A	2	NS MATERNITAS 2A (GD BARU)	5.7	2.7
55	EX MATERNITAS	A	2	R. 1	7.6	5.8
56	EX MATERNITAS	A	2	R. 2	7.6	5.8
57	EX MATERNITAS	A	2	R. 3	7.6	5.8
58	EX MATERNITAS	A	2	JANITOR	1.4	1.4
59	EX MATERNITAS	A	2	TOILET	3.2	3.2
60	EX MATERNITAS	A	2	DEPAN TANGGA DARURAT	5.8	4.8
61	EX MATERNITAS	A	2	LORONG LT 2 GD A	23.3	3.5
62	IRNA	A	3	NS 3A	5.7	2.7
63	IRNA	A	3	R. 1	7.6	5.8
64	IRNA	A	3	R. 2	7.6	5.8
65	IRNA	A	3	R. 3	7.6	5.8
66	IRNA	A	3	JANITOR	1.4	1.4
67	IRNA	A	3	TOILET	3.2	3.2
68	IRNA	A	3	DEPAN TANGGA DARURAT	5.8	4.8
69	IRNA	A	3	LORONG LT 3 GD A	23.3	3.5
70	IRNA	A	4	NS 4A	5.7	2.7
71	IRNA	A	4	R. 1	7.8	5.8

72	IRNA	A	4	R. 2	7.8	5.8
73	IRNA	A	4	R. 3	7.8	5.8
74	IRNA	A	4	JANITOR	1.4	1.4
75	IRNA	A	4	TOILET	3.2	3.2
76	IRNA	A	4	DEPAN TANGGA DARURAT	5.8	4.8
77	IRNA	A	4	LORONG LT 4 GD A	23.3	3.5
78	HALL	A	5	TOILET 1	3	2.6
79	HALL	A	5	HALL SAKURA	17.8	11.3
80	HALL	A	5	DEPAN HALL	5.8	7.9
81	HALL	A	5	JANITOR	1.4	1.4
82	HALL	A	5	TOILET 2	3.2	3.2
83	IRNA	A	6	NS 6A	5.4	2.4
84	IRNA	A	6	LORONG LT 6 GD A	23.3	3.5
85	IRNA	A	6	R. 1	7.6	5.9
86	IRNA	A	6	R. 2	7.6	5.9
87	IRNA	A	6	R. 3	7.6	5.9
88	IRNA	A	6	JANITOR	1.4	1.4
89	IRNA	A	6	TOILET	3.2	3.2
90	IRNA	A	6	DEPAN TANGGA DARURAT	6.3	5.7
91	IRNA	A	7	NS 7A	5.4	2.4
92	IRNA	A	7	LORONG LT 7 GD A	23.3	3.5
93	IRNA	A	7	R. 1	7.6	5.9
94	IRNA	A	7	R. 2	7.6	5.9
95	IRNA	A	7	R. 3	7.6	5.9
96	IRNA	A	7	JANITOR	1.4	1.4
97	IRNA	A	7	TOILET	3.2	3.2
98	IRNA	A	7	DEPAN TANGGA DARURAT	6.3	5.7
99	IRNA	A	8	NS 8A	5.4	2.4
100	IRNA	A	8	LORONG LT 8 GD A	23.3	3.5
101	IRNA	A	8	R. 1	7.6	5.9
102	IRNA	A	8	R. 2	7.6	5.9
103	IRNA	A	8	R. 3	7.6	5.9
104	IRNA	A	8	JANITOR	1.4	1.4
105	IRNA	A	8	TOILET	3.2	3.2
106	IRNA	A	8	DEPAN TANGGA DARURAT	6.3	5.7
107	FARMASI	B	1	DEPO FARMASI	4.7	2.22
108	FARMASI	B	1	PERACIKAN FARMASI	7.5	6.5
109	FARMASI	B	1	R. TUNGGU FARMASI	7.74	11.5
110	INSTALASI GIZI	B	1	INSTALASI GIZI	12.9	8.57
111	INSTALASI GIZI	B	1	GIZI TROLI MAKANAN	5.35	2.5
112	CSSD	B	1	R. BERSIH	4.1	4.01
113	CSSD	B	1	R. KOTOR	5.5	3.5
114	RUANG MANAJEMEN	B	2	RUANG MANAJEMEN 2B	17.24	8.04
115	PT DPM	B	2	RUANG PT DPM	18.22	16.03

116	IRNA	B	2	NS IRNA 2A	3.46	3.09
117	IRNA	B	2	VIOLA 6	4.65	3.68
118	IRNA	B	2	VIOLA 5	4.95	3.68
119	IRNA	B	2	VIOLA 4	4.95	3.68
120	IRNA	B	2	VIOLA 1-3	16.4	3.17
121	IRNA	B	2	ANGGREK 1	4.65	3.12
122	IRNA	B	2	ANGGREK 2	4.95	3.12
123	IRNA	B	2	PANTRY 2A	2.57	1.5
124	IRNA	B	2	JANITOR 2A	3.02	1.2
125	IRNA	B	2	SELASAR LT 2	21.6	3.67
126	IRNA	B	2	SELASAR LT 2 ICU	12.3	2.58
127	IRNA	B	3	LORONG 3B	16.8	1.6
128	IRNA	B	3	DAHLIA 3.11-3.15	6.1	5.85
129	PENCAMPURAN OBAT	B	3	R. PENCAMPURAN OBAT	5.6	2.3
130	ESWL	B	3	R. ESWL + OPERATOR	6.8	6.2
131	IRNA	B	4	CEMPAKA 4.21-4.24	6.1	5.8
132	IRNA	B	4	CEMPAKA 4.11-4.14	6.1	6.8
133	IRNA	B	4	LORONG LT 4 GD B	17.1	1.5
134	IRNA	B	4	GUDANG ALKES	5.6	2.6
135	HALL	B	5	BELAKANG HALL SAKURA	5.8	4.8
136	HALL	B	5	LORONG HALL CEMARA	20.5	1.5
137	HALL	B	5	HALL CEMARA	13	6.5
138	HALL	B	5	TOILET HALL CEMARA	5.6	2.2
139	RADIOLOGI	C	1	USG RADIOLOGI	4.76	2.5
140	RADIOLOGI	C	1	RONTGENT	4.87	3.69
141	RADIOLOGI	C	1	CT SCAN	6.23	6.68
142	RADIOLOGI	C	1	CT SCAN OPERATOR	5.97	1.69
143	IKO	C	1	IKO PREMEDI	4.68	3.63
144	IKO	C	1	IKO 1	4.75	4.43
145	IKO	C	1	IKO 2	4.25	5.1
146	IKO	C	1	IKO 3	3.47	5.9
147	IKO	C	1	IKO 4	3.8	5.9
148	IKO	C	1	R. ALAT IKO	2.7	4.9
149	IKO	C	1	R. BEDAH MINOR	4.6	2.86
150	IKO	C	1	RECOVERY ROOM	6.5	3.37
151	IRNA	C	2	NS 2C	3.81	3.54
152	IRNA	C	2	DAHLIA 2.41 - 2.46	7.84	7.01
153	IRNA	C	2	NS ICU	6	3.85
154	IRNA	C	2	ICU TINDAKAN	11.76	6
155	IRNA	C	2	HCU	9.7	3.7
156	IRNA	C	3	NS 3C	5.98	1.9
157	IRNA	C	3	SELASAR CEMPAKA	19.6	2.71
158	IRNA	C	3	CEMPAKA 3.61 & 3.62	6.09	3.86
159	IRNA	C	3	CEMPAKA 3.91 & 3.92	5.98	3.88

160	IRNA	C	3	CEMPAKA 3.81 & 3.82	5.9	3.88
161	IRNA	C	3	CEMPAKA 3.71 & 3.72	5.9	3.88
162	IRNA	C	3	BOUGENVILE 3.11 & 3.12	6.94	3.8
163	IRNA	C	3	BOUGENVILE 3.21 & 3.22	6.94	3.8
164	IRNA	C	3	BOUGENVILE 3.31 & 3.32	6.94	3.8
165	IRNA	C	3	RUANG KOMITE KEPERAWATAN	3.67	2.7
166	IRNA	C	3	JANITOR	3.67	3.9
167	IRNA	C	3	NS 3A	2.7	3.6
168	IRNA	C	3	CEMPAKA 3.31	3.99	3.3
169	IRNA	C	3	CEMPAKA 3.41	3.99	3.3
170	IRNA	C	3	CEMPAKA 3.21	5.6	3.2
171	IRNA	C	3	CEMPAKA 3.11	5.6	3.2
172	IRNA	C	3	DAHLIA 3.1	5.3	3.1
173	IRNA	C	3	DAHLIA 3.2	5.5	3.1
174	IRNA	C	3	DAHLIA 3.3	5.5	3.1
175	IRNA	C	3	SELASAR 4C	19.52	2.5
176	IRNA	C	4	NS 4	4.09	1.99
177	IRNA	C	4	DAHLIA 4.31	5.8	5.8
178	IRNA	C	4	DAHLIA 4.1	5.8	5.8
179	IRNA	C	4	BOUGENVILLE 4.2	5.8	5.8
180	IRNA	C	4	NICU	2.8	6.8
181	IRNA	C	4	PERINATOLOGI	6.9	3.7
182	IRNA	C	4	JANITOR	6.9	4.7
183	IRNA	C	4	TINDAKAN MATERNITAS	18.6	12.4
184	IRNA	C	5	BOUGENVILLE 5.31	5.8	3.7
185	IRNA	C	5	BOUGENVILLE 5.1	5.8	3.7
186	IRNA	C	5	BOUGENVILLE 5.2	5.8	3.7
187	IRNA	C	5	ISOLASI 5.1	5.8	3.7
188	IRNA	C	5	ISOLASI 5.2	6.8	3.7
189	IRNA	C	5	DAHLIA 5.1	6.8	7.8
190	IRNA	C	5	NS	7.69	2.8
191	IRNA	C	5	JANITOR	5.6	3.68
192	FARMASI	DPM	1	GUDANG FARMASI	9.36	5.02
193	FARMASI	DPM	1	GUDANG VAKSIN & INJECT	2.3	1.65
194	FARMASI	DPM	1	GUDANG B3	1.87	1.62
195	GUDANG UMUM	DPM	1	GUDANG UMUM	9.34	2.22
196	IPSRS	DPM	1	IPSRS	9.39	3.03
197	GUDANG DPM	DPM	1	GUDANG DPM	8.26	2.08
198	RUANG TUNGGU	DPM	1	RUANG TUNGGU	15.76	9.12
199	IRJA	DPM	1	POLI PENYAKIT DALAM	4.14	2.93
200	IRJA	DPM	1	POLI JANTUNG	9.03	2.89
201	IRJA	DPM	1	POLI JANTUNG (VAKSIN)	3.91	3.91
202	IRJA	DPM	1	EKS FARMASI	8.16	4.63

203	IRJA	DPM	1	POLI SYARAF	5.03	3.14
204	REKAM MEDIS	DPM	1	GUDANG RM	4.99	1.69
205	REKAM MEDIS	DPM	1	REKAM MEDIS	16.95	5.95

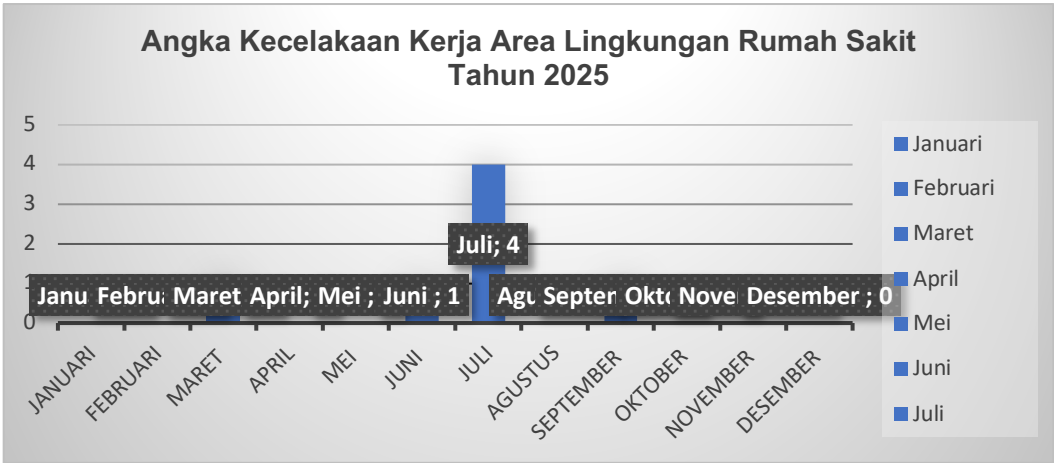
3.4.3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja

3.4.3.1 Keselamatan

Tabel Jumlah Angka Kecelakaan Kerja Tahun 2025

BULAN	ANGKA KECELAKAAN KERJA	KETERANGAN
Januari	-	Tidak ada laporan kecelakaan kerja.
Februari	-	Tidak ada laporan kecelakaan kerja.
Maret	1	1 orang petugas dapur terkilir tangan kanan saat mengambil box makanan (cedera ringan), posisi pengambilan yang salah, tindakan penanganan dibawa ke IGD.
April	-	Tidak ada laporan kecelakaan kerja.
Mei	-	Tidak ada laporan kecelakaan kerja.
Juni	1	Tgl 26 Juni 2025, salah satu petugas dokter MCU terkena jarum (saat akan dibuang) luka pada jari.
Juli	4	Terjadi 4 kali kejadian kecelakaan kerja pada bulan Juli - Tanggal 18 Juli 2025, seorang petugas CS tertusuk jarum yang menembus lapisan safety box, safety box tidak tahan tembus. - Tanggal 20 Juli 2025, seorang petugas CS IGD membersihkan kloset kamar mandi di masjid dengan menggunakan cairan lime away. Cairan tersebut dimasukkan ke botol bekas, staf lupa jika botol bekas tersebut bekas bayclin, akhirnya menguauo dan terhirup. - Tanggal 16 Juli 2025, 2 petugas IPSRS, saat melakukan pengecekan dan perbaikan tekanan dental unit 2, menggunakan air sabun, lalu tiba - tiba air sabun meledak dan mengenai mata
Agustus	-	Tidak ada laporan kecelakaan kerja.
September	1	1 orang petugas IGD tertusuk jarum saat memegang pasien (tidak tenang).
Oktober	0	Tidak ada laporan kecelakaan kerja.
November	0	Tidak ada laporan kecelakaan kerja.
Desember	0	Tidak ada laporan kecelakaan kerja.

Grafik Angka Kecelakaan Kerja Tahun 2025



Keterangan :
 Dibulan Desember tidak ada laporan kecelakaan kerja.

Analisis :

- a) Januari 0 kecelakaan kerja.
- b) Februari 0 kecelakaan kerja.
- c) Maret 1 kecelakaan kerja.
- d) April 0 kecelakaan kerja.
- e) Mei 0 kecelakaan kerja.
- f) Juni 1 kecelakaan kerja.
- g) Juli 4 kecelakaan kerja.
- h) Agustus 0 kecelakaan kerja.
- i) September 1 kecelakaan kerja.
- j) Oktober 0 kecelakaan kerja.
- k) November 0 kecelakaan kerja.
- l) Desember 0 kecelakaan kerja.

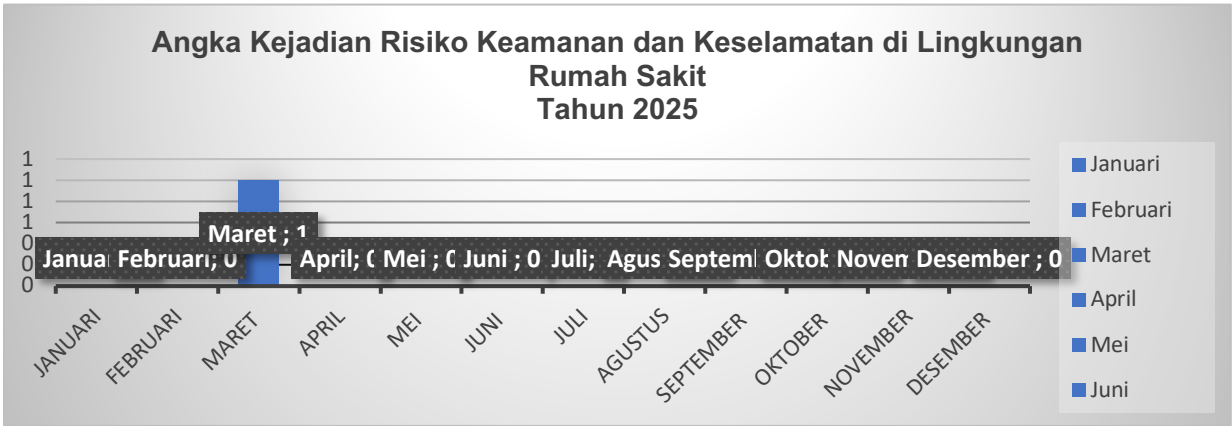
3.4.3.2 Keamanan

Tabel Laporan Keamanan Oleh Security Tahun 2025

BULAN	HASIL PEMANTAUAN SHIFT			KETERANGAN
	PAGI	SIANG	MALAM	
Januari	Tidak ada kejadian terkait keselamatan dan kemanan	Tidak ada kejadian terkait keselamatan dan kemanan	Tidak ada kejadian terkait keselamatan dan kemanan	Di bulan Januari tahun 2025 tidak ada kejadian terkait keselamatan dan keamanan
Februari	Tidak ada kejadian terkait keselamatan dan kemanan	Tidak ada kejadian terkait keselamatan dan kemanan	Tidak ada kejadian terkait keselamatan dan kemanan	Di bulan Februari tahun 2025 tidak ada kejadian terkait keselamatan dan keamanan
Maret	Tidak ada kejadian terkait keselamatan dan kemanan	Ada 1 kejadian orang tidak dikenal sedang meminta di area masjid	Tidak ada kejadian terkait keselamatan dan kemanan	Di bulan Maret tahun 2025 ada 1 kejadian terkait keselamatan dan keamanan
April	Tidak ada kejadian terkait keselamatan dan kemanan	Tidak ada kejadian terkait keselamatan dan kemanan	Tidak ada kejadian terkait keselamatan dan kemanan	Di bulan April tahun 2025 tidak ada kejadian terkait keselamatan dan keamanan
Mei	Tidak ada kejadian terkait keselamatan dan kemanan	Tidak ada kejadian terkait keselamatan dan kemanan	Tidak ada kejadian terkait keselamatan dan kemanan	Di bulan Mei tahun 2025 tidak ada kejadian terkait keselamatan dan keamanan
Juni	Tidak ada kejadian terkait keselamatan dan kemanan	Tidak ada kejadian terkait keselamatan dan kemanan	Tidak ada kejadian terkait keselamatan dan kemanan	Di bulan Juni tahun 2025 tidak ada kejadian terkait keselamatan dan keamanan
Juli	Tidak ada kejadian terkait keselamatan dan kemanan	Tidak ada kejadian terkait keselamatan dan kemanan	Tidak ada kejadian terkait keselamatan dan kemanan	Di bulan Juli tahun 2025 tidak ada kejadian terkait

				keselamatan dan keamanan
Agustus	Tidak ada kejadian terkait keselamatan dan kemanan	Tidak ada kejadian terkait keselamatan dan kemanan	Tidak ada kejadian terkait keselamatan dan kemanan	Di bulan Agustus tahun 2025 tidak ada kejadian terkait keselamatan dan keamanan
September	Tidak ada kejadian terkait keselamatan dan kemanan	Tidak ada kejadian terkait keselamatan dan kemanan	Tidak ada kejadian terkait keselamatan dan kemanan	Di bulan September tahun 2025 tidak ada kejadian terkait keselamatan dan keamanan
Oktober	Tidak ada kejadian terkait keselamatan dan kemanan	Tidak ada kejadian terkait keselamatan dan kemanan	Tidak ada kejadian terkait keselamatan dan kemanan	Di bulan Oktober tahun 2025 tidak ada kejadian terkait keselamatan dan keamanan
November	Tidak ada kejadian terkait keselamatan dan kemanan	Tidak ada kejadian terkait keselamatan dan kemanan	Tidak ada kejadian terkait keselamatan dan kemanan	Di bulan November tahun 2025 tidak ada kejadian terkait keselamatan dan keamanan
Desember	Tidak ada kejadian terkait keselamatan dan kemanan	Tidak ada kejadian terkait keselamatan dan kemanan	Tidak ada kejadian terkait keselamatan dan kemanan	Di bulan November tahun 2025 tidak ada kejadian terkait keselamatan dan keamanan

Grafik Laporan Risiko Keamanan dan Keselamatan Lingkungan Rumah Sakit Tahun 2025



Keterangan :

Tidak ada kejadian risiko keamanan dan keselamatan di lingkungan Rumah Sakit di bulan Desember.

Analisis :

- a) Januari 0 kejadian.
- b) Februari 0 kejadian.
- c) Maret 1 kejadian.
- d) April 0 kejadian.
- e) Mei 0 kejadian.
- f) Juni 0 kejadian.
- g) Juli 0 kejadian.
- h) Agustus 0 kejadian.
- i) September 0 kejadian.
- j) Oktober 0 kejadian.
- k) November 0 kejadian.
- l) Desember 0 kejadian.

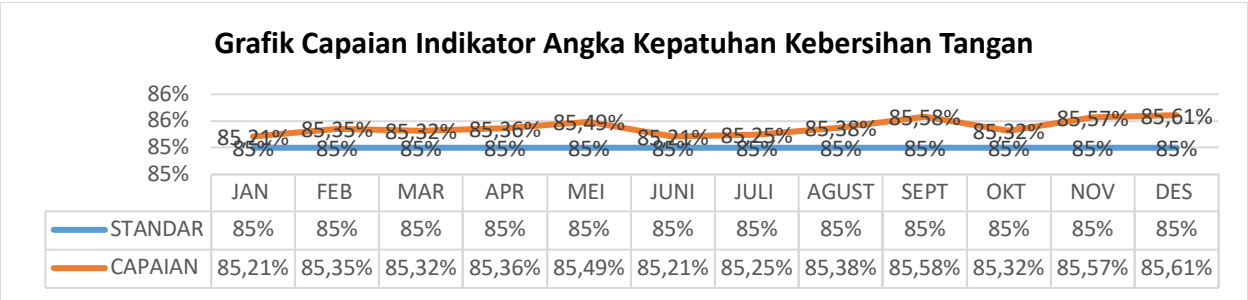
3.5. Kinerja Produktifitas Komite Mutu

3.5.1 Mutu Nasional

NO	JUDUL	STAND	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Juli '25	Agust '25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%	85,21%	85,35%	85,32%	85,36%	85,49%	85,21%	85,25%	85,38%	85,58%	85,32%	85,57%	85,61%	85,39%
2.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	93,01%	93,06%	93,1%	93,22%	93,54%	96,3%	93,79%	94,3%	94,33%	94,52%	96,88%	96,86%	94,41%
3.	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	99,55%	99,92%	99,77%	99,96%	99,88%	100%	93,93%	99,94%	99,83%	99,96%	100%	99,92%	99,38%
4.	Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergensi	≥ 80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
5.	Waktu Tunggu Rawat Jalan	≥ 80%	89,16%	89,38%	99,1%	98,21%	97,58%	97,33%	96,23%	96,60%	96,62%	96,88%	96,89%	96,91%	95,91%
6.	Penundaan Operasi Elektif	≤ 5%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,32%	0%	0%	0%	0,03%
7.	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥ 80%	75,9%	76,21%	74,93%	74,19%	72,26%	78,28%	66,22%	60,55%	70,4%	62,74%	71,55%	67,81%	70,92%
8.	Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium	100%	96,9%	97,31%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99,52%
9.	Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional	≥ 80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
10.	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (Clinical Pathway)	≥ 80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
11.	Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh	100%	99,75%	98,64%	99,1%	99,44%	97,65%	99,09%	96,33%	95,04%	93,45%	89,47%	96,68%	94,62%	96,61%
12.	Kecepatan Waktu Tanggap Komplain	≥ 80%	100%	99,92%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99,99%
13.	Kepuasan Pasien	≥ 76,61	99,81%	99,79%	100%	99,88%	99,76%	97,12%	99,46%	99,56%	99,89%	99,9%	99,62%	92,80%	98,97%

3.5.1.1 Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan

Grafik Capaian Indikator Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan

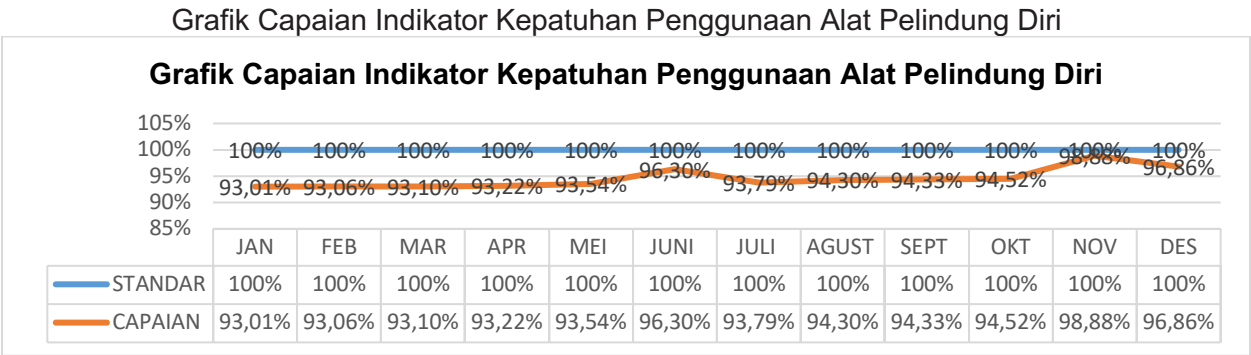


Dari grafik indikator angka keptuhan kebersihan tangan bulan Januari tahun 2025 diketahui bahwa capaian telah mencapai standart yaitu 85,21% dan pada bulan Februari capaian meningkat menjadi 85,35%, capian di bulan Maret yaitu 85,32%, capaian di bulan April yaitu 85,36%, capaian di bulan Mei 85,49%, capaian di bulan Juni adalah 85,21%, capaian di bulan Juli adalah 85,25%, Agustus sebesar 85,38%, September sebesar 85,58, Oktober 85,32%, November 85,57% dan Desember 85,61% dengan rata rata bulan Januari hingga Desember yaitu 85,39%. Meskipun belum mencapai 100% tetapi nilai tersebut telah mencapai standart. Petugas masih dengan anggapan bahwa tangannya dalam kondisi masih bersih dan terkadang karena kondisi harus segera dilakukan tindakan pada pasien jadi lupa tidak melakukan cuci tangan karena memang belum terbiasa. Di harapkan capaian ini dapat ditingkatkan di bulan berikutnya.

PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka kepatuhan kebersihan tangan semaksimal mungkin hingga 100%.				
DO	a) Lakukan audit kepatuhan kebersihan tangan secara rutin. b) Anjurkan IPCLN untuk membuat video edukasi terkait cuci tangan sebagai media sosialisasi. c) Berikan reward pada unit yang prosentase cuci tangannya baik. d) Lakukan control monitoring fasilitas kebersihan tangan di unit pelayanan. e) Berikan proses pembelajaran pada petugas yang belum paham atau tidak menjalankan kebersihan tangan dengan baik.				
STUDY	Dari grafik indikator angka keptuhan kebersihan tangan bulan Januari tahun 2025 diketahui bahwa capaian telah mencapai standart yaitu 85,21% dan pada bulan Februari capaian meningkat menjadi 85,35%, capian di bulan Maret yaitu 85,32%, capaian di bulan April yaitu 85,36%, capaian di bulan Mei 85,49%, capaian di bulan Juni adalah 85,21%, capaian di bulan Juli adalah 85,25%, Agustus sebesar 85,38%, September sebesar 85,58, Oktober 85,32%, November 85,57% dan Desember 85,61% dengan rata rata bulan Januari hingga Desember yaitu 85,39%. Meskipun belum mencapai 100% tetapi nilai tersebut telah mencapai standart. Petugas masih dengan anggapan bahwa tangannya dalam kondisi masih bersih dan terkadang karena kondisi harus segera dilakukan tindakan pada pasien jadi lupa tidak melakukan cuci tangan karena memang belum terbiasa. Di harapkan capaian ini dapat ditingkatkan di bulan berikutnya.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
f) Meningkatkan kebersihan tangan.	g) Meningkatkan kepatuhan kebersihan tangan.	h) Seluruh petugas pelayanan pasien	i) Lakukan audit kepatuhan kebersihan tangan secara rutin. j) Anjurkan IPCLN untuk membuat video edukasi terkait cuci tangan sebagai media sosialisasi. k) Berikan reward pada unit yang	n) Perawat /Bidan o) Dokter p) Karu q) IPCLN/IPCN	r) Satu bulan

			prosentase cuci tangannya baik. l) Lakukan control monitoring fasilitas kebersihan tangan di unit pelayanan. m) Berikan proses pembelajaran pada petugas yang belum paham atau tidak menjalankan kebersihan tangan dengan baik.		
--	--	--	--	--	--

3.5.1.2 Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)



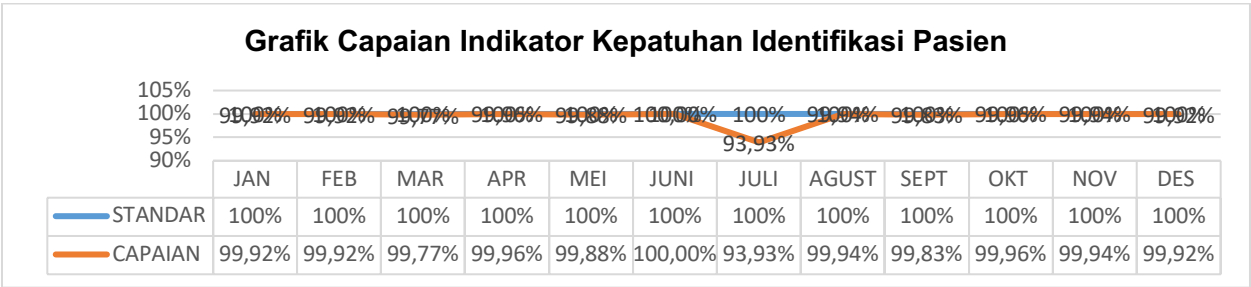
Berdasarkan grafik capaian indikator kepatuhan penggunaan alat pelindung alat pelindung diri pada bulan Januari hingga Desember Tahun 2025 capaian belum mencapai standart, oleh karena itu perlu dilakukan PDSA dengan langkah-langkah sebagai berikut :

PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka kepatuhan penggunaan APD semaksimal mungkin hingga 100%.				
DO	s) Melakukan monitoring pelaksanaan audit kepatuhan penggunaan APD yang sesuai. t) Melakukan supervise terkait ketersediaan dan kesesuaian penggunaan APD. u) Memberikan edukasi pemakaian APD yang tepat antar staf dibantu oleh IPCLN dan anggota Komite PPI lainnya. v) Memberikan proses pembelajaran kepala unit dan IPCLN yang anggotanya ketahuan tidak patuh dalam pemakaian APD. (mendata ketidakpatuhan pemakaian APD petugas dapur). w) Sudah dikeluarkan edaran terkait penggunaan jas dokter. x) Menanamkan kesadaran pada pribadi masing-masing petugas bahwa pemakaian APD yang benar ini penting.				
STUDY	Prosentase kepatuhan penggunaan APD keseluruhan belum mencapai standart. Capaian di bulan Januari tahun 2025 yaitu 93,01%, bulan Februari sebesar 93,06%, bulan Maret sebesar 93,1%, bulan April 93,22%, bulan Mei 93,54%, bulan Juni 96,3% dan bulan Juli 93,79% serta bulan Agustus sebesar 94,3%, bulan September yaitu 94,33%, bulan Oktober 94,2%, bulan November 96,88% dan Desember 96,86% dengan rata-rata 94,41%. Ketidakpatuhan ini berpotensi meningkatkan risiko penularan infeksi silang antar pasien dan tenaga kesehatan. Berdasarkan temuan, masih ada petugas yang dengan sengaja tetap menggunakan handscoon untuk menulis rekam medis.Selain itu masih ada DPJP yang menggunakan satu APD untuk visit ke seluruh pasien. Hal tersebut menunjukkan kurangnya kesadaran dan disiplin dalam penggunaan APD.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU

y) Meningkatkan kepatuhan pemakaian APD.	z) Meningkatkan kepatuhan pemakaian APD di unit.	aa) Tercapainya kepatuhan APD hingga maksimal 100%.	bb) Sosialisai secara berkelanjutan tentang pentingnya penggunaan APD kepada seluruh tenaga Kesehatan cc) Melakukan audit harian kepatuhan APD dan memberikan Feedback langsung dd) Memberikan apresiasi (reward) bagi tenaga Kesehatan yang patuh	ee) Kepala ruangan dan IPCN ff) Kepala ruangan gg) Kepala Bidang	hh) Satu Bulan
--	--	---	--	--	----------------

3.5.1.3 Kepatuhan Identifikasi Pasien

Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Identifikasi Pasien



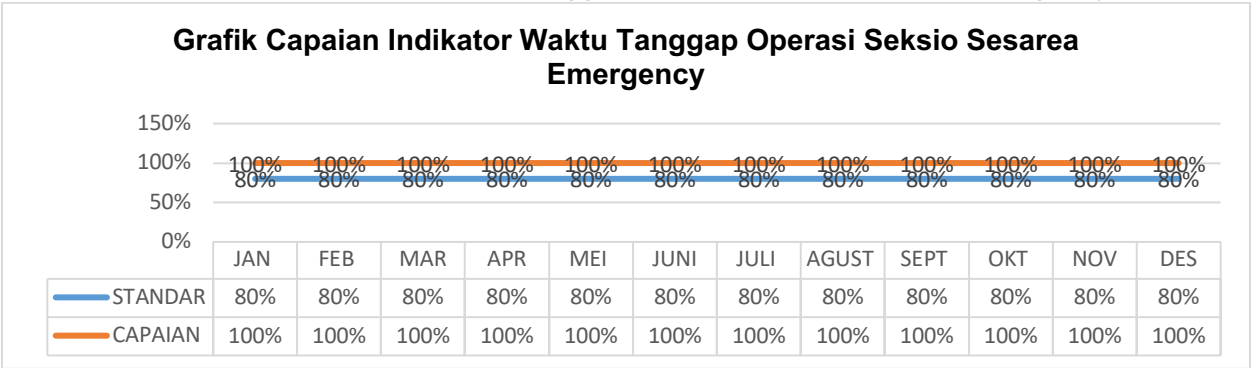
Berdasarkan grafik capaian indikator kepatuhan identifikasi pasien pada bulan Januari hingga Mei Tahun 2025 capaian belum mencapai standart, pada bulan Juni tahun 2025 capaian telah meningkat menjadi 100%,namun kembali menurun di bulan Juli yaitu 93,93%, bulan Agustus yaitu 99,94%, bulan September yaitu 99,83%, bulan Oktober yaitu 99,96%, bulan November 99,94% dan Desember 99,92% dengan rata rata bulan Januari hingga Desember 99,38%.

PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka keatuhan identifikasi pasien semaksimal mungkin (100%).				
DO	ii) Melakukan supervisi pada petugas di unit secara berkelanjutan jj) Kepala Instalasi untuk terus melaksanakan supervisi dan sosialisasi terkait identifikasi pasien kk) Memberikan teguran kepada petugas yang tidak melakukan identifikasi pasien atau melakukan identifikasi tetapi masih salah				
STUDY	Berdasarkan grafik capaian indikator kepatuhan identifikasi pasien pada bulan Januari hingga Mei Tahun 2025 capaian belum mencapai standart, pada bulan Juni tahun 2025 capaian telah meningkat menjadi 100%,namun kembali menurun di bulan Juli yaitu 93,93%, bulan Agustus yaitu 99,94%, bulan September yaitu 99,83%, bulan Oktober yaitu 99,96%, bulan November 99,94% dan Desember 99,92% dengan rata rata bulan Januari hingga Desember 99,38%. Dari temuan dilapangan diketahui bahwa DPJP seringkali tidak melakukan identifikasi pasien ketika melakukan visite karena sudah didampingi oleh perawat. Supervisi secara berkelanjutan serta memberikan teguran secara langsung cukup efektif untuk meningkatkan kepatuhan identifikasi pasien.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU

ll) Mempertahankan kepatuhan identifikasi pasien	mm) Mempertahankan kepatuhan identifikasi pasien	nn) Tercapainya indikator kepatuhan identifikasi pasien pada bulan berikutnya.	oo) Terus melakukan supervisi pada petugas unit pp) Memberikan teguran secara langsung jika menemukan petugas yang tidak melakukan identifikasi pasien dengan tepat. qq) Perawat diharapkan bisa membantu melakuakn identiifikasi pasien ulang ketika melakukan visite	rr) Seluruh petugas yang melakukan pelayanan di RS.	ss) Satu Bulan
--	--	--	--	---	----------------

3.5.1.4 Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergency

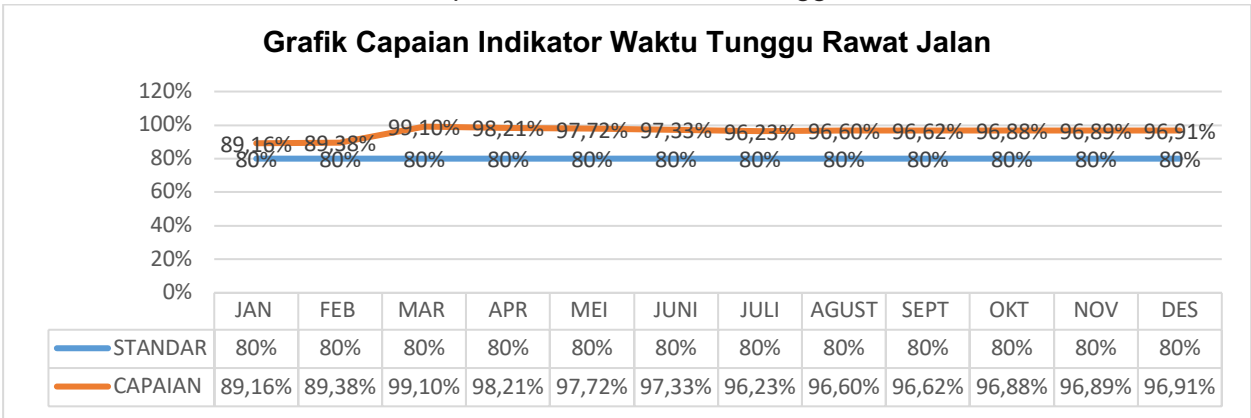
Grafik Capaian Indikator Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergency



Dari grafik indikator waktu tanggap SC emergency bulan Januari hingga bulan Desember tahun 2025 diketahui capaian telah mencapai standart 100%, hal ini berkat kerjasama yang baik antara unit Instalasi Gawat Darurat, Unit Maternitas dan Instalasi Kamar Operasi serta manajemen Rumah Sakit Prima Husada Malang yang telah bersinergi untuk mempertahankan capaian waktu SC emergency. Ketersediaan SDM serta sarana dan prasarana yang mendukung juga menjadi faktor tercapainya indikator waktu tanggap operasi SC emergency. Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan di tahun berikutnya.

3.5.1.5 Waktu Tunggu Rawat Jalan

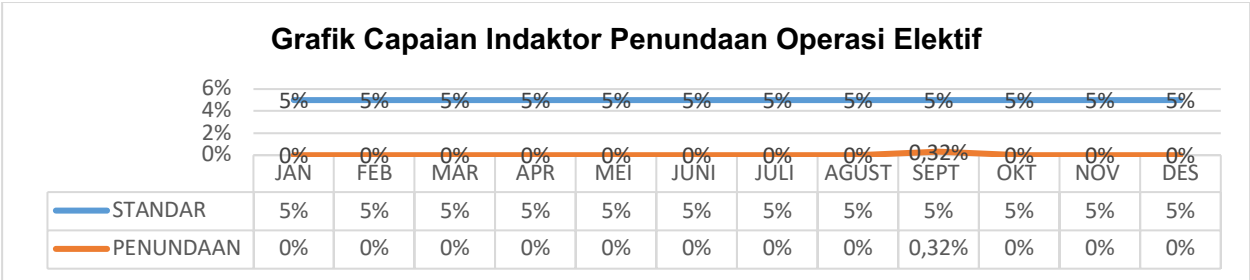
Grafik Capaian Indikator Waktu Tunggu Rawat Jalan



Berdasarkan grafik capaian indikator waktu tunggu rawat jalan pada bulan Januari Tahun 2025 capaian telah mencapai standart dengan capaian 98,16%, capaian di bulan Februari 89,38%, capaian di bulan Maret 99,1%, capaian di bulan April 98,22%, capaian di bulan Mei 97,71%, capaian di bulan Juni adalah 97,33% dan capaian di bulan Juli adalah 96,23%, capaian di bulan Agustus yaitu 96,60%, di bulan September yaitu 96,52%, capaian di bulan Oktober yaitu 96,88%, capaian di bulan November yaitu 96,89% dan Desember 96,91% dengan rata-rata 95,91%. Hal ini berkat kerjasama yang baik antara manajemen dan juga DPJP yang sudah berusaha datang tepat waktu dan evaluasi berkelanjutan yang telah dilakukan manajemen terhadap keterlambatan DPJP. Adanya aturan baru bahwa pasien bisa di daftar 1 jam sebelum jadwal praktek dokter juga sangat membuat waktu tunggu rawat jalan menjadi lebih pendek. Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan di tahun 2026 dengan cara Optimalisasi alur pendaftaran dan koordinasi antar unit.

3.5.1.6 Penundaan Operasi Elektif

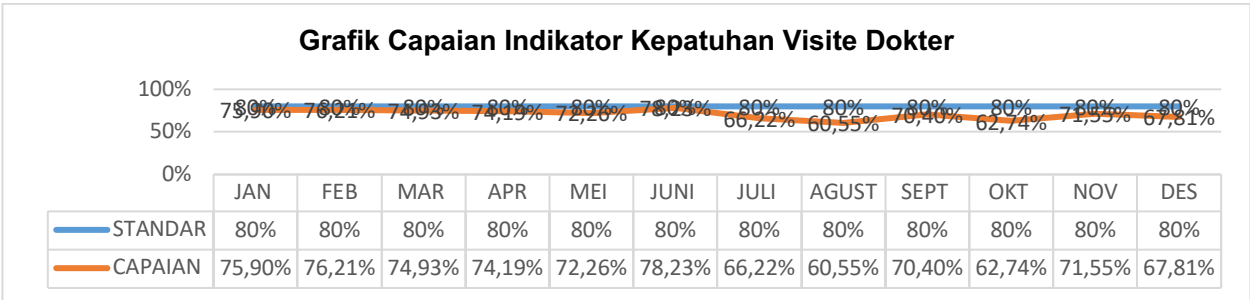
Grafik capaian Indikator Penundaan Operasi Elektif



Dari grafik indikator penundaan operasi elektif bulan Januari hingga Desember tahun 2025 diketahui capaian telah mencapai standart dengan rata rata 0,03% hal ini berkat kerjasama yang baik antara unit Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap dan Instalasi Kamar Operasi serta manajemen Rumah Sakit Prima Husada Malang yang telah bersinergi untuk mempertahankan capaian indikator penundaan operasi elektif . perencanaan yang matang dari segi SDM, alat dan ruang operasi juga telah dilakukan guna meminimalisir terjadinya penundaan operasi elektif. Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan di tahun 2026 melalui ketersediaan alat dan kesiapan tim.

3.5.1.7 Kepatuhan Waktu Visite Dokter

Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Visite Dokter



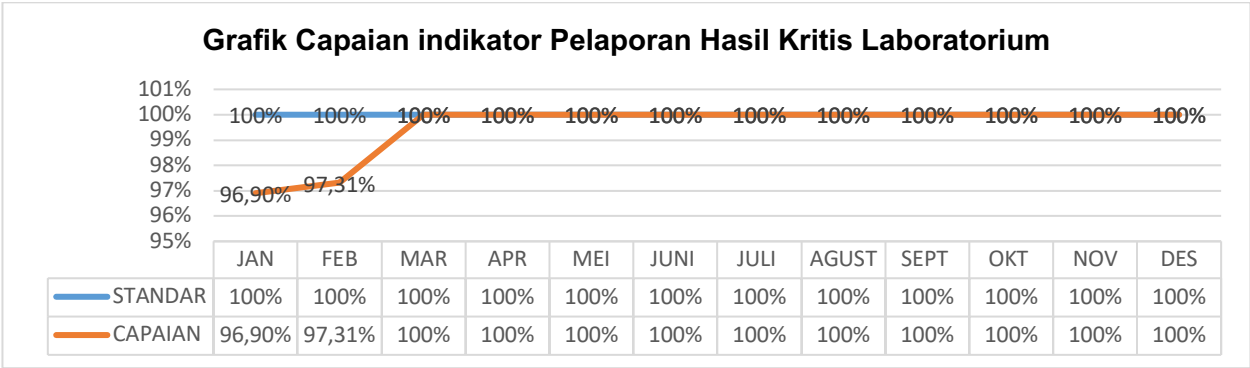
Berdasarkan grafik capaian indikator kepatuhan visite Dokter pada bulan Januari hingga Desember Tahun 2025 belum mencapai standart, oleh karena itu perlu dilakukan PDSA dengan langkah-langkah sebagai berikut :

PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka kepatuhan waktu visite dokter hingga dapat mencapai standart 80%.
DO	Memberikan masukan pada SDM dan Kabid pelayanan untuk melakukan rekrutmen home dokter lebih banyak
STUDY	Berdasarkan hasil capaian di atas, diketahui persentase kepatuhan waktu visite dokter pada bulan Januari tahun 2025 belum mencapai standart dengan capaian 75,9%, capaian di bulan februari yaitu 76,21%, capaian di bulan Maret yaitu 74,93%, capaian di bulan April yaitu 74,19%, capaian di bulan Mei yiatsu 72,26%, capaian di bulan Juni yaitu 78,23%, capaian di bulan Juli yaitu 66,22% dan capaian di bulan Agustus yaitu 60,55%, capaian bulan September yaitu 70,4%,

	Oktober 62,74%, November 71,55% dan Desember 67,81% dengan rata-rata 70,92%. Dari hasil supervisi didapatkan Angka kepatuhan waktu visite Dokter belum mencapai standart karena dokter seringkali memiliki jadwal yang padat termasuk jadwal praktik klinik dan tugas di rumah sakit lain. Selain itu budaya di rumah sakit yang belum sepenuhnya mengutamakan kepatuhan terhadap indikator mutu nasional, diaman visite di anggap fleksibel atau dapat di sesuaikan di luar jam standart.				
	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
tt) Meningkatkan kepatuhan waktu visite dokter	uu) Meningkatkan kepatuhan waktu visite dokter	vv) Capaian Kepatuhan Visite dokter bisa meningkat pada bulan selanjutnya	ww) Kepala ruangan memantau kehadiran dokter pada waktu visite yang dijadwalkan. xx) Data dikumpulkan dan dibandingkan dengan jadwal resmi. yy) Supervisi secara konsisten zz) Mengkomunikasikan dengan DPJP supaya berkomitmen untuk visite di jam yang sudah disepakati supaya ketika pasien bertanya, perawat bisa menjelaskan secara tepat.	Manajemen RS	aaa) Satu Bulan

3.5.1. 8 Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium

Grafik Capaian Indikator Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium



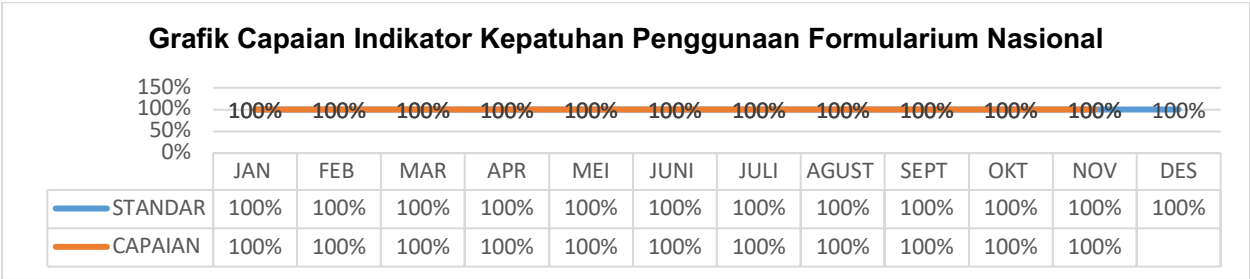
Berdasarkan grafik capaian indikator Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium pada bulan Januari dan Februari Tahun 2025 diketahui capaian belum mencapai standart dan capaian meningkat hingga 100% di bulan Maret hingga Desember.

PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan pelaporan hasil kritis laboratorium hingga mencapai standart 100%
DO	Meningkatkan supervisi baik dari komite mutu maupun kepala instalasi laboratorium supaya seluruh petugas laboratorium segera melaporkan hasil kritis dan melakukan dokumentasi dengan baik dan lengkap.
STUDY	Berdasarkan hasil capaian di atas, diketahui indikator pelaporan hasil kritis laboratorium pada bulan Januari tahun 2025 belum mencapai standart dengan capaian 96,9% dan bulan Februari 97,31%. Capaian meningkat pada bulan Maret hingga Desember yang telah mencapai standart 100%. Berdasarkan hasil supervisi masih ada petugas yang melaporkan hasil kritis laboratorium tetapi tidak dilakukan pendokumentasian dengan lengkap yang membuat indikator tidak tercapai di bulan Januari dan Februari. Perbaikan telah dilakukan dengan cara menganalisa jumlah hasil kritis laboratorium yang terlapor dan tidak terlapor, memasukkan catatan ketidak patuhan staf kedalam evaluasi kinerja staf secara langsung kepada petugas laboratorium yang tidak melaporkan hasil kritis laboratorium ataupun yang melapor tapi tidak dilakukan pendokumentasian dengan baik dan lengkap, memberikan pemahaman akan pentingnya

	melaporkan hasil kritis karena melalui hasil kritis dapat mempercepat mengetahui kondisi yang mengancam jiwa pasien.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
bbb) Meningkatkan capaian indikator pelaporan hasil kritis labDari goratorium	ccc) Meningkatkan capaian indikator pelaporan hasil kritis laboratorium	ddd) Capaian pelaporan hasil kritis laboratorium dapat mencapai standart 100% pada bulan berikutnya	eee) Menganalisa jumlah hasil kritis laboratorium yang terlapor dan tidak terlapor fff) Memasukkan catatan ketidak patuhan staf kedalam evaluasi kinerja staf secara langsung kepada petugas laboratorium yang tidak melaporkan hasil kritis laboratorium ataupun yang melapor tapi tidak dilakukan pendokumentasian dengan baik dan lengkap. ggg) Memberikan pemahaman akan pentingnya melaporkan hasil kritis karena melalui hasil kritis dapat mempercepat mengetahui kondisi yang mengancam jiwa pasien.	hhh) Komite mutu iii) Kepala instalasi laboratorium	jjj) Satu Bulan

3.5.1.9 Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional

Grafik Capaian Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional

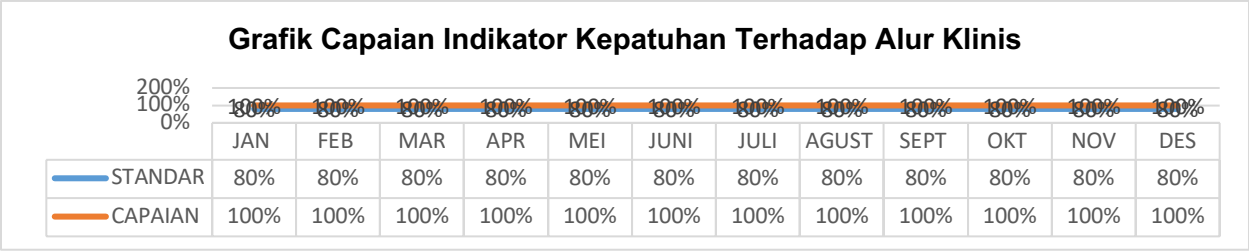


Grafik indikator Formularium Nasional bulan Januari hingga Desember tahun 2025 diketahui capaian telah mencapai standart 100%, hal ini kerjasama yang baik antara dokter penanggungjawab pasien, instalasi farmasi dan juga manajemen Rumah Sakit Prima Husada Malang yang telah bersinergi untuk mempertahankan capaian kepatuhan penggunaan formularium Nasional . Adanya payung hukum yang kuat, seperti Keputusan Menteri Kesehatan

tentang Formularium Nasional, memberikan landasan hukum yang wajib dipatuhi oleh fasilitas pelayanan kesehatan dalam pelaksanaan pelayanan Kesehatan juga menjadi faktor yang membuat rumah sakit wajib mematuhi standart formularium nasional. Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan di tahun 2026.

3.5.1.10 Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (Clinical Pathway)

Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Terhadap Alur Klinis



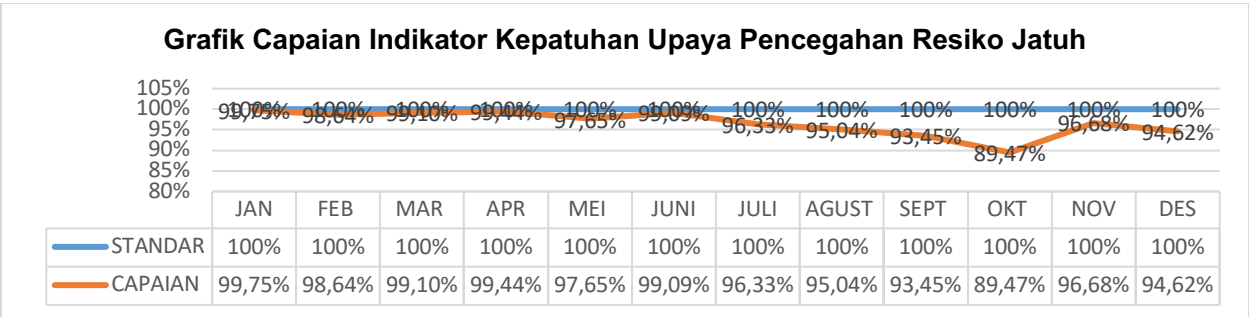
Dari grafik indikator kepatuhan terhadap alur klinis bulan Januari hingga Desember tahun 2025 diketahui capaian telah mencapai standart 100%, unit yang patuh dalam pengisian CP daalah unit maternitas dengan diagnosa partus normal dan SC. Alur klinis sendiri sebenarnya membantu menstandardisasi perawatan untuk diagnosis tertentu, memastikan konsistensi dalam pelayanan yang diberikan kepada pasien.

Daftar Clinical Pathway Bulan Desember 2025

DIAGNOSA	JUMLAH	PATUH	TIDAK PATUH
DF			
CVA Infark			
Gastritis			
Batu Ureter			
DM			
GEA			
CHF			
FAM			
TB Paru			
HT			
CA Mammae			
HIV			
STEMI			
NSTEMI/UAP			
Pneumonia			
Sectio Caesarea		74	
Partus Normal		51	
Jumlah		125	

3.5.1.11 Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Jatuh

Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Jatuh



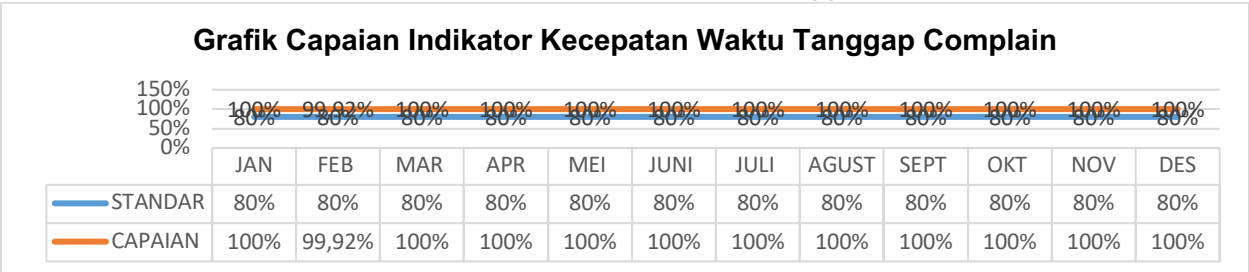
Berdasarkan grafik capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh pada bulan Januari hingga Desember Tahun 2025 capaian belum mencapai standart, oleh karena itu perlu dilakukan PDSA dengan langkah-langkah sebagai berikut :

PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh hingga mencapai standart 100%				
DO	Meningkatkan KIE kepada pasien dan keluarga tentang kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh				
STUDY	Berdasarkan capaian diatas, dapat diketahui bahwa prosentase kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh pada bulan Januari tahun 2025 belum mencapai standart dengan capaian yaitu 99,75%, capaian di bulan Februari yaitu 98,64%, capaian di bulan Maret yaitu 99,1%, capaian di bulan April yaitu 99,44%, capaian di bulan Mei yaitu 97.65%, capaian di bulan Juni adalah 99,09%, capaian di bulan Juli adalah 96,33% dan capaian di bulan Agustus yaitu 95,04%, September 93,45%, Oktober 89,47%, November 96,68% dan Desember 94,62% dengan rata-rata 96,61%. Kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh belum mencapai standart karena masih ditemukan tempat tidur pasien yang tidak terpasang handrell pada pasien rawat inap. Perawat telah memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga pasien agar selalu memasang handrell tetapi seringkali keluarga pasien tidak memasang kembali handrell ketika pasien telah dari kamar mandi. Temuan pada unit IGD yaitu kurangnya kepedualian petugas dalam upaya pencegahan risiko jatuh, hal ini diketahui dari ditemukannya pasien IGD dengan tempat tidur yang tidak terpasang handrel dan tanda risiko jatuh yang tidak diberikan pada tempat tidur pasien. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi petugas yang masih rendah dalam menjalankan prosedur keselamatan pasien secara konsisten.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
kkk) Meningkatkan capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh	III) Meningkatkan capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh	mmm) Capaian indikator kepatuhan terhadap upaya pencegahan resiko jatuh bisa mencapai 100%.	nnn) Melakukan supervisi berjenjang mulai dari PJ shift, kepala ruangan, kepala bidang keperawatan dan tim mutu guna memastikan perawat ruangan telah melakukan KIE kepada pasien dan keluarga tentang upaya pencegahan resiko jatuh harus lebih ditekankan dan disertai tanda tangan sebagai bukti bahwa edukasi telah dilakukan. ooo) Memberikan teguran langsung kepada petugas yang tidak melakukan upaya pencegahan resiko jatuh ppp) Meningkatkan pengetahuan perawat mengenai SPO pencegahan resiko jatuh dengan cara melakukan sosialisasi kembali	Perawat instalasi rawat inap	qqq) Satu Bulan

			dan pengajuan diklat sasaran keselamatan pasien.		
--	--	--	--	--	--

3.5.1.12 Kecepatan Waktu Tanggap Komplain

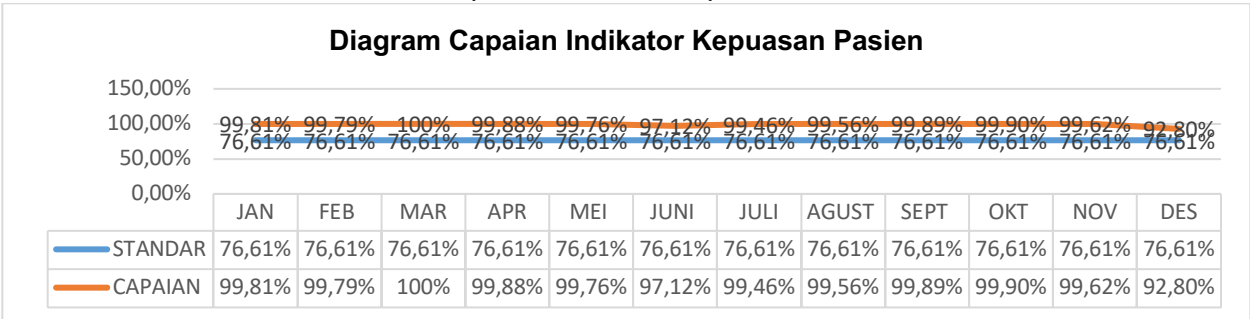
Grafik Capaian Indikator Kecepatan Waktu Tanggap Komplain



Dari grafik indikator waktu tanggap kompalian bulan Januari hingga Desember tahun 2025 diketahui capaian telah mencapai standart lebih dari 80% dengan rata-rata 99,99%, hal ini berkat kerjasama yang baik antara PIPP dan juga manajemen Rumah Sakit Prima Husada Malang yang telah bersinergi untuk segera menanggapi dan melakukan tindak lanjut terkait komplain yang diterima. Upaya lain yang telah dilakukan adalah mekanisme pelaporan yang mudah bisa langsung melalui PIPP, bisa melalui tlp, WA dan formulir online. Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan di bulan berikutnya. Adanya staf yang terlatih khusus dalam manajemen komplain dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik juga menjadi salah satu upaya yang dilakukan supaya indikator kecepatan waktu tanggap complain dapat tercapai.

3.5.1.13 Kepuasan Pasien

Grafik Capaian Indikator Kepuasan Pasien



Dari grafik indikator kepuasan pasien bulan Januari hingga Desember tahun 2025 diketahui capaian telah mencapai standart lebih dari 76,61% dengan rata-rata 98,97%, meskipun belum mencapai nilai sempurna 100% tetapi capaian ini telah melebihi standart. Hal ini karena kerjasama yang baik antara seluruh karyawan Rumah Sakit Prima Husada Malang dan juga manajemen Rumah Sakit Prima Husada Malang yang telah bersinergi untuk berfokus pada kualitas pelayanan secara keseluruhan. Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan di tahun berikutnya.

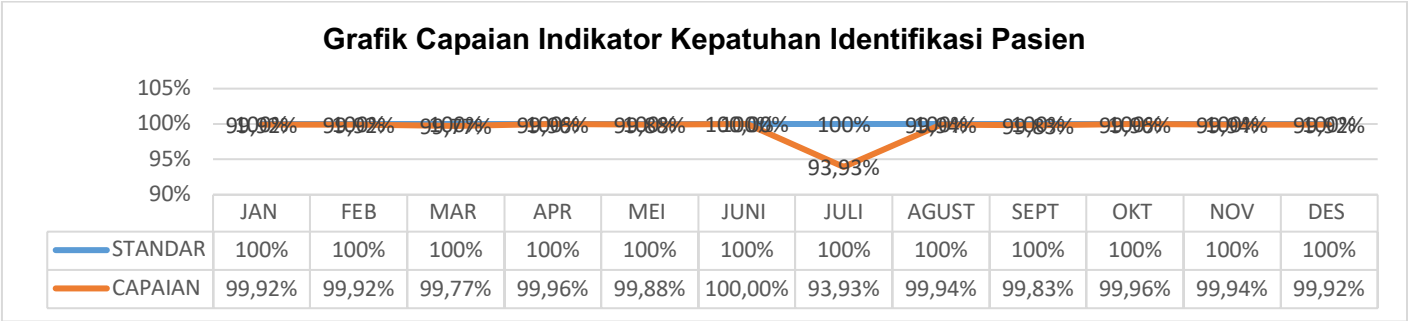
3.5.2 Mutu prioritas Rumah Sakit
A. Mutu Sasaran keselamatan Pasien /SKP

NO	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agust '25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	99,55%	99,92%	99,77%	99,96%	99,88%	100%	93,93%	99,94%	99,83%	99,96%	99,94%	99,92%	99,34%
2.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis (IRNA,IRJA, IGD,IKO)	100%	99,55%	99,92%	99,73%	99,51%	99,33%	99,93%	99,37%	99,41%	99,46%	99,36%	100%	99,96%	99,6%
3.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi (IRNA,IGD,IKO)	100%	100%	100%	100%	100%	90,86%	100%	100%	100%	100%	98,62%	99,12%	99,93%	98,96%
4.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%	91,38%	98,85%	100%	100%	100%	100%	100%	95,96%	99,11%
5.	Kejadian Ketidaklengkapan Lembar Operan Pasien (IRNA,IRJA, IGD,IKO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Angka Kelengkapan Penyiapan Dan Pengelolaan Obat Yang Perlu di Waspadai / High Alert (Farmasi)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.	Kepatuhan penyiapan, pengelolaan, pemberian sesuai standar obat elektrolit pekat (Farmasi)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8.	Kepatuhan Penandaan Lokasi Operasi Sesuai Prosedur (IGD,IRNA,IKO)	100%	100%	100%	99,57%	99,77%	90,41%	97,63%	98,22%	98,48%	98,52%	98,62%	98,86%	99,53%	98,1%

9.	Kepatuhan Pengisian Daftar Tilik Keselamatan Pasien Operasi (IKO)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10.	Angka Kelengkapan Penilaian Risiko Jatuh (Awal, Ulang, Lanjutan) (IRNA,IRJA,IGD,IKO)	100%	98,64%	98,64%	99,32%	99,63%	98,74%	99,31%	99,48%	98,71%	98,79%	99,93%	100%	99,78%	99,2%
11.	Kepatuhan upaya pencegahan risiko jatuh	100%	98,64%	98,65%	98%	99,44%	97,65%	98,48%	96,33%	95,04%	95,21%	89,47%	96,68%	94,62%	96,8%
12.	Angka Kepatuhan kebersihan tangan	85%	85,21%	85,35%	85,32%	85,36%	85,49%	85,21%	85,25%	85,38%	85,42%	85,32%	85,57%	85,61%	85,36%

1 Kepatuhan Identifikasi Pasien

Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Identifikasi Pasien

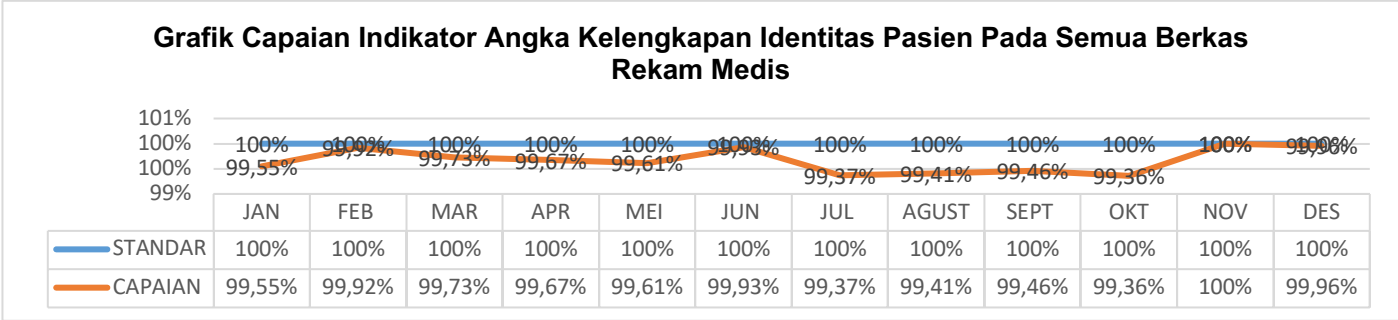


Berdasarkan grafik capaian indikator kepatuhan identifikasi pasien pada bulan Januari hingga Mei Tahun 2025 capaian belum mencapai standart, pada bulan Juni tahun 2025 capaian telah meningkat menjadi 100%,namun kembali menurun di bulan Juli yaitu 93,93%, bulan Agustus yaitu 99,94%, bulan September yaitu 99,83%, bulan Oktober yaitu 99,96%, bulan November 99,94% dan Desember 99,92% dengan rata rata bulan Januari hingga Desember 99,38%.

PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka keatuhan identifikasi pasien semaksimal mungkin (100%).				
DO	rrr) Melakukan supervisi pada petugas di unit secara berkelanjutan sss) Kepala Instalasi untuk terus melaksanakan supervisi dan sosialisasi terkait identifikasi pasien ttt) Memberikan teguran kepada petugas yang tidak melakukan identifikasi pasien atau melakukan identifikasi tetapi masih salah				
STUDY	Berdasarkan grafik capaian indikator kepatuhan identifikasi pasien pada bulan Januari hingga Mei Tahun 2025 capaian belum mencapai standart, pada bulan Juni tahun 2025 capaian telah meningkat menjadi 100%,namun kembali menurun di bulan Juli yaitu 93,93%, bulan Agustus yaitu 99,94%, bulan September yaitu 99,83%, bulan Oktober yaitu 99,96%, bulan November 99,94% dan Desember 99,92% dengan rata rata bulan Januari hingga Desember 99,38%. Dari temuan dilapangan diketahui bahwa DPJP seringkali tidak melakukan identifikasi pasien ketika melakukan visite karena sudah didampingi oleh perawat. Supervisi secara berkelanjutan serta memberikan teguran secara langsung cukup efektif untuk meningkatkan kepatuhan identifikasi pasien.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Mempertahankan kepatuhan identifikasi pasien	Mempertahankan kepatuhan identifikasi pasien	Tercapainya indikator kepatuhan identifikasi pasien pada bulan berikutnya.	-Terus melakukan supervisi pada petugas unit -Memberikan teguran secara langsung jika menemukan petugas yang tidak melakukan identifikasi pasien dengan tepat. -Perawat diharapkan bisa membantu melakuakn identiifikasi pasien ulang ketika melakukan visite	Seluruh petugas yang melakukan pelayanan di RS.	Satu Bulan

2. Angka Kelengkapan Identitas Pasien Pada Semua Berkas Rekam Medis

Grafik Capaian Indikator Angka Kelengkapan Identitas Pasien Pada Semua Berkas Rekam Medis



Dari grafik indikator angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis pada bulan Januari hingga Desember tahun 2025 belum mencapai standart dengan rata-rata 99,6%. Oleh karena itu perlu dilakukan PDSA dengan langkah-langkah sebagai berikut :

PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka keidentifikasi pasien semaksimal mungkin (100%).				
DO	-Melakukan supervisi pada petugas di unit secara berkelanjutan -Kepala Instalasi untuk terus melaksanakan supervisi dan sosialisasi terkait identifikasi pasien -Memberikan teguran kepada petugas yang tidak melakukan identifikasi pasien atau melakukan identifikasi tetapi masih salah				
STUDY	Berdasarkan hasil capaian di atas, dapat diketahui bahwa capaian kepatuhan identifikasi pasien di RS Prima Husada Malang masih belum mencapai standart dengan capaian bulan Januari tahun 2025 yaitu 99,55%, capaian di bulan Februari yaitu 99,92%, capaian di bulan Maret 99,77%, capaian di bulan April yaitu 99,55%, capaian di bulan Mei yaitu 99,33%, bulan Juni sebesar 99,93%, bulan Juli sebesar 99,37% , bulan Agustus yaitu 99,41%, bulan September yaitu 99,46%, bulan Oktober yaitu 99,36%, November 100% , desember 99,96% dengan rata rata 99,6%				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	Meningkatkan angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	Tercapainya indikator angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	-Melakukan supervisi pada seluruh berkas rkam medis -Memberikan teguran secara langsung jika menemukan petugas yang tidak menuliskan identitas dengan lengkap pada berkas rekam medis Sosialisasi yang berkelanjutan mengenai Standar Prosedur Operasional (SPO) pengisian rekam medis memastikan semua petugas memiliki pengetahuan yang sama dan mutakhir. -Audit internal secara berkala terhadap kelengkapan rekam medis, diikuti dengan evaluasi dan umpan balik yang konstruktif kpada unit terkait. -Adanya sanksi atau teguran yang tegas bagi petugas yang lalai, dan penghargaan bagi yang patuh, dapat meningkatkan motivasi dan disiplin.	-Seluruh petugas IRNA, IGD dan IKO	-Satu Bulan

3. Kepatuhan Pelaksanaan Readback Dalam Komunikasi Via Alat Telekomunikasi

Kepatuhan Pelaksanaan Readback Dalam Komunikasi Via Alat Telekomunikasi



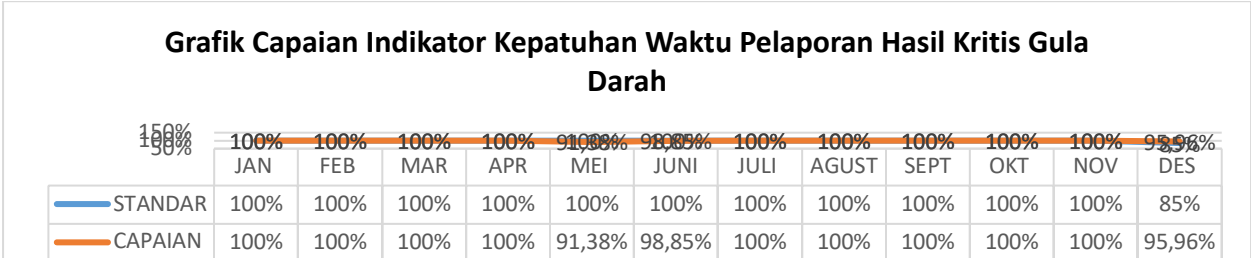
Dari grafik capaian indikator kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat komunikasi dapat diketahui bahwa capaian di bulan Januari hingga April telah mencapai standart. Petugas IRNA, IGD dan IKO telah melaksanakan readback dengan baik. Capaian menurun di bulan Mei yaitu 90,86% namun kembali meningkat pada bulan Juni hingga September menjadi 100%, capaian kembali menurun pada bulan Oktober menjadi 98,62%. Capaian kembali meningkat namun belum mencapai standart di bulan November yaitu 99,12% dan Desember 99,93% dengan rata rata bulan Januari hingga Desember yaitu 99,93%. Berdasarkan hasil supervisi dan observasi petugas tidak melaksanakan readback sesuai SPO. Untuk itu perlu dilakukan PDSA dengan langkah-langkah sebagai berikut

PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat komunikasi semaksimal mungkin (100%).				
DO	uuu) Melakukan supervisi pada petugas di unit secara berkelanjutan vvv) Kepala ruang untuk terus melaksanakan supervisi dan sosialisasi terkait pelaksanaan readback www) Memberikan teguran kepada petugas yang tidak melakukan readback sesuai SPO				
STUDY	Dari grafik capaian indikator kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat komunikasi dapat diketahui bahwa capaian di bulan Januari hingga April telah mencapai standart. Petugas IRNA, IGD dan IKO telah melaksanakan readback dengan baik. Capaian menurun di bulan Mei yaitu 90,86% namun kembali meningkat pada bulan Juni hingga September menjadi 100%, capaian kembali menurun pada bulan Oktober menjadi 98,62%. Capaian kembali meningkat namun belum mencapai standart di bulan November yaitu 99,12% dan Desember 99,93% dengan rata rata bulan Januari hingga Desember yaitu 99,93%. Berdasarkan hasil supervisi dan observasi petugas tidak melaksanakan readback sesuai SPO. Untuk itu perlu dilakukan PDSA dengan langkah-langkah sebagai berikut.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan angka kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat komunikasi	Meningkatkan angka kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat komunikasi	Tercapainya indikator angka kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat komunikasi hingga 100%	-Melakukan supervisi pada petugas di unit secara berkelanjutan -Kepala ruang untuk terus melaksanakan supervisi dan sosialisasi terkait pelaksanaan readback -Memberikan teguran kepada petugas yang tidak melakukan readback sesuai SPO -Seluruh staf, terutama yang terlibat langsung dalam komunikasi kritis (seperti perawat, dokter, dan petugas medis lainnya), menerima pelatihan berkala mengenai SPO tersebut. Pelatihan ini memastikan pemahaman yang seragam dan konsisten	Seluruh petugas IRNA, IGD dan IKO	Satu Bulan

			dalam penerapan teknik <i>readback</i>. -Memberikan dukungan penuh dari manajemen puncak dan kepala departemen dalam menegakkan kebijakan dan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai standar mutu.		
--	--	--	--	--	--

4. Kepatuhan Waktu Pelaporan Hasil Kritis Gula Darah

Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Waktu Pelaporan Hasil Kritis Gula Darah



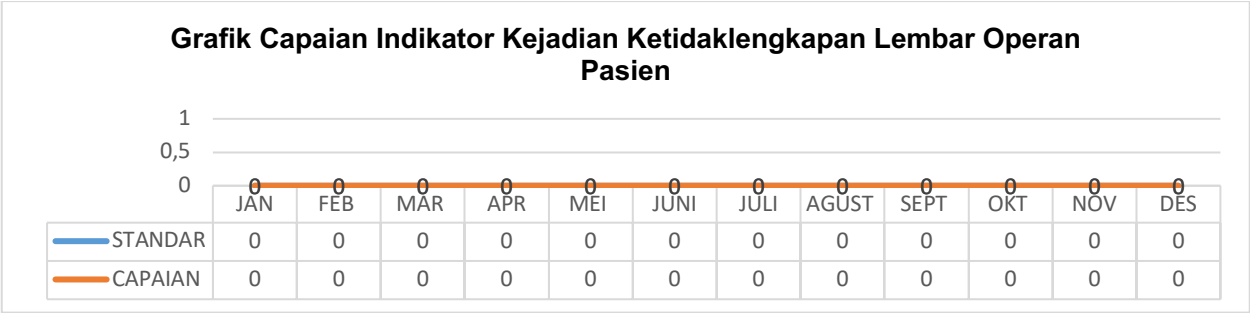
Dari grafik capaian indikator waktu pelaporan hasil kritis gula darah dapat diketahui bahwa capaian telah mencapai standart dibulan Januari hingga April, capaian menurun dibulan Mei yaitu 91,38%, bulan Juni 98,85% dan bulan Juli hingga November menjadi 100%. Capaian kembali menurun di bulan Mei dan Juni, kemabali meningkat di bulan Juli hingga November dan kembali menurun di bulan Desember. Berdasarkan observasi yang dilakukan, penurunan capaian terjadi karena perawat seringkali tidak melaporkan nilai kritis gula darah kepada petuga laborat, nilai kkritis ahanya dilaporkan kepada DPJP saja. Untuk itu perlu dilakukan PDSA dengan langkah-langkah sebagai berikut :

PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah semaksimal mungkin (100%).				
DO	-Melakukan supervisi pada petugas di unit secara berkelanjutan -Kepala ruang bertanggung jawab untuk terus melaksanakan supervisi dan sosialisasi terkait pelaksanaan kepatuhan pelaporan gula darah -Memberikan teguran kepada petugas yang tidak melakukan readback sesuai SPO				
STUDY	Dari grafik capaian indikator waktu pelaporan hasil kritis gula darah dapat diketahui bahwa capaian telah mencapai standart dibulan Januari hingga April, capaian menurun dibulan Mei yaitu 91,38%, bulan Juni 98,85% dan bulan Juli hingga November menjadi 100%. Capaian kembali menurun di bulan Mei dan Juni, kemabali meningkat di bulan Juli hingga November dan kembali menurun di bulan Desember. Berdasarkan observasi yang dilakukan, penurunan capaian terjadi karena perawat seringkali tidak melaporkan nilai kritis gula darah kepada petuga laborat, nilai kkritis ahanya dilaporkan kepada DPJP saja. Untuk itu perlu dilakukan PDSA dengan langkah-langkah sebagai berikut.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU

xxx) Meningkatkan angka kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	Meningkatkan angka kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	- Tercapainya indikator angka kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah hingga 100%.	-Melakukan supervisi pada petugas di unit secara berkelanjutan -Kepala ruang bertanggung jawab untuk terus melaksanakan supervisi dan sosialisasi terkait pelaksanaan kepatuhan pelaporan gula darah -Memberikan teguran kepada petugas yang tidak melakukan readback sesuai SPO -Melakukan pelaporan dicatat secara rapi dan sistematis dalam rekam medis, mencakup waktu penyerahan hasil dan nama penerima laporan, yang berfungsi sebagai bukti kepatuhan terhadap standar mutu. -Adanya Standar Prosedur Operasional (SPO) yang Jelas : Terdapat SPO tertulis yang mengatur secara rinci alur pelaporan hasil kritis, mulai dari identifikasi hasil kritis oleh petugas laboratorium, metode komunikasi (telepon atau lisan dengan teknik read-back/TBaK), hingga pendokumentasian di rekam medis. -Komunikasi Efektif: Penggunaan metode komunikasi yang efektif dan cepat (seperti telepon atau pager alfanumerik) dengan konfirmasi baca balik (TBaK - Tulis, Baca Kembali, Konfirmasi) untuk memastikan informasi diterima dengan benar oleh dokter yang merawat.	Seluruh petugas IRNA, IGD dan IKO	Satu Bulan
---	--	--	--	-----------------------------------	------------

5. Kejadian Ketidaklengkapan Lembar Operan Pasien

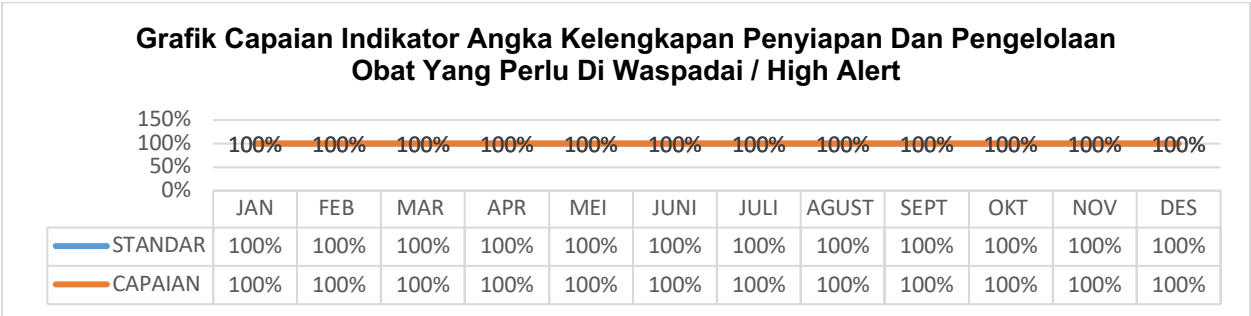
Grafik Capaian Indikator Kejadian Ketidaklengkapan Lembar Operan Pasien



Berdasarkan grafik capaian indikator kejadian ketidaklengkapan lembar operan pasien dapat diketahui bahwa pada bulan Januari hingga Desember tahun 2025 telah mencapai standart, artinya lembar operan pasien telah terisi dengan lengkap. Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan di bulan selanjutnya.

6. Angka Kelengkapan Penyiapan Dan Pengelolaan Obat Yang Perlu Di Waspadai / High Alert

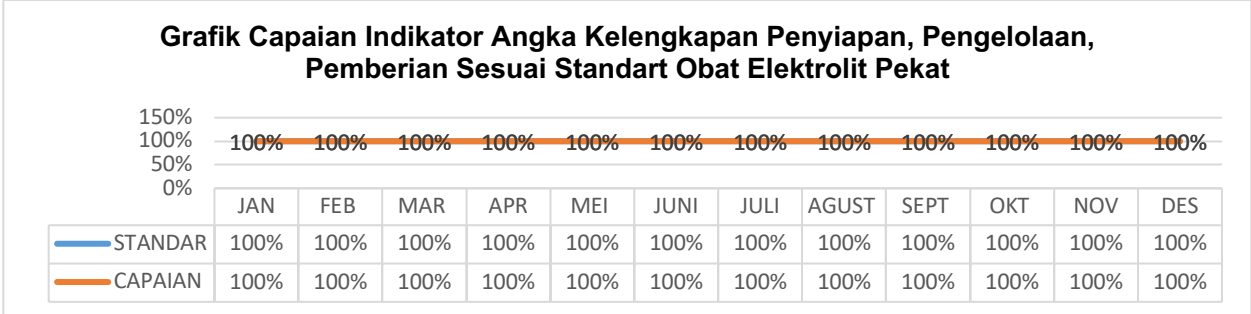
Grafik Capaian Indikator Angka Kelengkapan Penyiapan Dan Pengelolaan Obat Yang Perlu Di Waspadai



Berdasarkan grafik capaian indikator angka kelengkapan penyiapan dan pengeloaan obat yang perlu diwaspadai pada bulan Januari hingga Desember tahun 2025 telah mencapai standart. Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan di tahun 2026.

7. Kepatuhan Penyiapan, Pengelolaan, Pemberian Sesuai Standart Obat Elektrolit Pekat

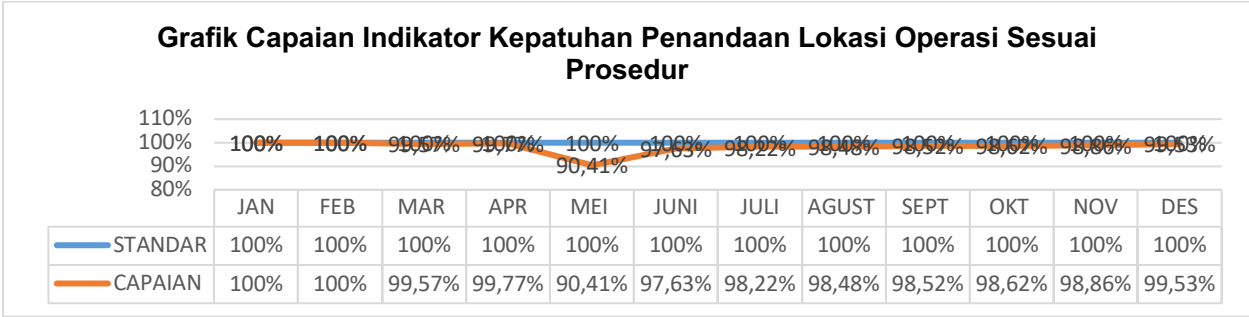
Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Penyiapan, Pengelolaan, Pemberian Sesuai Standart Obat Elektrolit Pekat



Berdasarkan grafik capaian indikator angka kelengkapan penyiapan, pengelolaan, pemberian sesuai strandart obat elektolit pekat pada bulan Januari hingga Desember tahun 2025 telah mencapai standart. Capaian ini dihrapkan dapat dipertahankan di tahun 2026.

8. Kepatuhan Penandaan Lokasi Operasi Sesuai Prosedur

Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Penandaan Lokasi Operasi Sesuai Prosedur



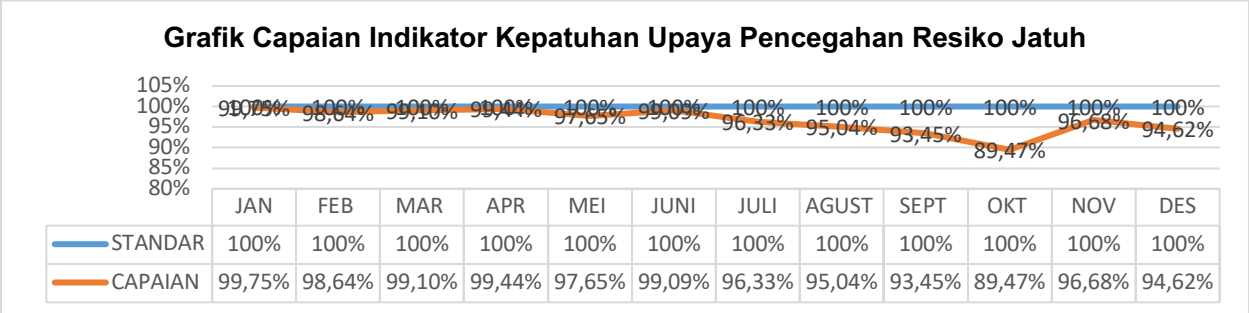
Dari grafik indikator kepatuhan penandaan lokasi operasi sesuai prosedur dapat diketahui bahwa capaian di bulan Januari hingga Desember tahun 2025 belum mencapai standart dengan rata-rata 98,1%. Oleh karena itu perlu dilakukan PDSA dengan langkah-langkah sebagai berikut :

PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan capaian indkator kepatuhan penandaan Lokasi operasi sesuai prosedur hingga mencapai standart maksimal (100%).				
DO	-Melakukan supervisi pada petugas di unit secara berkelanjutan -Kepala ruang melakukan supervisi terkait kepatuhan penandaan Lokasi operasi.				
STUDY	Berdasarkan grafik indikator kepatuhan penandaan lokasi operasi sesuai prosedur dapat diketahui bahwa capaian di bulan Januari hingga Desember tahun 2025 belum mencapai standart dengan rata-rata 98,1%.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan caaian indkator kepatuhan penandaan Lokasi operasi sesuai prosedur hingga mencapai standart maksimal (100%).	Meningkatkan angka capaian indkator kepatuhan penandaan Lokasi operasi sesuai prosedur hingga mencapai standart maksimal (100%).	Tercapainya capaian indkator kepatuhan penandaan Lokasi operasi sesuai prosedur	- Melakukan supervisi pada petugas di unit secara berkelanjutan -Kepala ruang melakukan supervisi terkait kepatuhan penandaan Lokasi operasi. -Monitoring dan Evaluasi Intensif: Adanya sistem pemantauan dan evaluasi rutin oleh tim mutu atau komite keselamatan pasien (TKPRS) untuk memastikan kepatuhan terhadap SPO. Hasil evaluasi digunakan untuk mengidentifikasi area yang perlu perbaikan -Sumber Daya yang Adekuat: Ketersediaan sarana pendukung seperti spidol bedah (surgical skin marker) yang sesuai standar sangat penting. Kekurangan sumber daya dapat menjadi penghalang dalam mencapai	Seluruh petugas IRNA, IGD dan IKO	Satu Bulan

	meningkat Di bulan November menjadi 100% dan kembali menurun di bulan Desember menjadi 99,78% dengan rata-rata bulan Januari hingga Desember yaitu 99,2%.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan capaian angka kelengkapan penilaian risiko jatuh	Meningkatkan capaian angka kelengkapan penilaian risiko jatuh	Capaian indikator angka kelengkapan penilaian risiko jatuh bisa mencapai 100%.	-Pelatihan yang Efektif: Staf perawat telah menerima pelatihan yang tepat dan memahami materi mengenai pentingnya penilaian risiko jatuh, penggunaan instrumen penilaian yang benar (misalnya, Skala Jatuh Morse atau Skala Humpty Dumpty untuk anak-anak), serta Standar Prosedur Operasional (SPO) terkait. -Pemahaman Pentingnya <i>Patient Safety</i> : Adanya kesadaran dan pemahaman yang tinggi di antara staf bahwa penilaian risiko jatuh adalah bagian fundamental dari keselamatan pasien dan dapat mengurangi kejadian yang tidak diharapkan serta potensi cede	Perawat IRNA, IRJA, IGD, IKO	Satu Bulan

11. Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Jatuh

Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Jatuh



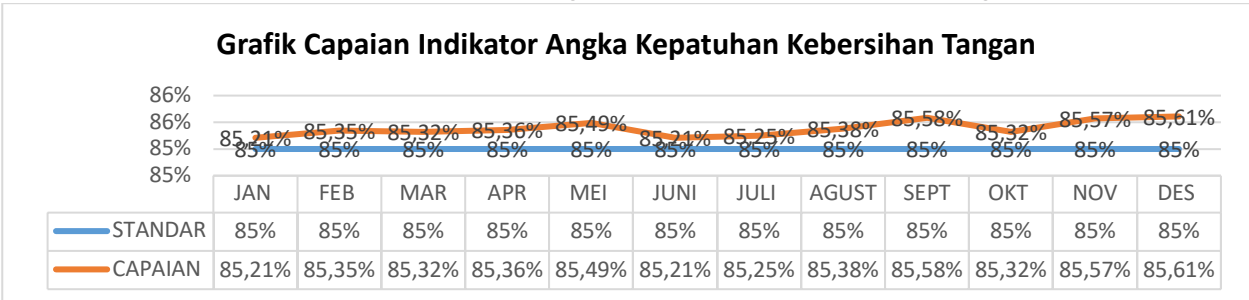
Berdasarkan grafik capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh pada bulan Januari hingga Desember Tahun 2025 capaian belum mencapai standart, oleh karena itu perlu dilakukan PDSA dengan langkah-langkah sebagai berikut :

PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh hingga mencapai standart 100%
DO	Meningkatkan KIE kepada pasien dan keluarga tentang kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh

STUDY	Berdasarkan capaian diatas, dapat diketahui bahwa prosentase kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh pada bulan Januari tahun 2025 belum mencapai standart dengan capaian yaitu 99,75%, capaian di bulan Februari yaitu 98,64%, capaian di bulan Maret yaitu 99,1%, capaian di bulan April yaitu 99,44%, capaian di bulan Mei yaitu 97.65%, capaian di bulan Juni adalah 99,09%, capaian di bulan Juli adalah 96,33% dan capaian di bulan Agustus yaitu 95,04%, September 93,45%, Oktober 89,47%, November 96,68% dan Desember 94,62% dengan rata-rata 96,61%. Kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh belum mencapai standart karena masih ditemukan tempat tidur pasien yang tidak terpasang handrell pada pasien rawat inap. Perawat telah memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga pasien agar selalu memasang handrell tetapi seringkali keluarga pasien tidak memasang kembali handrell ketika pasien telah dari kamar mandi. Temuan pada unit IGD yaitu kurangnya kepedualian petugas dalam upaya pencegahan risiko jatuh, hal ini diketahui dari ditemukannya pasien IGD dengan tempat tidur yang tidak terpasang handrel dan tanda risiko jatuh yang tidak diberikan pada tempat tidur pasien. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi petugas yang masih rendah dalam menjalankan prosedur keselamatan pasien secara konsisten.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh	Meningkatkan capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh	Capaian indikator kepatuhan terhadap upaya pencegahan resiko jatuh bisa mencapai 100%.	-Melakukan supervisi berjenjang mulai dari PJ shift, kepala ruangan, kepala bidang keperawatan dan tim mutu guna memastikan perawat ruangan telah melakukan KIE kepada pasien dan keluarga tentang upaya pencegahan resiko jatuh harus lebih ditekankan dan disertai tanda tangan sebagai bukti bahwa edukasi telah dilakukan. -Memberikan teguran langsung kepada petugas yang tidak melakukan upaya pencegahan risiko jatuh -Meningkatkan pengetahuan perawat mengenai SPO pencegahan risiko jatuh dengan cara melakukan sosialisasi kembali dan pengajuan diklat sasaran keselamatan pasien.	Perawat instalasi rawat inap	Satu Bulan

12. Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan

Grafik Capaian Indikator Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan



Dari grafik indikator angka keptuhan kebersihan tangan bulan Januari tahun 2025 diketahui bahwa capaian telah mencapai standart yaitu 85,21% dan pada bulan Februari capaian meningkat menjadi 85,35%, capian di bulan Maret yaitu 85,32%, capaian di bulan April yaitu 85,36%, capaian di bulan Mei 85,49%, capaian di bulan Juni adalah 85,21%, capaian di bulan Juli adalah 85,25%, Agustus sebesar 85,38%, September sebesar 85,58, Oktober 85,32%, November 85,57% dan Desember 85,61% dengan rata rata bulan Januari hingga Desember yaitu 85,39%. Meskipun belum mencapai 100% tetapi nilai tersebut telah mencapai standart. Petugas masih dengan anggapan bahwa tangannya dalam kondisi masih bersih dan terkadang karena kondisi harus segera dilakukan tindakan pada pasien jadi lupa tidak melakukan cuci tangan karena memang belum terbiasa. Di harapkan capaian ini dapat ditingkatkan di bulan berikutnya.

PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka kepatuhan kebersihan tangan semaksimal mungkin hingga 100%.					
DO	-Lakukan audit kepatuhan kebersihan tangan secara rutin. -Anjurkan IPCLN untuk membuat video edukasi terkait cuci tangan sebagai media sosialisasi. -Berikan reward pada unit yang prosentase cuci tangannya baik. -Lakukan control monitoring fasilitas kebersihan tangan di unit pelayanan. -Berikan proses pembelajaran pada petugas yang belum paham atau tidak menjalankan kebersihan tangan dengan baik.					
STUDY	Dari grafik indikator angka keptuhan kebersihan tangan bulan Januari tahun 2025 diketahui bahwa capaian telah mencapai standart yaitu 85,21% dan pada bulan Februari capaian meningkat menjadi 85,35%, capian di bulan Maret yaitu 85,32%, capaian di bulan April yaitu 85,36%, capaian di bulan Mei 85,49%, capaian di bulan Juni adalah 85,21%, capaian di bulan Juli adalah 85,25%, Agustus sebesar 85,38%, September sebesar 85,58, Oktober 85,32%, November 85,57% dan Desember 85,61% dengan rata rata bulan Januari hingga Desember yaitu 85,39%. Meskipun belum mencapai 100% tetapi nilai tersebut telah mencapai standart. Petugas masih dengan anggapan bahwa tangannya dalam kondisi masih bersih dan terkadang karena kondisi harus segera dilakukan tindakan pada pasien jadi lupa tidak melakukan cuci tangan karena memang belum terbiasa. Di harapkan capaian ini dapat ditingkatkan di bulan berikutnya.					
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		PELAKSANA	WAKTU

Meningkatkan kebersihan tangan.	Meningkatkan kepatuhan kebersihan tangan.	Seluruh petugas pelayanan pasien	-Lakukan audit kepatuhan kebersihan tangan secara rutin. -Anjurkan IPCLN untuk membuat video edukasi terkait cuci tangan sebagai media sosialisasi. -Berikan reward pada unit yang prosentase cuci tangannya baik. -Lakukan control monitoring fasilitas kebersihan tangan di unit pelayanan. -Berikan proses pembelajaran pada petugas yang belum paham atau tidak menjalankan kebersihan tangan dengan baik.	-Perawat /Bidan -Dokter -Karu IPCLN/IPCN	Satu bulan
---------------------------------	---	----------------------------------	--	--	------------

B. Mutu Pelayanan Klinis Prioritas

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agust '25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Ketepatan Indikasi dan Pelaksanaan Operasi Apendicitis akut	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100%	100%	100%	100%
2.	Ketepatan Indikasi dan Pelaksanaan Operasi STT	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100%	100%	100%	100%

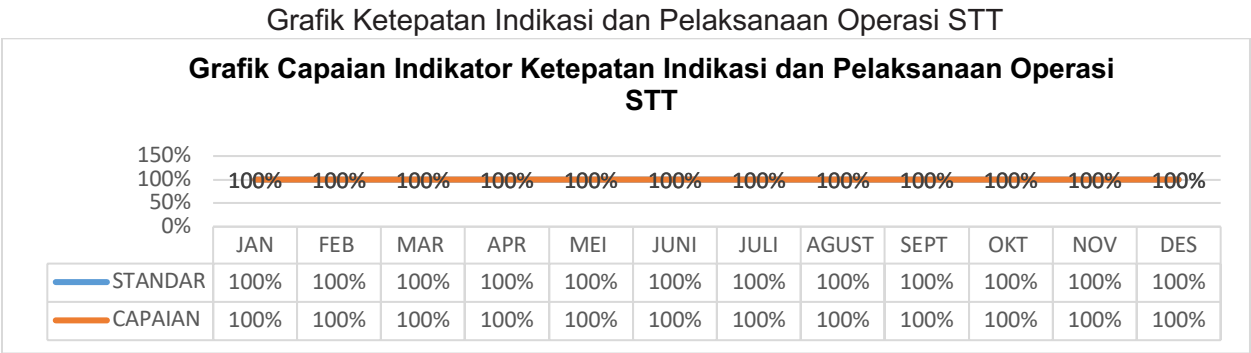
1. Ketepatan Indikasi dan Pelaksanaan Operasi Apendicitis Akut

Grafik Ketepatan Indikasi dan Pelaksanaan Operasi Apendicitis Akut



Berdasarkan grafik capaian indikator ketepatan indikasi dan pelaksanaan operasi apendicitis akut pada Januari hingga Desember tahun 2025 talah mencapai standart. Tidak ada kejadian yang menunjukkan ketidaktepatan indikasi ataupun pelaksanaan operasi

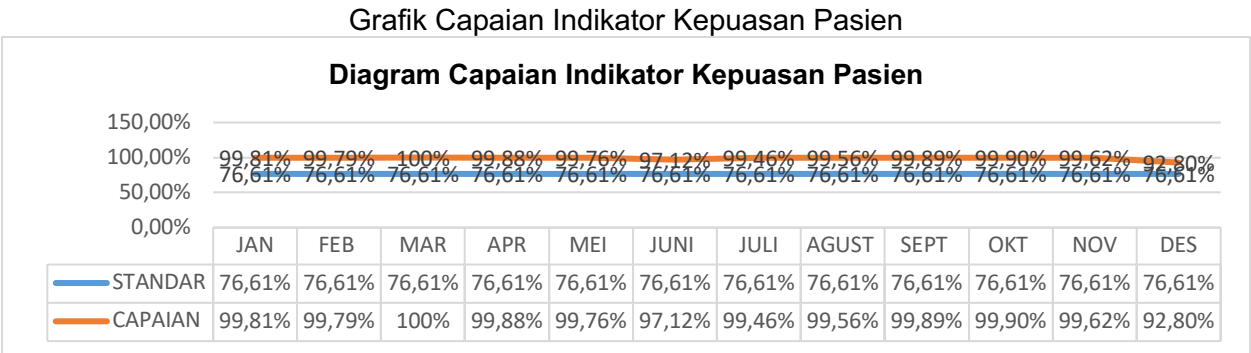
2. Ketepatan Indikasi dan Pelaksanaan Operasi STT



Berdasarkan grafik capaian indikator ketepatan indikasi dan pelaksanaan operasi STT akut pada Januari hingga Desember tahun 2025 telah mencapai standart. Semua pasien yang dilakukan appendektomi sudah melalui prosedur diagnostik sesuai standar (misal: pemeriksaan fisik, USG/CT-Scan bila diperlukan, dan penilaian klinis). Tidak ditemukan operasi yang dilakukan tanpa indikasi jelas.

C. Mutu Terkait Tujuan Strategis Rumah Sakit .

NO	JUDUL	STA ND	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Juli '25	Agust '25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Kepuasan Pasien	≥ 76,6 1	99,8 1%	99,7 9%	100 %	99,9 8%	99,7 6%	97,1 2%	99,46 %	99,56 %	99,89 %	99,9%	99,62 %	92,80 %	98,97%

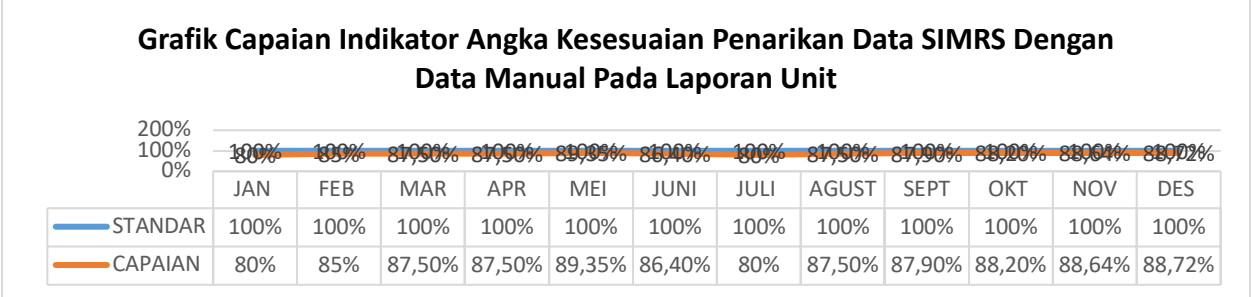


Dari grafik indikator kepuasan pasien bulan Januari hingga Desember tahun 2025 diketahui capaian telah mencapai standart lebih dari 76,61% dengan rata-rata 98,97%, meskipun belum mencapai nilai sempurna 100% tetapi capaian ini telah melebihi standart. Hal ini karena kerjasama yang baik antara seluruh karyawan Rumah Sakit Prima Husada Malang dan juga manajemen Rumah Sakit Prima Husada Malang yang telah bersinergi untuk berfokus pada kualitas pelayanan secara keseluruhan. Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan di tahun berikutnya

D. Mutu Terkait Perbaikan Sistem

No	Judul	Stan d	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agu st '25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata - Rata
1.	Kesesuaiaan Penarikan Data SIMRS Dengan Data Manual Pada Laporan Unit	100 %	80%	85%	87,5 %	87,5 %	89,3 5%	86,4 %	80%	87,5 %	87,9 %	88,2 %	88,6 4%	88,7 2%	86,4 %

Grafik Capaian Indikator Kesesuaian Penarikan Data SIMRS Dengan Data Manual Pada Laporan Unit



Dari grafik indikator kesesuaian data SIMRS dengan data manual pada laporan unit belum mencapai standart dengan rata-rata 86,4%. perbedaan data ini disebabkan karena masih terjadinya penginputan data yang tidak sesuai SPO sehingga data yang diperoleh tidak akurat. Di harapkan capaian ini dapat ditingkatkan di bulan berikutnya.

PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan indikator kesesuaian data SIMRS dengan data manual pada laporan unit hingga mencapai standart 100%. Supervisi penginputan data setiap hari terus dilakukan dan mengingatkan penanggungjawab mutu unit melalui grup WA.				
DO	-Supervisi penginputan data melalui monitoring laporan data mutu pad SIMRS -Mengingatkan penanggungjawab mutu unit melalui grup WA komite mutu				
STUDY	Dari grafik indikator kesesuaian data SIMRS dengan data manual pada laporan unit belum mencapai standart dengan rata-rata 86,4%. perbedaan data ini disebabkan karena masih terjadinya penginputan data yang tidak sesuai SPO sehingga data yang diperoleh tidak akurat. Di harapkan capaian ini dapat ditingkatkan di bulan berikutnya dengan cara supervisi penginputan data melalui monitoring laporan data mutu pada SIMRS dan juga mengingatkan penanggungjawab mutu unit melalui grup WA komite mutu.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan indikator kesesuaian data SIMRS dengan data manual pada laporan unit	Meningkatkan indikator kesesuaian data SIMRS dengan data manual pada laporan unit	-Kepala ruang - Penanggungjawab mutu	-Supervisi penginputan data melalui monitoring laporan data mutu pad SIMRS -Mengingatkan penanggungjawab mutu unit melalui grup WA komite mutu -Sistem Terintegrasi Penuh: SIMRS yang digunakan mungkin sudah terintegrasi penuh, di mana setiap input data manual di tingkat unit secara otomatis dan <i>real-time</i> masuk ke dalam database SIMRS. Ini menghilangkan kebutuhan untuk entri data ganda yang sering menjadi sumber kesalahan. -Budaya Kerja Positif: Lingkungan kerja yang mendorong kolaborasi dan akuntabilitas, di	-Kepala ruang - Penanggungjawab mutu	-Satu bulan

			mana kesalahan input data dianggap serius dan ditangani dengan perbaikan proses, bukan sekedar menyalahkan individu.		
--	--	--	--	--	--

E. Mutu Terkait Manajemen Risiko
3.5.3. Mutu Prioritas Internal Unit
3.5.3.1 Capaian Indikator Mutu Unit IGD

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agust '25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25
1.	Batas waktu pasien menunggu tempat tidur kurang dari 6 jam (Mutu Prioritas Unit)	100%	100%	100%	99,71%	99,7%	97,2%	99,48%	98,79%	98,2%	98,32%	99,9%	99,26%	88,44%%
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	98,2%	98,36%	98,37%	98,44%	98,72%	96,03%	95,23%	95,44%	95,68%	94,24%	94,41%	96,2%
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Waktu tanggap operasi seksio sesarea emergensi	≥ 80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.	Kepuasan pasien	85%	97,36%	97,29%	100%	98,2%	98,92%	98,45%	98,92%	98,82%	98,84%	98,9%	98,94%	99,2%
8.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10.	Kepatuhan pelaporan pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12.	Angka kelengkapan pengkajian awal medis di IGD	100%	100%	100%	100%	95,43%	92,7%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13.	Angka tindak lanjut screening nyeri pasien di IGD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

14.	Angka kepatuhan triage untuk penyakit menular di IGD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15.	Respon time IGD kurang dari 5 menit	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	4,65%	3,7%	2,38%	1,9%	1,67%	5,43%	1,96%	1,72%	1,52%	1,87%	2,02%	2,02%
17.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
18.	Kepatuhan pemasangan gelang identitas pasien kurang dari 30 menit setelah pasien terdaftar rawat inap	100%	73,21%	73,32%	75,11%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
19.	Kejadian merujuk pasien berdasarkan aspek pilihan pasien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
21.	Angka kelengkapan pengkajian populasi khusus (koma, gaduh gelisah, geriatric, menular, anak, remaja, risiko bunuh diri)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
22.	Angka kelengkapan komunikasi serah terima pasien (SBAR)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
23.	Kegiatan merujuk pasien (horizontal)	0	1	4	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0

Secara keseluruhan, **capaian indikator mutu Unit IGD menunjukkan hasil yang sangat baik dan stabil sepanjang tahun 2025**. Mayoritas indikator berhasil mencapai atau bahkan melampaui standar yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan pelaksanaan pelayanan gawat darurat yang sudah berjalan sesuai standar keselamatan pasien dan prosedur operasional.

Beberapa poin penting dari hasil capaian tersebut antara lain:

-
1. **Indikator pelayanan pasien emergensi dan non-emergensi** (seperti waktu tunggu pasien <5 menit untuk kasus gawat darurat dan <60 menit untuk non-emergensi) menunjukkan capaian **sangat tinggi dan konsisten di kisaran 98–100%**. Hal ini menggambarkan kecepatan serta ketepatan pelayanan tenaga medis IGD dalam menangani pasien.
 2. **Indikator keselamatan pasien dan pencegahan infeksi**, seperti **kepatuhan hand hygiene, penggunaan APD, dan identifikasi pasien**, juga mencapai **hasil optimal** dengan capaian di atas standar minimal. Hanya terdapat sedikit fluktuasi pada bulan Maret dan Juni yang kemungkinan disebabkan oleh beban kerja meningkat atau rotasi tenaga baru.
 3. **Indikator tanpa kejadian**, seperti **pasien jatuh, KTD, dan sentinel event**, menunjukkan **hasil nol (0%)** sepanjang tahun, menandakan pengawasan terhadap risiko keselamatan pasien berjalan sangat baik.
 4. **Kepatuhan terhadap aspek administrasi dan dokumentasi** (misalnya informed consent, form identifikasi, label obat high alert, dan pemasangan gelang pasien) juga tercapai 100% hampir setiap bulan. Ini menunjukkan komitmen tenaga IGD terhadap tata kelola dan tertib dokumentasi pelayanan.

Indikator yang masih perlu perhatian antara lain:

1. **Kebersihan lingkungan IGD**, yang memiliki capaian sangat rendah (1–5%). Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan pengawasan terhadap kebersihan area kerja dan sistem audit lingkungan.
2. **Ketepatan pelaporan hasil laboratorium ≤ 2 jam**, yang pada awal tahun sempat berada di bawah standar (sekitar 73%) sebelum akhirnya membaik di bulan-bulan berikutnya.
3. **Kejadian gugus insiden horizontal**, masih muncul beberapa kali (hingga 4 kasus) pada awal pertengahan tahun, menunjukkan adanya potensi masalah komunikasi atau tekanan kerja antarstaf.

Secara umum, **kinerja mutu Unit IGD dapat dikategorikan sangat baik** karena hampir seluruh indikator mencapai standar nasional. Namun, peningkatan berkelanjutan tetap diperlukan terutama pada aspek **kebersihan lingkungan, ketepatan pelaporan hasil laboratorium, dan hubungan kerja antarstaf** agar mutu pelayanan tetap optimal dan risiko keselamatan pasien bisa terus ditekan.

3.5.3.2 Capaian Indikator Mutu Unit IRNA 2A

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25
1.	Dilaksanakannya edukasi dan orientasi pada pasien dan keluarga (Mutu Prioritas Unit)	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	yyy)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Kepatuhan terhadap alur klinis (Clinical Pathway)	≥ 80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Angka kelengkapan penilaian risiko jatuh (awal, ulang, lanjutan)	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Kepuasan pasien	85%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

15.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	Angka efektivitas discharge planning	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	Kelengkapan pengisian edukasi pasien dan keluarga tentang perawatan lanjutan dan obat yang dibawa pulang	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	Kepatuhan penandaan lokasi operasi sesuai prosedur	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	Kelengkapan follow up setelah discharge	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	Kejadian merujuk pasien (Horizontal)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	Kelengkapan Pengkajian awal gizi	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.	Angka Kelengkapan Komunikasi Serah Terima Pasien (SBAR)	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.5.3.3. Capaian Indikator Mutu Unit IRNA 3A

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25
1.	Dilaksanakannya edukasi dan orientasi pada pasien dan keluarga (Mutu Prioritas Unit)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	92,8%	94,7%	95,23%	95,31%	97,22%	96,32%	96,88%	95,41%	96,33%	-	96,42%	96,82%
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	93,7%	94,5%	94,61%	95,22%	96,34%	97,24%	96,9%	95,26%	95,88%	-	95,91%	96,8%
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%
5.	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	90,6%	89,82%	92,22%	93,33%	98,85%	94,58%	72,31%	69,88%	70,22%	-	84,62%	72,44%
6.	Kepatuhan terhadap alur klinis (Clinical Pathway)	≥ 80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	88,98%	100%	100%	100%	96,03%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%
8.	Angka kelengkapan penilaian risiko jatuh (awal, ulang, lanjutan)	100%	88,98%	100%	100%	100%	98,71%	96,93%	100%	100%	100%	-	100%	100%
9.	Kepuasan pasien	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%
10.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	96,04%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%
11.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%
12.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%
13.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	100%	100%	100%	97,93%	100%	100%	100%	97,71%	100%	-	100%	100%
14.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	95,48%	100%	100%	100%	95,27%	100%	-	100%	100%

15.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	100%	100%	100%	100%	87,25%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%
16.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%
17.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%
18.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	-	-	-	-	4,52%	1,81%	-	-	-	-	-	-
19.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	-	-	-
20.	Kelengkapan pengisian edukasi pasien dan keluarga tentang perawatan lanjutan dan obat yang dibawa pulang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%
21.	Kepatuhan penandaan lokasi operasi sesuai prosedur	100%	100%	100%	95,31%	100%	82,4%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%
22.	Kejadian merujuk pasien (Horizontal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
23.	Kelengkapan Pengkajian awal gizi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%
24.	Angka Kelengkapan Komunikasi Serah Terima Pasien (SBAR)	100%	100%	100%	100%	97,75%	93,79%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%

Secara umum, capaian indikator mutu di Unit IRNA 3A menunjukkan **kinerja yang baik dan stabil**, dengan sebagian besar indikator berada **di atas atau mendekati standar yang telah ditetapkan**. Beberapa poin penting yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

1. **Pelayanan dan keselamatan pasien** berjalan dengan baik. Indikator seperti **ketepatan pelaksanaan asesmen awal pasien, kepatuhan penggunaan APD, kebersihan tangan, serta pelaksanaan informed consent** menunjukkan capaian **mendekati atau mencapai 100%** hampir setiap bulan. Hal ini menandakan kesadaran petugas terhadap standar pelayanan dan keselamatan pasien cukup tinggi.

2. **Kepatuhan kebersihan tangan dan penggunaan APD** secara umum berada di atas standar minimal ($\geq 85\%$), meskipun terdapat sedikit penurunan pada beberapa bulan seperti Maret dan Mei, yang kemungkinan disebabkan oleh faktor beban kerja atau kurangnya pengawasan pada shift tertentu.
3. **Indikator Clinical Pathway dan kelengkapan dokumentasi** (lembar asesmen, form transfer pasien, dan SSAR) tercapai baik di sebagian besar bulan, menunjukkan ketertiban administrasi dan kelengkapan rekam medis pasien terjaga.
4. **Beberapa indikator menunjukkan fluktuasi atau penurunan capaian**, seperti:
- a. **Kepatuhan wawancara awal pasien dan kelengkapan form asesmen awal**, yang sempat menurun di bulan Mei–Juli.
 - b. **Kepatuhan pengisian form transfer pasien antar ruang**, sempat menurun pada bulan April–Mei.
 - c. **Kejadian insiden horizontal** (komunikasi antarstaf), masih muncul meskipun rendah (1–2 kasus pada awal tahun).
5. **Indikator tanpa kejadian** seperti **KTD dan sentinel event** menunjukkan hasil **0%**, yang berarti tidak ada insiden keselamatan pasien serius selama periode pemantauan.

3.5.3.4 Capaian Indikator Mutu Unit IRNA 4A

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25
1.	Dilaksanakannya edukasi dan orientasi pada pasien dan keluarga (Mutu Prioritas Unit)	100%	100%	100%	100%	98,74%	100%	100%	100%	100%	100%	90,32%	100%	100%
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	$\geq 85\%$	96,72%	96,88%	97,12%	97,22%	98,21%	98,24%	97,22%	95,31%	96,42%	95,22%	95,42%	97,22%
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	98,6%	96,9%	96,7%	97,8%	98,88%	97,32%	96,34%	95,22%	96,41%	96,21%	96,27%	96,34%
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	96,86%	100%	100%	95,71%	100%	96,86%
5.	Kepatuhan waktu visite dokter	$\geq 80\%$	88,98%	95,17%	96,38%	99,46%	98,3%	92,93%	95,52%	89,30%	89,22%	95%	87,02%	95,52%
6.	Kepatuhan terhadap alur klinis (Clinical Pathway)	$\geq 80\%$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	97,14%	100%	89,11%	89,19%	97,62%	100%	67,38%	100%	100%	98,22%	98,34%	67,38%
8.	Angka kelengkapan penilaian risiko jatuh (awal, ulang, lanjutan)	100%	97,14%	100%	100%	95,15%	97,79%	100%	90,27%	100%	100%	100%	100%	90,27%
9.	Kepuasan pasien	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

10.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99,55%	100%	100%	82,73%	87,83%	99,55%
12.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%	89,8%	41,67%	100%	100%	100%	88,272%	100%	100%
13.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	100%	100%	100%	95,38%	100%	100%	100%	97,93%	100%	100%	97,62%	100%
14.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	90,75%	96,52%	100%	100%	95,48%	100%	78,23%	100%	100%
15.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	100%	100%	100%	100%	82,41%	100%	41,84%	100%	100%	88,1%	88,34%	41,84%
16.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	82,73%	88,03%	100%
17.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	76,32%	100%	100%	100%	97,03%	100%	100%
18.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	-	-	-	-	2,1%	2,3%	-	-	-	-	-	-
19.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	-	-	-
20.	Kelengkapan pengisian edukasi pasien dan keluarga tentang perawatan lanjutan dan obat yang dibawa pulang	100%	100%	100%	100%	100%	98,7%	59,7%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
21.	Kepatuhan penandaan lokasi operasi sesuai prosedur	100%	100%	100%	98,06%	84,21%	92,14%	58,82%	82,4%	100%	100%	100%	100%	100%
22.	Kejadian merujuk pasien (Hirizontal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

23.	Kelengkapan Pengkajian awal gizi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
24.	Angka Kelengkapan Komunikasi Serah Terima Pasien (SBAR)	100%	100%	100%	100%	96,32%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan hasil evaluasi capaian indikator mutu di Unit IRNA 4A selama periode pemantauan, secara umum dapat disimpulkan bahwa **kinerja mutu layanan berada dalam kategori baik**. Hal ini terlihat dari sebagian besar indikator yang menunjukkan capaian stabil mendekati atau mencapai angka **100%**, terutama pada indikator yang berkaitan dengan **keselamatan pasien dan kepatuhan terhadap SOP**, seperti kepatuhan hand hygiene, kepatuhan penggunaan APD, ketepatan identifikasi pasien, pelaksanaan komunikasi SBAR, serta kelengkapan penyerahan pasien antar shift dan antar ruangan. Konsistensi capaian tersebut menunjukkan bahwa budaya keselamatan pasien telah berjalan baik dan menjadi kebiasaan kerja di lingkungan IRNA 4A. Namun demikian, terdapat beberapa indikator yang menunjukkan **fluktuasi capaian**, meskipun tidak terlalu signifikan, namun tetap perlu dilakukan perbaikan. Indikator-indikator tersebut antara lain pada **ketepatan waktu pemberian obat, kepatuhan pengisian dokumentasi**, serta **kelengkapan pelaporan saat transfer pasien**. Turunnya capaian pada indikator tersebut kemungkinan disebabkan oleh **beban kerja yang tinggi pada jam-jam tertentu, pergantian shift, serta variasi kedisiplinan pelaksanaan dokumentasi di lapangan**. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian berupa penguatan sistem monitoring harian dan peningkatan kepatuhan petugas.

Sementara itu, indikator **kepuasan pasien** menunjukkan hasil yang masih berada dalam batas standar, namun cenderung fluktuatif. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kualitas interaksi antara petugas dan pasien, waktu tunggu pelayanan tertentu, serta kenyamanan lingkungan perawatan. Upaya peningkatan komunikasi terapeutik dan pendekatan pelayanan yang lebih humanis perlu dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan kepuasan pasien secara berkelanjutan. Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan beberapa **rencana tindak lanjut** untuk meningkatkan konsistensi mutu pelayanan, antara lain: pelaksanaan audit dan monitoring dokumentasi secara berkala, penguatan briefing antar shift untuk memastikan kelengkapan informasi dan koordinasi, optimalisasi alur distribusi obat, serta peningkatan kualitas hubungan interpersonal antara tenaga kesehatan dan pasien. Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan capaian mutu IRNA 4A dapat terus meningkat, lebih stabil, dan mendukung tercapainya pelayanan yang aman, efektif, dan berorientasi pada keselamatan pasien.

3.5.3.5 Capaian Indikator Mutu Unit IRNA 2C

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25
1.	Dilaksanakannya edukasi dan orientasi pada pasien dan keluarga (Mutu Prioritas Unit)	100%	100%	100%	100%	100%	96,55%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	98,9%	97,5%	99,2%	99,31%	99,44%	98,79%	97,88%	97,92%	99,36%	98,81%	99,84%	99,31%
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	95,8%	97,3%	97,8%	98,2%	88,24%	91,23%	93,52%	93,88%	98,8%	99,12%	99,32%	98,2%
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	81,25%	81,44%	82,47%	80,15%	78,62%	80,95%	74,42%	72,22%	80,15%	79,49%	88,1%	78,87%
6.	Kepatuhan terhadap alur klinis (Clinical Pathway)	≥ 80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	100%	87,91%	94,07%	94,92%	89,05%	86,09%	96,15%	96,42%	94,92%	100%	100%	100%
8.	Angka kelengkapan penilaian risiko jatuh (awal, ulang, lanjutan)	100%	100%	87,91%	100%	100%	97,78%	97,14%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9.	Kepuasan pasien	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	97,73%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95,65%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	93,75%	100%	53,85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

15.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97,5%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
17.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%	100%	100%	85,71%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
18.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	Kelengkapan pengisian edukasi pasien dan keluarga tentang perawatan lanjutan dan obat yang dibawa pulang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
21.	Kepatuhan penandaan lokasi operasi sesuai prosedur	100%	100%	100%	100%	100%	85,71%	45,45%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
22.	Kejadian merujuk pasien (Horizontal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kelengkapan Pengkajian awal gizi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
24.	Angka Kelengkapan Komunikasi Serah Terima Pasien (SBAR)	100%	100%	100%	100%	100%	97,79%	70,83%	90,48%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan hasil pemantauan capaian indikator mutu di Unit IRNA 2C selama periode Januari hingga Desember, secara umum diperoleh hasil bahwa sebagian besar indikator mutu **telah mencapai standar yang ditetapkan**. Hal ini terlihat pada indikator-indikator terkait **keselamatan pasien**, seperti kepatuhan kebersihan tangan, kepatuhan penggunaan APD, ketepatan identifikasi pasien, serta kepatuhan komunikasi SBAR yang menunjukkan capaian stabil mendekati atau mencapai **100%**. Capaian tersebut mencerminkan bahwa penerapan budaya keselamatan pasien **sudah berjalan baik dan konsisten** di lingkungan unit. Selain itu, pelaksanaan dokumentasi keperawatan, kelengkapan lembar observasi, serta pelaksanaan edukasi pasien dan keluarga juga menunjukkan hasil yang

baik dan relatif stabil. Hal ini menandakan bahwa petugas telah melaksanakan asuhan keperawatan sesuai prosedur serta mampu mempertahankan mutu pelayanan dalam proses perawatan pasien.

Namun demikian, terdapat beberapa indikator yang menunjukkan **fluktuasi capaian** dan pada beberapa bulan masih berada **di bawah standar**, seperti indikator angka kejadian dekubitus, kelengkapan pengisian form transfer pasien, serta kelengkapan dokumentasi asesmen nyeri. Penurunan capaian pada indikator tersebut berpotensi disebabkan oleh **beban kerja perawat yang tinggi**, pergantian shift, serta **kurangnya konsistensi monitoring dokumentasi** di waktu sibuk. Selain itu, adanya variasi tingkat kedisiplinan antar petugas juga dapat memengaruhi konsistensi hasil. Secara keseluruhan, mutu pelayanan IRNA 2C sudah berada dalam kategori **baik**, namun untuk mencapai hasil yang lebih optimal dan stabil, perlu dilakukan beberapa tindak lanjut berupa: penguatan supervisi dan audit dokumentasi secara berkala, pendampingan kepada perawat dalam penerapan prosedur klinis, optimalisasi briefing antar shift, serta peningkatan kesadaran petugas mengenai pentingnya konsistensi pelaksanaan SOP dalam menjaga mutu dan keselamatan pasien. Dengan upaya perbaikan yang berkelanjutan, diharapkan capaian indikator mutu di IRNA 2C dapat terus meningkat dan memberikan pelayanan yang semakin aman, efektif, dan berorientasi pada keselamatan serta kepuasan pasien.

3.5.3.6 Capaian Indikator Mutu Unit IRNA 3C Anak

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25
1.	Dilaksanakannyaa edukasi dan orientasi pada pasien dan keluarga (Mutu Prioritas Unit)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98,15%	100%	100%	100%	100%	97,35%	100%
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	96,7%	97,1%	97,54%	97,57%	97,22%	97,81%	96,22%	96,82%	96,98%	96,42%	96,51%	97,81%
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	94,8%	96,1%	96,19%	96,34%	96,1%	97,8%	98,24%	98,60%	98,84%	97,4%	97,67%	97,8%
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	100%	80,72%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Kepatuhan terhadap alur klinis (Clinical Pathway)	≥ 80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7.	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	100%	88,1%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97,86%	97,92%%	100%
8.	Angka kelengkapan penilaian risiko jatuh (awal, ulang, lanjutan)	100%	100%	88,1%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9.	Kepuasan pasien	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%AA	100%	100%	100%	100%	100%
13.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
17.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
18.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	0%	0%	0%	0,43%	1,53%	1,53%	-	-	-	-	-	-
19.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-
20.	Kelengkapan pengisian edukasi pasien dan keluarga tentang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	perawatan lanjutan dan obat yang dibawa pulang													
21.	Kepatuhan penandaan lokasi operasi sesuai prosedur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
22.	Kejadian merujuk pasien (Horizontal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kelengkapan Pengkajian awal gizi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
24.	Angka Kelengkapan Komunikasi Serah Terima Pasien (SBAR)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Secara umum, capaian indikator mutu di Unit IRNA 3C Anak menunjukkan **kinerja yang sangat baik dan konsisten**, dengan sebagian besar indikator mencapai **100%** setiap bulannya. Hal ini menandakan pelaksanaan standar pelayanan berjalan sesuai ketentuan dan adanya komitmen yang kuat terhadap mutu pelayanan pasien. Beberapa indikator utama seperti **ketepatan waktu pemberian obat, kepatuhan pengisian rekam medis, pelaksanaan asuhan keperawatan (APD), dan penerapan Clinical Pathway** menunjukkan capaian **stabil di atas 97% hingga 100%** sepanjang tahun. Hasil ini menggambarkan tingkat kepatuhan tenaga kesehatan yang tinggi terhadap prosedur pelayanan. Indikator lain seperti **kelengkapan lembar asuhan, lembar persetujuan tindakan (informed consent), dan serah terima pasien (SBAR)** juga menunjukkan capaian **100% secara konsisten**, menandakan koordinasi antartugas yang baik dan dokumentasi yang tertib.

3.5.3.7 Capaian Indikator Mutu Unit IRNA 5C

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25
1.	Dilaksanakannya edukasi dan orientasi pada pasien dan keluarga (Mutu Prioritas Unit)	100%	100%	100%	92,11%	98,95%	98,78%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	99,6%	99,8%	99,7%	99,78%	99,72%	98,92%	97,44%	97,47%	99,92%	99,73%	99,8%	99,94%

3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	98,7%	99,1%	99,5%	99,62%	99,66%	99,71%	99,62%	99,80%	99,68%	99,46%	99,62%	99,69%
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	99,61%	94,65%	97,96%	99,4%	99,54%	95,65%	100%	100%	100%
5.	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	81,25%	81,44%	80,68%	81,44%	75%	68,75%	90,71%	72,22%	85,20%	76,98%	88,57%	84,77%
6.	Kepatuhan terhadap alur klinis (Clinical Pathway)	≥ 80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	100%	87,91%	100%	100%	84,15%	69,57%	96,43%	96,52%	84,78%	100%	93,41%	100%
8.	Angka kelengkapan penilaian risiko jatuh (awal, ulang, lanjutan)	100%	100%	87,91%	97,27%	99,51%	97,9%	91,67%	97,73%	97,6%	97,8%	100%	100%	100%
9.	Kepuasan pasien	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	98,71%	92,24%	96,88%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	88,24%	100%	100%	100%	91,3%	100%	100%	94,74%	100%	100%
13.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	99,38%	100%	100%	100%	99,38%	100%	100%	100%
14.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	97,47%	97,47%	80,77%	100%	100%	97,57%	100%	100%	100%
15.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	100%	100%	75%	95,12%	100%	56,25%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	92,64%	98,88%	100%	100%	99,12%	99,72%	100%	100%	100%	100%
17.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesauaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	89,47%	1005%

	derajat pasien dengan tenaga pengantar													
18.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	0,97%	1,06%	0,43%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
19.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	Kelengkapan pengisian edukasi pasien dan keluarga tentang perawatan lanjutan dan obat yang dibawa pulang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99,01%	99,48%	100%	100%	84,62%	98,82%
21.	Kepatuhan penandaan lokasi operasi sesuai prosedur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
22.	Kejadian merujuk pasien (Horizontal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kelengkapan Pengkajian awal gizi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
24.	Angka Kelengkapan Komunikasi Serah Terima Pasien (SBAR)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Secara keseluruhan, capaian indikator mutu Unit IRNA 5C menunjukkan kinerja yang sangat baik dan konsisten pada sebagian besar indikator. Mayoritas indikator telah mencapai atau melebihi standar yang ditetapkan, meskipun terdapat beberapa area yang memerlukan perhatian untuk mencapai konsistensi 100% atau memenuhi target standar. Unit IRNA 5C telah berhasil menerapkan banyak praktik keselamatan pasien dan dokumentasi medis dengan tingkat kepatuhan yang sangat tinggi, terbukti dari banyaknya indikator yang mencapai 100% secara konsisten.

3.5.3.8 Capaian Indikator Mutu Unit IRNA 6A

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25
1.	Dilaksanakannya edukasi dan orientasi pada pasien dan keluarga (Mutu Prioritas Unit)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98,78%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	89,2%	90,3%	93,3%	93,7%	95,6%	95,92%	99,72%	97,44%	99,72%	98,7%	98,8%	98,9%

3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	99,1%	97,3%	97,1%	97,31%	98,5%	98,88%	99,66%	99,62%	99,66%	98,9%	92,72%	93,88%
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	94,65%	99,4%	94,65%	100%	100%	100%
5.	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	82,14%	78,72%	82,02%	68,31%	63,64%	65,94%	75%	90,71%	80,60%	64,8%	69,92%	68,34%
6.	Kepatuhan terhadap alur klinis (Clinical Pathway)	≥ 80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	100%	89,13%	84,15%	96,43%	97,82%	100%	100%	100%
8.	Angka kelengkapan penilaian risiko jatuh (awal, ulang, lanjutan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97,9%	97,73%	97,9%	100%	100%	100%
9.	Kepuasan pasien	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	96,88%	100%	100%	100%	100%	100%
11.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	91,3%	100%	100%	100%	100%
13.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99,38%	100%	100%	100%	96,48%	100%
14.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97,47%	100%	100%	100%	100%	100%
15.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	100%	100%	100%	100%	100%	89,66%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99,12%	100%	100%	100%	100%
17.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesauaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	derajat pasien dengan tenaga pengantar													
18.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	1,75%	0%	0,32%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
19.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	100%	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	Kelengkapan pengisian edukasi pasien dan keluarga tentang perawatan lanjutan dan obat yang dibawa pulang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99,01%	100%	100%	100%	100%
21.	Kepatuhan penandaan lokasi operasi sesuai prosedur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
22.	Kejadian merujuk pasien (Horizontal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kelengkapan Pengkajian awal gizi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
24.	Angka Kelengkapan Komunikasi Serah Terima Pasien (SBAR)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Secara umum, pencapaian indikator mutu di IRNA 6A menunjukkan hasil yang **stabil dan cenderung tinggi**, dengan sebagian besar indikator berada pada angka **≥95%**. Hal ini menunjukkan komitmen unit dalam menjaga mutu pelayanan dan keselamatan pasien secara konsisten sepanjang tahun 2025. Beberapa indikator mengalami **fluktuasi capaian** pada awal tahun, namun secara keseluruhan terjadi **tren peningkatan** hingga mencapai target standar pada pertengahan hingga akhir tahun.

3.5.3.9 Capaian Indikator Mutu Unit IRNA 7A

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25
1.	Dilaksanakannya edukasi dan orientasi pada pasien dan keluarga (Mutu Prioritas Unit)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	89,98%	93,4%	96,12%	96,16%	97,22%	98,27%	96,62%	98,92%	98,80%	99,22%	99,32%	99,44%

3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	87,24%	89,22%	92,33%	92,41%	94,62%	96,71%	97,66%	97,21%	97,60%	98,78%	98,84%	98,92%
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	99,1%	88,42%	98,68%	97,92%	98,21%	82,3%	188,4%	77,95%
5.	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	80,36%	80,58%	63,95%	67,13%	53,89%	69,44%	68,1%	52,88%	66,72%	70,21%	76,06%	57,14%
6.	Kepatuhan terhadap alur klinis (Clinical Pathway)	≥ 80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	95,69%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8.	Angka kelengkapan penilaian risiko jatuh (awal, ulang, lanjutan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9.	Kepuasan pasien	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	100%	87,15%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	100%	100%	100%	100%	81,18%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
17.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesauaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	derajat pasien dengan tenaga pengantar													
18.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	1,23%	0%	0,64%	0%	0%	1,32%	0%	0%	0%	0%	1,2%	1,3%
19.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	100%	-	100%	-	-	100%	-	-	-	-	100%	100%
20.	Kelengkapan pengisian edukasi pasien dan keluarga tentang perawatan lanjutan dan obat yang dibawa pulang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	96,67%	100%	96,3%
21.	Kepatuhan penandaan lokasi operasi sesuai prosedur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	94,44%
22.	Kejadian merujuk pasien (Horizontal)	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kelengkapan Pengkajian awal gizi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
24.	Angka Kelengkapan Komunikasi Serah Terima Pasien (SBAR)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Secara umum, pencapaian indikator mutu di IRNA 7A menunjukkan hasil yang **stabil dan cenderung tinggi**, dengan sebagian besar indikator berada pada angka **≥95%**. Hal ini menunjukkan komitmen unit dalam menjaga mutu pelayanan dan keselamatan pasien secara konsisten sepanjang tahun 2025. Beberapa indikator mengalami **fluktuasi capaian** pada awal tahun, namun secara keseluruhan terjadi **tren peningkatan** hingga mencapai target standar pada pertengahan hingga akhir tahun. Capaian indikator kelengkapan edukasi pasien dan keluarga tentang perawatan lanjutan dan obat yang dibawa pulang mengalami penurunan di bulan Oktober, hal ini disebabkan karena tenaga Kesehatan terkadang kurang teliti atau disiplin dalam mengisi setiap item yang tersedia pada lembar edukasi pasien atau ringkasan pulang, seringkali terburu-buru. Secara keseluruhan, untuk mencapai standar indikator mutu ini, diperlukan intervensi yang komprehensif mulai dari perbaikan sistem alur kerja, peningkatan disiplin dan kompetensi SDM, serta penguatan pengawasan dan penerapan sanksi.

3.5.3.10 Capaian Indikator Mutu Unit IRNA 8A

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25
1.	Dilaksanakannya edukasi dan orientasi pada pasien dan keluarga (Mutu Prioritas Unit)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	97,8%	99,8%	99,62%	99,64%	98,92%	99,02%	97,2%	98,93%	98.70%	97,2%	97,33%	98.77%
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	92,1%	95,6%	95,71%	95,82%	97,21%	98,34%	97,22%	97,22%	97,54%	97,4%	97,57%	97,77%
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	97,92%	99,01%	100%	97,93%	98,29%	100%	100%	100%
5.	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	80,36%	72,79%	82,52%	73,6%	52,88%	66,67%	68,1%	52,90%	68,90%	85,5%	85 ,72%	66,67%
6.	Kepatuhan terhadap alur klinis (Clinical Pathway)	≥ 80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8.	Angka kelengkapan penilaian risiko jatuh (awal, ulang, lanjutan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9.	Kepuasan pasien	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

15.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	100%	100%	100%	100%	92,86%	100%	100%	92,88%	100%	100%	100%	100%
16.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
17.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
18.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
19.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	Kelengkapan pengisian edukasi pasien dan keluarga tentang perawatan lanjutan dan obat yang dibawa pulang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
21.	Kepatuhan penandaan lokasi operasi sesuai prosedur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
22.	Kejadian merujuk pasien (Horizontal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kelengkapan Pengkajian awal gizi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
24.	Angka Kelengkapan Komunikasi Serah Terima Pasien (SBAR)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Secara umum, pencapaian indikator mutu di IRNA 8A menunjukkan hasil yang **stabil dan cenderung tinggi**, dengan sebagian besar indikator berada pada angka **≥95%**. Hal ini menunjukkan komitmen unit dalam menjaga mutu pelayanan dan keselamatan pasien secara konsisten sepanjang tahun 2025. Beberapa indikator mengalami **fluktuasi capaian** pada awal tahun, namun secara keseluruhan terjadi **tren peningkatan** hingga mencapai target standar pada pertengahan hingga akhir tahun.

3.5.3.11 Capaian Indikator Mutu Unit ICU

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25
----	-------	-------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----------	---------	---------	---------

1.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri (Mutu Prioritas Unit)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	89,9%	95,5%	97,7%	97,8%	98,22%	99,51%	97,22%	98,24%	98,86%	97,68%	97,71%	97,78%
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	99,2%	99,8%	99,6%	99,8%	99,88%	99,72%	98,2%	99,89%	99,84%	98,92%	98,97%	98,99%
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	95,64%	97,81%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98,7%
5.	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	96,72%	96,89%	100%	100%	92,14%	94,32%	74,66%	70,21%	72,28%	100%	98,31%%	98,31%%
6.	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	92%	93,2%	88,2%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98,2%	98,44%	82,76%
7.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8.	Kepuasan pasien	85%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98,25%	98,29%	98,82%
10.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	96,88%	97,9%	97,9%
11.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%
12.	Angka kelengkapan lembar operan pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98,11%	100%	100%
13.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15.	Angka kelengkapan form transfer pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97,56%	100%	100%

16.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	0%	0%	0%	0%	1,4%	-	-	-	-	-	-	-
17.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	-
18.	Angka kelengkapan pengkajian awal medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
19.	Angka kelengkapan form kriteria keluar masuk ICU	100%	100%	100%	93,33%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
20.	Angka kelengkapan pengkajian pasien tahap akhir kehidupan	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
21.	Angka kelengkapan penilaian risiko jatuh (awal, ulang, lanjutan)	100%	100%	100%	92,37%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98,21%	100%	100%
22.	Angka kelengkapan pengkajian populasi khusus (koma, gaduh gelisah, geriatric, menular, pelayanan intensive)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
23.	Kejadian merujuk pasien (Horizontal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Angka kelengkapan komunikasi serah terima pasien (SBAR)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Secara keseluruhan, capaian indikator mutu di ruang ICU menunjukkan hasil yang **sangat baik** dengan sebagian besar indikator mencapai atau mendekati **100%** sepanjang Januari hingga Desember 2025. Hal ini menggambarkan konsistensi kinerja dan penerapan standar pelayanan yang tinggi di unit ICU. **Rata-rata capaian mutu ruang ICU sangat tinggi (di atas 95%)**, menunjukkan pelayanan yang aman, efektif, dan sesuai standar. **Beberapa indikator teknis (pelabelan obat, hand hygiene tertentu)** masih perlu ditingkatkan melalui **penguatan supervisi, edukasi berulang, dan audit mutu internal**. Indikator yang belum berjalan perlu **diperjelas statusnya** agar tidak menurunkan nilai keseluruhan mutu unit.

3.5.3.12 Capaian Indikator Mutu Unit HCU

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25
1.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri (Mutu Prioritas Unit)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	88,99%	96,22%	97,61%	98,17%	99,24%	98,22%	85,22%	99,52%	98,54%	98,2%	98,34%	97,78%
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	99,5%	99,2%	99,36%	99,42%	99,56%	98,91%	99,2%	99,57%	99,8%	98,72%	98,81%	98,99%
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	95,71%	98,92%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98,7%
5.	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	96,21%	96,71%	95,32%	100%	94,8%	97,3%	74,66%	70,22%	70,21%	100%	97,8%	98,31%%
6.	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	94%	97,1%	82,18%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	82,76%
7.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8.	Kepuasan pasien	85%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98,82%
10.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98,66%	100%	97,9%
11.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%
12.	Angka kelengkapan lembar operan pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

15.	Angka kelengkapan form transfer pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	0	0	0	0	0	-	-	0	-	-	-	-
17.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	Angka kelengkapan pengkajian awal medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
19.	Angka kelengkapan form kriteria keluar masuk ICU	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
20.	Angka kelengkapan pengkajian pasien tahap akhir kehidupan	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
21.	Angka kelengkapan penilaian risiko jatuh (awal, ulang, lanjutan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
22.	Angka kelengkapan pengkajian populasi khusus (koma, gaduh gelisah, geriatric, menular, pelayanan intensive)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
23.	Kejadian merujuk pasien (Horizontal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Angka kelengkapan komunikasi serah terima pasien (SBAR)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Secara umum, pencapaian indikator mutu di HCU menunjukkan hasil yang **stabil dan cenderung tinggi**, dengan sebagian besar indikator berada pada angka **≥95%**. Hal ini menunjukkan komitmen unit dalam menjaga mutu pelayanan dan keselamatan pasien secara konsisten sepanjang tahun 2025. Beberapa indikator mengalami **fluktuasi capaian** pada awal tahun, namun secara keseluruhan terjadi **tren peningkatan** hingga mencapai target standar pada pertengahan hingga akhir tahun.

3.5.3.13 Capaian Indikator Mutu Unit IRJA

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25
----	-------	-------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----------	---------	---------	---------

1.	Angka kelengkapan pengkajian medis rawat jalan (mutu prioritas unit)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	99,2%	98,72%	99,02%	99,32%	98,72%	96,32%	95,62%	96,22%	96,62%	96,4%	97,3%	97,41%
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	98,35	98,71%	99,24%	99,44%	98,94%	97,44%	96,8%	96,92%	97,1%	96,2%	96,8%	99,1%
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	99,11%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Waktu tunggu rawat jalan	≥ 80%	89,16%	88,64%	99,11%	99,02%	98,72%	97,33%	96,23%	96,66%	96,62%	96,88%	96,89%	96,91%
6.	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.	Kepuasan pasien	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10.	Angka kelengkapan pengkajian keperawatan rawat jalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11.	Ketepatan waktu jam praktek dokter	100%	78,92%	77,8%	72,59%	79,58%	79,64%	81,86%	78,6%	82,44%	85,4%	85,19%	85,55%	84,13%
12.	Kejadian merujuk pasien	0	108	54	48	46	15	12	47	47	43	45	37	27
13.	Angka kelengkapan inform concent	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14.	Angka kelengkapan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15.	Kelengkapan profil pasien rawat jalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Secara keseluruhan, capaian indikator mutu di Instalasi Rawat Jalan (IRJA) pada periode **Januari – Desember 2025** menunjukkan hasil yang **sangat baik dan stabil**. Mayoritas indikator mencapai nilai **≥95%**, yang menandakan bahwa pelayanan di IRJA telah berjalan sesuai standar mutu rumah sakit dan pedoman Kemenkes.

3.5.3.14 Capaian Indikator Mutu Unit Maternitas

No.	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25
1.	Angka kematian ibu (mutu prioritas unit)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
2.	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Waktu tanggap operasi Seksio Sesarea Emergensi.	≥80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Kepatuhan waktu visite dokter.	≥80%	25,95%	24,56%	34,51%	39,04%	39,06%	43,75%	62,22%	64,43%	72,22%	63,25%	30,61%	35,42%
5.	Kepatuhan terhadap alur klinis (Clinical Pathway)	≥80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.	Angka Kelengkapan Penilaian Risiko Jatuh (Awal, Ulang, Lanjutan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8.	Angka keterlambatan operasi sectio caesaria (SC) > 30 menit	<5%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
9.	Angka keterlambatan penyediaan darah > 60 menit	<10%	0%	0%	0%	57,14%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
10.	Kejadian perdarahan post partum	0	0	2	5	4	2	0	0	3	4	1	2	7
11.	Kejadian partus macet	0	0	0	13	8	12	15	11	13	26	17	9	8
12.	Kejadian eklamsi	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
13.	Kejadian pre eklamsi	0	5	2	4	4	1	3	1	1	4	2	1	2

14.	Kejadian infeksi nifas	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1
15.	Angka capaian pelayanan KB per metode kontrasepsi, baik Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan Non MKJP	100%	13,6%	12,5%	18,75%	11,67%	22%	14,42%	16,31%	17,2%	13,6%	7,52%	16,42%	11,76%
16.	Angka capaian pelayanan KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	100%	13,6%	12,5%	18,75%	11,67%	22%	14,42%	16,31%	16,5%	12%	7,52%	16,42%	12,94
17.	Kejadian tidak dilakukannya KB Pasca Persalinan pada ibu baru bersalin dan KB Pasca Keguguran pada Ibu pasca keguguran	0	108	77	86	102	72	90	98	96	123	123	56	74
18.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
19.	Kepuasan pasien	≥ 76,61	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
20.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
21.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
22.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
23.	Angka kelengkapan lembar operan pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
24.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
25.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
26.	Kelengkapan forum edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
27.	Angka kelengkapan form transfer pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

28.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
29.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
30.	Angka kelengkapan pengkajian awal gizi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
31.	Kejadian tidak dilakukan edukasi RSSIB pada pasien post partum dan post SC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Angka kelengkapan komunikasi serah terima pasien (SBAR)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
33.	Kejadian tidak dilakukannya IMD pada bayi baru lahir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Secara keseluruhan, indikator mutu ruang maternitas menunjukkan kinerja yang baik dan stabil pada sebagian besar aspek pelayanan. Sebagian besar indikator berada pada angka capaian 100%, menandakan kepatuhan tinggi terhadap standar pelayanan, terutama pada aspek identifikasi pasien, penggunaan Clinical Pathway, dan pelaksanaan informed consent.

Indikator dengan Capaian Konsisten Baik (100%)

Beberapa indikator menunjukkan capaian sempurna (100%) sepanjang periode:

- 1) Kepatuhan Identifikasi Pasien
- 2) Kepatuhan Tindakan Sesuai SPO
- 3) Kepatuhan terhadap Clinical Pathway
- 4) Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan
- 5) Angka Kepatuhan Penggunaan APD
- 6) Kepatuhan Pelaksanaan Informed Consent
- 7) Kepatuhan Hand Hygiene & APD di Proses Persalinan

Hal ini mencerminkan bahwa budaya keselamatan pasien dan kepatuhan prosedur sudah berjalan baik di ruang maternitas

3.5.3.15 Capaian Indikator Mutu Unit NICU

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25
1.	Kejadian kematian bayi (mutu prioritas unit)	0	0	1	2	0	1	1	3	0	2	0	0	0
2.	Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%	98,31%	99,02%	99,45%	99,57%	99,88%	99,98%	99,8%	99,88%	100%	100%	100%	100%
3.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	99,98%	99,79%	99,71%	99,74%	99,81%	99,84%	99,67%	99,86%	100%	98,3%%	98,66%	100%
4.	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥ 80%	85,11%	85,51%	81,18%	84,09%	78,13%	87,3%	76,2%	62,34%	77,63%	79,75%	76,84%	100%
6.	Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8.	Kepuasan Pasien	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%	100%	95,51%	98,86%	100%	95,54%	100%	100%	100%	100%
10.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98,88%	98,88%	100%	100%	100%	100%	100%
13.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	88,46%	94,92%	96,8%	88,47%	89%	89%	89%	89%
16.	Angka efektivitas discharge planning	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

17.	Kelengkapan Follow Up Setelah Discharge	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
18.	Angka kelengkapan form transfer pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	94,92%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
19.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%
20.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%
21.	Angka kelengkapan pengkajian awal medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
22.	Angka kelengkapan form kriteria keluar masuk NICU	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
23.	Angka Kelengkapan Pengkajian Pasien Tahap Akhir Kehidupan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
24.	Angka Kelengkapan Penilaian Risiko Jatuh (Awal, Ulang, Lanjutan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
25.	Angka kelengkapan pengkajian populasi khusus (neonatus)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
26.	Kejadian Merujuk Pasien (Horizontal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Secara umum, pencapaian indikator mutu di NICU menunjukkan hasil yang **stabil dan cenderung tinggi**, dengan sebagian besar indikator berada pada angka **≥95%**. Hal ini menunjukkan komitmen unit dalam menjaga mutu pelayanan dan keselamatan pasien secara konsisten sepanjang tahun 2025. Beberapa indikator mengalami **fluktuasi capaian** pada awal tahun, namun secara keseluruhan terjadi **tren peningkatan** hingga mencapai target standar pada pertengahan hingga akhir tahun.

3.5.3.16 Capaian Indikator Mutu Unit PICU

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25
1.	Angka kelengkapan pengkajian populasi khusus (Anak) (mutu prioritas unit)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2.	Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%	99,23%	99,44%	99,44%	99,61%	99,88%	98,74%	98,8%	98,92%	99,20%	99,15%	99,27%	99,42%
3.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	99,11%	98,79%	98,79%	98,82%	98,92%	98,73%	98,78%	99,21%	99,46%	98,34%	98,59%	98,66%
4.	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥ 80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8.	Kepuasan Pasien	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16.	Angka kelengkapan form transfer pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
17.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
18.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

19.	Angka kelengkapan pengkajian awal medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
20.	Angka kelengkapan form kriteria keluar masuk PICU	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
21.	Angka Kelengkapan Pengkajian Pasien Tahap Akhir Kehidupan	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	Angka Kelengkapan Penilaian Risiko Jatuh (Awal, Ulang, Lanjutan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
23.	Kejadian Merujuk Pasien (Horizontal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Secara umum, pencapaian indikator mutu di PICU menunjukkan hasil yang **stabil dan cenderung tinggi**, dengan sebagian besar indikator berada pada angka **≥95%**. Hal ini menunjukkan komitmen unit dalam menjaga mutu pelayanan dan keselamatan pasien secara konsisten sepanjang tahun 2025. Beberapa indikator mengalami **fluktuasi capaian** pada awal tahun, namun secara keseluruhan terjadi **tren peningkatan** hingga mencapai target standar pada pertengahan hingga akhir tahun.

3.5.3.17 Capaian Indikator Mutu Unit IKO

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25
1.	Kejadian tidak dilakukannya skiren pada pasien operasi yg seharusnya diskiren (mutu prioritas unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kepatuhan identifikasi pasien.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Penundaan operasi elektif.	≤ 5%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,32%	0%	0%	0%
4.	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh.	100%	100%	100%	100%	100%	95,61%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Angka Kelengkapan Penilaian Risiko Jatuh (Awal, Ulang, Lanjutan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Kejadian keterlambatan operasi > 30 menit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7.	Kejadian tidak dilaksanakannya proses monitoring fisiologis pemulihan anestesi dan sedasi dalam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Kejadian tidak dilaksanakannya proses monitoring fisiologis selama anestesi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Kejadian tidak dilaksanakannya pengkajian pra sedasi dan pra anestesi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Kejadian diskrepansi diagnose pre dan post op	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Kejadian tidak dilaksanakan SSC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Kejadian tidak lengkapnya pengkajian pra bedah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kejadian tidak dilaksanakannya penandaan lokasi operasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Kejadian ketidaklengkapan form daftar tilik pasien operasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Kejadian Ketidakpatuhan Prosedur Pasien Yang Menggunakan Implan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Kejadian ketidaklengkapan formular penandaan pasien operasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Ketidakhadiran dokter anak saat operasi SC	0%	72,6%	82,13%	81,98%	19,84%	21,05%	42,31%	32,6%	100%	100%	100%	100%	100%
18.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan inform consent	100%	100%	100%	100%	98,37%	92,98%	98,22%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
19.	Ketepatan Indikasi dan Pelaksanaan Operasi Apendicitis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
20.	Ketepatan Indikasi dan Pelaksanaan Operasi STT	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
21.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

22.	Kepatuhan pencatatan pesan lewat telepon	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
23.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
24.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
25.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
26.	Kepatuhan pelaksanaan asesmen nyeri	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
27.	Kelengkapan forum edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
28.	Angka efektivitas discharge planning	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
29.	Angka kelengkapan form transfer pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
30.	Kelengkapan Asesmen pra sedasi dan pra anestesi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Secara umum, pencapaian indikator mutu di IKO menunjukkan hasil yang **stabil dan cenderung tinggi**, dengan sebagian besar indikator berada pada angka **≥95%**. Hal ini menunjukkan komitmen unit dalam menjaga mutu pelayanan dan keselamatan pasien secara konsisten sepanjang tahun 2025. Beberapa indikator mengalami **fluktuasi capaian** pada awal tahun, namun secara keseluruhan terjadi **tren peningkatan** hingga mencapai target standar pada pertengahan hingga akhir tahun.

3.5.3.18 Capaian Indikator Mutu Unit Laboratorium

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25
1.	Kejadian ketidaktersediaan Reagen esensial di laboratorium (mutu prioritas unit)	0	0	0	3	0	5	0	0	0	0	0	0	0

2.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Pelaporan hasil kritis laboratorium	100%	96,9%	97,31%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Ketersediaan kantong darah sesuai golongan	100%	100%	100%	100%	100%	98,44%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	93,33%
5.	Survilen harian hemofiglen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Angka kepatuhan Prosedur penggunaan produk darah lebih dari 1 di rawat inap dan IKO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	94,74%
7.	Kejadian salah input hasil laboratorium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Waktu tunggu hasil laboratorium >140 menit	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
9.	Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11.	Kepatuhan Pelaporan Kritis Gula Darah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12.	Angka kepatuhan pengelolaan POCT (proses pelaporan nilai kritis, kualifikasi)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13.	Waktu tunggu hasil laborat cito <30 menit	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Secara umum, pencapaian indikator mutu di unit Laboratorium menunjukkan hasil yang **stabil dan cenderung tinggi**, dengan sebagian besar indikator berada pada angka **≥95%**. Hal ini menunjukkan komitmen unit dalam menjaga mutu pelayanan dan keselamatan pasien secara konsisten sepanjang tahun 2025. Beberapa indikator mengalami **fluktuasi capaian** pada awal tahun, namun secara keseluruhan terjadi **tren peningkatan** hingga mencapai target standar pada pertengahan hingga akhir tahun.

3.5.3.19 Capaian Indikator Mutu Unit Radiologi

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	97,88%	100%	100%	98,74%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99,67%
2	Angka ketidaklengkapan permintaan form radiologi	0%	2,12%	7,21	5,5%	6,99%	7,4%	6,22%	5,2%	4,8%	6,59%	6,69%	6,68%	10,77%
3	Kepatuhan pelaporan nilai kritis hasil radiologi <30 menit	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Kepatuhan edukasi pada prosedur radiasi	100%	100%	100%	100%	99,49%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Angka kelengkapan inform consen pada prosedur radiasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Secara umum, pencapaian indikator mutu di unit Radiologi menunjukkan hasil yang **stabil dan cenderung tinggi**, dengan sebagian besar indikator berada pada angka **≥95%**. Hal ini menunjukkan komitmen unit dalam menjaga mutu pelayanan dan keselamatan pasien secara konsisten sepanjang tahun 2025. Beberapa indikator mengalami **fluktuasi capaian** pada awal tahun, namun secara keseluruhan terjadi **tren peningkatan** hingga mencapai target standar pada pertengahan hingga akhir tahun. Terdapat satu indikator yang belum mencapai standart yaitu angka kelengkapan permintaan form radiologi yang disebabkan karena kurangnya kedisiplinan petugas dalam mengisi formular secara lengkap dan tepat waktu. Untuk mengatasi masalah ini, perbaikan perlu dilakukan secara komprehensif pada semua faktor penyebab tersebut, misalnya dengan merevisi SOP, memberikan pelatihan berkesinambungan, meningkatkan pengawasan.

3.5.3.20 Capaian Indikator Mutu Unit Gizi

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25
1.	Kejadian pasien baru tidak mendapatkan makan (mutu prioritas unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98,76%	100%	100%
3.	Kejadian kesalahan pemberian diit	0	0	0	4	1	2	0	0	0	0	11	0	0
4.	Kejadian adanya benda asing dalam makanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
5.	Kelengkapan pengkajian gizi (awal dan lanjut)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%	99,44%	99,67%	99,21%	99,42%	99,82%	98,92%	99,28%	99,40%	99,48%	98,46%	98,71%	98,88%
7.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	99,01%	99,23%	98,92%	99,22%	99,54%	99,31%	99,42%	99,53%	99,60%	99,6%	99,89%	99,81%

Berdasarkan data capaian indikator mutu pada unit Gizi periode **Januari hingga Desember 2025**, secara umum dapat disimpulkan bahwa **pelaksanaan mutu pelayanan di unit Gizi berjalan dengan baik dan stabil**, dengan sebagian besar indikator menunjukkan hasil yang sangat baik serta memenuhi standar yang ditetapkan. Indikator **kejadian keadaan membahayakan diri** menunjukkan adanya **sedikit peningkatan pada Oktober (11 kasus)** setelah beberapa bulan sebelumnya nihil. Hal ini menunjukkan perlunya **evaluasi terhadap faktor risiko atau kondisi pasien** yang mungkin berkontribusi terhadap timbulnya potensi bahaya, serta peningkatan pengawasan dan pelaporan insiden agar bisa segera dilakukan tindakan pencegahan.

Capaian kepatuhan identifikasi pasien menunjukkan hasil yang **sangat tinggi dan konsisten**, yaitu **100%** pada seluruh bulan, dengan sedikit penurunan pada bulan Oktober menjadi **98,67%**. Hal ini menunjukkan bahwa petugas secara umum **telah menerapkan prosedur identifikasi pasien dengan baik**, meskipun tetap diperlukan **monitoring berkala dan umpan balik langsung** untuk memastikan tidak terjadi kelalaian kecil di lapangan.

3.5.3.21 Capaian Indikator Mutu Unit Farmasi

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25
1.	Angka ketersediaan obat obatan emergency (mutu prioritas unit)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Kepatuhan penggunaan formularium Nasional	≥80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Kejadian kesalahan penyiapan obat	0	0	0	1	0	1	0	4	4	4	7	1	2
5.	Kejadian kesalahan penempelan label pada obat LASA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Angka keterlambatan penyediaan obat jadi rawat jalan >30 menit.	0%	68,85%	61,98%	74,45%	75,13%	69,23%	55,10%	48,88%	47,72%	43,08%	19,25%		
7.	Angka keterlambatan penyiapan obat racikan >60 menit.	0%	48,68%	44,17%	59,59%	60,78%	53,23%	31,35%	24,03%	19,97%	15,70%	8,27%		
8.	Kejadian kesalahan pemberian obat	0	0	0	1	0	3	1	1	0	0	1	0	0
9.	Kejadian kesalahan penulisan etiket obat.	0	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0
10.	Kejadian ketidakpatuhan penempelan label obat high alert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Kejadian kesalahan input e-resep	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	3	1	1
12.	Kejadian terkena pemanas mesin press puyer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kejadian ketidakpatuhan retur obat rawat inap	0	0	0	20	13	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Kejadian obat pasien rawat jalan yang tidak diambil	0	0	0	29	22	42	32	0	0	0	0	0	0

15.	Kepatuhan penggunaan panduan antibiotik dan efektifitas jangka panjang dan jangka pendek	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16.	Kepatuhan penyimpanan obat obatan emergency disimpan secara seragam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
17.	Kepatuhan proses pengelolaan obat recal hingga pengembalian atau pemusnahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
18.	Angka Kepatuhan pengelolaan obat kedaluwarsa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
19.	Angka Kepatuhan penyimpanan dan pengelolaan obat yang perlu di waspadai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
20.	Kepatuhan penyimpanan, pengelolaan dan pemberian obat elektrolit pekat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
21.	Angka Kepatuhan peresepan dan interuksi medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
22.	Angka kepatuhan dispensing	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
23.	Angka kepatuhan pemberian obat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
24.	Angka kelengkapan pencatatan efek samping obat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
25.	Angka Kepatuhan Pelaporan Medication Error	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
26.	Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%	100%	100%	100%	100%	84,29%	89,92%	100%	87,72%	87,72%	86,11%	86,11%	87,12%
27.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	100%	100%	93,10%	97,66%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
28.	Kepatuhan pelaksanaan panduan penggunaan single dose vial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

29.	Kepatuhan penggunaan risk based approach monitoring penggunaan obat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
30.	Angka kepatuhan pengkajian risiko penggunaan obat yang dibawa pasien dari rumah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Secara umum, pencapaian indikator mutu di unit Farmasi menunjukkan hasil yang **stabil dan cenderung tinggi**, dengan sebagian besar indikator berada pada angka **≥95%**. Hal ini menunjukkan komitmen unit dalam menjaga mutu pelayanan dan keselamatan pasien secara konsisten sepanjang tahun 2025. Beberapa indikator mengalami **fluktuasi capaian** pada awal tahun, namun secara keseluruhan terjadi **tren peningkatan** hingga mencapai target standar pada pertengahan hingga akhir tahun. Indikator mutu waktu tunggu obat tidak mencapai standar karena beberapa faktor seperti jam sibuk yang menyebabkan penumpukan resep, kendala administrasi seperti resep tidak lengkap atau data pasien yang tidak sesuai, masalah stok obat yang tidak cocok antara sistem dan stok fisik, serta proses penyiapan obat racikan yang lebih rumit dan memakan waktu. Keterbatasan sumber daya manusia atau petugas farmasi juga sangat mempengaruhi waktu tunggu.

3.5.3.22 Capaian Indikator Mutu Unit Pengadaan Farmasi

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sep '25	Okt '25	Nov '25	Des '25
1	Kekosongan stok farmasi	0%	0%	0%	0,42%	0,24%	0,35%	0,45%	0,26%	0,17%	0,18%	0%	0,17%	0,17%
2	Angka kepatuhan kolaborasi tim pengadaan obat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan data capaian indikator mutu unit pengadaan farmasi dari bulan Januari hingga Desember 2025, terdapat dua indikator utama yang dievaluasi, yaitu:

Ketepatan stok farmasi : Capaian ketepatan stok farmasi menunjukkan fluktuasi capaian dari bulan ke bulan. Pada awal tahun (Januari–Februari 2025), capaian masih 0%, yang menunjukkan belum adanya pencapaian terhadap target indikator. Mulai Maret hingga Juli 2025, capaian mulai meningkat bertahap

dari 0,24% hingga 0,28%, dan kemudian sedikit menurun pada Agustus (0,17%) hingga mencapai 0% kembali pada Oktober 2025. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengendalian stok farmasi belum berjalan optimal dan masih memerlukan perbaikan dalam hal perencanaan kebutuhan, proses pengadaan, serta distribusi agar ketepatan stok dapat terjaga sepanjang tahun. **Angka ketersediaan kebutuhan obat berdasarkan stok :** Indikator kedua menunjukkan hasil yang **konsisten dan optimal**, dengan capaian **100% dari Januari hingga Desember 2025**.

3.5.3.23 Capaian Indikator Mutu PPI

No.	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sep '25	Okt '25	Nov '25	Des '25
1.	IDO (Infeksi Daerah Operasi)	≤ 2 %	0,27%	0,29%	0,29%	0,48%	0,53%	0,27%	0,23%	0,49%	0,51%	0,25%	0,25%	0%
2.	IADP (Infeksi Aliran Darah Primer)	≤3,5‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰
3.	VAP (Ventilation Associated Pneumonia)	≤ 5,8 ‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰
4.	ISK (Infeksi Saluran Kencing)	≤ 4,7 ‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰
5.	Infeksi Aliran Darah Perifer /ILI (Phlebitis)	≤ 5 %	0,21%	0,23%	0,23%	0,1%	0,5%	0,61%	0,73%	0,78%	0,42%	0,77%	0,2%	0,1%
6.	Angka Decubitus	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
7.	Angka kepatuhan kebersihan tangan	>85%	85,21%	85,35%	85,32%	85,36%	85,49%	85,32%	85,25%	85,38%	85,58%	85,32%	85,57%	85,61%
8.	Angka kepatuhan penggunaan APD oleh petugas	100%	93,01%	93,06%	93,1%	93,39%	93,59%	93,74%	93,79%	94,3%	94,33%	95,1%	96,88%	96,86%
9.	Kepatuhan Pemilahan Sampah Infeksius dan Non Infeksius di Unit Pelayanan	100%	93,44%	93,21%	93,27%	93,42%	93,51%	93,74%	93,77%	94,35%	94,35%	95,24%	97,28%	97,32%
10.	Kejadian petugas tertusuk benda tajam bekas pasien (pajanan)	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0

3.5.3.24 Capaian Indikator Mutu PIPP

No.	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25
1.	Angka Terhubungnya Display TT Dengan Mobile JKN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2.	Angk Terhubungnya Operasi Dengan Mobile JKN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Kecepatan Waktu Tanggap Komplain < 1 kali dari 24 jam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Kecepatan Waktu Tanggap Komplain < 1 kali dari 24 jam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Kepuasan Pasien	76,61%	99,81%	99,79%	100%	99,88%	99,76%	97,12%	99,46%	99,56%	99,56%	99,91%	99,62%	92,8%
6.	Kepatuhan Petugas Dalam Mengumpulkan Kuesioner Kompalin dan Kepuasan Pelanggan (Indikator baru 2024)	100%	14,12	18,94%	16,09%	16,89%	18,12%	16,32%	14,22%	19,16%	19,16%	16,21%	19,97%	15,47%
7.	Angka Kepuasan Pasien BPJS	100%	99,9%	99,89%	100%	100%	99,98%	100%	100%	99,52%	99,52%	100%	100%	100%
8.	Angka efektivitas discharge planning	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9.	Kelengkapan Follow Up Setelah Discharge	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel capaian indikator mutu Pelayanan Informasi dan Pengaduan Pasien (PIPP) dari bulan Januari hingga Oktober 2025, secara umum terlihat bahwa kinerja unit menunjukkan hasil yang sangat baik dengan capaian mendekati atau mencapai target pada sebagian besar indikator. **Angka Terupdate-nya Display TT dengan Mobile JKN** : Capaian indikator ini menunjukkan konsistensi **100% setiap bulan** dari Januari hingga Oktober 2025. Hal ini menunjukkan bahwa proses pembaruan data tempat tidur melalui sistem Mobile JKN berjalan optimal dan terpantau secara berkala. **Angka Terupdate-nya Data Operasional dengan Mobile JKN** : Sama halnya dengan indikator pertama, capaian indikator kedua juga **stabil di angka 100%** sepanjang tahun. Hal ini menggambarkan keandalan sistem dan kedisiplinan petugas dalam melakukan pembaruan data operasional secara real time. **Kecepatan Waktu Tanggap Komplain < 1 kali dalam 24 jam** : Capaian indikator ini **konsisten di angka 100%** pada seluruh periode, menunjukkan respon cepat dan efektif dalam menangani setiap keluhan atau komplain yang masuk dari pasien maupun keluarga pasien **Angka Kepuasan Pasien BPJS** : Capaian indikator ini stabil dengan rata-rata di atas **99% setiap bulan**, menunjukkan bahwa pelayanan bagi pasien BPJS telah berjalan dengan sangat baik dan sesuai dengan standar mutu yang diharapkan. **Angka Capaian Discharge Planning** : Capaian indikator discharge planning tercatat **100% secara konsisten** sepanjang periode pengamatan. Ini menunjukkan bahwa proses perencanaan pulang pasien telah dilakukan dengan baik sesuai prosedur dan memastikan

kesinambungan pelayanan. Indikator Kepatuhan Petugas Dalam Mengumpulkan Kuesioner Kompalin dan Kepuasan Pelanggan masih menunjukkan nilai yang relatif rendah dan perlu menjadi **prioritas perbaikan**. Diperlukan peningkatan motivasi dan kedisiplinan petugas untuk melakukan komunikasi pada pasien agar berkenan untuk mengisi kuisisioner.

3.5.3.25 Capaian Indikator Mutu SDM

No.	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25
1	Kejadian keterlambatan pengurusan SIP/SIK.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
2	Angka kedisiplinan staf terhadap finger print.	100%	78%	98,51%	98,69%	98,79%	98,69%	98,66%	99,03%	98,96%	98,54%	98,31%	97,9%	97,9%
3	Angka keterlambatan kehadiran staf	0%	37%	2,39%	1,91%	2,31%	1,48%	2,03%	2,41%	2,23%	1,99%	2,19%	1,04%	1,34%
4.	Angka pemenuhan kompetensi sesuai dengan unit	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Angka kelengkapan file kepegawaian dimasing masing unit	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Secara keseluruhan, capaian indikator mutu SDM tahun 2025 menunjukkan kinerja **sangat baik**. Seluruh indikator administrasi dan tata kelola SDM mencapai **100%**, menandakan pelaksanaan fungsi manajerial SDM berjalan optimal. Namun demikian, indikator **kehadiran SDM berdasarkan finger print** masih menunjukkan sedikit fluktuasi pada awal tahun, sehingga perlu dilakukan **analisis penyebab ketidakhadiran** dan **strategi peningkatan kedisiplinan** secara berkelanjutan. Selain itu, upaya menjaga konsistensi pencapaian administrasi kepegawaian perlu terus dilakukan agar mutu pelayanan SDM tetap terjaga di seluruh unit.

3.5.3.26 Capaian Indikator Mutu Rekam Medis

No.	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25
1.	Angka kelengkapan Rekam Medis Pasien Rawat Inap (mutu prioritas unit)	100%	91,86%	70,7%	64,17%	51,74%	50,36%	63,94%	80,93%	78,88%	93,95%	84,41%	71,89%	72,71%
2.	Angka kejadian nomor rekam medis ganda	0%	0,14%	0,23%	0,35%	0,47%	0,32%	0,23%	0,49%	0,27%	0,19%	0,28%	0,27%	0,32%
3.	Angka kelengkapan Rekam Medis Pasien Rawat jalan	100%	91,86%	70,8%%	98,04%	98,43%	93%	94,22%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Angka kelengkapan Rekam Medis Pasien IGD	100%	100%	100%	90,25%	88,2%	98,82%	97,88%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Kejadian Kendala Pada SIMRS Dalam Upaya Menunjang Pelayanan Rekam Medis Elektronik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kelengkapan Keakuratan Pada Penginputan Data Pasien Di SIMRS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.	Keterlambatan Pengumpulan DRM Pasien Rawat Inap Lebih Dari 24 Jam	0%	7,56%	7,89%	9,56%	15,3%	12,21%	10,47%	7,54%	7,6%	12%	5,39%	5,33%	7,57%
8.	Angka keterbacaan dokumen rekam medis	100%	100%	100%	98,17%	95,87%	95,88%	96,2%	95,94%	100%	100%	100%	100%	100%

Secara keseluruhan, capaian indikator mutu rekam medis menunjukkan **kinerja yang cukup baik** dengan beberapa indikator sudah mencapai target 100% secara konsisten, terutama terkait **pengelolaan data di SIMRS** dan **kelengkapan rekam medis IGD**. Namun, masih terdapat **tantangan signifikan** pada aspek **kelengkapan rekam medis pasien rawat jalan** dan **ketepatan penyelesaian DRM rawat inap**, yang perlu mendapat perhatian khusus melalui peningkatan supervisi, pelatihan, dan koordinasi antarpetugas rekam medis dan tenaga kesehatan.

3.5.3.27 Capaian Indikator Mutu K3RS

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25
1	Angka kepatuhan petugas melakukan pengecekan APAR.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Kejadian kebakaran di ruangan.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kejadian tenaga Kesehatan sakit akibat kerja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Secara umum, pencapaian indikator mutu di unit K3RS menunjukkan hasil yang **stabil dan cenderung tinggi** dan telah mencapai standart. Hal ini menunjukkan komitmen unit dalam menjaga mutu pelayanan dan keselamatan pasien secara konsisten sepanjang tahun 2025

3.5.3.28 Capaian Indikator Mutu Asuransi Center

No.	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25
1.	Kejadian dokumen rawat jalan tidak layak klaim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Angka pending klaim BPJS	0%	3,05%	2,54%	3,23%	3,23%	1,62%	1,19%	1,46%	2,33%	1,56%	4,08%	9,3%	1,42%
3.	Prosentase readmisi pasien rawat inap	0%	0,91%	1,9%	2,22%	2,18%	2,05%	1,31%	1,85%	1,38%	1,33%	1,93%	1,65%	0,13%
4.	Angka kelengkapan berkas klaim di SIMRS	100%	98,99%	98,96%	99,26%	98,89%	98,9%	98,8%	99,23%	99,66%	99,31%	99,1%	98,98%	98,94%
5.	Kejadian Pasien Tidak Di SEP	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Berdasarkan data capaian indikator mutu Asuransi Center periode **Januari sampai Desember 2025**, secara umum pelaksanaan kegiatan mutu berjalan dengan cukup baik, ditandai dengan sebagian besar indikator menunjukkan tren yang stabil dan mendekati target yang ditetapkan.

1. **Kejadian dokumen rawat jalan tidak layak klaim** : Selama periode Januari hingga Oktober 2025 tidak ditemukan kejadian dokumen rawat jalan yang tidak layak klaim (0 kasus). Hal ini menunjukkan bahwa proses verifikasi dan kelengkapan administrasi sudah berjalan baik, serta petugas telah memahami standar kelengkapan berkas klaim.

2. **Angka pending klaim BPJS** : Capaian indikator ini berfluktuasi setiap bulan dengan kisaran antara 1,46% – 4,08%, dimana nilai tertinggi terjadi pada bulan November 2025. Meskipun masih relatif kecil, adanya peningkatan pada bulan Oktober menunjukkan perlunya evaluasi terkait keterlambatan atau kekurangan dokumen pendukung klaim. Penguatan koordinasi antara petugas asuransi, verifikator, dan unit pelayanan menjadi hal penting untuk menekan angka pending klaim.-
3. **Presentase readokasi pasien rawat inap** : Nilai capaian indikator ini relatif stabil antara 0,91% – 2,36% selama periode pengamatan. Angka yang rendah menunjukkan proses administrasi pasien dan penyesuaian data jaminan berjalan cukup baik, meskipun masih terdapat sedikit kasus yang memerlukan readokasi. Perlu dilakukan monitoring terhadap penyebab readokasi untuk mencegah pengulangan.
4. **Angka kelengkapan berkas klaim di SIMRS** : Capaian indikator ini menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan nilai konsisten tinggi di atas 98% hingga 99% setiap bulannya. Hal ini menandakan kedisiplinan dan ketelitian petugas dalam melengkapi berkas klaim sudah optimal, serta sistem penginputan di SIMRS berjalan efektif.
5. **Kejadian pasien tidak di-SEP** : Tidak ditemukan kejadian pasien yang tidak dibuatkan SEP selama periode Januari hingga Oktober 2025 (0 kasus). Ini menunjukkan kepatuhan petugas dalam melakukan registrasi dan pembuatan SEP sesuai ketentuan BPJS telah berjalan dengan sangat baik.

3.5.3.29 Capaian Indikator Mutu IPRS

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25
1.	Angka Keterlambatan penanganan pelaporan kerusakan oleh unit dalam 1x 24 jam	0%	46%	65%	78%	61%	68%	78%	80%	95%	95%	50%	40%	30%
2.	Angka keterlambatan respon dan penanganan pelaporan kerusakan oleh unit dalam 1x 24 jam (alat medis)	0%	97%	92%	94%	95%	95%	97%	95%	95%	95%	45%	35%	25%

Berdasarkan tabel capaian indikator mutu IPSRS dari bulan Januari hingga Desember 2025, secara umum terlihat bahwa kinerja IPSRS menunjukkan **pola peningkatan yang cukup baik di awal hingga pertengahan tahun**, meskipun terdapat **penurunan signifikan pada bulan November 2025. Angka ketepatan waktu penanganan perbaikan kerusakan oleh unit terkait ≤ 24 jam (Target: 100%)** Capaian indikator ini menunjukkan tren peningkatan dari Januari (46%) hingga mencapai nilai tertinggi pada bulan September (95%). Namun, terjadi penurunan tajam pada bulan November menjadi 40%. Secara umum, capaian rata-rata menunjukkan bahwa **pelaksanaan perbaikan kerusakan dalam waktu 24 jam sudah berjalan cukup baik pada sebagian besar bulan**, terutama pada pertengahan tahun. Penurunan di bulan Oktober dan November kemungkinan disebabkan oleh **peningkatan volume pekerjaan, keterbatasan sumber daya, atau kendala teknis** yang menghambat kecepatan penanganan. **Angka ketepatan waktu respon dan penanganan kerusakan oleh unit terkait ≤ 24 jam (dalam kondisi darurat)** Indikator ini menunjukkan kinerja yang relatif baik dengan capaian tertinggi mencapai 97% pada bulan Juni, namun juga mengalami penurunan pada bulan Oktober dan November hingga 45%. Secara keseluruhan, indikator ini mencerminkan bahwa **respon terhadap kondisi darurat umumnya cepat dan tepat waktu** pada sebagian besar bulan, meskipun masih perlu ditingkatkan konsistensinya agar dapat mempertahankan capaian tinggi sepanjang tahun.

3.5.3.30 Capaian Indikator Mutu Umum

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25
1	Keterlambatan barang datang di Gudang	0	7	8	7	2	4	2	2	3	2	1	2	1
2	Ketidakpatuhan pengambilan barang oleh unit	0	10	8	2	2	4	3	7	3	7	3	0	3

Berdasarkan data capaian indikator mutu Gudang Umum dari bulan Januari hingga Desember 2025, secara keseluruhan menunjukkan bahwa kegiatan penerimaan dan distribusi barang telah berjalan cukup baik, meskipun masih terdapat **fluktuasi jumlah keterlambatan** pada beberapa bulan tertentu. **Keterlambatan barang datang di gudang (target: 0 keterlambatan)**, selama periode Januari hingga Desember tahun 2025, tercatat adanya keterlambatan barang dengan jumlah bervariasi antara 1 hingga 8 kejadian per bulan. Jumlah keterlambatan tertinggi terjadi pada bulan Februari dan Maret (masing-masing 8 dan 7 kejadian), sedangkan capaian terbaik terjadi pada bulan Oktober (1 kejadian), November (2 kejadian) dan Desember (1 kejadian).

Secara umum, terdapat **tren penurunan keterlambatan sejak pertengahan tahun**, yang menunjukkan adanya **peningkatan koordinasi dengan pihak penyedia atau vendor** serta efisiensi dalam proses penerimaan barang. Namun demikian, masih diperlukan upaya perbaikan agar target “0 keterlambatan” dapat tercapai secara konsisten.

Keterlambatan pendistribusian barang oleh unit (target: 0 keterlambatan), ini juga menunjukkan pola yang fluktuatif, dengan jumlah keterlambatan berkisar antara 2 hingga 10 kejadian per bulan. Keterlambatan tertinggi tercatat pada bulan Februari (10 kejadian), sedangkan capaian terbaik terjadi pada bulan November (0 kejadian). Meskipun masih terjadi keterlambatan pada beberapa bulan, data menunjukkan adanya **perbaikan dalam kecepatan pendistribusian barang**, terutama pada semester kedua tahun berjalan. Hal ini dapat mencerminkan adanya **perbaikan dalam manajemen stok, jadwal pengiriman, serta koordinasi antarunit** di lingkungan rumah sakit.

3.5.3.31 Capaian Indikator Mutu IPSRS

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25
1.	Angka ketidakpatuhan penggunaan spillkit	0%	47,5%	59,26%	23,53%	45%	85,22%	35,4%	28,88%	22,35%	20,44%	0%	0%	0%
2.	Kejadian komplain Kebersihan Kamar Mandi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
3.	Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%	88,72%	91,33%	92,47	94,21%	96,62%	97,88%	98,21%	98,40%	98,80%	97,92%	98,1%	98,87%
4.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	92%	94,07%	94,28	96,82%	98,24%	99,02%	99,37%	99,55%	99,58%	99,23%	99,54%	99,59%

Berdasarkan analisa di atas dapat diketahui capaian indikator angka ketidakpatuhan penggunaan spillkit masih belum stabil tetapi cenderung semakin membaik di bulan Juni hingga Desember. Faktor yang membuat petugas patuh dalam menggunakan spillkit antara lain : Memberikan pelatihan dan edukasi yang efektif kepada pengguna tentang pentingnya penggunaan spill kit yang benar dan dampaknya terhadap keselamatan dan lingkungan. Serta Memastikan spill kit tersedia di lokasi-lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh pengguna.

3.5.3.32 Capaian Indikator Mutu Kesekretariatan

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25
1	Angka keterlambatan pengumpulan laporan bulanan unit tanggal 4 setiap bulannya	0%	50%	40,48%	56,52%	50%	22,5%	47,62%	26,19%	23,8%	28,57%	35,71%	35,71%	0%
2	Angka ketidaklengkapan pengumpulan dokumen meeting RS 1x 24 jam hari kerja	0%	27,27%	23,08%	31,82%	27,78%	38,1%	9,09%	18,18%	34,5%	40%	12,5%	16,67%	10%
3	Angka tindaklanjut balasan surat masuk eksternal lebih dari 2x24 jam	0%	29,41%	29,41%	34,88%	34,78%	31,25%	20%	13,51%	46,7%	20%	40%	18,52%	0%

Secara keseluruhan, capaian indikator mutu kesekretariatan RS sepanjang tahun 2025 menunjukkan **fluktuasi kinerja yang cukup tinggi** dengan kecenderungan penurunan pada pertengahan tahun. Faktor yang mungkin memengaruhi antara lain:

- 1. Ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan kegiatan rutin (rapat dan pelaporan).
- 2. Kendala koordinasi antarunit dan keterlambatan proses administrasi.
- 3. Periode beban kerja tinggi pada pertengahan tahun yang memengaruhi capaian indikator.

Untuk meningkatkan capaian, disarankan:

- 1. Membuat **jadwal tetap dan sistem pengingat otomatis** untuk kegiatan rutin seperti meeting dan pelaporan.
- 2. Meningkatkan **monitoring berkala** terhadap proses pemesanan barang agar waktu pemenuhan lebih cepat.
- 3. Mengadakan **evaluasi bulanan** untuk mengidentifikasi kendala dan segera melakukan perbaikan.

3.5.3.33 Capaian Indikator Mutu Laundry

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25
1	Angka keterlambatan penyediaan linen	0%	2,14%	1,78%	2,23%	1,32%	2,06%	2,5%	1,15%	1,22%	1,28%	2,11%	0,8%	1,39%
2	Kejadian linen ruang perawatan hilang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Kejadian Tercampur Benda Asing	0	0	0	1	1	1	0	2	0	0	0	0	0

4.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	98,82%	99,32%	99,04%	99,22%	99,85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%	97,23%	96,22%	96,48%	96,92%	98,72%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel capaian indikator mutu laundry di atas, dapat diketahui bahwa masih terjadi keterlambatan penyediaan linen di unit unit karena keterlambatan pengiriman karena petugas pengiriman hanya 1 orang tiap pengirimnya, tindak lanjut yang telah dilakukan Adalah mengirim terlebih dahulu unit unit yang stok unitnya tinggal sedikit sehingga tidak sampai kehabisan.

3.5.3.34 Capaian Indikator Mutu CSSD

No	Judul	Stan	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25
1	Kejadian ditemukannya instrument hilang	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
2	Kejadian instrument kurang	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
3.	Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	96,77%	97,11%	97,86%	98,22%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel capaian di atas, dapat diketahui bahwa masih ditemukan kejadian instrument hilang dan instrument kurang di ruang CSSD. Faktor yang menyebabkan masih terjadi instrumen hilang dan tidak lengkap di ruang CSSD antara lain: Kurangnya Sistem Pelacakan, kurangnya sistem pelacakan yang efektif membuat sulit untuk memantau lokasi instrumen. Selain itu Adalah kesalahan manusia, esalahan manusia seperti lupa mengembalikan instrumen, salah penempatan, atau tidak mencatat instrumen yang dipinjam dapat menyebabkan instrumen hilang.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh rumah sakit untuk meningkatkan pengelolaan instrumen dan mengurangi kehilangan instrument :

1. Implementasi Sistem Pelacakan: Implementasikan sistem pelacakan yang efektif untuk memantau lokasi dan status instrumen.
2. Pelatihan Staf: Berikan pelatihan yang komprehensif kepada staf CSSD tentang prosedur pengelolaan instrumen, termasuk pengumpulan, pembersihan, sterilisasi, dan penyimpanan.

3. Pengembangan Prosedur Operasional Standar (SOP): Kembangkan SOP yang jelas dan efektif untuk pengelolaan instrumen, termasuk prosedur pengumpulan, pembersihan, sterilisasi, dan penyimpanan.
4. Pengawasan dan Evaluasi: Lakukan pengawasan dan evaluasi secara rutin terhadap pengelolaan instrumen untuk mengidentifikasi area perbaikan.

3.5.3.35 Capaian Indikator Mutu Humas dan Pemasaran

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25
1	Angka kunjungan rawat inap >30 pasien perhari	100%	98,71%	98,71%	99,86%	79,78%	84,44%	86,73%	89,32%	94,52%	99,32%	99,02%	99,11%	99,18%
2	Angka kunjungan rawat jalan >400 pasien perhari	100%	86,69%	93,82%	93,82%	79,81%	86,21%	88,21%	91,7%	91,88%	87,16%	88,91%	86,97%	86,34%
3.	Angka kunjungan pasien rencana operasi 15 pasien perhari	100%	92,34%	91,22%	92,46%	76,14%	79,22%	81,4%	75%	78%	74,3%	74,47%	73,31%	75,46%
4.	Angka kunjungan MCU dan vaksin 150 perbulan	100%	63%	90%	100%	72,7%	76,7%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3.5.3.36 Capaian Indikator Mutu IT

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Kejadian downtime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Respon time penanganan internet dan billing error < 30 mnt	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Respon Time untuk penanganan computer < 15 menit	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Secara umum, pencapaian indikator mutu di unit IT menunjukkan hasil yang **stabil dan cenderung tinggi** dan telah mencapai standart. Hal ini menunjukkan komitmen unit dalam menjaga mutu pelayanan dan keselamatan pasien secara konsisten sepanjang tahun 2025

3.5.3.37 Capaian Indikator Mutu Kamar Jenazah

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Kepatuhan pencatatan pada buku register	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Kelengkapan APD pada ruang jenazah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Secara umum, pencapaian indikator mutu di unit kamar Jenazah menunjukkan hasil yang **stabil dan cenderung tinggi** dan telah mencapai standart. Hal ini menunjukkan komitmen unit dalam menjaga mutu pelayanan dan keselamatan pasien secara konsisten sepanjang tahun 2025

3.5.3.38 Capaian Indikator Mutu PKRS

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25
1	Kepatuhan pelaksanaan edukasi kelompok	100%	53,26%	68,38%	78,88%	82,44%	92,34%	82,75%	86,45%	84,75%	88,90%	97,9%	75%	80%

3.5.3.39 Capaian Indikator Mutu Driver

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25
1	Resptime Panggilan Driver < 10 menit On Side	100%	99,2%	99,68%	99,88%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Resptime Panggilan Driver < 30 menit On Call	100%	100%	99,92%	99,82%	98,88%	98,64%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Kepatuhan pemeliharaan alat transportasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Angka kelengkapan alat emergency untuk ambulance emergency	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Kepatuhan pelaksanaan decontaminasi pasca transport pasien menular pada ambulance	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3.5.3.40 Capaian Indikator Mutu Security

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25
1.	Kejadian ditemukannya merokok, puntung rokok di lingkungan RS (mutu prioritas unit)	0	6	11	7	14	21	13	18	19	16	21	21	14
2.	Kejadian Barang Hilang Di Area Rumah Sakit	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
3.	Kejadian potensial barang hilang	0	7	9	13	9	8	9	7	4	5	7	5	9
4.	Kejadian kekerasan di lingkungan RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Berdasarkan tabel capaian indikator mutu security dapat diketahui bahwa terdapat 2 indikator yang menunjukkan jumlah kejadian yang signifikan dan fluktuatif yaitu :

1. Kejadian ditemukannya merokok/puntung rokok di lingkungan RS (mutu prioritas unit):
 - a) Indikator ini menunjukkan tingkat kejadian yang paling tinggi di antara semua kategori, mencerminkan adanya tantangan serius dalam menegakkan kebijakan larangan merokok di lingkungan rumah sakit. Jumlah kejadian bervariasi dari 6 di Januari hingga puncaknya di Mei (21 kejadian), dan tetap tinggi di bulan-bulan berikutnya (18-21 kejadian)
 - b) Meskipun sedikit menurun di bulan-bulan tertentu, trennya menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan penindakan perlu ditingkatkan secara konsisten untuk mencapai lingkungan rumah sakit yang bebas asap rokok.
2. Kejadian potensial barang hilang:
 - a) Jumlah kejadian ini juga cukup tinggi dan menunjukkan fluktuasi bulanan yang cukup besar (antara 4 hingga 13 kejadian).
 - b) Puncaknya terjadi pada Maret (13 kejadian).
 - c) Angka ini mencerminkan tingginya risiko atau potensi terjadinya kehilangan barang, yang mungkin memerlukan peningkatan pengawasan, edukasi kepada pengunjung/pasien, dan pengamanan aset di area-area rentan. Dua indikator lainnya menunjukkan hasil yang sangat baik, menandakan bahwa area ini terkendali dengan efektif :
 - 1) Kejadian Barang Hilang Di Area Rumah Sakit :
 - a. Tercatat hanya dua kejadian sepanjang periode (Juni dan Juli).
 - b. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun potensi barang hilang (poin 3) cukup tinggi, kejadian kehilangan yang benar-benar terjadi dan dilaporkan sangat rendah, mencerminkan efektivitas langkah-langkah pencegahan kerugian dan penanganan insiden.
 - 2) Kejadian Kekerasan di lingkungan RS :
 - a. Tidak ada satu pun kejadian yang tercatat dari Januari hingga Desember 2025 (0 di setiap bulan)
 - b. Ini adalah capaian mutu yang sangat baik dan menunjukkan bahwa lingkungan rumah sakit relatif aman dari insiden kekerasan.

REKAP IKP BULAN TAHUN 2025

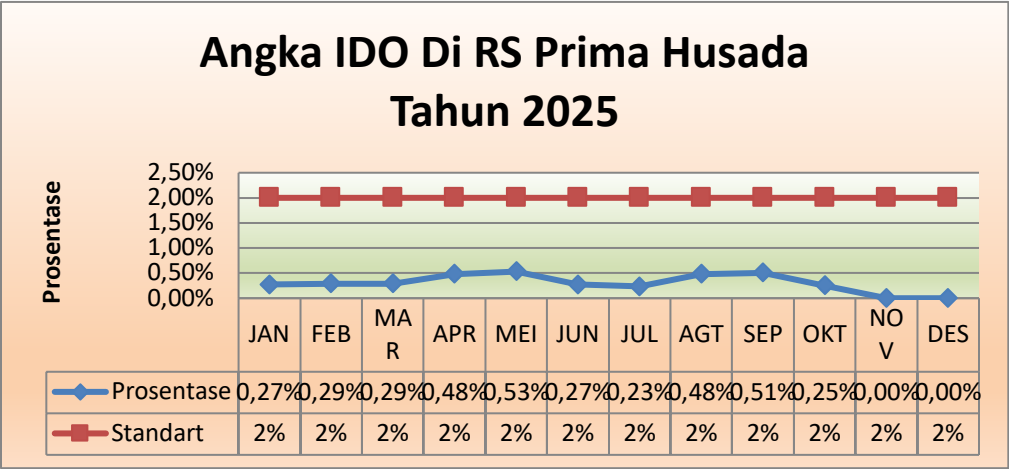
	KPC	KNC	KTC	KTD	SENTINEL
JANUARI	8		2		
FEBRUARI	7				
MARET	10	1	7		
APRIL	8		1		
MEI	7	1	6		
JUNI	6		1		
JULI	12	1	1	2	
AGUSTUS	5		1	6	
SEPTEMBER	11	5		3	2
OKTOBER	13	3	6	4	
NOVEMBER	8	1			
DESEMBER	5	1		1	
JUMLAH	100	13	25	16	2

3.6. Kinerja Produktifitas Komite PPI

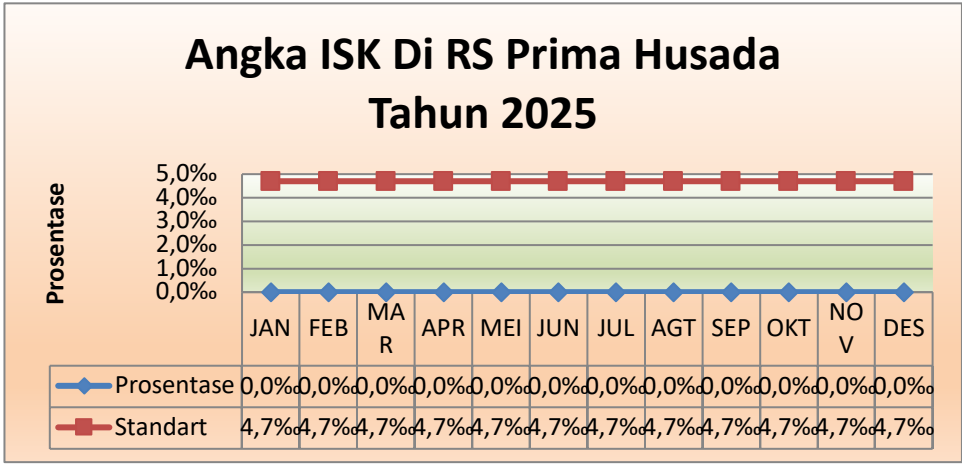
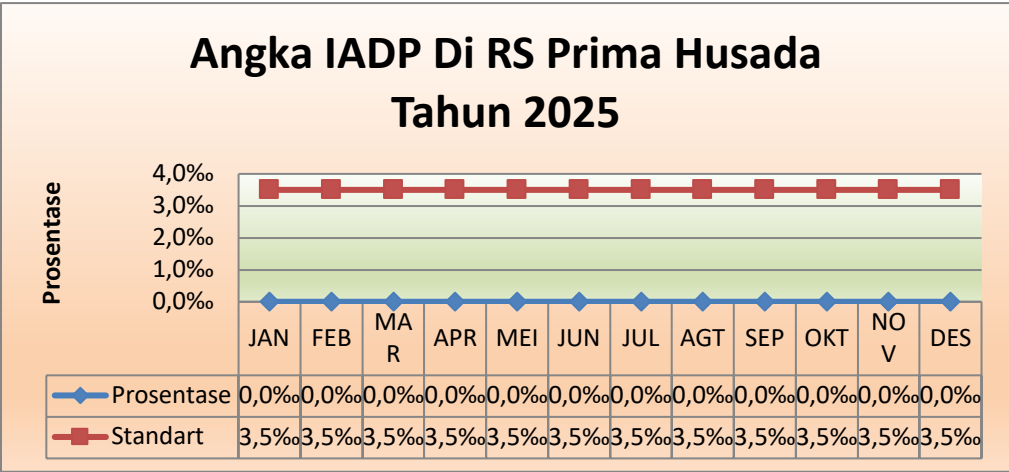
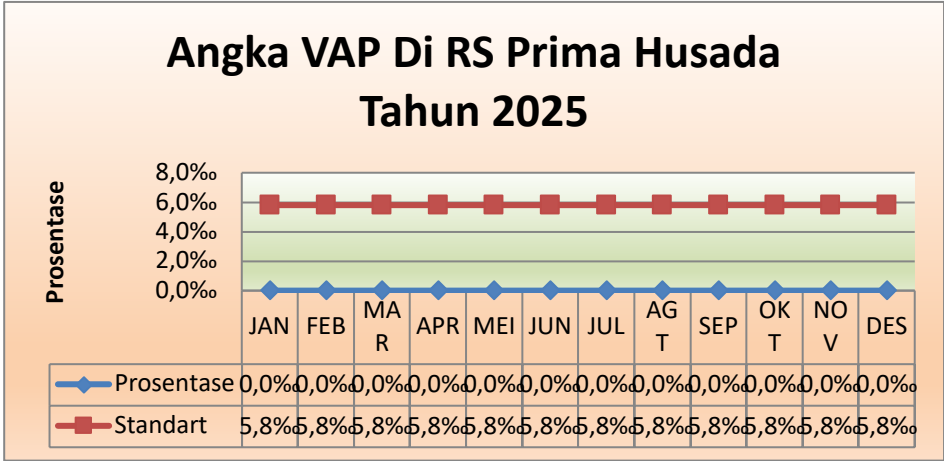
3.6.1 Monitoring Hasil Surveilans HAI's PPI dan Mutu PPI bulan Januari – Desember 2025

Jenis HAI's & Mutu PPI	Standart Nasional	Rate Infeksi % atau ‰ (Tahun 2025)											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
IDO (Infeksi Daerah Operasi)	≤ 2 %	0,27%	0,29%	0,29%	0,48%	0,53%	0,27%	0,23%	0,49%	0,51%	0,25%	0%	0%
IADP (Infeksi Aliran Darah Primer)	≤3,5‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰
VAP (Ventilation Associated Pneumonia)	≤ 5,8 ‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰
ISK (Infeksi Saluran Kencing)	≤ 4,7 ‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰
Infeksi Aliran Darah Perifer /ILI (Phlebitis)	≤ 5 %	0,21%	0,23%	0,23%	0,1%	0,51%	0,61%	0,73%	0,78%	0,42%	0,77%	0,2%	0,1%
Decubitus	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Angka kepatuhan kebersihan tangan	>85%	85,21%	85,35%	85,32%	85,36%	85,49%	85,21%	85,25%	85,38%	85,58%	85,32%	85,57%	85,61%
Angka kepatuhan penggunaan APD oleh petugas	100%	93,01%	93,06%	93,1%	93,39%	93,56%	93,73%	93,79%	94,3%	94,33%	95,1%	96,88%	96,86%
Kepatuhan Pemilahan Sampah Infeksius dan Non Infeksius di Unit Pelayanan	100%	93,44%	93,21%	93,27%	93,42%	93,45%	93,74%	93,77%	94,35%	94,35%	95,24%	97,28%	97,32%
Kejadian petugas tertusuk benda tajam bekas pasien (pajanan)	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0

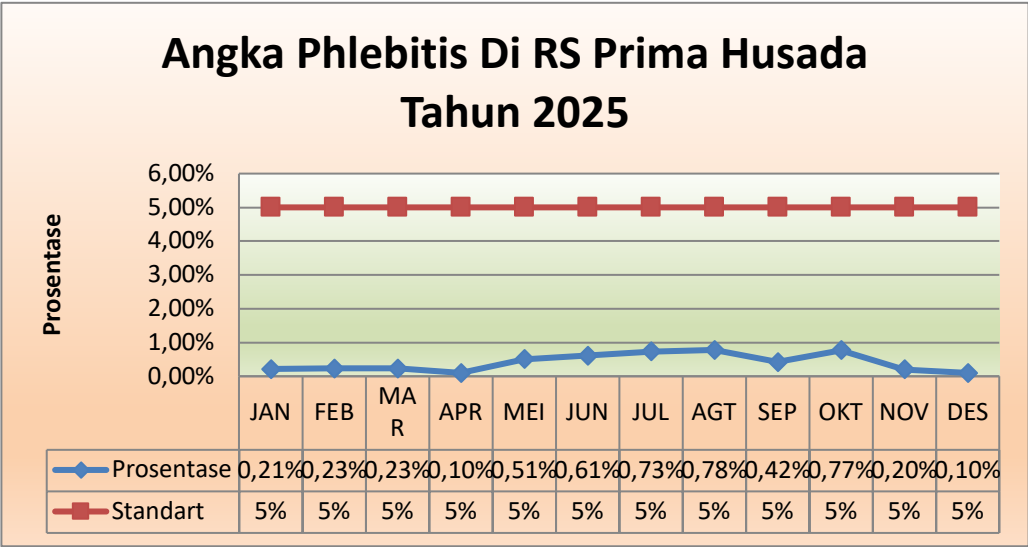
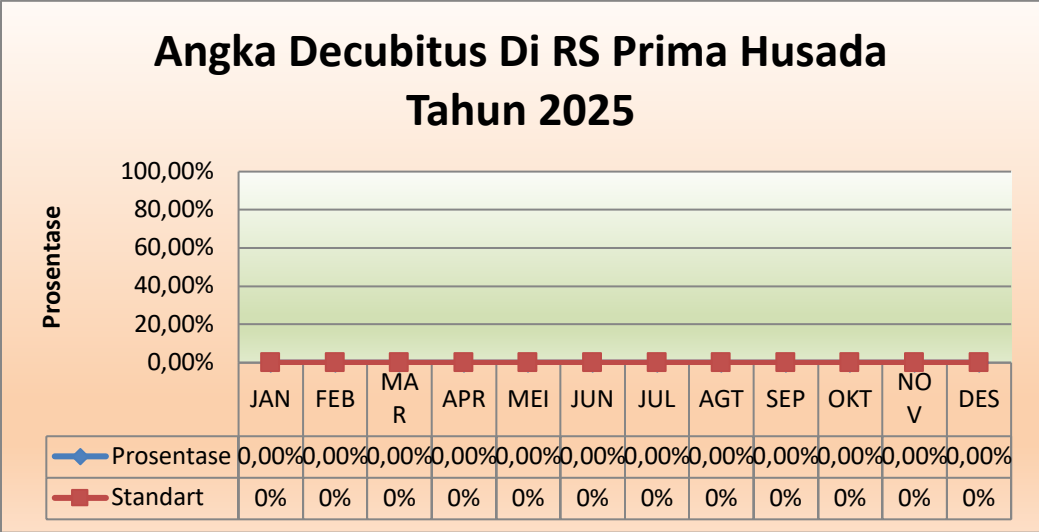
Grafik Monitoring Hasil Surveilans HAI's PPI Tahun 2025



Grafik Monitoring Hasil Surveilans HAI's PPI Tahun 2025



Grafik Monitoring Hasil Surveilans HAI's PPI Tahun 2025



1. Analisa :

Angka HAI's di Rumah Sakit Prima Husada masih memenuhi standar yang ada. Selama tahun 2025, angka IDO jauh di bawah standar yang ditetapkan. Terlihat fluktuasi ringan pada beberapa bulan (April, September), namun tidak menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Angka IDO bulanan berada pada kisaran $\pm 0,27\%$ – $0,53\%$. Pada monitoring VAP, tidak ditemukan kasus VAP selama tahun 2025. Hal ini menunjukkan kepatuhan yang sangat baik terhadap bundle VAP (kebersihan tangan, posisi head-up, oral hygiene, evaluasi ekstubasi). Sama halnya dengan ISK, IADP dan decubitus, pada tahun ini juga memenuhi standar 0%. Sedangkan angka phlebitis masih jauh di bawah standar, meskipun terdapat sedikit peningkatan pada pertengahan tahun (Mei–Agustus). Namun, nilai tersebut tetap dalam batas aman, rata-rata berkisar antara $0,21\%$ – $0,78\%$. Pelaksanaan pemasangan dan perawatan infus sudah cukup baik, namun tetap perlu kewaspadaan.

2. Evaluasi:

1) Capaian

- a. Seluruh indikator HAI's memenuhi bahkan melampaui standar nasional.
- b. Tidak ditemukan kejadian VAP, IADP, ISK, dan decubitus.
- c. Angka IDO dan phlebitis tetap rendah dan terkendali.

2) Faktor Pendukung

- a. Kepatuhan tenaga kesehatan terhadap kebersihan tangan (hand hygiene)

- b. Penerapan bundle PPI secara konsisten.
 - c. Monitoring dan surveilans PPI yang dilakukan secara rutin.
 - d. Edukasi dan sosialisasi PPI kepada tenaga kesehatan berjalan baik.
- 3) Area yang Perlu Diperhatikan
- Fluktuasi ringan pada angka IDO dan phlebitis menunjukkan perlunya: Penguatan supervisi di unit rawat inap dan kamar operasi dan evaluasi teknik pemasangan infus dan perawatan luka operasi.
3. Rekomendasi Tindak Lanjut Tahun Berikutnya:
- a. Mempertahankan capaian nol kasus untuk VAP, IADP, ISK, dan decubitus.
 - b. Meningkatkan audit kepatuhan bundle PPI, khususnya pada tindakan invasif.
 - c. Refresh training PPI secara berkala bagi tenaga kesehatan.
 - d. Analisa kasus individual jika terjadi peningkatan angka IDO atau phlebitis.
 - e. Penguatan budaya keselamatan pasien melalui umpan balik hasil surveilans ke unit kerja.

3.6.1.1 Evaluasi Program Edukasi Pasien, Keluarga Pasien, dan Pengunjung.

Evaluasi:

- 1) Edukasi terhadap pasien dilakukan oleh seluruh unit perawatan dengan materi hand hygiene dan etika batuk serta materi yang berhubungan dengan PPI lainnya seperti PHBS, perawatan luka dan penggunaan obat antibiotik pada seluruh pasien dengan didokumentasikan pada lembar edukasi pada rekam medis menggunakan media leaflet dan praktek langsung.
- 2) Edukasi secara kelompok pasien/keluarga/pengunjung terdokumentasi dengan baik mulai bulan Januari 2025 dengan jadwal minimal 8x/bulan dilakukan di ruang tunggu rawat jalan maupun rawat inap dengan capaian edukasi sebanyak 889 orang yang teredukasi dalam edukasi kelompok dengan jumlah edukasi sebanyak 130 kali edukasi.

3.6.1.2 Evaluasi Program Peningkatan Mutu dan Pelayanan PPI.

- 1) Upaya menurunkan risiko infeksi pada pelayanan pasien.
 - a) Pemantauan kualitas udara.

Evaluasi: dilakukan pemantauan udara pada bulan Juni 2025 di ruang IKO 3, IGD, Isolasi 5C, CSSD dan LAF dengan hasil memenuhi syarat.
 - b) Pemantauan kualitas air.

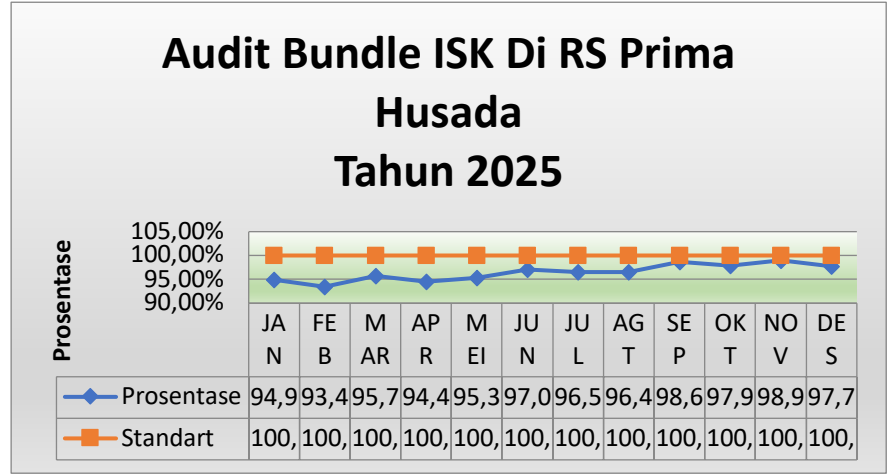
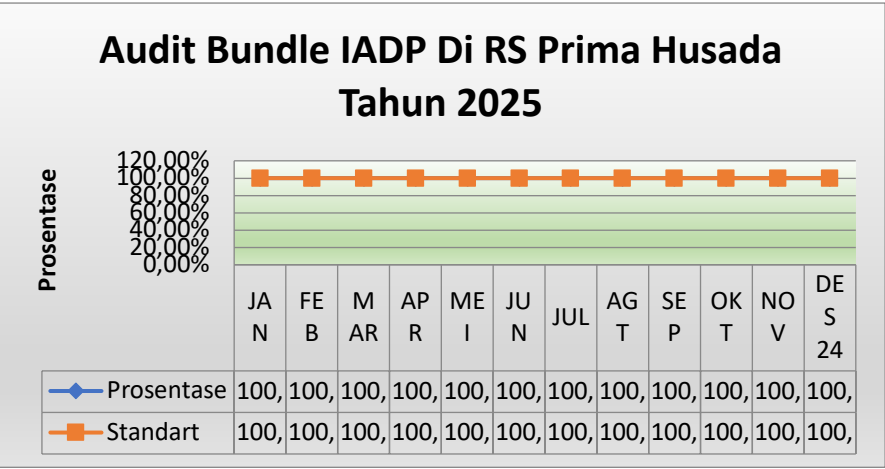
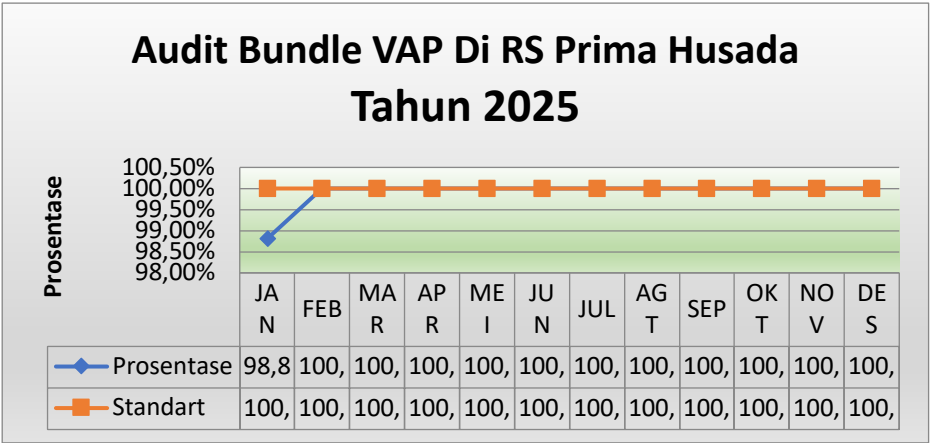
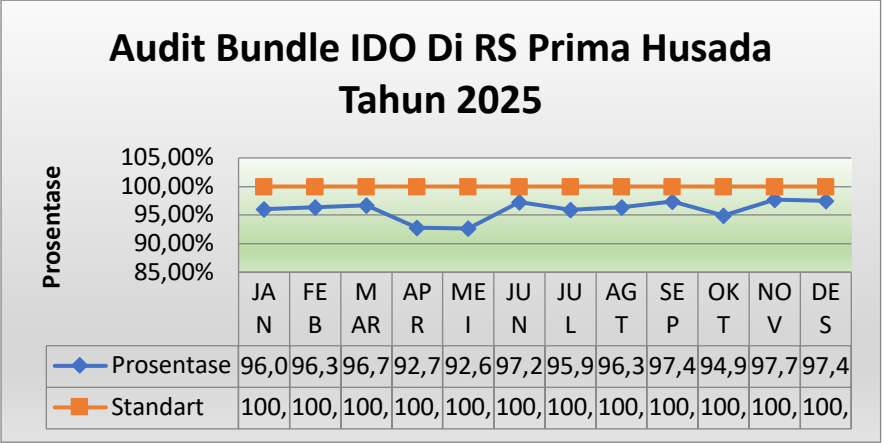
Evaluasi: Pemeriksaan mikrobiologi air bersih dilakukan pada 2 sumber air dengan sampling air di ruang IKO (sumber sumur bor) dan air kran di Gedung DPM dengan hasil memenuhi syarat. Pemeriksaan juga dilakukan pada sumber air minum yang digunakan di RS Prima Husada dengan hasil memenuhi syarat.
 - c) Pemantauan kebersihan lantai & dinding.

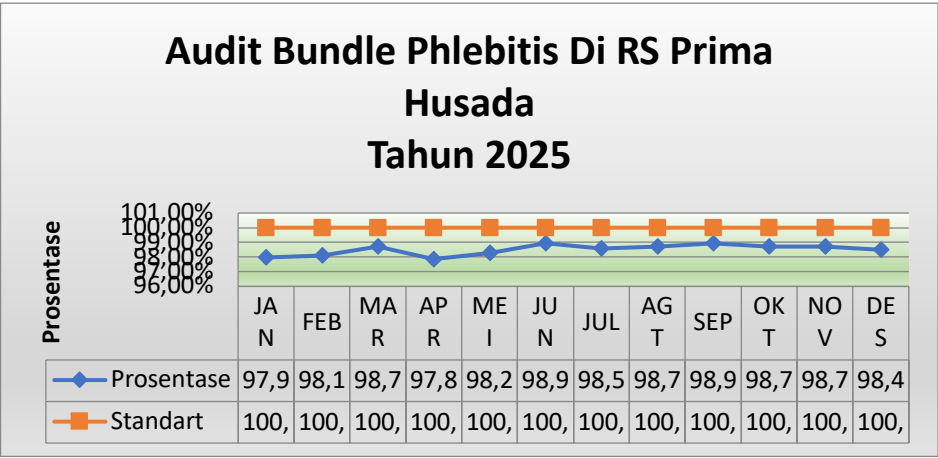
Evaluasi: Sudah dilakukan pemeriksaan swab lantai dan dinding secara rutin pada bulan Juni 2025 pada unit seperti: CSSD, IGD, IKO, IRJA bedah, IRNA 4A, Isolasi 5C, LAF, NICU, Tindakan Maternitas, Dapur (R. Pemorsian) dengan hasil semuanya memenuhi syarat. Desember 2025 sudah dilakukan permohonan kembali pemeriksaan lingkungan namun belum mendapatkan jadwal dari Labkesda ka. Malang.
 - d) Pemantauan sterilitas alat medis, linen, dan meja operasi.

Evaluasi: Sudah dilakukan rutin pemeriksaan swab alat medis steril, linen steril, dan meja operasi pada bulan Juni 2025 dan didapatkan hasil memenuhi syarat yang dilakukan oleh Lab Dinkes Kab. Malang kecuali pada alat rawat luka dimana didapatkan angka lempeng total 10 CFU/cm², nilai normal <1. Evaluasi kembali proses penyeterilan mulai dari cleaning sampai penyeterilan. Dicek kembali alat yang dilakukan pemeriksaan apakah ada yang berkarat atau tidak dan dianjurkan tidak digunakan karena terdapat permukaan yg mulai berkarat. Sudah dilakukan cek fungsi alat steril apakah berfungsi baik, termasuk kertas indikator steril, serta waktu penyeterilan yang sudah sesuai.

3.6.1.3 Monitoring Audit Bundle HAIs.

Grafik Monitoring Audit Bundle HAIs

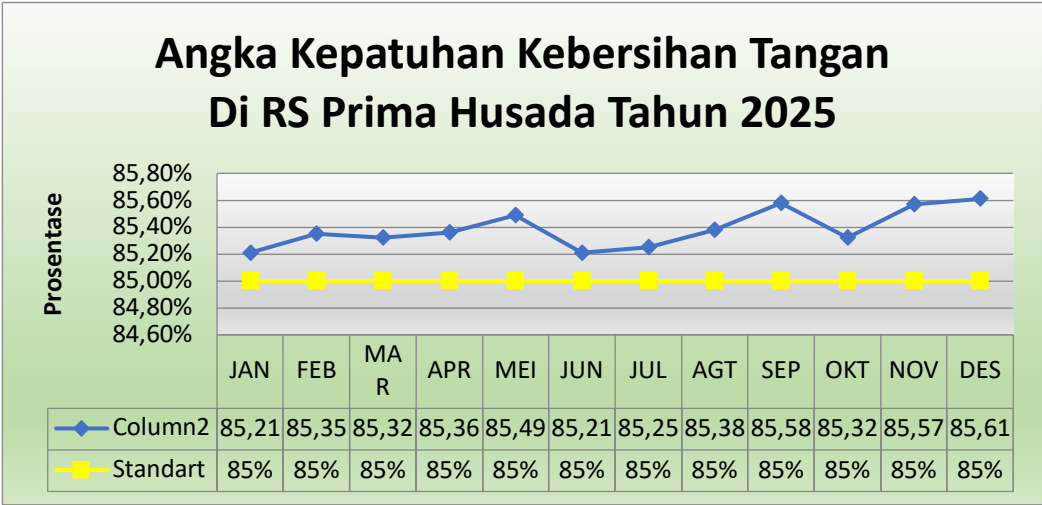




Evaluasi :
Kegiatan pencegahan risiko infeksi (Audit Bundle HAIs) sudah dilakukan dengan baik oleh petugas di unit, namun masih ada beberapa unit yang tidak tertib mendokumentasikan pada form audit bundle HAIs dan Sebagian petugas hanya mengandalkan IPCLN untuk pengisiannya. Dengan disambungkannya data register dengan data audit bundle's HAI's, mempermudah petugas untuk menginputkan data sehingga tidak terlalu bergantung pada IPCLN namun seluruh anggota unit turut aktif.

- e) Melaksanakan pengkajian dampak renovasi / pembongkaran / pembangunan Gedung dengan program ICRA.
Evaluasi: Program ICRA belum berjalan dengan baik pada 2 tahun sebelumnya, belum dapat dilakukan evaluasi pada tahun 2025 dikarenakan belum ada kegiatan renovasi/pembangunan pada tahun 2025 ini, namun terkait dokumentasi kegiatan pada tahun 2024 sudah dilakukan dengan baik.

- 2) Upaya menurunkan risiko infeksi pada petugas kesehatan.
a) Monitoring Kebersihan Tangan bulan Januari – Desember 2025:
Gambar 3.3.4.2 Grafik Monitoring Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan bulan Januari – Desember 2024

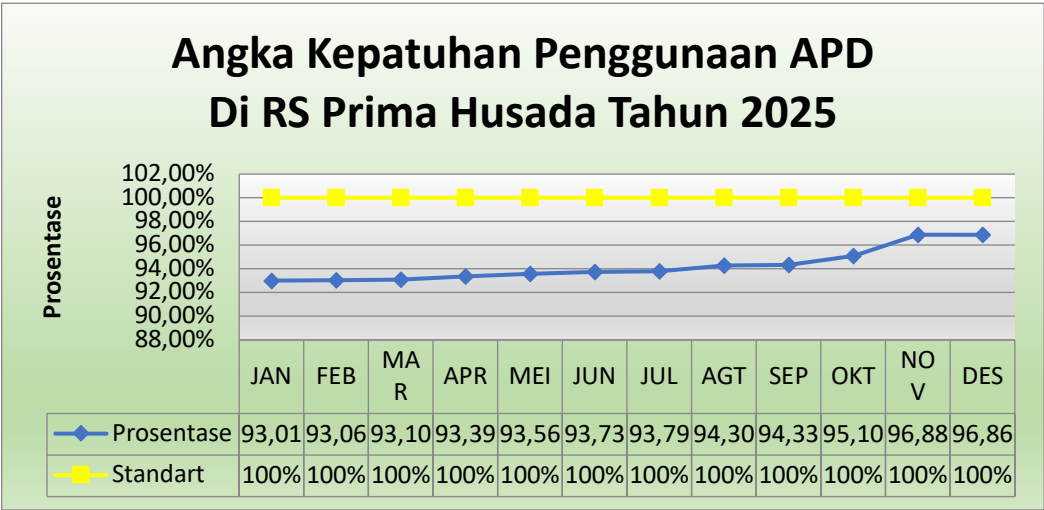


Analisa :
Berdasarkan grafik Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan RS Prima Husada Tahun 2025, terlihat bahwa kepatuhan hand hygiene selama satu tahun berada pada kisaran ±85,21%–85,61%. Secara umum, capaian ini menunjukkan kinerja yang cukup stabil.
Tren data menunjukkan adanya fluktuasi ringan antar bulan. Peningkatan kepatuhan terlihat pada bulan Mei, September, November, dan Desember, dengan

capaian tertinggi pada bulan Desember ($\pm 85,61\%$). Sebaliknya, penurunan relatif terjadi pada bulan Juni dan Oktober, yang mengindikasikan kemungkinan pengaruh beban kerja, kepadatan pasien, atau penurunan kewaspadaan petugas terhadap kepatuhan kebersihan tangan.

Meskipun sebagian besar capaian berada di sekitar standar, kondisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan kebersihan tangan belum sepenuhnya menjadi budaya yang konsisten di seluruh unit. Hal ini menandakan perlunya penguatan edukasi, pengawasan, dan pembinaan berkelanjutan agar kepatuhan dapat meningkat dan dipertahankan secara optimal.

- b) Monitoring Kepatuhan penggunaan APD bulan Januari – Desember 2025:
Gambar 3.3.4.2 Grafik Kepatuhan penggunaan APD RS Prima Husada bulan Januari – Desember 2024



Analisa :
Berdasarkan grafik Angka Kepatuhan Penggunaan APD RS Prima Husada Tahun 2025, terlihat bahwa kepatuhan penggunaan APD selama satu tahun berada pada kisaran 93,01%–96,86%. Secara umum, capaian ini menunjukkan tren peningkatan yang konsisten sepanjang tahun, meskipun belum mencapai standar yang ditetapkan yaitu 100%.
Pada awal tahun (Januari–Maret), angka kepatuhan berada pada kisaran 93,01%–93,10%, kemudian mengalami peningkatan bertahap mulai bulan April hingga Agustus. Peningkatan yang lebih signifikan terlihat pada bulan Oktober hingga Desember, dengan capaian tertinggi pada bulan November dan Desember (96,86%). Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kepatuhan petugas terhadap penggunaan APD seiring dengan penguatan pembinaan dan monitoring.
Meskipun terjadi peningkatan, masih terdapat selisih sekitar 3% dari standar 100%, yang mengindikasikan bahwa kepatuhan penggunaan APD belum sepenuhnya konsisten di seluruh unit dan seluruh waktu. Faktor yang kemungkinan berpengaruh antara lain beban kerja, kepatuhan individu, serta kebiasaan penggunaan APD pada kondisi tertentu.

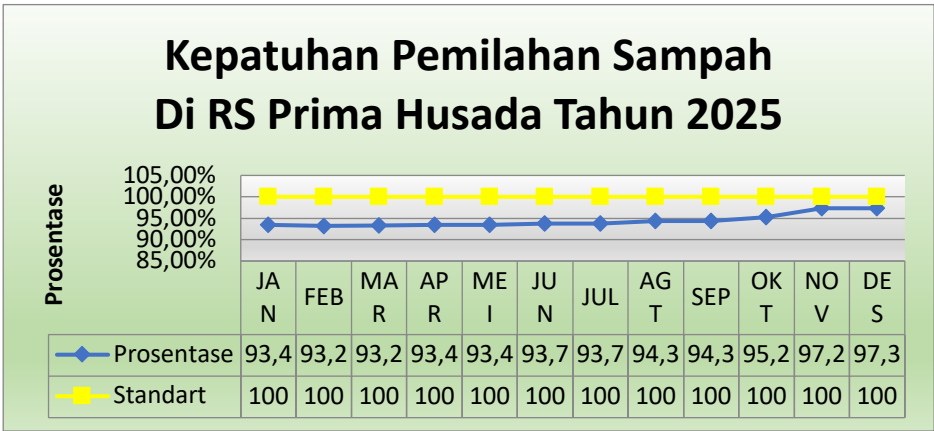
Rencana Tindak Lanjut:

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI / TINDAKAN	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan kepatuhan penggunaan APD sesuai standar	Seluruh tenaga kesehatan	Edukasi ulang penggunaan APD sesuai risiko melalui PPI Quick Tips	Tim PPI / IPCN	Triwulan I 2026
Menutup gap capaian menuju 100%	Unit dengan kepatuhan rendah	Monitoring langsung dan umpan balik hasil observasi	IPCN / Link Nurse	Rutin bulanan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI / TINDAKAN	PELAKSANA	WAKTU
Memperkuat budaya keselamatan kerja	Tenaga kesehatan di unit pelayanan	Penguatan disiplin APD melalui briefing awal shift	Kepala Ruangan	Berkelanjutan
Menjamin ketersediaan APD	Seluruh unit pelayanan	Monitoring stok, distribusi, dan jenis APD sesuai risiko	Logistik, Tim PPI	Rutin
Evaluasi berkelanjutan	Manajemen & unit terkait	Evaluasi capaian indikator penggunaan APD dan pelaporan ke PMKP	Tim PPI / PMKP	Setiap triwulan

- c) Pemeriksaan kesehatan petugas secara berkala.
- Evaluasi:
- 1) Pemeriksaan kesehatan karyawan untuk tahun ini sudah dilakukan mulai tanggal 22 – 28 September 2025, dimana pemeriksaan yang dilakukan meliputi anamnesa & pemeriksaan vital sign, skrining DM (cek GDP), dan pemeriksaan HbsAg untuk all staf dan pemeriksaan tambahan thorax dan cek HIV untuk unit tertentu. Dengan evaluasi kehadiran yang lebih meningkat dari tahun lalu dimana didapatkan 12 orang tidak melakukan MCU rutin tahunan ini, dan bagi yang tidak mengikuti sudah diberikan peringatan oleh SDM dan diwajibkan untuk memberikan hasil tes kesehatan secara mandiri.
 - 2) Belum dilakukan pemeriksaan khusus untuk pendengaran pada petugas laundry, hanya pemeriksaan fisik saja area pendengaran petugas pada saat MCU dan hasilnya masih baik.
 - 3) Sudah dilakukan pemeriksaan rectal swab khusus pada petugas penjamah makanan rutin pada bulan Juli 2025, dengan hasil ada 2 penjamah makanan yang memiliki hasil kuman patogen (Salmonela thypi). Hygiene penjamah makanan sangat penting diperhatikan karena dapat menjadi sumber pembawa penyakit pada pasien. Kedua penjamah makanan tersebut sudah dikonsultasikan pada dokter untuk memperoleh pengobatan.
- d) Monitoring Kepatuhan Pemilahan Sampah Infeksius dan Non Infeksius di Unit Pelayanan

Grafik Kepatuhan Pemilahan Sampah RS Prima Husada bulan Januari – Desember 2025



Analisa:

Berdasarkan grafik Kepatuhan Pemilahan Sampah RS Prima Husada Tahun 2025, terlihat bahwa kepatuhan pemilahan sampah selama satu tahun berada pada kisaran 93,21%–97,32%. Secara umum, capaian ini menunjukkan tren peningkatan yang positif sepanjang tahun, meskipun belum mencapai standar yang ditetapkan

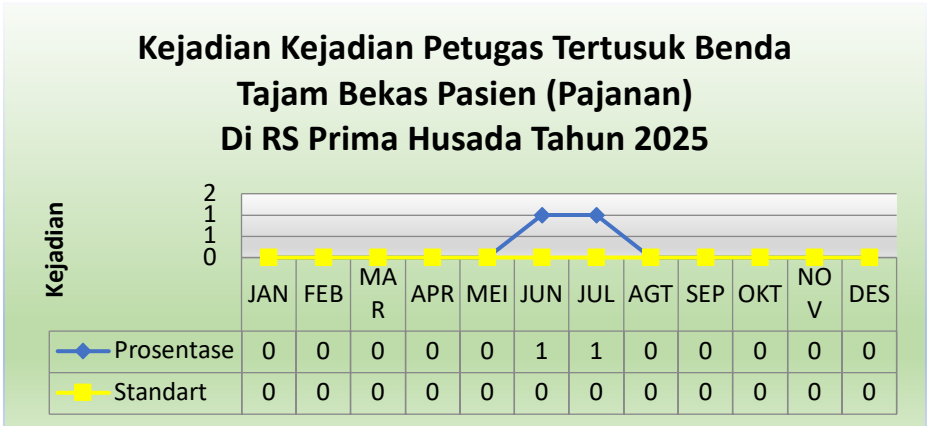
yaitu 100%. Pada periode Januari hingga Mei, tingkat kepatuhan relatif stabil di kisaran 93,21%–93,45%, yang mengindikasikan bahwa pemahaman petugas terhadap pemilahan sampah sudah baik namun belum konsisten sepenuhnya. Mulai Juni hingga Agustus, terlihat peningkatan bertahap hingga mencapai 94,35%–93,77%, dan peningkatan yang lebih signifikan terjadi pada bulan Oktober hingga Desember, dengan capaian tertinggi pada bulan Desember (97,32%). Peningkatan pada akhir tahun menunjukkan bahwa edukasi PPI, pembinaan petugas, serta monitoring pemilahan sampah mulai berjalan lebih efektif. Namun demikian, masih terdapat selisih capaian terhadap standar 100%, yang mengindikasikan perlunya penguatan budaya kepatuhan, pengawasan rutin, dan penegasan kembali SOP pemilahan sampah di seluruh unit pelayanan.

Rencana tindak lanjut:

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI / TINDAKAN	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan kepatuhan pemilahan sampah sesuai standar	Seluruh tenaga kesehatan dan petugas kebersihan	Edukasi ulang pemilahan sampah sesuai kode warna melalui PPI Quick Tips	Tim PPI / IPCN	Triwulan I 2026
Menutup gap capaian menuju 100%	Unit dengan kepatuhan rendah	Monitoring langsung dan umpan balik hasil observasi	IPCN / Sanitarian	Rutin bulanan
Memperkuat budaya disiplin pengelolaan limbah	Tenaga kesehatan & CS	Penguatan disiplin melalui briefing dan reminder visual di area kerja	Kepala Ruangan / IPSRS	Berkelanjutan
Menjamin sarana pemilahan sampah	Seluruh unit pelayanan	Monitoring ketersediaan tempat sampah sesuai warna dan label	IPSRS / Tim PPI	Rutin
Evaluasi berkelanjutan	Manajemen & unit terkait	Evaluasi indikator kepatuhan pemilahan sampah dan pelaporan ke PMKP	Tim PPI / PMKP	Setiap triwulan

e) Penanganan pasca pajanan dari pasien (Terkena benda tajam bekas pasien)

Grafik Kejadian Petugas Tertusuk Benda Tajam Bekas Pasien RS Prima Husada bulan Januari – Desember 2025



Evaluasi :

Masih ditemukan 2 kejadian pajanan infeksius pada tahun ini dan 1 diantaranya dikarenakan kondisi alkes/jarum yang bengkok saat dilakukan penutupan tutup jarum. 1 orang lainnya mengalami pajanan tusukan jarum karena safety box yang tembus jarum, karena pada saat petugas memegang badan safety box, petugas tersebut terkena jarum yang menebus lapisan safety boxnya. Dari hasil tracing pasien, tidak ditemukan penyakit menular pada pasien dan pada saat MCU sudah dilakukan cek HbsAg maupun HIV dan hasilnya baik.

3.7. Kinerja Produktifitas Tim PKRS
3.7.1 Kinerja Produktifitas

NO	BULAN	KEGIATAM	TARGET	HASIL	ANALISA	RENCANA TINDAK LANJUT
1	Januari	Produksi Leaflet Baru	2x/bln	0 buah (0/2)x100% = 0%	Produksi media edukasi cetak dan audiovisual menunjukkan tren peningkatan pada semester kedua. Namun, capaian KIE melalui media sosial dan WAG komunitas belum optimal dan masih fluktuatif. Podcast edukasi belum berjalan konsisten.	1. Penyusunan kalender konten PKRS tahunan 2. Optimalisasikan pemanfaatan media sosial sebagai sarana edukasi pasien dan masyarakat 3. Pengembangan format audio/visual yang lebih menarik dan mudah diproduksi.
		Produksi Poster/Flyer	4x/bln	4 buah (4/4)x100% = 100%		
		Pembuatan Video	1x/bln	2 buah (2/1)x100% = 200%		
		Pembuatan Podcast/ Audio Edukasi	2x/bln	- (0/1)x100% = 0%		
		KIE Massa Rasio Central	-/bln	- (0/25)x100% = 0%		
		Edukasi Feed di Sosmed (IG,FB,Tiktok)	25x/bln	9 (9/12)x100% = 1%		
		Pemberdayaan Komunitas (F-KUL)	2x/bln	2 (2/2)x100% = 100%		
		Pemberdayaan Komunitas (Senmil)	2x/bln	2 (2/2)x100% = 100%		
		Pemberdayaan Komunitas (Shirotul Jannah Akhwat)	2x/bln	2 (2/2)x100%= 100%		
		Pemberdayaan Komunitas (Shirotul Jannah Ikhwan)	2x/bln	2 (2/2)x100%= 100%		
2	Februari	Produksi Leaflet Baru	2x/bln	0 buah (0/2)x100% = 0%		
		Produksi Poster/Flyer	4x/bln	1 buah (1/4)x100% = 0,25%		
		Pembuatan Video	1x/bln	3 buah (3/1)x100% = 300%		
		Pembuatan Podcast/ Audio Edukasi	2x/bln	- (0/1)x100% = 0%		

3		KIE Massa Rasio Central	-/bln	- (0/25)x100% = 0%		
		Edukasi Feed di Sosmed (IG,FB,Tiktok)	25x/bln	12 buah (12/12)x100% = 100%		
		Pemberdayaan Komunitas (F-KUL)	2x/bln	2 (2/2)x100% = 100%		
		Pemberdayaan Komunitas (Senmil)	2x/bln	2 (2/2)x100% = 100%		
		Pemberdayaan Komunitas (Shirotul Jannah Akhwat)	2x/bln	2 (2/2)x100%= 100%		
		Pemberdayaan Komunitas (Shirotul Jannah Ikhwan)	2x/bln	2 (2/2)x100%= 100%		
	Maret	Produksi Leaflet Baru	2x/bln	0 buah (0/2)x100% = 0%		
		Produksi Poster/Flyer	4x/bln	0 buah (0/4)x100% = 0%		
		Pembuatan Video	1x/bln	10 buah (10/1)x100% = 100%		
		Pembuatan Podcast/ Audio Edukasi	2x/bln	- (0/1)x100% = 0%		
		KIE Massa Rasio Central	-/bln	- (0/25)x100% = 0%		
		Edukasi Feed di Sosmed (IG,FB,Tiktok)	25x/bln	16 buah (16/12)x100% = 100%		
		Pemberdayaan Komunitas (F-KUL)	2x/bln	2 (2/2)x100% = 100%		
		Pemberdayaan Komunitas (Senmil)	2x/bln	2 (2/2)x100% = 100%		
		Pemberdayaan Komunitas (Shirotul Jannah Akhwat)	2x/bln	1 (1/2)x100%= 50%		
		Pemberdayaan Komunitas (Shirotul Jannah Ikhwan)	2x/bln	2 (2/2)x100%= 100%		

4	April	Produksi Leaflet Baru	2x/bln	33 buah $(33/2) \times 100\% = 100\%$		
		Produksi Poster/Flyer	4x/bln	0 buah $(0/4) \times 100\% = 0\%$		
		Pembuatan Video	1x/bln	7 buah $(7/1) \times 100\% = 100\%$		
		Pembuatan Podcast/ Audio Edukasi	2x/bln	- $(0/1) \times 100\% = 0\%$		
		KIE Massa Rasio Central	-/bln	- $(0/25) \times 100\% = 0\%$		
		Edukasi Feed di Sosmed (IG,FB,Tiktok)	25x/bln	16 buah $(16/12) \times 100\% = 100\%$		
		Pemberdayaan Komunitas (F-KUL)	2x/bln	1 $(1/2) \times 100\% = 50\%$		
		Pemberdayaan Komunitas (Senmil)	2x/bln	1 $(1/2) \times 100\% = 50\%$		
		Pemberdayaan Komunitas (Shirotul Jannah Akhwat)	2x/bln	1 $(1/2) \times 100\% = 50\%$		
		Pemberdayaan Komunitas (Shirotul Jannah Ikhwan)	2x/bln	2 $(2/2) \times 100\% = 100\%$		
5	Mei	Produksi Leaflet Baru	2x/bln	15 buah $(15/2) \times 100\% = 100\%$		
		Produksi Poster/Flyer	4x/bln	0 buah $(0/4) \times 100\% = 0\%$		
		Pembuatan Video	1x/bln	1 buah $(1/1) \times 100\% = 100\%$		
		Pembuatan Podcast/ Audio Edukasi	2x/bln	- $(0/1) \times 100\% = 0\%$		
		KIE Massa Rasio Central	-/bln	- $(0/25) \times 100\% = 0\%$		
		Edukasi Feed di Sosmed (IG,FB,Tiktok)	25x/bln	12 buah $(12/12) \times 100\% = 100\%$		

		Pemberdayaan Komunitas (F-KUL)	2x/bln	2 (2/2)x100% = 100%		
		Pemberdayaan Komunitas (Senmil)	2x/bln	1 (1/2)x100% = 50%		
		Pemberdayaan Komunitas (Shirotul Jannah Akhwat)	2x/bln	2 (2/2)x100%= 100%		
		Pemberdayaan Komunitas (Shirotul Jannah Ikhwan)	2x/bln	2 (2/2)x100%= 100%		
6	Juni	Produksi Leaflet Baru	2x/bln	0 buah (0/2)x100% = 0%		
		Produksi Poster/Flyer	4x/bln	0 buah (0/4)x100% = 0%		
		Pembuatan Video	1x/bln	1 buah (1/1)x100% = 100%		
		Pembuatan Podcast/ Audio Edukasi	2x/bln	- (0/1)x100% = 0%		
		KIE Massa Rasio Central	-/bln	- (0/25)x100% = 0%		
		Edukasi Feed di Sosmed (IG,FB,Tiktok)	25x/bln	12 buah (12/12)x100% = 100%		
		Pemberdayaan Komunitas (F-KUL)	2x/bln	1 (1/2)x100% = 50%		
		Pemberdayaan Komunitas (Senmil)	2x/bln	2 (2/2)x100% = 100%		
		Pemberdayaan Komunitas (Shirotul Jannah Akhwat)	2x/bln	2 (2/2)x100%= 100%		
		Pemberdayaan Komunitas (Shirotul Jannah Ikhwan)	2x/bln	2 (2/2)x100%= 100%		
7	Juli	Produksi Leaflet Baru	2x/bln	0 buah (0/2)x100% = 0%		
		Produksi Poster/Flyer	4x/bln	1 buah (1/4)x100% = 25%		
		Pembuatan Video	1x/bln	6 buah		

				$(6/1) \times 100\% = 100\%$		
		Pembuatan Podcast/ Audio Edukasi	2x/bln	- $(0/1) \times 100\% = 0\%$		
		KIE Massa Rasio Central	-/bln	- $(0/25) \times 100\% = 0\%$		
		Edukasi Feed di Sosmed (IG,FB,Tiktok)	25x/bln	7 buah $(7/12) \times 100\% = 0,58\%$		
		Pemberdayaan Komunitas (F-KUL)	2x/bln	2 $(2/2) \times 100\% = 100\%$		
		Pemberdayaan Komunitas (Senmil)	2x/bln	2 $(2/2) \times 100\% = 100\%$		
		Pemberdayaan Komunitas (Shirotul Jannah Akhwat)	2x/bln	2 $(2/2) \times 100\% = 100\%$		
		Pemberdayaan Komunitas (Shirotul Jannah Ikhwan)	2x/bln	2 $(2/2) \times 100\% = 100\%$		
8	Agustus	Produksi Leaflet Baru	2x/bln	0 buah $(0/2) \times 100\% = 0\%$		
		Produksi Poster/Flyer	4x/bln	3 buah $(3/4) \times 100\% = 75\%$		
		Pembuatan Video	1x/bln	7 buah $(7/1) \times 100\% = 100\%$		
		Pembuatan Podcast/ Audio Edukasi	2x/bln	- $(0/1) \times 100\% = 0\%$		
		KIE Massa Rasio Central	-/bln	- $(0/25) \times 100\% = 0\%$		
		Edukasi Feed di Sosmed (IG,FB,Tiktok)	25x/bln	8 buah $(8/12) \times 100\% = 0,67\%$		
		Pemberdayaan Komunitas (F-KUL)	2x/bln	2 $(2/2) \times 100\% = 100\%$		
		Pemberdayaan Komunitas (Senmil)	2x/bln	2 $(2/2) \times 100\% = 100\%$		

9	September	Pemberdayaan Komunitas (Shirotul Jannah Akhwat)	2x/bln	2 (2/2)x100%= 100%		
		Pemberdayaan Komunitas (Shirotul Jannah Ikhwan)	2x/bln	2 (2/2)x100%= 100%		
		Produksi Leaflet Baru	2x/bln	2 buah (2/2)x100% = 100%		
		Produksi Poster/Flyer	4x/bln	3 buah (3/4)x100% = 75%		
		Pembuatan Video	1x/bln	3 buah (3/1)x100% = 100%		
		Pembuatan Podcast/ Audio Edukasi	2x/bln	- (0/1)x100% = 0%		
		KIE Massa Rasio Central	-/bln	- (0/25)x100% = 0%		
		Edukasi Feed di Sosmed (IG,FB,Tiktok)	25x/bln	7 buah (7/12)x100% = 0,58%		
		Pemberdayaan Komunitas (F-KUL)	2x/bln	2 (2/2)x100% = 100%		
		Pemberdayaan Komunitas (Senmil)	2x/bln	2 (2/2)x100% = 100%		
		Pemberdayaan Komunitas (Shirotul Jannah Akhwat)	2x/bln	2 (2/2)x100%= 100%		
		Pemberdayaan Komunitas (Shirotul Jannah Ikhwan)	2x/bln	2 (2/2)x100%= 100%		
10	Oktober	Produksi Leaflet Baru	2x/bln	1 buah (1/2)x100% = 50%		
		Produksi Poster/Flyer	4x/bln	0 buah (0/4)x100% = 0%		
		Pembuatan Video	1x/bln	4 buah (4/1)x100% = 100%		
		Pembuatan Podcast/ Audio Edukasi	2x/bln	- (0/1)x100% = 0%		
		KIE Massa Rasio Central	-/bln	-		

				$(0/25) \times 100\% = 0\%$		
		Edukasi Feed di Sosmed (IG,FB,Tiktok)	25x/bln	19 buah $(19/12) \times 100\% = 100\%$		
		Pemberdayaan Komunitas (F-KUL)	2x/bln	2 $(2/2) \times 100\% = 100\%$		
		Pemberdayaan Komunitas (Senmil)	2x/bln	2 $(2/2) \times 100\% = 100\%$		
		Pemberdayaan Komunitas (Shirotul Jannah Akhwat)	2x/bln	2 $(2/2) \times 100\% = 100\%$		
		Pemberdayaan Komunitas (Shirotul Jannah Ikhwan)	2x/bln	2 $(2/2) \times 100\% = 100\%$		
11	November	Produksi Leaflet Baru	2x/bln	0 buah $(0/2) \times 100\% = 0\%$		
		Produksi Poster/Flyer	4x/bln	4 buah $(4/4) \times 100\% = 100\%$		
		Pembuatan Video	1x/bln	4 buah $(4/1) \times 100\% = 100\%$		
		Pembuatan Podcast/ Audio Edukasi	2x/bln	- $(0/1) \times 100\% = 0\%$		
		KIE Massa Rasio Central	-/bln	- $(0/25) \times 100\% = 0\%$		
		Edukasi Feed di Sosmed (IG,FB,Tiktok)	25x/bln	14 buah $(14/12) \times 100\% = 100\%$		
		Pemberdayaan Komunitas (F-KUL)	2x/bln	2 $(2/2) \times 100\% = 100\%$		
		Pemberdayaan Komunitas (Senmil)	2x/bln	2 $(2/2) \times 100\% = 100\%$		
		Pemberdayaan Komunitas (Shirotul Jannah Akhwat)	2x/bln	2 $(2/2) \times 100\% = 100\%$		
		Pemberdayaan Komunitas (Shirotul Jannah Ikhwan)	2x/bln	2 $(2/2) \times 100\% = 100\%$		
12	Desember	Produksi Leaflet Baru	2x/bln	1 buah		

				$(1/2) \times 100\% = 50\%$		
		Produksi Poster/Flyer	4x/bln	4 buah $(4/4) \times 100\% = 100\%$		
		Pembuatan Video	1x/bln	4 buah $(4/1) \times 100\% = 100\%$		
		Pembuatan Podcast/ Audio Edukasi	2x/bln	- $(0/1) \times 100\% = 0\%$		
		KIE Massa Rasio Central	-/bln	- $(0/25) \times 100\% = 0\%$		
		Edukasi Feed di Sosmed (IG,FB,Tiktok)	25x/bln	13 buah $(13/12) \times 100\% = 100\%$		
		Pemberdayaan Komunitas (F-KUL)	2x/bln	2 $(2/2) \times 100\% = 100\%$		
		Pemberdayaan Komunitas (Senmil)	2x/bln	2 $(2/2) \times 100\% = 100\%$		
		Pemberdayaan Komunitas (Shirotul Jannah Akhwat)	2x/bln	2 $(2/2) \times 100\% = 100\%$		
		Pemberdayaan Komunitas (Shirotul Jannah Ikhwan)	2x/bln	2 $(2/2) \times 100\% = 100\%$		

Hasil Kinerja KIE Kelompok Tiap Unit Tahun 2025

No	Bulan	Unit	Target	Capaian	Mandok	Analisa	Rencana Tindak Lanjut
1	Januari	ICU/HCU	4x/bln	4x	Lampiran B	Hasil kinerja KIE kelompok menunjukkan bahwa sebagian unit telah melaksanakan edukasi sesuai target (8x/bln), khususnya unit IRNA. Hal ini menunjukkan meningkatnya kesadaran petugas dalam memberikan edukasi kelompok sebagai bagian dari pelayanan dan komunikasi fektif. Namun, masih terdapat beberapa unit yang belum mencapai target atau belum melaksanakan KIE Kelompok secara konsisten. Kendala utama meliputi keterbatasan waktu petugas, beban kerja pelayanan yang tinggi, serta belum optimalnya peran PIC PKRS unit dalam pengaturan jadwal dan pelaporan kegiatan.	1. Menyusun jadwal KIE kelompok bulanan yang terintegrasi dengan jadwal kerja unit. 2. Memperkuat peran PIC PKRS unit dalam koordinasi dan pelaporan KIE Kelompok 3. Melakukan pendampingan dan supervisi rutin kepada unit dengan capaian rendah. 4. Mengoptimalkan penggunaan media edukasi sederhana (leaflet, radio, audio) untuk mendukung KIE Kelompok 5. Monitoring dan evaluasi capaian KIE Kelompok secara berkala sebagai bagian dari indikator mutu PKRS.
		IRNA 3C	4x/bln	4x	Lampiran B		
		IRNA 2C	4x/bln	4x	Lampiran B		
		IRNA 2,3,4A	4x/bln	4x	Lampiran B		
		IRJA	4x/bln	4x	Lampiran B		
		IRNA 5C	4x/bln	4x	Lampiran B		
		IRNA 6,7,8A	4x/bln	4x	Lampiran B		
		MATERNITAS	4x/bln	4x	Lampiran B		
		PERINA	4x/bln	4x	Lampiran B		
		IGD	4x/bln	1x	Lampiran B		
		FARMASI	4x/bln	4x	Lampiran B		
		GIZI	4x/bln	4x	Lampiran B		
2	Februari	ICU/HCU	4x/bln	2x	Lampiran B	Hasil kinerja KIE kelompok menunjukkan bahwa sebagian unit telah melaksanakan edukasi sesuai target (8x/bln), khususnya unit IRNA. Hal ini menunjukkan meningkatnya kesadaran petugas dalam memberikan edukasi kelompok sebagai bagian dari pelayanan dan komunikasi fektif. Namun, masih terdapat beberapa unit yang belum mencapai target atau belum melaksanakan KIE Kelompok secara konsisten. Kendala utama meliputi keterbatasan waktu petugas, beban kerja pelayanan yang tinggi, serta belum optimalnya peran PIC PKRS unit dalam pengaturan jadwal dan pelaporan kegiatan.	1. Menyusun jadwal KIE kelompok bulanan yang terintegrasi dengan jadwal kerja unit. 2. Memperkuat peran PIC PKRS unit dalam koordinasi dan pelaporan KIE Kelompok 3. Melakukan pendampingan dan supervisi rutin kepada unit dengan capaian rendah. 4. Mengoptimalkan penggunaan media edukasi sederhana (leaflet, radio, audio) untuk mendukung KIE Kelompok 5. Monitoring dan evaluasi capaian KIE Kelompok secara berkala sebagai bagian dari indikator mutu PKRS.
		IRNA 3C	4x/bln	4x	Lampiran B		
		IRNA 2C	4x/bln	4x	Lampiran B		
		IRNA 2,3,4A	4x/bln	4x	Lampiran B		
		IRJA	4x/bln	4x	Lampiran B		
		IRNA 5C	4x/bln	4x	Lampiran B		
		IRNA 6,7,8A	4x/bln	4x	Lampiran B		
		MATERNITAS	4x/bln	4x	Lampiran B		
		PERINA	4x/bln	4x	Lampiran B		
		IGD	4x/bln	0x	Lampiran B		
		FARMASI	4x/bln	4x	Lampiran B		
		GIZI	4x/bln	4x	Lampiran B		
3	Maret	ICU/HCU	4x/bln	4x	Lampiran B	Hasil kinerja KIE kelompok menunjukkan bahwa sebagian unit telah melaksanakan edukasi sesuai target (8x/bln), khususnya unit IRNA. Hal ini menunjukkan meningkatnya kesadaran petugas dalam memberikan edukasi kelompok sebagai bagian dari pelayanan dan komunikasi fektif. Namun, masih terdapat beberapa unit yang belum mencapai target atau belum melaksanakan KIE Kelompok secara konsisten. Kendala utama meliputi keterbatasan waktu petugas, beban kerja pelayanan yang tinggi, serta belum optimalnya peran PIC PKRS unit dalam pengaturan jadwal dan pelaporan kegiatan.	1. Menyusun jadwal KIE kelompok bulanan yang terintegrasi dengan jadwal kerja unit. 2. Memperkuat peran PIC PKRS unit dalam koordinasi dan pelaporan KIE Kelompok 3. Melakukan pendampingan dan supervisi rutin kepada unit dengan capaian rendah. 4. Mengoptimalkan penggunaan media edukasi sederhana (leaflet, radio, audio) untuk mendukung KIE Kelompok 5. Monitoring dan evaluasi capaian KIE Kelompok secara berkala sebagai bagian dari indikator mutu PKRS.
		IRNA 3C	4x/bln	4x	Lampiran B		
		IRNA 2C	4x/bln	4x	Lampiran B		
		IRNA 2,3,4A	4x/bln	4x	Lampiran B		

		IRJA	4x/bln	4x	Lampiran B		
		IRNA 5C	4x/bln	4x	Lampiran B		
		IRNA 6,7,8A	4x/bln	4x	Lampiran B		
		MATERNITAS	4x/bln	4x	Lampiran B		
		PERINA	4x/bln	4x	Lampiran B		
		IGD	4x/bln	4x	Lampiran B		
		FARMASI	4x/bln	4x	Lampiran B		
		GIZI	4x/bln	4x	Lampiran B		
4	April	ICU/HCU	4x/bln	3x	Lampiran B		
		IRNA 3C	4x/bln	4x	Lampiran B		
		IRNA 2C	4x/bln	4x	Lampiran B		
		IRNA 2,3,4A	4x/bln	4x	Lampiran B		
		IRJA	4x/bln	4x	Lampiran B		
		IRNA 5C	4x/bln	4x	Lampiran B		
		IRNA 6,7,8A	4x/bln	4x	Lampiran B		
		MATERNITAS	4x/bln	4x	Lampiran B		
		PERINA	4x/bln	4x	Lampiran B		
		IGD	4x/bln	4x	Lampiran B		
		FARMASI	4x/bln	4x	Lampiran B		
		GIZI	4x/bln	4x	Lampiran B		
5	Mei	ICU/HCU	4x/bln	4x	Lampiran B		
		IRNA 3C	4x/bln	4x	Lampiran B		
		IRNA 2C	4x/bln	4x	Lampiran B		
		IRNA 2,3,4A	4x/bln	4x	Lampiran B		
		IRJA	4x/bln	4x	Lampiran B		
		IRNA 5C	4x/bln	2x	Lampiran B		
		IRNA 6,7,8A	4x/bln	4x	Lampiran B		
		MATERNITAS	4x/bln	4x	Lampiran B		
		PERINA	4x/bln	4x	Lampiran B		
		IGD	4x/bln	4x	Lampiran B		
		FARMASI	4x/bln	4x	Lampiran B		

6	Juni	GIZI	4x/bln	4x	Lampiran B		
		ICU/HCU	4x/bln	4x	Lampiran B		
		IRNA 3C	4x/bln	4x	Lampiran B		
		IRNA 2C	4x/bln	4x	Lampiran B		
		IRNA 2,3,4A	4x/bln	4x	Lampiran B		
		IRJA	4x/bln	4x	Lampiran B		
		IRNA 5C	4x/bln	4x	Lampiran B		
		IRNA 6,7,8A	4x/bln	2x	Lampiran B		
		MATERNITAS	4x/bln	4x	Lampiran B		
		PERINA	4x/bln	4x	Lampiran B		
		IGD	4x/bln	4x	Lampiran B		
		FARMASI	4x/bln	4x	Lampiran B		
		GIZI	4x/bln	4x	Lampiran B		
7	Juli	ICU/HCU	4x/bln	4x	Lampiran B		
		IRNA 3C	4x/bln	4x	Lampiran B		
		IRNA 2C	4x/bln	4x	Lampiran B		
		IRNA 2,3,4A	4x/bln	4x	Lampiran B		
		IRJA	4x/bln	4x	Lampiran B		
		IRNA 5C	4x/bln	1x	Lampiran B		
		IRNA 6,7,8A	4x/bln	0x	Lampiran B		
		MATERNITAS	4x/bln	4x	Lampiran B		
		PERINA	4x/bln	4x	Lampiran B		
		IGD	4x/bln	4x	Lampiran B		
		FARMASI	4x/bln	4x	Lampiran B		
		GIZI	4x/bln	4x	Lampiran B		
8	Agustus	ICU/HCU	4x/bln	4x	Lampiran B		
		IRNA 3C	4x/bln	4x	Lampiran B		
		IRNA 2C	4x/bln	4x	Lampiran B		
		IRNA 2,3,4A	4x/bln	4x	Lampiran B		
		IRJA	4x/bln	4x	Lampiran B		
		IRNA 5C	4x/bln	4x	Lampiran B		

		IRNA 6,7,8A	4x/bln	3x	Lampiran B		
		MATERNITAS	4x/bln	4x	Lampiran B		
		PERINA	4x/bln	4x	Lampiran B		
		IGD	4x/bln	4x	Lampiran B		
		FARMASI	4x/bln	4x	Lampiran B		
		GIZI	4x/bln	4x	Lampiran B		
9	September	ICU/HCU	4x/bln	4x	Lampiran B		
		IRNA 3C	4x/bln	4x	Lampiran B		
		IRNA 2C	4x/bln	4x	Lampiran B		
		IRNA 2,3,4A	4x/bln	4x	Lampiran B		
		IRJA	4x/bln	4x	Lampiran B		
		IRNA 5C	4x/bln	4x	Lampiran B		
		IRNA 6,7,8A	4x/bln	1x	Lampiran B		
		MATERNITAS	4x/bln	4x	Lampiran B		
		PERINA	4x/bln	4x	Lampiran B		
		IGD	4x/bln	4x	Lampiran B		
		FARMASI	4x/bln	4x	Lampiran B		
		GIZI	4x/bln	4x	Lampiran B		
10	Oktober	ICU/HCU	4x/bln	4x	Lampiran B		
		IRNA 3C	4x/bln	0x	Lampiran B		
		IRNA 2C	4x/bln	4x	Lampiran B		
		IRNA 2,3,4A	4x/bln	4x	Lampiran B		
		IRJA	4x/bln	4x	Lampiran B		
		IRNA 5C	4x/bln	2x	Lampiran B		
		IRNA 6,7,8A	4x/bln	0x	Lampiran B		
		MATERNITAS	4x/bln	4x	Lampiran B		
		PERINA	4x/bln	4x	Lampiran B		
		IGD	4x/bln	4x	Lampiran B		
		FARMASI	4x/bln	4x	Lampiran B		
		GIZI	4x/bln	4x	Lampiran B		
11	November	ICU/HCU	4x/bln	4x	Lampiran B		

		IRNA 3C	4x/bln	0x	Lampiran B		
		IRNA 2C	4x/bln	4x	Lampiran B		
		IRNA 2,3,4A	4x/bln	4x	Lampiran B		
		IRJA	4x/bln	4x	Lampiran B		
		IRNA 5C	4x/bln	0x	Lampiran B		
		IRNA 6,7,8A	4x/bln	0x	Lampiran B		
		MATERNITAS	4x/bln	4x	Lampiran B		
		PERINA	4x/bln	4x	Lampiran B		
		IGD	4x/bln	4x	Lampiran B		
		FARMASI	4x/bln	4x	Lampiran B		
		GIZI	4x/bln	4x	Lampiran B		
12	Desember	ICU/HCU	4x/bln	4x	Lampiran B		
		IRNA 3C	4x/bln	0x	Lampiran B		
		IRNA 2C	4x/bln	4x	Lampiran B		
		IRNA 2,3,4A	4x/bln	4x	Lampiran B		
		IRJA	4x/bln	4x	Lampiran B		
		IRNA 5C	4x/bln	0x	Lampiran B		
		IRNA 6,7,8A	4x/bln	0x	Lampiran B		
		MATERNITAS	4x/bln	4x	Lampiran B		
		PERINA	4x/bln	4x	Lampiran B		
		IGD	4x/bln	4x	Lampiran B		
		FARMASI	4x/bln	4x	Lampiran B		
		GIZI	4x/bln	4x	Lampiran B		

3.7.2 KIE Upaya Preventif dan Promotif Prognas

Tabel Hasil Kinerja Upaya Proven Program Nasional (Edukasi Kelompok/Massa/Seminar/ WS) Tahun 2025

NO	BULAN	MATERI	TARGET	CAPAIAN	BUKTI DI FORM EDUKASI TERINTEGRASI/KOLABORASI	ANALISA	RENCANA TINDAK LANJUT
1	Januari	TBC	4x/bln	-	-	Hasil kinerja proven program nasional menunjukkan bahwa pelaksanaan edukasi untuk beberapa materi prioritas seperti TBC, HIV/AIDS, PONEK-KIA dan KB telah terlaksana, meskipun sebagian belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan. Sementara itu, edukasi terakait stunting/wasting belum berjalan optimal. Kondisi ini dipengaruhi oleh belum terintegrasinya jadwal edukasi proven dengan kegiatan rutin unit dan lintas program. Akibatnya penyampaian edukasi program nasional kepada pasien dan keluarga belum merata.	1. Menyusun jadwal edukasi PROGNAS yang terintegrasi dengan kegiatan PKRS dan unit pelayanan 2. Menetapkan materi PROGNAS prioritas sebagai bagian wajib edukasi kelompok dan individu sesuai karakteristik unit 3. Meningkatkan koordinasi lintas program (PKRS, PPI, KIA, GIZI, PMKP) dalam pelaksanaan edukasi PROGNAS 4. mengoptimalkan penggunaan media edukasi cetak dan digital untuk materi prognas 5. monitoring dan evaluasi rutin capaian PROGNAS sebagai bagian dari indikator mutu PKRS dan RS.
		HIV/AIDS	4x/bln	-	-		
		Stunting/Wasting	4x/bln	1	√		
		Ponek-KIA	4x/bln	-	-		
		KB	4x/bln	-	-		
2	Februari	TBC	4x/bln	-	-		
		HIV/AIDS	4x/bln	-	-		
		Stunting/Wasting	4x/bln	-	-		
		Ponek-KIA	4x/bln	-	-		
		KB	4x/bln	-	-		
3	Maret	TBC	4x/bln	-	-		
		HIV/AIDS	4x/bln	-	-		
		Stunting/Wasting	4x/bln	-	-		
		Ponek-KIA	4x/bln	-	-		
		KB	4x/bln	-	-		
4	April	TBC	4x/bln	-	-		
		HIV/AIDS	4x/bln	-	-		
		Stunting/Wasting	4x/bln	-	-		
		Ponek-KIA	4x/bln	-	-		
		KB	4x/bln	-	-		
5	Mei	TBC	4x/bln	-	-		
		HIV/AIDS	4x/bln	-	-		
		Stunting/Wasting	4x/bln	-	-		
		Ponek-KIA	4x/bln	-	-		
		KB	4x/bln	-	-		

6	Juni	TBC	4x/bln	-	-		
		HIV/AIDS	4x/bln	-	-		
		Stunting/Wasting	4x/bln	-	-		
		Ponek-KIA	4x/bln	1	√		
		KB	4x/bln	-	-		
7	Juli	TBC	4x/bln	-	√		
		HIV/AIDS	4x/bln	-	√		
		Stunting/Wasting	4x/bln	3	√		
		Ponek-KIA	4x/bln	-	√		
		KB	4x/bln	-	√		
8	Agustus	TBC	4x/bln	1	√		
		HIV/AIDS	4x/bln	-	-		
		Stunting/Wasting	4x/bln	1	√		
		Ponek-KIA	4x/bln	1	√		
		KB	4x/bln	-	-		
9	September	TBC	4x/bln	-	-		
		HIV/AIDS	4x/bln	-	-		
		Stunting/Wasting	4x/bln	-	-		
		Ponek-KIA	4x/bln	4	√		
		KB	4x/bln	-	-		
10	Oktober	TBC	4x/bln	-	√		
		HIV/AIDS	4x/bln	-	√		
		Stunting/Wasting	4x/bln	1	√		
		Ponek-KIA	4x/bln	3	√		
		KB	4x/bln	-	√		
11	November	TBC	4x/bln	-	-		
		HIV/AIDS	4x/bln	-	-		
		Stunting/Wasting	4x/bln	3	√		
		Ponek-KIA	4x/bln	4	√		
		KB	4x/bln	1	√		
12	Desember	TBC	4x/bln	-	-		

		HIV/AIDS	4x/bln	-	-		
		Stunting/Wasting	4x/bln	4	√		
		Ponek-KIA	4x/bln	4	√		
		KB	4x/bln	1	√		

3.7.3 Pembinaan Komunitas Berbasis RS Prima Husada Malang

Tabel Hasil Kinerja Pembinaan Komunitas berbasis RS Prima Husada MalangTahun 2025

BULAN	NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN	RINCIAN KEGIATAN	CAPAIAN	JML PESERTA	DOKUMENTASI
JANUARI	1	Senam Hamil	09 Januari 2025	- Pemeriksaan Kesehatan - Demonstrasi Senam - Penyuluhan Kesehatan (Stunting & Persiapan Persalinan) - Hypnopregnancy	50%	@18	-
						-	-
	2.	Senam Lansia	10 Januari 2025	- Pemeriksaan Kesehatan - Senam - Hipno - Pemberian Snack - Penyuluhan Kesehatan	100%	@38	-
			24 Januari 2025			@20	-
	3.	Shirothul Jannah Perempuan	08 Januari 2025	Pengajian Bersama Ustadzah Ucik dan Ustdz Sudirman	50%	@146	-
			22 Januari 2025	LIBUR NATAL		@193	-
	4.	Shirothul Jannah Ikhwan	11 Januari 2025	Pengajian Bersama Ustadz Sudirman	100%	@19	-
			25 Januari 2025			@18	-
BULAN	NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN	RINCIAN KEGIATAN	CAPAIAN	Jml Peserta	DOKUMENTASI

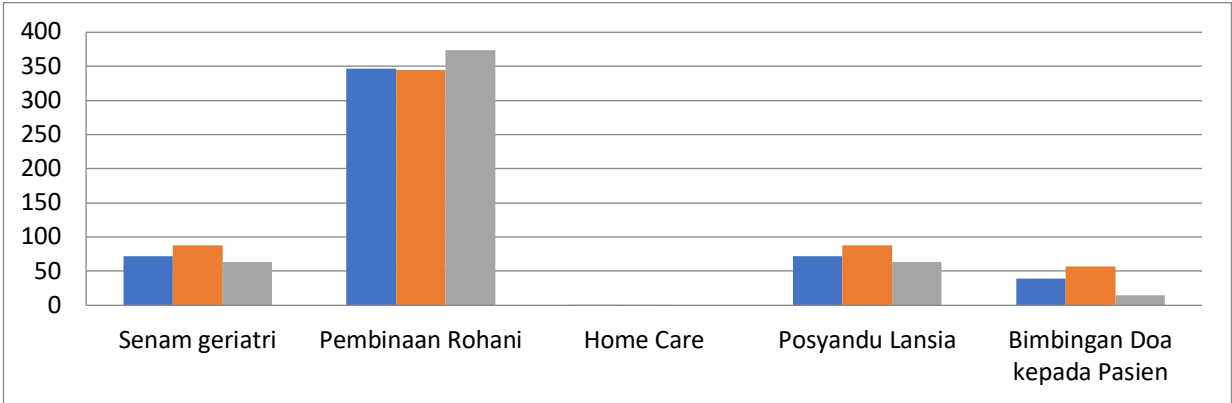
FEBRUARI	1	Senam Hamil	-	- Pemeriksaan Kesehatan - Demonstrasi Senam - Penyuluhan Kesehatan (Stunting & Persiapan Persalinan) Hypnopregnancy	50%	-	-
			12 Februari 2025			@29	-
	2.	Senam Lansia	14 Februari 2025	- Pemeriksaan Kesehatan - Senam - Hipno - Pemberian Snack - Penyuluhan Kesehatan	100%	@26	-
			28 Februari 2025			@25	-
	3.	Shirothul Jannah Perempuan	11 Februari 2025	Pengajian Bersama Ustdz Sudirman	50%	@139	-
			25 Februari 2025	Pengajian Bersama Ustadzah Ucik		@189	-
	4.	Shirothul Jannah Ikhwan	1 Februari 2025	Pengajian Bersama Ustadz Sudirman	100%	@19	-
			15 Februari 2025			@23	-

3.8. Kinerja Produktifitas Tim Geriatri
3.8.1 Laporan Komunitas Geriatri

Tabel Jumlah Peserta Kegiatan Komunitas Geriatri Triwulan III Tahun 2025

No.	Jenis Kegiatan	Jumlah		
		Juli 2025	Agustus 2025	September 2025
1.	Senam Geriatri	72 Peserta	88 Peserta	64 Peserta
2.	Pembinaan Rohani (Pengajian)	347 Peserta	345 Peserta	374 Peserta
3.	Home Care	1x Kunjungan	1x Kunjungan	0
4.	Posyandu Lansia : 1. MCU 2. KIE 3. Seminar 4. Hipnoterapi 5. Game	72 Peserta	88 Peserta	64 Peserta
5	Bimbingan Doa kepada Pasien	39 Pasien	57 Pasien	15 Pasien

Grafik Jumlah Peserta Kegiatan Komunitas Geriatri Bulan Juli – September 2025



Analisis :

- 1) Terjadi peningkatan jumlah peserta senam geriatri, posyandu lansia dan bimbingan doa kepada pasien dari bulan Juli ke bulan Agustus 2025 dan mengalami penurunan di bulan September 2025.
- 2) Terjadi penurunan jumlah peserta pembinaan rohani (pengajian pada bulan Agustus 2025, kemudian meningkat kembali pada bulan September 2025.
- 3) Kegiatan home care dilakukan selama 2x pada bulan Juli dan bulan Agustus 2025.

Rencana Tindak Lanjut :

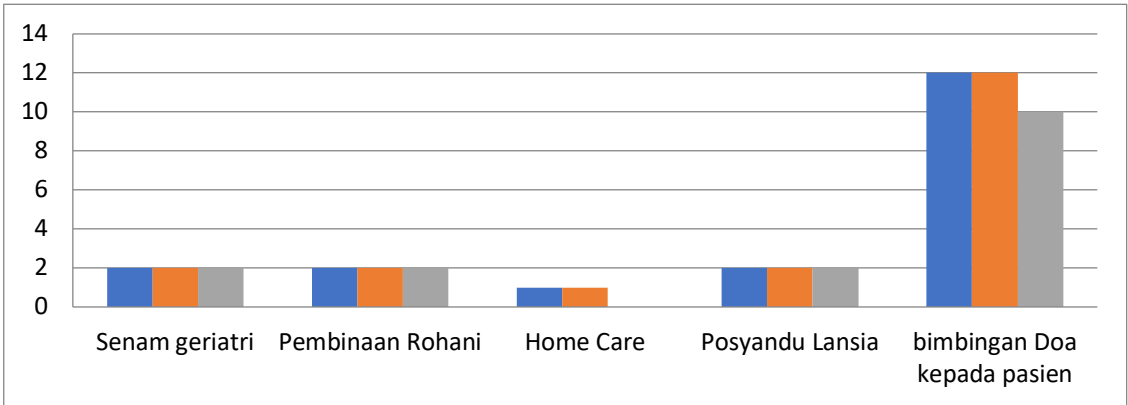
- 1) Mulai melakukan kembali kegiatan home care dan posyandu lansia serta meningkatkan pelayanan pada kegiatan senam geriatri dan pembinaan rohani (pengajian).
- 2) Secara rutin melaksanakan rapat tim geriatri untuk meningkatkan pelayanan kegiatan geriatri serta monitoring dan evaluasi kegiatan.

Tabel Frekuensi Kegiatan Komunitas Geriatri Bulan Triwulan III Tahun 2025 di RS Prima Husada Malang

No.	Jenis Kegiatan	Target/ Standar	Tahun 2025					
			Juli		Agustus		September	
			Jml	Pencapaian	Jml	Pencapaian	Jml	Pencapaian
1.	Senam Geriatri	2x/bulan	2x	Tercapai	2x	Tercapai	2x	Tercapai

2.	Pembinaan Rohani (Pengajian)	2x/bulan	2x	Tercapai	2x	Tercapai	2x	Tercapai
3.	Home Care	1x/bulan	1x	Tercapai	1x	Tercapai	0	Tidak Tercapai
4.	Posyandu Lansia : 1. MCU 2. KIE 3. Seminar 4. Hipnoterapi 5. Game	2x/bulan	2x	Tercapai	2x	Tercapai	2x	Tercapai
5.	Bimbingan Doa Kepada Pasien	12x/ Bulan	12x	Tercapai	12x	Tercapai	10x	Tidak Tercapai

Grafik Frekuensi Kegiatan Komunitas geriatri Bulan Triwulan III Tahun 2025 di RS Prima Husada Malang

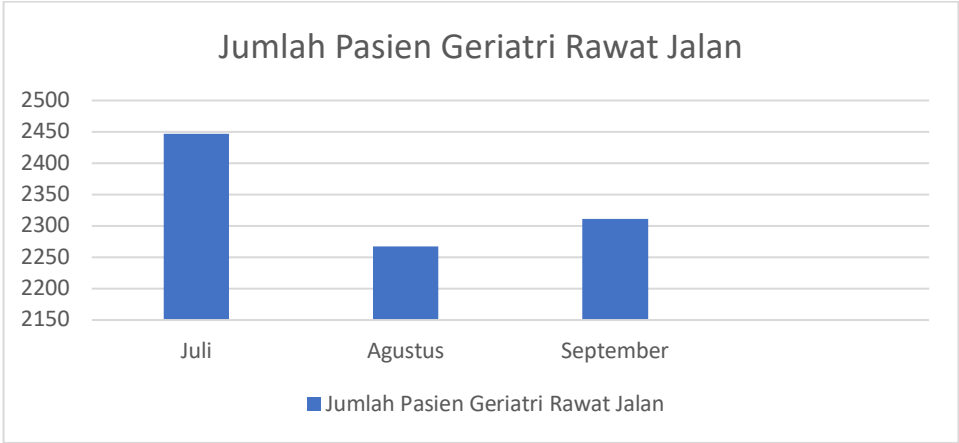


3.8.2 Laporan Cakupan Kunjungan Pasien Geriatri Rawat Jalan Triwulan Iii (Bulan Juli – September 2025)

Tabel Jumlah Pasien Geriatri Rawat Jalan

No.	Bulan	Jumlah
1.	Juli	2447 Pasien
2.	Agustus	2267 Pasien
3.	September	2311 Pasien

Grafik Jumlah Pasien Geriatri Rawat Jalan



Analisa:
Terjadi Penurunan secara signifikan jumlah pasien Geriatri Rawat Jalan pada bulan Agustus 2025 kemudian meningkat kembali pada bulan September 2025.

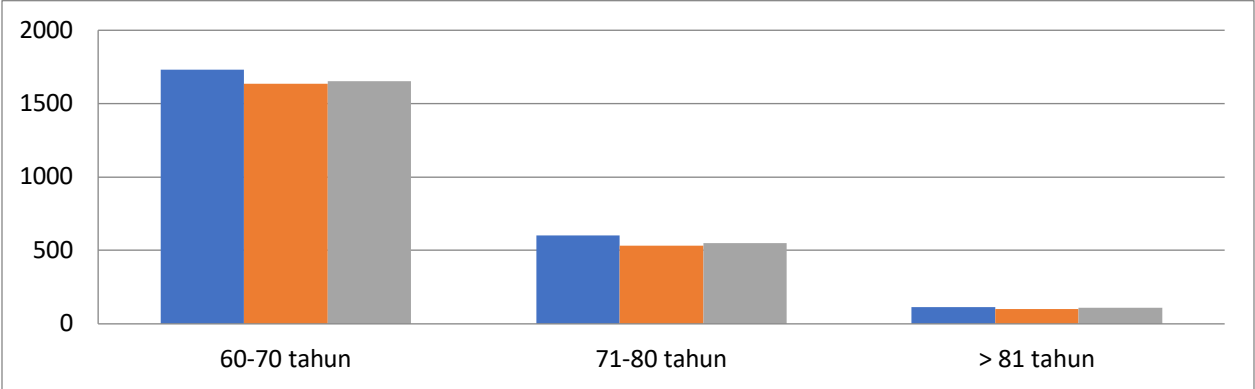
Rencana Tindak Lanjut :

Melakukan peningkatan pelayanan geriatri di rumah sakit agar tetap menjadi rumah sakit rujukan bagi masyarakat serta memberikan edukasi ke pada pasien dan keluarga agar rajin dan teratur untuk memeriksakan pasien geriatri ke Rumah Sakit.

Tabel Jumlah Pasien Geriatri Rawat Jalan Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah		
		Juli	Agustus	September
1.	60-70 tahun	1733 pasien	1636 pasien	1652 pasien
2.	71-80 tahun	602 pasien	532 pasien	551 pasien
3.	> 81 tahun	112 pasien	99 pasien	108 pasien

Grafik Jumlah Pasien Geriatri Rawat Jalan Berdasarkan Usia Bulan Juli – September 2025



Analisis :

Terjadi penurunan jumlah pasien geriatri pada semua rentang usia (60-70 tahun, 61-70 tahun dan >81 tahun) dari bulan Juli 2025 sampai bulan Agustus 2025, kemudian meningkat kembali pada bulan September 2025.

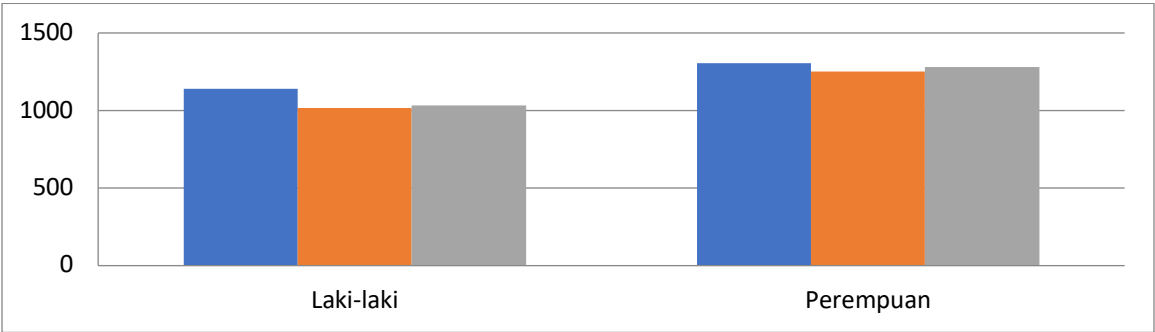
Rencana Tindak Lanjut :

Melakukan peningkatan pelayanan geriatri di rumah sakit agar tetap menjadi rumah sakit rujukan bagi masyarakat serta memberikan edukasi ke pada pasien dan keluarga agar rajin dan teratur untuk memeriksakan pasien geriatri ke Rumah Sakit.

Tabel Jumlah Pasien Geriatri Rawat Jalan Berdasarkan Jenis Kelamin Bulan Juli - September 2025

No	Jenis Kelamin	Jumlah		
		Juli	Agustus	September
1.	Laki-laki	1141 pasien	1017 pasien	1031 pasien
2.	Perempuan	1306 pasien	1250 pasien	1280 pasien

Grafik Jumlah Pasien Geriatri Rawat Jalan Berdasarkan Jenis Kelamin pada Bulan Juli - September 2025



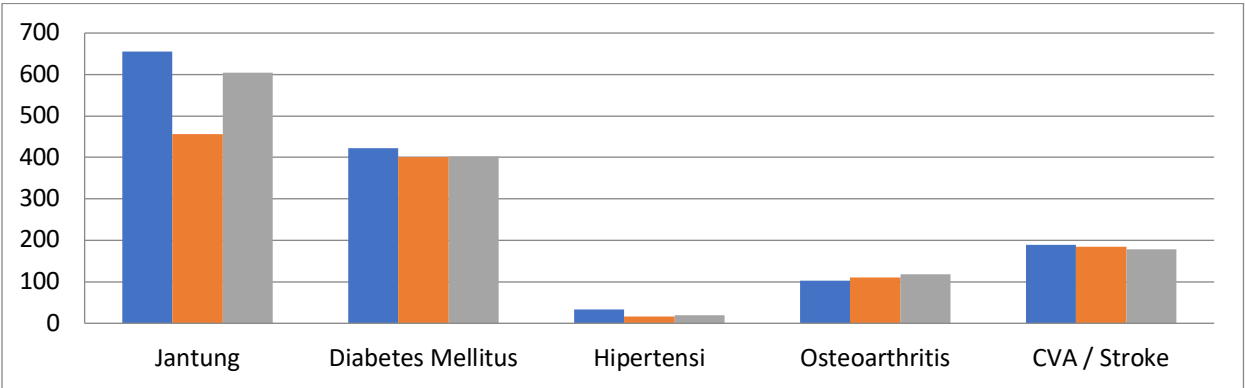
Analisis :
Terjadi penurunan jumlah pasien geriatri pada jenis kelamin laki-laki maupun perempuan pada bulan Agustus 2025, kemudian meningkat kembali di bulan September 2025.

Rencana Tindak Lanjut :
Melakukan peningkatan pelayanan geriatri di rumah sakit agar tetap menjadi rumah sakit rujukan bagi masyarakat serta memberikan edukasi ke pada pasien dan keluarga agar rajin dan teratur untuk memeriksakan pasien geriatri ke Rumah Sakit.

Tabel Jumlah Pasien Geriatri Rawat Jalan Berdasarkan Penyakit Terbanyak

No.	Penyakit	Jumlah		
		Juli	Agustus	September
1.	Jantung	656 pasien	456 pasien	605 pasien
2.	Diabetes Mellitus	422 pasien	401 pasien	402 pasien
3.	Hipertensi	33 pasien	16 pasien	19 pasien
4.	Osteoarthritis	103 pasien	111 pasien	118 pasien
5.	CVA / Stroke	190 pasien	184 pasien	179 pasien

Grafik Jumlah Pasien Geriatri Rawat Jalan Berdasarkan PenyakitTerbanyak Bulan Juli - September 2025



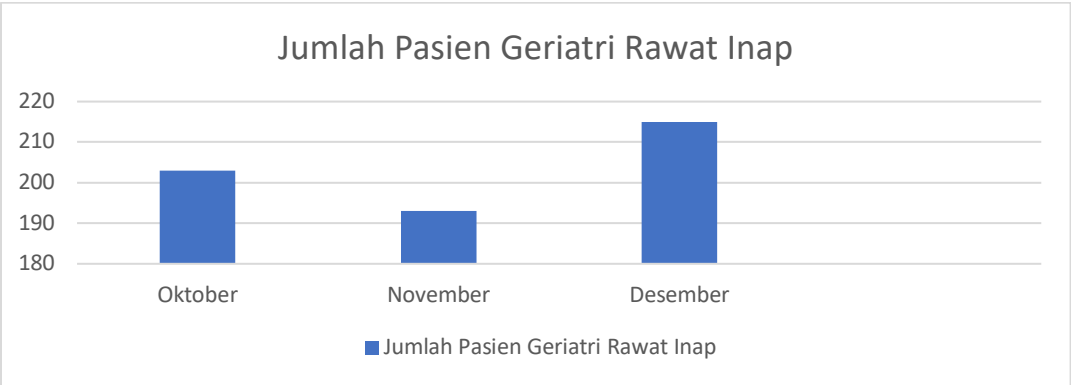
- Analisis :**
- 1) Penyakit yang paling banyak di derita pasien geriatri rawat jalan adalah jantung dan diabetes mellitus.
 - 2) 5 penyakit yang paling banyak terdapat di rawat jalan adalah jantung, diabetes mellitus, hipertensi, osteoarthritis dan CVA / Stroke.
 - 3) Terjadi penurunan jumlah pasien geriatri dengan penyakit jantung, diabetes melitus dan hipertensi dari bulan Juli 2025 sampai bulan Agustus 2025, kemudian meningkat kembali pada bulan September 2025.
 - 4) Terjadi peningkatan jumlah pasien geriatri dengan penyakit osteoarthritis selama 3 bulan berturut-turut.
 - 5) Terjadi penurunan jumlah pasien geriatri dengan penyakit CVA / stroke selama 3 bulan berturut-turut.

- Rencana Tindak Lanjut :**
- 1) Melakukan peningkatan pelayanan geriatri di rumah sakit agar tetap menjadi rumah sakit rujukan bagi masyarakat serta memberikan edukasi ke pada pasien dan keluarga agar rajin dan teratur untuk memeriksakan pasien geriatri ke Rumah Sakit.

3.83 Laporan Cakupan Kunjungan Pasien Geriatri Rawat Inap Triwulan III (Bulan Oktober – Desember 2024)

Tabel Jumlah Pasien Geriatri Rawat Inap		
No.	Bulan	Jumlah
1.	Oktober	203 Pasien
2.	November	193 Pasien
3.	Desember	215 Pasien

Grafik Jumlah Pasien Geriatri Rawat Inap



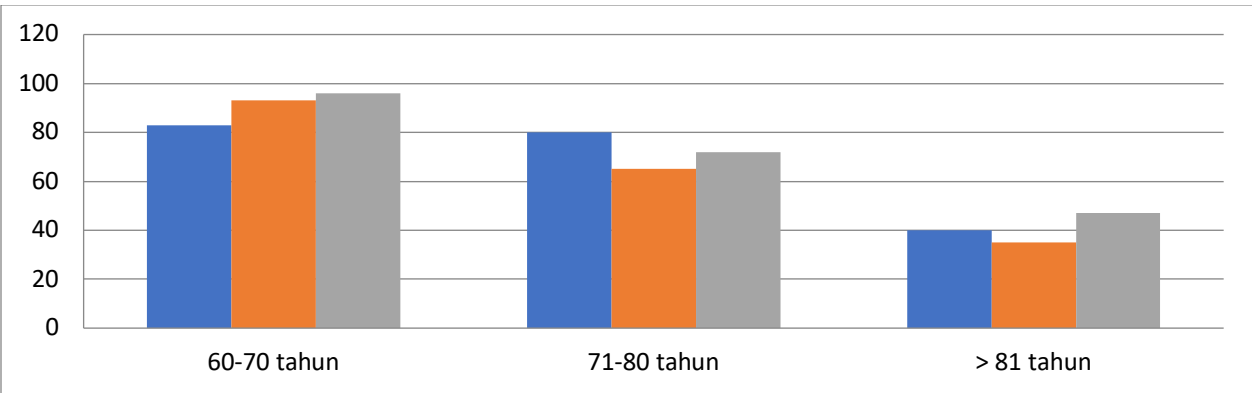
Analisa:
Terjadi Penurunan Jumlah pasien rawat Inap pada bulan Oktober 2024 ke bulan November 2024 dan mengalami peningkatan kembali di bulan Desember 2024

Rencana Tindak Lanjut :
Melakukan peningkatan pelayanan geriatri di rumah sakit agar tetap menjadi rumah sakit rujukan bagi masyarakat serta memberikan edukasi ke pada pasien dan keluarga agar rajin dan teratur untuk memeriksakan pasien geriatri ke Rumah Sakit.

Tabel Jumlah Pasien Geriatri Rawat Inap Berdasarkan Usia Bulan Oktober - Desember

No	Usia	Jumlah		
		Oktober	November	Desember
1.	60-70 tahun	83 pasien	93 pasien	96 pasien
2.	71-80 tahun	80 pasien	65 pasien	72 pasien
3.	> 81 tahun	40 pasien	35 pasien	47 pasien

Grafik Jumlah Pasien Geriatri Rawat Inap Berdasarkan Usia Bulan Oktober – Desember 2024



Analisis :
1) Terjadi peningkatan signifikan untuk pasien geriatri umur 60-70 tahun di rawat inap mulai bulan Oktober sampai bulan November 2024

- 2) Terjadi penurunan jumlah pasien geriatricumur 70 – 80 tahun di rawat inap di bulan Oktober 2024 ke bulan November 2024 dan mengalami peningkatan di bulan Desember 2024
- 3) Terjadi penurunan jumlah pasien geriatri umur > 81 tahun di rawat inap di bulan Oktober 2024 ke bulan November 2024 dan mengalami peningkatan di bulan Desember 2024

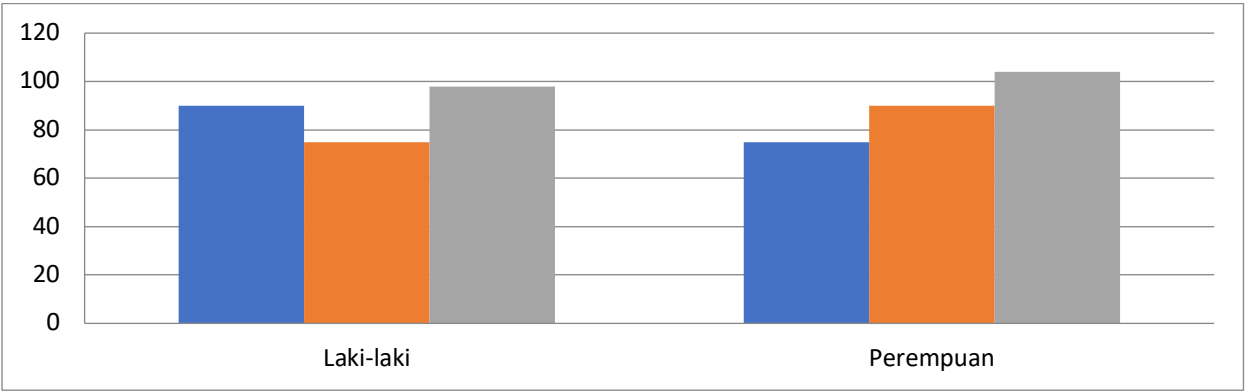
Rencana Tindak Lanjut :

Melakukan peningkatan pelayanan geriatri di rumah sakit agar tetap menjadi rumah sakit rujukan bagi masyarakat serta memberikan edukasi ke pada pasien dan keluarga agar rajin dan teratur untuk memeriksakan pasien geriatri ke Rumah Sakit.

Tabel Jumlah Pasien Geriatri Rawat Inap Berdasarkan Jenis Kelamin Bulan Oktober – Desember 2024

No	Jenis Kelamin	Jumlah		
		Oktober	November	Desember
1.	Laki-laki	90 pasien	75 pasien	98 pasien

Gambar Jumlah Pasien Geriatri Rawat Inap Berdasarkan Jenis Kelamin pada Bulan Oktober – Desember 2024



Analisis :

- 1) Terjadi penurunan jumlah pasien geriatri dengan jenis kelamin Laki – Laki dari bulan Oktober ke bulan November 2024, kemudian meningkat secara signifikan pada bulan Desember 2024 dikarenakan meningkatnya secara keseluruhan jumlah pasien geriatri pada bulan Desember 2024.
- 2) Terjadi Peningkatan secara signifikan pasien Geriatri di rawat inap dengan jenis kelamin Perempuan dari bulan Oktober 2024 sampai bulan Desember 2024

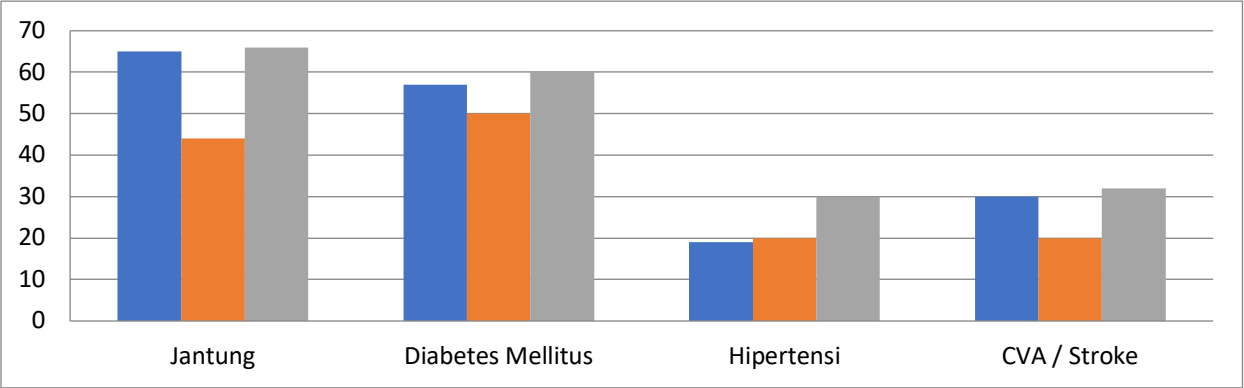
Rencana Tindak Lanjut :

Melakukan peningkatan pelayanan geriatri di rumah sakit agar tetap menjadi rumah sakit rujukan bagi masyarakat serta memberikan edukasi ke pada pasien dan keluarga agar rajin dan teratur untuk memeriksakan pasien geriatri ke Rumah Sakit.

Tabel Jumlah Pasien Geriatri Rawat Inap Berdasarkan Penyakit Terbanyak Bulan Oktober – Desember 2024

No.	Penyakit	Jumlah		
		Oktober	November	Desember
1.	Jantung	65 pasien	44 pasien	66 pasien
2.	Diabetes Mellitus	57 pasien	50 pasien	60 pasien
3.	Hipertensi	19 pasien	20 pasien	30 pasien
4.	CVA / Stroke	30 pasien	20 pasien	32 pasien

Grafik Jumlah Pasien Geriatri Rawat Inap Berdasarkan Penyakit Terbanyak Bulan Oktober – Desember 2025



Analisis :

- 1) Penyakit yang paling banyak di derita pasien geriatri rawat Inap adalah jantung dan diabetes mellitus.
- 2) 4 penyakit yang paling banyak terdapat di rawat Inap adalah jantung, diabetes mellitus, CVA, dan hipertensi.
- 3) Terjadi penurunan jumlah pasien geriatri yang menderita diabetes mellitus di bulan November dan meningkat di bulan Desember 2024
- 4) Terjadi penurunan jumlah pasien geriatri yang menderita jantung, dan CVA pada bulan November kemudian meningkat kembali pada bulan Desember 2024.

Rencana Tindak Lanjut :

Melakukan peningkatan pelayanan geriatri di rumah sakit agar tetap menjadi rumah sakit rujukan bagi masyarakat serta memberikan edukasi ke pada pasien dan keluarga agar rajin dan teratur untuk memeriksakan pasien geriatri ke Rumah Sakit.

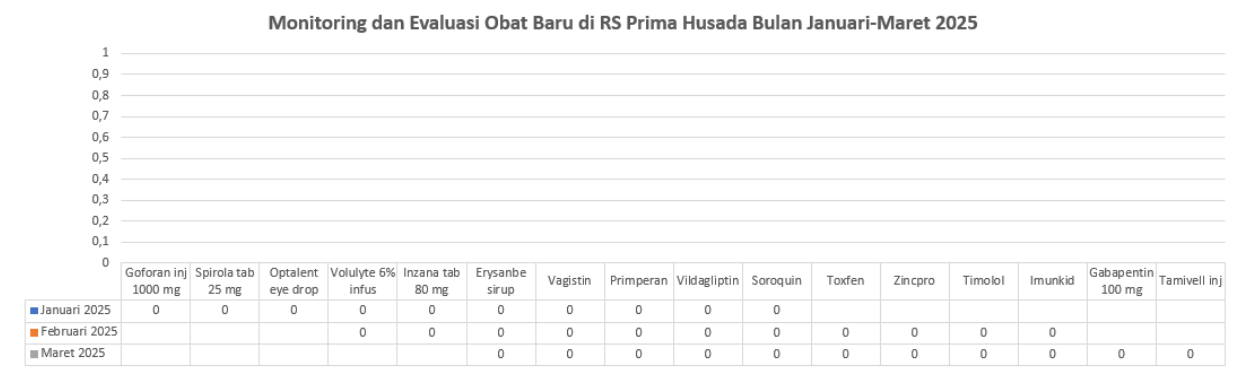
3.9 Kinerja Produktifitas Komite Farmasi dan Terapi
3.9.1 Hasil Monitoring dan Evaluasi Obat Baru di RS Prima Husada Bulan Januari - Maret 2025

Tabel Hasil Monitoring dan Evaluasi Obat Baru di RS Prima Husada Bulan Januari - Maret 2025

No	Nama Obat	Pemantauan Bulan			Temuan	Keterangan
		Nov 2025	Des 2025	Jan 2025		
1	Goforan inj 1000 mg	0	0	0	0	Tidak Ada Temuan
2	Spirola tab 25 mg	0	0	0	0	Tidak Ada Temuan
3	Optalent eye drop	0	0	0	0	Tidak Ada Temuan
No	Nama Obat	Des 2024	Jan 2025	Feb 2025	Temuan	Keterangan
1	Volulyte 6% infus	0	0	0	0	Tidak Ada Temuan
2	Inzana tab 80 mg	0	0	0	0	Tidak Ada Temuan
3	Erysanbe sirup	0	0	0	0	Tidak Ada Temuan
No	Nama Obat	Jan 2025	Feb 2025	Mar 2025	Temuan	Keterangan
1	Vagistin	-	-	0	0	Tidak Ada Temuan
2	Primperan	-	-	0	0	Tidak Ada Temuan
3	Vildagliptin	-	-	0	0	Tidak Ada Temuan
No	Nama Obat	Feb	Mar	Apr	Temuan	Keterangan

		2025	2025	2025		
1	Soroquin	0	0	-	0	Tidak Ada Temuan
2	Toxfen	0	0	-	0	Tidak Ada Temuan
3	Zincpro	0	0	-	0	Tidak Ada Temuan
4	Timolol	0	0	-	0	Tidak Ada Temuan
5	Imunkid	0	0	-	0	Tidak Ada Temuan
No	Nama Obat	Mar 2025	Apr 2025	Mei 2025	Temuan	Keterangan
1	Gabapentin 100 mg	0	-	-	0	Tidak Ada Temuan
2	Tamivell inj	0	-	-	0	Tidak Ada Temuan

Grafik Hasil Monitoring dan Evaluasi Obat Baru di RS Prima Husada Bulan Januari - Maret 2025



- Analisis :**
- 1) Pencatatan monitoring dilakukan setiap hari oleh PIC di unit terkait dalam form monitoring dan evaluasi obat baru.
 - 2) Hasil monitoring penggunaan obat baru selama 3 bulan tidak ditemukan terjadinya efek samping obat, alergi obat, interaksi obat, dan ROTD.
 - 3) Kurangnya pelaporan kejadian efek samping obat oleh tenaga kesehatan.

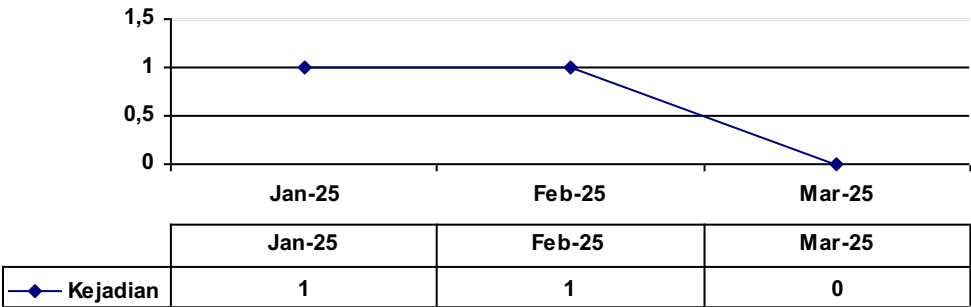
- Tindak Lanjut :**
- 1) Kolaborasi dengan komite medik, kepala bidang keperawatan, kepala bidang pelayanan medis untuk sosialisasi pentingnya pelaporan kejadian efek samping obat, alergi obat, interaksi obat, dan ROTD oleh tenaga kesehatan.
 - 2) Monitoring Efek Samping Obat (MESO) dan Pemantauan Reaksi Obat Tidak Dikehendaki (ROTD) dilaksanakan secara kolaboratif antara dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya, ditulis di dalam dokumen rekam medik pasien dan dilaporkan selambat - lambatnya 1 x 24 jam dalam bentuk laporan MESO dan dicatat dalam status pasien.
 - 3) Mendeteksi adanya kejadian reaksi obat yang tidak dikehendaki (ESO).
 - 4) Mengidentifikasi obat-obatan dan pasien yang mempunyai risiko tinggi mengalami ESO.
 - 5) Menganalisa laporan ESO.
 - 6) Mengisi formulir ESO (lihat di lembar pelaporan ESO).
 - 7) Melaporkan ke Tim MESO dan ROTD.

3.7.3 Hasil Monitoring dan Evaluasi Peresepan di Luar Formularium di RS Prima Husada Bulan Januari - Maret 2025

Tabel Hasil Monitoring dan Evaluasi Peresepan di Luar Formularium di RS Prima Husada Bulan Januari - Maret 2025

No.	Bulan	Nama Obat	Temuan	DPJP	Tindak Lanjut
1	Januari 2025	(16/1/2025) Nocid kaplet (Asam Amino)	1	dr. Ardhany, Sp.PD, K-GH	Subtitusi ke Prorenal kapsul
2	Februari 2025	(10/02/2025) Salep Kenalog (Triamcinolone Oral base)	1	dr. Vita Sp. KK	Pembelian di Apotek rekanan yaitu di Apotek Arjasa
3	Maret 2025	-	0	-	-

Grafik Hasil Monitoring dan Evaluasi Peresepan di Luar Formularium di RS Prima Husada
Bulan Januari - Maret 2025



Analisis :

- 1) Pencatatan monitoring dilakukan setiap hari oleh PIC di unit terkait dalam form monitoring dan evaluasi peresepan di luar formularium.
- 2) Hasil monitoring peresepan diluar formularium selama 3 bulan bulan ditemukan masih terjadi peresepan diluar formularium RSPH karena obat dibutuhkan pasien.

Tindak Lanjut :

- 1) Kolaborasi dengan komite medik agar DPJP patuh menggunakan formularium RS yang sudah tersedia dan terwujudnya pelayanan obat kepada pasien yang efektif dan efisien berdasarkan daftar obat yang mengacu pada formularium RS.
- 2) Dokter yang melakukan peresepan di luar formularium karena obat tidak tersedia dan pasien membutuhkan obat tersebut maka DPJP mengajukan form pengajuan sediaan farmasi baru.
- 3) Sesuai standar akreditasi maka pengadaan obat di RS / apotek rekanan. Disepakati obat yang dibutuhkan dalam jumlah kecil, namun tidak perlu diadakan di RSPH agar dibuatkan perjanjian kerjasama dengan RS atau apotek rekanan.

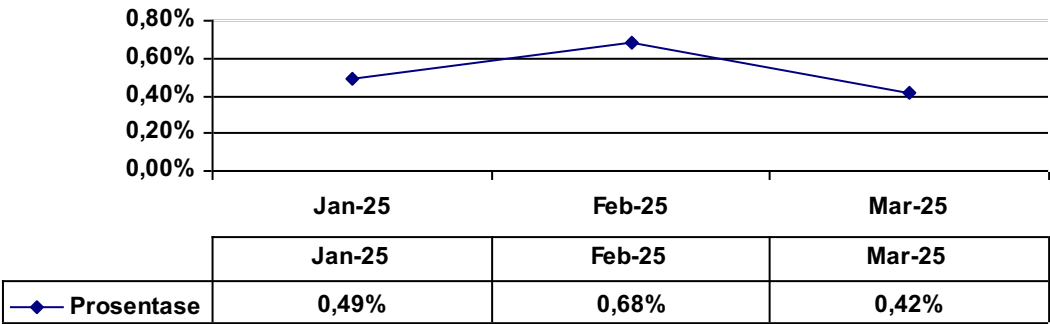
3.7.4 Hasil Monitoring dan Evaluasi Ketersediaan Obat di RS Prima Husada Bulan Januari - Maret 2025

Tabel Monitoring dan Evaluasi Ketersediaan Obat di RS Prima Husada Bulan
Januari - Maret 2025

No	Tanggal	Nama Obat	Golongan Obat	Distributor	Tindak Lanjut
1	1/1/2024 - 4/1/2024	Cefuroxime inj	Antibiotik	PT. Anugrah Argon Medica	Tanpa saran substitusi
2	1/1/2024 – 31/1/2024	Phenobarbital inj	Anti epilepsi – anti konvulsi	PT. Rajawali Nusindo	Tanpa saran substitusi
3	13/1/2024 - 25/1/2024	Uperio tab 100 mg	Anti hipertensi sistemik	PT. Rajawali Nusindo	Substitusi ke Uperio tab 200 mg
4	21/1/2024 - 25/1/2024	Symbicort rapihaler	Anti asma	PT. Anugerah Pharmindo Lestari	Tanpa saran substitusi
5	21/1/2024 - 25/1/2024	Symbicort turbuhaler	Anti asma	PT. Anugerah Pharmindo Lestari	Tanpa saran substitusi
Total prosentase Januari 2025 = 0.49%					

1	1/2/2025-28/2/2025	Hydrochlorothiazide (HCT) tab 25 mg	Diuretik	PT. Kimia Farma	Tanpa saran substitusi
2	1/2/2025-28/2/2025	Spironolakton tab 100 mg	Diuretik	PT. Anugrah Argon Medica	Substitusi ke Spironolakton tab 25 mg
3	1/2/2025-28/2/2025	Orezinc syr 60 ml	Obat untuk diare	PT. Antar Mitra Sembada	Zincpro syr 60 ml
4	1/2/2025-28/2/2025	Quetvell tab 200 mg	Anti psikosis	PT. Antar Mitra Sembada	Soroquin tab 200 mg
5	1/2/2025-28/2/2025	Haloperidol tab 5 mg - Yarindo	Anti psikosis	PT. Parit Padang Global PT. Kebayoran Pharma	Substitusi ke Haloperidol tab 0.5 mg
6	1/2/2025-28/2/2025	Methylergometrin tab 0,125 mg	Oksitosik	PT. Kimia Farma	Substitusi dengan Bledstop tab 0,125 mg
7	1/2/2025-28/2/2025	Itraconazole caps 100 mg	Anti fungi	PT. Tri Sapta Jaya	Tanpa saran substitusi
8	1/2/2025-28/2/2025	Gliquidone tab 30 mg	Anti diabetes	PT. Anugrah Argon Medica	Substitusi dengan golongan Antidiabetes Oral lain
Total prosentase Februari 2025 = 0.68%					
1	1/3/2025-31/3/2025	Hydrochlorothiazide (HCT) tab 25 mg	Diuretik	PT. Kimia Farma	Tanpa saran substitusi
2	1/3/2025-31/3/2025	Quetvell tab 200 mg	Anti psikosis	PT. Antar Mitra Sembada	Soroquin tab 200 mg
3	1/3/2025-31/3/2025	Methylergometrin tab 0,125 mg	Oksitosik	PT. Kimia Farma	Substitusi dengan Bledstop tab 0,125 mg
4	1/3/2025-31/3/2025	Itraconazole caps 100 mg	Anti fungi	PT. Tri Sapta Jaya	Tanpa saran substitusi
5	1/3/2025-31/3/2025	Haloperidol tab 5 mg - Yarindo	Anti psikosis	PT. Parit Padang Global PT. Kebayoran Pharma	Substitusi ke Haloperidol tab 0.5 mg
Total prosentase Maret 2025 = 0.42%					

Grafik Hasil Monitoring dan Evaluasi Ketersediaan Obat di RS Prima Husada Bulan Januari - Maret 2025



Analisis :

- 1) Pencatatan monitoring dilakukan setiap hari oleh PIC di unit terkait dalam form monitoring dan evaluasi ketersediaan obat.
- 2) Hasil monitoring ketersediaan obat selama 3 bulan ditemukan masih sering terjadi kekosongan di distributor karena kekurangan bahan baku, delisting produk (pabrik tidak produksi), stok di distributor habis, kekosongan produk originator seperti Haloperidol tab 5 mg – Yarindo, Hydrochlorothiazide (HCT) tab 25 mg, dan Itraconazole caps 100 mg sehingga tidak tersedia di pabrik lain dengan kandungan yang sama.
- 3) RS belum bisa melakukan pembelian lewat e-purchasing sehingga belum bisa order obat fast moving khusus obat kronis

Tindak Lanjut :

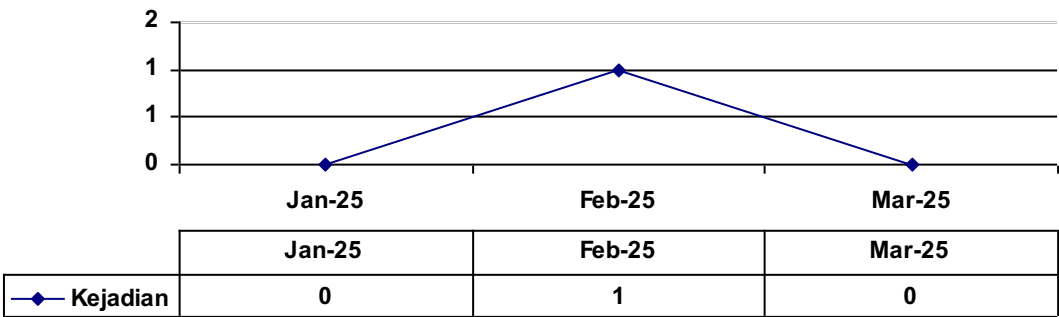
- 1) Evaluasi mutu perjanjian kerjasama dengan distributor untuk memberikan konfirmasi apabila stok barang tidak tersedia di distributor setelah menerima pesanan dari RS.
- 2) Mencari substitusi obat lain yang isi/ kandungannya sama.

- 3) Memberi informasi kekosongan obat dan substitusinya ke DPJP melalui surat edaran.
- 4) Evaluasi stok minimal depo farmasi dan Gudang farmasi serta alur pengadaan.

Tabel Hasil Monitoring Efek Samping Obat di RS Prima Husada Bulan Januari - Maret 2025

No.	Bulan	Nama Obat	Temuan	ESO	Tindak Lanjut
1	Januari 2025	-	0	-	-
2	Februari 2025	(06/02/2025) Divalproex sodium er tab 500 mg - Yarindo	1	Tidak bisa tidur	Apoteker konsul ke DPJP dan resep diubah ke Velpraz tab 250 mg
3	Maret 2025	-	0	-	-

Grafik Hasil Monitoring Efek Samping Obat di RS Prima Husada Bulan Januari - Maret 2025



Analisis :

- 1) Pencatatan monitoring dilakukan oleh PIC di unit terkait dalam form MESO dan form IKP.
- 2) Hasil monitoring pelaporan MESO ditemukan terjadinya efek samping obat Divalproex sodium er tab 500 mg – Yarindo yaitu tidak bisa tidur.

Tindak Lanjut :

- 1) Kolaborasi dengan komite medik, kepala bidang keperawatan, kepala bidang pelayanan medis untuk sosialisasi pentingnya pelaporan kejadian efek samping obat, alergi obat, interaksi obat, dan ROTD oleh tenaga kesehatan.
- 2) Monitoring Efek Samping Obat (MESO) dan Pemantauan Reaksi Obat Tidak Dikehendaki (ROTD) dilaksanakan secara kolaboratif antara dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya, ditulis di dalam dokumen rekam medik pasien dan dilaporkan selambat - lambatnya 1 x 24 jam dalam bentuk laporan MESO dan dicatat dalam status pasien.
- 3) Mendeteksi adanya kejadian reaksi obat yang tidak dikehendaki (ESO).
- 4) Mengidentifikasi obat-obatan dan pasien yang mempunyai risiko tinggi mengalami ESO.
- 5) Menganalisa laporan ESO.
- 6) Mengisi formulir ESO (lihat di lembar pelaporan ESO).
- 7) Melaporkan ke Tim MESO dan ROTD.
- 8) Konsul ke DPJP untuk tindak lanjut ESO yang terjadi.

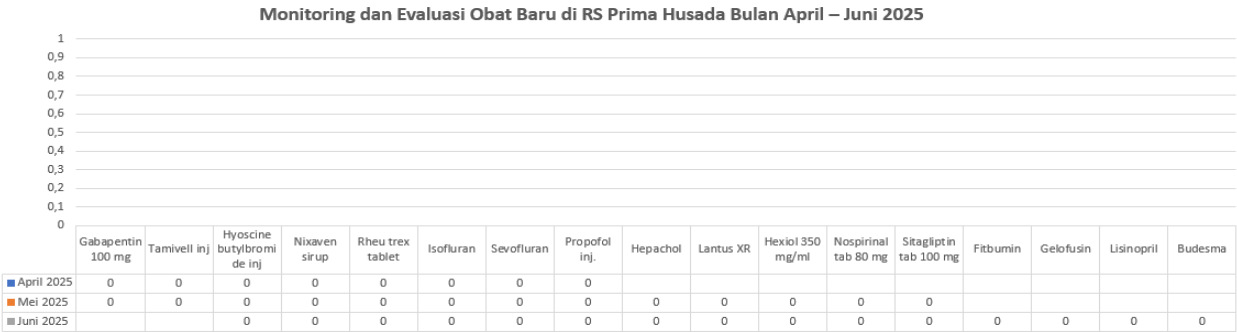
3.7.5 Hasil Monitoring dan Evaluasi Obat Baru di RS Prima Husada Bulan April - Juni Tahun 2025

Tabel Hasil Monitoring dan Evaluasi Obat Baru di RS Prima Husada Bulan April - Juni Tahun 2025

No	Nama Obat	Pemantauan Bulan			Temuan	Keterangan
		Mar 2025	Apr 2025	Mei 2025		

1	Gabapentin 100 mg	0	0	0	0	Tidak Ada Temuan
2	Tamivell inj	0	0	0	0	Tidak Ada Temuan
No	Nama Obat	Apr 2025	Mei 2025	Jun 2025	Temuan	Keterangan
1	Hyoscine butylbromide inj	0	0	0	0	Tidak Ada Temuan
2	Nixaven sirup	0	0	0	0	Tidak Ada Temuan
3	Rheu trex tablet	0	0	0	0	Tidak Ada Temuan
4	Isofluran	0	0	0	0	Tidak Ada Temuan
5	Sevofluran	0	0	0	0	Tidak Ada Temuan
6	Propofol inj.	0	0	0	0	Tidak Ada Temuan
No	Nama Obat	Mei 2025	Jun 2025	Jul 2025	Temuan	Keterangan
1	Hepachol	0	0	-	0	Tidak Ada Temuan
2	Lantus XR	0	0	-	0	Tidak Ada Temuan
3	Hexiol 350 mg/ml	0	0	-	0	Tidak Ada Temuan
4	Nospirinal tab 80 mg	0	0	-	0	Tidak Ada Temuan
5	Sitagliptin tab 100 mg	0	0	-	0	Tidak Ada Temuan
No	Nama Obat	Jun 2025	Jul 2025	Ags 2025	Temuan	Keterangan
1	Fitbumin	0	-	-	0	Tidak Ada Temuan
2	Gelofusin	0	-	-	0	Tidak Ada Temuan
3	Lisinopril	0	-	-	0	Tidak Ada Temuan
4	Budesma	0	-	-	0	Tidak Ada Temuan

Grafik Hasil Monitoring dan Evaluasi Obat Baru di RS Prima Husada Bulan April - Juni Tahun 2025



- Analisis :**
- 1) Pencatatan monitoring dilakukan setiap hari oleh PIC di unit terkait dalam form monitoring dan evaluasi obat baru.
 - 2) Hasil monitoring penggunaan obat baru selama 3 bulan tidak ditemukan terjadinya efek samping obat, alergi obat, interaksi obat, dan ROTD.
 - 3) Kurangnya pelaporan kejadian efek samping obat oleh tenaga kesehatan.
- Tindak Lanjut :**
- 1) Kolaborasi dengan komite medik, kepala bidang keperawatan, kepala bidang pelayanan medis untuk sosialisasi pentingnya pelaporan kejadian efek samping obat, alergi obat, interaksi obat, dan ROTD oleh tenaga kesehatan.
 - 2) Monitoring Efek Samping Obat (MESO) dan Pemantauan Reaksi Obat Tidak Dikehendaki (ROTD) dilaksanakan secara kolaboratif antara dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya, ditulis di dalam dokumen rekam medik pasien dan dilaporkan selambat - lambatnnya 1 x 24 jam dalam bentuk laporan MESO dan dicatat dalam status pasien.

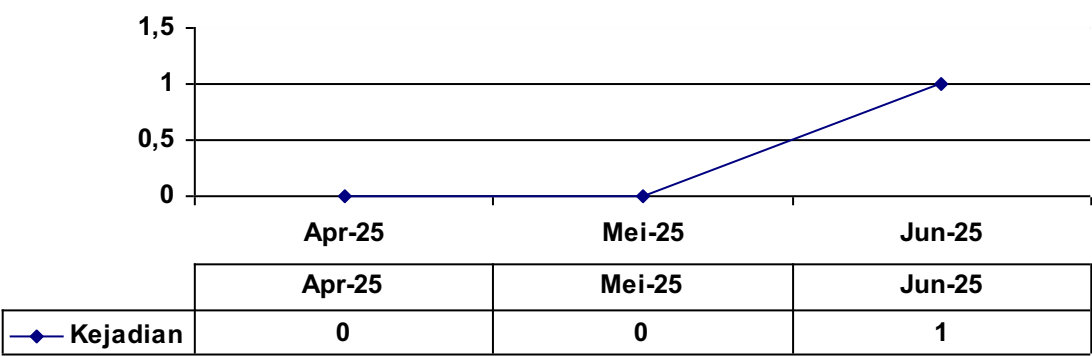
- 3) Mendeteksi adanya kejadian reaksi obat yang tidak dikehendaki (ESO).
- 4) Mengidentifikasi obat-obatan dan pasien yang mempunyai risiko tinggi mengalami ESO.
- 5) Menganalisa laporan ESO.
- 6) Mengisi formulir ESO (lihat di lembar pelaporan ESO).
- 7) Melaporkan ke Tim MESO dan ROTD.

3.7.6 Hasil Monitoring dan Evaluasi Peresepan di Luar Formularium di RS Prima Husada Bulan Bulan April - Juni Tahun 2025

Tabel Hasil Monitoring dan Evaluasi Peresepan di Luar Formularium di RS Prima Husada Bulan Bulan April - Juni Tahun 2025

No.	Bulan	Nama Obat	Temuan	DPJP	Tindak Lanjut
1	April 2025	-	0	-	-
2	Mei 2025	-	0	-	-
3	Juni 2025	(28/06/2025) Infus NaCl 0,45%	1	dr. Farid, Sp. S	Melakukan pengoplosan (pengenceran) menggunakan NaCl 0,9% dan WFI

Grafik Hasil Monitoring dan Evaluasi Peresepan di Luar Formularium di RS Prima Husada Bulan April - Juni Tahun 2025



Analisis :

- 1) Pencatatan monitoring dilakukan setiap hari oleh PIC di unit terkait dalam form monitoring dan evaluasi peresepan di luar formularium.
- 2) Hasil monitoring peresepan diluar formularium selama 3 bulan bulan ditemukan masih terjadi peresepan diluar formularium RSPH karena obat dibutuhkan pasien.

Tindak Lanjut :

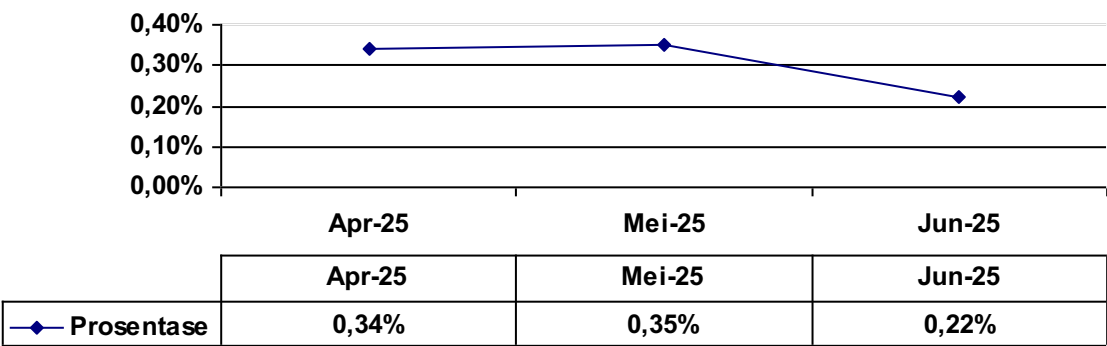
- 1) Kolaborasi dengan komite medik agar DPJP patuh menggunakan formularium RS yang sudah tersedia dan terwujudnya pelayanan obat kepada pasien yang efektif dan efisien berdasarkan daftar obat yang mengacu pada formularium RS.
- 2) Dokter yang melakukan peresepan di luar formularium karena obat tidak tersedia dan pasien membutuhkan obat tersebut maka DPJP mengajukan form pengajuan sediaan farmasi baru.
- 3) Sesuai standar akreditasi maka pengadaan obat di RS / apotek rekanan. Disepakati obat yang dibutuhkan dalam jumlah kecil, namun tidak perlu diadakan di RSPH agar dibuatkan perjanjian kerjasama dengan RS atau apotek rekanan.

3.7.7 Hasil Monitoring dan Evaluasi Ketersediaan Obat di RS Prima Husada Bulan April - Juni Tahun 2025

Tabel Hasil Monitoring dan Evaluasi Ketersediaan Obat di RS Prima Husada Bulan April - Juni Tahun 2025

No	Tanggal	Nama Obat	Golongan Obat	Distributor	Tindak Lanjut
1	1/4/2025-31/4/2025	Hydrochlorothiazide (HCT) tab 25 mg	Diuretik	PT. Kimia Farma	Tanpa saran substitusi
2	1/4/2025-31/4/2025	Quetvell tab 200 mg	Anti psikosis	PT. Antar Mitra Sembada	Soroquin tab 200 mg
3	1/4/2025-31/4/2025	Methylergometrin tab 0,125 mg	Oksitosik	PT. Kimia Farma	Substitusi dengan Bledstop tab 0,125 mg
4	1/4/2025-31/4/2025	Itraconazole caps 100 mg	Anti fungi	PT. Tri Sapta Jaya	Tanpa saran substitusi
Total prosentase April 2025 = 0.34%					
1	1/5/2025-31/5/2025	Hydrochlorothiazide (HCT) tab 25 mg	Diuretik	PT. Kimia Farma	Tanpa saran substitusi
2	1/5/2025-31/5/2025	Methylergometrin tab 0,125 mg	Oksitosik	PT. Kimia Farma	Substitusi dengan Bledstops tab 0,125 mg
3	1/5/2025-31/5/2025	Itraconazole caps 100 mg	Anti fungi	PT. Tri Sapta Jaya	Tanpa saran substitusi
4	1/5/2025-15/5/2025	Ketoprofen tab 100 mg	Analgesik	PT. Antar Mitra Sembada	Tanpa saran substitusi
Total prosentase Mei 2025 = 0.35%					
1	1/6/2025-31/6/2025	Hydrochlorothiazide (HCT) tab 25 mg	Diuretik	PT. Kimia Farma	Tanpa saran substitusi
2	1/6/2025-31/6/2025	Methylergometrin tab 0,125 mg	Oksitosik	PT. Kimia Farma	Substitusi dengan Bledstop tab 0,125 mg
3	1/6/2025-31/6/2025	Itraconazole caps 100 mg	Anti fungi	PT. Tri Sapta Jaya	Tanpa saran substitusi
4	1/6/2025-15/6/2025	Santagesik inj 1 gr	Analgesik	PT. Bina San Prima	Tanpa saran substitusi
Total prosentase Juni 2025 = 0.22%					

Grafik Hasil Monitoring dan Evaluasi Ketersediaan Obat di RS Prima Husada Bulan April - Juni Tahun 2025



Analisis :

- 1) Pencatatan monitoring dilakukan setiap hari oleh PIC di unit terkait dalam form monitoring dan evaluasi ketersediaan obat.
- 2) Hasil monitoring ketersediaan obat selama 3 bulan ditemukan masih sering terjadi kekosongan di distributor karena kekurangan bahan baku, delisting produk (pabrik tidak

produksi), stok di distributor habis, kekosongan produk originator seperti Hydrochlorothiazide (HCT) tab 25 mg dan Itraconazole caps 100 mg sehingga tidak tersedia di pabrik lain dengan kandungan yang sama.

- 3) RS belum bisa melakukan pembelian lewat e-purchasing sehingga belum bisa order obat fast moving khusus obat kronis

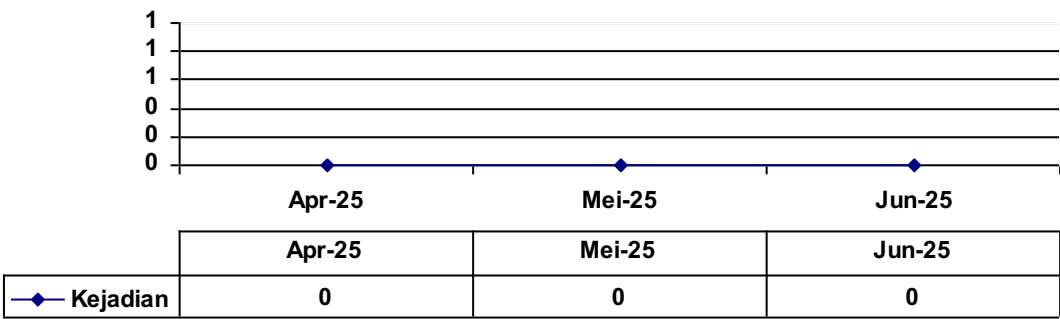
Tindak Lanjut :

- 1) Evaluasi mutu perjanjian kerjasama dengan distributor untuk memberikan konfirmasi apabila stok barang tidak tersedia di distributor setelah menerima pesanan dari RS.
- 2) Mencari substitusi obat lain yang isi/ kandungannya sama.
- 3) Memberi informasi kekosongan obat dan substitusinya ke DPJP melalui surat edaran.
- 4) Evaluasi stok minimal depo farmasi dan Gudang farmasi serta alur pengadaan.

Tabel 4 Hasil Monitoring Efek Samping Obat di RS Prima Husada Bulan April - Juni Tahun 2025

No.	Bulan	Nama Obat	Temuan	ESO	Tindak Lanjut
1	April 2025	-	0	-	-
2	Mei 2025	-	0	-	-
3	Juni 2025	-	0	-	-

Grafik Hasil Monitoring Efek Samping Obat di RS Prima Husada Bulan Bulan April - Juni Tahun 2025



Analisis :

- 1) Pencatatan monitoring dilakukan oleh PIC di unit terkait dalam form MESO dan form IKP.
- 2) Hasil monitoring pelaporan MESO tidak ditemukan terjadinya efek samping obat.

Tindak Lanjut :

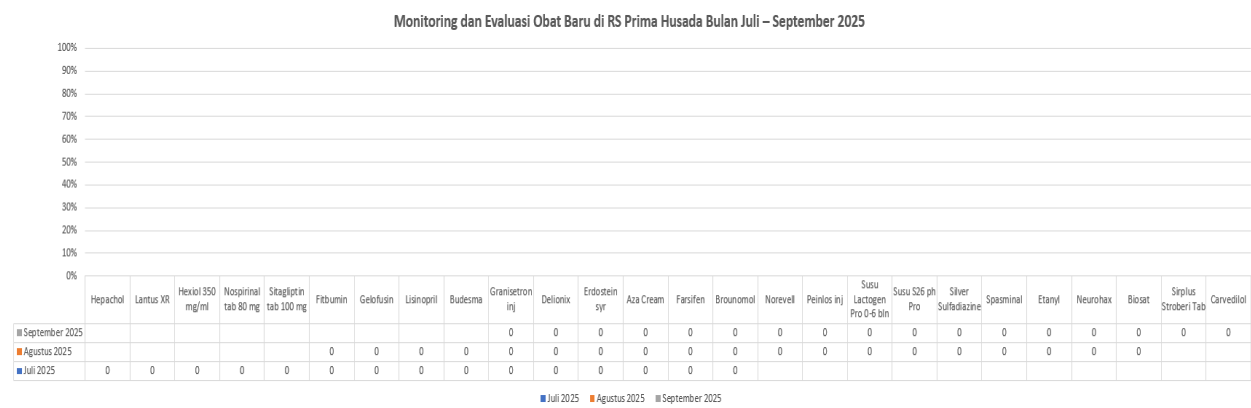
- 1) Kolaborasi dengan komite medik, kepala bidang keperawatan, kepala bidang pelayanan medis untuk sosialisasi pentingnya pelaporan kejadian efek samping obat, alergi obat, interaksi obat, dan ROTD oleh tenaga kesehatan.
- 2) Monitoring Efek Samping Obat (MESO) dan Pemantauan Reaksi Obat Tidak Dikehendaki (ROTD) dilaksanakan secara kolaboratif antara dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya, ditulis di dalam dokumen rekam medik pasien dan dilaporkan selambat - lambatnya 1 x 24 jam dalam bentuk laporan MESO dan dicatat dalam status pasien.
- 3) Mendeteksi adanya kejadian reaksi obat yang tidak dikehendaki (ESO).
- 4) Mengidentifikasi obat-obatan dan pasien yang mempunyai risiko tinggi mengalami ESO.
- 5) Menganalisa laporan ESO.
- 6) Mengisi formulir ESO (lihat di lembar pelaporan ESO).
- 7) Melaporkan ke Tim MESO dan ROTD.

3.7.8 Hasil Monitoring dan Evaluasi Obat Baru di RS Prima Husada Bulan Juli - September Tahun 2025

Tabel Hasil Monitoring dan Evaluasi Obat Baru di RS Prima Husada Bulan Juli - September Tahun 2025

No	Nama Obat	Pemantauan Bulan			Temuan	Keterangan
		Mei 2025	Jun 2025	Jul 2025		
1	Hepachol	0	0	0	0	Tidak Ada Temuan
2	Lantus XR	0	0	0	0	Tidak Ada Temuan
3	Hexiol 350 mg/ml	0	0	0	0	Tidak Ada Temuan
4	Nospirinal tab 80 mg	0	0	0	0	Tidak Ada Temuan
5	Sitagliptin tab 100 mg	0	0	0	0	Tidak Ada Temuan
No	Nama Obat	Jun 2025	Jul 2025	Ags 2025	Temuan	Keterangan
1	Fitbumin	0	0	0	0	Tidak Ada Temuan
2	Gelofusin	0	0	0	0	Tidak Ada Temuan
3	Lisinopril	0	0	0	0	Tidak Ada Temuan
4	Budesma	0	0	0	0	Tidak Ada Temuan
No	Nama Obat	Jul 2025	Ags 2025	Sep 2025	Temuan	Keterangan
1	Granisetron inj	0	0	0	0	Tidak Ada Temuan
2	Delionix	0	0	0	0	Tidak Ada Temuan
3	Erdosteine syr	0	0	0	0	Tidak Ada Temuan
4	Aza Cream	0	0	0	0	Tidak Ada Temuan
5	Farsifen	0	0	0	0	Tidak Ada Temuan
6	Brounomol	0	0	0	0	Tidak Ada Temuan
No	Nama Obat	Ags 2025	Sep 2025	Okt 2025	Temuan	Keterangan
1	Norevell	0	0	-	0	Tidak Ada Temuan
2	Peinlos inj	0	0	-	0	Tidak Ada Temuan
3	Susu Lactogen Pro 0-6 bln	0	0	-	0	Tidak Ada Temuan
4	Susu S26 ph Pro	0	0	-	0	Tidak Ada Temuan
5	Silver Sulfadiazine	0	0	-	0	Tidak Ada Temuan
6	Spasminal	0	0	-	0	Tidak Ada Temuan
7	Etanyl	0	0	-	0	Tidak Ada Temuan
8	Neurohax	0	0	-	0	Tidak Ada Temuan
9	Biosat	0	0	-	0	Tidak Ada Temuan
No	Nama Obat	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Temuan	Keterangan
1	Sirplus Stroberi Tab	0	-	-	0	Tidak Ada Temuan
2	Carvedilol	0	-	-	0	Tidak Ada Temuan

Grafik Hasil Monitoring dan Evaluasi Obat Baru di RS Prima Husada Bulan Juli - September Tahun 2025



Analisis :

- 1) Pencatatan monitoring dilakukan setiap hari oleh PIC di unit terkait dalam form monitoring dan evaluasi obat baru.
- 2) Hasil monitoring penggunaan obat baru selama 3 bulan tidak ditemukan terjadinya efek samping obat, alergi obat, interaksi obat, dan ROTD.
- 3) Kurangnya pelaporan kejadian efek samping obat oleh tenaga kesehatan.

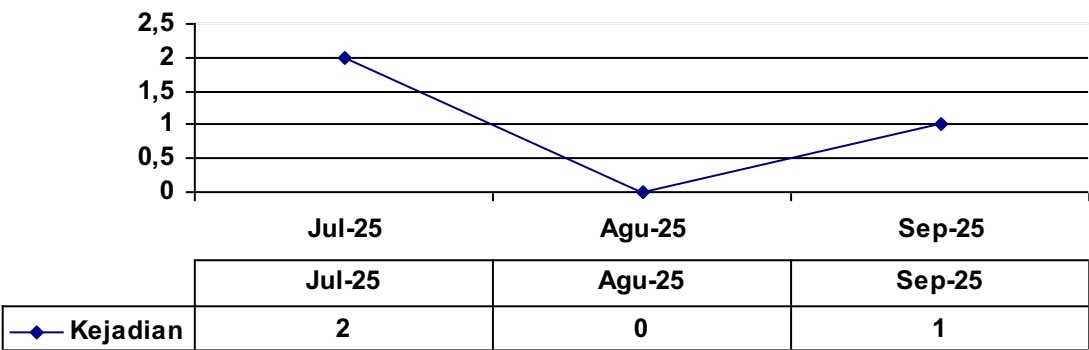
Tindak Lanjut :

- 1) Kolaborasi dengan komite medik, kepala bidang keperawatan, kepala bidang pelayanan medis untuk sosialisasi pentingnya pelaporan kejadian efek samping obat, alergi obat, interaksi obat, dan ROTD oleh tenaga kesehatan.
- 2) Monitoring Efek Samping Obat (MESO) dan Pemantauan Reaksi Obat Tidak Dikehendaki (ROTD) dilaksanakan secara kolaboratif antara dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya, ditulis di dalam dokumen rekam medik pasien dan dilaporkan selambat - lambatnya 1 x 24 jam dalam bentuk laporan MESO dan dicatat dalam status pasien.
- 3) Mendeteksi adanya kejadian reaksi obat yang tidak dikehendaki (ESO).
- 4) Mengidentifikasi obat-obatan dan pasien yang mempunyai risiko tinggi mengalami ESO.
- 5) Menganalisa laporan ESO.
- 6) Mengisi formulir ESO (lihat di lembar pelaporan ESO).
- 7) Melaporkan ke Tim MESO dan ROTD.

Tabel Hasil Monitoring dan Evaluasi Peresepan di Luar Formularium di RS Prima Husada Bulan Bulan Juli - September Tahun 2025

No.	Bulan	Nama Obat	Temuan	DPJP	Tindak Lanjut
1	Juli 2025	1. (05/07/2025) Infus NaCl 0.45% 2. (14/07/2025) Kapsul Garam Inggris (Garam Epsom / MgSO4)	2	1. dr. Farid, Sp.S 2. dr. Ardhany Sp.PD	1. Melakukan pengenceran NaCl 0.9% dengan WFI. 2. Pembelian di Apotek rekanan yaitu di Apotek Nayu Farma.
2	Agustus 2025	-	0	-	-
3	September 2025	(28/09/2025) ⇒ Levemir FlexPen Insulin	1	dr. Ira, Sp.JP	Substitusi dengan nama dagang lain yaitu Ezelin

Grafik Hasil Monitoring dan Evaluasi Peresepan di Luar Formularium di RS Prima Husada
Bulan Juli - September Tahun 2025



Analisis :

- 1) Pencatatan monitoring dilakukan setiap hari oleh PIC di unit terkait dalam form monitoring dan evaluasi peresepan di luar formularium.
- 2) Hasil monitoring peresepan diluar formularium selama 3 bulan bulan ditemukan masih terjadi peresepan diluar formularium RSPH karena obat dibutuhkan pasien.

Tindak Lanjut :

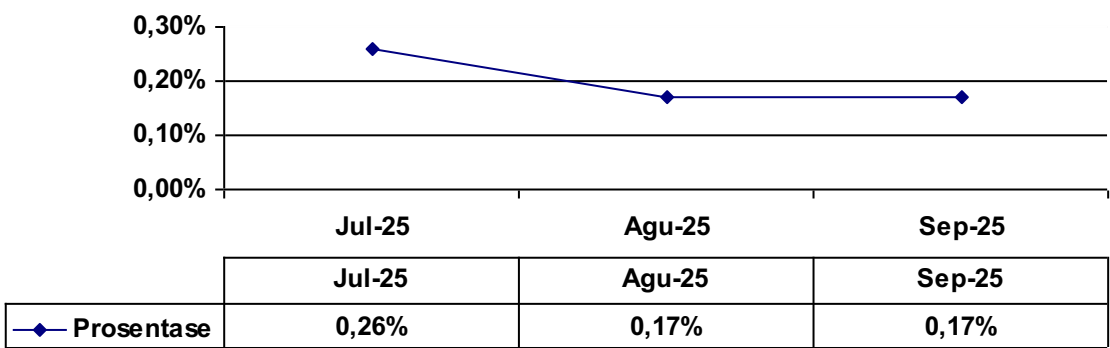
- 1) Kolaborasi dengan komite medik agar DPJP patuh menggunakan formularium RS yang sudah tersedia dan terwujudnya pelayanan obat kepada pasien yang efektif dan efisien berdasarkan daftar obat yang mengacu pada formularium RS.
- 2) Dokter yang melakukan peresepan di luar formularium karena obat tidak tersedia dan pasien membutuhkan obat tersebut maka DPJP mengajukan form pengajuan sediaan farmasi baru.
- 3) Sesuai standar akreditasi maka pengadaan obat di RS / apotik rekanan. Disepakati obat yang dibutuhkan dalam jumlah kecil, namun tidak perlu diadakan di RSPH agar dibuatkan perjanjian kerjasama dengan RS atau apotek rekanan.

3.7.9 Hasil Monitoring dan Evaluasi Ketersediaan Obat di RS Prima Husada Bulan Juli - September Tahun 2025

Tabel Hasil Monitoring dan Evaluasi Ketersediaan Obat di RS Prima Husada Bulan Juli - September Tahun 2025

No	Tanggal	Nama Obat	Golongan Obat	Distributor	Tindak Lanjut
1	1/7/2025-31/7/2025	Hydrochlorothiazide (HCT) tab 25 mg	Diuretik	PT. Kimia Farma	Tanpa saran substitusi
2	1/7/2025-31/7/2025	Methylergometrin tab 0,125 mg	Oksitosik	PT. Kimia Farma	Substitusi dengan Bledstop tab 0,125 mg
3	1/7/2025-30/7/2025	Itraconazole caps 100 mg	Anti fungi	PT. Tri Sapta Jaya	Tanpa saran substitusi
4	1/7/2025-4/7/2025	Divalproex sodium tab 500 mg	Anti konvulsan	PT. Parit Padang Global	Tanpa saran substitusi
Total prosentase Juli 2025 = 0.26%					
1	1/8/2025-31/8/2025	Hydrochlorothiazide (HCT) tab 25 mg	Diuretik	PT. Kimia Farma	Tanpa saran substitusi
2	1/8/2025-31/8/2025	Methylergometrin tab 0,125 mg	Oksitosik	PT. Kimia Farma	Tanpa saran substitusi
Total prosentase Agustus 2025 = 0.17%					
1	1/9/2025-30/9/2025	Hydrochlorothiazide (HCT) tab 25 mg	Diuretik	PT. Kimia Farma	Tanpa saran substitusi
2	1/9/2025-30/9/2025	Methylergometrin tab 0,125 mg	Oksitosik	PT. Kimia Farma	Tanpa saran substitusi
Total prosentase September 2025 = 0.17%					

Grafik Hasil Monitoring dan Evaluasi Ketersediaan Obat di RS Prima Husada Bulan Juli - September Tahun 2025



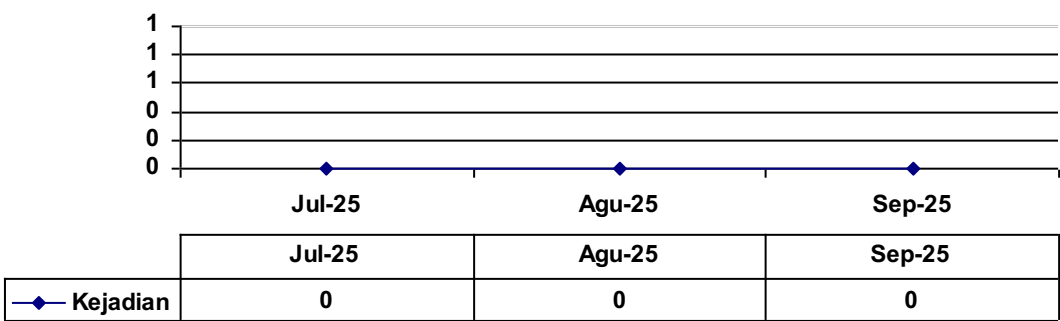
- Analisis :**
- 1) Pencatatan monitoring dilakukan setiap hari oleh PIC di unit terkait dalam form monitoring dan evaluasi ketersediaan obat.
 - 2) Hasil monitoring ketersediaan obat selama 3 bulan ditemukan kekosongan di distributor karena kekurangan bahan baku, delisting produk (pabrik tidak produksi), stok di distributor habis, kekosongan produk originator, dan kosong nasional seperti Hydrochlorothiazide (HCT) tab 25 mg dan Methylethergometrin tab 0,125 mg (paten dan generik) sehingga tidak tersedia di pabrik lain dengan kandungan yang sama.
 - 3) RS belum bisa melakukan pembelian lewat e-purchasing sehingga belum bisa order obat fast moving khusus obat kronis

- Tindak Lanjut :**
- 1) Evaluasi mutu perjanjian kerjasama dengan distributor untuk memberikan konfirmasi apabila stok barang tidak tersedia di distributor setelah menerima pesanan dari RS.
 - 2) Mencari substitusi obat lain yang isi/ kandungannya sama.
 - 3) Memberi informasi kekosongan obat dan substitusinya ke DPJP melalui surat edaran.
 - 4) Evaluasi stok minimal depo farmasi dan Gudang farmasi serta alur pengadaan.

Tabel Hasil Monitoring Efek Samping Obat di RS Prima Husada Bulan Juli - September Tahun 2025

No.	Bulan	Nama Obat	Temuan	ESO	Tindak Lanjut
1	Juli 2025	-	0	-	-
2	Agustus 2025	-	0	-	-
3	September 2025	-	0	-	-

Grafik Hasil Monitoring Efek Samping Obat di RS Prima Husada Bulan Juli - September Tahun 2025

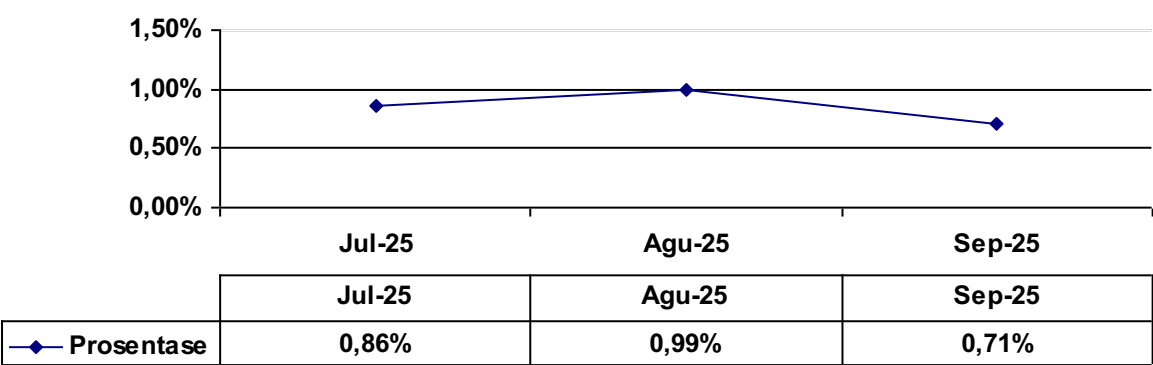


- Analisis :**
- 1) Pencatatan monitoring dilakukan oleh PIC di unit terkait dalam form MESO dan form IKP.
 - 2) Hasil monitoring pelaporan MESO tidak ditemukan terjadinya efek samping obat.

- Tindak Lanjut :**
- 1) Kolaborasi dengan komite medik, kepala bidang keperawatan, kepala bidang pelayanan medis untuk sosialisasi pentingnya pelaporan kejadian efek samping obat, alergi obat, interaksi obat, dan ROTD oleh tenaga kesehatan.

- 2) Monitoring Efek Samping Obat (MESO) dan Pemantauan Reaksi Obat Tidak Dikehendaki (ROTD) dilaksanakan secara kolaboratif antara dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya, ditulis di dalam dokumen rekam medik pasien dan dilaporkan selambat - lambatnya 1 x 24 jam dalam bentuk laporan MESO dan dicatat dalam status pasien.
- 3) Mendeteksi adanya kejadian reaksi obat yang tidak dikehendaki (ESO).
- 4) Mengidentifikasi obat-obatan dan pasien yang mempunyai risiko tinggi mengalami ESO.
- 5) Menganalisa laporan ESO.
- 6) Mengisi formulir ESO (lihat di lembar pelaporan ESO).
- 7) Melaporkan ke Tim MESO dan ROTD.

Grafik Hasil Monitoring dan Evaluasi Ketidاكلengkapan Pemulisan Resep di RS Prima Husada Bulan Juli - September Tahun 2025



- Analisis :**
- 1) Pencatatan monitoring ketidaklengkapan penulisan resep dilakukan setiap hari oleh petugas farmasi.
 - 2) Dari data di atas masih banyak ditemukan resep yang tidak lengkap.
Dari segi telaah administrasi : sudah lengkap karena menggunakan e-resep
Dari segi telaah farmasetik : masih ditemukan dokter salah input dosis dan jumlah obat, aturan dan cara penggunaan serta rute pemberian tidak lengkap terisi.

- Tindak Lanjut :**
- 1) Koordinasi dengan tim SIMRS untuk membuat sistem jika resep tidak terinput dengan lengkap maka resep tidak dapat masuk ke IFRS.
 - 2) Inputan resep harus dilakukan oleh dokter/ dokter spesialis yang kompeten dan berwenang mulai dari identitas pasien, nama obat, dosis, rute pemberian, waktu pemberian, nama dan tandatangan dokter (untuk resep manual).
 - 3) Pelatihan penulisan resep untuk semua dokter dan dokter spesialis.

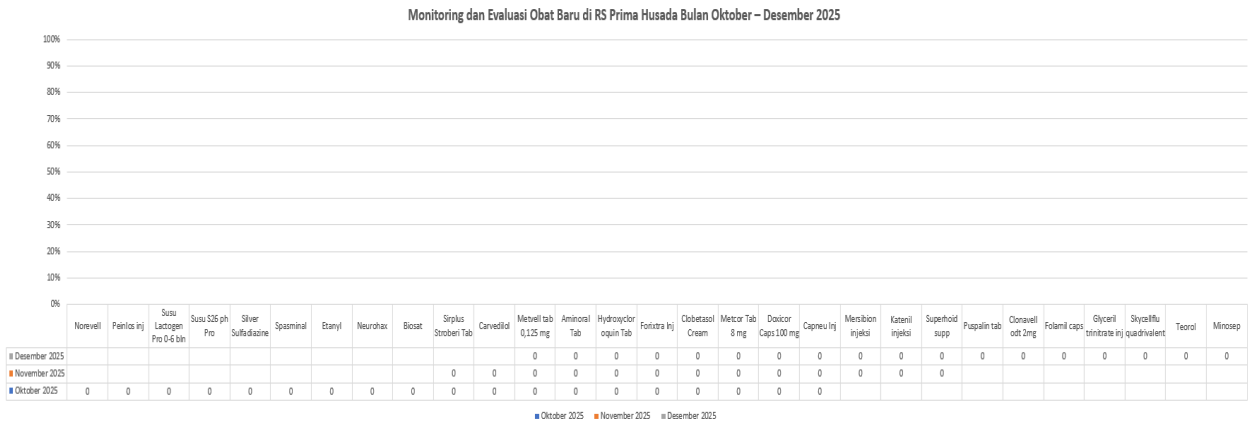
3.7.10 Hasil Monitoring dan Evaluasi Obat Baru di RS Prima Husada Bulan Oktober - Desember Tahun 2025

Tabel Hasil Monitoring dan Evaluasi Obat Baru di RS Prima Husada Bulan Oktober - Desember Tahun 2025

No	Nama Obat	Pemantauan Bulan			Temuan	Keterangan
		Ags 2025	Sep 2025	Okt 2025		
1	Norevell	0	0	0	0	Tidak Ada Temuan
2	Peinlos inj	0	0	0	0	Tidak Ada Temuan
3	Susu Lactogen Pro 0-6 bln	0	0	0	0	Tidak Ada Temuan
4	Susu S26 ph Pro	0	0	0	0	Tidak Ada Temuan
5	Silver Sulfadiazine	0	0	0	0	Tidak Ada Temuan
6	Spasminal	0	0	0	0	Tidak Ada Temuan
7	Etanyl	0	0	0	0	Tidak Ada Temuan
8	Neurohax	0	0	0	0	Tidak Ada Temuan

9	Biosat	0	0	0	0	Tidak Ada Temuan
No	Nama Obat	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Temuan	Keterangan
1	Sirplus Stroberi Tab	0	0	0	0	Tidak Ada Temuan
2	Carvedilol	0	0	0	0	Tidak Ada Temuan
No	Nama Obat	Okt 2025	Nov 2025	Des 2025	Temuan	Keterangan
1	Metvell tab 0,125 mg	0	0	0	0	Tidak Ada Temuan
2	Aminoral Tab	0	0	0	0	Tidak Ada Temuan
3	Hydroxycloquin Tab	0	0	0	0	Tidak Ada Temuan
4	Forixtra Inj	0	0	0	0	Tidak Ada Temuan
5	Clobetasol Cream	0	0	0	0	Tidak Ada Temuan
6	Metcor Tab 8 mg	0	0	0	0	Tidak Ada Temuan
7	Doxicor Caps 100 mg	0	0	0	0	Tidak Ada Temuan
8	Capneu Inj	0	0	0	0	Tidak Ada Temuan
No	Nama Obat	Nov 2025	Des 2025	Jan 2026	Temuan	Keterangan
1	Mersibion injeksi	0	0	-	0	Tidak Ada Temuan
2	Katenil injeksi	0	0	-	0	Tidak Ada Temuan
3	Superhoid supp	0	0	-	0	Tidak Ada Temuan
No	Nama Obat	Des 2025	Jan 2026	Feb 2026	Temuan	Keterangan
1	Puspalin tab	0	-	-	0	Tidak Ada Temuan
2	Clonavell odt 2mg	0	-	-	0	Tidak Ada Temuan
3	Folamil caps	0	-	-	0	Tidak Ada Temuan
4	Glyceril trinitrate inj	0	-	-	0	Tidak Ada Temuan
5	Skycellflu quadrivalent	0	-	-	0	Tidak Ada Temuan
6	Teorol	0	-	-	0	Tidak Ada Temuan
7	Minosep	0	-	-	0	Tidak Ada Temuan

Grafik Hasil Monitoring dan Evaluasi Obat Baru di RS Prima Husada Bulan Oktober - Desember Tahun 2025



Analisis :

1) Pencatatan monitoring dilakukan setiap hari oleh PIC di unit terkait dalam form monitoring dan evaluasi obat baru.

- 2) Hasil monitoring penggunaan obat baru selama 3 bulan tidak ditemukan terjadinya efek samping obat, alergi obat, interaksi obat, dan ROTD.
- 3) Kurangnya pelaporan kejadian efek samping obat oleh tenaga kesehatan.

Tindak Lanjut :

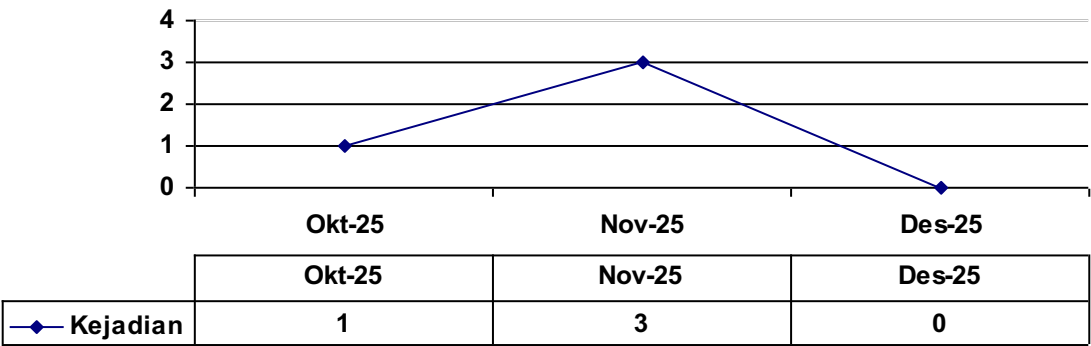
- 1) Kolaborasi dengan komite medik, kepala bidang keperawatan, kepala bidang pelayanan medis untuk sosialisasi pentingnya pelaporan kejadian efek samping obat, alergi obat, interaksi obat, dan ROTD oleh tenaga kesehatan.
- 2) Monitoring Efek Samping Obat (MESO) dan Pemantauan Reaksi Obat Tidak Dikehendaki (ROTD) dilaksanakan secara kolaboratif antara dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya, ditulis di dalam dokumen rekam medik pasien dan dilaporkan selambat - lambatnya 1 x 24 jam dalam bentuk laporan MESO dan dicatat dalam status pasien.
- 3) Mendeteksi adanya kejadian reaksi obat yang tidak dikehendaki (ESO).
- 4) Mengidentifikasi obat-obatan dan pasien yang mempunyai risiko tinggi mengalami ESO.
- 5) Menganalisa laporan ESO.
- 6) Mengisi formulir ESO (lihat di lembar pelaporan ESO).
- 7) Melaporkan ke Tim MESO dan ROTD.

3.7.11 Hasil Monitoring dan Evaluasi Peresepan di Luar Formularium di RS Prima Husada Bulan Bulan Oktober - Desember Tahun 2025

Tabel Hasil Monitoring dan Evaluasi Peresepan di Luar Formularium di RS Prima Husada Bulan Bulan Oktober - Desember Tahun 2025

No.	Bulan	Nama Obat	Temuan	DPJP	Tindak Lanjut
1	Oktober 2025	(24/10/25) Caffeine injeksi	1	dr. Ratih, Sp.A	Pemesanan cito ke distributor Penta Valent
2	November 2025	1. (04/11/25) Aminosteril infant 6% 2. (13/11/25) Betadine gargline 3. (14/11/25) Betadine gargline	3	1. dr. Ratih, Sp. A 2. dr. Sigit, Sp.BP. 3. dr. Sigit, Sp.BP.	3. Pembelian di RS rekanan yaitu RS Prasetya Husada 4. Pembelian mandiri oleh pasien 5. Pembelian mandiri oleh pasien
3	Desember 2025	-	0	-	-

Grafik Hasil Monitoring dan Evaluasi Peresepan di Luar Formularium di RS Prima Husada Bulan Oktober - Desember Tahun 2025



Analisis :

- 1) Pencatatan monitoring dilakukan setiap hari oleh PIC di unit terkait dalam form monitoring dan evaluasi peresepan di luar formularium.
- 2) Hasil monitoring peresepan diluar formularium selama 3 bulan bulan ditemukan masih terjadi peresepan diluar formularium RSPH karena obat dibutuhkan pasien.

Tindak Lanjut :

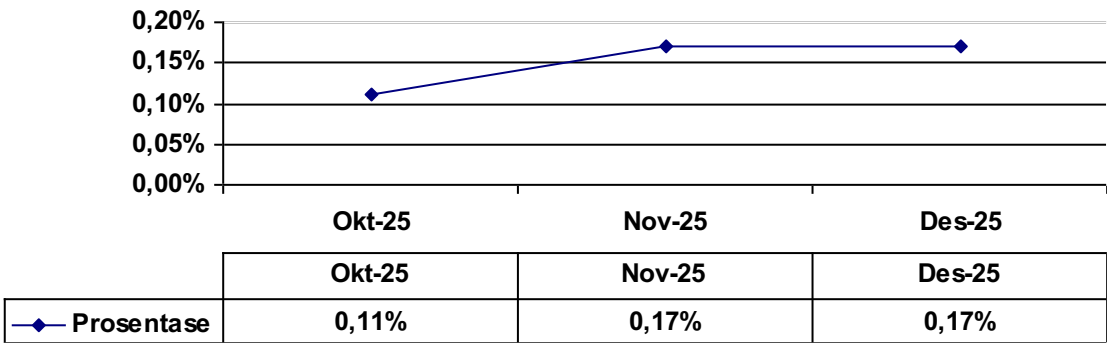
- 1) Kolaborasi dengan komite medik agar DPJP patuh menggunakan formularium RS yang sudah tersedia dan terwujudnya pelayanan obat kepada pasien yang efektif dan efisien berdasarkan daftar obat yang mengacu pada formularium RS.
- 2) Dokter yang melakukan peresepan di luar formularium karena obat tidak tersedia dan pasien membutuhkan obat tersebut maka DPJP mengajukan form pengajuan sediaan farmasi baru.
- 3) Sesuai standar akreditasi maka pengadaan obat di RS / apotik rekanan. Disepakati obat yang dibutuhkan dalam jumlah kecil, namun tidak perlu diadakan di RSPH agar dibuatkan perjanjian kerjasama dengan RS atau apotek rekanan.

3.8.11 Hasil Monitoring dan Evaluasi Ketersediaan Obat di RS Prima Husada Bulan Oktober - Desember Tahun 2025

Tabel Hasil Monitoring dan Evaluasi Ketersediaan Obat di RS Prima Husada Bulan Oktober - Desember Tahun 2025

No	Tanggal	Nama Obat	Golongan Obat	Distributor	Tindak Lanjut
1	1/10/2025-31/10/2025	Borraginol-N Suppositoria	Hemoroid	PT. United Dico Citas	Tanpa saran substitusi
2	1/10/2025-31/10/2025	Borraginol-S Suppositoria	Hemoroid	PT. United Dico Citas	Tanpa saran substitusi
Total prosentase Oktober 2025 = 0.11%					
1	1/11/2025-30/11/2025	Borraginol-N Suppositoria	Hemoroid	PT. United Dico Citas	Substitusi Superhoid suppositoria
2	1/11/2025-30/11/2025	Borraginol-S Suppositoria	Hemoroid	PT. United Dico Citas	Substitusi Superhoid suppositoria
Total prosentase November 2025 = 0.17%					
1	1/12/2025-31/12/2025	Borraginol-N Suppositoria	Hemoroid	PT. United Dico Citas	Substitusi Superhoid suppositoria
2	1/12/2025-31/12/2025	Borraginol-S Suppositoria	Hemoroid	PT. United Dico Citas	Substitusi Superhoid suppositoria
Total prosentase Desember 2025 = 0.17%					

Grafik Hasil Monitoring dan Evaluasi Ketersediaan Obat di RS Prima Husada Bulan Oktober - Desember Tahun 2025



Analisis :

- 1) Pencatatan monitoring dilakukan setiap hari oleh PIC di unit terkait dalam form monitoring dan evaluasi ketersediaan obat.
- 2) Hasil monitoring ketersediaan obat selama 3 bulan ditemukan kekosongan di distributor karena kekurangan bahan baku, delisting produk (pabrik tidak produksi), stok di distributor habis, kekosongan produk originator, dan kosong nasional seperti Borraginol-

N Suppositoria dan Borraginol-S Suppositoria (produk paten originator) sehingga tidak tersedia di pabrik lain dengan kandungan yang sama.

- 3) RS belum bisa melakukan pembelian lewat e-purchasing sehingga belum bisa order obat fast moving khusus obat kronis

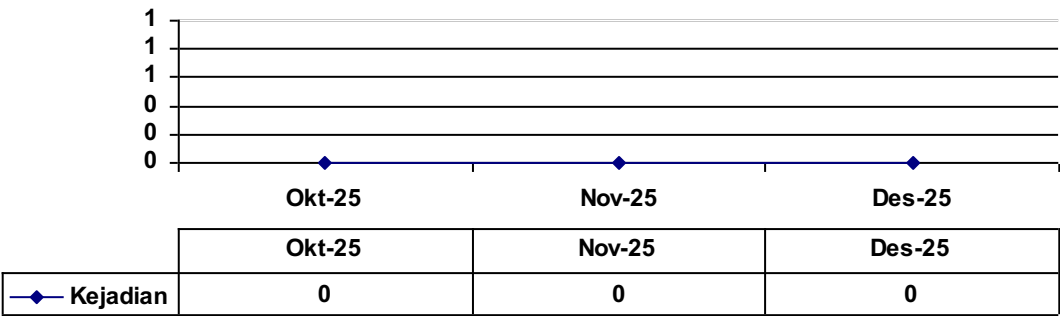
Tindak Lanjut :

- 1) Evaluasi mutu perjanjian kerjasama dengan distributor untuk memberikan konfirmasi apabila stok barang tidak tersedia di distributor setelah menerima pesanan dari RS.
- 2) Mencari substitusi obat lain yang isi/ kandungannya sama.
- 3) Memberi informasi kekosongan obat dan substitusinya ke DPJP melalui surat edaran.
- 4) Evaluasi stok minimal depo farmasi dan Gudang farmasi serta alur pengadaan.

Tabel Hasil Monitoring Efek Samping Obat di RS Prima Husada Bulan Oktober - Desember Tahun 2025

No.	Bulan	Nama Obat	Temuan	ESO	Tindak Lanjut
1	Oktober 2025	-	0	-	-
2	November 2025	-	0	-	-
3	Desember 2025	-	0	-	-

Grafik Hasil Monitoring Efek Samping Obat di RS Prima Husada Bulan Bulan Oktober - Desember Tahun 2025



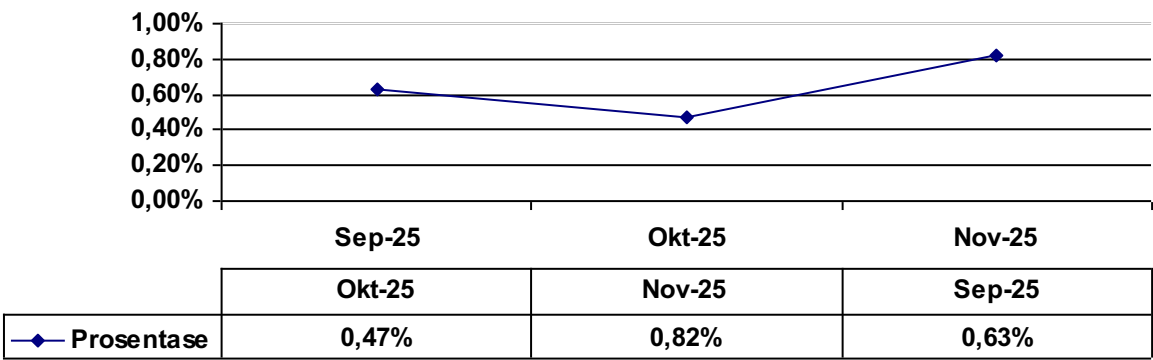
Analisis :

- 1) Pencatatan monitoring dilakukan oleh PIC di unit terkait dalam form MESO dan form IKP.
- 2) Hasil monitoring pelaporan MESO tidak ditemukan terjadinya efek samping obat.

Tindak Lanjut :

- 1) Kolaborasi dengan komite medik, kepala bidang keperawatan, kepala bidang pelayanan medis untuk sosialisasi pentingnya pelaporan kejadian efek samping obat, alergi obat, interaksi obat, dan ROTD oleh tenaga kesehatan.
- 2) Monitoring Efek Samping Obat (MESO) dan Pemantauan Reaksi Obat Tidak Dikehendaki (ROTD) dilaksanakan secara kolaboratif antara dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya, ditulis di dalam dokumen rekam medik pasien dan dilaporkan selambat - lambatnya 1 x 24 jam dalam bentuk laporan MESO dan dicatat dalam status pasien.
- 3) Mendeteksi adanya kejadian reaksi obat yang tidak dikehendaki (ESO).
- 4) Mengidentifikasi obat-obatan dan pasien yang mempunyai risiko tinggi mengalami ESO.
- 5) Menganalisa laporan ESO.
- 6) Mengisi formulir ESO (lihat di lembar pelaporan ESO).
- 7) Melaporkan ke Tim MESO dan ROTD.

Grafik Hasil Monitoring dan Evaluasi Ketidaklengkapan Pemulisan Resep di RS Prima Husada
Bulan Oktober - Desember Tahun 2025



Analisis :

- 1) Pencatatan monitoring ketidaklengkapan penulisan resep dilakukan setiap hari oleh petugas farmasi.
- 2) Dari data di atas masih banyak ditemukan resep yang tidak lengkap.
Dari segi telaah administrasi : sudah lengkap karena menggunakan e-resep
Dari segi telaah farmasetik : masih ditemukan dokter salah input dosis dan jumlah obat, aturan dan cara penggunaan serta rute pemberian tidak lengkap terisi.

Tindak Lanjut :

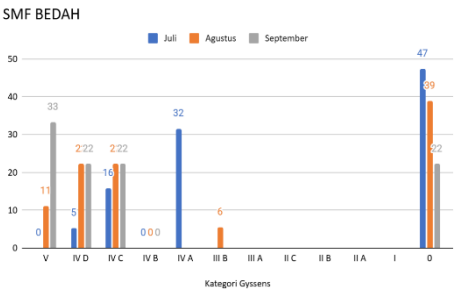
- 1) Koordinasi dengan tim SIMRS untuk membuat sistem jika resep tidak terinput dengan lengkap maka resep tidak dapat masuk ke IFRS.
- 2) Inputan resep harus dilakukan oleh dokter/ dokter spesialis yang kompeten dan berwenang mulai dari identitas pasien, nama obat, dosis, rute pemberian, waktu pemberian, nama dan tandatangan dokter (untuk resep manual).
- 3) Pelatihan penulisan resep untuk semua dokter dan dokter spesialis.

3.10. Kinerja Produktifitas Tim Review Rekam Medis
Tidak Ada Laporan

3.11 Kinerja Produktifitas Komite PPRA
3.11.1 Audit penggunaan antibiotika secara kualitatif (Gyssens)
1. SMF Bedah

Tabel audit penggunaan antibiotika SMF Bedah secara kualitatif
(Gyssens)

NO	Kategori Gyssens	Jumlah (%)		
		Juli	Agustus	September
1.	Kategori V	0	11	33
2.	Kategori IV D	5	22	22
3.	Kategori IV C	16	22	22
4.	Kategori IV B	0	0	0
5.	Kategori IV A	32	0	0
6.	Kategori III B	0	6	0
7.	Kategori III A	0	0	0
8.	Kategori II C	0	0	0
9.	Kategori II B	0	0	0
10.	Kategori II A	0	0	0
11.	Kategori I	0	0	0
12.	Kategori 0	47	39	22
Total		100	100	100



Analisa :

- 1) Pada triwulan III, terdapat kategori 0 yaitu penggunaan antibiotik tepat dan rasional. Presentase kategori 0 tertinggi pada SMF Bedah terdapat pada bulan Juli sebesar 47%. Namun, masih belum ada persentase dari ketiga bulan tersebut yang memenuhi standar.
- 2) Kategori III B pada SMF Bedah terdapat di bulan Agustus dengan prosentase sebesar 6% yang menunjukkan durasi pemberian antibiotik terlalu singkat.
- 3) Kategori IV A, ada pada bulan Juli dengan prosentase sebesar 32% yang menunjukkan pilihan antibiotik yang diberikan tidak tepat karena ada antibiotik lain yang lebih efektif.
- 4) Kategori IV C terdapat pada SMF Bedah sebesar 22% dibulan Agustus dan September yang menunjukkan pilihan antibiotik yang diberikan tidak tepat karena terdapat antibiotik lain yang lebih murah.
- 5) Kategori IV D terdapat pada SMF Bedah sebesar 22% dibulan Agustus dan September yang menunjukkan pilihan antibiotik yang diberikan tidak tepat karena ada antibiotik lain yang lebih sempit spektrumnya.
- 6) Kategori V terdapat pada SMF Bedah sebesar 33% dibulan September yang menunjukkan adanya pemberian antibiotik namun tidak ada indikasi.

Rencana Tindak Lanjut :

- 1) Untuk SMF Bedah, persentase Gyssens kategori V (Pemberian antibiotik tanpa indikasi) masih termasuk cukup tinggi. Begitu juga dengan kategori Gyssens kategori 0 (Pemberian antibiotik tepat dan rasional) yang persentasenya masih belum memenuhi standar, sehingga perlu dukungan manajemen melalui komite medis untuk melakukan supervisi dan sosialisasi terkait penggunaan antibiotik yang bijak dan rasional.

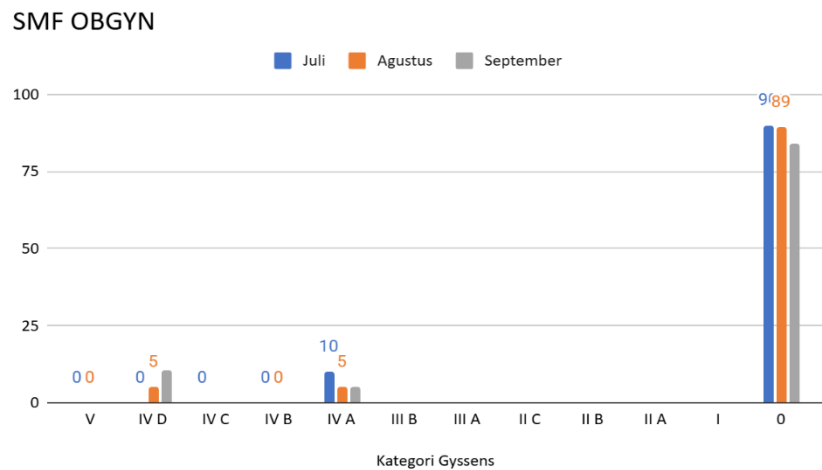
2. SMF Obgyn

Tabel audit penggunaan antibiotika SMF Obgyn secara kualitatif(Gyssens)

NO	KATEGORI GYSSENS	JUMLAH (%)		
		JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER
1.	Kategori V	0	0	0
2.	Kategori IV D	0	5	11
3.	Kategori IV C	0	0	0
4.	Kategori IV B	0	0	0
5.	Kategori IV A	10	5	5
6.	Kategori III B	0	0	0
7.	Kategori III A	0	0	0
8.	Kategori II C	0	0	0
9.	Kategori II B	0	0	0
10.	Kategori II A	0	0	0
11.	Kategori I	0	0	0

12.	Kategori 0	90	90	84
Total		100	100	100

Grafik Audit Penggunaan Antibiotik SMF Obgyn Secara Kualitatif (Gyssens)



Analisa :

- 1) Pada SMF Obgyn terdapat kategori 0 yang menunjukkan penggunaan antibiotik tepat dan rasional. Presentase tertingginya 90% pada bulan Juli dan Agustus. Hasil tersebut sudah sesuai dengan standart yaitu perolehan persentase kategori 0 ≥ 50%.
- 2) Kategori IV A, ada pada bulan Juli dengan prosentase sebesar 10% yang menunjukkan pilihan antibiotik yang diberikan tidak tepat karena ada antibiotik lain yang lebih efektif.
- 3) Kategori IV D terdapat pada SMF Obgyn sebesar 11% dibulan September yang menunjukkan pilihan antibiotik yang diberikan tidak tepat karena ada antibiotik lain yang lebih sempit spektrumnya.

Rencana Tindak Lanjut :

Untuk SMF Obgyn, persentase Gyssens kategori 0 (Pemberian antibiotik bijak dan rasional) pada triwulan III seluruhnya telah mencapai standar. Masih terdapat beberapa kategori lain seperti kategori IV A yaitu pemilihan antibiotik yang tidak efektif, dan IV D yaitu penggunaan antibiotik yang tidak tepat karena ada antibiotik lain yang lebih sempit spektrumnya. Namun, persentasenya kecil sehingga perlu dipertahankan dan diperbaiki.

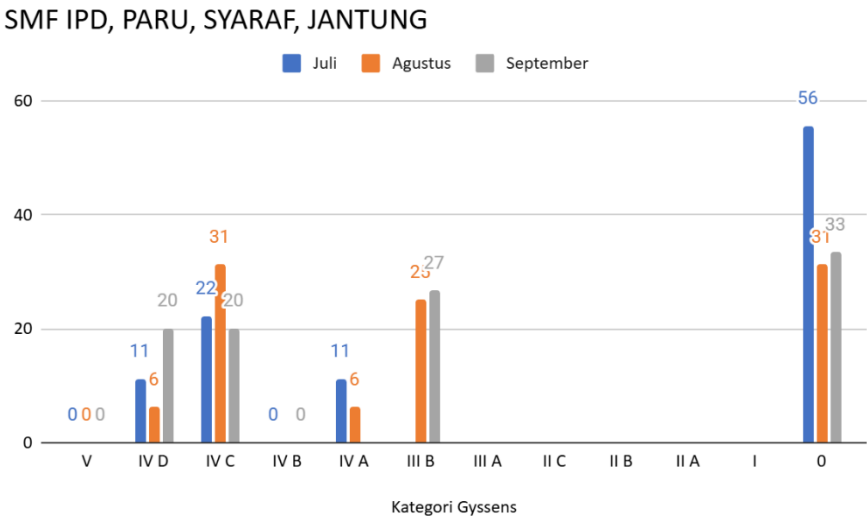
3. SMF IPD, Paru, Jantung dan Syaraf

Tabel Audit Penggunaan Antibiotika SMF IPD, Paru, Syaraf dan Jantung secara kualitatif (Gyssens)

NO	KATEGORI GYSSENS	JUMLAH (%)		
		JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER
1.	Kategori V	0	0	0
2.	Kategori IV D	11	6	20
3.	Kategori IV C	22	31	20
4.	Kategori IV B	0	0	0
5.	Kategori IV A	11	6	0
6.	Kategori III B	0	25	27
7.	Kategori III A	0	0	0
8.	Kategori II C	0	0	0
9.	Kategori II B	0	0	0
10.	Kategori II A	0	0	0

11.	Kategori I	0	0	0
12.	Kategori 0	56	31	33
Total		100	100	100

Grafik Audit Antibiotik SMF IPD, Paru, Syaraf dan Jantung Secara Kualitatif (Gyssens)



Analisa penggunaan antibiotika secara kualitatif (Gyssens) :

- 1) Pada triwulan III, terdapat kategori 0 yaitu penggunaan antibiotik tepat dan rasional. Presentase kategori 0 tertinggi terdapat pada bulan Juli sebesar 56%.
- 2) Kategori III B tertinggi pada SMF IPD, Jantung, Paru, Syaraf dengan prosentase sebesar 27% dibulan September yang menunjukkan durasi pemberian antibiotik terlalu pendek.
- 3) Kategori IV A tertinggi pada SMF IPD, Jantung, Paru, Syaraf. Prosentase tertinggi sebesar 11% dibulan Juli yang menunjukkan pilihan antibiotik yang diberikan tidak tepat karena ada antibiotik lain yang lebih efektif.
- 4) Kategori IV C paling tinggi terdapat pada SMF IPD, Jantung, Paru, Syaraf sebesar 31% dibulan Agustus yang menunjukkan pilihan antibiotik yang diberikan tidak tepat karena terdapat antibiotik lain yang lebih murah.
- 5) Kategori IV D, yaitu pemilihan antibiotik yang kurang tepat karena ada antibiotik lain yang lebih sempit spektrumnya, terdapat prosentase yang paling tinggi yaitu 20% pada bulan September.

Rencana TINDAK LANJUT :

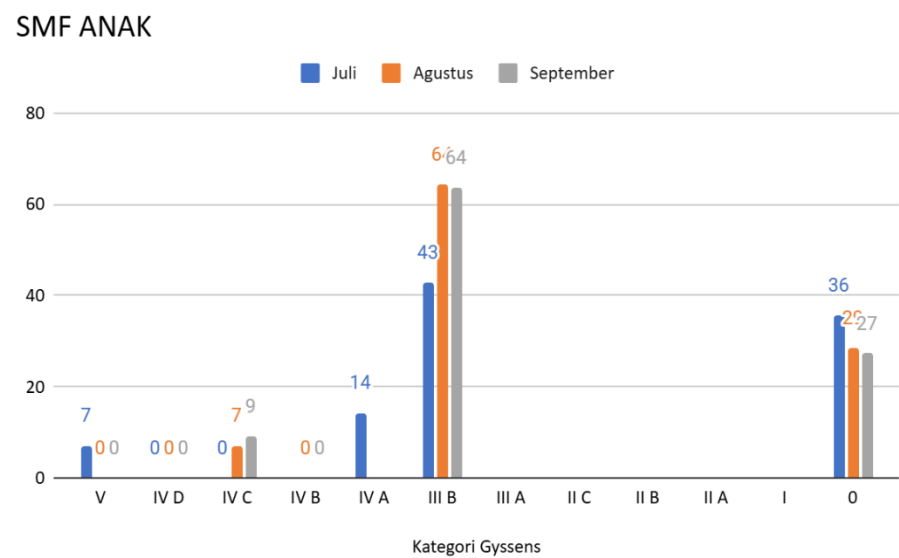
Untuk SMF IPD, Jantung, Paru, Syaraf, persentase Gyssens kategori 0 (Pemberian antibiotik bijak dan rasional) pada bulan Juli telah mencapai standar. Namun tetap ada pemberian antibiotik yang masih kurang tepat, ditunjukan dengan adanya kategori lain, yaitu III B, IV A, IV C dan IV D. Sehingga tetap perlu adanya perbaikan untuk berikutnya.

4. SMF Anak

Tabel audit penggunaan antibiotika SMF Anak secara kualitatif (Gyssens)

NO	KATEGORI GYSENS	JUMLAH (%)		
		JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER
1.	Kategori V	7	0	0
2.	Kategori IV D	0	0	0
3.	Kategori IV C	0	7	9
4.	Kategori IV B	0	0	0
5.	Kategori IV A	14	0	0
6.	Kategori III B	43	64	64
7.	Kategori III A	0	0	0
8.	Kategori II C	0	0	0
9.	Kategori II B	0	0	0
10.	Kategori II A	0	0	0
11.	Kategori I	0	0	0
12.	Kategori 0	36	29	27
Total		100	100	100

Grafik Audit Antibiotik SMF Anak secara kualitatif (Gyssens)



Analisa penggunaan antibiotika secara kualitatif (Gyssens)

- 1) Pada triwulan III, terdapat kategori 0 yaitu penggunaan antibiotik tepat dan rasional. Presentase kategori 0 tertinggi terdapat pada bulan Juli sebesar 36%.
- 2) Kategori III B, dengan prosentase sebesar 64% dibulan Agustus dan September yang menunjukkan durasi pemberian antibiotik terlalu pendek
- 3) Kategori IV A tertinggi pada SMF Anak dengan prosentase tertinggi sebesar 14% dibulan Juli yang menunjukkan pilihan antibiotik yang diberikan tidak tepat karena ada antibiotik lain yang lebih efektif.
- 4) Kategori IV C paling tinggi sebesar 9% dibulan September yang menunjukkan pilihan antibiotik kurang tepat karena terdapat antibiotik lain yang lebih murah.
- 5) Kategori V, yaitu pemilihan antibiotik yang kurang tepat karena tidak ada indikasi, terdapat pada bulan Juli dengan prosentase sebesar 7%.

Rencana Tindak Lanjut :

Untuk SMF Anak, persentase Gyssens kategori 0 (Pemberian antibiotik bijak dan rasional) pada triwulan III masih belum ada yang memenuhi standar. Terdapat juga pemberian antibiotik yang masih kurang tepat, ditunjukkan dengan adanya kategori lain, yaitu III B, IV A, IV C dan V. Sehingga perlu adanya perbaikan untuk triwulan berikutnya.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan penggunaan antibiotik rasional, maka perlu dilakukan PDSA sebagai berikut :

PLAN	DO	STUDY	ACTION
1. Meningkatkan persepahan antibiotik rasional >50%. 2. Meningkatkan kepatuhan DPJP terhadap PPAB dengan cara: • Melakukan sosialisasi secara rutin dan terus-menerus • Melaksanakn monitorig dan evaluasi terhadap penggunaan antibiotik rasional oleh tim PPRA.	1. Mengamati pelanggaran DPJP terhadap PPAB 2. Menelusuri penyebab terjadinya pelanggaran tersebut dengan pendekatan secara personal.	DPJP diajak berdiskusi untuk membentuk PPAB yang sesuai dengan PPK yang betul-betul disepakati.	Meningkatkan kepatuhan DPJP terhadap PPAB dengan cara: 1. melakukan sosialisasi secara rutin dan terus menerus

3. Surveilans pola kuman dan kepekaan antibiotika tahun 2025
- Surveilans pola kuman dan kepekaan antibiotika tahun 2025 masih dalam proses pengajuan pembuatan pola kuman.

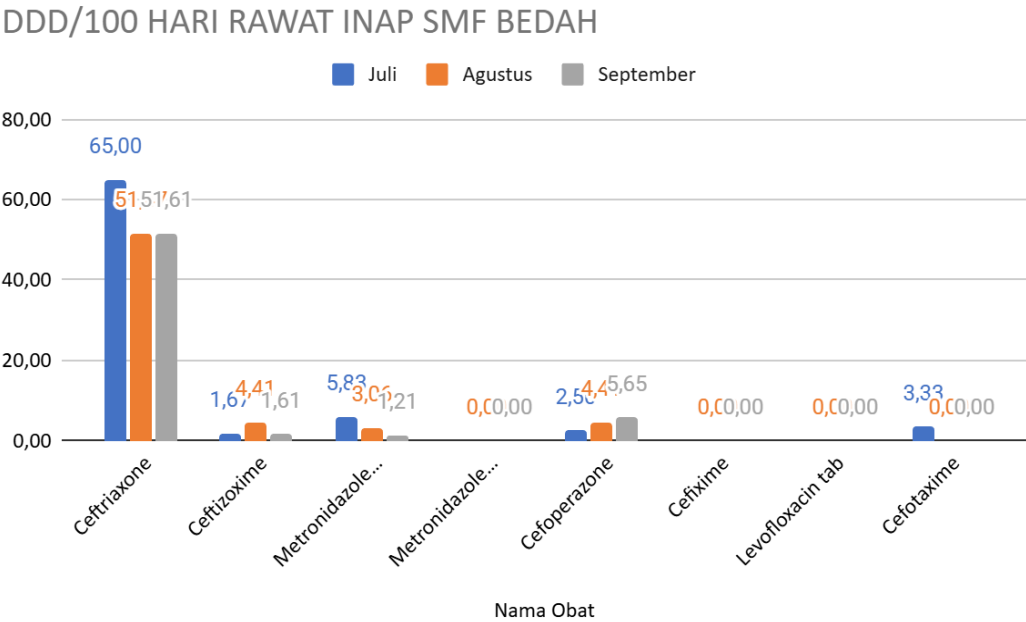
3.11.2 Audit Penggunaan Antibiotik secara Kuantitatif Triwulan III Tahun 2025

1. SMF Bedah

Tabel Perhitungan Antibiotik pada SMF Bedah Secara Kuantitatif

NO	NAMA OBAT	BULAN (DDD/100)		
		JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER
1.	Ceftriaxone	65,00	51,47	51,61
2.	Ceftizoxime	1,67	4,41	1,61
3.	Metronidazole tab	5,83	3,06	1,21
4.	Metronidazole inf	0	0,00	0,00
5.	Cefoperazone	2,50	4,41	5,65
6.	Cefixime	0	0,00	0,00
7.	Levofloxacin tab	0	0,00	0,00
8.	Cefotaxime	3,33	0,00	0,00

Grafik Penggunaan Antibiotik Pada SMF Bedah Secara Kuantitatif



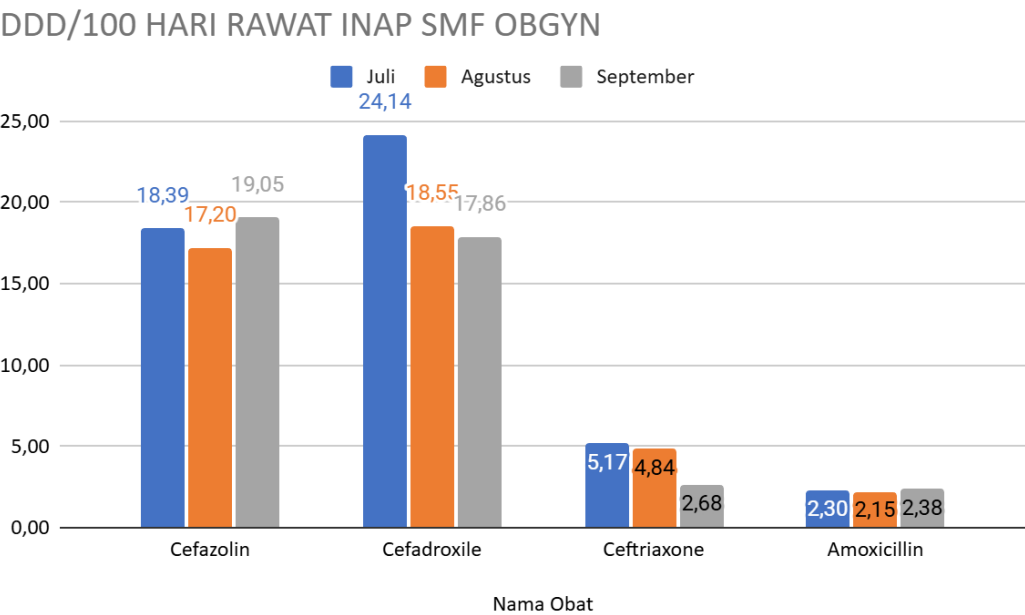
Analisa :
Penggunaan antibiotik pada triwulan III tahun 2025 oleh SMF Bedah terdiri dari Ceftriaxone, Ceftizoxime, Metronidazole po, Metronidazole inf, Cefoperazone, Cefixime, Levofloxacin po, dan Cefotaxime. Antibiotik yang paling banyak digunakan oleh SMF bedah adalah antibiotik Ceftriaxone. Nilai tertinggi terdapat di bulan Juli sebesar 65,00 DDD/100 hari rawat inap. Hasil tersebut dapat dikaitkan dengan pemberian Ceftriaxone sebagai terapi empiris pada kebanyakan diagnosis infeksi di RS Prima Husada Malang.

2. SMF Obgyn

Tabel Perhitungan Antibiotik pada SMF Obgyn Secara Kuantitatif

NO	NAMA OBAT	BULAN (DDD/100)		
		JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER
1.	Cefazolin	18,39	17,20	19,05
2.	Cefadroxile	24,14	18,55	17,86
3.	Ceftriaxone	5,17	4,84	2,68
4.	Amoxicillin	2,30	2,15	2,38

Grafik Penggunaan Antibiotik pada SMF Obgyn



Analisa :
Penggunaan antibiotik pada SMF Obgyn terdiri dari Cefazolin, Cefadroxile, Ceftriaxone, dan Amoxicillin. Antibiotik yang paling banyak di gunakan pada SMF Obgyn adalah antibiotik Cefadroxile. Nilai DDD/100 Cefadroxile tertinggi terdapat pada bulan Juli sebesar 24,14 DDD/100 hari rawat inap.

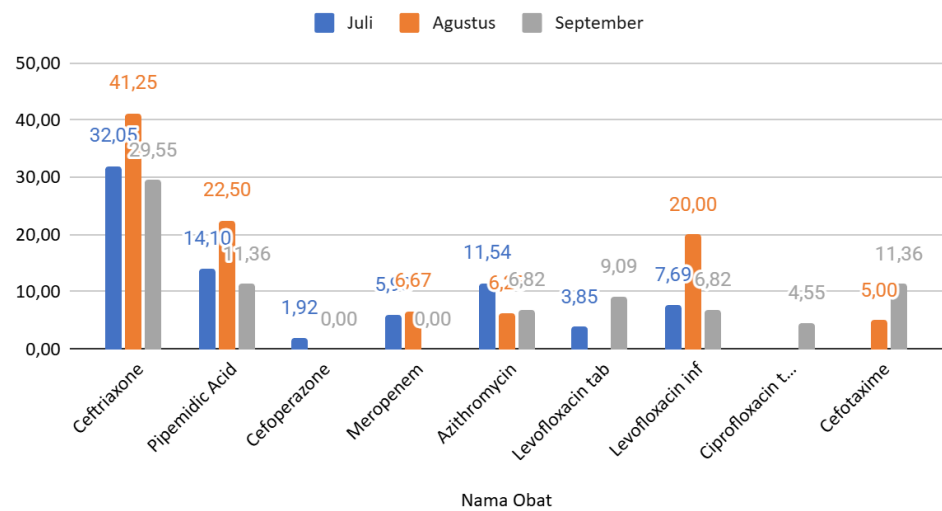
3. SMF IPD, Paru, Jantung dan Syaraf

Tabel Perhitungan Antibiotik pada SMF IPD, Paru, Jantung dan Syaraf

NO	NAMA OBAT	BULAN (DDD/100)		
		JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER
1.	Ceftriaxone	32,05	41,25	29,55
2.	Pipemidic Acid	14,10	22,50	11,36
3.	Cefoperazone	1,92	0	0,00
4.	Meropenem	5,98	6,67	0,00
5.	Azithromycin	11,54	6,25	6,82
6.	Levofloxacin tab	3,85	0	9,09
7.	Levofloxacin inf	7,69	20,00	6,82
8.	Ciprofloxacin tab	0	0	4,55
9.	Cefotaxime	0	5,00	11,36
10.	Clindamycin tab	0	0	12,50
11.	Meropenem	0	0	5,95

Grafik Penggunaan Antibiotik pada SMF IPD, Paru, Syaraf, Jantung

DDD/100 HARI RAWAT INAP SMF IPD PARU, JANTUNG, SYARAF



Analisa :
Penggunaan antibiotik oleh SMF IPD, Jantung, Paru dan Syaraf pada triwulan III terdiri dari 9 macam antibiotik. Antibiotik yang paling banyak di gunakan pada SMF SMF IPD, Paru, Syaraf dan Jantung adalah antibiotik Ceftriaxone. Nilai tertinggi penggunaan Ceftriaxoen terdapat dibulan Mei dengan nilai 41,25 DDD/100 hari rawat inap.

3.12. Kinerja Produktifitas Komite Keperawatan
3.12.1 Jumlah penanganan kasus Etik Keperawatan yang Ditangani

Tabel Data Penanganan Kasus Etik Keperawatan Triwulan III Tahun 2025

Tanggal	Jenis Pelanggaran	Unit	Kategori Pelanggaran Kasus	Jumlah Kasus	Bentuk Pembinaan/Teguran	Hasil Pembinaan	Tindak Lanjut	Petugas Pembina	Status
29/07/2025	Kejadian komplain pada Google review (bintang 1) karena sikap petugas (perawat) yang dianggap tidak baik.	IRJA	Pelanggaran sedang-berat dengan objek tanggung jawab perawat terhadap pasien.	1	- Teguran Lisan - SP 1 (sesuai tatib RS) - Pembinaan oleh Karu unit	Perawat memahami kesalahan dan berkomitmen tidak mengulangi serta akan membantu menaikkan rating google review RS.	Monitoring perilaku petugas dalam pelayanan.	Sub Komite Etik Keperawatan SDM Kepala Ruang IRJA	Selesai
18/10/2025	Kejadian komplain Karu IRNA 5C kepada perawat IRJA yang dianggap melakukan fitnah dengan menganggap menyebarkan	IRJA	Riangan (Kesalahpahaman antar staf)	1	- Klarifikasi - Mediasi	Masing-masing perawat dan pihak terkait paham kesalahan masing-masing dan sudah tidak ada lagi kesalahpahaman diantara mereka, sudah saling memaafkan dan	Monitoring perilaku dan komunikasi antar perawat.	Sub Komite Etik Keperawatan SDM	Selesai

	berita tidak benar.					berkomitmen untuk memperbaiki komunikasi antar perawat.			
--	---------------------	--	--	--	--	---	--	--	--

Analisa :

Selama Triwulan III Tahun 2025, terdapat 2 kasus pelanggaran etik keperawatan yang ditangani oleh Sub Komite Etik Keperawatan. Kasus pertama berasal dari unit IRJA (Rawat Jalan) berupa komplain publik melalui Google Review yang menyoroti sikap petugas terhadap pasien. Kasus kedua terjadi di unit IGD, terkait ketidaksesuaian tindakan dan refund biaya pasien di luar ketentuan SPO rumah sakit. Dari hasil penelusuran dan klarifikasi, diperoleh beberapa poin analisa:

- a) Faktor individu: kurangnya kontrol diri dan etika komunikasi beberapa petugas saat menghadapi pasien, terutama pada kondisi padat pelayanan.
- b) Faktor sistem: masih kurangnya sosialisasi dan supervisi rutin tentang penerapan etika profesi dan komunikasi terapeutik.
- c) Faktor lingkungan: tekanan beban kerja dan situasi darurat di IGD yang berpotensi menurunkan kualitas interaksi dengan pasien.
- d) Faktor organisasi: mekanisme pelaporan dan umpan balik terhadap keluhan pasien belum tersampaikan cepat ke Sub Komite Etik.

Secara umum, setelah dilakukan pembinaan dan teguran lisan oleh Kepala Ruangan serta Sub Komite Etik, kedua petugas telah memahami kesalahan dan berkomitmen untuk tidak mengulangi. Tidak ditemukan unsur pelanggaran berat yang memerlukan tindak lanjut disiplin lanjutan.

Rencana Tindak Lanjut

Tujuan	Sasaran	Strategi / Tindakan	Pelaksana	Waktu
Meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan etika profesi perawat	Seluruh perawat RS Prima Husada	Melaksanakan refreshment etika keperawatan dan komunikasi terapeutik di setiap unit	Sub Komite Etik & Komite Keperawatan	Oktober 2025
Menurunkan potensi keluhan pasien akibat sikap petugas	Unit IGD & IRJA	Supervisi rutin perilaku petugas dan simulasi komunikasi efektif saat menghadapi pasien	Kepala Ruang & Bidang Keperawatan	Oktober–Desember 2025
Memperkuat sistem pelaporan dan tindak lanjut kasus etik	Semua unit pelayanan	Membuat formulir pelaporan etik sederhana dan grup koordinasi internal antar kepala ruangan	Sub Komite Etik & SDM	November 2025
Meningkatkan citra dan kepuasan pasien	Unit pelayanan rawat jalan dan IGD	Melakukan survei kepuasan pasca pembinaan dan evaluasi respon pasien	Komite Keperawatan & PKRS	Desember 2025

Tabel Data Penanganan Kasus Etik Keperawatan Triwulan IV tahun 2025

Tanggal	Jenis Pelanggaran	Unit	Kategori Pelanggaran Kasus	Jumlah Kasus	Bentuk Pembinaan/Teguran	Hasil Pembinaan	Tindak Lanjut	Petugas Pembina	Status
13/10/2025	Kurang menghargai privacy, hasil kerja, martabat profesi lain (dokter), dengan membandingkan hasil kerja dpjp dengan dpjp lain.	IRNA 5C	Pelanggaran ringan dengan objek tanggung jawab perawat terhadap profesi lain.	1	- Teguran Lisan	Perawat memahami kesalahan komunikasi yang dibuat dan berkomitmen tidak mengulangi lagi.	Monitoring perilaku petugas dalam pelayanan.	Sub Komite Etik Keperawatan SDM Kepala Ruang IRNA 5C	Selesai
18/10/2025	Kejadian komplain Karu IRNA 5C kepada perawat IRJA yang dianggap melakukan fitnah dengan menganggap menyebarkan berita tidak benar.	IRJA	Riangan (Kesalahpahaman antar staf)	1	- Klarifikasi - Mediasi	Masing-masing perawat dan pihak terkait paham kesalahan masing-masing dan sudah tidak ada lagi kesalahpahaman diantara mereka, sudah saling memaafkan dan berkomitmen untuk memperbaiki komunikasi antar perawat.	Monitoring perilaku dan komunikasi antar perawat.	Sub Komite Etik Keperawatan SDM	Selesai

Analisa :

Pada Triwulan IV Tahun 2025 terdapat 2 (dua) kasus etik keperawatan yang ditangani oleh Sub Komite Etik Keperawatan. Seluruh kasus termasuk dalam kategori pelanggaran ringan, yang didominasi oleh masalah komunikasi dan pemahaman antar tenaga keperawatan serta kurangnya sikap saling menghargai profesionalisme antar profesi.

Bentuk penanganan yang diberikan berupa teguran lisan, klarifikasi, dan mediasi, yang menunjukkan bahwa pendekatan pembinaan lebih diutamakan dibandingkan sanksi. Hasil pembinaan menunjukkan adanya perubahan sikap positif, meningkatnya pemahaman terhadap kesalahan komunikasi, serta komitmen petugas untuk tidak mengulangi pelanggaran.

Meskipun seluruh kasus berstatus selesai, kejadian ini mengindikasikan perlunya penguatan komunikasi efektif, etika profesi, dan budaya saling menghargai di lingkungan kerja, khususnya di unit pelayanan dengan intensitas kerja tinggi seperti IRNA dan IRJA

Rencana Tindak Lanjut

Tujuan	Sasaran	Strategi / Tindakan	Pelaksana	Waktu
Meningkatkan pemahaman etika profesi keperawatan	Seluruh perawat IRNA & IRJA	Sosialisasi ulang kode etik keperawatan dan etika komunikasi profesional	Sub Komite Etik Keperawatan, SDM Keperawatan	Triwulan I 2026
Mencegah terulangnya konflik antar tenaga keperawatan	Perawat pelaksana di unit pelayanan	Edukasi komunikasi efektif dan manajemen konflik dalam pelayanan	Sub Komite Etik Keperawatan	Triwulan I 2026
Memperkuat budaya saling menghargai antar profesi	Perawat dan tenaga kesehatan terkait	Pembinaan berkelanjutan melalui briefing unit dan role model kepala ruangan	Kepala Ruangan, Komite Keperawatan	Berkelanjutan
Meningkatkan deteksi dini permasalahan etik	Kepala Ruangan dan Koordinator Shift	Monitoring perilaku profesional dan pelaporan dini potensi masalah etik	Kepala Ruangan, Sub Komite Etik	Berkelanjutan

3.13. Kinerja Produktifitas Komite Medis

NO	KEGIATAN POKOK	RINCIAN KEGIATAN	STANDART	TARGET	HASIL	KET
1	Kedisiplinan pengurusan SIP dokter	1. Pendataan SIP yang akan habis 2. Follow up pengurusan	100%	Belum memenuhi target 100%, karena ada 5 dokter yang habis masa SIP nya	1. Mendata SIP DPJP yang akan habis pada tahun 2025 2. Melakukan follow up pengurusan STR 3. Koordinasi dengan SDM terkait kelengkapan apa saja yang dibutuhkan untuk pengurusan SIP 4. Membantu membuat surat keterangan jumlah pasien/Tindakan untuk pengurusan STR	

2	Pelaksanaan E-RM	1. Sosialisasi E-RM pada dokter spesialis 2. Koordinasi dengan programmer 3. Membuat fitur aplikasi E-RM 4. Melakukan trial secara bertahap 5. Melakukan monitoring dan eksekusi apabila ada kendala 6. Melengkapi sarana prasarana yang	100%	Belum memenuhi target 100%, karena rehab medik belum full E-RM	1. Yang sudah melaksanakan E-RM adalah semua dokter. Termasuk poli rehab medik 2. Ada beberapa pasien yang di review oleh RM< hasilnya masih ada yang belum connect antara billing IRJA dengan RMdibutuhkan seperti PC, tab , specimen dll	
3	Kredensial dokter baru	1. Menyiapkan berkas kelengkapan kredensial termasuk draft RKK 2. Mengajukan pada ketua komdik untuk dilakukan kredensial sesuai instruksi direktur 3. Pengisian draft RKK diserahkan bisa softcopy maupun hardcopy 4. Sekomdik mengajukan draft RKK ke Sub Kredensial dan disetujui oleh Ketua Komite Medik 5. Direktur menerbitkan surat penugasan	100%	Terpenuhi	Dokter yang melakukan proses kredensial tahun 2025 : 1. Drg. Khadijah Sp.KG	

		klinis jika RKK sudah ditandatangani oleh sub kredensial dan ketua komdik				
4	Proporsi	Kebijakan PT terkait tarif proporsi dilakukan per September 2025	100%	Sudah memenuhi target	1. Rapat dan diskusi dilakukan oleh PT untuk kedua RS, RPHM dan RSPHS 2. Tarif proporsi dikenakan untuk pasien rawat jalan dan rawat inap 3. Jika ada pasien yang melebihi plafon inacbg's maka DPJP akan dikenakan tarif proporsi, sedangkan jika DPJP melakukan perawatan pada pasien dibawah inacbgs, maka akan surplus 4. Karena banyak DPJP yang tidak puas dengan adanya tarif proporsi, diadakan rapat diskusi baik offline door to door maupun zoom yang dilakukan untuk menjembatani agar kebijakan proporsi dapat diterima dengan bijak 5. Perubahan tarif obat, tindakan maupun ruangan di	

					review ulang oleh PT 6. Diharapkan DPJP dapat bekerjasama dan koordinasi terkait kendala dan solusi dari kebijakan proporsi, agar kebijakan tersebut tetap safety di dpjp maupun pasien	
--	--	--	--	--	--	--

3.14 Kinerja Produktifitas Komite Tenaga Kesehatan Lain

Kegiatan pada Tahun 2025 di Bidang SDM

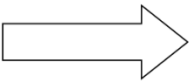
NO	KEGIATAN POKOK	PEMENUHAN RENCANA KEGIATAN
1	Kebutuhan SDM	Perubahan pembentukan komite tenaga kesehatan lain.
2	Orientasi	Tidak ada karyawan baru yang perlu diorientasi.
3	Pendidikan dan Pelatihan	a) Update ilmu dilakukan dengan mengikuti daring seminar. b) Sosialisasi dilakukan oleh SDM kepada seluruh anggota komite nakes lain
4	Kredensialing	Kegiatan diikuti oleh seluruh tim komite dan unit (kredensial nakes lain dilakukan setiap 3 tahun sekali/jika ada penambahan atau perubahan kompetensi)

Analisis :

- Ruang lingkup komite nakes lain meliputi kebutuhan SDM, orientasi, pendidikan dan pelatihan beberapa berjalan sesuai target pada tahun 2025.
- Sosisalisasi oleh SDM tetap dilakukan oleh para anggota komite nakes lain di unit.
- Telah dilakukan kredensialing oleh komite tenaga kesehatan lain pada karyawan lama.

Perubahan Pembentukan Komite Tenaga Kesehatan Lain

KOMITE TENAGA KESEHATAN LAIN		KOMITE TENAGA KESEHATAN LAIN	
Ketua Komite Tenaga Kesehatan Lain	: Ayu Bintang Tinara, A.Md.Rad	Ketua Komite Tenaga Kesehatan Lain	: Dinar Sahara, A.Md.Fis
Sekretaris	: Enicha Risdavati, A.Md.Gz	Sekretaris	: Elzada Sofi Ananda A.Md. Kes
Sub Komite Mutu	: Elis Wahyuni, A.Md.AK	Sub Komite Mutu	: Elis Wahyuni, A.Md.AK
Sub Komite Etik dan Disiplin	: Elzada Sofi Ananda Amd. Kes	Sub Komite Etik dan Disiplin	: apt. Guspa Gayatri Azmi, S. Farm
Sub Komite Kredensial	:	Sub Komite Kredensial	:
Rekam Medik	: Annisa Aulia Savira, A.Md.Kes	Rekam Medik	: Annisa Aulia Savira, A.Md.Kes
Radiodiagnostik dan Radioterapi	: Isma Mufida Amd.Rad	Radiodiagnostik dan Radioterapi	: Isma Mufida Amd.Rad
Apoteker dan TTK	: Rikdah Bunga Kvintana S.Farm.,Apt	Apoteker dan TTK	: apt. Guspa Gayatri Azmi, S. Farm
Ahli Gizi	: Suci Nur Pratiwi S. Gz	Ahli Gizi	: Suci Nur Pratiwi S. Gz
Analisis Kesehatan	: Bella Kristyana Devi Amd.Kes	Analisis Kesehatan	: Arinta Astri Maulina, A.Md.Kes
Fisioterapis	: Dinar Sahara, A.Md.Fis	Fisioterapis	: Amalia Lusyanti, A.Md.Fis



Analisis:

- 1. Terjadi perubahan struktur dikarenakan ketua dimutasi dari RS Prima Husada Malang ke PT Disa Prima Medika
- 2. Sekretars sudah menjadi anggota akreditasi (PAP)
- 3. Struktur komite juga diharapkan komite KTKL lebih aktif dibanding dengan sebelumnya.

Tabel Rincian Jumlah Tenaga Kesehatan Lain

NO	UNIT	JUMLAH YANG SUDAH KREDENSIAL TAHUN 2025	JUMLAH YANG AKAN DIKREDENSIAL TAHUN 2026
1	FARMASI	33	
	APOTEKER		0
	TTK		0
2	LABORATORIUM	9	0
3	REKAM MEDIS	11	5
4	GIZI	6	0
5	RADIOLOGI	7	0
6	FISIOTERAPI	5	1
TOTAL		71	6

Analisis:

- 1. Komite tenaga kesehatan lain telah melakukan rekredensialing pada tahun 2025. Kredensial dilakukan kepada staf lama yang terakhir kredensial di 2022 dan staf baru yang masuk.
- 2. Komite tenaga kesehatan lain akan melakukan kegiatan kredensial pada tahun 2025 sejumlah 6 orang. Hal ini disebabkan karena staf lama yang harus dilakukan kredensial ulang.
- 3. Jumlah staf KTKL yang telah di kredensial sejumlah 71 orang terdiri dari staf baru dan staf lama yang terkhir kredensial di tahun 2022.

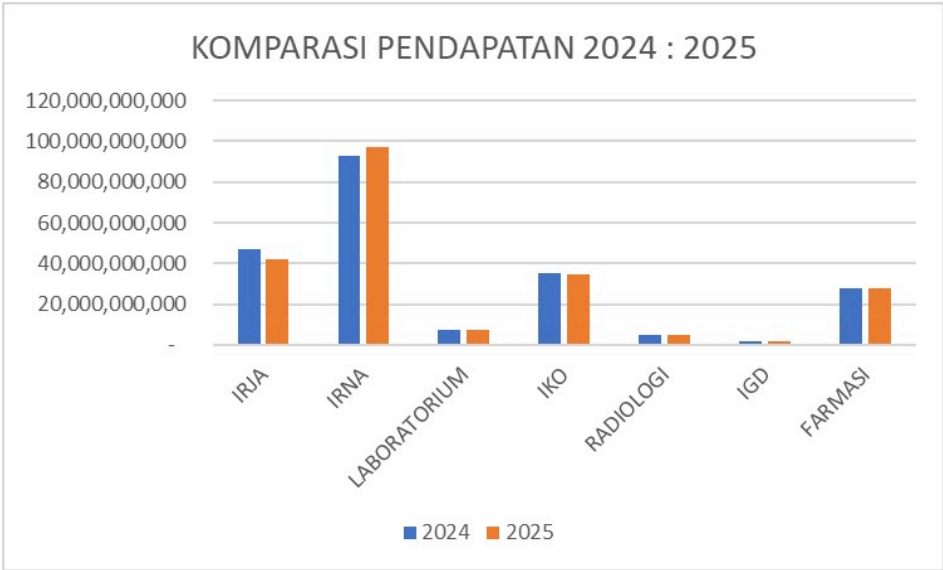
Tabel Mekanisme Pengelolaan Tenaga Kesehatan Lain

NO	KEGIATAN POKOK	RINCIAN KEGIATAN TAHUN 2025
1	Pengelolaan tenaga kesehatan lain	Pada bulan Triwulan ini dilakukan perubahan penetapan anggota komite tenaga kesehatan lain.
2	Kredensialing	a. Kredensial unit dilakukan oleh sub komite tenaga kesehatan lain yang kemudian dilakukan kegiatan kredensial. b. Rincian kewenangan klinis diterbitkan oleh Rumah Sakit yang ditandatangani oleh direktur

BAB IV

KINERJA KEUANGAN

4.1 Pendapatan Tahun 2025



UNIT	2024	2025
IRJA	46,891,630,550	42,006,218,743
IRNA	92,890,300,215	97,379,347,303
LABORATORIUM	7,254,554,759	7,599,655,706
IKO	35,326,937,514	34,411,401,485
RADIOLOGI	4,603,732,404	4,915,335,375
IGD	1,686,103,431	1,616,365,638
FARMASI	27,859,509,714	28,031,600,906

Analisa :
Tahun 2025 terdapat penurunan terbesar pada rawat jalan dikarenakan penurunan pasien rawat jalan sebesar 13 % dari tahun sebelumnya

Rencana Tindak Lanjut :
Peningkatan jumlah kunjungan rawat jalan, rawat inap dan pemeriksaan terpisah lain di tahun 2026

- 4.2 Biaya Tahun 2024
Data disampaikan oleh PT. Disa Prima Medika
- 4.3 Rasio Keuangan
Data disampaikan oleh PT. Disa Prima Medika

4.4 Kinerja Piutang

PIUTANG RS PRIMA HUSADA MALANG																
PERIODE 2025																
NO	DESKRIPSI	SALDO AWAL PIUTANG	PEMBAYARAN (BULAN SEBELUMNYA)	SELISIH KURANG BAYAR (BULAN SEBELUMNYA)	SISA PIUTANG (BULAN SEBELUMNYA)	PENAMBAHAN PIUTANG (BULAN BERJALAN)	PEMBAYARAN (BULAN BERJALAN)	SELISIH KURANG BAYAR (BULAN BERJALAN)	SISA PIUTANG (BULAN BERJALAN)	SALDO AKHIR PIUTANG	UMUR PIUTANG					JUMLAH PIUTANG
											Y	Z	AA	AB	AC	
											0-30 HARI	31-60 HARI	61-90 HARI	91-120 HARI	>120 HARI	
		a	b	c	(a-b-c=d)	e	f	g	(e-f-g=h)	d+h						Total
PERIODE DESEMBER 2025 :																
1	Asuransi	365,763,239	157,130,658	4,069,247	204,563,334	217,353,863	40,252,270	2,488,949	174,612,643	379,175,978	306,083,359	37,019,208	12,513,724	9,735,415	13,824,272	379,175,979
2	Perusahaan	628,339,622	421,301,342	526,580	206,511,700	283,931,794	-	-	283,931,794	490,443,494	385,068,163	8,028,394	47,889,611	-	48,657,327	490,443,495
3	Mandiri Inhealth	167,785,401	64,787,170	1,511,696	101,486,535	52,768,084	-	-	52,768,084	154,254,619	154,254,619	-	-	-	-	154,254,619
4	Jasa Raharja	260,845,598	218,626,708	1	42,218,889	186,456,651	82,569,144	1	103,887,506	146,106,395	146,106,395	-	-	-	-	146,106,395
5	BPJS Ketenagakerjaan	619,614,952	597,740,684	798,501	21,075,767	557,155,732			557,155,732	578,231,499	557,155,732	375,949	-	-	20,699,818	578,231,499
									Total Saldo	1,748,211,985	1,549,468,267	45,423,551	60,403,335	9,735,415	83,181,416	1,748,211,986

Keterangan :
- Cut Off Piutang per 31 Desember 2025 Rp 1.748.211.986,-

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Rumah Sakit Prima Husada Malang yang selalu berbenah untuk meningkatkan pelayanan baik dari sisi Sarana dan prasarana maupun dari sisi Sumber Daya Manusia supaya pelayanan Kesehatan di RS Prima Husada Malang lebih baik lagi. Seiring dengan berjalannya waktu dan adanya perubahan regulasi di bidang Kesehatan, masih terdapat beberapa kendala baik dari kelompok tenaga Kesehatan dan juga kelompok non tenaga Kesehatan terutama dari segi administrasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tata cara penempatan SDM di Rumah Sakit masih terdapat penempatan karyawan yang belum sesuai dengan kompetensi dan sertifikasinya, sehingga terjadi beberapa rotasi dan mutasi di lingkup RS Prima Husada Malang. Situasi proporsi jumlah antara karyawan kontrak/tidak tetap dengan karyawan tetap di Rumah Sakit, Dimana jumlah karyawan kontrak/tidak tetap yang lebih banyak dibandingkan dengan jumlah karyawan tetap di RS Prima Husada Malang, hal ini diperkirakan bisa mempengaruhi kualitas pelayanan di Rumah Sakit Prima Husada Malang.

Struktur Organisasi dan TataKelola Rumah Sakit Prima Husada Malang sudah terpenuhi untuk unsur jajaran Direksi sampai dengan bulan Desember, Dimana secara SOTK Rumah Sakit jajaran Direksi terdiri dari Direktur Rumah Sakit, Kepala Bidang Pelayanan Medis, Kepala Bidang Penunjang Medis, Kepala Bidang Keperawatan dan Kepala Bagian Umum dan Keuangan. Disamping beberapa jabatan non Struktural di Rumah Sakit seperti Komite Medik, Komite Keperawatan, Komite etik, Komite mutu dan beberapa Tim yang ada di Rumah Sakit Prima Husada Malang.

Kinerja RS Prima Husada Malang mengalami peningkatan di tahun sebelumnya meskipun dalam penilaian indikator Mutu Rumah Sakit ada beberapa indikator yang belum tercapai, salah satu diantaranya adalah kepatuhan DPJP dalam visite pasien dan kepatuhan dalam Clinical pathway. Hal ini juga mempengaruhi kualitas mutu layanan di Rumah Sakit. Untuk jumlah kunjungan di Rumah Sakit Prima Husada Malang masih didominasi oleh pasien JKN selama tahun 2025.

5.2 Saran

1. Meningkatkan ketertiban administrasi di Rumah Sakit
2. Meningkatkan dan mengoptimalkan kinerja dari komite – komite dan Tim yang ada di Rumah Sakit Prima Husada Malang
3. Meningkatkan kepatuhan visite DPJP untuk meningkatkan pelayanan di Rumah Sakit Prima Husada Malang
4. Meningkatkan kepatuhan terhadap Clinical Pathway untuk meningkatkan mutu layanan di Rumah Sakit
5. Memperbaiki proses recruitment staf sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit
6. Meningkatkan skills dan pengetahuan SDM dengan giat mengikuti mengaktifkan diklat dan pelatihan internal serta mengikuti pelatihan secara eksternal
7. Meningkatkan marketing dan promosi untuk meningkatkan kunjungan ke Rumah Sakit Prima Husada Malang
8. Menjalin lebih banyak Kerjasama dengan stakeholder dari luar Rumah Sakit Prima Husada Malang

BAB VI

PENUTUP

Laporan kinerja Rumah Sakit Prima Husada Malang merupakan laporan tertulis atas penyelenggaraan rumah sakit yang baik, ini menggambarkan kinerja Rumah Sakit Prima Husada Malang dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran dan juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dengan tersusunnya laporan kinerja Rumah Sakit Prima Husada ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja RS Prima Husada kepada pihak-pihak terkait dan pemilik maupun representasi pemilik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif dalam pelayanan rumah sakit

Malang, 10 Januari 2026

PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada



dr. Resti Lestantini, M.Kes